

李可学术思想探讨

小三爷 整理

返朴归真研经方——李可学术思想探讨之一	1
伏邪不醒变成癆——李可学术思想探讨之二	9
火不归原引火汤——李可学术思想探讨之三	17
血证关键在脾胃——李可学术思想探讨之四	24
病证冲突当从证——李可学术思想探讨之五	30
肺癆阴阳气血虚——李可学术思想探讨之六	39
附子用量煎服法——李可学术思想探讨之七	47
培元固本治未病——李可学术思想探讨之八	56
热病急症汗清下——李可学术思想探讨之九	65
阴阳盛衰发有时——李可学术思想探讨之十	73
见皮治皮永无期——李可学术思想探讨之十一	81
中医之秘在于量——李可学术思想探讨之十二	91
少腹鼓凸大气陷——李可学术思想探讨之十三	99
伏邪作祟多痛证——李可学术思想探讨之十四	107
浊阴不升高、心病——李可学术思想探讨之十五	120

中风危证不避麻——李可学术思想探讨之十六130

附子丸散简效廉——李可学术思想探讨之十七138

内伤热证温引敛——李可学术思想探讨之十八150

重危急症小青龙——李可学术思想探讨之十九162

——李可学术思想探讨之二十162

调燮三焦治水气——李可学术思想探讨之二十一

返朴归真研经方

—李可学术思想探讨之一

李可老中医，是山西中医界独具特色的临床家，著有《李可老中医急危重症疑难病经验专辑》。一般急症都是西医的事，然而在李可任职灵石县人民医院中医科时，急救却是中医科的事。这在全国各医院中可谓绝无仅有的，故被著名中医大家邓铁涛称为“中医的脊梁”。该书收录其急重疑难验案 246 例，常有一剂知，二剂已的功效，且均为真名实姓，经得起实践检验，这在中医史上堪称一绝。他还坦诚失手的案例，进行由衷地反思，以警示初学者。李可不仅才识过人，而且医德高尚。他常年奔波在贫困山区，救治穷苦百姓。遇到不识字的病人家属，因不能按医嘱服药，就深夜守候在侧，亲自为病人煎药、灌药，直到脱险方可离去。其著书、做人不拘一格，真实、动情、感人。他打破了儒家治医，崇尚空谈的老套，脚踏实地地开创了中医一代新风。

1 经方的返朴归真

李可认为，研究经方要返朴归真。他指出，回顾中医史上，自明代医界流行“古之一两，即今之一钱”之说，数百年来，已成定律。习用轻剂，固然可以四平八稳，但却阉割了仲景学术的一大特色。近代用法，大违仲景立方本义与用药原貌，无疑严重影响了经方临床效用的发挥，阻碍了仲景学说的发展与创新（404 页）。李可从经方的剂量、煎服法、冲洗法等方面，发掘经方的不传之秘。

1.1 经方的剂量 李可认为，汉代一两，合现代克。经方以此量治重危急症，可收到一剂知，二剂已，攻无不克之奇效（142 页）。现附其验案，以为佐证。

身麻脚肿一老妇，76 岁，右半身麻，膝以下冷，脚肿不能穿鞋，渴不思饮，漱水即唾。睡醒一觉，舌干不能转动，心悸头眩，难再入睡，脉迟细，舌干红无苔。李可予以大剂人参真武汤：附子 30g，白术 30g，茯苓 45g，白芍 45g，生姜 45g，红参（另炖）15g。3 剂后肿退，寐安，舌上生出薄白苔，津液满口。又予大剂补阳还五汤加入附子 30g，白芥子 10g，全虫 3g，蜈蚣 2 条，6 剂后麻木亦愈（61 页）。

按 真武汤原方剂量：炮附子 1 枚（大者为 20~30 克），茯苓、白芍、生姜各 3 两，白术 2 两。合今之剂量：附子 30g、茯苓、白芍、生姜各 45g，白术 30g。从中可见李可是遵经方之旨，故取效亦捷。

1.2 经方的煎服法 李可认为，仲景在历史上运用乌、附剂最早，使用频率最高。仲景方中，乌、附大多生用，用量之大，古今少有。何以保证无害？奥秘全在经方的配伍、炮制与煎服方法上见真谛。以《金匱》乌头汤为例，其煎服法寓有深意。先以蜜 2 升（汉代 1 升合今之 200 毫升）煎川乌 1 枚，煎至 1 升时去川乌，留蜜待用。蜜煎川乌，有两层意义：一则蜜为百花之精华，善解百毒，尤为川乌毒之克星；二则以稠粘之蜜汁文火煮之，必影响毒性之分解。川乌剽悍燥烈之性，已不能为害。然后全方 5 味药，以水 3 升，煮取 1 升去渣，与煎妥之川乌蜜混合再煎，进一步中和毒性。再看服法：服 7 合（140 毫升，为全剂的 2/3）。服药后的效果要求：“不知，尽服之。”服后唇舌微觉麻木为“知”。“不知”即无此感觉，则“尽服之”，即把所剩 1/3 药液全部服下，以“知”为度。此必仲景当年亲历、亲尝的切身体验之谈，绝非臆测可比（69 页）。李可深得经旨，用乌头必配蜂蜜久煎。详见下面病例：

鸡爪风症 宋某，女，26 岁。产后 9 个月，忽觉四肢麻木，气怯神倦，腰困如折，劳累或气候突变则加重。近 1 个月来，麻木一旦发作，手脚便频频抽搐如鸡爪状。内科诊为缺钙性抽搐，补钙亦不能控制。视其面色萎黄欠华，脉细舌淡。断为产后血虚，肝失所养，故挛急，遂予加味芪桂五物汤：生芪 45g，当归 30g，白芍 90g，桂枝、红参（另炖）、肾四味各 10g，黑木耳 30g，炙草 10g，生姜 10 片，大枣 10 枚，胡桃肉 20g，7 剂。二诊：药后精神健旺，面色红润，气怯腰困麻木均愈，而遇冷仍有抽搐。详询病史，知患者产后未及满月，淘菜洗衣不避冷水，致寒湿深入血分，正虚不能鼓邪外达。前方为补益气血，无直接驱寒作用，服后仅体质改善而有小效，病根未拔，故遇寒又发。且本例之寒，非表寒可比，乃深伏厥、少二经之伏寒，非大辛大热温通十二经之猛将不能胜任。乃选乌头汤加味进治：生芪 90g，当归、白芍各 45g，川乌 30g，炙草 60g，麻黄、桂枝、细辛各 15g，肾四味、防风、黑小豆各 30g，全蝎 12 只、蜈蚣 4 条（研末

冲服），蜂蜜 150g，生姜 10 片，大枣 10 枚，核桃（打）4 枚。加冷水 2500 毫升，文火煮取 600 毫升，日分 3 次服，3 剂。服后诸症均愈（122 页）。

按 李氏以加味芪桂五物汤治愈多例鸡爪风，但用于本例仅有小效。经详询病史，得知患者产后未及满月，做饭洗衣不避冷水，致寒湿深入血分，内寒久伏。遂改用乌头汤配蜂蜜，加冷水 2500 毫升，煎煮时间 3 小时左右，可有效破坏乌头碱之剧毒，结果 3 剂而愈。

1.3 经方的冲洗法 李可对《伤寒论》中的注释也不放过。他说：《伤寒论》吴茱萸汤方下注一“洗”字，是仲景用法奥妙所在。即以沸水冲洗 7 遍后入煎，可免入口辛辣及服后“瞑眩”之弊（377 页）。下面举例证之：

蛛网膜下腔出血 温某，女，27 岁。怀孕 5 个月，突然剧烈头痛，喷射状呕吐，经急诊治疗两周，病势转重，邀李氏诊视。询知 CT 见“蛛网膜下腔出血”，颅内压居高不下，频频喷射状呕吐。近日多次发生短暂性抽搐，一度口眼歪斜，头痛如破，呻吟不绝，目赤气粗，呕吐稠粘痰涎及黄绿色苦水，其气秽臭。脉弦滑而劲，阵阵神糊。证属肝胃痰火上攻，气机逆乱，有升无降，内风已动，有蒙蔽神明之险，急则治标，予降气涤痰和胃降逆：赭石、怀牛膝、生半夏各 30g，胆星、天竺黄、柴胡、黄芩、酒龙胆草、枳实、炙甘草各 10g，白芍 45g，珍珠母、茯苓各 30g，全虫 5g、蜈蚣 3 条（研末冲服），生姜 30g，姜汁 10 毫升（对入），煎取浓汁 300 毫升，小量多次缓缓呷服，待呕止，顿服安宫牛黄丸 1 丸。1 剂后，头痛减，抽搐未发，神志已清。凌晨又见剧烈头痛约 1 刻钟，呕减而未止，吐出酸苦粘涎，脉弦滑较昨稍缓，舌上水滑，胃中觉凉。改投镇肝熄风汤合吴茱萸汤加减，重在降逆和肝胃：赭石 45g，怀牛膝、生半夏、茯苓各 30g，红参（另炖）、吴茱萸（开水冲洗 7 次）、炙甘草各 15g，全虫 10g，蜈蚣 10 条，生姜 30g，姜汁 10 毫升。1 剂后痛呕均止，颅压正常。仍予原方加减，侧重化瘀两剂，诸症均退，未见任何后遗症。唯输液一侧之下肢肿，予补阳还五汤调理而愈（45 页）。

按 本例之剧烈头痛，在加吴茱萸汤后一剂而止。因吴茱萸辛苦大热，其气燥烈，李氏在下笔之际曾有犹豫，恐不合于“脑出血”症。中医虽无“蛛网膜下腔出血”之病名，但患者头痛如破，剧烈呕吐，吐出物为酸苦涎沫，又自觉胃凉，正是肝胃虚寒，痰饮上冲之吴茱萸汤证，投之“效如桴鼓”。李可之经验：**吴茱萸 10 克以下无效，15 克显效，30 克攻无不克**。凡遇小儿、老人、羸弱病人则先煎沸 2~3 分钟，换水重煎，则更稳妥（377 页）。其用生半夏，也遵仲景之冲洗法，以温水淘洗 3 次，加等量生姜佐之，既解其毒，又加强疗效，不可不知（8 页）。

2 经方的基础有效量

李可在返朴归真研究经方的基础上，进一步提出经方“**基础有效量**”概念。他说：伤寒方的不传之秘在于剂量。按 80 年代初，考古发现之汉代度量衡器“权”，以此推算汉代一两，为今之克，则用伤寒方当以原方折半计量为准，这是仲景经

方的基础有效量（183 页）。凡用经方治大症，以基础有效量为准，一次用足，大剂频投，日夜连服，方能阻断病势，解救危亡。低于此量则无效，或缓不济急，贻误病机，误人性命（141 页）。兹举其案例如下：

发热待诊刘某，男，31 岁。患者以“发热待诊”入院，每日下午 3~8 时高热 40℃不退，已半月。滴注红霉素，服银翘白虎汤无效，请李氏诊治。询知患者于半月前感寒发病，初起全身骨节、肌肉酸疼，项背强急，不渴，打针服药无效，各项检查无异常。1 周后变为有规律发热，过时便逐渐减轻。发热时眉棱骨痛，先寒战，后高热，有如疟状。烧退后头晕，夜间盗汗。口苦、咽干、呕逆、目眩、便燥，舌苔厚腻，舌中裂纹，脉沉滑数。证本寒邪束表，初治见热治热，过用寒凉，致遏邪不得外透，渐入少阳、阳明，表寒未罢，里热初结，予大柴胡汤两解之：柴胡 125g，黄芩 30g，半夏 60g，赤芍、大黄、枳实各 30g，生姜 30g，二煎混匀，准于正午 12 时顿服 1 剂。患者于 11 时 50 分服药，药后全身躁热，约 10 分钟得畅汗，半小时后通便，热退痛止，诸症均愈而出院（183 页）。

按大柴胡汤的基础有效量：柴胡 125g（汉之半斤），半夏 60g（汉之半升），大黄 30g（汉之 2 两）等。午时顿服，药后仅 10 分钟即得畅汗，高烧半个月竟 1 剂而解，不能不令人折服。笔者对李氏用药做过初步统计，仅以葛根为例，在全书医案中出现 20 次，其中 60 克为 11 次，90 克以上为 4 次，30 克为 3 次（少年 1 例，老人 1 例，暴暗 1 例），10 克为 1 次（幼儿 1 例）。也就是说，葛根常用量为 60，其根据为经方葛根汤、葛根加半夏汤、桂枝加葛根汤等，诸方的葛根均为 4 两，此为葛根的基础有效量。从中可以看出：**李可不仅处方遵从“基础有效量”，其用药亦效法“基础有效量”，这是他疗效卓著的关键所在。**

3 经方的改良

李可认为，仲景在 1700 多年前，已取得了临床**应用乌附剂的成功经验：一、凡乌、附类方，炙甘草为乌、附之两倍，甘草善解百毒，甘缓以制其辛燥；二、蜜制川乌，蜜为百花之精华，芳香甘醇凉润，善解百毒，并制其燥烈；三、余药另煎，取汁与蜜再煎，中和毒性，使乌头之毒性降到最低点**（69 页）。但后世由于配伍不当，煎煮不遵法度，偶有中毒事故发生，遂使当今中医界畏乌附如蛇蝎，因噎废食，弃置不用，使仲景起死回生妙方有绝传之虞（145 页）。为此，他对经方乌附剂进行必要的改良。所谓“改良”，是在经方疗效不变的前提下，对乌附剂的毒性所采取的安全有效措施，以做到万无一失。

3.1 乌头剂的改良 李可在 60 年前初，为乌头剂增加了 3 条安全措施：①配伍：凡乌头剂，必加两倍之炙甘草，蜂蜜 150 克，黑小豆、防风各 30 克。黑小豆解砒石、甘遂、天雄、附子之百药之毒；防风解乌头、附子、羌花之毒。《中药大辞典》无黑小豆条文，但在黑大豆条文“备考”中指出：黑大豆入药，其紧小者为雄豆，入药尤佳。李氏之黑小豆，当指“雄豆”而言。②同煎、久煎：李氏将仲景蜜煎川乌之另煎法，改为全方诸药之同煎、久煎法，凡乌头超过 30 克

时（包括 30 克），即加冷水 2500 毫升，文火煮取 500 毫升，日分 3 次服。煎煮时间 3 小时左右，可有效破坏乌头碱之剧毒。③示范煎药、以知为度：凡用乌头剂，必亲临病家，示范煎药。病人服药后，必守护观察，详询服后唇舌感觉，以知为度，待病人安然无事，方可离去（70 页）。1965 年，李可曾参与川乌中毒濒危抢救，因服用川乌 9 克，3 例中毒，其中一例已死亡，另外两例经使用下面方法，均在 40 分钟救活。其处方为：**生大黄、防风、黑小豆、甘草各 30 克，蜂蜜 150 克，煎汤送服绿豆粉 30 克**（122 页）。**日本的乌头加工方法是高压 120 度，经 2 小时可破坏乌头碱之剧毒**，这样入汤剂就安全多了，也毋需先煎、久煎。

3.2 附子剂的改良 李可亦为附子剂增加 3 条安全措施：①配伍：凡用附子超过 30 克时，不论原方有无，皆加炙甘草 60 克，即可有效监制附子毒性。②文火久煎：附子剂用于慢性心衰者，加冷水 1500 毫升，文火煮取 500 毫升，日分 2~3 次服，煎煮时间 1 个半小时左右。③武火急煎：危急濒死心衰病人，使用大剂破格救心汤时，则开水武火急煎，随煎随灌，不循常规，以救生死于顷刻（70 页）。下面看一则武火急煎案例：

无脉垂死案 一老妇，60 岁。1961 年 7 月，当时患者四肢冰冷，测不到血压，摸不到脉搏，仅心口微温，呼吸心跳未停，遂破格重用附子 150 克于四逆加入参汤中，武火急煎，随煎随灌，1 小时后终于起死回生。按现代药理实验研究，附子武火急煎 1 小时，正是其毒性分解的高峰。余由此悟出：对垂死的心衰病人而言，附子的剧毒，正是救命的仙丹（3 页）。

按 此例无脉垂死案，当时为了救急而不得已用武火急煎、随煎随灌，纯属偶然。结果 1 小时后起死回生，李氏结合现代药理的提示，终于悟出了其中的道理，从此**附子武火急煎便成为救治危急心衰**的必然规律。

4 经方的突破

李可认为，1981 年汉代度量衡器“权”的发现，意义重大，值得引起中医界高度重视。剂量问题是方剂治病的核心，没有特定的“量”，便不能突破特定的“质”（404 页）。只有超常破格用药，独闯新路，才能攻克世界医学难题（自序 2 页）。李可在改良经方的基础上，又实现了 3 个突破。

4.1 突破经方的剂量 李可常和垂死病人打交道，为救危亡于顷刻，其被逼上急症攻关之路，多破格用药。例如风心病心衰垂危案（9 页），四逆汤中的附子用至 200 克（原方为 50 克），日夜连服 3 剂，附子 24 小时竟达 600 克；血栓闭塞性脉管炎案（65 页），乌头汤中的黄芪用至 240 克（原方为 45 克）；产后便燥肛裂出血案（117 页），黄土汤中的白术用至 120 克（原方为 45 克）。

4.2 突破经方的容量 所谓经方的容量，是指方剂所容纳的“复方多法”多少而言。广络兼备法（即数方或数法按一定规律组合而成的），就是方剂在容量方面的较高境界。李可治疗疑难重症，因其病证多种，相互牵制，不同时治疗又不足以祛病，故其医案多为广络兼备法。下面举例证之：

颈椎增生症 王某，男，51岁。初诊：右肩凝，臂不能上抬后展，阵阵麻木，项强痛、不能转侧月余。X片见颈2、3椎唇形增生，肩胛骨增厚。阴雨天项、背、肩有痛、麻、抽搐感。口腔及下唇生疮，此起彼伏，经年不愈。三五日辄感冒，脉沉细涩，舌淡红。证属精血亏损，络脉失养，卫阳不固，复被风寒外袭，留而成痹；阴虚阳浮，火不归原而上热。拟益气养血，滋阴和阳，逐寒通络复方：生芪120g，葛根90g，当归、川乌、黑小豆、二冬、巴戟肉、茯苓各30g，熟地90g，五味子6g，桂枝、细辛各15g，桃仁、红花、地龙各10g，白芍90g，炙草60g，防风20g，全虫12只、蜈蚣4条（研末冲服），肉桂（米丸先吞），生姜10片，大枣10枚，蜂蜜150g，加冷水2500毫升，文火煎煮取600毫升，3次分服。上药服6剂，诸证悉除（219页）。

按 该方融入了乌头汤、桂枝加葛根汤、当归四逆汤、补阳还五汤、引火汤、止痉散等复方多法，突破了经方的容量，其广络兼备法可见一斑。

4.3 突破经方的毒量 所谓经方的毒量，是指方剂的毒药剂量。古今本草，早有定论，附子有大毒。但李可认为，附子为强心主将，其毒性对垂死的心衰病人而言，正是救命的仙丹（3页）。李可在四逆汤基础上，研制出破格救心汤，救治各种类型心衰急症，其方剂组成：附子30~100~200g，干姜60g，炙甘草60g。红参10~30g（另炖），山萸肉60~120g，生龙牡、磁石各30g，麝香（分次冲服）。现举验案，以为佐证：

风心病心衰垂危 吴某，男，55岁。患风湿性心脏病12年，此次因急性心衰合并室颤，心率212次/分，已发病危通知书，邀李氏会诊。诊见患者目暗无神，面如死灰，头汗如油，神识昏糊，喘不能言，气息奄奄，小便自遗。唇、舌、指甲青紫，口鼻气冷，全身冰冷，仅胸部微温，腹胀如鼓，下肢烂肿如泥，吸氧，测不到血压，寸口部脉如游丝。五脏绝症已见其三。元阳垂绝，危在顷刻。所幸下三部太溪根脉微弱可辨，是为一线生机，遂投大剂破格救心汤，重用附子200克，加沉香粉3克、油桂3克冲，茯苓、泽泻各30克，以纳气归肾、利水消肿。武火急煎，边煎边灌。服药一刻钟阳回厥退，汗敛喘定。一个半小时即知饥索食，心率100次/分，脱险。嘱原方再取3剂，3小时1次，昼夜连服。6小时后，水肿消退，心率82次/分，已能拄杖出游。计前后31小时，服附子公斤，山萸肉0.5公斤，古今视为必死之症，竟获治愈（10页）。

按 此案已发病危通知书，李氏用大剂破格救心汤，前后仅用31小时治愈，折合一昼夜附子用至600克，这在中医史上可谓绝无仅有的。

5 经方是攻克急症的仙丹妙药

李可认为，自明代医界流行“古之一两，即今之一钱”之说，数百年来，已成定律。习用轻剂，固然可以四平八稳，但却阉割了仲景的一大特色，丢掉了急症阵地（142页）。李氏在经方四逆汤基础上，研制出破格救心汤救治各种类型心衰急危重症，如风心病心衰垂危案便是明证（10页）；其在大承气汤基础上，

又研制出攻毒承气汤救治多种危重急腹症，竟获成功，占领了急症阵地。下面看一则急腹症验案：

阑尾脓肿合并肠梗阻 任某，女，48岁。患者取右侧位卧于炕上，痛苦呻吟，频频呕吐秽臭粘涎并夹有黑便，豆粒大之汗珠从头部淋漓滴下。右腿弯曲不敢稍伸，阑尾部有包块，隆起馒头大，外观红肿，痛不可近。扪之灼热，有波动感。腹胀如瓮，阵阵绞痛，已三日不便，亦不能矢气，小便赤热刺痛。高热寒战，叩齿咯咯有声。腋下体温 39.5℃，口气秽臭，舌黑起刺、干涩。可断为肠痈脓成，热毒壅闭三焦、阳明腑实之关格大证，建议手术治疗，但患者畏惧开刀，宁死不去。李氏拟攻毒承气汤加味：①生白萝卜 2.5 公斤，芒硝 120 克，加水 5000 毫升同煎，分 3 次入萝卜，待熟煮一批，捞出再换一批，得浓汁缩至 500 毫升，备用。②双花 240g，连翘、苡仁、赤芍、桃仁、厚朴、槟榔、芙蓉叶、芦根各 30g，冬瓜仁 60g，生大黄 45g，丹皮、枳实各 15g，皂刺、炮甲、白芷、甘草各 10g，木香、沉香各 3g（磨汁对入）。加水过药二寸，加白酒 100 毫升，浸泡 40 分钟，然后武火急煎 10 分钟，取汁 1000 毫升，与方一混合，每隔 2 小时服 300 毫升，连续服用，以通为度。第一次服药后两小时，腹中绞痛，上下翻滚，腹中阵阵雷鸣，频频打嗝矢气。幸得三焦气机升降已复，乃一鼓作气，再进 300 毫升，患者欲便仍未便下，但胀痛已大为松缓。3 小时后又进 300 毫升，药后 3 小时便下黑如污泥，极臭，夹有硬结成条、块状粪便及脓血状物一大便盆。随即索食面条 1 碗，安然入睡。次日清晨，阑尾部之包块已消，仍有压痛，体温 37℃，舌上黑苔退净，六脉和缓从容。予清肠饮倍苡仁，加芙蓉叶、甲珠、皂刺以清余邪，3 剂而愈（128 页）。

按 现代医学认为，阑尾穿孔合并腹膜炎或脓毒血症者，二者若见其一，已非保守疗法适应症。但李氏治此类病人，以攻毒承气汤，前后不出 10 小时，费用不过数元。若于大柴胡合方，重用柴胡 125 克，可于 40 分钟内使急性胰腺炎痛止、肿消，还用于重症肺脓疡、肝痛、外科创伤毒血症、急性子宫内膜炎等多种急腹症。

6、经方是破解世界性医学难题的一把金钥匙

李可认为，《伤寒杂病论》是中医学宝库中之宝库，有强大的生命力。仲景学说是中医学说的灵魂，是中医取之不尽的源头之水，是攻克世界性医学难题的一把金钥匙（406 页）。下面看一则李氏用经方治疗世界性医学难题验案：

血栓闭塞性脉管炎 高某，男，51 岁。患者素有严重冻伤，10 年前下肢冷痛，多次住院无效，后来病情恶化，确诊为脑动脉硬化、心肌下壁梗塞、双下肢血栓闭塞性脉管炎，建议高位截肢。绝望之下，求李氏诊治。诊见双下肢膝以下冰冷，足趾青紫，电击样剧痛日夜不休，左下肢麻木，脉沉细迟微，双足背动脉消失。面色苍白晦暗，畏寒神倦。证由寒邪深伏血分，痹阻血脉，已成脱疽重症及真心痛。遂拟乌头汤合当归四逆加吴茱萸生姜汤，加虫类入络搜剔，麝香辟秽

通窍，合而大辛大热，开冰解冻，益气破瘀，通络定痛之剂：生黄芪 240g，附子、当归、炙草各 60g，川乌、丹参、川牛膝、黑小豆、防风各 30g，麻黄、桂枝、细辛、赤芍、桃仁各 15g，肉桂 10g，吴茱萸 20g（开水冲洗 7 次），另用麝香 1g、炮甲 5g、水蛭 3g、全虫 3g、蜈蚣两条（研粉冲服），蜂蜜 150g，生姜 45g，大枣 10 枚，加水 2500 毫升，文火煮取 500 毫升，对入黄酒 500 毫升，日 3 夜 1 服，4 剂。服 1 剂，当夜安然入睡。又连服 3 剂，诸证均退。原左足大趾内侧之溃疡亦收口愈合，心绞痛及下肢电击样剧痛亦消失。后服培元固本散半月而痊愈（65 页）。

按 李可在他的书中，多次提到用经方攻克世界性医学难题，如以破格救心汤使上百例西医下病危通知书的濒死心衰起死回生（1 页），以破格救心汤变方治愈世界性新增疾病谱中疑难绝症肺间质纤维化 2 例（25 页），以乌头汤合当归四逆加吴茱萸生姜汤治愈西医建议高位截肢的寒凝型脉管炎 7 例等（67 页）。由此看来，经方是攻克世界性医学难题的一把金钥匙，确切地说，经方乌、附剂便是这把金钥匙，其在血栓闭塞性脉管炎案结束语中已点明这一观点，应引起中医界的高度重视。

7、经方的感悟

李可在经方诸方面，取得了令人瞩目的成就。现在我们再回过头来看，他对经方是如何感悟的。

李可自述：23 岁自学中医，6 年以后记了些方，只会对号入座，有时效果不好也闹不清是怎么回事，就请教老中医，他们告诉我：中医的出路在《伤寒论》。于是就学习《伤寒论》，治病情况有所改善。以前是拿方套人，后来是把各种各样的病都放在六经中去考虑，内、外、妇、儿都是这样，就进步一些。61 年（即 31 岁），在甘肃救活一心衰病人，昏迷，四肢厥冷，脉摸不到了，血压也没了，即无脉垂死案，仅心口微温，呼吸心跳未停。开始用 30 克附子，用开水急煎，煮沸 1 刻钟即进煎边喂，当加到 150 克时，1 小时后病人睁开眼，能说话了。62 年又治一例心衰，每剂药用 45 克附子。当时家属已准备后事，媳妇不懂得，把 3 副药一起煮了，在 3 小时里一勺一勺都给婆婆灌了下去，结果当天晚上老太太就醒过来，要吃饭，次日即可下炕走路。从此我查遍医书，看到宋人许叔微《伤寒九十论》中记有一个病案：病人久治不愈，按《伤寒论》上原方原量，一剂药 3 次服，而两次服已豁然而愈。又读名医类案卷一，载吴球用附子验案。吴球浙人，曾为明太医。一富室患中寒阴证，名医盈座束手，后吴御医至，诊之曰：“非附子莫救，令人拣极重者 3 枚，生切为一剂，计量三两投之。”众医咋舌，私自减其半量，以一两半为剂进之，病遂已。吴复诊曰：“为何减吾药量？吾投三枚，将令其活三年，今止活一年半耳。”后半果病发而卒。这两位前辈的当头棒喝，如一声惊雷，引导我走上试药尝药之路。只有亲手做过，方可发现真理。这一次的误打误撞，侥幸成功，对我震动极大。使我意识到，剂量是疗效的关键，而经

方基础有效量便是突破口。李时珍说：“古之一两，约今之一钱。”这句话害苦了《伤寒论》470年，现在的用量只是伤寒方的十分之一，岂不是阉割了伤寒论！关云长是三国名将，你收缴了他的青龙偃月刀，他还有什么威风！伤寒方之所以不能治大病，中医之所以沦为慢郎中，之所以退出急症阵地，之所以沦为西医附庸的根本原因就在这里。从那以后，经我手治疗的心衰、肺衰、肾衰病人，没有死过一例。

李可取得上述经验，还有一个客观原因，那就是晋中地区，凡西医发了病危通知书，不抬回家就火化，而当地人特别怕火化，就找中医、找李可。李可就是在这“死人堆”里（即垂死心衰病人），才炼就了中医之十八般武艺。一个23岁自学中医的人，中间入狱2年半，从1959年（即29岁）到1961年内开始对心脏病攻关，就对经方已经大彻大悟。1981年，汉代度量横器的考古发现，完全验证了他在19年前实践中行之有效的剂量正与仲景原方用量相符。这不是先知先觉，又是什么呢？所以“南风窗”杂志的记者在采访李可时说：许多病人称呼您“救命先生”，还有人说您是“当代张仲景”。这应当引起我们深刻的反思。

李可研究经方的思路，现简要归纳如下：**经方的返朴归真；经方的基础有效量；经方的改良；经方的突破；经方是攻克急症的仙丹妙药；经方是破解世界性医学难题的一把金钥匙。**

伏邪不醒变成痼

——李可学术思想探讨之二

简介：针对伏邪与伤寒、温病关系问题，进一步探讨了李可学术思想。李可研究伏邪的思路：伏邪的概念；伏邪的病因病机；伏邪的发病特点；伏邪的治疗规律。

关键字：伏邪概念 病因 病机 发病特点 治疗规律 李可 医案

伏邪，《中医大辞典》认为：藏伏于体内而不立即发病的病邪。温病学说亦称伏邪为“伏气”。千百年来，伏邪一直作为阐释温热病病因病机的专用名词。其实，在《伤寒杂病论》中也可以找到伏邪的依据，如外寒内饮之小青龙汤证，热入血室之小柴胡汤证，《金匱要略》之伏饮、留饮、里水等。李可在仲景之伏邪观点基础上，对伏邪的概念、病因病机、发病特点、治疗规律，进行系统整理和发挥。笔者根据李氏之伏邪医案30余则，整理出以下内容：

1 伤风不醒变成痼

李可首先提出伏邪的概念。他认为，邪初在表，失治则由表入里，正虚无力驱邪外出，深入五脏，伏于血分，在治疗上便成“半死半生”之局。“伤风不醒变成痹”，这则民间谚语道破了伏邪的深刻病理、病机（22 页）。下面看一则伏邪演变虚劳案：

布鲁氏杆菌病急性心衰濒危 张某，男，28 岁。患者从事牧羊 3 年，传染布鲁氏杆菌病 1 年半，迁延失治，心、肝、肾实质均受损害。半月前因感冒而突发心衰，经省人民医院抢救 5 日无效，病危出院，准备后事，邀李可作最后挽救。诊见患者端坐呼吸，频咳暴喘，喉间痰鸣漉漉，呕吐涎沫；面色灰暗，神情萎顿，似睡似醒，唇指紫暗，胸痛彻背；全身凹陷性水肿，脐凸胸平，睾丸水肿，尿少，日夜约 150 毫升；厌食，食入则胀急欲死；憎寒无汗，亦无涕泪；脉促，114 次/分，频见雀啄；舌紫暗，满布紫黑瘀斑。从脉证推断，必是初病失表，致外邪深入五脏，正虚无力驱邪外出，伏于血分，渐致阴竭阳亡。此次因感冒而突发心衰，憎寒无汗，是表气闭塞，三焦气化冰结，聚水成肿之主因。少阴与太阳同病，有麻黄附子细辛汤法，温里寒，开表闭。遂拟以破格救心汤，重用附子 200 克，加麻黄、细辛开表闭透伏邪，加油桂、五苓蒸动气化而利水，更合瓜蒌薤白白酒汤、丹参饮开胸涤痰破瘀，麝香辟秽开窍而救呼吸衰竭，日夜连服 3 剂，3 小时 1 次。当服第 1 次药后，头部见汗，喘咳顿减；服第 2 次药后，全身得畅汗，小便大增，日夜达 3000 毫升以上，水肿消去十之七八，脉沉弱 82 次/分，脱险（11 页）。

按 本案患布鲁氏杆菌病 1 年半，迁延失治，渐致虚劳。此次因新感引动伏邪，憎寒无汗，频咳暴喘，全身凹陷性水肿，突发心衰，生命垂危。以麻黄附子细辛汤合破格救心汤，温里寒，开表闭，透伏邪，日夜连服 3 剂而脱险。

2 伏邪的病因病机

李可认为，伏邪的病因病机，主要有以下几点：①外感失表，由表入里，深入脏腑（11 页）；②表未解而误攻，则邪陷入里，变生不测；③表未解而误补，则闭门留寇，后患无穷（198 页）；④表未解而误投寒凉，则损伤正气，遂成痼疾（153 页）。下面举例证之：

表证误攻变证 温某，女，37 岁。患胃病多年，近感风寒，头痛恶寒与脘痛呕逆同见。医者失察，置表证于不顾，迳投保和汤治胃，其中有莱菔子、瓜蒌各 30g，枳实、青皮各 10g，服药 3 剂，反增腹泻，四肢酸懒，卧床不起。李氏询知仍觉畏寒无汗，头痛体楚，脉反沉紧。表证未罢而见里证里脉，为消导开破药损伤正气，寒邪由表陷里所致。逆流挽舟法治痢疾失表、邪陷入里，可以借鉴：羌活、独活、前胡、川芎、枳壳、桔梗、红参（另炖）、麻黄、炙草各 10g，茯苓 30g，吴茱萸 15g（洗），生姜 15 片，大枣 10 枚，水煎服。上药仅服 1 剂，得汗，诸证遂愈（198 页）。

按 本案为表证误攻腹泻，李氏以人参败毒散扶正托邪，开门逐盗，1剂得汗而内外均解。李可之二弟，少时体弱，患外感身痛，医者但见面黄肌瘦，予补脾之剂3付，缠绵2个月不愈，致寒湿外邪深入五脏，遂演变为风心病。

3 伏邪隐匿 但有征兆

李可在论述伏邪与水肿关系时指出，慢性肾炎水肿及顽固心衰水肿，多由表邪入里而来。唯病程一长，多数病人对致病之由皆不能记忆，而医者亦见病治病，忽略追根寻底，投剂则隔靴搔痒，无济于事（9页）。从中可以看出，伏邪易被医患双方所忽视，再加上邪藏于里，比较隐匿，捕捉伏邪就是个棘手问题。为此，李可进一步指出捕捉时机：**既有伏邪，必有征兆。新感引动伏邪，邪正相争而宿疾发作，便显示出病邪盘据的经络脏腑，暴露了疾病的奥秘**（22页）。现附验案，以为佐证：

风心病合并冠心病 张某，女，40岁。病史：风心病、冠心病、肺瘀血已10年。现证见心悸、气喘、咳血。动则尤甚。每进食必心中大动，故每届饭时，忧心忡忡。为免心跳，吃吃停停，一餐常延搁二三小时之久。心率常在170~210次/分左右。脉促，四肢厥冷，胸闷刺痛，唇、指、舌青紫。自汗淋漓，腰困如折，入夜不能左侧卧，否则呛咳喘悸不停。纵观诸证，为心之阴阳皆虚，阳虚偏重。拟炙甘草汤、参附龙牡救逆汤、丹参饮合方化裁，温肾回阴、通脉化瘀、滋液救心为治，21剂。药后悸止、喘定、肢厥、紫绀消失。进食已不心跳，胸闷刺痛在服至10剂时痊愈。唯月初曾出现反复，穷追细问，始得知10年来每经期必感冒，每感冒一次，病情就加重。其症为月经前1日寒热如疟，呕吐耳聋，经净自愈。此乃六淫外邪久羁，由表入里，深入血分不能透达，即《伤寒论》热入血室之证，当因势利导，予小柴胡汤加味，提透血分伏邪：柴胡、红参（另炖）、五灵脂、川芎、酒芩、干姜、桃仁、炙草各10g，丹参、当归、益母草、半夏各30g，赤芍15g，泽兰、香附各12g，黑芥穗6g，生姜10片，大枣10枚，6剂，每月经前一日连服3剂。药后，经前感冒得以根除。除风心病存在外，已无自觉证状，以固本散善后（20页）。

按 本案重病10年，邪入血室即达10年。由于经期必感冒，新感引动伏邪，邪正交争而宿疾发作，便显示出病邪盘踞在血室之奥秘。乘伏邪之蛛丝马迹在此时暴露无遗之际，因势利导，一举破其巢穴。遂以一味黑芥穗之深入血分，加入小柴胡汤内，扶正达邪、和解表里，使10年伏邪得以外透，从此步入坦途。

4 伏邪的发病特点

李可认为，伏邪发病，或交节病作，或经前必犯，或周期发作（152页）。凡久治不愈，反复发作的重病、顽症、痼疾，必有六淫外邪深伏（22页）。现根据李氏之详实医案，归纳出以下内容：

4.1 伏邪病史特点

伏邪病史有以下特点：①寒邪久伏病史：李可之经验，凡慢性肾炎水肿及顽固性心衰水肿病人，病程多在 10~30 年不等，均有外感寒邪病史（9、22 页）。如肺心病合并脑危象急性肾功衰竭案（8 页）。②反复感冒病史：一般人把感冒不当回事，李可却认为，如此反复感冒，每感冒一次，即有一点寒气积于体内，寒邪一层压一层，深伏不出，便成顽症（379 页）。所以，反复感冒不可轻描淡写，也是诊断伏邪的依据，如过敏性鼻炎案（282 页），阳虚型红斑狼疮案（202 页），其月月感冒 2、3 次，便是明证。

4.2 伏邪发病时间特点

伏邪发病时间有以下特点：①交节病作：如肺间质纤维化案（31 页），于时痉挛性暴咳约 3 分钟。因半夜阴气大盛，阳不胜阴，故痉咳而痰难出。②经前必犯：如风心病合并冠心病案（21 页），每逢经期，诸证加剧。③久治不愈、反复发作：如重症痢疾疑癌变案（152 页），每隔月余即暴痢 1 次，其周期性发作是新感引动伏邪，正虚无力鼓邪外出。

4.3 伏邪证候特点

伏邪证候有以下特点：①表里并病：《伤寒论》有合病与并病之分，**合病**为两经或三经同时受病；**并病**为一经未退又传一经，必须为一经症状还在，而又具备后一经证状。根据伏邪的概念，可知伏邪是表里并病。李可之经验，顽固心衰水肿病人，均有外感久伏病史，察知多寒邪深伏少阴，常予对证方内加入麻黄、细辛，开提肺气，透发伏邪（22 页）。②表证隐匿：伏邪是初病失表，由表入里。但不是全入里，即表证的一部分入里，一部分还在表。正因为一部分入里，所以**伏邪的表证就比较轻微、隐匿，很少有典型的表证**（寒热、无汗头痛），多为肩背沉困，甚如压一石磨感（380 页），背部似冷水浇灌（27 页），胸上如压一石磨感（40 页），全身如捆之感（28 页），偏头无汗（152 页），每进食胸背无汗等（28 页）。③表证久羁：伏邪的表证，不但轻微、隐匿，而且久羁，如重症痢疾疑癌变案（152 页），肩背沉困、偏头无汗多年，便是太阳表气闭阻之明证。④里证深伏：伏邪入里，既可侵入五脏，又可深伏血分，尤其要详辨三阴。如结核性胸膜炎案（47 页），为外寒内饮，阴邪窍居阳位；鸡爪风症案（122 页），为厥、少二经之伏寒。

5 伏邪但从里去 不死不休

喻嘉言在《医门法律·痢疾门》中指出：邪陷入里，虽百日之久，仍当引邪由里出表，若但从里去，不死不休。下面举例证之：

重症痢疾疑癌变 王某，男，23 岁。患痢经年不愈，其病始于抗洪抢险，在水中浸泡 26 昼夜，劳倦内伤，复加寒湿郁久化热成痢，住院 3 个月，日见加重，查出直肠息肉，手术切除坚硬、灰黑色赘生物 4 枚，活检不能排除癌变。接受化疗 2 个疗程，服抗癌中药百余剂，病情迅速恶化，呕逆不能进食，痢下日夜无度，体重锐减 10 公斤，又查出直肠有多个赘生物长出，因重度贫血无法进行

手术。李可诊时患者卧床不起，两目无神，时时思睡，喘汗不止，烦躁不宁，心动震衣，双颧艳若桃花，膝冷如冰，口舌糜烂，脉见浮洪，重按则如游丝。病情危重，恐有阴阳离决之变，以回阳救脱为要：红参（另炖）、附子、龙牡、炙草各 30g，山芋肉 120g，赤石脂 30g，肉桂 1.5（冲）。因有假热在上，嘱热药冷服。服 1 剂，险象尽退，安然入睡，汗敛喘定。唯下痢无度，所下多脓血及腐臭黑水、脂膜之类，10 多分钟即下痢 1 次。师法张锡纯燮理汤变通方，4 日后下痢为 10 次左右。又服 4 日已能起床，1 日夜痢下 2~3 次，不再腹痛后重。令其停药，每日蒸食鲜山药半斤与 30 克山楂粉加红白糖佐餐，半月后痢止，体重恢复，基本康复。不料 1 个月后又生突变，每隔月余即暴痢 1 次，稍加调治即愈，但其周期性发作不能根治。患者屡屡诉说肩背沉困，便是太阳表气闭阻之明证。初治失表，过用攻下中药百余剂，致邪深陷入里，遂成危症。喻氏云：邪陷入里，虽百日之久，仍当引邪由里出表。若但从里去，不死不休。拟逆流挽舟法，引入里之邪从表透出：红参（另炖）、羌活、独活、前胡、川芎、枳壳、桔梗、炙草各 10g，茯苓 15g，薄荷 3g，生姜 3 片，2 剂。药后周身得微汗，其多年之偏头无汗、肩背如压一石磨之沉困感亦愈。伏邪尽透，经年久痢竟获治愈，直肠镜检，息肉亦已消失（152 页）。

按 本案初治失表，过用攻下，但从里去，结果痢下日夜无度，体重锐减，喘汗不止，心动震衣、颧艳如妆，阴阳欲绝。李氏初用参附龙牡救逆汤回阳固脱，继用燮理汤变方治愈。唯每隔月余即暴痢 1 次，其周期性发作不能根治。经穷追细问，始得知患者屡屡诉说肩背沉困，仍是太阳表气闭阻之明证。遂用逆流挽舟法引深陷入里之邪从表透出，从此便步入坦途。**人参败毒散**，原出宋代《和剂局方》，是一首著名的益气解表方剂。喻嘉言把它引入痢疾门，成为中国医学史上第一首以解表法治痢之方，在痢疾的治疗上另出枢机，独辟蹊径。

6 伏邪的治疗规律

李可认为，《内经》说“善治者治皮毛”，不单是为表证立法，也是治疗重、难、痼证的法宝（22 页）。古人又有“正旺邪自退”之说，比如对待一个气息奄奄的痢疾病人，黄连、大黄沾唇必死，即“十分虚邪，无实可攻”。于是“但扶其正，听邪自去”，确保住了病人的性命。调动人体的正气去战胜疾病，即“不治之治”是中医治法中的最高境界（177 页）。现将其治法归纳如下：

6.1 伏邪之常法

6.1.1 扶正达邪法

扶正达邪法有以下诸方：①小柴胡汤加黑芥穗：用于热入血室，如风心病合并冠心病案（22 页），红斑狼疮案（203 页）；②乌蛇荣皮汤加味：用于皮肤病，如过敏性紫癜案（328 页）；③人参败毒散加味：用于伏邪之感冒，如结核性心包炎、心包积液案（49 页）。

6.1.2 助阳透邪法

助阳透邪法有以下诸方：①小青龙汤加味：用于痰饮内伏，如肺心病急性肾功衰竭案（8 页）；②麻黄附子细辛汤加味：用于寒邪深伏少阴，如布鲁氏杆菌病心衰案（11 页），过敏过鼻炎案（282 页）；③乌头汤加味：用于寒邪深伏血分、痹阻血脉，如鸡爪风症案（122 页），血栓闭塞性脉管炎案（65 页）。

6.1.3 逆流挽舟法

逆流挽舟法有如下方剂：人参败毒散，用于邪伏于里之泻痢，如表证误攻变证案（198 页），重症痢疾疑癌变案（152 页）。

6.1.4 广络兼备法

广络兼备法有如下方剂：偏正头风散，用于头风痼疾。偏正头风散，原出《和剂局方》，药 18 味。李可经临证运用，重新修订之后，增至 27 味，大大突破了原方的主治范围。头风顽症，正气先虚，外淫六邪袭入，日久由经络渐入于脏，湿痰死血筑成巢穴，深伏不出，遂成痼疾。李氏采用广络兼备法，以人参、天麻、制首乌、白蒺藜补元气、益精血；川草乌通十二经脉，破沉寒、驱伏邪；芎、芷、荆、防、羌活、辛夷、苍耳、苍术，芳香透窍，开门逐盗；天麻、南星、白附，化痰定风；石膏甘寒清热，监制辛热诸品；雄黄、苍术，解毒辟秽；乳香、没药，化瘀定痛；诸虫深入血分，搜剔伏匿之邪；白芷一味，号称植物麝香，善通诸窍，与川芎专理头痛相配，引诸药上达头部，破其巢穴。诸药相合，对风、寒、湿、痰、血瘀多种伏邪，皆有透发之效（242 页）。

总之，**伏邪常法用药，以扶正助阳、开表、透邪 3 法组成**。扶正多用人参，助阳多用附子，开表多用麻黄、羌活，透邪多用细辛、黑芥穗。**李氏经验，伏邪之开表法，只用一两次，表闭开、营卫通即弃之，透邪药可以继服**，详见肺间质纤维化案（28 页）。

6.2 伏邪的变法

根据“**正旺邪自退**”、“**十分虚邪，无实可攻**”的原则，凡是体虚之伏邪，李可多用变法。如产后阴黄重症案（172 页），用人参四逆汤合茵陈五苓散加味，回阳破阴、温肾固下；伏寒奇症案（380 页），前后用药 43 剂，始终用温氏奔豚汤温肾回阳、镇敛冲气，均是用补法之明证。下面看一则痢症用补法之验案：

久痢成癆 杜某，女，23 岁，病危邀诊。病史：1 年前患者因 8 个月男孩因病夭折，悲伤过度，食少形瘦。今春流产，失血过多，多次发生贫血性休克。夏末患痢，寒热如疟，日下脓血便 10 余次。服白头翁汤不效，又服葛根芩连汤 12 剂，病不减，反不能食。盛夏憎寒，不离棉衣，日渐消瘦，咳嗽盗汗。经 X 光透视见右肺浸润型肺结核。已闭经、卧床不起 4 个月。食少呕逆。咳喘自汗，脓血便乃未止，每便必脱肛。经抗癆药后食纳锐减，形容枯槁，眼眶塌陷，皮肤干瘪。一日数度晕厥，气息奄奄，病情危重。脉细数不乱，两迟尚能应指。病由寒痢误用苦寒损伤脾阳，邪陷入里成癆。延久损及于肾，生命根基动摇，已无实可攻。亟扶正固脱，醒脾救胃：红参（捣末同煎）、生半夏各 30g，山芋肉、山药各 100g，炙草 15g，生姜 10 片，煎取浓汁 300 毫升，对入姜汁一盅，一日内不分次数缓

缓呷服。呕止后，改为日分3次服，3剂。服1剂后当日呕止，服完第二剂后，汗敛喘定，知饥，索食藕粉1小碗，服稀粥4~5次。服完第三剂后，可日进食半斤许。患者已能半卧位，两目有神。脉虽细弱，但属有根。下痢脓血如前，未再休克。因呕止，原方去半夏，合补中益气汤：生芪18g，红参（另炖）、白术、当归各10g，柴胡、升麻、陈皮各3g，肾四味各10g，山芋肉、山药各100g，炙草15g，生姜3片，大枣4枚，胡桃4枚打，3剂。药后已能起坐，日可进食七八两。便脓血、咳嗽、午后潮热不减。第3方咬定护元气，补土生金之法，原方加炒谷、麦芽醒脾，**煨龙壮固脱**。服20剂后，已能起床下炕游走几次，进食身有微汗，正气渐复，营卫通调而伏邪外透，痢疾不治而愈。效不更方，再进20剂，间日1剂。药后咳嗽、潮热止，月经来潮，可到户外活动。经X光检查，右肺结核已钙化，一年后生一男孩（205页）。

按 此例属于误治败症，故断然打破了古人“痢无补法”之禁律。首诊方虽药仅5味，却是起死回生的关键。其中红参、山芋肉益气敛脱，山药补肾益肺、滋润血脉，**生半夏为降胃安冲止呕圣药，与等量之生姜、姜汁、炙草合用，既解其毒，又能止剧烈之呕吐，从而使胃气复苏，为本症的治疗破一呕阻难关**。如此垂危重症，经治2个月，服药49剂，无一味治痢之药而痢愈；仅一味山药治痢之药而痢亦愈。可见古人“扶正邪自退”之说，确有至理。

7 伏邪与伤寒关系

温病学说称伏邪为伏气；《中医大辞典》认为伏邪是藏伏于体内而不立即发病的病邪。二者意思相近，均把伏邪指向伏气，纳入温病范畴。李可在仲景伏邪观点基础上，对伏邪的概念、病因病机、发病特点、治疗规律，进行系统整理和发挥，从中可以领略伏邪与伤寒的关系。

7.1 伏邪偏重寒邪

李可之伏邪医案34则，其中属于寒邪或寒湿者32例，如脊髓神经胶质瘤案（341页），类风湿性关节炎合并硬皮症案（208页）。仅有两例为外感风热或热毒所致，如高热惊风案（71页），疹毒内陷案（78页）。

7.2 伏邪为表证与三阴并病

伏邪的证候特点是表里并病，进一步说是表证与三阴并病。如鸡爪风症案（122页），患者产后未及满月，淘米洗衣不避冷水，致寒湿深入厥、少二经；结核性腹膜炎合并胆囊炎案（58页），患者怕冷、无汗、咳喘、腹水、尿少、全身浮肿等，诊为少阴（肾）虚寒为本，兼见太阳表寒实，渐传太阴（肺、脾）虚寒证。

7.3 伏邪为六经辨证之延伸

《伤寒论》是外感病的治疗规律，其中详于三阳辨证，而略于三阴辨证。故笔者曾误以为六经辨证只限于外感病，而与内伤杂病无涉。后来读了《李可老中医急危重症疑难病经验专辑》，眼界大开。李可之全书共246例医案，其中伏

邪医案 34 则，占总数的 14%，从中可见伏邪是内伤杂证的常见病。笔者在文中引用布鲁氏杆菌病急性心衰（11 页）、表证误攻变证（198 页）、风心病合并冠心病（20 页）、重症痢疾疑癌变（152 页）、久痢成癆（305 页）等诸案，详细记录了病初失表，由表入里，深入五脏三阴的演变过程。其治疗不仅用经方小青龙汤、麻黄附子细辛汤、小柴胡汤、乌头汤，亦用时方人参败毒散、验方偏正头风散、自制方乌蛇荣皮汤等。李可之伏邪理论，详于三阴辨证，弥补了六经辨证的薄弱环节，并进一步把六经辨证扩展到内伤杂病领域。

7.4 伏邪属于伤寒范畴

仲景在《伤寒杂病论》中之伏饮、留饮、里水，以及小青龙汤证、麻黄附子细辛汤证、小柴胡汤证、乌头汤证等，已经涉及到伏邪的实质，这应当在《中医大辞典》中大写一笔。而《中医大辞典》之伏邪条文解释（即藏于体内而不立即发病的病邪），其实质是伏气，没有涵盖仲景之伏邪观点，显然是不妥的。李可在仲景伏邪观点基础上，进行系统整理和发挥，理法方药应有尽有。这样看来，伏邪的概念，应当正名；伏邪与伏气，应当分开。伏气是藏伏于体内而不立即发病的病邪；伏邪是初病失表，由表入里，深入五脏，伏于血分。伏邪属于伤寒范畴，伏气归于温病范围。这样分类，名符其实，对规范证候，指导临床，有着重要的意义。

李可研究伏邪的思路，现简要归纳如下：伏邪的概念；伏邪的病因病机；伏邪的发病特点；伏邪的治疗规律。

火不归原引火汤

——李可学术思想探讨之三

简介：针对引火归原之火的不确定性，进一步探讨了李可学术思想。李可研究引火归原的思路：火不归原证的概念；火不归原证的特点；火不归原分型论治；火不归原类证鉴别；引火归原有狭广二义。

键字：火不归原证 概念 特点 分型论治 类证鉴别 引火归原法 李可 医案

引火归原是用温药治疗龙火上燔的一种方法，属于从治法。王冰在《内经》“甚者从之”句下注解中指出：“病之大甚者，犹龙火也，得湿而焰，遇水而燔。不知其性，以水湿折之，适足以光焰诣天，物穷方止矣。识其性者，反常其理，以火逐之，则燔灼自消，焰光扑灭”。明清温补医家根据上述理论，将引火归原广泛用于临床。但由于离原之火理论上的不确定，造成了诸多认识上的混乱，不少医家陷于相互矛盾之中。如既称阴虚之火，又称阳虚之火；既指有根之火，又指无根之火；既包括格阳，又涵盖戴阳。李可对引火归原治疗，喜用傅青主之引

火汤，原方组成为：**熟地 90g，巴戟、天麦冬各 30g，茯苓 15g，五味子 6g**，主治阴虚乳蛾。现根据其医案 40 余则，整理出以下内容：

1 水浅不养龙 龙火离位上奔

李可认为，肾为先天之本，内寄命门之火，为水火之脏。肾中水火，共处一宅。水火相抱，阴平阳密。水足则火藏于下，温煦脏腑，统领一身气化，是为健康无病。若因外感内伤，致水亏于下，则火失其制，古人喻为火浅不养龙，于是离位上奔（240 页）。下面看一则水浅不养龙案：

血管神经性头痛 李某，女，38 岁。患者因剧烈右偏头痛 7 日入院，诊为血管神经性头痛，经用安络痛、当归注射液穴位封闭不能控制，邀李氏会诊。自冬至近 1 个月以来，每到太阳出山便觉有热流上攻头面，面赤如醉，轰热难忍。一周前拂晓，突觉热流攻冲不止，右下颌角突然如电击、火灼，阵阵剧痛窜至右太阳，约 3~5 分钟发作 1 次。每日如此反复发作 10 余次，5 时痛起，日中痛剧，下午 5 时渐松，太阳落山痛止，入夜则如常人。便燥口干，双膝独冷，夜难成寐。脉洪大而虚，舌光红无苔。脉证合参，当属肾阴亏损，阴不抱阳，水浅不养龙，故龙雷之火上奔无制。阴虚之患，寅末日将出而病，日中阳气大盛，故病重。日落阳气衰，得天时之助而暂愈。入夜阴气渐充，故如常人。法宜大剂滋水，导龙归海，引火归原，佐入酸甘柔肝缓急：熟地 90g，巴戟、天麦冬各 30g，茯苓 15g，五味子 6g，白芍 100g，炙草 30g，葛根 60g。二诊：药进 3 剂，当天热流攻冲之势大缓，次日轰热止而痛亦止。偶于下午 2~3 时有短暂发作，脉敛，面色转淡，舌上生出薄白苔，带原方 3 剂出院。追访 3 年未复发（239 页）。

按 龙雷之火，顾名思义，是形容它产生于顷刻之间、突然而来。中医认为，肝肾同源，肾水既亏，肝失滋荣，势必随肾中龙火上燔，而成燎原之势。证见日出便热流上攻，面赤如醉，日落痛止。治以引火汤壮水，芍药甘草汤缓急柔肝，3 剂而解。

2 水寒不藏龙 无根之火上扰

李可认为，肾水寒于下，逼真火浮游于上，亦可致成火不归原之证（241 页）。下面看一则水寒不藏龙案：

齿衄 王某，男，44 岁。腹泻日 3~5 次，月余不愈。近 1 周来，上下牙龈出血，红肿如柿色。舌红少苔，脉细肢凉，双膝尤冷。腰困不耐坐立，近日尤感气怯身软。证由泄泻日久，中阳大伤，脾失统血之能，且下焦肾气虚寒已露，火不归原。拟四君补脾，三仙炭止血，七味益肾，骨碎补、肉桂引火归原：党参、焦术、茯苓各 30g，炙草、姜炭、三仙炭各 10g，熟地、砂仁各 10g，山药、山萸肉各 30g，五味子、泽泻各 10g，骨碎补 12g，肉桂冲服 3g。二诊：6 剂后泻止，牙龈肿敛，出血亦止。原方守服 3 剂善后（297 页）。

按 此案牙龈出血，红肿如柿色，舌红少苔，脉细肢凉，膝冷腰困，证属肾

气虚寒，无根之火上扰。李氏喜用引火汤加肉桂，温脏敛阳。但本例病人，脾虚泄泻，中阳大伤，故改为四君补脾，七味益肾，骨碎补、肉桂引火归原。

3 阴盛格阳 浮阳上越

所谓**格阳证**，是指阴寒内盛而格阳于外；**戴阳证**，是阴寒下盛而格阳于上。《伤寒论》中的通脉四逆汤证、白通加猪胆汁汤证，便是格阳、戴阳之明证。二者均为上热下寒证，与龙雷之火有相近之处，故不少医家把格阳、戴阳之治法称为“**引火归原**”。李可也有这方面案例，例如：

阴盛格阳 赵某，女，29岁。因无故头面阵阵发热，服升阳散火汤1剂，变为心悸、气喘、自汗，头面轰热不止，面色嫩红，烦躁欲寐，足膝冰冷，多尿失禁，脉微细而急，120次/分。本属阴盛格阳，误作上焦郁火而投升散之剂，致有此变。幸在壮年，未致亡阳暴脱。予白通加人尿猪胆汁汤，破阴通阳为治：附子、干姜各30g，葱白3节，童便、猪胆汁各1杯对入，2剂。次日来告，上药服1剂，心悸喘汗均止，足膝已热，月余之轰热证亦罢。本病病机，为下焦阴寒独盛，格拒真阳不能回归宅窟而浮越于上，故见种种上热假象。以白通汤破阴通阳，因有假热在上，以人尿猪胆汁之苦咸寒为反佐，热因寒用，宣通上下，消除格拒，引浮越之阳归于下焦而病愈（187页）。

按 李氏在本案中指出，因有假热在上，以人尿猪胆汁之苦咸寒为反佐，热因寒用，宣通上下，消除格拒，引浮越之阳归于下焦。“引浮越之阳归于下焦”实际就是“引火归原”。

肺结核合并肺心病（戴阳危证） 英某，女，68岁。传染科住院病人，诊断：肺结核；肺气肿合并急性感染。经抗结核、抗菌治疗无效，请中医协治。李氏诊见双颊艳若桃花，双目神采外露，发热烦躁，咳喘月余。盗汗，渴喜热饮，双膝极冷，心动神摇，六脉细数无伦，心率132次/分，舌淡。患者年近古稀，肾元久虚，复加久病耗伤，过服清热凉剂，致成上盛下虚戴阳格局，有欲脱之虞。急急固肾敛肝，引火归原，纳气归根为治：山萸肉90g，红参（另炖）15g，龙牡、白芍各30g，炙草15g，油桂3g（米丸吞），附子30g。上药连服3剂，脱险，出院回家调养（23页）。

李按 此戴阳为下元虚极，真阳不能下守，浮游于上，阴盛格阳之危候。又因过用秦艽鳖甲之类，开破肝气，致肝虚不敛。故用参附龙牡救逆汤合来复汤（山萸肉90g，红参15g，龙牡、白芍各30g，炙草15g），加油桂固摄下焦、温纳浮阳，重用山萸肉敛肝固脱（23页）。

4 八脉失养 冲脉上攻

李可认为，**奇经八脉病有两大特点**，一是久治不愈的“**频发痼疾**”；二是“**定时发作**”类病证。经方桂枝加桂汤是治疗奔豚症（冲脉病变）的特效疗法（194页）。因奇经八脉病有定时发作和冲脉上攻等特点，与龙火上奔有相近之处，故

在此举例证之：

奇经频发痼疾 赵某，女，45岁。1周前晚8时，忽觉舌根部如电击样麻辣，抽搐，口不能言，继而双腿从踝部以上，震颤抖动不止，寒战嘎齿，不能自制，10余分钟后渐止。此后，每晚8时，准时发病。心荡神摇，恐惧殊甚。脉急而细，120次/分。舌红、口渴喜热饮。西医诊为癔病，用药3日不能控制，请李可诊治。询知患者5年前暴崩几死，久病耗伤，损及于肾，肾阳虚不主温煦，寒由内生。肾之经络络舌本，寒主收引，故舌根麻而抽搐；肾在变动为“栗”，在志为恐，故震颤抖动，无故恐惧；肾精不充，血海空虚，八脉失养，故有此变。予温氏奔豚汤（附子、肉桂、红参、沉香、砂仁、山药、茯苓、泽泻、牛膝、炙甘草），重用附子50g、油桂10g，壮命门之火，加芪归阿胶益气养血，**龟鹿胶填充八脉**，龙牡磁石摄纳上下而定志。煎取浓汁300毫升，于每晚7时病发前1小时顿服。药进1剂，发作停止，3剂后痊愈，予培元固本散1料治本（386页）。

按 本案每晚8时准时发病，双腿震颤，舌根麻辣，寒战嘎齿，不能自制。证由5年前暴崩欲死，损及于肾，八脉失养。故以温氏奔豚汤壮命门之火，龟鹿胶填充八脉，芪归阿胶益气养血，3剂而愈。

5 火不归原证的特点

李可认为，**龙雷之火是脏腑内生虚火**，与六淫外感实火大不相同。龙火上奔，多见种种上热见证，如头痛、头晕、耳痛、齿浮、齿衄、目赤如鸠、面赤如醉、心悸暴喘，耳鸣如潮、口舌生疮、咽痛如灼等（240页）。现根据其医案，归纳以下内容：

5.1 火不归原发病特点

龙火上燔有两大特点：①交节病作、遇阳则动：李可指出，龙雷之火随阴阳盛衰之年节律、日节律演变，如冬至阳生则病，春令阳升转重，夏至阴生渐缓；日出病作，日中病甚，日落病缓，入夜自愈（240页）。如“鼻衄奇案”，病发冬至时节，清晨4时突然鼻衄出血（279页）。②来势暴急、顷刻突变：李可说，龙火上燔往往来势暴急跋扈，如迅雷闪电，顷刻突变（241页）。如“白塞氏综合症案”，其口腔、外阴溃疡，每逢冬至当日立刻发病，一两分钟即令人不能忍耐（291页）。

5.2 火不归原证候特点

火不归原证候，可以这样概括：头面五官赤痛衄，上热下寒热上攻，尿多不渴膝独冷，舌红无苔脉大洪。下面分别论述：①头面五官赤痛衄：证见头痛、头晕、面赤如醉、耳鸣如潮、鼻衄、咽痛如灼、舌衄、口舌生疮，齿痛、齿浮、目赤如鸠、白睛溢血、心悸暴喘等（241页）。②上热下寒热上攻：热势轰轰，或由脚底，或由脐下，上攻头面，按火不归原治速效。外感无此现象，误用苦寒直折则危（241页）。③尿多不渴膝独冷：下寒常见膝冷、尿多不渴，还见腰困、足膝软弱等肾虚之证。全书火不归原案约20例，其中膝冷者12人，多尿者5

人，不渴者 3 人。从中可见“膝冷”在辨证中的重要位置。笔者还注意到“膝冷”有轻重之别，轻者为自觉膝冷，重则膝扣如冰（280 页），或足膝扣之如冰（288 页）。④舌红无苔脉大洪：全书火不归原案，舌红无苔者 12 人，脉洪、或大、或洪大者 12 人。故此舌脉应为龙火上燔的指证。

6 火不归原分型论治

6.1 火不归原基本型 李可把火不归原分为两个基本证型：水浅不养龙，阴虚于下，则火失其制而离位上奔；水寒不藏龙，逼真火浮游于上，致成火不归原之证。病机既明，当用“甚者从之”之法。水亏者，以引火汤壮水敛火，导龙归海；水寒者，以引火汤加油桂饭丸先吞，温脏敛阳、引火归原（241 页）。笔者理解，水寒不藏龙是在水浅不养龙基础上发展的，其主要指证是双膝冷甚（363 页），它不是实寒、阴证，而是虚寒、阴损及阳。如“齿衄案”，李氏明确指出是下焦肾气虚寒已露，用七味地黄益肾，骨碎补、油桂引火归原（297 页）；“虚寒性糖尿病案”，阴虚于下，水浅不养龙雷，故目赤轰热；阴损及阳，命火衰微而津液不能上达，故饮多；肾失统束而膀胱失约，故尿多。治以引火汤加肉桂、山萸肉、红参、胡桃等滋阴助阳、引火归原（55 页）。明清医家多用七味都气丸、七味地黄丸治水亏者，用八味地黄丸治水寒者。而李可却喜用引火汤加肉桂，其原因何在？笔者分析：①引火汤乃滋阴大剂，熟地用至 90 克，力量专一，取效甚捷。如癌证化疗、放疗损伤肾阴，而见头面升火之火不归原证，引火汤两剂必退（363 页）。②引火归原用巴戟 30 克，五味子 6 克，油桂 3 克，寓有“阴中求阳”之意。其中肉桂米丸先吞，取于乌梅丸之法，专用于下焦痼疾，最宜深究。

6.2 火不归原变通型

对于火不归原兼脾虚泄泻者，用引火汤易增加腹泻，故李氏改用四君子合七味地黄汤变通。详见下面案例：

复发性口腔溃疡 燕某，女，29 岁。口舌生疮 6 年，1 月数发，时愈时作。近 1 月来，因流产后恣食瓜果生冷，复因暑热，夜睡不关电扇，门窗大开，又遭风寒外袭，遂致身痛呕逆，食少便秘。外感愈后，口舌于今晨突发白色丘疹一圈，灼痛不可忍。按脉细弱，舌淡欠华，面色萎黄，腰困膝软，此属肾虚脾寒、虚火上僭。《证治准绳》治此类口疮，用四君七味（六味加肉桂）合方加玄参、细辛，极效。但本例病人，脾胃气弱殊甚，寒凉滋腻不可沾唇，变通如下：红参（另炖）10g，焦白术、茯苓各 30g，炙草、姜炭、细辛各 10g，油桂 1.5g（饭丸先吞），肾四味各 15g，3 剂。二诊：诸证均愈。予补中益气汤加肾四味（枸杞子、菟丝子、补骨脂、仙灵脾）、胎盘粉 5 克（冲），10 剂，培元固本，以杜再发（286 页）。

按 此方为四君理中汤培土敛火，肾四味、肉桂引火归原，加细辛火郁发之。李氏凡遇火不归原证而脾胃虚弱之病人，即投上述变通方，皆效。

7 引火归原有狭广二义

自明清以来，温补派医家在临床上频繁应用引火归原法，用于阴虚、阳虚、阴盛、戴阳、格阳等，其方法有内服、外敷、噙含等，使得该理论有些泛化，造成诸多认识上的混乱。笔者认为，探讨引火归原的内涵与外延，应认清以下有关问题：

7.1 上热下寒之真假

为了说理方便，可把与引火归原有关的上热下寒证，分为真寒假热和真寒真热。上热下寒之真寒假热证，主要指格阳与戴阳，《伤寒论》中的通脉四逆汤、白通加猪胆汁汤证，便是明证。上热下寒之真寒真热证，主要指龙雷之火，上热与下寒俱真，皆为离位之火上移所致。

7.2 上热下寒之从治

引火归原，是根据《内经》“甚者从之”引申而来的。所以，认清上热下寒之从治有哪几种情况，也是必要的。水浅不养龙，用壮水敛火法，属于“寒之而热者取之阴”，为从治；水寒不藏龙，用温脏敛阳法，属于“热因热用”，为从治；格阳、戴阳证，用四逆辈破阴回阳，属于“热因热用”，为从治；格阳、戴阳证，用四逆辈热药冷服、或加猪胆汁苦寒反佐，为反治之妙也。

7.3 火不归原证

火不归原为病因病机，亦为证候；而引火归原是治法。李可认为，水浅不养龙，阴虚于下，则火失其制而离位在奔；水寒不藏龙，逼真火浮游于上，致成火不归原之证（241 页）。他在这里明确提出“火不归原”证候概念，即指水浅不养龙和水寒不藏龙。

7.4 引火归原法

笔者从李可之格阳、戴阳 19 例医案中发现：他从不称格阳、戴阳证为“火不归原证”，但有 3 种情况称格阳、戴阳证之治法为“引火归原”，如“阴盛格阳案”用白通汤加人尿猪胆汁（187 页）；“咽痛寒证案”四逆汤热药冷服（298 页）；“急性盆腔炎戴阳案”用四逆汤加肉桂 3 克（115 页）等，便是明证。格阳、戴阳证，由于里寒太盛，热药常被格拒不纳，所以要在热药中加入人尿猪胆汁苦寒反佐，或热药冷服，使同气相求，引阳药直入阴中，故称之为引火归原。至于四逆汤少佐肉桂的问题，还得从附子、肉桂的作用谈起。李氏在“温氏奔豚汤”一文中指出，温氏奔豚汤由附子、肉桂、红参、沉香、砂仁、山药、茯苓、泽泻、牛膝、炙草组成，是一首纯阳益火、救困扶危妙方。原方无剂量，李可经验：**君药附子，轻证温养用 10 克，大病阳衰 15~30 克，危急重证、破阴救阳 100~200 克；肉桂平剂温阳 10 克，火不归原用小量 3 克米丸先吞等**（372 页）。他在这里，只提肉桂为引火归原，而不提附子，这是为什么？因为格阳、戴阳证已见浮阳上越的现象，遇火（热药）即飞。所以像四逆辈、附子类热药下去，欲飞的浮阳就飞得更快。如何把壮火剂通过上热的关口，就是一个棘手的技巧问题。

附子偏于阳气，而肉桂独入血分，故引火归原只用肉桂，而不提附子。以肉桂为响导，3克米丸先吞，取其同气相求，引浮游之假热归于下焦，然后再服四逆辈治本，就不存在格拒问题了。笔者还注意到：李可对由内伤而来的戴阳（即素阴虚，而病患戴阳），多用四逆辈少佐肉桂，或附子剂少佐肉桂，如“肺结核合并肺心病戴阳案”（23页），“肺心病奇症案”（375页），“急性盆腔炎寒证案”（115页）等。

7.5 引火归原有狭广二义

火不归原证与引火归原法，格阳、戴阳证与引火归原法，既有联系，又有区别。为了理清它们之间的关系，笔者根据李可之上述理论，提出引火归原有狭广二义：①狭义引火归原：指火不归原证，即水浅不养龙（阴不抱阳）与水寒不藏龙（阴损及阳）；②广义引火归原：除了火不归原证，还涵盖格阳、戴阳之热药冷服，或热药反佐苦寒，或热药少佐肉桂等。前者（阴不抱阳、阴损及阳）之引火归原属于治法，而后者（热药冷服、反佐苦寒、佐用肉桂）之引火归原归于技巧。如“咽痛寒症兼齿衄案”中指出四逆汤热药冷服，古人称之为“偷渡上焦”，李可称之为披上“冷”的伪装，“骗”过咽喉一关，入胃则热性缓缓发挥，引浮游之假热归于下焦病愈（290页）。所谓“偷”、“骗”、“伪装”等都是同一个意思，即“巧诈法”。所以后者之引火归原，可称为巧诈法。③格阳、戴阳证与引火归原法：引火归原是格阳、戴阳治法中的一部分，只有上述3种情况可称为引火归原法，其它如格阳、戴阳之“足心发热案”（236页）、“重症呃逆案”（196页）、“阳虚型高血压案”等（383页），李氏均不称其为引火归原法，其旨义当细心揣摩。

8 火不归原的类证鉴别

火不归原证与格阳、戴阳、奇经八脉证有相似之处，鉴别起来有一定的难度。笔者根据李可之火不归原案20例，格阳、戴阳案16例，奇经八脉案5例，整理出以下鉴别要点：

8.1 火不归原与格阳、戴阳

火不归原与格阳、戴阳鉴别要点：①寒热真假：火不归原之上热下寒俱真，格阳、戴阳为真寒假热证。②交节发病：二者均为交节发病，但火不归原为遇阳则动，遇阴则静；而格阳、戴阳为遇阴则动，遇阳则静。如“足心发热案”，日轻夜重（236页）。③暴急突变：火不归原证，来热暴急，顷刻突变；而格阳、戴阳证，虽屡误治，却无急变，详见“咽痛寒症案”（298页）。④面色特征：火不归原之面赤如醉，即色红鲜艳。如“倒经衄血案”（281页）；格阳、戴阳之面赤如妆（亦称艳如桃李、艳若涂丹），即面色嫩红，如“抱儿痲案”（304页）。其中“妆”字最耐寻味，已含有假象之义。⑤附子用量：火不归原之阴损及阳型，其附子为小剂，如“舌衄案”引火汤加附子10克（296页）；而格阳、戴阳之附子，多为大剂（30克以上），如“重症呃逆案”之附子为30克（196

页)。

8.2 火不归原与奇经八脉

火不归原与奇经八脉鉴别要点：①定时发作：奇经八脉痼疾，多为八脉皆虚，阴损及阳，肝肾阴寒夹冲脉上攻，故遇阴则动，遇阳则静，如“奇经频发痼疾案”每晚8时准时发病（386页）。而火不归原则正好相反，遇阳则动，遇阴则静。②病势上攻：火不归原为**热势上攻**，每自脚底、脐下而起；奇经八脉证为**冷气上冲咽喉**，多从双脚外侧、脐下而起。③附子用量：火不归原之阴损及阳型，其附子为小剂；而奇经八脉之附子，多为大剂，如“奇经频发痼疾案”3个病例中，附子均为30~50克（384页）。下面看一则火不归原鉴别案：

咽痛寒症 王某，男，50岁。患咽干痛、口舌生疮，用清心火、滋肾阴正治诸法，服药60余剂，六神丸、梅花点舌丹各1瓶，皆无效，渐渐食少、便秘、神倦，缠绵3月不愈。邀李可诊治，询知其症日轻夜重，不渴尿多，双膝冷痛，脉沉细，舌淡润。来势缓，虽屡屡误治，却无急变。知非火不归原证型。四末不温，非极烫之水不喝，直断为少阴真寒证。缘由少阴之脉循喉咙，挟舌本。若肾宫寒极，逼其火浮游于上，则成上假热、下真寒格局。宜与温少阴、逐里寒：炙草60g，干姜30g，附子30g，桔梗、益智仁各10g，水煎冷服2剂。二诊：药后诸证已减七八，原方续进2剂，痊愈（298页）。

按 本案从火不归原与戴阳证之寒热真假、交节发病、暴急突变、附子用量等方面进行鉴别，层次井然，细致入微，不能不令人折服。

李可研究火不归原的思路，现简要归纳如下：**火不归原证的概念；火不归原证的特点；火不归原分型论治；火不归原类证鉴别；引火归原有狭广二义。**

血证关键在脾胃

——李可学术思想探讨之四

简介：针对见血止血和苦寒止血问题，进一步探讨了李可学术思想。李可之血证分型：胃气上逆，血热妄行；脾气不升，血失统摄；肝不藏血，血热妄行；火不归原，上热熏蒸；肾不封藏，气随血脱；阴损及阳，阳微欲绝。李氏之血证论特点：血证关键在脾胃；重要一环肝传脾；气随血脱肾不固；阴损及阳阳欲绝；善后固本拔病根；选方用药偏于温；四炭三七平淡神。

关键字：血证 分型论治 特点 李可 医案

出血证是血液不循常道溢出于外，中医术语称作“血液妄行”。治疗血证，首先应分别出血部位。因为鼻出血和大小便出血的内脏和病因不同。一般以血得

热而妄行，清血比较多用。又因急则治标，故多用收涩法。但失血原因并不简单，不是凉血涩血所能包括的，因而有用温补法，如黄土汤治便后下血。有用益气法，如当归补血汤治崩漏不止。虚火上浮的吐血，还可用引火归原法，方如肉桂七味丸。李可在前人血证理论上，对血证的病因病机、治疗规律，进行系统整理和发挥。笔者根据李氏之血证医案近 30 例，整理出以下内容：

1 见血休止血

前人有“见血休止血”之说，意思是出血只是表面现象，酿成血证有寒热、虚实、上下之分，不探求其本源，仅用止血法是不起作用的。李可认为，**见血止血为血证大忌**，也是医者易犯的通病。治血如治水，一味堵涩，愈补愈瘀，必致冲决堤坝。见效于一时，遗害于无穷（125 页）。下面看一则见血休止血案：

脑出血合并眼底出血 一农妇，37 岁。患原发性高血压 18 年，由于暴怒引发蛛网膜下腔出血，昏迷 48 小时，醒后暴盲。诊见寒战、咳逆无汗，查颅内血肿、水肿，双眼底出血、水肿。眼科名家陈达夫云：凡目疾，无外症而暴盲，为寒邪直中少阴，玄府（毛孔）闭塞所致，当用麻黄附子细辛汤温肾散寒。李可见此妇禀赋素壮，证见寒战无汗，纯属表实，与少阴无涉，遂径与麻黄汤一剂令服。次日诊之，夜得畅汗，小便特多，8 小时约达 3000 毫升，头胀痛得罢，目珠胀痛亦止，目赤亦退，血压竟然复常，已可看到模糊人影。又以通窍活血汤冲服水蛭末 12 克，调理一段，终于复明，左、右眼视力分别为 1.2、0.8（《中国中医药报》2005.8.4）。

按 中医虽无“蛛网膜出血”这样的病名，但患者寒战无汗，纯属表实。病机既合，投一剂麻黄汤之后，夜得畅汗，头痛得罢，目赤亦退，可看到模糊人影。前后诊治，竟无一味止血药，却“效如桴鼓”。可见，中西医结合，绝对不能“对号入座”。

2 血证分型论治

李可把血证分为 6 个基本证型，一个变通型，2 个善后方。现分别论述如下：

2.1 胃气上逆 血热妄行

李可认为，胃失和降，气逆而为火，火性炎上，血热妄行，血从上溢则病吐衄。证见面赤气粗，口苦苔黄，脉象数实。此时急以旋覆代赭汤加炙枇杷叶 30 克，降肺胃之气。气有余便是火，气降则火降，血自归经（125 页）。下面举例证之：

肺结核大咯血 董某，男，36 岁。患肺结核 10 年，3 年来不断发生大口咯血，频咳不止，胸痛，神疲，住院 7 日，未能控制。每次大咯血约 200 毫升，现仍频频咳喘，面赤气粗，胸痛彻背，脉洪大，舌红尖赤，边有瘀斑。每次犯病，即用针剂止血，血虽暂止，胸膈积瘀已甚，难免堤防溃决，不可收拾。肺胃以降为顺，今气火冲逆，有升无降，血热妄行，咯血不止。但降其气，气降则火降，

血自归经。血证不可一味兜涩，于止血之中行瘀、化瘀：旋覆花 12g（包），代赭石 30g，瓜蒌 30g，薤白 15g，生半夏 30g，姜汁 1 盅（对），丹参 30g，檀降香各 10g，炙枇杷叶 30g，桃杏仁各 15g，甘草 10g，童便、韭汁各 30 毫升对入，“三七 5g、白芨 10g”研粉煮糊加红白糖服，3 剂。二诊：血止，病象显露，面色苍白少华，拟培元固本散善后（310 页）。

按 患者肺胃气逆，血热妄行，咯血不止，以旋覆代赭汤加炙枇杷叶，但降其气，气降则火降。又每次犯病，即用针剂止血，血虽暂止，胸膈积瘀已甚，证见胸痛彻背，舌有瘀斑，故用瓜蒌薤白合丹参饮加味。

2.2 脾气不升 血失统摄

李可指出，脾气不升，则血失统摄而下出，而病崩漏便血。证见少气懒言，面色萎黄，甚则苍白欠华，脉多细弱，寸部尤弱。急以补中益气汤重用黄芪，峻补其气，加四炭温经止血，红参、五灵脂等量研粉益气止血、化瘀。脾气渐旺，自能摄血（126 页）。兹举其病例如下：

青霉素过敏后血崩 张某，女，48 岁。3 天前青霉素过敏休克，急以毫针刺素髀穴，行雀啄术苏醒脱险。然暴受惊恐，气短身软不能起床。前日适值经期，遂致暴崩不止，经妇科抢救，仍淋漓不断，邀李会诊。见患者面色苍白，气喘自汗，食少头晕，心动神摇。血色鲜红无块屑，脉沉细弱，舌淡红。此由惊则气乱，恐则气下，脾胃气虚下陷不能摄血，陷者举之：生芪 60g，当归 20g，煅龙牡、朱茯神各 30g，山萸肉 60g，姜炭、三仙炭、红参（另炖）、灵脂、炙草各 10g，柴胡、升麻各 6g，鲜姜 5 片，枣 6 枚，3 剂。二诊：血止，脉起，食纳好，隐隐头痛不休，此由血脱气陷，血不上荣所致，予补中益气汤 3 剂而愈（123 页）。

按 此由惊恐而起，惊则气乱，恐则气下，脾胃之气随之下陷而不能摄血，治以当归补血合补中益气汤加减，3 剂血止，脉起。

2.3 肝不藏血 血热妄行

李可认为，血证初期，多见肝不藏血，血热妄行。证见血上溢或下出，势急量多，面赤气粗，暴躁易怒，头晕胁痛，口苦脉弦数。以丹栀逍遥散舒肝之都，炙枇杷叶 30 克清金制木；生地、阿胶，滋水涵木，凉血养血，止血柔肝，赭石降气抑火平木。栀子炒炭减其苦寒之性，又能入血泻火而止血。煨姜易姜炭 3 克以护胃气，加三七粉 6 克吞服，止血化瘀不留瘀，最是血证妙药（126 页）。现附验案，以为佐证：

乳衄 刘某，女，34 岁。双乳房憋胀窜痛半年多，渐见乳头内陷，乳房萎缩。挤压乳房有粘稠之黄臭液及鲜血溢出。近来乳衄频发，变为有恶臭味之黑血，每次可淹湿一条毛巾。兼见胁肋胀痛，带多黄臭。曾去省医院检查，不能确诊，建议手术切除双乳，免除后患。邀李氏商治，询知病由长期气恼所致，诊脉弦。七情内伤，肝失疏泄，五志过极化火、化毒。拟疏肝解郁，通络化瘀，解毒化湿为治：柴胡 15g，归、芍、茯苓、白术各 30g，丹皮 15g，栀子 10g，酒炒龙胆草 10g，苡仁 30g，苍术、黄柏、川牛膝、橘络、炮甲珠、六路通、甘草各 10g，漏

芦 12g, 公英 90g, 连翘、王不留行各 30g, 贯众炭 5g 研粉冲服, 车前子 10g (包), 鲜姜 10 片, 枣 10 枚, 10 剂。二诊: 服 7 剂后出血止, 带亦减。10 剂服完诸证悉除, 且内陷萎缩之双乳亦渐形丰满, 2 年后生一子 (119 页)。

按 此由气恼所致, 证见乳房憋胀窜痛, 乳衄频发恶臭之黑血, 带多黄臭。当属肝郁化火、化毒, 治以丹栀逍遥合四妙散加味, 疏肝解郁, 解毒化湿, 通络化瘀。7 剂后血止、带减, 10 剂后诸证悉除。

2.4 火不归原 上热熏蒸

李可指出, 火不归原, 上热熏蒸, 势急如焚, 面赤如醉, 白睛溢血, 鼻衄, 舌衄, 吐血, 口舌生疮, 目赤如鸠, 比之实火尤为暴急。以腰困如折, 双膝独冷, 尿多不渴为辨。乃肾阴亏极, 逼龙雷之火上奔无制, 以大剂引火汤加肉桂 3 克米丸先吞, 引火归原 (127 页)。对于火不归原兼脾虚泄泻者, 用引火汤易增加腹泻, 故李氏改用四君合肉桂七味丸变通。下面举例证之:

齿衄 王某, 男, 44 岁。腹泻 3~5 次。月余不愈。近一周来, 上下牙龈出血, 红肿如柿色。舌红少苔, 脉细肢凉、双膝尤冷。腰困不耐坐立, 近日尤感气怯身软。证由泄泻日久, 脾阳大伤, 且下焦肾气虚寒已露, 火不归原。拟四君七味加减: 党参、焦术、茯苓各 30g, 炙草、姜炭、三仙炭各 10g, 熟地、砂仁各 10g, 山药、山萸肉各 30g, 五味子、泽泻各 10g, 骨碎补 12g, 油桂 3g。二诊: 6 剂后泻止, 牙龈肿敛, 出血亦止。原方守服 3 剂善后 (297 页)。

按 此案牙龈出血, 红肿如柿色, 舌红少苔, 脉细膝冷, 证属火不归原。李氏喜用引火汤加肉桂, 温脏敛阳。但本例病人, 脾虚泄泻, 中阳火伤, 故改为四君补脾, 七味益肾, 骨碎补、肉桂引火归原, 投之皆效。

2.5 肾不封藏 气随血脱

李可认为, 肾不封藏轻症, 仅见腰困微喘, 自汗尿多不渴, 出血如注, 急以大剂当归补血汤加红参助元气, 重用山萸肉 90g, 敛肝固肾救脱, 加肾四味鼓舞肾气, 龙牡固摄肾气, 姜炭止血, 阿胶 30 克, 三七粉 3 克, 挽血脱之危 (127 页)。下面看一则肾不封藏案:

蛮补致崩 马某, 女, 30 岁。素有“功血”宿疾, 赴外地求医, 连服芪归、阿胶、龙牡大剂 10 余剂。至经期不行, 腹痛如绞, 次日暴崩, 一天下血一痰盂。3 日后, 变为淋漓不断又 7 日, 血色素 6 克, 面色萎黄无华, 自汗而喘, 心悸, 夜不能寐, 脉反洪数, 124 次/分。**血脱脉宜细弱, 大则病进, 恐有气随血脱之变**, 急固之: 山萸肉 100g, 生芪 30g, 当归 15g, 红参 10g, 五灵脂 5g, 白芍 15g, 沉香、四炭、炙草各 10g, 麦冬、五味子各 10g, 龙牡、磁石各 30g, 3 剂。二诊: 血止, 汗敛喘定。唯觉腰困如折, 原方制小其剂, 加肾四味 (枸杞、菟丝子、补骨脂、仙灵脾) 各 15 克, 胡桃 4 枚, 以固封藏之本。3 剂后诸证悉除 (125 页)。

按 此案素有“功血”宿疾, 连进芪归、阿胶、龙牡大剂, 蛮补致崩, 一天下血一痰盂, 血色素 5 克, 自汗而喘, 气随血脱, 急以来复汤、当归补血汤、生脉散复方大剂, 重用山萸肉, 以救危急。

2.6 阴损及阳 阳微欲绝

李可指出，**肾不封藏重证，出血如注，腰困尿多不渴，证见肾不封藏轻型，而见四末不温或四肢厥冷，神疲欲寐，大汗暴喘，气息微弱，脉沉迟微细，或反见数极无伦，七急八败，一分钟超过120次以上，为气随血脱，阴损及阳，阳微欲绝，生命垂危。**急投破格救心汤平剂，龙牡煅用，山萸肉加至120克，干姜改姜炭10克，三仙炭各10克，血余炭4克冲，生芪30克，当归15克，阿胶20克，或加熟地45克，以滋阴救阳，益气止血固脱（14、127页）。现附验案，以为佐证：

暴崩脱症 王某，女，42岁。突然暴崩，出血一大便盆，休克1小时许，面如白纸，四肢冰冷，气息奄奄，六脉俱无，下三部太溪脉似有似无，厂医注射止血、强心剂无效，现仍出血不止，被褥狼藉。遂从血脱亡阳立法，以破格救心汤合当归补血汤为治：山萸肉120g，附子100g，姜炭50g，炙草60g，煅龙牡、红参各30g（捣末同煎），生芪60g，当归30g，血余炭6g冲，2时50分边煎边灌，**并以大艾柱灸神阙**。3时30分血止，厥回脉渐出，黄昏时开口说话，夜1时索食藕粉、蛋糕，脱险。后以当归补血汤加红参、山萸肉、龙眼肉、肾四味、龟鹿二胶连服7剂始能起床，以红参、灵脂、三七、琥珀、胎盘、乌贼骨、茜草炭、肾四味，制粉服40日始康复，现仍健在，已70岁（124页）。

按 李可用破格救心汤合当归补血汤加减，治疗妇科大出血21例，其中晚期宫颈癌2例，子宫肉膜异位3例，更年期功血11例，原因不明暴崩5例，全部在8小时内脱险。

2.7 善后固本 以求根治

李氏认为，肝不藏血，血热妄行，以丹栀逍遥散加味。血止后，当养血柔肝，滋水涵木以治本，以七味都气丸之山萸肉为君，加枸杞子并三七粉蜜丸服（126页）。对于血证各型，善后均给予增减培元固本散1-2月，培补先天，修复受损脏器，重建人身免疫力，以求根治（12页）。详见“胃溃疡大出血案”（14页）。

3 李可血证论特点

根据李氏血证诸多医案，可以归纳出以下特点：

3.1 血证关键在脾胃

李可认为，治血如治水，补中兼疏导，引血归经则愈。血证的关键在脾胃，脾主中气，气为血帅，统血而主升；胃为水谷之海，统冲任而主降，为人体气机升降的枢纽。脾升胃降，血循常道（125页）。根据李氏之血证6种分型，可以看出脾胃的重要作用。如胃气上逆、血热妄行和脾气不升、血失统摄型，病的主脏在脾胃，勿需多言。肝不藏血、血热妄行型，多犯胃克脾，故用丹栀逍遥散舒肝，术、苓、草健脾，煨姜护胃。火不归原、上热熏蒸型，李氏又设置了“火不归原兼脾虚型”，以四君七味地黄丸加减变通，详见“齿衄案”（296页）。肾不封藏、气随血脱型，其病机为脾不统血、肝不藏血累及于肾，变为肾不封藏，生命之根本动摇，故用大剂当归补血汤加红参、姜炭益气温脾止血，重用山萸肉

90 克敛肝，加肾四味、龙牡益肾固摄。阴损及阳、阳微欲绝型，李氏又明确指出病机为脾肾阳衰，不能统摄血液，应投破格救心汤合当补血汤加四炭、阿胶滋阴救阳、益气止血固脱。以上可以看出，血证 6 型均与脾胃有关。根据李氏之血证医案，也可以看出脾胃重要作用，其全书血证医案 27 则，其中主脏在胃者 7 人，涉及脾脏者 13 人，可见“血证关键在脾胃”是言之有据的。

3.2 重要一环肝传脾

李氏指出，肝脏体阴而用阳，又为“生命之萌芽”，木能克土，若过用苦寒攻伐，损此萌芽，则虚化为脾不统血，病变又深一层矣！善于理肝，则可截断血证传变，实为重要一环（126 页）。下面看一则肝传脾病例：

乳衄 刘某，女，44 岁。乳衄 2 月余，由生闷气渐致两肋窜病，右乳结核如胡桃大，乳头溢出鲜血。每适经期，必头眩泛呕，血黑多块。常觉有一股热流从右肋下章门穴向乳房涌来，立即灼痛如针刺状，随即有鲜血溢出，轰热自汗，左侧亦有同感。每月经行 2 次，经量少则乳头出血必多。舌红无苔口苦，脉沉弦而数。脉证合参，必是七情内伤，肝气久郁化火。今见一旦动气，病必发作，明是木强侮土。疏泄太过，则肝不藏血；脾胃过弱，则不能统血。治法拟养脾胃之阴，清金制木而解胃之围，兼柔肝之体而敛其用：醋柴胡 10g，当归、白芍、生地、石斛、沙参、枸杞、山萸肉、乌梅各 30g，麦冬 15g，川楝子 10g，三仙炭各 12g，丹皮、黑栀子、炙草各 10g，3 剂。二诊：药后块消血止，但增多腹胀如孕状，视之，少腹鼓凸。神倦、腰困膝冷，舌红无苔，脉沉，右寸极弱。一诊见患者口苦舌红，遂用大剂养胃汤之甘寒，丹栀之苦寒，致损中下之阳，中气随之下陷，故有此变，医之罪也！遂改投大剂补中益气汤升提下陷，加肾四味温养肾命：生芪 60g，当归、白术各 20g，红参（另炖）、灵脂、炙草、三仙炭、柴胡、升麻、桔梗各 10g，陈皮 3g，肾四味 120g，鲜姜 10 片，枣 10 枚，胡桃 4 枚（打）。患者连服 9 剂，已痊愈，且腰困、经乱亦愈（120 页）。

按 患者服一诊方，药后竟块消血止，应当说疗效可观。但李氏鉴于又增腹胀如孕状，腰困膝冷，脉沉右寸弱，却进行检讨：“一诊见患者口苦舌红，遂用大剂养胃汤之甘寒，丹栀之苦寒，致损中下之下阳，中气随之下陷，故有此变，医之罪也！”深刻感人。

3.3 气随血脱肾不固

因气虚而血出不止，前人多用当归补血汤、黄土汤、固本止崩汤，均以甘温补中为主，佐以养血收敛。但李可认为，气随血脱，不仅仅是脾不统血，更重要的是肝气不敛、肾不封藏，证见血出如注，自汗微喘，腰困多尿不渴，除了应用大剂当归补血汤加姜炭外，还加红参助元气，重用山萸肉 90 克敛肝固肾救脱，肾四味鼓舞肾气，龙牡固摄肾气挽血脱。如“小儿白血病案”（367 页）。

3.4 阴损及阳阳欲绝

出血从阳虚论治，以“火神派”为杰出代表，清代名医郑钦安之血证诗可见一斑：吐血都传止血方，生军六味作主张；甘寒一派称良法，并未逢人用附姜。

血水如潮本阳亏，阳衰阴盛敢僭为；人若识得升降意，宜苦宜辛二法推。所以，“火神派”常用四逆汤，附子理中汤、甘草干姜汤治血证。李可治血证，亦从阳虚立法，但病机的着眼点不同。他说，各种大出血，突变四肢厥冷，大汗淋漓，面白如纸，气息奄奄等，此为气随血脱之甚者，是阴损及阳，脾肾阳衰，不能统摄血液，速投破格救心汤合当归补血汤加味（14 页）。在李氏看来，阴阳是相互依附的，阴没有了，阳也就没有了。故既用大剂当归补血汤加红参、阿胶滋阴，又用破格救心汤救阳。如“暴崩欲脱案”（123 页）。

3.5 善后固本拔病根

日久不止，反复大出血者，必损及于肾。在血证分型论治后，血虽止住了，但不等于治愈，日后多有复发。为了修复重要脏器病理损伤，再造人体免疫之功，李氏又研制了培元固本散：胎盘、鹿茸、红参、灵脂、三七、琥珀（392 页）。一般连服 40 天，即可拔除病根，如“暴崩脱症案”（124 页）。

3.6 选方用药偏于温

李可之血证 6 型论治，含苦寒、甘寒之剂，只有丹栀逍遥散和引火汤。对此，他在治疗效能不变的前提下，又采取了相应措施，把苦寒、甘寒之性降到最低点。如丹栀逍遥散，栀子炒炭减其苦寒之性，又能入血泻火止血；把煨姜改成姜炭，以护胃。对于引火汤，脾胃怯弱者，熟地可小其剂，或加砂仁拌炒，或改为四君七味地黄汤变通；或引火汤加肉桂，既可引火归原，又能反佐寒凉之剂，以护脾胃（347 页）。总之，李可之血证分型论治，方如旋覆代赭汤加味，补中益气汤加味，来复汤合当归补血汤加味，破格救心汤合当归补血汤加味等，选方用药均偏于温。

3.7 四炭三七平淡神

李可之血证 6 种分型论治，所用止血药为四炭、三七、血余炭。其血证医案 27 则，所用止血药为四炭、三七、血余炭、蒲黄、三芫、韭汁、大蓟、地榆、苈麻根、灶心土等，其中用四炭者 13 人，三七者 9 人。李可认为，四炭（炮姜炭、三仙炭）是治脾不统血要药，为山西中医学校温碧泉老师心传，平淡中寓神奇之效，百试不爽，颇堪倚重（126 页）；三七止血化瘀而不留瘀，最是血证妙药（126 页）。

以上从 7 个方面归纳李氏之血证论特点，其中前 5 条突出理论特色，后 2 条侧重方药特点。

李可血证学术思想，现简要归纳如下：李氏之血证分型：胃气上逆，血热妄行；脾气不升，血失统摄；肝不藏血，血热妄行；火不归原，上热熏蒸；肾不封藏，气随血脱；阴损及阳，阳微欲绝。李氏之血证论特点：血证关键在脾胃；重要一环肝传脾；气随血脱肾不固；阴损及阳阳微绝；善后固本拔病根；选方用药偏于温；四炭三七平淡神。

病证冲突当从证

——李可学术思想探讨之五

简介：针对中医治西医病存在先入为主和对号入座问题，进一步探讨了李可学术思想。李可治西医病思路：认清人、病、证三者之间关系；诸病当先解表；伏邪百日当引邪外透；以阴阳为纲，寒热虚实分型；针对个体特异性，一把钥匙开一把锁；面对西医急性炎症，也不要跟着“炎”字跑；不在病名上钻牛角，六经辨证统百病；万病不治求脾肾，不治之治最上乘。

键字：西医病 中医证 解表 透邪 寒热虚实分型 六经辨证 不治之治 李可医案

辨病与辨证相结合，是中医临床工作者普遍采用的一种形式。辨病，是指辨西医之病；辨证，是讲辨中医之证。随着中西医结合的不断深入，多数人认为中医在宏观、定性、动态方面的研究有独到之处，但在微观、定量、静态方面的研究似有不足。而从中西医结合的现状来看，大部分地方是西医诊断，中医用药，按图索骥，对号入座。李可对此有截然不同的做法。现根据其诸多医案，整理出以下内容：

1 认清人、病、证三者之间关系

1.1 人与病

自古以来，中医就认为，从人体与疾病来说，人体是本，疾病是标。但是，由于时代的原因，中医所谓的“病”，大多是以证状来命名的，如咳嗽、胃脘痛、哮喘等等。那么，西医之“病”与人又是怎样的关系？李可认为，气化之理，总是以人为本，病为标。正胜则邪从热化、实化；正虚则邪从寒化、虚化（146 页）。下面看一则病从寒化之案例：

补法治痢疾脱症温某，女，50 岁。1975 年 8 月 7 日发病，起病即噤口，饥不能食，渴不能饮，水米不入，频频呕逆，痢下赤白相杂，腹痛后重，日夜不休，约 10 分钟 1 次，喘汗如油，肛脱不收，面赤如妆，心悸躁扰不宁，热势方张（39.5℃），声低神萎，舌胖齿痕，中有黄腻苔，脉大如波涛汹涌，重按则似有似无。询知患者已病休 10 年，素有晨泻之疾，时时昏眩倾倒，稍触风寒即感冒缠绵病榻，显系脾肾元气大亏，暴感时邪作痢，起病正气先溃，已见脱象。古人谓“痢疾脉大身热者死”，盖即邪毒盘踞，精血下夺，正气不能内守而外越，油尽焰高，倏忽将灭，确是危候。亟亟固脱为要：山药 120g，归、芍各 30g，山芋肉 90g，山楂 30g，红参（另炖）、石莲子、黄连、肉桂、炙草各 10g，龙牡各 30g，三

七粉 6g（冲），红白糖各 30g（冲入），姜汁 1 小盅（对入），2 剂。未服药前先点刺舌下金津、玉液，双尺泽放血，以泄其毒，呕势已平，服药安然入胃，至夜半子时，脉敛，痢止，安然入睡，次晨全好。

李按此病例发生于当年灵石疫痢流行高峰期，凡病皆然，殊少不同，“辟秽解毒汤”投治辄效。但本例病情蹊跷，从体质秉赋，察知同中有异。正虚则邪从寒化、虚化，正气无力与外邪抗争，初病即正气先溃，生命垂危。不仅用山药、红参之甘平益气滋液，且用山萸肉、龙牡之酸涩固脱，去邪仅黄连、三七、山楂，犹恐黄连苦寒伤胃，更辅以肉桂。所拟方即张锡纯氏“来复汤”加味（146 页）。

本案发生于疫痢流行高峰期，即有暴痢日夜不休，下痢赤白相杂，腹痛后重，高热 39.50℃ 等疫痢之征；又有喘汗如油，脱肛不收，面赤如妆，躁扰不宁，脉大如波涛汹涌等脱象。李氏根据正虚则邪从寒化、虚化，急投来复汤加味，2 剂而解。

1.2 病与证

李可从气化理论去把握人与病的关系，并进一步提出中医“证”的概念。他认为，**中医学的“证”，正是人体阴阳气血、五脏生克、气机生降——整体失调在患病阶段的主要矛盾的集中点。**其中包含了“个体特异性”，即同样的病，在不同的病人身上，有特异的表现，更是辨证的关键（39、116 页）。简而言之，中医之“证”是整体失调在患病阶段主要矛盾的集中点。那么，西医之病与中医之证又是什么关系？李可说，一切局部的病变，皆由整体失调所派生。故治“证”即是调节整体，整体康复，则局部的病变，常可奇迹般地不治而愈（39 页）。他一语道出了**中医之证与西医之病为主从关系**，其影响将是深远的。

1.3 人、病、证三者之间关系、

当西医之病与中医之证发生冲突时，应当怎么办？李可认为，**当中医之“证”与现代医学之“病”发生冲突时，要毫不犹豫地舍病从证。**中西医结合，中医没有现成饭可吃。在多数情况下，需要另起炉灶，独立辨证。有时甚至要反其道而行之（23 页）。下面看一则舍病从证案例：

小儿白血病程某，男，13 岁。由其父背来就诊。询知两月前突然高热寒战，体温 40.0℃，鼻衄如注，2 日不止，大便如柏油状。急赴山医三院，诊断：血色素 4 克，白细胞 36 万，急性粒细胞型白血病。经抢救脱险，但血色素 4 克，输血 1600 毫升无效，用化疗 2 疗程后，处于弥留状态。患者面色萎黄虚浮，唇指白如麻纸，眩晕不能坐立，纳呆日进食 1~2 两，五心烦热，心动震衣，自汗如洗，两目失神；舌如猪腰子，光降无苔而干，六脉浮弦搏指，一息七至以上。从脉舌形神见证，已属气阴两竭之死候。但不吐不泻，胃气未至败亡。李氏遂以当归补血汤、生脉散合方，重用参芪，加山萸肉益气固脱：黄芪 30g，当归、红参

（另炖）、麦冬、五味子、三仙炭、炙草各 10g，山萸肉、熟地各 30g，砂仁 10g，元肉、女贞子、旱莲草各 10g，阿胶 10g，生姜 5 片，大枣 6 枚，浓煎，小量多次分服。二诊：首剂得效，服 3 剂可起坐，服 5 剂可进食半斤，服 7 剂已能下床散步，服完 10 剂后，日可进食 1 斤多。不料前日忽然泛呕泄泻，脐下筑动应衣，喉中痰鸣如拽锯，下肢发凉，瑟缩畏寒，脉浮尺虚。此必久病伤肾，元阳不固，厥脱先兆。本应加鹿茸血肉有情之品，奈患者贫病交困，姑以肾四味代之，温养肾命，双补气血为治：黄芪 30g，当归、红参（另炖）、元肉、姜炭、三仙炭、炙草各 10g，炒白术、山药、炒谷麦芽各 30g，阿胶、生半夏、茯苓各 12g，肾四味 60g，生姜 10 片，大枣 6 枚。三诊：服 2 剂胃寒退，泻止脉敛，服 5 剂脐动隐，元阳固，可户外玩耍，10 剂后已如常人，血色素上升至 7.5 克，白细胞降至 11 万。效不更方，加参鹿膏 10g，10 剂。四诊：血色素上升至 9.5 克，白细胞降至 5 万 7 千，原方守服 7 剂后，血色素 11 克，白细胞 2 万 7 千。因贫困停服中药，予单味参鹿膏 150g，半月量。3 周后，血色素 12g，白细胞 19500。李氏嘱病家慎饮食，避风寒，以防不测。不料 1 周后，其母高热昏迷，买一大西瓜，病孩乘其父外出配药偷吃多半个（约 5 公斤），当夜腹痛作泻，急用大剂参附龙牡山萸肉，投剂不应，不幸夭亡。

李按小儿血白病类似“小儿急惊”。本例禀赋素虚，邪从寒化、虚化，初病即见正气先溃，气随血脱，奄奄待毙，复加化疗摧残，气血耗伤殆尽。当此生死存亡系于一发关头，则当急急固脱为先。一切攻癌解毒、苦寒败胃之品，毫末不可沾唇。经抢救 4 个月，服药 40 剂，未用一味抗癌药，终于降服白细胞，使血色素恢复正常。可见“以人为本”的思想，固护脾肾元气的治则，在癌症治疗中具有特殊地位（370 页）。

从中可看出，李可对**人、病、证三者**之间的学术倾向：①**以人为本**：气化之理，总是以人为本，病为标。②**证与病为主从关系**：中医之“证”是整体失调在患者阶段主要矛盾的集中点；一切局部的病变，皆由整体失调所派生。③**病证冲突当从证**：当中医之“证”与西医之“病”发生冲突时，要毫不犹豫地舍病从证。治证即是调节整体，整体康复，则局部的病变，常可奇迹般地不治而愈。

2 诸病当先解表

李可指出，《内经》明示“上工救其萌芽”、“善治者，治皮毛”。凡病，但有表证便当解表为先。外邪侵入，先从皮毛肌表而入。此时，邪在轻浅表层，妥施汗法，开门逐盗，一服可解。如有正虚的据，则佐以益气、养血、滋阴、助阳等法（176、198 页）。他治西医病，**无论是急性病，还是慢性病，都反复提到“诸证当先解表”，即使是有数十年病史者，也不忘用解表法**，这令笔者眼界大开。下面看一则慢性久病而用解表法之案例：

肺间质纤维化张某，女，44 岁。20 年前，产后暴感寒邪，患咳喘，久治不

愈，凡节令交替或气候骤变必犯，逐成痼疾。近因感冒缠绵不断，终至喘不能步而住院。经省二院诊为“特发性肺间质纤维化合并肺心病”，用大剂激素疗法、吸氧等无效。心衰、呼吸衰竭日见严重，病危出院。诊见羸瘦脱形，面色青惨。两目无神，声哑无音，喘息抬肩，气息奄奄。唇指青紫，杆状指，下肢凹陷性水肿。喉间痰鸣漉漉，咳吐白痰涎沫。四肢厥逆，脉急而促，133次/分（频发房性室早搏）。舌胖，苔灰腻，两侧瘀斑成条。唯食纳好，胃气尚存，虽亡阳厥脱诸症毕见，尚有可挽之机。李氏遂以大剂破格救心汤救阳固脱为先，参蛤散纳气归肾，麝香辟秽，化浊痰，开上窍，以救呼吸衰竭，加开水急煎，昼夜连服3剂。二诊：服首剂的2/3，痉咳暴喘得罢，上肢回温，基本脱险。服完2剂，安睡约2小时。醒后痰鸣声一度消失，暴暗20余日，第一次发出声音。一昼夜用附子600g，指掌虽温而下肢冰冷如昔。近半年来，盛夏不离棉衣，自觉如入冰窑，背部似冷水浇灌。此次重病月余，始终恶寒无汗，全身如绳索捆绑。胸痛彻背，憋闷如窒。病虽20年，而小青龙证之主证不变。营卫闭塞，寒邪冰伏，少阴亡阳与太阳表实同见，成为本病一大死结。遂拟一方，师法麻黄附子细辛汤意，助元阳、开表闭：麻黄30g（单煎150毫升），细辛20g，附子200g，干姜25g，炙草60g，山萸肉120g，生半夏、茯苓、生姜各45g、葱白3寸，丽参20g、蛤蚧1对、麝香0.5g（研粉分吞）。服药选午前阳旺之时，以助正气。每次对入麻黄汁50毫升，得汗后止服。三诊：上午于9时服1次，至10时30分，仍无汗意。令缩短给药时间，加服1次，并以生姜末、红糖、胡椒粉煮汤1碗，热服以助药力。午时头部见汗，少顷颈项胸背皆得润汗，令去麻黄汁继服药液。四诊：药后表闭一开，真阳敷布，背部冰冷及全身如捆之感，一服而解。上肢厥冷已退，喉间痰鸣消失，唇指色转淡红，喘定，痉咳偶见一二次，小便增多，踝肿亦退。脉象缓和，80次/分，顽固性心衰及呼吸衰竭之危，得以解除。二日来吐痰甚多，胸中憋闷感亦大为松宽。可见汗法得宜，有助于人体正气来复，使盘踞肺络之湿痰死血，渐有外透之机。逐改方调治，以下从略（28页）。

按 本案病已20年，而小青龙汤证之主证不变。李可重用麻黄，1剂则表闭即开，真阳敷布，病由此使步入坦途。所以李可反复告戒我们：“**诸症当先解表**”，似乎是老生常谈，平淡之极。然而正因为它平淡，往往被医者忽略，而造成严峻局面。表居八法之首，凡兼挟外邪诸证，皆当以解表为先，开门逐盗，拒敌于国门之外，最是上策（198页）。

3 伏邪百日，当引邪外透

李可之经验，**凡久治不愈，反复发作的重病、顽症、痼疾，或交节病作类疾病，必有六淫外邪深伏**（22页）。李可之全书共246例医案，其中伏邪医案34则，占总数的14%，可视为常见病，即见于急性炎症，如急性肺炎高热抽风案（71）、急性结核性胸膜炎案（47页）、布鲁氏杆菌病急性心衰案（11页）；又见于慢性久病，如肺心病心衰案（8页）、风心病合并冠心病案（22页）、肺间质纤维

化案（26 页）、血栓闭塞性脉管炎案（64 页）。下面举例证之：

风心病合并冠心病 张某，女，40 岁。病史：风心病、冠心病、肺瘀血已 10 年。现证见心悸、气喘、咳血。动则尤甚。每进食必心中大动，故每届饭时，忧心忡忡。为免心跳，吃吃停停，一餐常延搁二三小时之久。心率常在 170～210 次/分左右。脉促，四肢厥冷，胸闷刺痛，唇、指、舌青紫。自汗淋漓，腰困如折，入夜不能左侧卧，否则呛咳喘悸不停。纵观诸证，为心之阴阳皆虚，阳虚偏重。拟炙甘草汤、参附龙牡救逆汤、丹参饮合方化裁，温肾回阴、通脉化瘀、滋液救心为治，21 剂。药后悸止、喘定、肢厥、紫绀消失。进食已不心跳，胸闷刺痛在服至 10 剂时痊愈。唯月初曾出现反复，穷追细问，始得知 10 年来每经期必感冒，每感冒一次，病情就加重。其症为月经前 1 日寒热如疟，呕吐耳聋，经净自愈。此乃六淫外邪久羁，由表入里，深入血分不能透达，即《伤寒论》热入血室之证，当因势利导，予小柴胡汤加味，提透血分伏邪：柴胡、红参（另炖）、五灵脂、川芎、酒芩、干姜、桃仁、炙草各 10g，丹参、当归、益母草、生半夏各 30g，赤芍 15g，泽兰、香附各 12g，黑芥穗 6g，生姜 10 片，大枣 10 枚，6 剂，每月经前一日连服 3 剂。药后，经前感冒得以根除。除风心病存在外，已无自觉证状，以固本散善后（20 页）。

按 本案重病 10 年，邪入血室即达 10 年。由于经期必感冒，新感引动伏邪，邪正交争而宿疾发作，便显示出病邪盘踞在血室之奥秘。乘伏邪之蛛丝马迹在此时暴露无遗之际，因势利导，一举破其巢穴。遂以一味黑芥穗之深入血分，加入小柴胡汤内，扶正达邪、和解表里，使 10 年伏邪得以外透，从此步入坦途。

4 以阴阳为纲，寒热虚实分型

李可认为，“病”可以有千种万种，但病机则不出八纲六经之范围（45 页）。他根据“**正旺则邪从热化、实化正虚则邪从寒化、虚化**”的原则，把一些西医病分为两个基本型，形成一整套行之有效的理法方药。如血栓闭塞性脉管炎分为阳虚寒凝与湿热化毒型（65），白塞氏综合症分为火不归原和湿热化毒型（291 页），美尼尔氏综合症分为脾不运湿和火不生土型（272、386 页），细菌性痢疾分为湿热秽浊与正虚欲脱型（144、145 页），红斑狼疮分为阴虚血瘀与阳虚血凝型（202 页），过敏性紫癜分为肝热妄动与脾不统血型（328 页），小儿白血病分为邪毒炽盛与气血两竭型（368 页）。下面举例证之：

白塞氏综合症张某，男，34 岁。病已 8 年之久，先觉左手掌鱼际部痒肿，随即上唇亦肿，口腔粘膜开始溃烂，紧接龟头亦痒肿，患处奇痒难耐，稍一搔之则其痛贴心。初病时寒热如疟，二三年后仅感目干涩不欲睁，思睡而难入睡，身体沉重困乏，辗转不宁。口苦粘腻，脉沉滑数。见证与《金匱》之狐惑病大同小异，不同处为：目不得睁，面部无黑白变化，痛痒极重。其病机属内蕴湿热，外受风邪引发。从清湿热解毒、驱风止痒立法，以四妙散加味进治：苡仁 45g，苍

术、黄柏各 15g，川膝、苦参、生地、白蒺藜各 30g，白藓皮 60g，胡黄连、甘草各 10g，丹皮、紫草各 15g，3 剂。服 1 剂，病退强半，2 剂痒止肿消，3 剂服完已了无痕迹。患者惜药，以药渣煎汤洗龟头，止痒消肿效果极好。一年后又因暴饮大醉，引发旧疾，即按所留旧方，内服外洗，2 剂而愈。追访 10 年来未犯

李按现代谓之“白塞氏综合症”，即《金匱》之“狐惑病”。余治湿热化毒型，用上方四妙散加味，经治 6 例 35 岁以下之青壮年患者，皆获根治。35 岁以上，病程旷日持久者，多转为引火汤证，虽不能根治，却见效迅速，使病人免除许多痛苦（293 页）。

5 针对个体特异性，一把钥匙开一把锁

李可治西医病，一方面以阴阳为纲，寒热虚实分型；一方面针对个体特异性，一把钥匙开一把锁，谨守病机，法随证变（330 页）。下面举例证之：

过敏性紫癜痼疾张某，女，52 岁。患过敏性紫癜 33 年，14 岁时，正值经期，正在洗头，被母追打，赤身跑出野外，遂致经断。当晚腹痛阵作，下肢发出青紫斑块多处。3 日后喝红糖生姜末，全身燥热，发际、身、目、鼻、口、喉、前后阴，痒如虫钻，发一身点、片、条状红疹而解。此后，年年不论冬夏发病 3~5 次、7~8 次不等。连生 8 胎，2 胎产后服生化汤 3 剂，竟 1 年未发。今次发病 3 日，正在出疹之际，腹痛如绞，抓搔不已。视之，右腿有紫斑 4 处，左腿 2 处，脐上到胸、背后致胯，红云片片。抓耳、挠腮、揉眼，奇痒如万虫钻心。脉沉数，舌红苔黄，边尖瘀斑成片。此症初病经期风寒外袭，邪入血室，暗结病根。日久化热，湿热与血凝结成毒，正邪相争则病作，是邪有外透之机，当因势利导，以乌蛇荣皮汤进治。方中桃红四物合桂枝汤养血化瘀和营，**丹皮紫草可代犀角**，更加青黛 10g，共奏清营化斑之效，**定风丹（首乌、白蒺藜）**养血祛风，**白藓皮清化血中湿热而止奇痒**，乌蛇扶正托毒治大风，加地榆 30g，白蔹 15g，清肠解毒敛疮，**以黑芥穗、皂刺深入血络，透发伏毒**，三七 10g 破瘀，直捣病巢。上方连服 10 剂，数十年痼疾竟得治愈。

按李可治过敏性紫癜分为肝热妄动与脾不统血型。肝不藏血、血热妄动型，常用桃红四物汤加丹皮、紫草、大蓟、青黛，清热解毒、凉血化斑，多数在半月痊愈。此例证情有别，初病经期风寒外袭，邪入血室，暗结病根。日久化热，湿热与血凝结成毒，当因势利导，以乌蛇荣皮汤调治，加皂刺、黑芥穗深入血络，透发伏毒。故李可又进一步指出，**上述二型，可互为演变。肝不藏血者，用过苦寒，损伤脾胃之阳，可虚化为脾不统血，亟亟改弦易辙，温脾统血**。脾不统血者，正气来复，可阴证转阳化热，大是佳兆，予补中益气汤内加知母 20g，大蓟 30g 即可。疾病变化万千，总是要以人为本，针对个体特异性，一把钥匙开一把锁（330 页）。

6 面对急性炎症，也不要跟着“炎”字跑

面对西医诸多的急性炎症，中医应采取什么态度？这是检验中医大夫是否发扬中医特色的试金石。李可认为，对急性炎症的治疗，当因人而异，不可把“炎”字理解为火上加火，不可一见血象高便恣用苦寒攻泻。由于体质禀赋的差异，血象虽高，证属虚寒者并不少见（116 页）。为此，笔者对李可的急性炎症医案做了初步统计，现归纳如下：①急性炎症概况：全书急性炎症案例 20 则（不包括外科急腹症），涉及 17 个病种。如急性黄疸型肝炎案（116 页），急性肾炎等案（161 页）。从实热论治者 7 例，如急性肺炎案（71 页）；从虚寒论治者 6 例，如急性结核性胸膜炎案（47 页）；从寒热错杂、虚实夹杂论治者 7 例，如肺心病急性感染案（18 页）。②急性炎症兼高热者：急性炎症兼高热者 9 例，从实热论治 6 例，如小儿急性腮腺炎案（81 页）；从虚寒论治 1 例，如细菌性痢疾脱症案（145 页）；从寒热错杂、虚实夹杂论治 2 例，如急性肾盂肾炎案（159 页）。③急性炎症兼血象高者：急性炎症兼血象高者 5 例，从实热论治 1 例，如急性中耳炎案（277 页）；从虚寒论治 2 例，如重症结核性腹膜炎合并急性胆囊炎案（55 页）；从寒热错杂、虚实夹杂论治 2 例，如慢性肾盂肾炎急性发作案（160 页）。下面看一则急性炎症从虚寒论治案例：

急性盆腔炎寒证耿某，女，33 岁。患者少腹两侧痛，拒按，黄带如注，秽臭。女检子宫前位，化验：白细胞 19500，中性 80。诊为慢性盆腔炎急性感染，转中医诊治。诊见胃中酸腐作呕，腰困膝冷，神疲欲睡，面色嫩红如妆。脉迟细，58 次/分，舌淡胖水滑。李氏分析：妇科虽诊为急性盆腔感染，而患者病情有异，不仅中下气化无权，且见浮阳飞越之戴阳危象。若妄用清热利湿之剂，难免顷刻生变。遂予少腹逐瘀汤合四逆汤，加党参、茯苓、泽泻、鸡冠花各 30g，附子 15g，油桂 3g（研粉冲服），引浮游之火归原，3 剂。二诊：服 3 剂，面赤如妆得退，腹痛止，带减，纳食已馨，两目有神，诊脉滑数，94 次/分。正气来复，加清热解毒之平和药公英 60 克清化，3 剂而愈。

李按《金鉴》外科云：“膏粱之变营卫过，藜藿之体气血穷。”古代中医早已认识到疾病的个体特异性。此例农妇，8 口人，6 个孩子，劳力少，生活困难，由劳倦内伤而致病，正气先虚，故多寒化、虚化。对西医确诊的病，中医仍需独立思考，深入剖析疑难，追根寻底，这样才能体现中医特色，恰合“人”情、病机，提高疗效（117 页）。

7 不在病名钻牛角，六经辨证统百病

李可认为，“病”可以有千种万种，但病机不出六经八纲之范围。伤寒六经辨证之法，统病机而执万病之牛耳，则万病无所遁形。正是《内经》“**知其要者，一言而终**”的明训，执简驭繁，万病一理。临证之际，不必在“病名”上钻牛角，不但不考虑西医的病名，连中医的病名也无须深究（45 页）。他这段箴言，从

“蛛网膜下腔出血”案中大彻大悟的。让我们来一起感受这一过程：

蛛网膜下腔出血 温某，女，27岁。怀孕5个月，突然剧烈头痛，喷射状呕吐，经急诊治疗两周，病势转重，邀李氏诊视。询知CT见“蛛网膜下腔出血”，颅内压居高不下，频频喷射状呕吐。近日多次发生短暂性抽搐，一度口眼歪斜，头痛如破，呻吟不绝，目赤气粗，呕吐稠粘痰涎及黄绿色苦水，其气秽臭。脉弦滑而劲，阵阵神糊。证属肝胃痰火上攻，气机逆乱，有升无降，内风已动，有蒙蔽神明之险，急则治标，予降气涤痰和胃降逆：赭石、怀牛膝、生半夏各30g，胆星、天竺黄、柴胡、黄芩、酒龙胆草、枳实、炙甘草各10g，白芍45g，珍珠母、茯苓30g，全虫5g、蜈蚣3条（研末冲服），生姜30g，姜汁10毫升（对入），煎取浓汁300毫升，小量多次缓缓呷服，待呕止，顿服安宫牛黄丸1丸。1剂后，头痛减，抽搐未发，神志已清。凌晨又见剧烈头痛约1刻钟，呕减而未止，吐出酸苦粘涎，脉弦滑较昨稍缓，舌上水滑，胃中觉凉。改投镇肝熄风汤合吴茱萸汤加减，重在降逆和肝胃：赭石45g，怀牛膝、生半夏、茯苓各30g，红参（另炖）、吴茱萸（开水冲洗7次）、炙甘草各15g，全虫10g，蜈蚣10条，生姜30g，姜汁10毫升。1剂后痛呕均止，颅压正常。仍予原方加减，侧重化瘀两剂，诸症均退，未见任何后遗症。唯输液一侧之下肢肿，予补阳还五汤调理而愈（45页）。

按 本例之剧烈头痛，在加吴茱萸汤后一剂而止。因吴茱萸辛苦大热，其气燥烈，李可在下笔之际曾有犹豫，恐不合于“脑出血”症。中医虽无“蛛网膜下腔出血”之病名，但患者头痛如破，剧烈呕吐，吐出物为酸苦涎沫，又自觉胃凉，正是**肝胃虚寒，痰饮上冲之吴茱萸汤证**，投之“效如桴鼓”，李氏由此悟出其中的道理。

8 万病不治求脾肾，不治之治最上乘

对待一个气息奄奄的痢疾病人，黄连、大黄沾唇必死，这时应该怎么办？李可指出，中医有“万病不治，求于脾肾”的论断，在危重疑难病的治疗上，确有起死回生之效。盖脾胃为后天之本，“有胃气则生，无胃气则死”。脾胃一伤，百药难施，故保护脾胃为第一要义。肾为先天之本，为人生命之主宰。内寄命门真火，为生命的原动力，五脏精气的源泉。故五脏之伤，穷必及肾，肾气败亡则生命终结。故凡治病，皆当首先顾护脾肾元气，勿使损伤。若已损伤，亟亟固脱救肾，醒脾救胃，使胃气来复，病人才有生机（307页）。下面看一则万病不治求脾肾案例：

久痢成癆 杜某，女，23岁，病危邀诊。病史：1年前患者因8个月男孩因病夭折，悲伤过度，食少形瘦。今春流产，失血过多，多次发生贫血性休克。夏末患痢，寒热如疟，日下脓血便10余次。服白头汤不效，又服葛根芩连汤12剂，病不减，反不能食。盛夏憎寒，不离棉衣，日渐消瘦，咳嗽盗汗。经X光透视见右肺浸润型肺结核。已闭经、卧床不起4个月。食少呕逆，咳喘自汗，脓血

便乃未止，每便秘脱肛。经抗痨药后食纳锐减，形容枯槁，眼眶塌陷，皮肤干瘪。一日数度晕厥，气息奄奄，病情危重。脉细数不乱，两迟尚能应指。病由寒痢误用苦寒损伤脾阳，邪陷入里成痼。延久损及于肾，生命根基动摇，已无实可攻。亟扶正固脱，醒脾救胃：红参（捣末同煎）、生半夏各 30g，山芋肉、山药各 100g，炙草 15g，生姜 10 片，煎取浓汁 300 毫升，对入姜汁一盅，一日内不分次数缓缓呷服。呕止后，改为日分 3 次服，3 剂。服 1 剂后当日呕止，服完第二剂后，汗敛喘定，知饥，索食藕粉 1 小碗，服稀粥 4~5 次。服完第三剂后，可日进食半斤许。患者已能半卧位，两目有神。脉虽细弱，但属有根。下痢脓血如前，未再休克。因呕止，原方去半夏，合补中益气汤：生芪 18g，红参（另炖）、白术、当归各 10g，柴胡、升麻、陈皮各 3g，肾四味各 10g，山芋肉、山药各 100g，炙草 15g，生姜 3 片，大枣 4 枚，胡桃 4 枚打，3 剂。药后已能起坐，日可进食七八两。便脓血、咳嗽、午后潮热不减。第 3 方咬定护元气，补土生金之法，原方加炒谷、麦芽醒脾，煅龙牡固脱。服 20 剂后，已能起床下炕游走几次，进食身有微汗，正气渐复，营卫通调而伏邪外透，痢疾不治而愈。效不更方，再进 20 剂，间日 1 剂。药后咳嗽、潮热止，月经来潮，可到户外活动。经 X 光检查，右肺结核已钙化，一年后生一男孩（305 页）。

按 李可治此案 2 个月，无一味治痢之药而痢愈；治小儿白血病 4 个月，未用一味抗癌药，终于降服白细胞，使血色素恢复正常。可见“以人为本”的思想，固守脾肾元气的原则，在万病不治的情况下，确有起死回生之效。故李氏又进一步指出，前人有“但扶其正，听邪自去”的说法，确有至理，它保住了病人的生命，调动了人体的正气（自然疗能）去战胜疾病，这就是中医的整体论，是中医学高层次辨证论治的经验总结，“不治之治”乃是治法中的最高境界（177 页）。

李可指出，中西医结合，是一个复杂的课题，当局者迷，有一生悟不透此理者，今特为点出（167 页）**首先从总体上把握好人、病、证三者之间关系，这是治西医病的原则：人是本，病为标；正胜则邪从热化、实化，正虚则邪从寒化、虚化；中医之“证”是整体失调在患病阶段的矛盾集中点，西医之“病”是局部的病变；当中医之“证”与西医之“病”发生冲突时，要毫不犹豫地舍病从证。其次是治西医病之七步：有表证者，当先解表；有伏邪者，当引邪外透；以阴阳为纲，寒热虚实分型；针对个体特异性，一把钥匙开一把锁；即使面对西医急性炎症，也不要跟着“炎”字跑；最后跳出病名的巢穴，超乎象外，以六经辨证统治百病；治法要独辟蹊径，万病不治求脾肾，“不治之治”乃是治法中的最高境界；走出一条中医自身发展的道路，去攻克世界性医学难题。**

肺癆陰陽氣血虛

——李可學術思想探討之六

簡介：針對肺癆甘寒養陰的傳統定法，進一步探討了李可學術思想。李可研究肺癆的思路：誤用清熱退蒸，險鑄大錯頓悟；肺癆病灶在肺，但波及肝脾腎；甘寒養陰傷脾陽，苦寒瀉火致戴陽；久病氣血大虛，脾腎元氣動搖；肺癆潮熱，乃肝脾腎虛極之假熱；當遵“勞者溫之”，理血痹治肺癆；重溫東垣《脾胃論》，補土生金探新徑；欲行補土生金，先得補火生土；肺癆夾寒飲者，反其道而行之。

關鍵字：肺癆 潮熱 病因 病機 治療規律 李可 醫案

回顧中醫史上，自丹溪創“陽有余陰不足論”600年間，歷代中醫皆宗其旨治肺癆，從“陰虛火旺”立論，滋陰降火定法。李可对肺癆的治療，有着正反兩方面的臨床經驗。現根據其醫案14則，整理出以下內容：

1 誤用清熱退蒸，險鑄大錯頓悟

李可在自學中醫的第7年，治1例肺癆宗丹溪“陰虛火旺”立論，結果險遭不測。這一深刻的教訓，使他終生不忘，並毅然脫離古人“滋陰降火”的巢穴，確立了“勞者溫之”，理血痹治肺癆的大法。下面讓我們來一起感受這一過程：

肺結核戴陽危症劉某，女，22歲。1963年5月23日初診：患干血癆3年多，經某醫院診為肺空洞型肺結核，病危出院。羸瘦脫形，四肢枯細，體重銳減20公斤。骨蒸潮熱，晝夜不止半个月。雙顴艷若桃李，口苦，舌光紅無苔而干，食少，干渴能飲，脈弦而數。古今醫家，皆謂“癆”為陽火灼陰，火炎水竭，真陰銷銹。尤以晝夜皆熱為重陽無陰，當亟瀉其陽，峻補其陰，乃選清骨散加龜板、黃芩、童便為治：龜、鼈甲（先煎）、地骨皮各30g，知母20g，銀柴胡、胡黃連、秦艽、青蒿、黃芩、炙草各3g，童便1杯對入，水煎分2次服。次日黎明，病情突變邀診。見患者呃逆頻頻，大汗肢厥，面如死灰，喘不能言，脈微欲絕。其母云：“昨日藥進一煎，患者即不思飲食。睡前服二煎，瀉稀便一次，隨即陣陣汗出，氣喘不能接續。半夜服參湯一杯，才勉強支持到天亮。”至此，余已知前方誤投。蓋患者雖在青年，但3年癆病，其陰陽氣血已耗傷殆盡。初診見其面若桃李，艷若塗丹，誤以為乃癆証必有征象，實則已是浮陽飛越之戴陽危象，當救陽固脫為先，反投清骨散，是為一錯。結果胡連、骨皮、知母苦寒敗壞胃陽，稀便一次，氣從下脫；銀胡、秦艽、青蒿之辛寒外散，多汗亡陽于上，尤以鼈甲一物，開破肝氣之力甚強，更促肝氣外泄，故藥後出現上下俱脫之危候。二錯在對脈學的书本式理解，“數”固主火、主熱，然當四診合參，全面分析，方不致誤。肺癆脈多數，瀕危之際，有一分鐘120~240次以上者，已是七急八敗之死脈，何來“火”與“熱”之可言！故**數脈變局中有“數則為勞，數則為虛”兩條。**

若非躬行实践，绝难领悟。逐急疏张锡纯氏来复汤合参附龙牡求逆汤，以救阳固脱：红参（捣末同煎）、附子各 30g，干姜 20g，炙草 60g，山萸肉 90g，龙牡、白芍各 30g。从煎沸 10 分钟后，频频喂服，余守护病榻，以大艾柱灸神阙，药进 5 次，约 200 毫升，半小时许，呃止、汗敛、喘定、厥回，幸得脱险（299 页）。

李按如此辛热燥烈大剂，其 3 年之久之骨蒸劳热竟 2 个月未发。足证骨蒸潮热，乃气血大虚，阳失统束之假热，绝不可见热投凉，见蒸退蒸。自此之后，余终生不用清骨散之类治骨蒸劳热之套方。

2 肺癆的病因病机

李可关于肺癆的病因病机，主要有以下几点：①肺癆病灶在肺，但波及四脏：肺癆为慢性消耗性疾病，本病病灶虽在肺，但上下四旁皆受波及，损及肝脾肾（310、314 页）；②甘寒养阴伤脾阳，苦寒泻火致戴阳：甘寒养阴 5 剂以上，胃口即倒，大便则稀；甚则苦寒泻火、清热退蒸，致成上盛下虚之戴阳格局（23、314 页）；③久病气血大虚，脾肾元气动摇：因久病气血耗伤过甚，损及脾肾元气，生命根本动摇（314 页）；④肺癆潮热，乃肝脾肾虚极之假热：肺癆阴阳气血耗伤殆尽，**潮热乃肝（肝虚失敛则寒热往来）脾（气虚则发热）肾（元阳外越）虚极之假热**（302 页）。下面看一则苦寒泻火致戴阳案例：

肺结核合并肺心病一老妇，68 岁。住院病人，最后诊断：肺结核；肺气肿合并急性感染。血沉 90 毫米，白血球 15650，中性 91，淋巴 9。经抗结核、抗菌治疗无效，请中医协治。诊见患者双颊艳若桃花，双目神采外露，发热、烦躁、咳喘月余。盗汗，渴喜热饮，双膝极冷，心动神摇，六脉细数无伦，心率 132 次/分，舌淡。患者年近古稀，肾元久虚，复加久病耗伤，过服清热凉剂，致成上盛下虚戴阳格局，有欲脱之虞。急急固肾敛肝，引火归原，纳气归根为治：山萸肉 90g，红参（另炖）15g，龙牡、白芍各 30g，炙草 15g，油桂 3g（米丸吞），附子 30g。上药连服 3 剂，脱险，出院回家将养（23 页）。

按患者年近古稀，肾元已虚，复加久病耗伤，又过用秦艽鳖甲之类方清热泻火，开破肝气，致成上盛下虚之戴阳败局，故用参附龙牡救逆汤合来复汤，加油桂固摄下焦，足证肺癆“苦寒泻火致戴阳”之病因病机。

3 重温东垣《脾胃论》，补土生金探新径

中医亦主张用培土生金法治癆病，这常用于**肺癆后期**，即脾胃虚弱为食呆、消化不良、大便溏泄；肺虚则气短、干咳、或痰中带血。此时补肺气则易生胀满，养肺阴又虑加腹泻。只有侧重脾胃甘平补中法，使后天生气充沛，则肺脏可得到滋养，方如参苓白术散。而李氏之补土生金法，是宗仲景“劳者温之”之旨，师东垣《脾胃论》之精义，以补中益气汤为基础方，探讨治癆新径竟达十年，终有所得。现附验案，以为佐证：

抱儿痲吴某，女，25岁。怀孕已5个月，因午后潮热，夜间盗汗，咳喘、痰多白粘，食少倦怠，诊为双肺结核浸润型，恐抗痲药伤害胎儿，特来中医科求治。诊见患者面色苍白，两颧艳若涂丹，虽在盛夏，畏寒特甚。呕逆食少，发生于最近半个月，乃结核中毒反应。腰困、少腹有坠胀感。脉大而虚，舌淡。有动胎之虞，用药颇多顾忌。拟补中益气汤合小半夏加茯苓汤，加肾四味、山萸肉、龙牡益气健脾、固肾护胎：生黄芪30g，当归、白芍各25g，白术20g，红参（另炖）、柴胡、升麻、苏梗、砂仁各10g，生半夏、生姜、茯苓、山萸肉、龙牡各30g，肾四味60g，炙草10g，姜汁10毫升（对入）。煎取浓汁300毫升，日分3次服，7剂。二诊：盗汗止，潮热退，咳喘已减十之七八，少腹已不坠胀，食纳增，精神佳，脉大之象已敛，唯觉掌心烦热。原方加乌梅30g，胎盘粉3g（冲服），7剂。三诊：咳止，痰已很少，腰已不困。近来食欲大增，面色红润，掌热已很轻微。原方10剂加山药30g，隔日1剂。四诊：诸证均退，以丸方治本：胎盘、山药各100g，冬虫草、红参、龟鹿二胶各30g，制蜜丸。每次1丸，2次/日。半年后复查，双肺结核已钙化，又足月顺产，母女均健（303页）。

按此案肺痲兼妊娠恶阻，故用补中益气汤合小半夏加茯苓汤；又少腹有坠胀感，恐有动胎之虞，佐入肾四味、逍遥散固肾、调气以安胎。

从李氏治肺痲诸案中，可以看出其补土生金有以下“新”义：①治痲有四本：病灶虽在肺，但上下四旁皆波及，故治痲有四本，即肺肝脾肾（310）；②“劳者温之”佐化瘀：治痲病当遵“劳者温之”之旨，师仲景血痹虚劳之意，在温补脾肾之中，佐以活血化瘀之法（309）；如“干血痲案”中加红参、灵脂益气化瘀，缓通血痹便是明证（302页）；③甘温除大热：肺痲潮热，从久病气血大虚、肝脾肾虚极之假热立论，以补中益气汤之大剂黄芪60g，山萸肉90g，乌梅、龙牡各30g，三五日转轻，半月退净（309页）；④**用药三禁一慎**：用药一禁燥烈，不得用燥剂治瘀；二禁伐气，不得用青枳肉蔻苏子破气之剂；三禁苦寒，不得用知柏芩连栀子泻火；慎用甘寒：阴分有亏者，李氏不用传统甘寒养阴药，而从补气、敛火药中筛选微温、平和兼养阴者，如山药、山萸肉、乌梅酸甘化阴、敛火固脱之品（310页）。

4 欲行补土生金，先得补火生土

李可认为，肺痲为久病气血耗伤过甚，损及脾肾元气，则根本动摇，危及生命。如何着手，颇费踌躇。万病不治，求之于肾。且肾中元阳是釜底（脾胃）之火，若非此火，脾胃何以蒸化？欲行补土生金，先得补火生土（302、314页）。下面看一则补火生土案例：

干血痲吴妻，女，24岁。经县医院拍片诊为双肺空洞型肺结核，已成干血痲症。病程1年，经闭5个月。咯血不止，食少便溏，黎明必泻。骨蒸潮热，面色皖白无华，唇、指白如麻纸。毛发枯焦，四肢枯细，身瘦脱形，一年时间体重减

轻 25 公斤。弱不禁风，动则喘息，夜不能卧，日仅进食 2~3 两。不仅无月经，亦无白带，自觉阴道干涩，符合血枯经闭特征。虽在酷暑，仍觉怯寒，四肢不温。午后则潮热阵作，汗出如洗，已备后事。虽已“大肉尽脱”，但患者正在青年，素体健壮，未必就是必死之证。盖脾胃为后天之本，脾胃健则气血得以生化，五脏赖之得养，病虽危殆，便有一线生机。且肾为先天之本，五脏之伤，穷必及肾，肾伤则生命根本动摇。当以先后二天并重，乃拟借重补中益气汤为主，增入山萸肉、龙牡、肾四味、油桂、赤石脂，温肾益精，固本救脱：生芪 30g，红参（另炖）、灵脂各 10g，白术、当归、肾四味各 10g，柴胡、升麻各 3g，炙草 10g，山萸肉、炒二芽、乌梅各 30g，油桂 3g 冲，赤石脂、龙牡各 10g，生姜 3 片，大枣 6 枚，胡桃肉 4 枚。上药二煎混匀，得汁 150 毫升，日分 3 次服。上方得效，连服 25 剂，服 3 剂停药 1 天。2 个月后来诊，潮热退净，汗敛喘定，胃口大开，日食量增至斤许，晨泻愈，大便成条。后经调治，月经亦通。治疗近 3 个月，患者体重增加 7.5 公斤，透视双肺空洞愈合、钙化。乃以河车大造丸加减为丸善后，服一料后，体重复元，第 2 年生一子（301 页）。

李按 患者病至五脏俱伤，脾肾元气将亡之境地，绝不可见病治病。余苦思彻夜，唯补土生金法可用，但必须先后二天并重。欲行补土生金，先得补火生土。故在补中益气汤中增入肾四味、油桂、赤石脂、龙牡、山萸肉，温肾益精、固本救脱。结果病有如此转机，大出意外，由此益证此症潮热乃肝脾肾虚极之假热。

5 肺癆夹寒饮者，反其道而行之

李可认为，肺癆若按西医诊断肺结核，投以清热解毒、养阴退蒸之剂，必然亡阳暴脱，变生顷刻，可见中西医结合，中医绝不能“对号入座、按图索骥”。多数情况，皆需另起炉灶，独立辨证，有时甚至要反其道而行之（23 页）。下面看一则反其道而行之案例：

肺癆夹寒饮赵某，女，44 岁。病史：半年前诊为双肺浸润型结核。患者工作繁重，日夜排练节目下乡演出，40 岁后体质渐虚，劳倦内伤，积劳成损。因潮热盗汗服知柏地黄汤加秦艽鳖甲 6 剂，热退后渐变五更泻泄，食少神倦，动辄自汗喘促，咳嗽痰多，有明显的咸味，候间有水鸣声，腰困如折，整日倦怠思卧，日渐清瘦，4 个月减体重 5 公斤。今春以来，特别怕冷，三天两头感冒，每排练一场戏，全身汗出如洗，遂病休。服抗癆药引起呕吐厌食，每日午后发热一阵，出冷汗，夜夜盗汗。面色萎黄，眼圈发黑，手指、膝盖发凉。脉沉细而弱，极数，每分 100 次以上。舌淡胖润，齿痕累累。拟用阳和汤加味变通，唯胃已伤，滋腻助湿，加砂仁拌捣，以制熟地之腻。加重姜炭用量，油桂吞服，以复胃阳。盗汗易麻黄为根。加生芪，甘温益气而除大热，且对疮疡有托毒生肌之效。加红参、灵脂益气化痰，缓通血痹。加山萸肉敛肝，防阴阳气血之脱散，山药益肺脾肾之阴：生芪、熟地各 30g，砂仁（拌捣）10g，山萸肉 30g，山药 60g，红参（另炖）、

灵脂各 10g，麻黄根 30g，白芥子（炒研）10g，鹿角胶 10g，油桂（粉吞）3g，姜炭 10g，生半夏、茯苓各 30g，五味子、细辛、炙草各 10g，生姜 10 片，二诊：连服 5 剂后，多年喉间水鸣声消失，喘汗减，食纳佳，去半夏、细辛、五味子，3 剂。三诊：诸证向愈，痰又多，晨喘重，腰困甚。复加生半夏、细辛、五味子，加补骨脂、胡桃肉各 30g，冬虫草 4g、蛤蚧尾 1 对、红参 10g 研末吞服，沉香磨汁（对入）3g，5 剂。四诊：稳步好转，晨泻止，便成形，精神食纳已如常人。加三七、胎盘各 5g（研末冲服），补肾气，化血痹。上方加减共服 30 剂，复查双肺结核钙化，体重回升，恢复工作（307 页）。

李按纵观脉证：**数脉主热，此为常；数则为虚为寒，此为变。**肺癆脉皆数，无一例外，数至七急八败，阴阳气血皆欲脱，非虚寒而何？误用苦寒，胃气先伤；盗汗 5 个月，阴损及阳；喘咳不休，肺病及肾。虽有中午一阵潮热，亦属肝虚失敛。虚证、寒证、阴证显然，为肺癆之本质，其它皆为假象。劳者温之，虚者补之，拟用阳和汤加味变通。本汤为治外科疮疡阴证之神剂，对骨结核、肠结核、淋巴结核皆有卓效。余用治各类结核病 10 余例，均在短期内治愈。

6 肺癆的治疗规律

李可治结核病 14 案，其中肺结核者 8 例，结核性胸膜炎者 2 例，结核性心包炎者 1 例，结核性腹膜炎者 3 例，多从虚证、寒证、阴证论治。如用补中益气汤合肾四味治肺结核 3 例（302、304、306 页），用参附龙牡救逆汤合来复汤治肺结核 2 例（23、299 页），用阳和汤变通治肺结核 1 例（300 页），用五味回生汤（红参、生半夏各 30g，山萸肉、山药各 100g，炙草 15g，生姜 10 片，姜汁 1 盅）治肺结核 1 例（306 页），用旋覆代赭石汤加减治肺结核大咯血 2 例（311、312 页），用小青龙汤合参附汤治结核性胸膜炎 1 例（47 页），用瓜蒌薤白白酒汤合丹参饮治结核性胸膜炎 1 例（46 页），用人参败毒散加味治结核性心包炎、心包积液 1 例（49 页），用少腹逐瘀汤合桂枝茯苓丸治结核性腹膜炎 1 例（102 页），用少腹逐瘀汤合海藻甘草汤治结核性腹膜炎 1 例（103 页），用真武汤加味治结核性腹膜炎 1 例（59 页）。从中可领略他的治疗特点：

6.1 肺癆的治则

6.1.1 治癆有四本

《理虚元鉴》曰：“治癆有三本肺脾肾。”李氏增一本，曰治肝。虚劳极期，亢热熏蒸，**肝之疏泄太过，元气欲脱，以大剂山萸肉敛火固脱救之**（310 页）。如肺结核合并肺心病案，来复汤之山萸肉为 90g（23 页）。

6.1.2 劳者温之佐化瘀

李氏认为，治癆当遵“劳者温之”之旨，师仲景理血痹治虚劳之法，在调补肺脾肾之中，佐以活血化瘀之法（309 页）。如干血癆案之人参，五灵脂益气化

瘀，缓通血痹（302 页）；肺癆夹寒饮案之胎盘、三七、亦然（309）。

6.1.3 保护脾胃为第一要义

治癆要把定保护脾胃元气一关，凡一切有碍脾胃元气之品，皆摒弃不用，三黄、栀子、生地、鳖甲均列为禁药（301 页）。

6.2 肺癆之常法

6.2.1 甘温除热、敛火固脱

甘温除大热，主要用于肺癆潮热。以补中益气汤大剂（生芪 60g）频投，加山萸肉 90g，乌梅、龙牡各 30g，敛火固脱，三五日转轻，半月退净（310、309 页）。如抱儿癆案（304 页）。

6.2.2 补土生金、补火生土

欲行补土生金，先得补火生土，主要用于脾肾元气动摇。以补中益气汤为主，增入肾四味、龙牡、油桂、赤石脂等（302 页）。详见干血癆案（301 页）。

6.2.3 救阳固脱

救阳固脱，主要用于戴阳危证，以来复汤合参附龙牡救逆汤（23 页）。如肺结核戴阳危证案（299 页）。

6.2.4 降逆止血化瘀

降逆止血化瘀，主要用于肺癆大咯血，以旋覆代赭石汤为主，加枇杷叶、桃仁、红花、三七等（311 页）。详见肺结核大咯血案（310 页）。

6.2.5 广络兼备

广络兼备法之代表方为黄芪保肺膏，通治各期肺结核。以黄芪鳖甲散（去鳖甲）合百合固金汤化裁，药计 29 味：生芪 300g，猫爪草 250g，百合、百部、白茅根、山药、山萸肉各 200g，党参、二地、二冬、鸡内金、杏仁、茯苓、沙参、玉竹、煅龙牡、功劳叶、三七粉各 100g，紫苑、五味子、甘草、川贝粉各 70g，龟鹿阿胶各 50g，油桂粉 10g，冰糖 1500g，梨 2500g，姜汁 100g。本方以顾保胃气为先，重用生芪为君，甘温益气而退虚热，合山萸肉、煅龙牡之敛固元气，止盗汗，定喘息，退骨蒸；以肉桂之辛甘大热补肾命真火，引浮越之假热归肾，更加姜汁暖脾胃，二药合力，监制大队养阴之寒凉腻隔，养肺阴而不伤脾阳（314 页）。

6.3 肺癆之变法

6.3.1 肺癆夹寒饮者，阳和加味变通

李氏用阳和汤治各类结核病 10 余例，均在短期内治愈，详见肺癆夹寒饮案（309 页）

6.3.2 肺癆兼呕泻者，五味回天建功

肺癆兼呕泻者，已无病可攻，急需醒脾救胃、固脱救肾之五味回生汤，起死回生，详见久痢成癆案（305）。

6.4 肺结核的治疗思路

笔者在《病证冲突当从证》一文中，探讨了李可治西医病思路的 8 个特点。那么，他治西医病肺结核又是怎样的思维？由于肺结核是一种慢性消耗性疾病，是比较特殊的例子，上面肺癆治疗规律之 3 点归纳就是偏重于个性。即便是这样，还是能看出**李氏治西医病的共性痕迹**。现简要概述如下：①**诸病当先解表**：如重症结核性腹膜炎合并胆囊炎案中，患者憎寒无汗，欲厚衣被，拟真武汤加麻黄 15g（59 页）；②**伏邪百日当引邪处透**：如结核性心包炎、心包积液案，心前区滞闷刺痛牵及后背，似有磨盘重压于胸中，以人参败毒散引邪外透（49 页），又肺癆夹寒饮案亦然（308 页）；③**以阴阳为纲，寒热虚实分型**：肺结核亦分为两个基本型，即甘温除大热和从阳化热型。如肺结核大咯血案，用旋覆代赭石汤加减 7 剂，诸症均退。日后上牙龈颊车穴处焮赤肿痛，口不能张，脉洪实。此为正气来复，从阳化热，大是佳兆。大失血后头晕为肾阴虚，龈肿为胃阴不足，阳火偏亢，予玉女煎 6 剂而解。故李氏指出，病难执定一法，人之秉赋各异，脏腑阴阳各有偏盛。此例病人若用补中、阳和，岂不永无愈期（313 页）。④**面对急性结核，也不要跟着“杆菌”跑**：详见急性结核性胸膜炎案（46 页）、肺浸润型结核案（308 页）。⑤**不在病名钻牛角，六经辨证统百病**：李氏不但不考虑西医之病名（肺结核），连中医的病名（肺癆）也无须深究，总是以人为本，探索出治癆新经，如肺结核戴阳危症案，就另起炉灶，用参附龙牡救逆汤加味（300 页）。⑥**万病不治求脾肾，不治之治最上乘**：如久痢成癆案，就阐明了这个道理：

久痢成癆 杜某，女，23 岁，病危邀诊。病史：1 年前患者因 8 个月男孩因病夭折，悲伤过度，食少形瘦。今春流产，失血过多，多次发生贫血性休克。夏末患痢，寒热如疟，日下脓血便 10 余次。服白头汤不效，又服葛根芩连汤 12 剂，病不减，反不能食。盛夏憎寒，不离棉衣，日渐消瘦，咳嗽盗汗。经 X 光透视见右肺浸润型肺结核。已闭经、卧床不起 4 个月。食少呕逆，咳喘自汗，脓血便乃未止，每便必脱肛。经抗癆药后食纳锐减，形容枯槁，眼眶塌陷，皮肤干瘪。一日数度晕厥，气息奄奄，病情危重。脉细数不乱，两迟尚能应指。病由寒痢误用苦寒损伤脾阳，邪陷入里成癆。延久损及于肾，生命根基动摇，已无实可攻。亟扶正固脱，醒脾救胃：红参（捣末同煎）、生半夏各 30g，山芋肉、山药各 100g，炙草 15g，生姜 10 片，煎取浓汁 300 毫升，对入姜汁一盅，一日内不分次数缓缓呷服。呕止后，改为日分 3 次服，3 剂。服 1 剂后当日呕止，服完第二剂后，

汗敛喘定，知饥，索食藕粉 1 小碗，服稀粥 4~5 次。服完第三剂后，可日进食半斤许。患者已能半卧位，两目有神。脉虽细弱，但属有根。下痢脓血如前，未再休克。因呕止，原方去半夏，合补中益气汤：生芪 18g，红参（另炖）、白术、当归各 10g，柴胡、升麻、陈皮各 3g，肾四味各 10g，山芋肉、山药各 100g，炙草 15g，生姜 3 片，大枣 4 枚，胡桃 4 枚打，3 剂。药后已能起坐，日可进食七八两。便脓血、咳嗽、午后潮热不减。第 3 方咬定护元气，补土生金之法，原方加炒谷、麦芽醒脾，煅龙牡固脱。服 20 剂后，已能起床下炕游走几次，进食身有微汗，正气渐复，营卫通调而伏邪外透，痢疾不治而愈。效不更方，再进 20 剂，间日 1 剂。药后咳嗽、潮热止，月经来潮，可到户外活动。经 X 光检查，右肺结核已钙化，一年后生一男孩（305 页）。

按 李可治此案 2 个月，无一味治痢之药而痢愈；仅一味山药治痢之药而痢亦愈。可见“以人为本”的思想，固守脾肾元气的原则，在万病不治的情况下，确有起死回生之效。

李可研究肺癆的思路，现简要归纳如下：误用清热退蒸，险铸大错顿悟；肺癆病灶在肺，但波及肝脾肾；甘寒养阴伤脾阳，苦寒泻火致戴阳；久病气血大虚，脾肾元气动摇；肺癆潮热，乃肝脾肾虚极之假热；当遵“劳者温之”，理血痹治肺癆；重温东垣《脾胃论》，补土生金探新径；欲行补土生金，先得补火生土；肺癆夹寒饮者，反其道而行之。

附子用量煎服法

——李可学术思想探讨之七

简介：摘要针对附子用量煎服法的分歧，进一步探讨了李可学术思想。李可关于附子用量：阳虚用小剂，阳衰用平剂，格阳用平剂，亡阳用中剂，垂死用大剂；关于附子煎服法：附子 30~100~200 克，加水 1500~2000~2500 毫升；慢性心衰，文火久煎；垂死心衰，开水急煎；关于附子“去麻”：治垂死心衰不去麻，治类风湿亦不去麻。

关键字：附子证 阳虚 阳衰 格阳 亡阳 垂死 用量 煎服法 李可 医案

附子是中药四帅之一。李可创制的破格救心汤，附子一昼夜用到 600 克，而他实际用量最多达 750 克。这样看来，探讨附子的用量和煎服法，就成为同道所关注的话题。现根据其 68 则医案，整理出以下内容：

1 《伤寒论》附子用量煎服法

1.1 附子用量

仲景是古代医家中最善用附子者，《伤寒论》113方，其中20方用附子。李可认为，考《伤寒论》四逆汤的原方，生附子1枚，约合今之20克（附子大者为20~30克），假定生附子之毒性与药效是制附子之两倍以上，则伤寒四逆汤类方所用附子相当于现代制附子40~60克（附子大者为60~90克），而历代用四逆汤仅是原方的1/6~1/10。以这样的轻量，要救生死于顷刻，诚然难矣（3、404页）。四逆汤原方在用法中指出，强人大附子1枚；而通脉四逆汤、通脉四逆加猪胆汁汤之附子均为大者1枚，相当于制附子60~90克，这是经方用药的本来面目。

1.2 附子煎服法

首先是药与水之比例：经笔者初步统计，伤寒之附子剂19方（除乌梅丸），其汤剂中药剂量按经方基础有效量（以原方折半计量为准）计算，药与水之比例最低者为1:6，为通脉四逆汤；最高者为1:26，为麻黄附子细辛汤；其药与水之比例平均值为1:10。其次是煎煮时间：笔者考四逆汤类方用于救急，所用的应为鲜附子（如生地瓜），这既容易浸泡，又易煎煮，故加水少，恒为600毫升，文火煎煮半小时左右（煎取220毫升，分2次服）；其它制附子剂，加水1200~1600毫升，文火久煎，煎煮1个半小时左右。而比较特殊的是麻黄附子细辛汤，因麻黄先煎去沫，故加水较多，为2000毫升，煎煮时间2小时左右。最后是煎服法：附子剂均煎煮1次，煮取200~600毫升左右，每次服110~200毫升；其顿服者1方，为干姜附子汤；分2次服者6方，为四逆汤类方；分3次服者10方，为附子汤等；分4次服者1方，为真武汤。

2 李可附子用量煎服法

李可创制的破格救心汤，其附子用量为30~100~200克，已突破了经方的剂量，故其对附子又增加了**3条安全措施**：①**配伍**：凡用附子超过30克时，不论原方有无，皆加炙甘草60克，即可有效监制附子毒性；②**文火久煎**：附子剂用于慢性心衰者，加冷水1500毫升，文火煮取500毫升，日分2~3次服，煎煮时间1个半小时左右；③**武火急煎**：危急濒死心衰病人，使用大剂破格救心汤时，则开水武火急煎，随煎随灌（70页）。以上3条只是原则性的，具体作法如下：

2.1 附子用量

李可之全书附子案70余则，根据病证的轻重而选择不同的剂量。主要分为以下几种情况：①轻者为阳虚，附子为小剂10克：所谓“**阳虚**”，仅见阳气某一方面不足，如缺乳案之五更泻（95页）、膝关节积液案之夜尿频多（251页）；小儿酌减为3~5克，如婴儿黄疸案（84页）。附子用小剂者17例，占总数的24.3%。②稍重为阳衰，附子为平剂15~30克：所谓“**阳衰**”，是阳气衰弱的证

候群，脏腑功能均受到不同程度的损害。如产后阴黄案之脾肾阳衰，寒湿充斥三焦（173 页）。附子用平剂者 7 例，占总数的 10%。③重者为**隐性心衰、格阳、戴阳证**，附子为平剂 30 克：李可认为，凡亡阳竭阴端倪初露，**隐性心衰的典型证状**出现（如动则喘急、胸闷，常于睡中憋醒，畏寒肢冷，时时思睡，夜尿多，以及无痛性的心肌梗塞之倦怠乏力，胸憋自汗等），急投破格救心汤平剂 30 克（6 页）。笔者注意到，对于格阳、戴阳证，李氏恒用附子 30 克，如阴盛格阳案（187 页）、肺心病戴阳案（23 页）。附子用平剂 30 克者 33 例，占总数的 47.1%。④甚者**亡阳、心衰重症**，附子为中剂 45~90 克：李氏认为，凡亡阳竭阴之格局已成、重症心衰，急投破格救心汤中剂（6 页）。如脉管炎合并心肌下壁梗塞案之附子为 60 克（64 页）。附子用中剂者 2 例，占总数的 2.9%。⑤危者**垂死心衰**，附子为大剂 100~200 克：李氏认为，破格救心汤用大剂，可挽垂绝之阳，救暴脱之阴。**凡内外妇儿各科危急重症，导致心衰休克，现代医院已下发病危通知的垂死病人，以及中医之五脏绝症和七怪脉绝脉等必死之症，只要心跳未停，一息尚存者，急投本方大剂，可 1 小时起死回生，3 小时脱离险境，一昼夜转危为安**（5 页）。如无脉垂死案，破格重用附子 150 克，武火急煎随煎随灌，终于 1 小时起死回生（3 页）。附子用大剂者 11 例，占总数的 15.7%。

从中可以看出，李可之附子用量，是很严格的。他**对附子应用，分为阳虚、阳衰、格阳、亡阳、垂死之 5 个等级**（6、372 页）。这是迄今为止，关于附子证最系统的辨证，应当引起中医界的重视。其中附子用平剂（30 克）、中剂（45~90 克），是与《伤寒论》四逆汤类方治格阳、亡阳证之附子用量基本吻合的。至于附子用大剂，那是用于古代之五脏绝症和七怪脉绝脉等必死之症，即现代西医下病危通知书的垂死病人，是对前人和现代医学的突破。只有这样客观地分析其附子用量，用于哪些新领域去解决世界性医学难题，最后也就“见怪”不怪了。

2.2 附子煎服法

首先是药与水之比例：附子 30 克者 5 例，恒加水 1500 毫升，药与水之比例最低者为 1: 3.5，如休息痢案（149 页）；最高者为 1: 12，如足心发热案（236 页）；其药与水之比例平均值为 1: 7。附子 60~200 克者，加水 2000 毫升者 5 例，药与水之比例最低者为 1: 2.3，如肺间质纤维化案（32 页）；最高者为 1: 3.5，如肺间质纤维化案（29 页）；其药与水之比例平均值为 1: 3.1。附子 90~200 克，加水 2500 毫升者 3 例，药与水之比例最低者为 1: 2.5，如布鲁氏杆菌病急性心衰案（11 页）；最高者 1: 3.5，如血栓闭塞性脉管炎案（65 页）；其药与水之比例平均值为 1: 3.1。其次是煎煮时间：用于慢性心衰，附子 30 克加水 1500 毫升者，煎煮时间 1 个半小时左右；附子 60~200 克加水 2000 毫升者，煎煮时间 2 小时左右；附子 90~200 克加水 2500 毫升者，煎煮时间 3 小时左右。用于垂死心衰，附子用大剂则加开水 1500 毫升，武火急煎，煮沸 1 刻钟后，随

煎随灌。最后是附子的煎服法：**附子剂均煎煮 1 次**；用于慢性心衰，文火煮取 500 毫升左右，日分 2~3 次服；用于垂死心衰，则开水武火急煎，随煎随灌，昼夜连进。

从中可以看出，李可附子煎服法亦效法仲景。仲景四逆汤类方用生附子治亡阳急症，加水 600 毫升，煎煮半小时左右。李氏用制附子大剂治垂死心衰，加开水 1500 毫升，武火急煎，1 小时起死回生。仲景用制附子剂，则加水 1200~1600 毫升，文火久煎 1 个半小时左右；李氏治慢性心衰，附子 30~100~200 克，则加水 1500~2000~2500 毫升，文火久煎 1.5~2~3 小时左右。二者之附子剂，均煎煮 1 次。这些精细之处，最宜深究。

3 关于附子久煎的思考

李可用附子重剂治慢性心衰，多加水在 2000 毫升，久煎在 2 小时左右。由于煎煮费时，给患者带来心理压力和生活不便，也使其弟子心有余悸不敢效法。为了解决这个棘手问题，笔者进行深入探索。

3.1 附子免于久煎之依据

早在 1977 年《中药大辞典》就指出，日本将川乌、生附子在加压罐内用 110℃ 1 公斤/平方厘米 40 分钟进行处理，此毒性乌头碱已分解，而其毒性则为生药 1/150（230 页）。经过 20 多年的临床实践，**日本又进一步完善了附子高温高压法，即高压 120℃，经 2 小时可破坏乌头碱之剧毒，这样入汤药毋需先煎、久煎**（《中药趣话》109 页）。

3.2 目前附子炮制得与失

1958 年卫生部简化中药商品规格，决定只保留附子的 3 个品种：盐附子、黑顺片、白附片。《中华本草》指出，黑顺片、白附片因加工方法类似，其炮制品的总生物碱含量下降为原生药的 1/6~1/9，而毒性双酯型乌头碱含量只相当于原生药的 1/100；盐附子因加工条件比较温和，总生物碱与上述附片类似，而毒性双酯型乌头碱比上者高得多（487 页）。从中可以看出，经过这样炮制，总生物碱含量只是原生药的 1/6~1/9，那么附子药效流失则为 83.4%~88.9%，其流失的比例是惊人的。

3.3 附子高温高压去毒效果好

1997 年《中华本草》是集传统药学大成并反映当代科研成果的本草巨著。该书认为，古今对川乌、附子的炮制方法虽然繁多，但归纳说来，可分为浸、泡、漂等水处理，烘、焙、炮等干热处理，蒸、煮等湿热处理 3 种类型。这些方法皆能达到去毒目的。但水处理生物碱随水流失较多，药效受到影响；干热处理对总生物碱含量影响不大，对药效影响较小，而毒性双酯型乌头碱含量相对较高；**湿**

热处理，特别是热压蒸制处理（即高温高压），总生物碱含量高，毒性双酯型乌头碱含量低，去毒效果好（479 页）。

3.4 附子用压力锅热压处理

笔者以《中华本草》附子热压蒸制法为指导，借鉴日本附子高温高压的成功经验，结合国内现有的条件，对附子进行热压处理设计：

3.4.1 附子品种的选择

目前制附子的商品，主要有盐附子、黑顺片、白附片 3 种。鉴于盐附子的毒性双酯型乌头碱含量比黑顺片、白附片高，暂不以它为研究对象。《中药炮制学辞典》又指出，附子经过浸、泡、漂的炮制过程，损失总生物碱达 80%以上，另外一个流失方面是附子去皮（274 页）。鉴于白附片去皮，暂不以它为研究对象。最后，确定了黑顺片为设计目标。

3.4.2 附子热压时间的取舍

由于黑顺片的炮制过程是取泥附子洗净，浸入食用胆巴的水溶液中数日，连同浸液煮至透心捞出水漂，纵切成厚片，蒸熟取出烘至半干，再晒干。也就是说，附子先煮沸至透心约半小时，再切成厚片蒸熟约半小时，总共蒸、煮为 1 小时。鉴于黑顺片是在常温下蒸煮 1 小时的，按高温高压应当时间折半，即高温高压 2 小时（日本经验）减去半小时。这样一来，黑顺片高温高压时间就设定为 1 个半小时。

3.4.3 附子热压前准备工作

首先，将黑顺片 1 公斤放在 22 型压力锅里，放冷水 500 毫升拌匀，盖上锅盖闷 2 个半小时。每隔 15 分钟，即翻动一次或颠簸一下；闷半小时后，用根筷子蘸一滴浸液点在舌尖上，会感到微苦涩；闷 1 小时（即第二个半小时），尝后舌尖有微麻辣感；闷 1 个半小时后，会有明显麻辣感；闷 2 小时后，会有刺舌感，此时黑顺片已基本闷透，只是大个、片厚的还有硬心；闷 2 个半小时后，尝后会有针扎感，黑顺片已经没有硬心了，即全部泡软，可进行热压处理。

3.4.4 附子热压操作

用 22 型压力锅，放冷水 1000 毫升（或 24 型压力锅，放冷水 1200 毫升），然后放入筲子（水要低于筲子），铺上已闷好的黑顺片，盖上锅盖，加热至排气管冒蒸汽时，扣上限压阀。当蒸汽稳定由限压阀处排气时，应立即调低火力，保持限压阀间歇排气和发生轻微响声。一个半小时后闭火，稍停片刻，然后打开锅盖，凉透后取出烘半干、再晒干。这样处理的制附子，入煎剂就可以免于久煎了。注意：如果限压阀不是“间歇排气”，而是“持续排气”，说明火急了，容易烧干锅。

3.4.5 讨论

讨论问题：①为什么附子要加水 500 毫升，多放水不闷得更快吗？制附子，如同熟地瓜干，是个“慢性子”。它和水多少没关系，如用湿手巾包裹，也可以在同样时间内把它闷透，都得需要 2 个多小时。问题是水放多了，附子闷透后就会有剩余的浸液，其浸液越多，则有效成分流失的就越多。而 1 公斤黑顺片，放 500 毫升水，最后正好被全吸收，说明附子有效成分没有流失，这是**炮制的关键**。②为什么要闷 2 个半小时？热压处理的要求，必须把制附子闷软、没有硬心。而个大、片厚的黑顺片，闷 2 小时还有硬心，所以要闷 2 个半小时。

4 关于附子煎服法的思考

对于附子煎服法，看似简单，可认真操作起来，每个细节都有学问。下面就从最基本的谈起：

4.1 煎药器

一般认为，煎药以砂锅为好。但由于砂锅体积小，附子重剂多不适用。另外，砂锅爱坏，如放开水、或急煎、或煎煮完放在石板上，均容易炸裂。笔者经过实践发现，压力锅不但具有砂锅的优点，如传热速度慢，受热均匀，汤温始终保持在 95℃左右，这样的温度利于饮片内的可溶性有机物向外渗出；它还有独特的优势，因压力锅密封，即使久煎，只能从排气孔排出微量的气体，药液挥发少，始终保持药与水之适当比例，保证有效成分煎出。

4.2 药与水之比例

一般煎药，多加水淹过药面一寸。由于煎药锅大小不一，单用淹过药面“一寸”来表示，那水量之差别可就太大了，急需改进。《伤寒论》附子剂，四逆汤类方加水 600 毫升，其它制附子剂，加水为 1200~1600 毫升，药与水之比例平均值为 1: 10。李可之附子剂，附子 30~100~200 克，加水 1500~2000~2500 毫升，药与水之比例 1: 3~1: 7。这都值得我们效法的。

4.3 浸泡时间

一般附子煎剂，多为冷水浸泡半小时，偶尔有浸泡 1 小时的。笔者的临床经验，制附子至少得浸泡 2 小时。因为浸泡半小时，尝后只有微苦涩；浸泡 1 小时，会有微麻辣感；浸泡 1 个半小时，会有明显麻辣感；浸泡 2 小时，会有刺舌感，此时附子的有效成分已达到高峰。从理论上讲，制附片只有充分泡软、细胞膨胀，有效成分才能溶解于饮片组织中，产生渗透压，然后扩散到水中。从中可以看出，附子浸泡少于 1 小时，就不会有麻辣感，而浸泡 2 小时，则出现刺舌感。真可谓：好的浸泡，等于煎煮的一半。

4.4 煎煮时间

4.4.1 《伤寒论》附子煎煮时间

仲景之四逆汤类方用鲜附子（如生地瓜）救急，加水 600 毫升，文火煎煮半小时左右；其它制附子剂，加水 1200~1600 毫升，文火久煎，煎者时间 1 个半小时左右。

4.4.2 李可附子煎煮时间

李氏治慢性心衰，附子 30~100~200 克，加水 1500~2000~2500 毫升，文火久煎，煎煮时间 1.5~2~3 小时左右；治垂死心衰，附子大剂，加水 1500 毫升，武火急煎，煮沸 1 刻钟后，随煎随灌。

4.4.3 笔者附子煎煮时间

笔者治慢性心衰，使用热压处理（高温高压 1 个半小时）之制附子，只煎煮 1 次，煎煮时间为 1 小时。其具体方法如下：用 22 或 24 型压力锅浸泡黑顺片，药与水之比例按李可之经验加水，浸泡 2 小时，然后加热至排气管冒蒸气时，不扣限压阀，而应立即调低火力，保持排气管间歇排气，此火候正是煲汤的温度，有利于蛋白质及可溶性有效成分向外渗出，煎煮 1 小时后，将药渣捞出，如药液多，则用武火急煎浓缩即可。为了验证此法是否安全，笔者曾试服李可之附子重剂（45~155 克）一个月，附子最高达 155 克，均煎服 1 小时，则无不良反应，值得推广。**注意**：如果排气管不是“间歇排气”，而是“持续排气”，说明火急了，容易烧干锅；压力锅在煎煮过程中，不能打开锅盖，否则药液会溢出伤人。

4.5 讨论

讨论问题：①附子浸泡 2 小时，夏季容易馊，是否有更简便的方法？笔者经验，可把热压处理之制附子，磨成玉米样大，浸泡 1 小时即可。因为附子价格很便宜，不存在造假问题，故院方可自行磨成“附子米”（即玉米粒大），这样就方便多了。②附子用重剂而煎煮 1 小时是否充分、安全？黑顺片经过热压处理 1 个半小时，已经去毒，毋需多虑。其煎煮是否充分，这取决于两方面：一是浸泡时间，制附子若浸泡 2 小时（或附子米浸泡 1 小时），会有刺舌感，说明有效成分已达到最佳状态；一是煎煮时间，李氏之经验，附子煎煮 1 小时，其有效成份之分解亦达到高峰（3 页）。

5 关于附子免煎的思考

目前，附子用重剂已经屡见不鲜了。即便是经热压处理之附子，可免于先煎、久煎，仍有不尽人意的地方。因为附子大剂量，则加水 1500~2000~2500 毫升，若煎煮 1 小时，那煎取的药汁多数会超过 600 毫升，这势必要再用半~1 小时浓缩药汁，是否有更简便的方法？笔者曾试服李可之附子重剂（45~155 克）一个月，均煎煮 1 小时，则无不良反应；随后，又进一步把热压处理之附子磨成粉，

从每次 1 克服起，逐日增加 1 克，日 3 次，以其汤药送服，连续服用 11 天，附子粉最高达 11 克，日 3 次。结果附子粉用到 33 克，相当于入煎剂之制附子 66~99 克，均无不良反应。所以，笔者体会，除急危重症外，凡制附子用量在 100 克以下，均可改为附子粉在 33 克以下。为了稳妥起见，暂定为热压处理之附子粉 1 克相当于入煎剂之制附子 3 克（即 1:3）。注意：不能用制附子直接磨粉，必须用热压处理之制附子（已有效破坏双酯型乌头碱之毒性），这样就安全、方便多了。

6 关于附子大剂量应用的讨论

6.1 邢斌对附子用量的困惑

邢斌在《急症难病倚附子》一书中说，附子剂量小则仅用 0.3 克，超大剂量用到 600 克，竟然相差 2000 倍。如此大的差异，恐怕是所有药物中绝无仅有的。而个中缘由，殊难理解，这着实是一个令人困惑的问题（29、39 页）。他从 6 个方面探讨了附子大剂量应用的原因，最后提出倾向性意见：通过以上分析，我们发现附子的用量差异，应该与患者的禀赋，不同的病证及附子的产地、炮制有关，这 3 个方面是合理的；而与地理气候、风俗习惯也有一定关系，但若拘泥于此而无视患者的具体情况，则又本末倒置矣。但是，这 4 方面因素并非真正导致附子用量巨大差异的主要原因。事实上，恐怕主要是因为开水长时间煎煮，以及医生的个人偏好、医学风尚，导致了附子的大剂量应用，这似乎并不合理（35 页）。

6.2 附子大剂量应用的原因

笔者认为，附子大剂量应用的原因，应从附子本身的药效流失和制约附子的人为因素去探讨。

6.2.1 附子本身的药效流失

附子的药效流失主要有以下原因：①附子炮制是药效流失的第一位原因：《中药炮制学词典》指出，附子在炮制过程中，经过浸、泡、漂等损失总生物碱达 80%以上（274 页）。所以，目前附子炮制是药效流失的第一位原因，亦是附子大剂量应用的第一位原因。②附子浸泡时间短是药效流失的主要原因：《伤寒论》对附子剂煎服法，没有说明浸泡时间，这是个缺憾。一般煎附子剂，多浸泡半小时，尝后只有微苦涩感，离麻辣相距甚远，其有效成分大部分没有分解出来。③附子用开水煎煮亦是有效成分流失主要原因：邢斌指出，云南地区名医，附子用开水煎煮 3 小时以上。如吴佩衡用附子 15~60 克，加多量开水，以猛火急煎，煮沸 2~3 小时（91 页）。他分析，这样做的目的，首先是出于安全考虑，因附子毒性双酯型乌头碱不耐久煮。可是乌头碱之毒性，也是附子镇痛、回阳的主要成分。如长时间煎煮，附子治疗痹证、亡阳的疗效就会降低。若疗效不显著，就

会增大附子的剂量；同时出于安全考虑又会进一步延长煎煮时间。如此反复，最后可能会达到一个有效剂量与煎煮时间的平衡点，但这时的剂量肯定会很大了，这可能是附子超过常规的原因之一。但需要指出的是用开水煎煮附子是否合理，是否会影响有效成分的煎出（34、36 页）？笔者认为，开水煎煮附子，在一般情况下是不合理的。因为制附子，类似熟地瓜干，含有丰富的淀粉及蛋白质等，其一遇开水、猛火，表层立即凝固而形成包膜，致使有效成分不易煎出而流失。但在特殊情况下，又是必要的。如李可治垂死心衰，开水急煎，随煎随灌，以救生死于顷刻。他用开水急煎是分秒必争，随煎随灌，1 小时能起死回生。现代药理证实，附子武火急煎 1 小时，正是其毒性分解的高峰，附子的剧毒，亦正是垂死心衰的救命仙丹（3 页）。这与云南地区名医之开水久煎 3 小时，以去附子的毒性，是大相径庭的。

6.2.2 制约附子的人为因素

制约附子的人为因素主要有以下情况：①病证轻重：病证本来是客观的，但它是由医生来掌握，所以又有“仁者见仁，智者见智”的说法，于是病证又受人的制约。前人告诉我们，有是证，用是药。那什么是附子证呢？李可对附子应用，分为阳虚、阳衰、格阳、亡阳、垂死之 5 个等级，这就是附子证。②医学流派：中医史上，学派林立，善用附子者，当首推伤寒派、火神派。张仲景无疑是古代医家中最善用附子者；伤寒派传人范中林，制附子用至 500 克，如少阴下利虚脱案（《范中林六经辨证医案》143 页）。火神派以郑钦安为代表，因善用、重用附子而得名。火神派传人吴佩衡，附子用至 400 克，如少阴证阴盛格阳案（《吴佩衡医案》40 页）。李可自称为“古中医学派”，其附子用至 600 克，如风心病心衰垂危案（9 页）。从中可以看出，附子证与医学流派是制约附子用量的主要原因。

7 关于附子“去麻”的讨论

7.1 邢斌对附子“去麻”的质疑

关于附子“去麻”问题，邢斌曾一度以为这是鉴别附子煎煮后是否有毒的好方法。但经反复实践后，发现不少疑问。他第一次实验，取单味附子 10 克，煎煮 10 分钟，尝 1 勺，味苦；继续煎煮 20 分钟，再尝，仍是味苦。其后又分别用单味附子 100 克、200 克，煎煮 20 分钟，尝 1 勺，味苦；当时没有出现麻辣的口味，之后也没有出现口麻的感觉。由于没有出现麻辣或口麻的感觉，所以最后还是没有把这个问题弄清楚（38 页）。

7.2 附子麻辣与麻口均有根据

《中药大辞典》指出，黑顺片在炮制过程中，用水漂洗至口尝无麻辣感时，可以捞出蒸熟，然后晒干（1197 页）。《金匱》在乌头汤服法中指出，服 7 合

（140 毫升，为全剂 2/3），服后唇舌微觉麻木为“知”，不知（无比感觉），则“尽服之”，即把所剩 1/3 药液全部服下。这前者是说附子在炮制过程中“去麻辣”，而后者是说乌头汤（附子与乌头同理）服法以“麻口”为度，说明前人关于附子“去麻”都是有根据的。

7.3 附子麻辣与麻口之别

附子之麻辣感，确切地说是指舌，如《中药大辞典》就明白指出是“味辛辣而舌麻”（228 页）。附子之麻口，应当是指口唇及舌麻木。麻辣，是附子药液作用于舌的味觉神经瞬间即时感觉；麻口，是药液通过胃而作用于中枢神经的中毒反应，其时间多在药后半小时。所以，《中药大辞典》又进一步指出，乌头碱中毒时间短者，多在服药后 30 分钟之内先觉口唇舌麻木，长者 1~2 小时后出现（231 页）。李可救治心衰用附子重剂，常等患者服药 40 分钟反应正常后才能离开，其道理就在这里，应当牢记。

7.4 附子麻辣与麻口用途

附子之麻辣主要用于：①炮制火候：如黑顺片的炮制，切片用水漂洗至口尝无麻辣感时，再取出蒸熟、晒干。②浸泡火候：临床经验证明，制附子浸泡 1 小时才有微麻辣，而至 2 小时尝后会有刺舌感，说明此时浸泡达到了最佳状态。③煎煮火候：制附子如不经过浸泡，而用开水急煎 1 小时，正是其毒性分解的高峰，口尝会有麻辣感，李可常用此法治垂死心衰，如无脉垂死心衰案（3 页）。治慢性心衰，则文火久煎 2 小时左右，意在去麻。附子之麻口主要用于：①服药效应：李氏用乌头附子剂治类风湿，服药以“知”为度，“不知”则增加药量，直至出现唇舌稍感麻木为止。如类风湿性关节炎合并硬皮病案（208）。②服药中毒反应：因附子使用或煎煮不当而中毒，若在半小时内出现口唇舌麻木，即可诊断。

7.5 附子在特殊情况下“不去麻”

根据附子麻辣与麻口之 5 种用途，可以看出，附子并不是一味“去麻”，如附子麻辣之“煎煮火候”用于垂死心衰，麻口之“服药效应”用于类风湿类病，便是“不去麻”之明征。这是李可之成功经验，是利用附子的“毒性”治病，是比较特殊的例子，详见有关案例（3、208 页）。

至此，我们再回过头来看邢斌单煎“附子 200 克”的话题。若单从煎煮时间谈起（不涉及浸泡时间），其煎煮 20 分钟，时间太短了，只有达到 1 小时才能有麻辣的口味；若从整个煎服法而论，只要浸泡时间或煎煮时间至 1 小时，均可出现麻辣感，甚至会出现麻口的感觉。

李可研究附子的思路，现简要归纳如下：关于附子用量：阳虚用小剂，阳衰用平剂，格阳用平剂，亡阳用中剂，垂死用大剂；关于附子煎服法：附子 30~

100~200 克，加水 1500~2000~2500 毫升；慢性心衰，文火久煎；垂死心衰，开水急煎；关于附子“去麻”：治垂死心衰不去麻，治类风湿亦不去麻。

培元固本治未病

——李可学术思想探讨之八

简介：针对中医未病先防、已病防传和愈病防犯的含义，进一步探讨了李可学术思想。李可关于愈病防犯的思路：恪守疾病禁忌，以免重蹈覆辙；培元固本治体，药分 3 个层次；万病不治求脾肾，不治之治最上乘。

关键字：中医治未病 愈病防犯 疾病禁忌 培元固本 不治之治 培元固本散 李可 医案

中医治未病的基本含义，包括未病先防、已病防传和愈病防犯 3 个方面。也是就说，病未发，当内养正气，外避风寒以预防；病已成，当加强被克者以防传变；病痊愈，当重建免疫屏障以防再犯。李可在前人治未病理论基础上，对愈病防犯之环节进行深入探索，40 年来终于有所突破。笔者根据培元固本散 11 首类方及 26 则医案，整理出以下内容：

1 培元固本散方解

李可从 60 年代开始，就以参茸胎盘治大病后久损不复得效。唯有的病人，用后有滞闷感。他认为，久损之大虚症，虚必夹瘀，虚甚而反不受补，蛮补反致气机滞塞，欲速则不达。遂加三七，补中有通、有化，虚证用之，可以平稳收功。70 年代后加灵脂、琥珀，基本定型。经临床运用 30 余年，随证加味，治一切久损不复之大虚证，先天不足，衰老退化，免疫缺陷，都取得了泛应曲当的疗效（392 页）。

组成胎盘 1-2 具，鹿茸 30-50g，红参 50-100g，五灵脂 30-50g，三七 50-100g，琥珀 30-50g。

功能补肾健脾，强脑益智，活血化瘀，溶解血凝；修复脏器，重建免疫，改善体质，终生不犯；延缓衰老，祛病延年，白发渐黑，皱纹消失（150、399 页）。

主治一切久损不复、或反复发作之大虚证，先天不足，衰老退化，免疫缺陷，及虚中夹瘀、夹痰、夹积等证。

方解：

胎盘，味甘咸，略有腥气，性温，入心肺脾经。本品古名紫河车，是古方补天丸、大造丸主药，为血肉有情之品，有一般草木药难以达到的补益功效，是中医医学最早使用的脏器疗法之一。功能温肾补精，益气养血，用于虚劳羸瘦，骨蒸盗汗，气短喘嗽，食少，阳痿遗精，不孕少乳诸虚百损，有再造人体免疫力之功。

现代药理证实，本品含有丙种胎盘球蛋白、干扰素、多糖、多种氨基酸、卵巢激素、黄体激素等。有增强人体免疫力，促进生长发育，抗感染，抗过敏，抗癌，升高白细胞，对再生障碍性贫血，白细胞减少症，女性生殖系统发育不良等症，均有较好疗效。

鹿茸，味甘咸，性温而柔润，入肝肾经。功能补肾气，强督脉，生骨髓，强筋骨，调冲任，止崩带，托疮毒。主治一切虚寒证，适用于精血衰少，阳痿遗精，精冷无子，畏寒肢冷，羸瘦神倦，宫冷不孕，崩漏带下，小儿发育不良，骨软行迟，老人衰老退化，耳聋目暗，健忘眩晕，筋骨痿软，骨质增生，齿浮动摇。现代药理证实，本品含 **25** 种氨基酸，具有促进生长，刺激血细胞、蛋白质和核酸合成，增强机体免疫系统功能，增强非特异抵抗力作用，还有增强性腺功能和生精效用。有明显强心作用，可使血压上升，心脏搏动有力。对再生障碍性贫血、血小板减少、白细胞减少等血液病有治疗作用。

红参，味甘微苦，性微温，入脾肺经。功能大补元气，补脾益肺，生津止渴，安神益智。久病虚羸不思食，用之有殊功。肺肾两虚之喘，小量打碎，细嚼慢咽，立刻生效。吐血崩漏，气虚暴脱，一味独参 **30** 克，煎浓汁可立挽危亡，故为补虚扶正救脱要药。现代药理证实，本品为抗衰延寿佳品，具有适应原样作用，增强非特异抵抗力作用。具有抗疲劳、抗癌、抗炎作用，调节心血管、物质代谢、内分泌、神经系统，兴奋造血系统，提高人体免疫力，保护肝脏、促性腺功能。还具有祛痰强心、抗过敏、抗利尿、降低血糖，改善肠胃消化吸收，降低血清胆固醇等作用。

五灵脂，味甘，性温，入肝脾经。功能活血止痛，化瘀止血。用于心腹血气诸痛，产后瘀血作痛，妇女血崩，伤冷积聚，小儿疳积等。红参、灵脂相配，一补一通，用于虚中夹瘀，益气活血，启脾消食，化积消症，化瘀定痛，化腐生肌。临床用于冠心病，胃肠溃疡，肝脾肿大，肠结核，结核性腹膜炎等。现代药理证实，有抑制血小板聚集，调节心血管，抗应激性损伤，抗炎等作用。

三七，味甘微苦，性温，入肝胃经。功能止血化瘀、通络定痛。治吐血，便血，崩漏，胸腹刺痛，跌扑肿痛。外伤出血，制粉涂之立止。血证用之，止血而不留瘀，推陈出新，妙用无穷。以单味三七治重症肝炎、高血脂症、冠心病、上消化出血、颅脑外伤、眼前房出血、前列腺肥大症，复方治多种结石皆获良效。现代药理证实，有对增加冠脉流量、降低心肌耗氧量、促进冠脉梗塞区侧枝循环的形成、增加心输出量、抗心律失常等功用，并有抗炎、镇痛、镇静、抗衰老、抗肿瘤等作用。

琥珀，味甘，性平，入心肝小肠经。功能镇惊安神，利尿通淋，活血化瘀。镇惊安神：可止小儿高热惊痫，失眠心悸，心律失常；利尿通淋：治砂石淋，血淋，癃闭；活血化瘀：治妇科痛经，经闭，月经不调，产后血瘀腹痛；本品与三七、灵脂合用，对心血瘀阻，胸痹、胸痛有奇效；明目退翳：内服对老年白内障

有确效。其化腐生肌之作用，可治胃溃疡。现代药理证实，有镇静、抗惊及降体温作用。

用法先以汤剂控制病情，缓解期则以培元固本散善后。开始采取小量缓补，每次 1-1.5 克，日 2-3 次；一周后改为每服 3 克，日 2 次，饭前 1 小时服为好，切忌贪图速效而用大量。若以培元固本散加味，可在六味培元固本散每日 6 克基础上加至 9 克，以每次 3 克，日 3 次；或每次 4.5 克，日 2 次，详见子宫肌瘤（100 页）、抱儿痲案（304 页）。**有条件者可长服 1 年以上，以期逆转实质病变。或遵春夏养阳之理，从夏至起服药 2 个月左右，连续 3 年。**大部分患者，不仅治愈了各种痼疾，而且白发变黑，牙齿不再脱落，面部皱纹消失，性功能恢复，抗衰老作用明显。经治 300 例以上，追访 5 年以上，疗效巩固（398 页）。

2 培元固本散类方

李可将培元固本散随证加味，用于临床各科，拟定出十余首协定方。为了使培元固本散类方便于记忆及推广，笔者按西医系统加以命名。下面举例证之：

2.1 肺系培元固本散

组成胎盘 2 具，坎气（脐带）100g，鹿茸、高丽参、灵脂各 50g，三七、琥珀、冬虫草、川贝、沉香各 30g，灵芝孢子粉 100g，蛤蚧 6 对。

主治咳喘痼疾。用于慢性气管炎、哮喘、肺心病、肺间质纤维化等。

案例肺间质纤维化张某，女，44 岁，患肺间质纤维化合并肺心病，痉咳暴喘，气息奄奄，声哑无音，面色、唇指青紫，杵状指，下肢凹陷性水肿，四肢厥冷，脉急而促，舌胖、苔灰腻，两侧有瘀斑。证属亡阳厥脱，以破格救心汤加味：附子 200g，干姜 25g，炙甘草 60g，山萸肉 120g，龙牡、磁石、煅紫石英各 30g，生半夏、茯苓、生姜各 45g，高丽参 20g、蛤蚧尾 1 对、麝香 1g 研粉分吞，3 剂。药后痉咳暴喘得罢，上肢回温，基本脱险。此次重病，始终恶寒无汗，全身如绳索捆绑，胸痛彻背，憋闷如窒，证属小青龙汤证，遂拟麻黄附子细辛汤加味 1 剂。药后表闭即开，背部冰冷及全身如捆之感均解，小便增多，踝肿亦退，顽固性心衰及呼吸衰竭之危，得以解除。善后以培元固本散如味：胎盘 1 具，坎气 50g，鹿茸 50g，高丽参 100g，灵脂 30g，三七 100g，琥珀、冬虫草、川贝、沉香、灵芝孢子粉、土元、水蛭、全蝎各 30g，蜈蚣 100 条，蛤蚧 10 对。制粉，日服 2 次，每次 3 克，热黄酒送。服散剂 1 料，诸证均退，体重渐复。虽经严冬，咳喘未发，亦未感冒。次年开春，洗衣、做饭、提水，已如常人（29 页）。

2.2 肺癆培元固本散

组成胎盘 2 具，坎气 100g，龟鹿二胶、高丽参、灵脂 50g，三七、琥珀各 30g，蛤蚧 6 对，冬虫草 50g。咯血者加白芨、川贝、煅牡蛎各 50g。上药制 10 克蜜丸，以增强润肺功效，日服 3 次，每次 1 丸。

主治肺结核、肺结核咯血。

案例肺结核大咯血董某，男，36 岁。患肺结核 10 年，3 年来不断发生大口咯血。现频频咳喘，咳剧则血沫喷溅，胸痛彻背，面赤气粗，脉洪大，舌红尖赤，

边有瘀斑。每次犯病，即用针剂止血，血虽暂止，胸膈积瘀已甚。遂拟方降逆化痰止血：瓜蒌 30g，薤白 15g，生半夏 30g，姜汁 1 盅（对入），丹参 30g，檀降香各 10g，旋覆花 12g，赭石 30g，炙枇杷叶 30g，桃杏仁各 15g，甘草 10g，童尿、韭汁各 30 毫升对入，三七 5g、白芨 10g 研粉煮糊，加红白糖服，3 剂。二诊：血止，病象显露，面色苍白少华，拟培元固本善后：胎盘 2 具，龟鹿二胶、红参、灵脂、三七、冬虫草、白芨、水蛭各 30g，制蜜丸服。随访 10 年宿疾未再复发（311 页）。

2.3 风心培元固本散

组成胎盘 1 具，鹿茸、红参、灵脂、三七、琥珀、灵芝孢子粉、炮甲珠各 100g，藏红花、全蝎各 30g，蜈蚣 100 条。喘加蛤蚧 6 对，冬虫草、沉香各 30g。每日另用黄芪 60 克煎汤送服。

主治风湿性心脏病、心肌及瓣膜受损。心衰明显、水肿重者，先服破格救心汤合真武五苓加黄芪 60 克半月。

案例风心病合并冠心病张某，女，40 岁。患风心病、冠心病、肺瘀血已 10 年，心悸、气喘、咳血、动则尤甚。心率常在 170-210 次/分左右。脉促，唇、指、舌青紫。四肢厥冷，胸闷刺痛，入夜不能左侧卧。拟炙甘草汤、参附龙牡救逆汤、丹参饮合方化裁 21 剂。药后悸止、喘定、紫绀消失。唯月初曾出现反复，穷细问，得知 10 年来每经期必感冒，每感冒一次，病情就加重。证属伏邪深入血室，予小柴胡汤加味 6 剂，于每月之经前一日连服 3 剂。药后经前感冒得以根除，拟培元固本散善后：胎盘 100g，鹿茸、红参各 30g，三七 100g，琥珀、冬虫草各 30g，蛤蚧 6 对（21 页）。

2.4 冠心培元固本散

组成胎盘 2 具，鹿茸 50g，红参、灵脂、三七、琥珀、灵芝孢子粉各 100g，炮甲珠、血竭、水蛭、藏红花、全蝎各 50g，蜈蚣 100 条。

主治冠心病、心肌梗死。

案例血栓闭塞性脉管炎合并心肌梗死高某，男，51 岁。患双下肢血栓闭塞性脉管炎合并心肌下壁梗死，建议高位截肢。绝望之下求李氏诊治。见双下肢膝以下冰冷，足趾青紫，电击样剧痛不休，左下肢麻木，脉沉细迟微，双足背动脉消失。面色苍白晦暗，畏寒神倦。证属脱疽重症及真心痛。遂拟乌头汤合当归四逆加吴茱萸生姜汤，加虫类药入络搜剔，麝香辟秽通窍，昼夜连服。服 1 剂，当夜安然入睡。又连服 3 剂，诸症均退。原左足大趾之溃疡亦收口愈合，下肢电剧击样痛及心绞痛亦消失。予培元固本散加味善后：胎盘 2 具，鹿茸 50g，红参、灵脂、三七、琥珀、灵芝孢子粉各 100g，炮甲珠、血竭、水蛭、藏红花、全蝎各 50g，蜈蚣 100 条，葛根 100g，蛤蚧 5 对，冬虫草 50g。百日后心电图复查无异常，3 次 CT 复查病灶了无痕迹，值得深入研究（246、400 页）。

2.5 血栓培元固本散

组成红参、灵脂、三七、琥珀、土元、水蛭、全蝎、蜈蚣、血竭各 30g。每日另用黄芪 60 克，煎浓汤送服散剂。

主治脑血栓、脑梗塞后遗症。弛缓性瘫痪加服制马钱子粉，每睡前温开水送下 0.6 克，服 7 日停 3 日，以防蓄积中毒，气虚甚者服补阳还五汤 10 剂。

案例脑血栓张某，男，69 岁。高大肥胖体型，昨晚突觉右肢麻木，今晨醒来已偏瘫，嘴向歪斜，漏气漏饭，舌短，语蹇，头晕气短，按脉浮软，舌淡胖有齿痕，舌左边瘀斑成片。以补阳还五汤加味，3 剂。二诊：每日配针灸曲池透少海，合谷透后溪、阳陵透阴陵等，口眼歪斜已愈，语言饮食已无碍，手脚可抬举。效不更方，原方 3 剂。三诊：生活已能自理。予培元固本散：胎盘、红参、三七、琥珀、全蝎、蜈蚣各 30 克（38 页）。

2.6 肝硬培元固本散

组成胎盘 1 具，鹿茸、红参、灵脂各 50g，三七 100g，琥珀 50g，土元、水蛭、全蝎、蜈蚣各 100g。

主治肝硬化。

案例肝硬化腹水陈某，女，60 岁。患肝硬化 7 年，重度腹水，肚大如瓮，青筋外露，畏寒不渴，下肢烂肿，胸背四肢布满蜘蛛痣，面黧黑，肌肤甲错，便燥如羊粪球，三五日一行。左天枢压痛甚著，脉沉弦，舌淡胖有齿痕，舌尖、舌左边瘀斑成片。予真武汤加红参、灵脂、麻黄各 10 克，大黄蛰虫丸 2 丸（包煎），温通之。一服得汗，小便日夜 2000 毫升以上，下瘀泥样黑便，日二行，稍见气怯。原方去麻黄，又服 10 剂，腹水消尽。予培元固本散加味（上方），服完痊愈。随访至 80 高龄，甚健壮（401 页）。

2.7 溃疡培元固本散

组成红参、灵脂、三七、琥珀、鱼鳔、大贝、乌贼、煅牡蛎、灵芝孢子粉、凤凰衣各 30g。肾虚者加鹿茸，消化迟滞加内金，慢性出血加血竭，痛甚者加醋元胡。

主治胃溃疡、十二指肠溃疡。一般服药 40 天，多根治。

案例胃溃疡大出血武某，男，41 岁。患者胃溃疡大出血病危，酒醉后吐血盈碗，沥青样黑糊便，血色素 5 克。因体质过虚，暂不宜手术。诊见面色、唇、指如白纸，食入即吐，神糊思睡，四肢冷，头晕不能起立，立则气喘自汗。脉迟细弱，48 次/分。频频呕吐，药难下咽，急则治标：赭石、生半夏、高丽参（另炖）、茯苓各 30g，吴茱萸、炙草各 15g，生姜 30g，姜汁 20 毫升，大枣 12 枚。小量频服，药后 2 小时呕止。遂投破格救心汤合三畏汤（人参、灵脂、油桂、赤石脂、丁香、郁金）加味。服 1 剂，大便潜血（一）。服 6 剂血色素上升至 9 克，日可进食斤许，出入已如常人。后以加味培元固本散：胎盘、鹿茸、高丽参、三七、琥珀、鱼鳔、大贝、煅牡蛎、凤凰衣、内金、血竭各 30g，蛤蚧 3 对。月余后医院复查，溃疡痊愈，随访 30 年健康逾于病前（15 页）。

2.8 疝积培元固本散

组成胎盘 1 具，鹿茸、红参、三七、蛋壳、鸡内金、炒二芽各 30g。每服 1 克，日 3 次，少许红白糖水调服。

主治小儿疳积。有潮热者，先服补中益气汤加乌梅、山萸肉、龙牡、焦三仙，至潮热退净，能食易饥时服散剂。

案例如丁奚疳重症案（86 页）。

2.9 类关培元固本散

组成胎盘 1 具，鹿茸、红参、三七、琥珀、血竭、炮甲珠各 30g，合偏正头风散（或以全蝎、蜈蚣各 30g 代之），加豨薟草，治类风湿有卓效。

主治类风湿性关节炎（243 页）。

案例如类风湿性关节炎合并硬皮病案（210 页）。

2.10 妇科培元固本散

组成红参、灵脂、三七、琥珀、土元、水蛭、全蝎、蜈蚣、川贝、桂枝、茯苓、丹皮、桃仁各 30g。上药以夏枯草、漂海藻、甘草各 500 克，熬膏，加炼蜜为丸 10 克，日服 3 次，每次 1 丸，肾虚畏寒者，加油桂。

主治子宫肌瘤、卵巢囊肿。用本方治二症 70 余例，均于 2 个月内治愈，其中瘤体最大者 15 公分。

案例如子宫肌瘤案（100 页）、多囊卵巢致不孕案（104 页）。

2.11 内障培元固本散

组成胎盘、鹿茸、红参、灵脂、三七、琥珀、川贝、夜明砂、沙苑子、乌贼骨、珍珠粉各 30g。上药加夏枯草、漂海藻、甘草各 500 克，熬膏，加炼蜜为丸 10 克，日服 3 次，每次 1 丸。

主治老年性白内障。经治 10 余例，重者均于 2 个月左右视力恢复。轻者服明目退翳汤半月左右即愈（402 页）。

案例如老年性白内障案（269 页）。

从李氏之培元固本散 11 首类方及 26 则医案中，可以看出**六味培元固散的加减变化**：①鹿茸：去鹿茸者 12 例，如肺结核（304、311 页）、脑血管病（36、38、400 页）、丁奚疳（86 页）、暴崩（124 页）、子宫肌瘤（100 页）、卵巢囊肿（402 页）、恶性淋巴瘤（337 页）、脊髓神经胶质瘤（343 页）、食道癌案（350 页）；②五灵脂：去五灵脂者 12 例，如肺心病（376 页）、抱儿案（304 页）、风心病（21 页）、脑血栓（38 页）、小儿大脑发育不全（396 页）、疳积（86、396 页）、胃溃疡（390 页）、休息痢（149 页）、尿毒症（164 页）、类风湿（245 页）、过敏性鼻炎案（283 页）。这些细微之处，最宜深究。

3 培元固本治未病

李可关于愈病防犯的学术思想，主要表现在以下方面：

3.1 恪守疾病禁忌，以免重蹈覆辙李可认为，古人关于疾病禁忌之说，乃经验之谈。某病当禁某事，犯禁则引发宿疾，确有至理（319 页）。

3.1.1 皮科缠绵多犯禁下面看一则皮肤病犯禁医案：

银屑病韩某，男，22岁。患银屑病2年，近因搔破感染，痒痛夜不能寐，双手背肿胀青紫，血痂累累，右腿内侧上1/3处粗糙溃烂，焮赤肿痛，腹股沟淋巴结肿硬疼痛，举步艰难。心烦口渴，舌红无苔，脉沉滑数。症由嗜酒无度，湿热深伏血分，蕴久化热化毒。拟乌蛇荣皮汤（生地、当归各30g，桂枝10g，赤芍15g，川芎、桃仁、红花各10g，丹皮、紫草各15g，制首乌、白蒺藜、白藓皮、乌蛇各30g，炙草10g，生姜10片，大枣10枚）加味。上药服5剂诸症均愈。小青年不遵守禁忌，恣食鱼虾酒酪，数日又发。留有旧方，照方取药，服三五剂又愈（319页）。

按西医银屑病，即中医之牛皮癣，至今原因不明，但对海鲜酒酪多表现了迟发性或蓄积性过敏，即中医所谓“嗜食无度，湿热蕴久化毒”所致。本案小青年不遵禁忌，时隔数日又发，便验证了李可“皮肤病之缠绵难愈多与不遵守禁忌有关”的道理。

3.1.2 创伤痈疽禁房事下面看一则痈疽犯禁医案：

血栓闭塞性脉管炎高某，男，56岁。3年前因双下肢血栓闭塞性脉管炎而齐膝截肢。术后肆酒无度，不遵禁忌，日吸烟3-4盒，截肢处开始电击样剧痛，周围紫红溃烂，脓水秽臭，腐烂见骨。六脉洪数而虚，舌红少苔。近2个月3次发作心绞痛。证属湿热化毒，血瘀气弱，又兼真心痛。遂予重剂四妙勇安汤合丹参饮加味。服药2剂时，患处灼热、剧痛消失。第4日脓水消失，第5日溃烂处收口结疤，第6日结疤脱落，肉芽嫩红，心绞痛亦愈。原方又服3剂，遂愈。事隔3月，又托人请诊。见患处又开始脓水淋漓，周围紫黑、秽臭，剧痛夜不能寐。诊脉洪大无伦，腰困微喘，损伤肾气，生命根基动摇，百药难施，已无能为力，终至不治（60页）。

按本案复诊时，李可见患处周围紫黑秽臭，腰困微喘，便知其行为不检，犯房室之忌，肾气败亡，遂婉辞。他进一步指出，一切创伤、痈疽皆当禁房事，若犯禁，轻则愈合后留有黑疤，重则肾气败亡而死，绝非危言耸听（69页）。

3.1.3 因果腹命夭折下面看一则饮食犯禁医案：

小儿白血病程某，男，13岁。两个月前患急性粒细胞型白血病，白细胞36万，血色素4克，高热寒战，鼻血如注，大便如柏油状，经抢救脱险。用化疗2疗程后，处于弥留状态。诊见唇指白如麻纸，眩晕不能坐立，纳呆日进1-2两，五心烦热，心动震衣，自汗如洗。遂以当归补血汤合生脉散加味，重用参芪、山萸益气固脱。首剂得效，服3剂可起坐，服10剂能下床散步，日可进食1斤多。不料前日忽然泛呕泄泻，脐下筑动应衣，下肢发凉，脉浮尺虚。此必久病伤肾，厥脱先兆。姑以当归补血汤合理中汤加温养肾命之品，服2剂胃寒退，泻止脉敛，服5剂脐动隐，元阳固，可户外玩耍，10剂后已如常人，血色素升至7.5克，白细胞降至2万7千。原方守服，加参鹿膏。李氏嘱病家慎饮食，避风寒，以防不测。不料1周后，其母高热昏迷，买一大西瓜，病孩乘其父外出配药偷吃多

半个（约 5 斤），当夜腹痛作泻，急用大剂参附龙牡山萸肉，投剂不应，不幸夭亡（369 页）。

按李氏一再叮咛病家“慎饮食，以防不测”，结果病孩只图果腹，当夜即腹痛作泻，滑脱不禁而夭折。

从李氏治急症疑难病诸案中，可以看出其愈症防犯的养生方法：①慎饮食：如小儿湿疹案，缘于其母在孕期过食辛辣发物，遗毒于胎儿所致（89 页）。②忌生冷：如胃下垂案，患者当忌生冷，结果病愈后就因食大桃 1 枚，旧病复发（254 页）。③避风寒：如脊髓神经胶质瘤案，就因经期夜卧开窗，入睡不关电扇，遂成顽疾（340 页）。④远悲喜：大虚之人，当戒大悲大喜。如宫颈癌案，患者服汤药 70 剂，已无病象。但因其夫暴病身亡，而悲伤过度而病逝（359 页）。⑤节房室：李氏从“宫颈癌患者妇检后，接触性出血数日不止”中悟出，宫颈癌患者当禁绝房事。可结果令他不胜慨叹：中年妇女患此，由于阴虚火旺，欲念极强，虽一再告诫，仍不免重蹈覆辙。余经治 16 例宫颈癌，唯两老妇得享天年，其余皆功败垂成，或愈后复发而死（361 页）。⑥长固本：李氏认为，治癌是持久战，瘤体的脱落，转移灶的消失，不等于癌毒的彻底消灭，仍须长期服培元固本散治本。因为“炉烟虽息，灰中有火”，一旦正气有亏，癌毒又成燎原之势（351 页）。如溶骨肉瘤案，服汤药已基本控制病情，因农民不堪重负，未遵嘱长期服培元固本散，半年后即病逝（352 页）。这些养生之道，看似极其平淡，但对于久损不复之大虚之人，就不是一般意义上的告诫，而是有针对性的、关系到生死存亡之大计。

3.2 培元固本治体，药分 3 个层次

李可认为，顽证痼疾若见腰困如折，缓解之后必多波折，为肾虚精怯，根基不固，宜加肾四味各 15-30 克，胡桃 6 枚打，以温养肝肾。虚馁过甚者，酌加小量血肉有情之品，峻补先天，如龟鹿二胶、鹿茸、胎盘。病情稳定后，服培元固本散 1-2 个月，以修复受损脏器，重建人体免疫力，以求根治（16 页）。从中可以看出，**培元固本之用药分为 3 个层次**：①补肾精、益肾气，**肾四味**：**肾四味由枸杞子、菟丝子、补骨脂、仙灵脾组成**。凡遇下元亏损，肾阳虚未至手足厥逆，肾阴亏未至舌光无苔，而属肾气、肾精不足之证，如腰困如折，头目昏眩，记忆衰退，阳痿遗精，老人小便余沥，夜尿频多，足膝酸软，不纳之喘，小儿遗尿，久病及肾等。贫穷病人可代价昂之鹿茸（180 页）。这最后一语（肾四味是植物鹿茸），便破道了肾四味之真谛，他在全书中使用之近 70 例，便是明证。②填补肾督，龟鹿二胶、鹿茸、胎盘：久病阴损及阳，兼及八脉多用之，如虚劳、妇科血征、颈椎病、帕金森氏症等。治颈椎病，则龟鹿二胶与鹿茸可同用，如颈椎病案（217 页）；而治肺癆，恒用龟鹿二胶，而不用鹿茸，如抱儿癆案（304 页）；③培元固本，培元固本散：上述 2 层次用药，是与汤药并进；而培元固本散，是用于缓解期以善后，确保终生不犯。如尿毒症案，予培元固本散巩固，随访 5 年一切如常（164 页）。

3.3 万病不治求脾肾，不治之治最上乘

一切久损不复之大虚证，波及五脏，百病丛生，这时该从何处入手？李可认为，中医有“万病不治，求于脾肾”的论断，在危重疑难病的治疗上，确有起死回生之效。脾胃一伤，百药难施，故保护脾胃为第一要义；命门一衰，诸病丛生，较脾胃之伤，又深一层。故固本则枝荣，此即本方“培元固本”之义（307、396页）。培元固本散，以胎盘，鹿茸填补先天，重健免疫屏障；红参、灵脂启脾进食，保护脾胃为第一要义；本方与三七、琥珀合用，补中有通，兼有活血、化痰、消积作用，可修复脏器损伤，再造人体免疫之功。故李可又进一步指出，前人有“但扶其正，听邪自去”的说法，确有至理。它调动了人体的正气（自然疗能）去战胜疾病，这就是中医的整体论，“不治之治”乃是治法中的最高境界（177页）。

李可关于愈病防犯的思路，现归纳如下：恪守疾病禁忌，以免重蹈覆辙；培元固本治体，药分3个层次；万病不治求脾肾，不治之治最上乘。

热病急症汗清下

——李可学术思想探讨之九

简介：针对热病治疗规律，进一步探讨了李可学术思想。李可治热病经方：麻杏石甘汤，白虎汤承气汤，大黄牡丹汤，小柴胡汤，大柴胡汤，猪苓汤；治热病自制方：犀四味，贯众石膏汤，羚麝止痉散，癍闭散，辟秽解毒汤，攻毒承气汤，攻承大柴胡汤；治热病特色：巧施汗清下，经方联合用，煎法别一格，霹雳手段攻；治热病思路：师仲景，遵六经，汗清下，统温病；承气汤，融解毒，创7方，探新径。

关键字：热病汗清下 羚麝止痉散 辟秽解毒汤 贯众石膏汤 攻毒承气汤 李可 医案

早在《内经》中，对热性病的治疗原则即有阐述。而汉代张仲景，对热病不仅用六经来归纳分析证候，辨别其性质与转归，而且具体提出汗、清、吐、下4种排泄毒素的方法，从理论和实践上发展了热病治则。李可治热病不用后世温病方，走“古中医”自身发展的道路，取得了令人瞩目的疗效。现根据其医案，整理出以下内容：

1 热病验案

李可之热病理论很少，仅散见于医案。必须先看其医案，然后再进行理论探讨。

1.1 急性肺炎合并急惊风

王某，男，4个月。因急性肺炎高热抽风入院，历一昼夜不能控制。患儿高热昏迷，体温39.70℃，牙关紧闭，角弓反张，两目上翻，痰壅鼻扇，频频抽搐，约5-6分钟一次。唇指青紫，四肢厥冷，体若燔炭，紫纹直透命关。证属风热犯肺，痰热内结，热极动风，邪陷心包。急以三棱针点刺十宣、双耳尖、百会、大椎出血。患儿大哭出声，全身汗出，四肢回温。以毫针飞针点刺涌泉、合谷、人中，雀啄术刺素寥约1分钟，患儿苏醒，抽搐亦止。令先服羚麝止痉散1克，加麝香0.3克。为疏清热熄风，宣肺涤痰，开窍止痉之剂：石膏30g，麻黄、杏仁、甘草、丹皮、紫草、天竺黄各10g，芦根30g，蚤休15g，竹沥20毫升，葶苈子10g，大枣10枚。煎汁60毫升，服至35毫升、散剂3次而愈。所剩药汁弃之不用，给散剂2次量，以防余热复炽（72页）。

李按 本案因急性肺炎，故以麻杏石甘汤为主。其中**石膏、丹皮、紫草，三药合用可代犀角，退高热奇效**。蚤休为清热解毒，熄风定惊要药，可治一切毒蛇、毒虫咬伤，解毒力最强，可清除入血之病毒而护心醒脑，又独有止痉功效，故为方中主药。**羚麝止痉散（羚羊角3g，麝香1克，蝎尾12只，蜈蚣2条为末，分3次服）**，为余急救小儿高热惊风开窍醒脑常备药。轻症单服立效，不必配服汤剂。此患儿有窒息之险，故另加麝香0.3克立解其危。

1.2 小儿流脑

温某，男，13岁。上学途中突然高热寒战，头痛呕吐昏厥，被校长抱回家中。经注射青霉素、安乃近不能控制，邀余诊治。体温39.70℃，颈项强直，频频抽搐，角弓反张，喷射状呕吐，体若燔炭，四肢厥冷，胸背部瘀点、瘀斑，神昏谵语，溲赤便结，大渴饮冷，脉滑数，牙关紧闭，不能察舌。已查血，白细胞2万、中性90，建议查脑脊液，家长拒绝。脑膜刺激征阳性。同学已有人患病住院及死亡，见症符合暴发型脑炎特征。逐急以三棱针重刺十宣、十二井、百会、大椎出血，双手中缝穴刺泄粘液、黑血。毫针雀啄术泻涌泉，点刺素寥、人中、合谷。针后病孩全身透汗，呕止苏醒。再查体温已降1度。辨证属瘟毒炽盛，气血两燔，热深厥深，入营动血，热结阳明，引动肝风，邪闭心包重症。予清瘟解毒，清气凉血，荡涤邪热，开窍熄风为治：①羚麝止痉散15克，玉枢丹2瓶，匀作5份，2小时1次。②石膏200g，丹皮、紫草、蚤休各15g，双花60g，连翘、生地、大青叶、芦根各30g，大黄、甘草各15g，青黛10g（包煎），芒硝15g（冲化），加冷水1500毫升，浸泡1小时，急火煮沸10分钟，取汁1000毫升，3小时服1次，每次200毫升，昼夜连服。二诊：于24小时内服完1剂，服至第3次后，泻下恶臭便2次，热退，抽搐止，头痛、呕吐亦止，脱险。今日体温38℃，气短有汗，呼吸弱，语音低，舌红脉数。气津耗伤，正气欲脱。原方石膏减半，去玉枢丹、硝黄、羚麝止痉，加西洋参15g，麦冬20g，五味子10g，2剂。每剂分6次服，3小时1次，昼夜连服。服1剂，热退净，知饥索食，2剂服完康复，10日后复学（78页）。

李按 流脑发病急，病势凶险，余所经病例，很少有按卫气营血演变者，起病即见气血两燔，热结阳明，动风惊厥，邪陷心包，故下不厌早。大黄荡涤热毒，釜底抽薪，对毒血症、脑病变，有迅速降低脑压，减轻脑部瘀血水肿之效。

1.3 疹毒内陷

康某，女，3岁。春患麻疹，体质健壮，至第4日疹已大部透发，不料其母又抱孩子外出，触冒风寒及秽浊之气，致麻疹突然回没，热毒内攻，高热400C，剧烈咳嗽，喘急鼻扇，唇指青紫。经用青霉素2日无效，高热不退，反增神昏惊厥，角弓反张。医生认为病程超过7天，血液中毒，呼吸循环衰竭，已无能为力。邀余诊治，诊见病孩昏迷抽搐，胸高喘急，胸腹灼热烫手，膝以下冰冷，口唇干裂，舌绛起刺，已3日不能吮乳，大小便俱闭。证属疹毒内攻之后，熏灼脏腑，不仅热毒闭肺，且已内陷心肝，引动肝风，蔽阻神明。先重刺十宣、二井出血，泻天井以透疹，重刺人中以醒神开窍，病孩啼哭出声。遂疏大剂人参白虎承气合麻杏石甘汤，通腑泻热，急下存阴，宣肺开闭：①石膏200g，西洋参20g（另炖），麻黄、杏仁、炙草、葶苈子、大黄、芒硝、皂刺、桃仁、红花、丹皮、紫草、赤芍各10g，蚤休15g，元参、芦根各30g，大枣10枚。②羚麝止痉散5g，牛黄、麝香、熊胆各1g，匀作8份，辟秽开窍，透疹熄风。③鸡冠血10毫升，入血透发疹毒。④外搓法：荞麦面2两，蛋清和匀，滴入香油数滴，搓成面团，反复搓擦背部，拔毒透疹。上药，急火煎汤400毫升，对化芒硝，频频灌之，每次对入散剂1份，鸡冠血3毫升，半小时1次。服药4次，搓擦2次，泻恶臭便1次，小便亦通，高热退至38.70C，下肢已暖，疹毒外透，全身麻疹复出，喘定咳减。全剂服完，又泻下2次，开始吮乳，脱险（81页）。

按针对“疹性喜透，非透不解”，李氏先以针刺十宣、十二井出血，泻天井以透疹，羚麝止痉散开窍透邪，汤剂之皂刺透血分伏毒，鸡血入血透发疹毒，其外搓法，使皮肤毛细血管充血，促使疹毒外透，将“透”贯彻始终。

1.4 中毒型菌痢

赵某，女，30岁。患者高热41C，昏迷呕吐腹痛。白血球19500、中性90，面赤如醉，谵语躁动，口气秽臭，脉滑实，舌苔黄燥起芒刺。诊为中毒性菌痢，邀余会诊。急以三棱针刺十宣出血，毫针重刺素寥穴，患者大汗苏醒，询之，腹痛后重，欲便不能。再以消毒针管从尺泽穴抽黑血4毫升，腹痛呕吐亦止。乃疏大剂辟秽解毒汤：双花90g，白头翁30g，香薷、藿香、佩兰、川连、肉桂、牛子（炒捣）、甘草各10g，白芍30g，炒扁豆12g，菖蒲12g，酒大黄30g，2剂。日夜连服，2小时1次。服1剂半，得畅泻，病愈出院（144页）。

李按 本方重用大队芳香化湿辟秽之品，透邪于外；重用双花、大黄、白头翁、黄连扫荡于内。且运用大剂频投、一鼓作气、日夜连服之法，使盘踞三焦之病毒，荡涤尽净，多数可救人于顷刻。此后多年，凡遇疫毒病，即投此方，疗效可靠。轻症1剂可愈，重症2剂必愈，极少有用3剂者。其中针刺放血疗法，其解毒退热醒神之效，不可轻视。

1.5 慢性肾盂肾炎急性感染

亚某，女，40岁。因连续熬夜排练、演出，于黎明时突然少腹绞痛，小便滴沥难通，每隔1-2分钟，即要小便1次，灼痛如刀割。发热烦渴，里急欲便不能，辗转颠倒，痛苦莫可名状。脉沉数实，舌红苔黄而干。诉三四年以来，每逢过劳即发，一发则十天半月不愈。当日化验：白细胞1900，蛋白++++。内科诊为慢性肾盂肾炎合并急性感染，已服呋喃坦啶、注射青霉素无效。证虽久延，但见前后不通，仍属湿热蕴蓄下焦之实证。而劳伤之体，例同无粮之师，利在速战，邪去则正安：大黄15g，海金沙、泽泻、血琥珀各9g，蜈蚣6条，全蝎12只，共研细粉，分作3包，每包以蛋清2枚调糊，热黄酒1两冲服，3小时1次。服散剂1包，1刻钟后尿出带有血条之小便约200毫升；服第二包，泻下恶臭便半痰盂，热退痛止，嘱剩余药弃之不用。次日觉尿道仍感灼热，气短不思饮食，四肢乏力，烦渴喜饮，脉沉数，舌红少苔。气阴已伤，拟猪苓汤滋阴通淋，加白参益气，沙参、乌梅酸甘化阴：阿胶20g（化入），茯苓30g，猪苓、泽泻12g，滑石30g，白人参20g（另炖），沙参、乌梅各30g，甘草6g。3剂后其病遂愈，随访7年未发（160页）。

按 本案属湿热蕴蓄下焦，三焦气化不行。劳伤之体，利在速战速决，急以大黄通下泻热，海金沙、泽泻、琥珀利湿通淋，虫类药善通膀胱窍道，1剂而安。此散为李氏治泌尿系感染致癃闭症急救常备药，故笔者称之为“癃闭散”，详见急性前列腺炎之癃闭案（156页）。

1.6 阑尾脓肿合并肠梗阻

任某，女，48岁。患者取右侧位卧于炕上，痛苦呻吟，频频呕吐秽臭粘涎并夹有黑便，豆粒大之汗珠从头部淋漓滴下。右腿弯曲不敢稍伸，阑尾部有包块，隆起馒头大，外观红肿，痛不可近。扪之灼热，有波动感。腹胀如瓮，阵阵绞痛，已三日不便，亦不能矢气，小便赤热刺痛。高热寒战，叩齿咯咯有声。腋下体温39.5℃，口气秽臭，舌黑起刺、干涩。可断为肠痈脓成，热毒壅闭三焦、阳明腑实之关格大证，建议手术治疗，但患者畏惧开刀，宁死不去。李氏拟攻毒承气汤加味：①生白萝卜2.5公斤，芒硝120克，加水5000毫升同煎，分3次入萝卜，待熟煮一批，捞出再换一批，得浓汁缩至500毫升，备用。②双花240g，连翘、苡仁、赤芍、桃仁、厚朴、槟榔、芙蓉叶、芦根各30g，冬瓜仁60g，生大黄45g，丹皮、枳实各15g，皂刺、炮甲、白芷、甘草各10g，木香、沉香各3g（磨汁对入）。加水过药二寸，加白酒100毫升，浸泡40分钟，然后武火急煎10分钟，取汁1000毫升，与方一混合，每隔2小时服300毫升，连续服用，以通为度。第一次服药后两小时，腹中绞痛，上下翻滚，腹中阵阵雷鸣，频频打嗝矢气。幸得三焦气机升降已复，乃一鼓作气，再进300毫升，患者欲便仍未便下，但胀痛已大为松缓。3小时后又进300毫升，药后3小时便下黑如污泥，极臭，夹有硬结成条、块状粪便及脓血状物一大便盆。随即索食面条1碗，安然入睡。

次日清晨，阑尾部之包块已消，仍有压痛，体温 37℃，舌上黑苔退净，六脉和缓从容。予清肠饮倍苡仁，加芙蓉叶、甲珠、皂刺以清余邪，3 剂而愈（128 页）。

李按 本案所用方剂：硝菴通结汤，其软坚润下通便之功甚为卓著，且无伤正之弊，虚人、老人之肠梗阻用之最宜；大黄牡丹汤加味而成之攻毒承气汤，方中破格重用疮毒圣药金银花，善治一切大小痈疽、肿毒恶疮，消肿排脓止痛之芙蓉叶，更加苡仁、冬瓜仁、透脓散，清热解毒排脓。并以木香、沉香磨汁对入，行气消胀、利水消肿之槟榔，配硝菴汤以破滞气，腑实一解，毒随便泄，沉疴立愈。

1.7 急性胆道蛔虫症并发急性胰腺炎

刘某，女，46 岁。患者于昨日早饭后上腹绞痛，频频呕吐，下午 4 时，吐出蛔虫 1 条，剧痛部位扩展至右上腹，疼痛剧烈，一度休克，注射杜冷丁 1 支未效。今日持续性、阵发性绞痛加剧，满腹拒按，手不可近，反跳痛，寒热如疟，体温 39.0℃，血象白细胞 18500 毫升、中性 90，初步诊断：急性胆道蛔虫症合并急性胰腺炎。询知患食肥甘酒酪，内蕴湿热，脉沉弦数实，苔黄厚燥，口苦、口臭。近日食滞，7 日不便，复加蛔虫内扰，窜入胆道、胰腺发炎。邪热壅阻脾胃肝胆，已成热实结胸、阳阴腑实重症，拟方如下：①舌下金津，玉液穴刺泻黑血，双尺泽穴抽取黑血 2 毫升，左足三里，右阳陵泉透阴陵泉，提插捻转泻法，留针半小时，针后呕吐止，剧痛缓解。②拟攻毒承气汤合大柴胡汤、乌梅丸化裁：柴胡 125g，黄芩 45g，生半夏 60g，白芍 45g，枳实、丹皮、大黄（酒浸后下）、槟榔、甘草各 30g，桃仁 15g，冬瓜仁 60g，乌梅 30g，川椒、黄连各 10g，细辛 15g，双花 90g，连翘 45g，芙蓉叶 30g，芒硝 40g（分冲），生姜 75g，大枣 12 枚。加水 2000 毫升，浸泡 1 小时，武火急煎 10 分钟，取汁 600 毫升，3 次分服，3 小时 1 次，日夜连服 2 剂，以阻断病势。二诊：服第 1 次药，2 小时后腹中雷鸣，频转矢气，呕止，痛去十之七八，仍无便意。令将 2 次药汁一并服下，2 小时后畅泻黑如污泥，极臭、极热，夹有如羊粪大便 1 大盆及蛔虫 3 条，痛全止，热退净。嘱其第 2 剂药去芒硝。服完又畅泻 2 次，泻下蛔虫 1 团，安睡一夜。次日化验血象已无异常，热退痛止，患者要求出院（140 页）。

李按 现代医学所称胆道系统疾病及胰腺急性炎变，与大陷胸汤证、大柴胡汤证之论述，基本合拍。故以大柴胡汤为核心组方，正是最佳方案。经治急性胰腺炎 6 例，急性胆囊炎、胆石症、胆绞痛 70 余例均愈。针刺与放血，在止痛、止呕、退高热方面起到了顿杀病势的效果，为辨证用药扫清了障碍。

2 攻毒承气汤

2.1 攻毒承气汤组成

笔者根据攻毒承气汤之医案 6 则，从反复出现的药物中筛选出以下 13 味药：组成双花 90-240g，连翘 30g，芙蓉叶 30g，大黄 10-45g，芒硝 15-40g，丹皮 15g，冬瓜仁 60g，桃仁 15g，皂刺、炮甲各 10g，槟榔 30g，苡仁 30-45g，甘草 10g。

功能清热解毒，通腑泻热，扫荡血毒。

主治急性阑尾炎，急性胰腺炎，重症肺病、肝病，外科创伤血症（130、135页）。

加减法合并肠梗阻，加硝菴通结汤：合并脓毒血症，或神昏谵语者，加犀四味（石膏、丹皮、紫草、蚤休）；急性胰腺炎，加大柴胡汤、金铃子散，重用柴胡 125g；未化脓者，减透脓散。

煎服法加水过药 2 寸，加白酒 100 毫升，浸泡 40 分钟；若嗜酒致病者，则不加白酒，浸泡 1 小时，武火急煎 10 分钟，煎取 600-1000-3000 毫升，2-3 小时 1 次，每次 200-300 毫升，日夜连服，以阻断病势。

按攻毒承气汤之“攻毒”是指什么，而“承气”又指什么？这得从其最大方和最小方来分析。最大方者，含有攻毒承气汤之 13 味药，如阑尾脓肿合并肠梗阻案（129 页）；最小方者仅含攻毒承气汤之 3 味药（双花、连翘、大黄），如脓疮内攻案（332 页）。其“攻毒”当指银翘、芙蓉叶，“承气”是指大黄牡丹汤。但李氏又指出，本方重用疮毒圣药金银花，善治一切大小痈疽、肿毒恶疮；大黄一味，号称将军，扫荡毒邪，拨乱反正（130、333 页）。简而言之，“攻毒”即指双花，承气又指大黄。

2.2 攻毒承气汤类案的启示

李氏在书中提到“攻毒承气汤”仅 6 例，如阑尾脓肿合并肠梗阻、化脓性阑尾炎合并重症腹膜炎、急性胆道蛔虫症并发急性胰腺炎、急性子宫内膜炎、耳源性脑炎、脓疮内攻诸案。还有许多虽是攻毒承气汤类案，如小儿流脑案之银翘、硝黄、丹皮、紫草、蚤休等，是典型之攻毒承气汤，他却不称其为“攻毒承气汤化裁”，这是为什么？笔者分析，这是因为小儿急症案是在外科急腹症之前，不能先提及，诸如小儿急性肺炎合并急惊风、疹毒内陷案均属此类。还有，如中毒性菌痢、急黄肝昏迷（177 页）、慢性肾盂肾炎急性感染（160 页）、脚气攻心（214 页）、秋季结膜炎重症（267 页）、恶性淋巴瘤（336 页）、宫颈癌诸案（360 页），均有攻毒承气汤之意，亦没提及之。这是因为他已列举了 6 例，此类案例没有必要再重复，读者可举一反三、融会贯通。我们从上面这 16 则攻毒承气汤案例中，应得到哪些启示？攻毒承气汤类案提示我们：

① 攻毒承气汤用于临床各科：攻毒承气汤不单为外科立法，还广泛用于内外妇儿、五官、皮肤、肿瘤各科，如急黄肝昏迷、急性子宫内膜炎、小儿疹毒内攻、耳源性脑炎、脓疮内攻、恶性淋巴瘤诸案。总之，“攻毒”并不限于双花，“承气”亦不限于大黄；只要符合“攻毒法”与“承气法”的药物，均可推而广之。

② 攻毒承气汤用于热病：攻毒承气汤不仅治急腹症，还广泛用于热病，如急性肺炎、小儿流脑、中毒性菌痢、急性肾盂肾炎诸案，这也是笔者为什么要在热病中大谈攻毒承气汤的道理。

③ 攻毒承气汤与破格救心汤：李氏不但善用附子、四逆；亦善用硝黄、承气，这都是经方的特色。笔者注意到：李氏在序言之自创方中只列举了破格救心汤与攻毒承气汤，说明能与破格救心汤并驾齐驱的，非它莫属。他把万病归为寒热 2 型，而破格救心汤和攻毒承气汤就是治之的两大法宝。

3 李可治热病特色

3.1 李可治热病经方

李氏治热病常用经方：①麻杏石甘汤：如小儿急性肺炎合并急惊风案、疹毒内攻案（71、81 页）；②白虎汤：如小儿流脑案、小儿急性肺炎案（71、77 页）；③承气汤：如急黄昏迷案、小儿流脑案（77、177 页）；④大黄牡丹汤：如疹毒内攻案（80 页）；⑤小柴胡汤：如瘟毒发斑之红斑狼疮案（203 案）；⑥大柴胡汤：如耳源性脑炎案（276 页）；⑦猪苓汤：泌尿系感染，恒用猪苓汤，如急性尿路感染、急性肾盂肾炎案（158、161 页）。

3.2 李可治热病自制方

李氏治热病自制方 7 首，其中 4 首已命名。为了便于记忆与推广，笔者将其它 3 方冠以名称，现归纳如下：

① **犀四味：肾四味**：可代昂贵之鹿茸，为李氏之创见。这四味药，类似于四君、四物汤之名方，所以笔者把它看作是补肾之成方。而犀角为热病急症之必用药，无奈已经禁用。经李氏多年临床实践发现，石膏、丹皮、紫草、蚤休可代犀角（72、396 页）。仿李氏肾四味之意，称其为“犀四味”，是治热病的凉血解毒方，退高热有奇效。其用量为石膏 30-250-500g，丹皮、紫草 10-15g，蚤休 15-30g。如小儿流脑案（77 页）。

② **贯众石膏汤**：用于瘟毒发斑，其组成为石膏 250g，贯众、黑小豆各 30g，西洋参、苍术各 15g，雄黄 0.3g（研末吞服），丹皮、紫草各 15g，青黛（包煎）、甘草各 10g。详见红斑狼疮案（203 页）；

③ **羚羊止痉散**：用于高热惊风，为小儿开窍醒脑常用药，羚羊角 3g，麝香 1g，蝎尾 12 只，蜈蚣 2 条为末，分 3 次服。详见小儿急性肺炎案（72 页）；

④ **癃闭散**：癃闭散用于湿热蕴蓄下焦之二便闭结，其组成为大黄 15g，海金沙、泽泻、血琥珀各 10g，蜈蚣 6 条，全蝎 12 只为末，分 3 次服。详见慢性肾盂肾炎急性感染案（160 页）；

⑤ **辟秽解毒汤**：用于中毒性痢疾，其组成为双花 90g，白头翁 30g，香薷、藿香、佩兰、川连、肉桂、牛子、甘草各 10g，白芍 30g，炒扁豆、菖蒲各 12g，酒大黄 15-30g。详见中毒型菌痢案（144 页）；

⑥ **攻毒承气汤**：用于急性阑尾炎、肺痈、肝痈、外科创伤血症，其组成为双花 90-240g，连翘 30g，芙蓉叶 30g，大黄 10-45g，芒硝 15-40g，丹皮 15g，冬瓜仁 60g，桃仁 15g，皂刺、炮甲各 10g，槟榔 30g，苡仁 30-45g，甘草 10g。详见阑尾脓肿合并肠梗阻案（129 页）；

⑦ **攻承大柴胡汤**：即攻毒承气汤加大柴胡汤，用于急性胰腺炎、急性胆囊炎、胆石症、胆绞痛、急性子宫内膜炎、耳源性脑炎、脓疮内攻等多种疾病。鉴于此方使用的机会比较多，应当起个简明而又顺口的名称加以推广，暂定为“攻毒大柴胡汤”，组成为柴胡 125g，黄芩 45g，生半夏 60g，白芍 45g，枳实、丹皮、大黄（酒浸后下）、槟榔、甘草各 30g，桃仁 15g，冬瓜仁 60g，双花 90g，连翘 45g，芙蓉叶 30g，芒硝 40g（分冲），生姜 75g，大枣 12 枚。详见急性胰腺炎案（141 页）。

3.3 李可治热病特色

3.3.1 巧施汗清下

3.3.1.1 汗法

伤寒用汗法，无可非议；而热病用汗法，就有争议了。李氏治热病之汗法，恒用麻杏石甘汤，宣开肺气，得汗而解。如小儿急性肺炎、疹毒内陷案（77、80 页）。他更善用针刺与放血，巧施汗法。如中毒型菌痢高热 41℃，昏迷呕吐腹痛。白血球 19500、中性 90，面赤如醉，谵语躁动，急以三棱针重刺十宣、双耳尖、大椎出血，随即全身汗出热减（71 页）；又如小儿流脑案亦然（76 页）。

3.3.1.2 清法

李氏之清法，喜用白虎汤，因知母苦寒滑肠，以芦根 30g 代之，详见疹毒内陷案（80 页）；凉血解毒，恒用犀四味，如小儿流脑案（26 页）；清热解毒，重用银翘，如急性子宫内膜炎案（134 页）。

3.3.1.3 下法

李氏之下法，常用调胃承气汤，如小儿流脑案（77 页）；或大黄牡丹汤，如阑尾脓肿合并腹膜炎案（132 页）；或大柴胡汤，如耳源性脑炎案（276 页）。

3.3.2 经方联合用

由于经方，药不过三五味，多用于一两个主证。而李氏用于热病重症，因变证丛生，常把数个经方连在一起，如小儿流脑案，即由人参白虎、调胃承气合麻杏石甘汤组成（77 页）；急性胰腺炎，以大柴胡、大黄牡丹合乌梅丸化裁（140 页）。

3.3.3 煎法别一格

小儿热病急症，加冷水浸泡 1 小时，武火急煎 10 分钟，取汁 200-600 毫升，3 岁以下，少量频服；5 岁以上，2-3 小时 1 次，日夜连服，保持血药浓度，中病弃之。急腹症，加水过药 2 寸，加白酒 100 毫升，以加速药物分解，浸泡 40 分钟，然后武火急煎 10 分钟，2-3 小时 1 次，每次 200-300 毫升，日夜连服，以通为度。

3.3.4 霹雳手段攻

李可认为，对于腑实、痈毒之患，可用霹雳手段，直捣病巢（27 页）。他对热病急症，亦常用霹雳手段攻邪：

① 针刺放血：急性子宫内膜炎，高热昏迷，喷射状呕吐，急以三棱针重刺十宣出血，双尺泽抽取黑血 10 毫升，全身透汗、苏醒，呕吐亦止（134 页）。小儿流脑，高热呕吐昏厥，经三棱针重刺十宣、十二井、百会、大椎出血，双手中缝穴刺泄粘液、黑血，随即汗出、呕止、苏醒，再查体温已降 1 度。可见针刺放血疗法，在止痛、止呕、退热方面起到了顿杀病势的效果，不可轻视（141 页）。

② 散剂救急：羚麝止痉散，是小儿高热惊风常备药，用于急性肺炎惊风、小儿流脑、小儿大脑发育不全、疹毒内陷、中风闭症等诸案。轻症单服立效。癰闭散亦然，详见急性前列腺炎、慢性肾盂肾炎急性感染案（156、160 页）。

③ 大剂频投：李可认为，用经方治大症，要大剂频投，日夜连服，方能阻断病势，立挽危亡（141 页）。如急性胰腺炎，予大剂大柴胡汤合并大黄牡丹汤、乌梅丸化裁，重用柴胡 125 克，生半夏 60 克等（140 页）。故有一剂知，二剂已之功效，如 1 剂病已者：详见阑尾脓肿合并肠梗阻（129 页）、急性子宫内膜炎（134 页）、小儿急性肺炎惊风（71 页）、疹毒内陷诸案（79 页）。

3.4 李可治热病思路

李氏治热病不用后世温病方，常用经方如麻杏石甘汤、白虎汤、承气汤、大黄牡丹汤、小柴胡汤、大柴胡汤、猪苓汤等，自制方如犀四味、贯众石膏汤、羚麝止痉散、癰闭散、辟秽解毒汤、攻毒承气汤、攻承大柴胡汤等。从这一系列自制方中不难发现，清热解毒贯穿于诸方始终，特别是把解毒法与承气法结合在一起，重用双花 240 克（关键在于其味甘、性微寒，而非苦寒、不伤胃），使承气汤、大黄牡丹汤发生质变，用于救治热病、急腹症，确有起死回生的神奇功效。李氏不但善用附子、四逆；亦善用硝黄、承气。他把万病归为寒热 2 型，而破格救心汤、攻毒承气汤就是治之的两大法宝。

从中可进一步感悟出李可治热病思路：师仲景，遵六经，汗清下，统温病；承气汤，融解毒，创 7 方，探新径。李氏在临床实践中，解决了长期以来用六经来统一温病之悬而未决的大问题，走出一条“古中医”自身发展的道路，应当引起中医界的关注。

阴阳盛衰发有时

——李可学术思想探讨之十

摘要：针对中医时间医学正处在整理研究阶段，进一步探讨了李可学术思想。李可关于时间辨证的方法：交节辨证、六经辨证、经络辨证、伏邪辨证；时间辨证的要领：阴阳盛衰、邪正交争、真假标本；时间辨证的特色：交节辨证规范、伏邪辨证新论、肺癆潮热新解。

关键词：中医时间医学 时间辨证 方法 要领 特色 李可 医案

自 1979 年美国人皮尔兹撰写《生物钟》一书翻译出版后，引起了我国中医界的极大兴趣，兴起了中医时间医学的整理研究热潮。事实上关于人体生命时间节律的发现，早在二千多年前的秦汉时期就有记载，如《内经》中的“四时五脏阴阳”理论，就是根据“天人相应”的观点，归纳出以人体五脏为主体，内系五官、五体、五神、五华等，对应自然环境的五方、五时、五气、五色、五味等所形成的五个功能系统，体现出中医学的人体内外环境的统一整体观。这种“四时五脏阴阳”的理论实质，反映出人体生命活动与自然界四时（春、夏、秋、冬）变化是同步的时间节律。认真整理我国历代医家有关时间证治的临床经验，就成为当前中医工作者的关注课题。李可在前人的基础上，对时间辨证的方法、要领、特色进行系统的整理和发挥。现根据其医案 60 余则，归纳出以下内容：

1 李可关于时间辨证的方法

李可关于时间辨证，主要有以下几种方法：

1.1 交节辨证

所谓“交节”，是指一年之二十四节气的更叠，或一日之四时的交替，即夜半相当于冬至，日中相当于夏至，晨旦相当于春分，日落相当于秋分。李可在论火不归原时指出，火不归原随阴阳盛衰之年节律、日节律演变，其天人相应现象最著，如冬至阳生则病，春令阳升转重，夏至阴胜渐缓，日出病作，日中病甚，日落病缓，入夜自愈（241 页）。简而言之，交节辨证是根据年节律、日节律而判断人体阴阳盛衰的治病方法。它多用于以下证候：

1.1.1 火不归原证 李可之火不归原案 17 则，其中按年节律辨证者 7 例，日节律辨证者 4 例。下面举例证之：

白塞氏综合症 包某，女，40 岁。冬至当日初诊，患口腔溃疡、外阴溃疡 6 年。发作多在每年冬季，尤以冬至，交节之时一到，立刻发病。经治多年无效。诊视，见舌红如柿，无苔，口干极而不欲饮。口角内侧，舌边尖部，白色溃疡成片。外阴每发病，先觉外阴辣痛，旋即口舌生疮。头晕如腾云驾雾，面部轰热如潮。按脉沉细，双膝独冷。其症发病甚急，说来就来，一二分钟即令人不能忍耐。此症，《金匱》谓之“狐惑”，由湿热生虫，蚀于喉为“惑”，蚀于阴为“狐”，治以清湿热而杀虫。此例病经多年，反复发作，未见湿热积毒征象。从脉证推断，恐系肾阴久亏，阴不敛阳。适逢冬至节令，一阳来复，龙雷之火不仅上燔，且肾与前阴相关，又且下焚，姑予引火汤 3 剂：熟地 90g、巴戟天、天麦冬各 30g、茯苓 15g、五味子 6g。药后诸症皆愈。此法并治 45 岁以上之男人多人，服药 1 剂，口舌疮即退，服 3 剂下阴部之溃疡亦了无痕迹（291 页）。

按 本案发作在每年冬季，尤以冬至当日，交节之时一到，立即发病，一二

分钟都不能忍耐，真是描写如绘，令人叫绝。

1.1.2 格阳、戴阳证 李氏之格阳、戴阳案，按交节辨证者 5 例，如足心发热案，为日轻夜重（236 页）。

1.1.3 奇经八脉证 李氏之奇经八脉案，按交节辨证者 3 例，如奇经八脉频发案，每晚 8 时准时发病（386 页）。

1.1.4 阳虚证 李氏之阳虚案，按交节辨证者 14 例，如经水不止心悸案，因心悸不敢夜卧、卧则心动震衣、手抖不停（229 页）。

1.1.5 伏邪 伏邪有交节发病的特点，如肺间质纤维化案，在子时、寅卯之交暴咳。缘于子时阴气大盛，阳不胜阴则咳久而难出；寅卯之交，日将出，阳气渐旺则咳时短而痰出较多（31 页）。

1.2 六经辨证

由于六经各有“欲解时”，根据各经在其所主的时辰内，功能相对旺盛的道理来判断疾病。刘力红在《思考中医》中指出，病人更关心的恐怕不是这个“欲解时”，而是疾病在什么时候发生或加剧。为此，他提出了“欲作时”概念，它（欲作时）必定就在与欲解时相反的位置上，即阴阳变化相反的位置上。如一咳嗽患者，若在半夜发作或加剧，那应该首先考虑太阳病，因为亥子丑与太阳的欲解时巳午未正相反。所以，“欲作时”对于疾病的诊断，具有更重要意义（22 页）。李可常用六经之“欲作时”来诊断疾病，如无热惊风成痿案中，幼儿夜半 2 时突然手足抽搐，角弓反张，牙关紧闭，两腿不能站立。由于营卫不固，子夜暴感寒邪，寒主收引，故频频抽搐（73 页）。又小儿暴喘案，下午喂肥肉两块，夜半突然暴喘痰壅，无汗、唇青、四肢欠温，证属寒喘夹食，以小青龙汤加莱菔子治之（83 页）。二者均为太阳“欲作时”之明证。

1.3 经络辨证

所谓“经络辨证”，是指十二经脉的时辰辨证。由于手太阴肺为十二经之首，而《内经》又有“寅”为一天之中阳气初生之时，于是根据“寅”时与手太阴肺相应而依次推论的，这说明每值某经的相应时辰其气血亦会相对旺盛的道理。李可亦用此法来判断疾病，如肺心病奇病案，每至寅时先觉脐下筑筑跃动，随即有冷气上攻至剑突，暴喘、自汗、心悸等。寅时发病者，属于手太阴肺，为十二经循行之始，说明经气起步难（375 页）。

1.4 伏邪辨证

伏邪不仅交节病作，还有其它时间特点：①经前必犯：如风心病合并冠心病案，每逢经期，诸证加剧（21 页）；②周期性发作：如重症痢疾疑癌变案，每隔月余即暴痢 1 次（152 页）；③久治不愈，反复发作：如休息痢案，患病 16

年，每年夏秋必发，服中药百剂不效（148 页）。

2 李可关于时间辨证的要领

李可在“溶骨肉瘤案”中指出，患者腰痛不能转侧，上午轻，下午重，入夜剧痛呻吟不能入睡。缘于久病阴损日甚，阳失依附而阳亦衰，乃症情“旦慧、昼安、夕加、夜甚”之所由来。而食后之寒热交作，亦非外感邪正交争，乃自身阴阳盛衰之变（351 页）。笔者根据此段话，悟出时间辨证的要领。

2.1 阴阳盛衰

阴阳盛衰，主要用于内伤之时辰辨证。所谓“自身阴阳盛衰之变”，是指内伤杂证之人体阴虚、阳虚、阴盛、阳盛，随着阴阳盛衰之年节律、日节律而发作或加剧的时辰疾病。如病以上午（或后半夜）出现或加重者，多属阴虚（或阳盛）病人。因为本身阴虚者（或阳盛者），又逢阳升（或阳生）之助，故病势更甚。同样的道理，证以下午（或前半夜）出现或加重者，大多属于阳虚（或阴盛）患者。现附验案，以为佐证：

咽痛寒证兼齿衄 牛某，男，50 岁。因齿衄年余不愈求治，近 1 月更增咽部干痛，痰多味咸，口干而不欲饮。食纳如常，偶见嘈杂泛酸。近 2 年异常发胖，体重增加 10 公斤，反不如过去精力旺盛。动则气喘，夜多小便，膝冷，脉沉细弱，舌淡胖有齿痕。牙龈色暗，血污满齿，日轻夜重，一觉醒来，满口黑紫血团。咽喉干痛，舌不能转动。曾用大剂量维 C，连服六神丸 22 瓶，出血、咽痛有增无减。脉证合参，确为命门火衰，少阴真寒证无疑。因胖为湿盛阳微，痰为阴邪，味咸为肾虚水泛；日轻夜重，为阳不胜阴；喘为肾不纳气；咽干痛不肿不渴，乃因肾脉循喉咙，系舌本，阴寒过重，逼下焦真火浮于咽喉要道；其齿衄从发胖后始见，齿为骨之余，骨乃肾所属；血属阴，必得阳旺始能统摄血循常道，阳衰失于统摄，故溢于外。乃投四逆汤：炙草 60g、附子、干姜各 30g，水煎冷服 3 剂。药后两证皆愈，唯觉腰困气短，加肾四味 120g，红参 10g，又服 3 剂，已康复如初，再无反复（289 页）。

按 此案既有阳虚的一面，如夜间尿频、膝冷、脉沉细弱；又有阴盛的一面，如体胖、痰多而咸、舌淡胖等。由于阳衰失于统摄，血溢于外，满口黑紫血团，日轻夜重。关键就在“阴阳盛衰”，而“盛衰”即“虚实”二字而已。如只论阴阳，而不分虚实，则往往误事。正所谓“知其要者，一言而终”是也。

2.2 邪正交争

邪正交争，主要用于外感或伏邪之时辰辨证。邪正交争之“邪”，当指外感或伏邪；而“正”是指正气，可引伸为自身之阴阳盛衰。所以，邪正交争既要分析邪气的表里、轻重等，又要判断正气的阴阳盛衰，然后把两方面的分析结合起来，作出全面的诊断。邪正交争的应用，大致分为两种情况：

①单纯外感辨证：如果是典型的六经病证，只要根据六经辨证就可得出结论，如发热待查案，每日下午 3~8 时高热，即可诊为阳明腑实证（183 页）；

②外感兼内伤：如肺间质纤维化案，既要分析外感伏邪，又要判断自身阴阳盛衰，最后综合判断：子时阴气大盛，阳不胜阴，故咳时久而痰难出；寅卯之时，日将出而阳气渐旺，故咳时短而痰出较多。由此得出，正气尚堪与邪交战，可挽之处，全在“发作有时”一节（31 页）。下面举例证之：

真热假寒 名医某，男，60 岁。冬至节后 2 日，忽患奇疾。如病似外感小恙，3 日后忽然昏迷。气息微弱，面色灰滞，手冷过肘，足冷过膝，头汗淋漓，神识似清似蒙，六脉似有似无。某医断为“伤寒，少阴亡阳，已属弥留，姑拟参附汤，聊尽人事”，邀余会诊，以定取舍。见证果如所云，然则室内秽气扑鼻，颇觉蹊跷。且证情突变，寸口脉乱难凭，摸其下三部之趺阳、太溪、太冲，则沉实有力，一息六至有余。欲观其舌，则病者昏昧，牙关牵紧，乃强刺颊车穴，以匙把撬开口，口中臭气熏人欲呕，舌面满布黄厚燥苔，中根已黑。询其小便，则如浓茶，亦有臊臭，大便 5 日未解。推按小腹板硬，至此，真相毕露。素知患者解放前吸食鸦片 20 余年，至今仍以樟脑酊维持精力，其脏腑积毒可知。且病在冬至之后，阴虚液亏之体，适值一阳来复，邪从热化、燥化，已由太阳转属阳明腑实，其肢厥乃热深厥深之变；神识昏蒙乃浊气上干神明；头汗粘手，亦属腑实熏蒸。种种见证悉为热闭阳明之腑，而非亡阳厥脱，且真寒证绝无口臭熏人之象。遂疏大承气合增液汤急下存阴，腑实一通，上闭即开：大黄 30g、芒硝（分冲）20g、枳实 15g、厚朴、生地、玄参、麦冬各 30g，煎分 2 次服，约 2 小时许，泻下恶臭便 1 次，被褥狼藉，移时神清而愈（52 页）。

按 此案病因病机盘根错节，既有吸鸦片病史、脏腑积毒在先，又逢冬至时节外感，老年阴亏之体而一阳来复，邪从热化、燥化，病由太阳转属阳明腑实，而肢厥乃热深厥深之变，为真热假寒。其脏腑辨证（指脏腑积毒）、交节之变和六经辨证纵横交错，堪称“邪正交争”之成功范例。

从中可以看出，外感邪正交争比自身阴阳之变更为复杂，是多种辨证方法的结合。因此在运用时，首先要抓住病因病机，侧重六经的，就用六经辨证；涉及交节的，就用交节辨证；若六经、交节还确定不了的，就用脏腑辨证等。

2.3 真假标本

李可在“奔豚兼脑鸣案”中指出，奔豚证分寒热二型，寒为本，热为标，寒证积聚日久，变生热证。患者在 30 岁时，即发现脐周绞痛，攻冲奔突达 50 年。老年之后，五液亏损，阴虚于下，故呈化热之势。每日病作，在凌晨 4 时前后，日重夜轻，寒热错杂（193 页）。笔者在上述“寒热标本”基础上，进一步感悟出“真假标本”之要领。

真假标本，主要用于真寒假热、真热假寒的时辰辨证。由于真寒假热、真热假寒都存在着标本问题，即真寒、真热是本，假热、假寒为标，其时辰辨证就有两种情况：

①时辰从本论：如“足心发热案”，自觉涌泉穴处呼呼往外冒火，日轻夜重，为下焦阳虚，阳不统阴，致阴火沸腾，其交节之变（日轻夜重）便是从本（从寒）而论（236 页）；“咽痛寒证案”，其假热如咽干痛、口舌生疮，日轻夜重，亦是从本而论（298 页）；

②时辰从标论：如“奔豚兼脑鸣案”，冲脉上攻应以寒为本，但患者高龄之后，阴虚于下，而呈脐周烧灼、尿赤便燥等化热之势，每日病作在凌晨 4 时之左右，日重夜轻，其交节之变（日重夜轻）便是从标（从热）而论（193 页）；“虚型红斑狼疮案”，每日午前一阵面赤如醉，过午渐消，真阳有外越之险，其交节之变亦是从标而论（202 页）；“阳虚型高血压案”，中午面赤如醉亦然（383 页）。

真寒假热、真热假寒证，是中医辨证的难点，而其时辰辨证又是难中之难。关键是要把握好“真假标本”。如真寒假热证，其“真寒”，是整体，而“假热”为局部。局部的“假热”，可以从标（从热），也可以从本（从寒），当依具体情况而定。如果“假热”表现为日重夜轻，就从标而论；若表现为日轻夜重，当从本立论。至于真热假寒证，也是同样的道理。总之，一切都要以人为本，谨守病机，不可拘执。

3 李可关于时间辨证的特色

李可关于时间辨证，主要有以下特色：

3.1 交节辨证规范

交节辨证，是李氏最常用的时辰辨证，用于火不归原者 11 例，格阳、戴阳者 5 例，奇经八脉者 3 例，阳虚者 14 例，伏邪者 7 例。从这 40 例医案中，可以看出交节辨证的成熟规范：

3.1.1 内容详实

下面看一则“内容详实”医案：

血管神经性头痛 李某，女，38 岁。患者因剧烈右偏头痛 7 日入院，诊为血管神经性头痛，经用安络痛、当归注射液穴位封闭不能控制，邀李氏会诊。自冬至近 1 个月以来，每到太阳出山便觉有热流上攻头面，面赤如醉，轰热难忍。一周前拂晓，突觉热流攻冲不止，右下颌角突然如电击、火灼，阵阵剧痛窜至右太阳，约 3~5 分钟发作 1 次。每日如此反复发作 10 余次，5 时痛起，日中痛剧，下午 5 时渐松，太阳落山痛止，入夜则如常人。便燥口干，双膝独冷，夜难成寐。

脉洪大而虚，舌光红无苔。脉证合参，当属肾阴亏损，阴不抱阳，水浅不养龙，故龙雷之火上奔无制。阴虚之患，寅末日将出而病，日中阳气大盛，故病重。日落阳气衰，得天时之助而暂愈。入夜阴气渐充，故如常人。法宜大剂滋水，导龙归海，引火归原，佐入酸甘柔肝缓急：熟地 90g、巴戟、天麦冬各 30g、茯苓 15g、五味子 6g、白芍 100g、炙草 30g、葛根 60g。二诊：药进 3 剂，当天热流攻冲之势大缓，次日轰热止而痛亦止。偶于下午 2~3 时有短暂发作，脉敛，面色转淡，舌上生出薄白苔，带原方 3 剂出院。追访 3 年未复发（239 页）。

按 本案自冬至近一个月以来，每到太阳出山便觉热流上攻，面赤如醉，轰热难忍。一周前拂晓，突觉热流攻冲不止，右下颌角突然如电击、火灼，阵阵剧痛窜至右太阳，约 3~5 分钟发作 1 次。每日如此反复发作 10 余次，5 时痛起，日中痛剧，下午 5 时渐松，太阳落山痛止，入夜如常人。从中可见“内容详实”之一斑。

3.1.2 情节生动

所谓“情节生动”，主要表现为“来势暴多急突变”。下面举例证之：

真寒假热 武某，男，57 岁。冬至当日，忽患口、舌、唇部生疮，其症颇急、颇奇。10 时发病，11 时即满口满舌如火灼。仓促之间，服用导赤散合凉膈散，其方甚轻，生地、连翘 10g，其余皆 3~5g。11 点半进头煎，药毕覆杯，立觉火从脐下直冲头面，双唇肿大如桃，舌亦肿痛更甚，且心烦懊恼，莫可名状。约 12 时半，其子邀诊。见患者面赤如醉，舌肿塞口，诉证不清。按脉洪大无论，重按则反如游丝，120 次/分，视其舌则边缘齿痕累累，有白色溃疡布满边尖。唇肿外翻，迸裂出血。问其二便，则大便干，小便未注意。口中亦无臭味。询其致病之由，其妻云：“年终总结，连续熬夜三晚后病”。问其渴否，患者摇头。此症颇费踌躇，望闻问切皆不得要领。犹疑之间，忽见患者扬手掷足，烦躁不可名状。进门时，仓促之间见其面赤如醉，细视之，则鲜艳光亮，如演员之涂油彩状。恍然悟及此与戴阳证之面赤如“妆”同义，唯戴阳证多见于外感临危之际，此则由内伤而来。摸其下肢，则果见足膝冰冷。此必下元久虚，恰值当日冬至阳生，阴不抱阳，龙火上奔无制。前医误作实火，妄用苦寒直折，致水焰烛天，不可收拾。急以大剂附桂八味冲服油桂，以救药误而和阴阳：附子、熟地、山药各 30g，茯苓、泽泻各 12g，五味子 10g，油桂 115g（冲），水煎冷服。患者服药 1 次，1 刻钟后安然入睡。2 小时许醒来，肿痛皆消，已无丝毫痕迹。次日复诊，口中仍觉麻辣，舌光红无苔，乃阴分受损见证。险证虽退，阴损未复，乃予大剂引火汤，两服痊愈（287 页）。

按 此案冬至当日 10 时发病，11 时即满口舌痛如火灼。11 点半误服小剂导赤散合凉膈散头煎，立觉火从脐下直冲头面，双唇肿大如桃，舌亦肿痛甚。12 点半李氏出诊，见患者面赤如醉，舌肿塞口，诉证不清。视其舌则边缘齿痕累累，

有白色溃疡满布，唇肿外翻，迸裂出血，扬手掷足，烦躁不安。发病前后仅两个半小时，戴阳之危症已显现，可谓“颇急、颇奇”是也。

3.1.3 逻辑严谨

所谓“逻辑严谨”，主要表现在类证鉴别。下面看一则类证鉴别案：

咽痛寒症 王某，男，50岁。患咽干痛、口舌生疮，用清心火、滋肾阴正治诸法，服药60余剂，六神丸、梅花点舌丹各1瓶，皆无效，渐渐食少、便秘、神倦，缠绵3月不愈。邀李可诊治，询知其症日轻夜重，不渴尿多，双膝冷痛，脉沉细，舌淡润。来势缓，虽屡屡误治，却无急变。知非火不归原证型。四末不温，非极烫之水不喝，直断为少阴真寒证。缘由少阴之脉循喉咙，挟舌本。若肾宫寒极，逼其火浮游于上，则成上假热、下真寒格局。宜与温少阴、逐里寒：炙草60g，干姜30g，附子30g，桔梗、益智仁各10g，水煎冷服2剂。二诊：药后诸证已减七八，原方续进2剂，痊愈（298页）。

按 本案近于戴阳证。为了进一步求证，必须从**戴阳与火不归原的鉴别**入手：
①寒热真假：火不归原之上热下寒俱真，而本案是上假热，如咽干痛不肿不渴；
②交节病作：火不归原遇阳则动、遇阴则静，而本案咽痛日轻夜重；
③暴急突变：火不归原来势暴急、顷刻突变，而本案屡屡误治，却无急变；
④附子用量：火不归原之阴损及阳型，其附子为小剂，而本案之附子为大剂。可谓细致入微，层次井然，不能不令人折服。

3.2 伏邪辨证新论

李可在仲景之“伏饮”观点基础上，对伏邪的概念、病因病机、治疗规律，进行系统整理和发挥，并归纳出伏邪发病的时间特点，是中医时间医学的新理论。例如：①交节病作：如伏寒奇证案，半夜子时必有冷气上攻胸际，气喘不能接续（380页）；②经前必犯：如阳虚型红斑狼疮案，经行寒战高热如疟（203页）；③周期性发作：如重症痢疾疑癌变案，每隔月余即暴痢1次（152页）；④久治不愈、反复发作：如过敏性鼻炎案，每年夏初必犯，缠绵32年不愈（262页）。

3.3 肺癆潮热新解

历来中医治肺癆午后潮热，皆从阴虚火旺立论，滋阴降火定法。李可从“肺结核戴阳危症案”误治中顿悟，对肺癆潮热有了新的解读：

① 重新认识肺癆病因病机：肺癆虽病灶在肺，但波及四脏，甘寒养阴伤脾阳，苦寒泻火致戴阳；久病气血大虚，脾肾元气动摇；肺癆潮热，乃肝脾肾虚极之假热。

② 重新探索肺癆治疗规律：治癆有四本，肺肝脾肾；劳者温之佐化癆；以补中益气汤甘温除大热，以来复汤合参附龙牡救逆汤救阳固脱等（300页）。笔

者以方测证，解析肺痿之病机，如李氏用补中益气汤加萸、梅、龙牡，为阴虚渐及气虚、气虚欲脱，即阴损及气；而用来复汤合参附龙牡救逆汤，为气虚已脱、浮阳外越，即气虚渐及阳虚。前者气阴两虚，偏重在气；而后者气阳两虚，偏重在阳。从气虚、阳虚的角度，再来看肺痿的午后发热，就与交节辨证（即气虚、阳虚多午后病作）基本吻合了。如肺痿“盗汗5个月”，便可诊为“阴损及阳”（308页）；其潮热，少则几个月，多则数年，导致阴阳气血诸虚，其时辰辨证关键就在“诸虚”二字，不能单从阴虚解读，望初学者留意。

3.4 从肺痿潮热引发的思考

笔者在李可之肺痿潮热新解的启示下，对阴虚潮热与气虚潮热进行一番深入思考。

3.4.1 阴虚潮热与气虚潮热的泛化

阴虚潮热，约起源于《内经》之“阴虚生内热”；**气虚潮热**，则起于东垣《脾胃论》之甘温除大热。千百年来，中医一直把阴虚潮热与气虚潮热加以演化。由于阴虚为午后发热，于是就把午后发作类病证如出汗、出血等，归于阴虚；气虚为午前发热，亦把午前发作类病证纳入气虚。**临床常用黄芪治自汗，地黄治盗汗**，便是这个道理，即使是名家医案亦屡见不鲜，这几乎成为中医临床的思维定式。

3.4.2 阴虚潮热与气虚潮热的反思

交节之变，是内伤时间辨证的普遍规律。根据这个规律，午前发热者，多为阴虚、阳盛；午后发热者，多为阳虚、阴盛。这与阴虚潮热和气虚潮热所阐明的道理，正好相反，那问题是出在哪里？李可对肺痿潮热已经有了新的解读，并对阴虚潮热亦有一系列提示。如李氏在论述肿瘤时指出，**凡肿瘤化疗、放疗损伤气阴，而见下午潮热、烦渴、舌红无苔等症，用补中益气汤加山萸肉、乌梅、龙牡，取效甚速**（363页）；他在论“阴虚舌”时又说，肺痿、骨蒸潮热而见阴虚舌，用甘温除大热，一周而潮热退（61页）。其“骨蒸潮热”就是指传统的阴虚潮热，并点明病机为“气阴两虚”。这样看来，传统的阴虚潮热应正名为“气阴两虚”之潮热。

至于气虚潮热，刘力红在论述阳明“欲作时”指出，这个问题有两个方面：一方面是一般欲作时相，而阳明欲解时为申至戌，那么欲作时当然就是寅至辰；另一方面是特殊的欲作时相，那就是日晡所发潮热（272页）。笔者从阳明潮热的特殊时相，联想到气虚潮热。因为按交节之变，阳明潮热（阳盛）本该在上午（寅至辰）病作，可实际上是在下午的日晡病作；气虚潮热本该在下午病作，可实际上却在上午。这样看来，脾与胃一虚一实，相互对应，既然阳明潮热为特殊时相，那么气虚潮热亦应该是特殊的时相。

总之，**传统的阴虚潮热，应正名为“气阴两虚”潮热，不能以“阴虚”的**

名义加以演绎；而东垣之气虚潮热是特殊的欲作时相，不能作为一般规律加以泛化。我们应当对由于二者的泛化而形成的中医临床思维（即午后发作类病证为阴虚、午前发作类病证为气虚）与交节辨证（旦慧、昼安、夕加、夜甚）相抵触，进行深刻的反思。

李可关于时间辨证的方法：交节辨证，六经辨证，经络辨证，伏邪辨证；时间辨证的要领：阴阳盛衰，邪正交争，真假标本；时间辨证的特色：交节辨证规范，伏邪辨证新论，肺劳潮热新解。

见皮治皮永无期

——李可学术思想探讨之十一

摘要：针对皮肤科见皮治皮的问题，进一步探讨了李可学术思想。李可治皮肤病思路：诸病当先解表；毒伏血分，当引邪外透；以阴阳为纲，寒热、虚实、燥湿分型；创制乌蛇荣皮汤，通治皮肤顽症。

关键词：皮肤病 解表透邪寒 热虚实燥湿分型 乌蛇荣皮汤 李可 医案

皮肤病很少危及生命，但顽固难愈。患者痛苦缠绵，医生焦头烂额，确是医学一大难题。故有“医生不治癣，治癣丢了脸”之谚。李可作为县中医院的基层中医，求治者五花八门，为了解除病人的痛苦，于是被逼上皮肤科难症攻关之路。他对皮肤小科病的剖析，可谓如狮搏兔，亦用全力之大手笔，体现了中医整体治疗的优势。现根据 18 种皮肤病 28 则医案，整理出以下内容：

1 风为百病之长

《内经》云“风者，天地之使也”。所谓“使”，其实就是说风是天地的一个代表，天气要发生变化，都可以从风上反映出来。比如天气要转寒了，它会首先出现北风；而天气要转热了，又会出现南风。风为六淫之首，寒、暑、燥、湿、热诸邪气多依附于风而侵犯人体，故中医又有“风为百病之长”之说，特别是与皮肤病关系甚密。李可说，中医之“风”字，包罗万象，善行而数变，可统括一切痒痛难忍、顽麻不仁、风瘙隐疹、白癜风、顽癣湿疹、皮肤角化等皮肤病（41、332 页）。下面举例证之：

神经性皮炎张某，女，41 岁。全身瘙痒 18 个月。其面颊部、耳垂部、手腕外侧呈对称性皮肤干燥脱屑。病起产后自汗，汗出当风，则患部肿起脱皮，痒痛如锥刺。便燥，3 日一行。唇色紫绛，舌色紫暗，边尖有瘀斑，脉沉涩。症属肺

卫失固，血虚内燥夹瘀，复感风毒。拟乌蛇荣皮汤（生地、当归各 309，桂枝 10g，赤芍 159，川 I 芎、桃仁、红花各 10g，丹皮、紫草各 159，定风丹 609，白鲜皮、乌蛇各 309，炙草 10g，生姜 10 片，大枣 10 枚），重用当归 90 克，加玉屏风固卫（生芪 309，白术 209，防风 10g）。上药连服 7 剂，服 4—5 剂时，正值经行，下紫黑甚多，诸症皆愈（320 页）。

按 本案起于产后自汗，外因汗出当风，则面颊、耳垂、手腕外侧肿起痒痛；内因产后血虚内燥化风，则患部干燥脱屑，治以乌蛇荣皮汤重用当归养血祛风，加玉屏风散固卫。其病因、辨证及治疗，均离不开“风”字。

从李氏治皮科诸案中，可以看出“风”的涵义：①病因病机：见于外风，如产后风寒入络，面部见风则肿，详见皮肤划痕症案（326 页）；见于内风，因血虚内燥化风，面颊斑驳如花脸，详见白癜风案（322 页）；或血燥化风，如产前过食辛辣发物，产后过食鸡鱼，致血热生燥化风，详见银屑病案（318 页）；②证状特点：多见风团，如面部见风则肿，肌肤麻木不仁，详见皮肤划痕症案（326 页）；或红色丘疹，如全身起红色小丘疹，瘙痒无度，搔破流水，属于内蕴湿热，复感风毒，详见花斑癣案（321 页）；或瘙痒顽症，如老年瘙痒症，因高年气血虚衰，内燥化风，不荣四末（318 页）；或鳞屑，如银屑病，皮损如老树皮，燥裂出血（318 页）；或善行数变，如白塞氏综合症，冬至交节一到立即发病，先觉外阴辣痛，旋即口舌生疮（291 页）。

2 毒为皮科之最

李可之皮肤病医案 28 则，其关系到风者 13 例，而涉及到毒者竟达 20 例，这引起了笔者的关注。李氏认为，一切皮肤病的根本原因，首先是整体气血失调，“邪之所凑，其气必虚”，然后风、寒、暑、湿、燥、火六淫之邪，或长期接触有害物质，诸多外因趁虚袭人而致病（315 页）。所谓“长期接触有害物质”，即包括药物、食物、家庭及室外环境等有害物质，这可能与“毒”有关。兹举其案例如下：

鹅掌风段某，男，57 岁。老牧羊人，两手掌龟裂出血，痒痛难忍 7 年，掌部粗糙如树皮。县医院外科诊为手癣、掌角化症。患者牧羊 41 年，外受风霜雨露之侵，双手日日接触畜粪，致风毒凝结肌肤，日久深伏血络，营卫阻塞，肌肤失养，血虚不荣四末。服乌蛇荣皮汤 7 剂痊愈（316 页）。

按 患者牧羊 41 年，外受风霜雨露之侵，双手日日接触畜粪，致风毒凝结肌肤，便是“长期接触有害物质”之明征，也是对“毒”的一种通俗解读。

从李氏治皮肤病诸案中，可以看出毒邪多与其它病因结合，或为它邪所化：①风毒：见于风毒者 5 例，如鹅掌风案（316 页）、神经性皮炎案（320 页）、白癜风案（322 页）；②湿毒：见于湿毒者 1 例，如臃疮案（327 页）；③湿热

化毒：见于湿热化毒者 4 例，如小儿湿疹案（88 页）、白塞氏综合症案（292 页）；④血分伏毒：见于血分伏毒者 11 例，如花斑癣案（321 页）、黄水疮案（325 页）、青霉素过敏性皮炎案（324 页）；⑤疮毒内攻：皮科用散剂外用药，若内毒未消，单用敛疮涂剂，则易使疮毒内攻，如脓疮内攻案（332 页）。

3 乌蛇荣皮汤通治皮肤病

李可治皮肤病初期，亦见皮治皮，搜集了大量外用方，以涂抹擦敷、止痒消炎解除燃眉之急，也有小效。但大多暂愈后发，此伏彼起，穷于应付。此路不通，日久才渐有所悟，终于研制出**乌蛇荣皮汤**，执简驭繁，用治多种皮肤顽症，竟获奇效。

组成：**生地（酒浸）、当归各 30g，桂枝 10g，赤芍 15g，川芎、桃仁、红花各 10g，丹皮、紫草各 15g，定风丹（制首乌、白蒺藜）60g，白鲜皮、乌蛇（蜜丸先吞）各 30g，炙草 10g，生姜 10 片，大枣 10 枚。**

功能：养血润燥，活血祛瘀，通调营卫。

方解：本方于桃红四物汤合桂枝汤，养血润燥，活血祛瘀，通调营卫，实是治皮科的基本大法。**定风丹**为首乌、蒺藜对药，滋养肝肾，乌须发，定眩晕，养血驱风止痒；丹皮、紫草凉血解毒；**白鲜皮**苦咸寒，入肺大肠脾胃四经，功能清湿热而疗死肌，为风热疮毒、皮肤痒疹特效药。服之，可使溃烂、坏死、角化之皮肤，迅速层层脱落而愈。乌蛇味甘咸，入肺脾二经，功能祛风、通络止痉。治皮肤肌肉诸疾，主诸风顽癣、皮肤不仁、风瘙隐疹、疥癣麻风、白癜风、瘰疬恶疮、风湿顽痹，实是一切皮肤顽症特效药。诸药相合，可增强体质，旺盛血行，使病变局部气血充盈，肌肤四末得养，则病愈（315 页）。

4 诸病当先解表

李可认为，皮病治肺，肺主皮毛而卫外，实则以麻黄、桔梗、白芷宣肺气，开表闭，以通毛窍之气，开门逐盗，阻断病邪深入（333 页）。现附验案，以为佐证：

青霉素过敏性皮炎朱某，男，30 岁。因腿部感染注射青霉素 2 日后，忽然气喘痰鸣，寒战嘎齿有声，全身瘙痒无度，口渴脉浮紧。予小青龙加石膏蝉衣：桂枝、赤芍各 10g，炙草 6g，麻黄、细辛、五味子各 10g，生半夏、石膏、蝉衣各 30g，生姜 10 片，大枣 10 枚，2 剂。二诊：喘定，痒甚，全身片状风团满布，愈搔愈多，致血痂满身，无片刻宁静，脉转浮数。拟清透血分伏毒，兼和营卫，乌蛇荣皮汤加蝉衣、浮萍各 10g，黑芥穗 5g，2 剂后痊愈（324 页）。

按本案因腿部感染注射青霉素过敏，忽然寒战嘎齿，气喘痰鸣，脉浮紧，属营卫闭塞，寒饮内停，为小青龙汤证，因过敏加蝉衣，兼口渴为热化，加石膏

30 克。药后表闭开，喘定、寒战止。二诊则以乌蛇荣皮汤收功。

5 伏邪入里，当引邪外透

李可之经验，凡久治不愈，反复发作的顽症痼疾，必有六淫外邪深伏（22 页）。全书皮肤病 28 则，其中毒入血分者 11 例，如花斑癣案（321 页）；邪伏肌肉者 2 例，如黄水疮案（325 页）；邪伏少阴者 1 例，如皮肤划痕症案（326 页）。下面看一则毒伏血分案：

银屑病韩某，男，22 岁。患银屑病 2 年，近因搔破感染，痒痛夜不能寐，双手背肿胀青紫，血痂累累，右腿内侧上 1 / 3 处粗糙溃烂，锨赤肿痛，腹股沟淋巴结肿硬疼痛，举步艰难。心烦口渴，舌红无苔，脉沉滑数。症由嗜酒无度，湿热深伏血分，蕴久化热化毒。拟乌蛇荣皮汤加味：重用生地 120 克，清热凉血；加二花 45 克，连翘 30 克，木鳖子 15 克，僵蚕 10 克，解毒散结消肿；以牛子、皂刺、黑芥穗各 10 克，透发血中伏毒；日久顽疾，加狼毒 3 克攻毒；蝉衣 10 克，引诸药直达皮部。上药服 5 剂诸症均愈。患者不遵守禁忌，恣食鱼虾酒酪，数日又发。留有旧方，照方取药，服三五剂又愈（319 页）。

按 西医银屑病，即中医之牛皮癣，至今原因不明，但对海鲜酒酪多表现了迟发性或蓄积性过敏，即中医所谓“嗜食无度，湿热蕴久化毒”所致。李可治银屑病，均加**皂刺、牛子、黑芥穗透血分伏毒**，这是为何？大概缘于银屑病的特征。银屑病初为红色小丘疹，可融合成形态不一的斑块，上面都覆盖着较厚的银白色鳞屑，刮去鳞屑，则下面露出淡红色半透明的薄膜，再刮则出现筛孔状出血，又称“血露”。所谓“血分伏毒”，即指向红疹、血露。本案患者不遵禁忌，时隔数日又发，便验证了李氏“皮肤病之缠绵难愈多与不遵守禁忌有关”的道理。

6 以阴阳为纲，寒热、虚实、燥湿分型

李可根据“正旺则邪从热化、实化；正虚则邪从寒化、虚化”的原则，将皮肤病分为两个基本型。

6.1 寒热分型

红斑狼疮分为阴虚血瘀与阳虚血凝型（202 页）。过敏性紫癜分为肝热妄动与脾不统血型。肝不藏血，血热妄行，治以桃红四物汤加丹皮、紫草、大蓟、青黛、清热解毒，凉血化斑，多数在半月内痊愈；脾不统血，从阴化寒，治以补中益气汤加姜炭、三仙炭、三七，补气温脾摄血（329 页）。但他更多的是以乌蛇荣皮汤变通为寒热两型。下面举例证之：

皮肤划痕症王某，女，34 岁。患本病 7 年。由产后风寒入络所致，久治不愈，今年入夏痒甚，夜不成寐。面部见风则肿，肌肤顽麻不仁。带多清稀如注。腰困如折，起立则眩晕。舌淡润，脉弱。乌蛇荣皮汤去生地、丹皮、紫草、白鲜

皮，加麻黄附子细辛汤（麻黄、附子、细辛各 10 g）解久伏之风寒，玉屏风散（生芪 30 g，白术 20 g，防风 10 g）固表，肾四味（枸杞子、菟丝子、补骨脂、仙灵脾各 30 g）固护肾气，脱敏灵（苏叶、浮萍、蝉衣、地龙各 10 g）脱敏，3 剂而愈（326 页）。

按 乌蛇荣皮汤本为血虚夹瘀、夹热而设，此案为血虚夹瘀、夹寒，故减去生地、丹皮、紫草、白鲜皮等寒凉，加附子、黄芪、肾四味等温热药。又如局限性皮炎案，亦属此类（330 页）。

6.2 虚实分型

白塞氏综合症，虚为火不归原，实则湿热化毒。下面举例证之：

白塞氏综合症包某，女，40 岁。冬至当日初诊，患口腔溃疡、外阴溃疡 6 年。发作多在每年冬季，尤以冬至，交节之时一到，立刻发病。经治多年无效。诊视，见舌红如柿，无苔，口干极而不欲饮。口角内侧，舌边尖部，白色溃疡成片。外阴每发病，先觉外阴辣痛，旋即口舌生疮。头晕如腾云驾雾，面部轰热如潮。按脉沉细，双膝独冷。其症发病甚急，说来就来，一二分钟即令人不能忍耐。此症，《金匱》谓之“狐惑”，由湿热生虫，蚀于喉为“惑”，蚀于阴为“狐”，治以清湿热而杀虫。此例病经多年，反复发作，未见湿热积毒征象。从脉证推断，恐系肾阴久亏，阴不敛阳。适逢冬至节令，一阳来复，龙雷之火不仅上燔，且肾与前阴相关，又且下焚，姑予引火汤 3 剂：熟地 90 g，巴戟天、天麦冬各 30 g，茯苓 15 g，五味子 6 g。药后诸症皆愈。此法并治 45 岁以上之男人多人，服药 1 剂，口舌疮即退，服 3 剂下阴部之溃疡亦了无痕迹（291 页）。

按 白塞氏综合症，李氏以年龄为辨认虚实的着眼点。即 35 岁以下青壮年患者，从湿热化毒论治，方以四妙散合定风丹，加丹皮、紫草、白鲜皮、苦参等，治疗 6 例，皆获根治；若 35 岁以上，病旷日持久者，多转为引火汤证，虽不能根治，却见效迅速，可免除一时之苦（293 页）。

6.3 燥湿分型

皮肤科以皮肤损害为直观特征，有着明显的干性与湿性之分，即燥湿分型。干性皮肤病，如银屑病、神经性皮炎、白癜风、老年瘙痒症，多与中医之风、燥有关，治之多用祛风、润燥法。例如银屑病重用生地 120 克（319 页），神经性皮炎重用当归 90 克（320 页），白癜风加沙苑子、女贞子、旱莲草各 30 克（322 页），便是润燥之明征。湿性皮肤病，如过敏性湿疹、黄水疮、脓疱疮、白塞氏综合症，多与湿热、湿毒有关，李可用三妙散化裁，加土茯苓 120 克。下面举例证之：

过敏性湿疹白某，女，35 岁。患过敏性湿疹 52 天。初病右头维穴处起红疹，瘙痒极重，搔破后流黄水，浸淫成片。继而背部及少腹起大片风团，搔破后流黄

水。日轻夜重，奇痒不能入睡。近 1 周来继发感染，泛发性脓疱疮布满少腹及背部。腹股沟及耳后淋巴结肿硬剧痛。脉细数，舌尖部有瘀点。经抗菌、抗过敏治疗 20 日不能控制，湿热化毒深伏血分。拟方清透：乌蛇荣皮汤加双花 90 g，连翘、木鳖子各 30 g，苡仁 45 g，苍术、黄柏各 15 g，全蝎 12 只、蜈蚣 2 条（研粉冲服），土茯苓 120 g，煎汤代水煎药，3 剂，3 夜 1 服，因剂量大，共服 5 日，痊愈（325 页）。

按 本案湿疹极重，背部及少腹起大片风团，搔破后流黄水，奇痒不能入睡，又继发感染，呈泛发性脓疱疮，腹股沟及耳后淋巴结肿硬剧痛，急以乌蛇荣皮汤加三妙清利湿热，重用双花、连翘、木鳖子解毒消肿。李氏之经验，大剂量土茯苓对重症湿疹，确有覆杯而愈之效；甚则加虫类药全蝎、蜈蚣入络搜风解毒，止痒效如桴鼓（89、325 页）。燥湿二型，可互为演变。如 4，J L 湿疹，初起湿热化毒，治以连翘败毒散合三妙散加味；若过用升散燥湿之剂，转为伤阴燥化，则用桃红四物汤合定风丹加味（89 页）。

从李可治皮肤病分型诸案中，可以看出他均以阴阳为纲，分为两个基本型，或表现为寒热，或表现为虚实，或表现为燥湿，这是由疾病本身的特点所决定的，而不要误以为是寒热、虚实、燥湿 6 个分型。

7 皮科用方集锦

李可治皮科常用方近 30 首，现归纳如下：

7.1 皮科常用方

7.1.1 解表皮肤病以桂枝汤通调营卫，详见乌蛇荣皮汤（316 页）；/ b J L 湿疹，以连翘败毒散为基础方，升散解毒（89 页）；扁平疣，以麻杏石甘汤开表清湿（89、324 页）；皮肤划痕症，以麻附辛汤解久伏之风寒（326 页）；神经性皮炎，病起于产后自汗，汗出当风则肿，以玉屏风散固表（320、326、337 页）；青霉素过敏性皮炎，外寒内饮，予小青龙汤治之（324 页）。

7.1.2 清营凉血犀角地黄汤是化斑常用方，而乌蛇荣皮汤之丹皮、紫草可代犀角（329 页），其桃红四物汤又含生地、赤芍，这是典型的犀角地黄汤。红斑狼疮，以贯众石膏汤辟秽化斑（203 页）。

7.1.3 活血化瘀乌蛇荣皮汤之桃红四物汤活血化瘀，兼养血润燥（316 页）。

7.1.4 脱敏皮肤过敏者，以脱敏灵治之，详见皮肤划痕症案（326 页）。

7.1.5 健脾化湿鹅掌风兼见面色萎黄，经少色淡，以四君子汤健脾运中以荣四末（318 页）；过敏性紫癜兼见食少便溏，治当补气，方以补中益气汤加味（329 页）。

7.1.6 补肾固本整体失调则补肾固本，恒加。肾四味，详见花斑癣、黄褐斑案（311、330 页）；若火不归原，以引火汤治之，详见白塞氏综合症案（292 页）；阳虚显露，以阳和汤组方，详见局限性皮炎案（331 页）。

7.1.7 攻毒疮毒内攻则危及生命，以攻毒承气汤扫荡血毒，详见廉疮内攻案（332 页）。

7.1.8 扶正祛邪若皮肤病慢性感染、脓肿、溃疡，证属正虚邪恋，借重半阴半阳证十味神效汤加减进治（生芪、当归、双花、炮甲、J 1 I 断、香附、甘草、生姜、桂枝、牛膝），见效较速（334 页）。

7.1.9 救急若浮阳飞越或火不归原，必兼见面如红妆，自汗而喘，为虚极欲脱之危象，亟亟敛肝救。肾之来复汤、引火汤、参附龙牡救逆汤（334 页）。

7.2 皮科自制方

7.2.1 乌蛇荣皮汤李可创制乌蛇荣皮汤，执简驭繁，随证加减拟定出十余首类方，如黄芪乌蛇荣皮汤治老年瘙痒症，狼毒乌蛇荣皮汤治白癜风等，随处可见。

7.2.2 贯众石膏汤用于瘟毒发斑，其组成为石膏 250g，贯众、黑小豆各 30g，西洋参、苍术各 15g，雄黄 0.3g，丹皮、紫草各 15g，青黛、甘草各 10g，详见红斑狼疮案（203 页）。

7.2.3 定风丹用于祛风止痒，其组成为首乌、白蒺藜各 30g，详见鹅掌风案（317 页）。

7.2.4 克白散用于白癜风，其组成为沙苑子 750g，稀莪草 500g，乌蛇 250g，定风丹 300g，三七 100g，藏红花、乌贼骨、白药子、苍术、蚤休、降香、紫草、甘草各 50g，每服 5 克，日 3 次（323 页）。

7.2.5 脱敏灵用于皮肤过敏，其组成为苏叶、浮萍、蝉衣、地龙各 10g，详见青霉素过敏性皮炎案（324）。

7.2.6 白塞氏实化汤用于白塞氏综合症实化证，其组成为四妙散、丹皮、紫草、白鲜皮、苦参、胡黄连、生地、定风丹；白塞氏综合症虚化证，用引火汤（292 页）。

7.2.7 胎毒湿化汤小儿湿疹亦称胎毒，胎毒湿化方，其组成为连翘败毒散、白鲜皮、苦参、三妙散、土茯苓；胎毒燥化方为桃红四物汤加丹皮、紫草、黑芝麻、定J 刚 t] —（89 页）。

7.2.8 紫癜热化汤过敏性紫癜热化方，其组成为桃红四物汤加丹皮、紫草、大蓟、青黛；过敏性紫癜寒化方，以补中益气汤加姜炭、三仙炭、三七（329 页）。

7.3 乌蛇荣皮汤临证思考

7.3.1 虚多实少乌蛇汤乌蛇荣皮汤功效：①功能：养血润燥，活血化瘀，通调营卫；②适应症：血虚（四物汤）、血热（犀角地黄汤）、血瘀（桃红四物汤）、湿热（白鲜皮、紫草）、营卫失调（桂枝汤）、风燥（乌蛇、定风丹）；③虚多实少：从乌蛇荣皮汤功能主治综合分析，其方偏于血虚、内燥、血热，兼顾血瘀、湿热、营卫。若偏于实热者，可参考下列各方：

7.3.2 表实热证连翘败毒散表实热证者，如 4，J L 湿疹兼见高热烦渴，痒痛流滋不止，用连翘败毒散升散，加三妙散、白鲜皮、苦参、土茯苓化湿解毒（88 页）。

7.3.3 血热发斑贯众石实热为血热发斑者，如红斑狼疮感受瘟毒，用贯众石膏汤辟秽化斑解毒（203 页）。

7.3.4 湿热犀角三妙苓实热为湿热者，如过敏性湿疹，用丹皮、紫草可代犀角凉血，三妙散、土茯苓化湿解毒（203 页）。

7.3.5 阳证转阴下治上皮科热毒结于局部，暂用清热解毒利湿，中病即止，勿伤中上之阳，过剂则寒化、虚化，反使水湿凝结难化。下面举例证之：

脚气兼冻疮李某，女，16 岁。患脚气 3 年，今冬脚冻成疮。近 3 日感染肿烂，脓水淋漓，红肿欣痛，不能步履。予清湿热解毒：苡仁 45g，苍术、黄柏、川牛膝各 12g，忍冬藤、芙蓉叶各 30g，公英、地丁各 20g，白蔹、车前子、甘草各 12g，生姜 5 片，大枣 10 枚。二诊：药进 3 剂，肿烂减而未愈。足背青紫，膝以下冰冷，右寸沉细。予益气温络和营：生芪 45g，当归 30g，桂枝 12g，赤芍 15g，吴茱萸 10g，炙草、桃仁、红花、通草、细辛各 10g，苡仁 45g，白蔹 12g，生姜 20g，大枣 10 枚。三诊：肿烂结痂，脚膝温，色红活，原方去白蔹再服 3 剂善后。

李按 “藜藿之体气血穷”，初诊未念其家境困顿，徒以清热解毒为能事，则损伤中气出现寒化、虚化。二诊下病治上，重用生芪之益气生肌化腐，又结合当归四逆加吴茱萸生姜汤温经治冻疮，在下之疮疡立愈，冻疮亦愈（213 页）。

从本案可以看出：①过用苦寒阴化阳：皮科感染，用清热解毒利湿，要掌握分寸，不可过剂，过之则伤中上之阳，阳证转阴化寒（252 页）；②左寸沉微重生芪：李氏经验，皮科一见左寸沉微，即投补气。生芪一味，运大气，主大风（即一切皮肤顽症的总称），化腐生肌敛疮，实是慢性疮疡之神药（215 页）；③下病治上启后学：下病治上之法，源自灵枢，傅山将此法具体化，拟出方药，启迪后学，厥功甚伟（215 页）。若下肢皮疹，用乌蛇荣皮汤效果欠佳时，不妨以下病治上加生芪，往往会收到意想不到的疗效。详见臙疮案（327 页）。

8 皮科用药汇粹

李可皮科用药，有许多独特经验，现归纳如下：

8.1 白癜风必用狼毒 白癜风者 3 例，均加狼毒 2.5~3 克，可视为专病用药（322 页）。

8.2 银屑病外透血毒 银屑病 2 例，均加双花、连翘、皂刺、牛子、黑芥穗。因继发感染而用银翘，故皂刺、牛子、黑芥穗为专病用药（319 页）。

8.3 继发感染用银翘 皮科继发感染，或皮疹色鲜红，恒用银花 45—120 克，连翘 30 克（319 页）。

8.4 湿疹三妙土茯苓 湿疹类病，恒用三妙散（即四妙散去牛膝）化裁，土茯苓 120g，可视为专病用药（325 页）。

8.5 神经皮炎用润燥 神经性皮炎 2 例，二者分别重用生地 120 克、当归 90 克，重用养血、滋阴为本病用药特点（320 页）。

8.6 淋巴肿大木鳖子 《本草纲目》载，木鳖子，苦、微甘、有小毒。李氏用此药 40 余年，未见有中毒者，通治一切痈肿、疮毒、瘰癧、痔疮；用于皮病继发感染，淋巴结肿大，煎剂极量 30 克（勿须捣碎），一剂即消，中病则止（118、320 页）。

8.7 营卫表证 3 层次

李可将营卫表证的治疗分为 3 个层次：

8.7.1 营卫不和桂枝汤 轻者营卫不和，皮科多表现痒痛，用乌蛇荣皮汤内桂枝汤治疗，往往缓解，如鹅掌风案（316 页）。

8.7.2 营卫阻塞麻桔芷 营卫不和之痒痛用桂枝汤不解者，说明久病营卫阻塞，则基本方加麻黄 5 克，或麻黄 5 克、桔梗 10 克，如鹅掌风案（317 页），或缘于湿热内蕴、瘀血内阻之营卫阻塞，则加白芷 5~10 克，如斑秃（326 页）、黄褐斑案（330 页）；或麻黄、白芷各 10 克，如扁平疣案（324 页）。

8.7.3 肺卫失固玉屏风 若见风则肌肤肿起，或风吹则麻木发痒，均属肺卫失固，为玉屏风散证（生芪 30g，白术 20g，防风 10g，），如神经性皮炎案（320 页）。

8.8 伏邪入里当外透 皮科之伏邪，有邪伏少阴、肌肉、血分之分：

8.8.1 邪伏少阴麻附辛 邪入少阴，为麻黄附子细辛汤证（麻黄、附子、细辛各 10g），以细辛透久伏之邪，如皮肤划痕症案（326 页）。

8.8.2 邪伏肌肉葛根透 李可说，邪由皮毛而入肌肉，邪又深入一层，加葛

根透发于外（333 页）。如黄水疮案（325 页）、神经性皮炎案（320 页）。

8.8.3 毒入血分皂芥牛 毒入血分者 11 例，这是皮肤病一大特点。李可喜用皂刺、牛子、黑芥穗透毒。其中单用黑芥穗者 2 例，如青霉素过敏性皮炎案（324 页）；皂刺、黑芥穗并用者 4 例，如花斑癣案（321 页）；皂刺、牛子、黑芥穗并用者 2 例，如银屑病案（318、319 页）。李氏又指出，皮科重症则加虫类药物入络，深入血分，搜剔伏匿之邪（86、243 页）。如小儿湿疹案之全蝎 12 只、蜈蚣 1 条（88 页），局限性皮炎案之炮甲 3 克、麝香 0.15 克（331 页）。

李可治皮肤病思路，现简要归纳如下：**诸病当先解表；毒伏血分，当引邪外透；以阴阳为纲，寒热、虚实、燥湿分型；创制乌蛇荣皮汤，通治皮肤顽症。**（内文页码源于《李可老中医急危重症疑难病经验专辑》一书。）

中医之秘在于量

——李可学术思想探讨之十二

摘要：针对中药之秘在于量，进一步探讨了李可用药规律。李可关于红参用量：补元用平剂，急救暴脱用大剂；红参剂型：捣末同煎，另炖，粉吞，块吞。肉桂用量：温肾阳、助气化、反佐用平剂；引火归原、降奔豚、止泄泻、护胃阳用小剂；肉桂剂型：平剂煎服，小剂粉冲、米丸吞服。山萸肉用量：小剂 10 克，平剂 30 克，中剂 60~90 克，大剂 100~120 克。吴茱萸用量：10 克以下无效，15 克显效，30 克攻无不克，50 克治大症。生半夏用量：小剂 10 克，平剂 30 克，中剂 45 克，大剂 60 克。

关键词：中药 红参 肉桂 山萸肉 吴茱萸 半夏 李可 医案

人参为中药四帅之一。李可创制的破格救心汤，高丽参用至 30 克。他在全书 246 则医案中，用红参多达 121 案，创下了人参之“最”。现根据其医案，整理出以下内容：

1 红参

李可关于红参用量：补元用平剂 10 克，急救暴脱用大剂 30 克（372 页）；红参剂型：捣末同煎，另炖，粉吞，块吞。

1.1 红参捣末同煎

红参捣末同煎用大剂，常用于血证暴脱，可立挽危亡。如暴崩欲脱案（123

页)、暴崩脱症案(124 页)、久痢成癆案(305 页)。

1.2 红参另炖

红参“另炖”法，即隔水炖也，缘于单煎红参易糊锅，不可不知。主要用于以下情况：①红参平剂：用于补元，红参为 10 克，偶见 15 克。这是红参最常见的用法，如顽麻怪症案(42 页)、尿毒症案(164 页)。②红参救脱：救脱用大剂，如胃溃疡大出血案(15 页)、妊娠恶阻案(107 页)。③破格救心：高丽参 30 克，如破格救心汤治肺心病心衰(7 页)。④奔豚厥脱：红参 30 克，如奔豚汤治伏寒奇症案(379 页)。

1.3 红参粉吞

主要用于特定的配伍，组成散剂。①参蛤散：肾不纳气之喘，红参 10 克(重则高丽参 20 克)，蛤蚧尾 1 对，研粉吞服，立解其危(14、29 页)。②参麝散：小儿慢惊风，以高丽参粉 5 克，麝香 0.3 克，以救呼吸衰竭(74 页)。③参灵散：李氏治数百例胃肠溃疡，红参、灵脂各 10 克等分，为散吞服，可当日止痛，半月痊愈(178 页)。

1.4 红参块吞

所谓红参“块吞”，即打小块吞服，其“小块”，亦称“粗末”，类似于粗玉米面。主要用于：①大气下陷：李可认为，用补中升陷法治大气下陷证，红参不入煎剂者，缘于汤药速效，虚馁之人下咽反觉胀闷，打小块吞服，入胃缓缓奏功，使下陷之气徐徐升达。如胃下垂案(254 页)、剖腹产后二便闭结案(112 页)。②肾不纳气：肺肾两虚之喘，红参小剂 10 克打碎，细嚼慢咽，立刻生效。详见急性结核性胸膜炎案(47、393 页)。

1.5 关于红参“另炖”的思考

红参“另炖”法，是李可临床使用频率最多的煎法。由于隔水炖之法，有人不知，亦比较麻烦；若单煎红参，又易糊锅。为此，笔者采用红参减半粉吞，代替红参“另炖法”。

2 肉桂

李可关于肉桂用量：温肾阳、助气化、反佐用平剂；引火归原、降奔豚、止泄泻、护胃阳用小剂；肉桂剂型：平剂煎服，小剂粉冲、米丸吞服。

2.1 肉桂煎服

肉桂入煎剂，一般为平剂 10 克，对于小儿、老人、羸弱之人，肉桂酌减，如小儿遗尿案之肉桂 3 克入煎(86 页)。主要用于以下情况：①温肾阳：如阳虚型红斑狼疮案，用附子、肉桂直温肾阳(202 页)；习惯性流产案，用附子、

肉桂温养命火（117 页）。②助气化：李可之经验，治三焦气化乖常诸疾，必以肉桂辛热善动之品，直入命门而补其火，火旺则阴凝解而气化得以蒸腾。如一老年肥大性前列腺炎急性感染致癃闭者，虽诊为湿热充斥、三焦闭塞，仍以对症汤剂加肉桂蒸动气化，2 剂而解（157 页）。又如结核性腹膜炎合并胆囊炎案，以真武汤加肉桂蒸动气化（39 页）。③反佐：李氏在论述攻癌夺命汤时指出，本方大队苦寒之品，脾胃怯弱者，以肉桂温热灵动之品反佐，以保护脾胃为第一要义（146 页）。如红斑狼疮案，用肉桂 10 克反佐玄参 100 克，以防寒凉损伤脾胃（204 页）。笔者注意到：**李氏凡用肉桂反佐，均列在反佐药之后。这一特殊笔法，值得借鉴**，如痢疾脱症案（146 页）。

2.2 肉桂粉冲

肉桂冲服，一般为小剂 1.5~6 克。主要用于以下情况：①降奔豚：肉桂、沉香、紫石英为药对，凡奔豚证，急投肉桂粉、沉香粉 3 克冲，煅紫石英 30 克，直入肝肾，破沉寒痼冷，安镇冲脉，下咽立效（16 页）。如伏寒奇症案之肉桂 1.5 克（380 页），肠梗阻合并疝嵌顿案之肉桂 6 克（133 页）。李可用奔豚汤，偶尔肉桂 10 克入煎。因症属厥脱，救阳为急，归于“温肾阳”一类，如噎膈重症案（389 页）。②止泄泻：肉桂、赤石脂为药对，自制方三畏汤之肉桂 1.5~6 克粉吞，赤石脂 15~30 克入煎，**取肉桂补命火，赤石脂甘温酸涩收敛，对脾肾虚寒导致之五更泻、久痢、久带，有特效**（179 页）。如糖尿病案之五更泻，3 剂而愈（57 页）。③护胃阳：李氏在肺癆兼寒饮案中指出，患者呕吐厌食，唯胃已伤，以阳和汤之肉桂粉冲，以复胃阳（308 页）。看来肉桂反佐与护胃阳有些相似之处，但仔细推敲，还是有区别的。**反佐的目的在于护胃，而针对的是苦寒药；护胃阳的目的在于扶胃，但针对的是胃虚证状，如胃凉、呕吐、便溏。**

2.3 肉桂米丸吞服

李可之经验，凡火不归原证，肉桂 1.5~6 克米丸吞服。**米丸做法：油桂刮去粗皮研粉，小米蒸烂为丸，如赤小豆大，药前囫囵吞下。取其米丸溶解较水丸、蜜丸缓慢，不在胃里分解，而在下焦徐徐吸收，引火归肾**（54、127、242 页）。如鼻衄奇症案（279 页）、复发性口腔溃疡案（286 页）。但有时，李氏名为“引火归原”法，却用肉桂粉吞，如虚寒型糖尿病案，这是为什么？因此案兼有胃阳虚（如胃脘冷痛、厌食呕逆），为了兼顾胃阳，以“保护脾胃为第一要义”，故改米丸为粉吞。从引火汤证诸案中，可以看出，凡火不归原证兼有胃阳虚、奔豚证、五更泻、反佐证，皆遵“保护脾胃为第一要义”，改米丸为粉吞，如肺心病奇症案兼奔豚证（374 页）、齿衄案兼泄泻（292 页）、鼻衄奇症案兼反佐黄连，均改米丸为粉吞（281 页）。

2.4 肉桂与油桂

笔者注意到，李氏多数称肉桂为“油桂”。考肉桂分 3 种：①官桂：又称筒桂、茵桂，为 5~6 年之幼树干皮、呈筒状；②企边桂：又称油桂、紫油桂，因其表面用指甲刻划时则现棕色油纹而得名，为 10 年的树皮，呈凹凸形半卷状；③板桂：又名桂楠，是老年厚树皮，呈板状。这三种肉桂，以油桂皮细肉厚，断面紫红色，油性大，香气者为佳。所以李氏恒用越南之紫油桂，而不用普通肉桂。其用药精纯，可见一斑。

3 山萸肉

李可关于山萸肉用量：小剂 10 克，平剂 30 克，中剂 60 克，大剂 90~120 克。

3.1 八味丸类方，山萸肉为小剂、平剂

李氏用八味丸类方，遵原方熟地与山萸肉之比例，故山萸肉用量偏轻，小剂者 2 例，平剂者 2 例，如膝关节积液案之济生肾气丸加味（251 页）、夜盲案之杞菊地黄丸加味（268 页）、急性肾盂肾炎案之知柏地黄汤加味（158 页）、真寒假热案之八味地黄汤加味（288 页）。

3.2 潮热、消渴、防脱，山萸肉为平剂

李氏之经验，凡肺癆、小儿疳积、癌证之化疗、放疗所致潮热者，以补中益气汤加山萸肉、乌梅、龙牡各 30 克，半月退净（302、363、396 页）；糖尿病之消渴，癌证之化疗、放疗之烦渴，恒加山萸 30 克（55、56、363 页）。治大气下陷证，下元虚者须防“提脱”，恒加山萸肉 30 克，如胃下垂案（254 页）；羸弱之人，以防阴阳气血之脱散，加山萸肉敛肝，如肺癆夹寒饮案（309 页）。

3.3 脱证、血证，山萸肉为中剂、大剂

气虚欲脱者，急以升陷汤加参、萸，重用山萸肉 90 克，如产后误用开破致变案（113 页），血脱者，见于脾不统血之崩漏便血，出血量多不止，汗出而喘，则是肝气已伤，疏泄太过，不能藏血，急加山萸肉 60 克以上，敛肝救脱；气随血脱者，出血如注，自汗而喘，腰困尿多不渴，急以大剂当归补血汤加红参助元气，重用山萸肉 90 克以上，敛肝固肾救脱；亡阳厥脱者，出血日夜不止，突变四肢厥冷，大汗暴喘，面白如纸，气息奄奄，阴损及阳，阳微欲绝，急投破格救心汤，重用山萸肉 120 克（124、125 页）。

3.4 心衰、呼吸衰竭，山萸肉为大剂

心衰重症，如肺心病心衰案，破格救心汤之山萸肉 120 克（7 页）；如呼吸衰竭，升陷汤合大剂参附龙牡救逆汤，加山萸肉 90 克，麝香 0.12 克（263 页）。

4 吴茱萸

李可关于吴茱萸用量：10 克以下无效，15 克显效，30 克攻无不克，50 克治大症（202、377 页）。

4.1 吴茱萸汤证

李氏认为，《伤寒论》吴茱萸汤证昭示：干呕，吐涎沫，头痛者，吴茱萸汤主之。止痛与止呕，正是吴茱萸的两大功效（44 页）。

4.2 吴茱萸主治

根据李氏之吴茱萸案 21 则，整理其主治：肝寒之巅顶头痛、眩晕、疝痛、缩阳、痛经、冻脚（202、376 页），胃寒之呕吐吞酸、噎膈反胃、胃脘痛、绕脐痛、少腹痛（376、382、389 页）；外敷涌泉引火归原治口疮，敷脐治小儿泄泻，其功不可尽述（376 页）。

4.3 中西汇录

吴茱萸为开冰解冻之剂，其性辛热燥烈，直入阳明、厥阴血分，暖肝和胃，降逆补虚，温化寒饮，能破沉寒痼冷，解除一切痉挛（274、390 页）。由此而解决一些现代医学之难题，如西医脑出血之脑膜刺激症，与中医肝胃虚寒、痰饮上冲巅顶有些相合，详见蛛网膜下腔出血案（44 页）；美尼尔氏综合症之内耳迷路积水、痉挛，与中医痰饮上犯于脑之眩晕相通，详见内耳眩晕症案（272 页）；西医食道、胃肠之痉挛，与中医之“寒主收引”同理，详见噎膈重症案、肠痉挛案（381、390 页）。

4.4 吴茱萸用量

李可认为，《伤寒论》吴茱萸汤之吴茱萸一升，约合今制 50 克。故用量 10 克以下无效，15 克显效，30 克攻无不克，50 克治大症。唯当今各家皆用 1.5～6 克，药难胜病，故其效不著（202、377 页）。李氏之吴茱萸案 21 则，其中吴茱萸小剂 10 克者 5 例，用于小儿、虚弱之人，如小儿过敏性紫癜案、急性肝炎误治变症案（329、170 页）；吴茱萸平剂 15～20 克者 11 例，如痛经痼疾案、血栓闭塞性脉管炎案（114、64 页）；吴茱萸中剂 30 克者 4 例，如美尼尔氏内耳眩晕症案、重症呃逆案（272、196 页）；吴茱萸大剂 50 克 1 例，如红斑狼疮案（202 页）。

4.5 吴茱萸冲洗法

李可认为，吴茱萸汤方下注一“洗”字，是仲景用法奥法所在，即用至 15 克以上，当以开水冲洗 7 次，而后入煎，可免入口辛辣及服后“瞑眩”之弊。凡遇小儿、老人、病弱之人，则先煎沸 2～3 分钟，换水重煎，以便稳妥（376、390 页）。

4.6 吴茱萸姜枣

李可指出，伤寒方用药精纯，虽姜、枣亦寓有深意，并非点缀。**吴茱萸加两倍之生姜、大枣 20~30 枚，则辛烈减，可保无害**（377、390 页）。详见胃溃疡大出血案（15 页）。

5 生半夏

李可关于生半夏用量：小剂 10 克，平剂 30 克，中剂 45 克，大剂 60 克。

5.1 小半夏汤类方

李氏喜用小半夏汤、小半夏加茯苓汤。《金匱》昭示：呕家本渴，渴者为欲解。今反不渴，心下有支饮故也，小半夏汤主之；卒呕吐，心下痞，膈间有水，眩悸者，小半夏加茯苓汤主之。

5.2 半夏主治

根据李氏之半夏案 52 则，整理其主治：肺气上逆之咳喘、喉间痰鸣（26 页），肝胃气逆之呕吐、眩晕、心下痞（45、234 页），脾胃痰湿之麻木、肿瘤（41、335 页）。

5.3 半夏自制方 李氏治咳，喜用小青龙汤，并使之改良；治呕，喜用小半夏加茯苓汤，且进一步推陈出新。

5.3.1 改良小青龙汤

《金匱》36 条提示：青龙汤下已，多唾口燥，寸脉沉，尺脉微，手足厥逆，气从小腹上冲胸咽。简而言之，服小青龙汤易引动下焦冲气上逆之奔豚证。为了克服这一弊端，李氏对此方进行了改良（**麻黄、桂枝、白芍、炙草各 10 克，生半夏 30 克，干姜、细辛、白芥子各 10 克，炙紫苑、炙冬花各 12 克，白果带壳 20 克打，生姜 10 片，大枣 10 枚**），即**小青龙汤加紫苑、冬花、白芥子降逆下气，白果收敛，通治一切咳喘**（397 页）。如虚证者，由肺及肾，肾不纳气，加红参 10 克，肾四味各 30 克；如小儿夜半暴喘（83 页）、或寒郁化热者加生石膏 30 克，如肺心病急性感染案（18 页）；太阳少阴同病，脉沉舌淡苔白滑，加附子 30 克（397 页），如急性结核性胸膜炎案（48 页）；过敏性哮喘者，加石膏、蝉衣各 30 克，如青霉素过敏性皮炎案（324 页）。

5.3.2 止呕汤

李可治呕吐，得力于小半夏加茯苓汤，并进行加味：生半夏、茯苓、赭石、生姜各 30 克，姜汁 10 毫升，炙草 10 克。他指出，其一生应用此方上万例，通治一切肝胃气逆之呕吐，如妊娠恶阻剧吐，水米不入；胃出血狂吐不止；现代医学确诊之脑膜刺激征；寒热错杂之胃肠痉挛等，皆有捷效。轻证服一两口即止，

稍重则服 2~3 次即愈，极重症 10 小时许过关。不论何种呕吐，皆由胃气上逆，胃为气机升降之中枢，胃气不降，则诸经之气皆逆。方以赭石、生半夏、生姜降胃，则气机升降复常，何呕吐之有？正是执简驭繁，以不变应万变之法（44 页）。该方实为小半夏加茯苓汤合旋覆赭石汤，减旋覆花、人参、大枣，加姜汁而成。为了便于记忆与推广，笔者称之为“止呕汤”，方歌为“止呕夏苓代汁草”。李氏之经验：若呕吐兼诸痛者（如头痛、胃痛、腹痛），则加吴茱萸、红参（即吴茱萸汤）。因吴茱萸汤亦有止呕作用，故笔者称止呕汤加吴、参为“双呕汤”，详见胃溃疡大出血案（15 页）。若呕吐兼欲脱，则加山萸肉、红参（取来复汤之意），详见久痢成癆案之“五味回生汤”（307 页）。

笔者很奇怪地发现：李氏治痰、咳，从不用二陈汤；治湿、呕，从不提平胃散。全书只字未提这两方，令人费解。笔者揣测：因为这两个方子，半夏用量偏轻或缺失，如二陈之半夏为 9 克，平胃散则无半夏；燥湿、化痰用理气药（陈皮、厚朴），而不用温化药，收效甚微。而他用生半夏一出手就是 30~45 克，治痰、咳则配细辛、五味子温肺化饮，治湿、呕则配吴萸、姜汁开冻解冻，常有一剂知，二剂已之功效。

5.4 生半夏用量

《伤寒论》之半夏，均为半升，合今为 60 克。半夏用量分为：①半夏小剂 10 克：半夏小剂者 5 案，用于小儿、羸弱之人，如婴儿幽门梗阻案、小儿白血病案、顽麻怪症案（85、368、42 页）。②半夏平剂 30 克：半夏平剂者 37 案，如肺心病心衰案（6 页）；体虚之人，半夏酌减为 15~20 克，如急性结核性胸膜炎案、急性黄疸型肝炎案（47、166 页）。③半夏中剂 45 克：半夏中剂者 3 例，均为咳、呕重症，如肺间质纤维化案、脑瘤术后复发案（29、245 页）。④半夏大剂 60 克：半夏大剂者 3 例，均为经方大症，如急性胰腺炎案之大柴胡汤证、红斑狼疮之小柴胡汤证（140、203 页）。

5.5 半夏冲洗法

《伤寒论》小柴胡汤方下之半夏注一“洗”字，即用温水淘洗 3 次，可解其毒，若多次淘洗则力减（7 页）。

5.6 半夏生姜

《金匱》载：小半夏汤，半夏 1 升，生姜半斤。考半夏 1 升为 130 克，生姜半斤合今为 125 克，即半夏与生姜等量。故李可指出，生半夏加等量生姜佐之，既解其毒，又加强疗效，颇有妙用（8 页）。笔者对《伤寒论》半夏方进行统计，半夏均为半升，即 60 克，而生姜多少不等，如厚朴生姜半夏甘草人参汤之生姜为 125 克，其次为旋覆赭石汤之生姜为 75 克，大柴胡汤亦为 75 克，生姜泻心汤为 60 克，小柴胡汤、葛根加半夏汤为 45 克，黄芩汤为 215 克，小青

龙汤、半夏泻心汤、甘草泻心汤则无生姜。从中可以看出，如经方中有干姜，或呕吐而兼热者，生姜酌减、或无。李氏之半夏案亦然。只有以小半夏汤、小半夏加茯苓汤、止呕汤为主方时，其半夏与生姜为等量，如妊娠恶阻案、婴儿梗阻案（84、107 页）。

6 麝香

李可关于麝香用量：每次最小量 0.075 克，最大量 0.5 克，日极量 1 克分 3 次服。

6.1 麝香功能

麝香，味芳香浓烈，性辛温入心脾经。功能辟秽化浊，开窍启闭，为急救醒神要药，开中有补，对一切脑危象（痰厥昏迷）有斩关夺门之功。其辛香走窜之力，又善开经络壅闭，具有解毒、活血、通经、消肿止痛作用，故又可用痈疽肿毒及跌扑瘀痛等症，效难尽述。现代药理证实，有兴奋中枢神经系统，增强呼吸中枢功能及强心救脱功效，对心衰、呼吸衰竭、血压下降、冠心病心绞痛发作，均有可靠疗效。又能促进各腺体的分泌，有发汗和利尿作用，故可用于血毒症的抢救。因其辛香走窜之力极强，故只可暂用，不可久服（4、177 页）。危重阶段，可连服 10 日停药，详见肺间质纤维化案（32 页）。

6.2 麝香主治

麝香配清热解毒方药，则善凉开宣窍，其作用较安宫、至宝为优；配回阳破阴方药，则善温开宣窍，其作用较苏合香丸为速（177）。分述如下：

6.2.1 昏迷 麝香为急救神识昏迷要药，如小儿高热抽搐之急惊风，单味麝香 0.15 克，一次灌服，立解其危（177 页）。小儿慢惊风，取高丽参粉 5 克，麝香 0.3 克，服后 20 分钟，抽搐停止，神识转清（74 页）。中风痰厥昏迷，麝香 0.3 克配姜汁竹沥灌下，如脑溢血案（36、177 页）。肝昏迷，属阴寒秽浊内闭外脱者，以茵陈人参白通四逆汤加菖蒲、麝香 0.3 克（173 页）；若湿热化毒，腑实内闭之急黄症，热深厥深者，以犀角地黄汤合大承气加菖蒲、郁金、麝香 0.5 克，4 小时可醒（177 页）。煤气中毒昏迷，以礞石滚痰丸加麝香 0.3 克（189 页）。脑外伤昏迷，以补阳还五汤加麝香 0.15 克（192 页）。

6.2.2 心衰、呼吸衰竭 李氏创制破格救心汤中，麝香 0.5 克分冲，救治各种心衰。如布鲁氏杆菌病心衰案之麝香 1 克分冲（11 页）。又以升陷汤合大剂参附龙牡救逆汤，加麝香 0.2 克，山萸肉 90 克，救治呼吸衰竭（263 页）。

6.2.3 剧痛 心绞痛发作，参灵散（红参、灵脂）加麝香 0.5 克，覆杯而愈（178 页）。急性心梗，先冲服麝香 0.5 克、冰片 0.3 克，含化速效救心丸 5 粒，苏合香丸 1 丸，为抢救赢得了宝贵的时间（12 页）。血栓闭塞性脉管炎

之剧痛，以乌头汤合当归四逆加吴茱萸汤加麝香 1 克分冲，当夜痛止（64 页）。脑瘤剧痛，以乌头汤加麝香 1 克分冲，1 剂痛止（247 页）。

6.2.4 通窍 眼底出血暴盲，以通窍活血汤之麝香，加水蛭数日复明；慢性鼻窦炎之嗅觉失灵，以麻黄汤合麻黄附子细辛汤加麝香 0.15 克，3 剂而愈（282 页），直肠癌术后尿闭，以补中益气汤加沉香、肉桂、麝香 0.5 克通下窍，40 分钟而解（113 页）。

6.3 麝香自制方

6.3.1 麝甲无敌散 麝香与炮甲相配，古方常有之，如《仁斋直指方》载：炮甲 5 分，入麝香少许，温酒服，治痘疮发黑。其麝香为“少许”，不易效法。李氏对此进行了规范，二者之常用比例为 1：30，即麝香 2 克、炮甲 60 克为一料，研粉分成 20 包，随中药早晚以热汤冲服各 1 包。因耗气伤阴，不可久服，服 10 日停药，但恶性肿瘤例外（29、342 页）。他认为，麝香与炮甲相配，穿透攻破，无微不至，无所不到，直捣病巢，消囊肿，破肿瘤（104、344 页）。用于多种顽症痼疾，如肺间质纤维化（29、32 页）、血栓闭塞性脉管炎合并心梗（65 页）、卵巢囊肿（104 页）、脑瘤（247 页）、脊髓神经胶质瘤（342 页）、局限性皮炎（333 页）、小儿遗尿等（87 页）。鉴于用途甚广，无所不能，故笔者称之为“麝甲无敌散”。若麝香紧缺，李氏之经验可用苏合香丸代之，即每服苏合香丸 1 丸，配炮甲粉 3 克（32 页）。

6.3.2 羚麝止痉散 羚麝止痉散（羚羊角 3 克，麝香 1 克，蝎尾 12 只，蜈蚣 2 条为末，分 3 次服），为李氏急救小儿高热惊风开窍醒神常备药。轻症单服立效，不必配服汤剂。详见小儿肺炎合并急惊风案、小儿流脑案、小儿大脑发育不全案、疹毒内陷案、中风闭症案（77、36 页）。

7 全蝎与蜈蚣

李可关于蝎蜈用量：全蝎小剂 3 克，平剂 12 只；蜈蚣小剂 2 条，平剂 4 条。李氏之全蝎小剂者 9 例，如急性肾炎案、蛛网膜下腔出血案（162、44 页）；全蝎平剂者 16 例，如颈椎病案、类风湿性关节炎（217、210 页）。全蝎 12 只，经笔者考“12 只”为 8 克，经水漂洗去盐后干燥为 6 克，研粉分冲，可谓“重剂”，故取效甚捷。蜈蚣小剂者 12 例，如急性肾炎案、三叉神经痛案（162、240 页）；蜈蚣平剂者 11 例，如颈椎病案、鸡爪风症案（217、122 页）。小儿、老人、病弱之人酌减，如小儿湿疹案之蜈蚣 1 条，重症结核性腹膜炎案之蜈蚣 1 条（88、103 页）。

李可用药规律，现简要归纳。红参用量：补元用平剂，急救暴脱用大剂；剂型有捣末同煎，另炖，粉吞，块吞。肉桂用量：温肾阳、助气化、反佐用平剂，引火归原、降奔豚、止泄泻、护胃阳用小剂；剂型有平剂煎服，小剂粉冲、米丸

吞服。山萸肉用量：小剂 10 克，平剂 30 克，中剂 60~90 克，大剂 120 克。吴茱萸用量：10 克以下无效，15 克显效，30 克攻无不克，50 克治大症。生半夏用量：小剂 10 克，平剂 30 克，中剂 45 克，大剂 60 克。麝香用量：每次最小量 0.01075 克，最大量 0.5 克，日极量 1 克。蝎蜈用量：全蝎小剂 3 克，平剂 12 只，蜈蚣小剂 2 条，平剂 4 条。

（内文页码源于《李可老中医急危重症疑难病经验专辑》一书。）

少腹鼓凸大气陷

——李可学术思想探讨之十三

摘 要 针对大气下陷辨证的分歧，进一步探讨了李可学术思想。李可研究大气下陷思路：继承东垣、锡纯大气下陷理论；提出少腹鼓凸症辨治要领；对补中益气汤、升陷汤进行改良；总结出防治提脱的用药经验。

关键词 大气下陷 少腹鼓凸症 补中益气汤 升陷汤 李可 医案

大气下陷理论由张锡纯独创。他认为，大气是诸气之纲领，此气一虚，呼吸即觉不利，而且肢体痿懒，精神昏愤，恼力心思为之顿减。若其气虚而且下陷，或下陷过甚者，其人即呼吸停顿，昏然罔觉。这无论在内伤慢性病中，或外感危重症中，均可见到，实为心肺功能极度低下。如果误认为“气滞胸闷”而投破气之药，往往变生顷刻；或认为“气逆不纳”而进纳气之药，则危在旦夕。李可对大气下陷理论进行系统整理和发挥。现根据其医案 13 则，整理出以下内容：

1 重温锡纯大气下陷理论

为了探本溯源，我们应当首先回顾一下锡纯之大气下陷理论。《医学衷中参西录》在“医方 治大气下陷方”条文中有 22 则医案，在“医案？气陷门”条文中有 5 则医案。笔者根据这些案例，归纳出以下内容：

病因 多得之力小任重，或枵腹（空腹）力作，或病后气力未复而勤于动作，或因泄泻日久，或服破气药太过，或气分虚极致下陷（32 页）。

证候 气短不足以息，或努力呼吸似喘（31 页），或努力呼气不能上达（690 页），或胸闷（38 页）或觉气不上达而常作太息（40 页），或五七呼吸之顷必长出气一口（43 页），或夜卧 1 小时（即觉气不上达），须得披衣而坐，将气调匀方能再睡（693 页）；或假寝片刻，气息将停，需急呼醒之，连喘数口（238 页）；或昏不知人，移时始苏，或睡时恒自惊醒（43 页）。或下陷甚，至少腹

下坠，或更作疼者（31 页）。其兼证，或寒热往来，或咽干作泻，或怔忡，或神昏健忘，诚难悉数（31 页）。脉象沉迟微弱，关前尤甚。其剧者，或六脉不全，或参伍不调。右寸弱者 1 例，关前尤甚者 3 例（37、695 页）。

处方 升降汤：生芪 18g，知母 9g，柴胡 4.5g，桔梗 4.5g，升麻 3g。

加减 锡纯之 27 案，生芪最大量 30 克者 3 例；若少腹下坠，或更作疼者，升麻 4.5~6 克；肾气浮动轻者，加人参 9 克者 3 例，山萸肉 6~12 克者 3 例；重则加龙牡各 15 克者 2 例，或玄参 12~18 克者 6 例，或桂枝 9 克者 3 例。

鉴别要点：

① 大气下陷与气逆不纳：

凡喘证，无论内伤外感，**气逆作喘剧者**必然肩息（《内经》谓喘而肩上抬者为肩息）；**大气下陷者**，虽至呼吸有声，必不肩息。盖肩息者，因**喘者之吸气难**；不肩息者，因**大气下陷之呼气难**也。欲辨此证，可作呼气难与吸气难之状，以默自体验，临证自无差谬。又喘者脉多数，或有浮滑之象，或尺弱寸强；大气下陷之脉，皆与此成反比例（38 页）。

② 真喘与似喘：

大气下陷者，气短不足以息，努力呼吸以自救，有似乎喘，实与气逆（不纳）之喘有天渊之别。观此证假寐片时，肺脏不能努力呼吸，气息即无，其病情可想也（31、38 页）。补中益气汤所治之喘，即大气下陷者努力呼吸也。若果系真喘，桔梗尚不宜用，况升麻乎？设医者，真以为补中益气汤果能治喘，而于气机上逆之真喘亦用之，岂不足僨事乎？此有关性命之外，临证者当审辨之（47 页）。简而言之，**真喘是指气逆不纳之喘，而似喘是指大气下陷之喘。**

点评 锡纯评东垣与补中益气汤：由于《灵枢》、《金匱》关于“大气”仅有只言片语，后人多不解其义。是以东垣于大气下陷证，亦多误以为中气下陷，故补中益气汤用白术以健胃补脾，而后来之调脾胃者，皆以东垣为法。夫中气诚有下陷之时，然不若大气下陷之尤属危险也。间有因中气下陷，泄泻日久，或转致大气下陷者，可仿补中益气之意。若但大气下陷，而中气不陷者，白术可不用，恐其气分或有郁结，而芪术并用，易生胀满也。补中益气汤所治之喘证，即大气下陷者努力呼吸也。若果系真喘，桔梗尚不宜用，况升麻乎？愚少时观东垣书，至此心尝疑之，后明大气下陷之理，始觉豁然，而究嫌其立言欠妥（47 页）。简而言之，东垣误将大气下陷为中气下陷，补中益气汤治喘之立言欠妥。

2 李可论大气下陷

李可论大气下陷，其理论不多，多散见于医案。

2.1 脏气下垂大气陷

李氏认为，中气下陷症临床多见，多由内伤积久而来。此症之重者，即张锡纯氏论述之“大气下陷症”，诸如胃下垂、子宫、直肠脱垂等脏器下垂症（254、255 页）。下面举例证之：

胃下垂重症 王某，男，56 岁。患胃下垂 10 年，近半月来少腹憋胀，不敢进食，食入胀急更甚。腹诊，少腹鼓凸，挺着一个大肚子，如怀孕 5~6 月之孕妇状，按之空软。神色憔悴，动则轰热喘汗。腰困如折，行路弯腰如虾，挺腰则困不可忍。脉细弱，舌淡无华。患者年近六旬，劳倦内伤，损及脾胃之阳，中气下陷于至阴之地而不能上达，且肾中真气不固，有上越下脱之险。拟补中益气汤去陈皮，加山萸肉、补骨脂、沉香固护下焦元气：生芪 30g，知母 18g，红参（打小块吞）10g，当归 15g，柴胡、升麻、炙草、沉香各 10g，山萸肉、补骨脂各 30g，白术 20g，生姜 5 片，大枣 10 枚，胡桃 4 枚（打），上方服 1 剂之头煎半小时，汗敛喘定，觉气从丹田缓缓上达，少腹之鼓凸、胀急，立时消散，3 剂服完纳食如常。患者大喜过望，忘乎所以，食闺女送来大桃 1 枚，喝凉茶 2 杯，1 刻钟后又复气陷坠胀如故。当晚咕咕有声。中午不敢进食。气机为病，瞬息万变。此由生冷寒凉，戕伤脾胃生阳之气，亟温之：干姜 30g，红参（打小块吞）、炙草各 10g，木香、柴胡各 3g，1 剂后平复如初（254 页）。

李按 胃下垂多见大气下陷症，上则见气短难续似喘，下则少腹明显鼓凸如孕归，按之必空软无物。脉多细弱，右寸尤弱。凡遇此症，万不可见胀消胀，稍涉散气消胀、寒凉败中或消导开破，立见危殆，错则难救。用补中益气汤，气弱之人，即陈皮之散，亦经受不起，宜慎。红参不入煎剂者，因汤剂效速，虚馁之人下咽反觉胀闷，打小块吞服，入胃缓缓奏功，使下陷之气，徐徐升达。古谓：“下虚者用补中升陷，须防提脱。”故加山萸肉、补骨脂、胡桃者，有敛固下焦肾气妙用。

2.2 妇科产后多气陷

李氏之大气下陷案，见于崩漏者 5 例，如青霉素过敏后血崩案（122 页）；胎前病者 2 例，如习惯性流产案（111 页）；产后病者 4 例，如产后尿闭案（113 页）。现附验案，以为佐证：

剖腹产后二便闭结 王某，女，30 岁。剖腹产后，腹胀气急，不能躺卧，二便闭结已 3 日。血色素 6 克，面色苍白近灰，声低息微，目不欲睁，脉芤大无伦，满腹鼓胀如小瓮，高出胸际寸余。导尿、灌肠皆无效。无矢气，按之中空。追询病史，已生 3 胎，均因子宫不收缩而剖腹，此系第 3 次。患者胀急欲死，频频要求通通大便。然腹大中空，纯属气虚不运，妄用通利是速其死也。迳投大剂补中益气汤，塞因塞用：生芪 60g，红参（另炖）15g，白术 30g，当归 30g，

柴胡、升麻、陈皮、炙草各 10g，木香、沉香、油桂、砂仁各 115g（研粉冲服），葱白 3 寸，生姜 5 片，枣 10 枚，2 剂。二诊：药进 1 剂，即频转矢气，胀消、二便皆通，食纳增，乳汁下，2 剂后已如常人，血色素上升至 7 克。嘱原方陈皮减为 5 克，去后四味，加元肉 10 克，3 剂后血色素上升至 10 克，出院（112 页）。

按 本案剖腹产后气血大虚，损伤冲任，大气既经下陷，复因下焦虚寒，二便不通。故以大剂补中益气汤升举，加油桂、沉香温下元，木香流气，葱白通阳，大气一转，病即霍然而愈。

2.3 呼吸衰竭大气陷

李可认为，大气下陷之呼吸困难，自觉气陷于脐下，病人有努力吸气状，面色苍白，神情恐惧。类似现代医学之呼吸衰竭，多见于肺心病心衰合并脑危象之前，属危急重症范围（262 页），兹举其案例如下：

呼吸衰竭 封某，女，28 岁。因急诊入院，主证为呼吸极度困难，似乎气息将停，危在顷刻，恐惧殊甚。气不能上达，动则喘、汗、心悸。胸透见右肺陈旧性胸膜炎。经内科给氧、抗炎治疗不能控制，邀中医会诊。见患者呼吸迫促，讲述病情需多次换气才能勉强讲下去，并辅以手势。胸际有重压感，且阵阵刺痛，四末不温，少腹鼓凸如临产状。脉细滑无力，右不上寸，左寸极弱，苔白腻，质绛而干。追询病史，由 10 多天前因胸闷痛服中药 4 剂，因其中有瓜蒌枳实后引起，患者病久，胸际本有停痰积瘀，阻塞大气升降道路，又服开破之品，致胸中大气下陷。乃疏升陷汤合丹参饮，升举大气兼通经络瘀阻，药用：生芪、山萸肉、丹参各 30g，柴胡、升麻各 6g，桔梗 9g，红参 10g（打小块吞），檀香、降香、炙草各 10g，砂仁 5g，知母 18g。药进一煎后 1 小时，呼吸衰竭之象解除，说话不喘，走路已如常人，嘱原方连服 3 剂。三诊：患者步行来门诊，面有喜色，气短基本痊愈，如孕大肚也消失了。唯觉脐下筑筑跃动，时时有气上冲心下，则一阵心悸。古人告诫，下虚者用补中升陷，须防“提脱”。此例患者因升陷过剂，竟出现肾气浮动，冲脉不安于位的奔豚证。改投小剂奔豚汤（附子、肉桂、砂仁、沉香、山药、茯苓、泽泻、怀牛膝、人参、炙草），因舌绛加熟地 30 克，又加紫石英、龙牡各 30 克镇冲豚，2 剂。药后痊愈出院（257 页）。

李按 古人告诫，下元虚者须防“提脱”。初涉临床时以为古人臆想，不料患者因升陷过剂竟出现肾气浮动，始知中医学理，深奥玄妙，绝非臆说。可见辨证投剂，不但要恰合病机，还要见微知著，预见发展，掌握分寸。

2.4 癥病怪症多气陷

李可认为，大气者聚于胸中，斡旋运动不息，五脏六腑出入升降各循常道，是为健康无病。此气一陷，肺失包养，肺气虚则燥，故悲伤欲哭而似甘麦大枣汤证；心失所养，神明无主，意志失常而见酸枣仁汤证；心气虚则恐，故时觉有人

跟踪；肝失大气之斡旋而见喜怒无常，震颤抽搐。其精神神经之异常，正是五脏五志之变。一切病象皆由气陷下焦，不能升举所致（258、259 页）。下面看一则瘕病案：

瘕病性截瘫 赵某，女，26 岁。因过服调经药 30 剂，突然大崩，致 7 日休克 5 次，后经中医治愈。之后体质一落千丈，经常头晕气短，站立不稳。去年冬天，流产后，将息失宜，感冒后致下肢痿软，不能下床，双足内翻，不能站立，上半身功能正常，经县医院诊为瘕病性截瘫。气短甚著，叙述病史，多次间断换气。虽已流产，少腹仍鼓凸如孕状。自觉气憋在肚脐之下，不能上达于胸，频频太息、提气。且尿频，脱肛，腰困如折，夜不成寐，食少不饥，时时悲伤欲哭。每至太阳落山，心中无端恐怖。此证由血脱而致气陷，中宫虚馁，五脏失养，日久损及先天肾气。其精神神经之异常，正是五脏五志之变，此痿症之成，与湿热、痰浊、阴虚皆无涉。从脾主四肢，肝主血，肺主气，肾为先天之本论治。升补大气，补肾益精，药用：生芪 30g，知母 18g，当归 20g，山萸肉 30g，红参（打小块吞）10g，柴胡、升麻、桔梗各 6g，小麦、百合、肾四味、龙牡各 30g，大枣 10 枚。上方连服 30 剂后，康复如初，上班工作（259 页）。

按 此证由血脱而致气陷，故以升陷汤合当归补血汤、甘麦大枣汤、肾四味加味。大气之斡旋复常，则五脏六腑出入升降循常道，五脏五志之病变亦霍然而愈。

2.5 少腹鼓凸大气陷

李可认为，**少腹鼓凸**是一个特殊的症状与体征，按之必空软无物。其特点是吸气难，气升不上来；重者觉气陷于脐下，病人有努力吸气状，面色苍白，神情恐惧。类似现代医学之呼吸衰竭，属急危重症范围（262 页）。现根据其医案，归纳出辨治要领：

病因 由内伤积久而来，多见于脏器下垂、呼吸衰竭、妇科产后病、瘕病怪症等。

证候 ①呼吸困难：自觉气短，气短难续似喘（254 页）；动则喘，甚则喘、汗；气怯难继，移时即经长吸一口气（257 页）；或觉气憋在肚脐之下，不能上达于胸，频频太息、提气（259 页）。其特点是吸气难，气升不上来；重者自觉气陷于脐下，病人有努力吸气状，面色苍白，神情恐惧（262 页）；呼吸息促，讲话需要多次换气，并辅以手势，甚则似乎气息将停，危在顷刻（256 页）。②少腹鼓凸：按之必空软无物，轻者少腹鼓凸如尿潴留状（349 页），加重依次为少腹鼓凸如 4 月胎孕状（259 页）、5 月孕妇状（262 页）、5~6 月胎孕状（253 页）、六月孕妇状（255 页）、临产状（256 页）。③脉象：多细弱，右寸尤弱（254 页）。少腹鼓凸者 13 案，而右寸尤弱者 5 例（257 页）。

处方 ①补中益气汤：生芪 30~60g，红参（打小块吞）10~15g，白术 20~30g，当归 20~30g，升麻 10g，柴胡 10g，陈皮 3~10g，炙草 10g。②参萸升陷汤：生芪 30~45g，红参（打小块吞）10~15g，山萸肉 30~90g，知母 9~18g，柴胡 415~6g，桔梗 415~6g，升麻 6g。③升陷汤合参附龙牡救逆汤：生芪 30g，柴胡 10g，桔梗 10g，升麻 10g，红参（打小块吞）10g，山萸肉 90g，附子 30~100g，龙牡各 30g，麝香 0.12g。（263 页）

加减 ①补中益气汤：气弱之人，陈皮多去之，如胃下垂案（253 页）、阴痒顽症案（262 页）；②升陷汤：治少腹鼓凸症，恒加红参、山萸肉；因知母苦寒滑肠，便溏或阳虚者多去之，如胃下垂案（255 页）、气陷瘕病案（258 页）；舌绛者可用之，如呼吸衰竭案（256 页）。③升陷汤合参附龙牡救逆汤：用于呼吸衰竭之危证，去知母之苦寒，加山萸肉 90 克，麝香 0.12 克，取破格救心汤之意。

鉴别 中气下陷与大气下陷：**中气下陷证**，多有胃肠病史，如胃下垂、子宫脱垂、脱肛，常见食入胀甚，久泻，小腹坠胀，动则喘促等，详见胃下垂、子宫脱垂案（254、257 页）；**大气下陷证**，多有肺病史，常见呼吸短促或微弱，胸闷，言语音低，讲话得多次换气，喘汗，少腹鼓凸等，详见呼吸衰竭案（256 页）。中气下陷之重者，可变为大气下陷证，上则见气短难续似喘，下则少腹鼓凸如孕，按之必空软无物（254 页）。

3 李可对大气下陷理论的继承与发挥

3.1 继承东垣、锡纯大气下陷理论

东垣倡导了中气下陷理论，锡纯创立了大气下陷学说。李氏认为，中气下陷与大气下陷，既有区别，又有联系，并将二者融为一体（详见上面“鉴别”论述）。补中益气汤与升陷汤各有适应证，由于**补中益气汤之组成兼顾方面比较多**，如脾虚、血虚，故李氏常用于内脏下垂、妇科产后病，如胃下垂案（253 页）、剖腹产后二便闭结案（112 页）。而**升陷汤力量比较专一**，故多用于大气下陷兼脱症、呼吸衰竭，如食道癌血脱案（349 页）、呼吸衰竭案（256 页）。

3.2 创建少腹鼓凸症辨治要领

李可认为，少腹鼓凸是一个特殊的症状与体征，多从病人主诉得知，一般不易引起注意。中医少用腹诊，一些青年妇女又羞于启齿，故更易忽略。但临床出现频率很高，又关乎病人生死，不可轻视。凡见此症状，先从“虚”处寻根问底（262 页）。李氏处在“穷乡僻壤”的县中院，而就诊的妇女又比较羞怯，其困难是可想而知的。但这病关系到生死，他也就顾不上这些了，被逼上了少腹鼓凸症攻关之路。笔者从病因、证候、处方、加减、鉴别等方面进行归纳，为急危重症的治疗又添了一笔。

3.3 对补中益气汤、升陷汤进行改良

东垣之补中益气汤，原方以 3 钱细末，水煎服。《方剂学》之补中益气汤，黄芪 15g，白术、当归各 10g，以这样的轻量，治疗大气下陷之急危重症，诚然难矣。李氏则重用生芪 60g，白术、当归 30g，红参 15g，如剖腹产后二便闭结案（112 页）；气弱之人，陈皮多去之，或以木香 3 克代陈皮（因气陷多生寒，故以辛温之木香流气），如子宫脱垂案（258 页）。锡纯之升陷汤，原方生芪 18 克，而李氏则重用生芪 45 克，恒加红参 10~15 克，山萸肉 30~90 克，可立解其危，如产后误用开破致变案（113 页）；因知母苦寒滑肠，便溏或阳虚者应去之，如胃下垂案（255 页）。

3.4 总结出防治提脱的用药经验

古人告诫，下虚者用补中升陷，须防“提脱”。为此，锡纯在升陷汤用法中指出，肾气浮动轻者加人参 9 克，山萸肉 6~12 克，重则加龙牡各 15 克，或玄参 12~18 克，或桂枝 9 克。李氏防治“提脱”分为 3 个层次：①预防提脱，以参萸为药对：为了防止“提脱”，恒用红参 10 克补元，山萸肉 30 克敛肝，如大气下陷夹痰瘀案（257 页）。②救脱固肾，以补骨脂、沉香、肾四味、龙牡为药对：见于肾不纳气之喘者，在参萸基础上，加补骨脂 30 克，沉香粉 3 克，鼓舞肾气，如子宫脱垂案（258 页）、胃下垂案（253 页）；腰困如折者，加肾四味各 30 克，心动神摇欲脱者，加龙牡固摄，如气陷癰病案（259 页）。③降冲奔豚，以紫石英、肉桂、沉香为药对：见于奔豚者，加煅紫石英 30 克，肉桂、沉香粉各 3 克，直入肝肾，安镇冲脉，如呼吸衰竭案（257 页）。

4 大气下陷的再思考

4.1 笔者对大气下陷的困惑

为了说理方便，笔者将肾不纳气之喘，称为“不纳之喘”，而把大气下陷之喘，称为“下陷之喘”。锡纯认为，不纳之喘，其剧者必然肩息，为吸气难；下陷之喘，虽然呼吸有声，必不肩息，为呼气难（38 页）。李可则认为，下陷之喘为吸气难（262 页）。关于下陷之喘，二者之观点则截然相反，这可把学验不精的笔者难住了。

4.2 锡纯大气下陷呼气难与气不能上达自相矛盾

锡纯认为，大气下陷为呼气难（38 页）。初学中医的人都知道，肾不纳气是吸气难。有了这样一个先入为主的前提，进而去接受大气下陷是呼气难，也是顺理成章的事，再加上《医学衷中参西录》是中医史上的名著，笔者最初就很自然地站到了这一边。但锡纯一方面指出大气下陷是呼气难（即气不能下降）；另一方面又反复强调大气下陷是气不能上达（690、692 页）。这一“上”一“下”是自相矛盾，让人无所适从。

4.3 李可为什么反复提示大气下陷是吸气难

李氏在大气下陷诸案中，呼吸困难的通常提法为气短难续似喘（254 页），移时须长吸一口气（257 页），或觉气憋在脐之下，不能上达于胸，频频太息、提气等（259 页）。只在最后一案之按语中，即一个不显眼的位置，提出“大气下陷是吸气难”的问题。由于《李可老中医急危重症疑难病经验专辑》一书，有些校对上的错误，故笔者怀疑李可与锡纯这一字之差（即“吸”与“呼”），很可能是校对上的问题。但后来发现在“大气下陷是吸气难”的后面还有一句：其重者，自觉气陷于脐下，病人有努力“吸”气状（262 页）。如果是校对上的错误，那不可能在前后两句话中，再重复一次。笔者按照这个逻辑，排除了校对问题的可能性，而反思自己是不是站“错队”了，就进一步揣摩大气下陷究竟是“呼气难”还是“吸气难”的问题。锡纯一再告诫我们，欲辨此证，可作呼气难与吸气难状，以默自体验，临证自无差谬（38 页）。笔者通过“默自体验”终于悟出：古人以形象的比喻，称肺为华盖而比作“伞”，即肺有升降功能，伞有开合作用。肺主气，偏于胸式呼吸；肾主纳气，偏于腹式呼吸。大气下陷则横膈不能上升，即伞打不开或开不到位，表现为胸式吸气难；肾不纳气则横膈不能下降，即伞合不上或合不到位，表现为腹式吸气难。这样看来，大气下陷“呼气难”应正名为大气下陷“吸气难”。

李可研究大气下陷思路，现简要归纳如下：继承东垣、锡纯大气下陷理论，提出少腹鼓凸症辨治要领，对补中益气汤、升陷汤进行改良，总结出防治提脱的用药经验。

伏邪作祟多痛证

——李可学术思想探讨之十四

摘要 针对痛证医学难题，进一步探讨了李可学术思想。李可治痛证自制方：偏正头风散，引火芍药甘草汤，葛根双五止痉汤，乌头当四豨鹳汤，类关培元固本散，类关乌头酒，类关乌头外熨方，苍术白虎汤，脱疽乌头汤，黄芪四妙勇安汤；治痛证思路：寒热分型，开表不止，透邪汇粹，霹雳手段

关键词 痛证 寒热分型 开表透邪 霹雳手段 自制方 李可 医案

痛证，包括头痛、项强痛、肩痛、脊背痛、腰痛和四肢痛。这些痛证，在临床上都以消除疼痛为主要目的，至于伤寒的头痛、身痛和泻利之腹痛，不以疼痛为主证的，不在讨论范围之内。本病常使患者抱痛终生，而令医生焦头烂额，确

是医学一大难题。李可对痛证的治疗，有着丰富的临床经验。现根据其医案 24 则，整理出以下内容：

1 痛证验案

1.1 头痛

1.1.1 引火汤证

李可认为，龙雷之火是脏腑内生虚火，与六淫外邪实火大不相同。若阴不抱阳，则火失其制，水浅不养龙，于是离位上奔；或肾水寒极，逼真火浮游于上，致成火不归原之证，而见种种上热见证，如头痛、头晕、牙痛等。水亏者，以引火汤壮水敛火，导龙归海；水寒者，以引火汤加肉桂 1.5 克（米丸先吞），温脏敛阳，引火归原（241 页）。下面举例证之：

三叉神经痛 裴某，女，55 岁。患原发性三叉神经经痛 8 年，迭用酒精封闭、针灸，服中药百剂皆无效。近年来发作频繁，因外受风寒，或大喜大怒，过度劳累，高声说话，咀嚼食物，洗脸刷牙，打呵欠皆能触发。8 年前仅下颌支患病。2 年之后累及上颌支，去年冬眼支亦病。以为龋齿作痛，牙已拔光，病势日见严重。以致不敢进食咀嚼，以流质食物维持不饿，致消瘦脱形，弱不禁风。此次发病已 3 日，病前无故右眼赤如鸠目，泪如泉涌，日夜不止，右耳鸣如潮声。今晨，因大声呼唤幼子起床，冷风拂面，突觉畏寒。同时觉有热气从右脚心沿腿之内侧上攻头面，迅如闪电，旋即整个右头部如蛇咬蝎蛰，火灼电击，剧痛嚎哭，惊扰四邻。每次发作约 5 分钟，频发 30 余次，持续 3 小时之久。诊脉洪大无伦，舌干红无苔。头晕脚软，足膝冰冷，口干便燥 3-4 日一行。拟傅山引火汤合芍药甘草汤大剂，滋阴恋阳，引火归原，柔肝缓急，以制雷火：熟地 90g，盐巴戟天、天麦冬各 30g，茯苓 15g，五味子 6g，白芍 100。炙草 30g，3 剂。二诊：药后脚底上冲之气已敛，发病次数逐日减少。每有发作，一闪即过，已可耐受，洪象已敛，目赤、耳鸣均愈。考虑多年痼疾，久痛入络，佐以虫类搜剔。原方加细辛 15 克，全蝎 12 只、蜈蚣 2 条研粉冲服。三诊：服 1 剂发作停止，已 4 日未发，全家人大喜过望。嘱原方再服 3 剂巩固。追访 10 年，未复发（240 页）。

李按 本病为临床常见疑难病之一，各家多以风、寒、痰、火、瘀论治，或见效于一时，后必复发。盖本案年逾五旬，肾气已衰，肾阴下夺，阴不恋阳，时值春令，阳气升发。脚底为肾经循行始发部位，龙雷之火之不能下安宅窟，循经上攻，上奔冲击无制，而成燎原之势，法宜大剂滋水，考虑多年痼疾，久病入络佐以虫类搜剔，更加细辛引入少阴而驱伏寒，兼寓火郁发之之意。

1.1.2 吴茱萸汤证

李可认为,《伤寒论》吴茱萸汤证昭示:干呕,吐涎沫,头痛者,吴茱萸汤主之。止痛与止呕,正是吴茱萸的两大功效(44 页)下面看一则吴茱萸汤证案:

蛛网膜下腔出血 温某,女,27 岁。怀孕 5 个月,突然剧烈头痛,喷射状呕吐,经急诊治疗两周,病势转重,邀李氏诊视。询知 CT 见“蛛网膜下腔出血”,颅内压居高不下,频频喷射状呕吐。近日多次发生短暂性抽搐,一度口眼歪斜,头痛如破,呻吟不绝,目赤气粗,呕吐稠粘痰涎及黄绿色苦水,其气秽臭。脉弦滑而劲,阵阵神糊。证属肝胃痰火上攻,气机逆乱,有升无降,内风已动,有蒙蔽神明之险,急则治标,予降气涤痰和胃降逆:赭石、怀牛膝、生半夏各 30g,胆星、天竺黄、柴胡、黄芩、酒龙胆草、枳实、炙草各 10g,白芍 45g,珍珠母、茯苓 30g,全虫 5g、蜈蚣 3 条(研末冲服广生姜 30g,姜汁 10 毫升(兑入),煎取浓汁 300 毫升,小量多次缓缓呷服,待呕止,顿服安宫牛黄丸 1 丸。1 剂后,头痛减,抽搐未发,神志已清。凌晨又见剧烈头痛约 1 刻钟,呕减而未止,吐出酸苦粘涎,脉弦滑较昨稍缓,舌上水滑,胃中觉凉。改投镇肝熄风汤合吴茱萸汤加减,重在降逆和肝胃:赭石 45g,怀牛膝、生半夏、茯苓各 30g,红参(另炖)、吴茱萸(开水冲洗 7 次)、炙草各 15g,全虫 10g,蜈蚣 10 条,生姜 30g,姜汁 10 毫升。1 剂后痛呕均止,颅压正常。仍予原方加减,侧重化痰两剂,诸症均退,未见任何后遗症。唯输液一侧之下肢肿,予补阳还五汤调理而愈(45 页)。

按 本例之剧烈头痛,在加吴茱萸汤后一剂而止。因吴茱萸辛苦大热,其气燥烈,李可在下笔之际曾有犹豫,恐不合于“脑出血”症。中医虽无“蛛网膜下腔出血”之病名,但患者头痛如破,剧烈呕吐,吐出物为酸苦涎沫,又自觉胃凉,正是肝胃虚寒,痰饮上冲之吴茱萸汤证,投之“效如桴鼓”。李氏之经验:吴茱萸 10 克以下无效,15 克显效,30 克攻无不克。凡遇小儿、老人、羸弱病人则先煎沸 2-3 分钟,换水重煎,则更稳妥(377 页)。

1.1.3 乌头汤证《金匮》

乌头汤,治历节不可屈伸疼痛。李可移用于寒湿脑络之头痛。现附验案,以为佐证:

脑瘤头痛 张某,女,25 岁。脑瘤术后复发,头痛如破,呕涎沫而肢厥,睛突目糊,口眼歪斜,右侧肢体失灵。辨属产后藩篱失固,贼风袭络,三阴寒凝,大气失运,浊痰死血深伏脑络。予改良乌头汤(川乌 30g,麻黄 15g,白芍 45g,黄芪 45g,黑小豆、防风各 30g,蜂蜜 150g,炙草 600 加吴茱萸 30g,生半夏 45g,川芎 30g,白芷 15g,麝香 1 分(冲),引诸药直捣病巢,一剂痛止呕罢。后予偏正头风散加守宫,炮甲、蜂房、川贝、麝香,以夏枯草 1500 克,依法熬膏合炼蜜为丸 15 克重,日服 2 次,每次 1 丸,以海藻、甘草各 30 克,煎浓汁送服,相反相成,激荡磨积,以加强软坚散结之力,服药 75 日赴京复查,病灶消失,恢复工作,现仍健在(247 页)。

按本案因术后藩篱失固，贼风袭络，三阴寒凝，大气失运，浊痰死血深伏脑络，头痛如裂而肢厥。故用乌头汤破沉寒痼冷，驱逐伏邪外透，一剂痛止呕罢。

1.1.4 偏正头风散证

李可认为，偏正头风散证，或每日定时发作，或交节病作，或经前必犯，发则头痛如破，睛胀头眩，呕吐涎沫，昏迷思睡。必是“伏邪”作祟，深伏不出，逐成痼疾（242 页）。他在民间验方“偏正头风散”基础上，调整主辅药之比例，增加了 8 味药，大大突破了原方的主治范围，通治各类头痛，如血管性、神经性、眼源性、鼻源性、外伤性（脑震药后遗症）、脑瘤之头痛，及现代一切机理不明之偏正头痛。方如下：

（红参、灵脂、制首乌、炒白蒺藜）、制川草乌、石膏、天麻、川芎、白芷、甘草各 12g，细辛、芥穗、防风、羌活、（辛夷、苍耳子、苍术）、全蝎、（蜈蚣）、僵蚕、地龙、天南星、制白附子、雄黄（另研兑入）、乳香、没药各 6g（括号内药品为李可所增）。

本方性味燥烈，偏于攻邪，故对热病及脏腑内伤所致头痛（如引火汤证头痛）则非所宜。上药共研细粉，日服 2 次，每次 3 克，饭后、睡前淡茶水调服，当日痛止，1 周痊愈。病程 10 年以上者，20 日可获根治，无一例失败，无一例复发（243 页）

1.2 骨质增生类痛

骨质增生症，是发生在骨与关节的增生性、退行性病变，如颈、胸、腰椎病，跟骨刺等；肩周炎，别名“五十肩”，亦属老年性、退行性病变，均可引起颈项、肩臂、腰脊、坐骨神经、四肢疼痛。

1.2.1 颈椎病

李可认为，颈椎病，遵仲景法，葛根汤类方专理颈项，疏通太阳经输，见效最速，主药葛根应 60 克以上；腰脊病，肾四味、骨碎补补肾督，强筋骨；胸椎病，瓜蒌薤白白酒汤合丹参饮。初治得效，以补阳还五汤大补气血，血肉有情补肾督，强筋壮骨，活血化瘀，虫类通络收功（223 页）。下面举例证之：

颈椎增生症 王某，男，51 岁。右肩凝，臂不能上抬后展，阵阵顽麻，项强痛，不能转侧月余。本院 X 见颈 2、3 椎唇形增生，肩甲骨增厚。阴雨天项、背、肩有痛、麻、抽搐感。口腔及下唇生疮，此起彼伏，经年不愈。三五日辄感冒，脉沉细涩，舌淡红。证属精血亏损，络脉失养；卫阳不固，复被风寒外袭，留而成痹。寒主收引，故见搐痛；阴虚阳浮，火不归原，故见上热。拟益气养血，滋阴和阳，逐寒通络复方：生芪 120g，葛根 90g，当归、川乌、黑小豆、二冬、巴戟肉、茯苓各 30g，熟地 90g，五味子 6g，桂枝、细辛各 15。桃仁、红花、地龙各 10g，白芍 90g，炙草 60g，防风 20g，全蝎 12 只，蜈蚣 4

条研末冲服，油桂 1.54 米丸先吞广生姜 10 片，大枣 10 枚，蜂蜜 150g，加冷水 2500 毫升，文火煮取 600 毫升，3 次分服。上药服 6 剂，诸证患除。予培元固本散 1 料善后，追访 4 年，很少感冒，体质大胜从前（219 页）。

按 患者年已五旬，气血渐衰。今肾虚精怯不能上承，故督脉空虚，络脉失养；卫阳不固，复被风寒外袭，留而成痹。故以葛根汤、乌头汤、当归四逆汤、补阳还五汤、引火汤合方，针对太阳经输不利、骨痹、精血亏损、火不归原诸证，6 剂病退。

1.2.2 足跟痛

李可认为，足跟痛之机理，因足少阴肾经经脉“入跟中”，肾虚精怯，经脉失养，加之湿盛气虚，气血失于周流，寒湿痹阻，不通则痛（222 页）。兹举其案例如下：

跟骨刺温某，女，47 岁。患双足跟痛 4 个月不愈，迈步困难，整日足不出户。经 X 片确诊为跟骨骨刺。肥胖体型，神疲、气短、畏寒，冬必冻脚。脉沉细，舌淡胖。局部皮色如常，不红不肿，有冷感。拟补阳还五汤合附桂八味、当归四逆加吴茱萸汤合方化裁，下病治上，益气温经，活血通络：生芪 120g，当归、附子各 30g，熟地 45g，油桂、川牛膝、木瓜、乳没、通草、细辛、防己、泽泻各 10g，吴茱萸(洗)、茯苓各 15g，白芍 30g，炙草 15g，化铁丸（楮实子、威灵仙）206，炮甲 6g、象牙屑 4g（研粉热酒送下），生姜 10 片，大枣 10 枚，5 剂。泡脚方：防风、苦参、红花、甘草、透骨草各 30g，水 1500 毫升，煎汁 1000 毫升，人白酒化 5 公斤，微沸，趁热搓洗，浸泡双足。上法，内外兼治，一日痛缓，二日后可走路，5 日后自觉症状消失，当年冬季亦未冻脚（222 页）。

按 骨刺为退行性病变，气血渐衰，以补阳还五汤治本；足跟痛，为肾经病变，用八味丸之 5 味药治之；冬必冻脚，为当归四逆加吴茱萸汤证；并佐以化铁丸、活络效灵丹止痛，消骨刺。李可以上方加减，治足跟痛 10 余例，均获捷效，且无复发。

1.2.3 肩周炎

李可认为，本病又名“五十肩”，属老年性、退行性病变。考肩臂乃手少阳、手阳明二经所过。肝气郁则木气克土，脾主四肢，脾气虚则痰湿内生，流于关节，故肢体为病。加之 50 岁后气血渐衰，复感风霜雨露外袭，日久遂成本病（224 页）。现附验案，以为佐证：

肩凝重症 马某，男，54 岁。因肩痛求治，右肩臂剧痛，手不能抬举、后展约年半，百治不效。境遇不顺，近年发胖。近日受凉加重，抬肩痛如撕裂，自己不能穿衣，苦不堪言，傅山先生论曰：肩臂痛，手经病，肝气郁。平肝散风，去痰通络为治，方为：当归、白芍各 90g，陈皮、柴胡各 156，羌活、秦艽、白芥子（炒研）、半夏各 9g，附子 3g。煎服法：水 6 碗，煎 3 沸，取汁 1

碗，人黄酒服之，一醉而愈。余师其意，原方加生芪 120 克益气运血，桂枝 15 克载药直达病所，止痉散（全蝎 3 克、蜈蚣 4 条）研粉冲服入络搜剔，更加桃仁、红花、地龙活血通经。患者海量，令水与黄酒各半煎之。热服取汗，以开表闭，逐寒凝，3 剂。服第一剂后得微汗，当夜安然入睡，次日顿觉大为松动，数月来开始穿衣不需人助。不料，服第二剂后，竟暴泻粘稠便 10 余次，而臂痛亦减轻十分之八九。因畏泻，剩一剂未服。隔两日又服，又腹痛作泻 5-6 次，右肩高举，后展已如常人（224 页）。

李按 考致泻之由，一是当归富含油质，大剂量难免滑肠；二是温药消溶痰湿，由大便而去。服法未遵先生法度，药量大，3 沸难以充分溶解有效成份。故改为冷水浸泡 1 小时，急火煮沸半小时，兑入黄酒，2 次热服。

1.3 风湿类痛

风湿类痛，常见于结缔组织病，如风湿性、类风湿性关节炎、急性风湿热、红斑狼疮、坐骨神经痛等。由于李氏治疗血栓闭塞性脉管炎、痛经与风湿相近，故放在一起讨论。

1.3.1 类风湿

李可之经验，以乌头汤为主，治风湿性、类风湿性关节炎、坐骨神经痛，约 2000 例以上，正虚加大剂量生芪，肾虚加肾四味，久病加虫类药，关节变形者加制马钱子粉，每次 0.15 克，渐加至 0.6-0.8 克，日服 2 次，连服 10 日，间息 5 日，用绿豆汤佐餐。多数病例 10 天痊愈，最长 1 例两个半月。合并风心病者以温氏奔豚汤治本（201 页）。下面看一则类风湿案：

类风湿性关节炎合并硬皮病 薛某，女，33 岁。患类风湿性关节炎 28 年，由产后入冷水过早引起。2 年前又合并硬皮病，百治不效，已不能起床。病历载：两手关节肿凸变形，右手不能屈伸，双下肢踝关节肿胀，足趾僵硬，迈步艰难。因相距遥远，患者恳求遥拟一方先服，待病情缓解后再面诊。师法仲景，遂仿乌头汤意拟一药酒方及外熨方。内服方：生芪 100g，川乌、附子、活络效灵丹（当归、丹参、乳没）、白芍、黑小豆、乌蛇各 30g，蜂蜜 120g，桂枝、防风、全蝎、甘草各 15g，蜈蚣 30 条，豹骨 15g。上药共捣粗末，加上白酒 3 斤人瓶浸泡 7 昼夜后，早晚各热服 1 次。从 1 酒盅起服，逐日渐加，至服后唇、舌稍感麻木为度。即以此量维持至服完。外熨方：沙苑子、川草乌、红藤、荆芥、防风、当归、鸡血藤、海桐皮、乳没、透骨草、川断、红花、细辛、花椒、伸筋草、威灵仙各 30g，乌蛇 50g，上药共捣粗末，95%酒精 600 毫升，拌匀，浸 3 日后，加陈醋 3 公斤，浸泡 7 昼夜，睡前以纱布 8 层蘸饱药液置于患处，以电熨斗熨之，干则再蘸，连续半小时。患者共服药酒 45 天，每次加至 30 毫升时，服后唇、舌麻木 40 分钟，维持服至 1 个月后，全身发热，从此脱去 30

年冬夏不离之棉袄，服完 1 料后，肿痛已减十之八九。患者前来面诊，指趾、腕踝关节肿凸处，服药酒后已恢复正常，唯天冷则痛不可忍，硬皮病亦有些微松动，但四肢皮肤犹如贴在骨上，僵硬、绷紧光亮，前额皮肤亦变硬，10 年前之满脸皱纹亦消失。由于上脸僵硬，两目不能闭合，夜间必须盖一条毛巾于面部，始能入睡。畏寒，夜尿频，腰困如折，脉弦，64 次/分。舌淡胖，边尖有瘀斑。当温养五脏，调节整体以治局部：生芪 120g，当归、熟地、川乌、附子、沙苑子、黑小豆各 30g，麻黄、桂枝、细辛、干姜各 15g，防风 30g，肾四味各 15g，红参 104 另炖），灵脂 10g，全蝎 12 只、蜈蚣 4 条（研粉冲服），炙草 60g，蜂蜜 150g，生姜 30g，大枣 10 枚，加冷水 2500 毫升，文火煮取 600 毫升，3 次分服，30 剂。药后腰困消失，四肢已不疼痛。已变硬之皮肤，明显松软，前额出现抬头纹，四肢出现皱纹，臂部已形丰满，眼睑活动灵活，可以闭合。嘱带原方 30 剂，加龟鹿二胶、胎盘粉各 10 克，趁伏天服完。药后其病基本恢复，可以操持家务（208 页）。

李按 类风关、硬皮病，现代医学认为与免疫缺陷有关。中医则认为邪之所凑，其气必虚。虽肺主皮毛，脾主四肢、肌肉，但 30 年痼疾耗伤，肾元必虚。此案经前后三诊，服药酒 3 料，汤剂 70 剂，不满 4 个月，内服附子 1945 克，川乌 2245 克，生芪 8400 克。基本方用药，谨遵仲景法度。世人目中不治之症，竟获痊愈。

1.3.2 坐骨神经痛

坐骨神经痛是臀部、髋部向下扩散到小腿外侧或足背，以患肢痛、酸、重、木为主症，严重者见坐骨神经循行部位掣痛，行走跛颠不利，为寒湿痹阻血脉。下面举例证之：

坐骨神经痛合并冠心病 王某，男，59 岁。2 年前，腰髋痛不能步，经县医院诊为坐骨神经痛，久治不愈，近 2 年退休后，环境与生活得到改善，觉体质较前些年大为好转，但病反加重，特来求治。询之，知在坑下作业 14 年，久受寒湿成痹，失治，演变为风心痛，虽盛夏亦畏寒。唯独今年发热，且四肢关节皆热肿，手腕肿不能翻，不能持箸，进食需人喂，扪之灼热，精神饮食均好，病热虽重，乃由阴转阳，由里出表之佳兆。应因势利导，予补阳还五汤重用生芪 120 克，加肾四味 120 克，益气壮腰，增强肾气，以一味芥穗深入血分，引伏邪外透。药进 3 剂，四肢关节肿甚，伏邪尽透于外。乃予乌头汤加减，温清并重，以求根治：石膏、川乌、附子、苡仁、骨碎补、黑小豆、木瓜、楮实子、川牛膝、防风各 30g，细辛、知、柏、苍术、甘草、威灵仙、麻黄、桂枝各 15g，全蝎 3g、蜈蚣 2 条（研粉冲服），蜂蜜 120g，生姜 15g，大枣 10 枚，加冷水 2500 克毫升，文火煮取 600 毫升，日分 3 次饭后服。上方加减进退，主药川乌不变，服至 9 剂时，肿痛全消，改补阳还五汤加肾四味 60 克，又服 3 剂，12 年痼疾得以痊愈（201 页）。

李按 此案之机理，颇有启迪。盖邪之所凑，其气必虚，且病与人之关系，人为本，病为标。正虚则邪从寒化；且由皮毛、肌肉，经络而深入脏腑，而不能透达于外，故久治不愈。今正气已旺，“满座皆君子，小人无存身之地”，故从热化、实化，乃予乌头汤、四妙散、桂枝芍药知母汤合方化裁，温清并重，9剂病退。

1.3.3 红斑狼疮

李可认为，一般把红斑狼疮定性为“阴虚血瘀”，李氏所治病例却属“阳虚血凝”证型。阴阳的判别，总以病人的正气强弱为转归。正气强者，受邪即病，邪正交争，从阳化热，表现为“阴虚血瘀”；正气虚者，卫外不固，无力抗争，病邪长驱直入，由表入里，深伏难出，从阴化寒，表现为“阳虚血凝”（205页）。

阳虚型红斑狼疮 赵某，女，15岁。病程3个月，今冬第1次寒潮袭来，顿觉指、趾冷痛、青紫、僵硬，四肢关节痛，不能屈伸，手足背潮红作痒，每日午前，阵阵面色酡红，鼻、颊部出现蝶形红斑，过午则渐渐隐去。经山西医大诊为系统性红斑狼疮。询知自幼体弱多病，极易感冒，每冬冻脚，嗜食生冷，口渴即饮冷水；月经月月超期，脐周绞痛，色黑多块，带多清稀，脉沉细涩，舌淡胖有齿痕。遵伤寒治厥阴脏寒之法，用当归四逆加吴茱萸汤；每日午前一陣面赤如醉，真阳有外越之险，更加附子、肉桂，直温少阴。顽症痼疾，当用重剂：当归 50g，桂枝、白芍各 45g，炙草、通草各 30g，细辛 45g，吴茱萸（洗）50g，附子 30g，油桂 10g，生姜 125g，大枣 2.5 枚。加冷水 1200 毫升，黄酒 500 毫升，文火煮取 600 毫升，日分 3 次温服，3 剂。二诊：服 1 剂，指、趾关节冷痛已愈。3 剂服完，肢端青紫亦退，唯觉活动尚不甚灵活。今日骤然降温，凌晨赴省医院检验，路途感寒、劳乏，返回时突然寒战高热如疟，体温 40.5℃，血象高，血沉 120，已用大剂量青霉素 800 万单位静滴，不能控制。大热、大渴、多汗、脉洪，舌中黄，口苦，呕逆，面部、背部红斑成片。证情突变，揣测原因有三：一则寒邪久伏，得温药之助，阴证转阳，遂见化热外透之机；二则经水适来，邪入血室，引动伏邪；三则正值冬季流感流行，兼夹瘟疫。既见发斑，为邪有外透之机，当因势利导，以拙拟贯众石膏汤，辟秽化斑解毒，以小柴胡汤加味，枢转少阳，清透厥阴血分，引领伏邪外透，日夜连服 3 剂，以阻断病势。三诊：上药连服 3 剂，热净身凉，红斑消去。化验血项正常，血沉 12。唯今日活动转多，将息失宜，双下肢出现紫癜样红斑，痒甚。以拙拟乌蛇荣皮汤加味，清解血分余毒善后（203 页）。

李按 本案先天肾气怯弱，藩篱失固，寒邪由表入里，深伏血分。日久沉寒痼冷盘踞胞宫，冲、任、带脉俱病。复暴感外寒，致血脉痹阻。遂投当归四逆加吴茱萸汤加附子、油桂，使阴证转阳，而见化热外透之机。

1.3.4 急性风湿热关节痛

李可之经验，急性风湿热关节剧烈肿痛，以苍术白虎汤（苍术 15g、苡仁 45g，黄柏 30g，豨莶草 50g，赤小豆、山药、知母、炙草各 30g，石膏 250g，赤白芍各 15g，下肢加川牛膝 300，煎汤送服偏正头风散 3 克，日 3 次，蜜水调服，10 日内可以痛止肿消（244 页）。下面举例证之：

风湿热痹 金某，女，47 岁。1 年前秋突然高热 42.1，全身肌肉筋骨剧痛。热退后双下肢僵硬肿胀青紫，痒痛不能入睡，脚肿不能穿鞋。今夏病重，停激素则高热 40.1 以上，大渴引饮，自汗心悸，六脉沉滑数实。病虽经年，幸未入营动血，按温病气分留连，予人参白虎加苍术、四妙清化之：石膏 100g，白藓皮 50g，西洋参 10g（另炖），苍术、黄柏各 15g，苡仁 45g，川牛膝、山药、双花、连翘、老鹳草、蚤休各 30g，桃仁、红花、丹皮、紫草各 15g，炮甲 6g 研粉冲服，炙草 15g，10 剂。外洗方：木鳖子（打）、白藓皮、苦参、大黄、芒硝、甘草各 30g，桑、槐、柳嫩枝各 1 握，白矾、雄黄各化入），煎汤一盆，趁热熏洗双脚，5 剂。上法内服外洗，半月后双下肢脱壳一层而愈，停用激素后亦未复发（206 页）。

按 本案即苍术白虎汤化裁，因下肢青紫，当属阴虚血瘀，故加桃仁、红花、丹皮凉血化瘀；因持续高热，热毒炽盛易犯心包，以丹皮、紫草、蚤休、银翘清热解毒护心；虫药炮甲，穿透攻破，引达病所，取效甚捷。

1.3.5 血栓闭塞性脉管炎

李可认为，血栓闭塞性脉管炎，属中医“脱疽”范围，由寒湿之邪痹阻血脉，日久趾、指坏死脱落，令人惨不忍睹。约可分为阳虚寒凝与湿热化毒二型，而瘀阻不通，又为两型所共有。故活血化瘀之法，必须贯彻始终。而气为血帅，气行则血行，不论寒热，皆以黄芪为君。气旺则可推动血行，而生芪又最擅托毒生肌，为痈疽要药，亦脱疽首选要药。其药性和平，又非破格重用难以奏效（66 页）。兹举其案例如下：

寒凝型血栓闭塞性脉管炎 高某，男，51 岁。患者素有严重冻伤，10 年前下肢冷痛，多次住院无效，后来病情恶化，确诊为脑动脉硬化、心肌下壁梗塞、双下肢血栓闭塞性脉管炎，建议高位截肢。绝望之下，求李氏诊治。诊见双下肢膝以下冰冷，足趾青紫，电击样剧痛日夜不休，左下肢麻木，脉沉细迟微，双足背动脉消失。面色苍白晦暗，畏寒神倦。证由寒邪深伏血分，痹阻血脉，已成脱疽重症及真心痛。遂拟乌头汤合当归四逆加吴茱萸汤，加虫类入络搜剔，麝香辟秽通窍，合而大辛大热，开冰解冻，益气破瘀，通络定痛之剂：生黄芪 240g，附子、当归、炙草各 60g，川乌、丹参、川牛膝、黑小豆、防风各 30g，麻黄、桂枝、细辛、赤芍、桃仁各 15g，肉桂 10g，吴茱萸开水冲洗 7 次），另用麝香 1g、炮甲 5g、水蛭 3g、全蝎虫 3g、蜈蚣两条（研粉冲服），

蜂蜜 130g，生姜 45g，大枣 10 枚，加水 2500 毫升，文火煮取 500 毫升，兑入黄酒 500 毫升，日 3 夜 1 服，4 剂。服 1 剂。当夜安睡。又连服 3 剂，诸证均退。原左足大趾内侧之溃疡亦收口愈合，心绞痛及下肢电击样剧痛亦消失。后服培元固本散半月而痊愈（65 页）。

热毒型血栓闭塞性脉管炎 高某，男，56 岁。3 年前因双下肢血栓闭塞性脉管炎而齐膝截肢。术后肆酒无度，不遵禁忌，日吸烟 3-4 盒，截肢处开始电击样剧痛，周围紫红溃烂，脓水秽臭，腐烂见骨。六脉洪数而虚，舌红少苔。近 2 个月 3 次发作心绞痛。证属湿热化毒，血瘀气弱，又兼真心痛。遂予重剂四妙勇安汤合丹参饮，清热解毒，下病上取，重用生芪益气托毒生肌，水蛭、炮甲破栓塞，化瘀通络为治：生芪 240g，双花、玄参各 90g、当归、丹参各 60g，甘草 30g，檀降香、桃仁、红花各 10g，砂仁 5g，水蛭、炮甲、醋元胡各 6g 粉吞。煎取浓汁 1500 毫升，6 次分服，日 4 夜 2 服，3 剂。服药 2 剂时，患处灼热、剧痛消失。第 4 日脓水消失，第 5 日溃烂处收口结疤，第 6 日结疤脱落，肉芽嫩红，心绞痛亦愈。原方又服 3 剂，遂愈。事隔 3 月，又托人请诊。见患处又开始脓水淋漓，周围紫黑、秽臭，剧痛夜不能寐。诊脉洪大无伦，腰困微喘，损伤肾气，生命根基动摇，百药难施，已无能为力，终至不治（66 页）。

李按 寒凝型，以当归四逆加吴茱萸汤合乌头汤，随证加减，大辛大热，开冰解冻，较果极好；热毒型，四妙勇安汤最效，加生芪则化腐生肌，效尤速。而二型所用虫类药穿透攻破之力甚强，可助活血化瘀破栓塞，为攻克本病之难关。热毒型一案复诊时，见患处周围紫黑秽臭，腰困微喘，便知其行为不检，犯房室之忌，肾气败亡，遂婉辞。余认为，一切创伤、痈疽皆当禁房事，若犯禁，轻则愈合后留有黑疤，重则肾气败亡而死，绝非危言耸听（69 页）。

1.3.6 痛经

李可之经验，痛经多从肝寒立法，用仲景当归四逆加吴茱萸汤，原方折半量（当归、桂枝、白芍、细辛各 45g，通草、炙草各 30g，吴茱萸 50g，生姜 125g，大枣 25 枚），从经前 1 日服至经净，连服 2 个月，痼疾痊愈（15、383 页）。现附验案，以为佐证：

痛经痼疾 马某，女，25 岁。室女时即患痛经，百治不效，婚后 5 年不孕。其症，经前 3 日，少腹开始坠胀绞痛，日甚一日，辗转床第，冷汗淋漓，肢厥如冰，头痛而呕涎沫，如害一场大病，至第 4 日经行始减。经量少，色黑多块。面色乌暗，眼圈、山根、环唇色黑。诊脉沉紧搏指，舌左边尖布满瘀斑。拟当归四逆加吴茱萸汤合少腹逐瘀汤合方化裁，开冰解凝，逐瘀通经：当归 45g，炙草、赤芍各 30g，肉桂、细辛、吴茱萸各 15g，通草、川芎、没药、炮姜各 10g，桃仁 20g，红花、土元、炒小茴各 10g，失笑散 20g(包)，柴胡 15g，丹参 30g，炮甲 6g(研粉热黄酒冲服)，生姜 10 片，大枣 12 枚。上药，即经前 3 日连服 6 剂，连服 2 个月。二诊：药后，当月月经畅行，下黑块屑甚多，痛减其半。次

月经前痛，经临胀痛轻微，已能耐受。刻诊，面部红润光泽，山根、环唇之黑色均退净。脉中取和缓，舌上瘀斑少有淡痕。原方桃仁减为 10 克，加肾四味 120 克，每月经见连服 3-5 剂，经净停药，连服 2 个月。病痊愈，次年怀孕（114 页）。李按 凡瘀积重者，为面色暗黑，眼有黑圈，环口一圈紫暗。本案属寒凝胞宫，寒主收引，不通则痛。且病程 10 年，久治不愈，深入血络，已成痼疾。故以当归四逆加吴茱萸汤合少腹逐瘀汤化裁。

1.4 脏腑痛

笔者从脏腑系统列举诸痛数端，因篇幅所限，只列方药，医案从略：

1.4.1 胆道蛔虫腹绞痛 乌梅丸化裁：乌梅 30g，黄连、川椒各 10g，细辛 15g，蜂蜜 120g，芒硝 15g（分冲），姜汁 30 毫升（139、141 页）。

1.4.2 心绞痛 参灵麝香散：红参、灵脂各 10g，麝香 0.3(178 页)。

1.4.3 胃溃疡疼痛 三畏汤：红参、灵脂、公丁香、郁金、肉桂各 10g，赤石脂 30g(17g)。

1.4.4 肺经右肋痛 瓜蒌薤白半夏汤合丹参饮化裁：瓜蒌 30g，薤白 15g，生半夏 30g，丹参 30g，檀香 10g，砂仁 5g，枳壳、白芥子（炒研）、桃杏仁、炮甲、炙草各 10g（226 页）。

1.4.5 肾盂肾炎腹绞痛 癥闭散：大黄 15g，海金沙、泽泻、琥珀各 10g，全蝎 12 只，蜈蚣 6 条（156、160 页）。

2 痛证方药

2.1 头痛方药

李可将头痛分为寒热二型，引火汤证偏于热化，而吴茱萸汤证、乌头汤证、偏正头风散证，均偏于寒化。关于伏邪用药，引火汤证佐以蝎蜈搜剔，细辛透伏寒（240 页）；吴茱萸汤证，亦用虫类入络透邪（43 页）；乌头汤证，更加守宫、炮甲、蜂房、麝香穿透攻破（247 页）；偏正头风散证，融透邪药之大成，对风、寒、湿、痰、火、瘀多种伏邪，皆有透发之效（243 页）。

2.2 骨增生症方药

骨增生症部位用药：颈椎病以葛根汤类方专理颈颈；腰椎病以肾四味、骨碎补强补督；胸椎病以瓜蒌薤白白酒汤合丹参饮涤痰通阳；四肢病以四君子汤加黄芪健脾利湿；足跟刺以八味丸加黄芪温肾利湿。骨增生症止痛方：止痉散、活络效灵丹、乌头汤。骨增生症通治方：葛根汤合补阳还五汤、止痉散。关于伏邪用

药，颈椎病以葛根透颈之邪（333 页），足跟刺以细辛透少阴之邪（222 页），肩凝症以羌活透手经之邪（224 页），诸症更以蝎蜈、炮甲、地龙搜剔伏匿之邪。

2.3 风湿方药

李可将风湿分为寒热二型，寒湿以乌头汤合当归四逆汤类方通治，如类风湿、坐骨神经痛、红斑狼疮、寒凝型血栓闭塞性脉管炎诸案；湿热以四妙散合白虎汤、四妙勇安汤论治，如风湿热痹、热毒型血栓闭塞性管脉案。风湿止痛方：止痉散、活络效灵丹、乌头汤。关于伏邪用药：类风湿、坐骨神经痛、脉管炎、痛经，均以细辛透寒邪；风湿热关节痛，以豨莶草透热邪；红斑狼疮，以黑芥穗透血分伏邪；诸症更以蝎蜈、炮甲、水蛭、麝香搜剔伏匿之邪。

2.4 脏腑方药

脏腑诸病，由于病因病机各异，不易找出通治方。但从伏邪用药来看，可以看出共性，如胆道蛔虫症用细辛，心绞痛用麝香，胃溃疡用灵脂（属于虫类药），右肋痛用炮甲，淋痛用蝎蜈，均属透邪药。

3 痛证自制方

李可之痛证自制方共 9 首，其中 2 首已命名，如偏正头风散、苍术白虎汤。为了便于记忆及推广，笔者将其它方冠以名称，现归纳如下：

3.1 头痛

寒热二型：

① 偏正头风散：红参、灵脂、制首乌、炒白蒺藜、制川草乌、石膏、天麻、川芎、白芷、甘草各 12g，细辛、芥穗、防风、羌活（辛夷、苍耳子、苍术）全蝎、（蜈蚣）、僵蚕、地龙、天南星、制白附子、雄黄、乳香、没药各 6g(243 页)；

② 引火芍药甘草汤：熟地 90g，盐巴戟天、天麦冬各 30g，茯苓 15g，五味子 6g，白芍 100g，炙草 30g(238、242 页)。

3.2 颈椎病

葛根双五止痉汤：由葛根汤合补阳还五汤、肾五味（肾四味加骨碎补）、止痉散组成，简称葛根双五止痉汤：生芪 120g，葛根 60-90g，桂枝 15-30g，白芍 30-90g，炙草 15-60g，当归 30g，川芎、桃仁、红花、地龙各 10g，肾五味各 30g，全蝎 12 只、蜈蚣 4 条研粉冲（218 页）。

3.3 急性风湿热

苍术白虎汤：苍术 15g，苡仁 45g，黄柏 30g，豨莶草 50g，赤小豆、山药、知母、炙草各 30g，石膏 250g，赤白芍各 45g，下肢加川牛膝 30g，煎汤送服偏正头风散或以全蝎 12 只、蜈蚣 4 条代之），日 3 次（244 页）。

3.4 类风湿性关节炎

下列诸方，虽以类风关命名，亦通治风寒湿痹、坐骨神经痛、腰间盘突出症：

① 乌头当四豨鹤汤：由乌头汤合当归四逆汤加豨莶草、老鹤草组成：生芪 120g，当归、川乌、附子、防风、黑小豆、老鹤草、豨莶草各 30g，麻黄 15g，细辛 20g，桂枝、白芍各 15g，炙草 60g，蜂蜜 150g，生姜 45g，大枣 20 枚，煎汤送服偏正头风散 3g（或以全蝎 12 只、蜈蚣 4 条代之），日 3 次（245 页）。

② 类风关培元固本散：胎盘 1 具，三七、血竭、炮甲、琥珀、鹿茸各 30g，合等量偏正头风散，加九制豨莶草 500g，变散为丸，日服 3 次（245 页）。

③ 类关乌头酒：由乌头汤合桂枝汤、活络效灵丹、止痉散组成：生芪 100g，川乌、附子、当归、丹参、乳没、白芍、黑小豆、乌蛇各 30g，蜂蜜 120g，桂枝、防风、全蝎、甘草各 15g，蜈蚣 30 条，豹骨 15g。上药共捣粗末，加上白酒 3 斤浸泡 7 昼夜，早晚各服 1 次。从 1 酒盅起服，逐日加至以口麻为度，即以此量维持到服完（208 页）。

④ 类关乌头外熨方：沙苑子、川草乌、红藤、荆芥、防风、当归、鸡血藤、海桐皮、乳没、透骨草、川断、红花、细辛、花椒、伸筋草、威灵仙各 30g，乌蛇 50g，上药共捣粗末，95 酒精 600 毫升，浸 3 日后，加陈醋 3 公斤，浸泡 4 昼夜，睡前以纱布 8 层蘸饱药液置于患处，以电熨斗熨之（209 页）。

3.5 血栓闭塞性脉管炎

寒热二型：

① 脱疽乌头汤：生芪 240g，附子、当归、炙草各 60g，川乌、丹参、黑小豆、川牛膝、防风各 30g，麻黄、桂枝、细辛、赤芍、桃仁各 15g，油桂 10g，吴茱萸洗），蜂蜜 150g，生姜 40g，大枣 20 枚，另用麝香 1g、炮甲 5g、生水蛭 3g、全蝎 3g、蜈蚣 2 条研粉分冲。

② 黄芪四妙勇安汤：生芪 240g，双花、元参各 90g，当归、丹参各 60g，甘草 30g，檀降香、桃仁、红花各 10g，砂仁 5g，另用生水蛭、炮甲、醋元胡各 6g 研粉分冲（66 页）。

4 李可治痛证思路

4.1 寒热分型

李可一向反对繁杂的辨证分型，着意探求删繁就简的证治规律。他把痛证分为寒热两个基本型，如引火汤证偏于热化，偏正头风散证偏于寒化；颈椎病 1 案偏于寒化，颈椎病 5 案偏于热化；急性风湿热偏于热化，类风湿偏于寒化。它们又可以互相转化，如坐骨神经痛、红斑狼疮案（201、203 页）。

4.2 开表不止

笔者在《论伏邪》一文中指出，李可之伏邪治法由扶正、开表、透邪 3 法组成。其中开表法用于轻症伏邪，只用一两次，表闭开，营卫通即弃之，透邪药可继用，详见肺间质纤维化案（2g 页）。治痛证则不然，疼痛不除，开表不止，如颈椎病案之葛根用至 30 剂，类风湿案之麻黄用至 60 剂，便是明证（218、210 页）。其开表不止之机理何在？李可认为，免疫系统疾病正气充足时，临床定有祛邪反应，譬如出现皮疹、关节肿、关节痛等，即正气足时有类表证的祛邪表现；而正气虚不能一鼓作气而驱邪外出时，正气消耗后，偃旗息鼓，伏邪继续隐匿。此病在春季加重，恰是人体借天地生发之大势，驱邪外散的表现。春曰发陈，亦发陈病也。正邪之间的拉锯战因正始终不能完全战胜邪而形成，导致了反复发作缠绵不愈的临床表现。

笔者理解，轻症伏邪之表证，如肩背沉困，或每进食胸背无汗等，往往一汗而解，详见结核性心包炎、心包积液案（49 页）；而痛证是重症状邪，与痰湿瘀血胶结在一起，正邪交争呈“拉锯战”之势，伏邪(痰湿)不外透，表证则不解。故反复开表，痛症才有望彻底治愈。

4.3 透邪汇粹

痛证之透邪药，寒邪用细辛，热邪用豨莶草，血分用黑芥穗，入络用虫类，更加川草乌、荆防、羌活、辛夷、白芷等融透邪药之大成，对风、寒、湿、痰、火、瘀多种伏邪，皆有透发之效，详见偏正头风散（243 页）。

4.4 霹雳手段

对于疼痛痼疾，李可常用霹雳手段，直捣病巢：

① 针刺放血：如食道癌之胸背痛，每日午时以梅花针叩刺患处，出血后，以走马罐拔吸瘀血，减轻病灶之瘀血、水肿，迅速缓解疼痛（348 页）；心绞痛，重刺素髻、左中冲，于左内关提插转捻 5 分钟则痛止（12 页）；胆绞痛，予阳陵泉透阴陵泉，行泻法，10 分钟剧痛缓解（037 页）。从中可以看出，针刺与放血，在止痛方面能起到顿杀病势的效果。

② 丸散急救：各类头痛，予偏正头风散当日痛止（244 页）；急性心梗，先冲服麝香 0.5 克，冰片 0.03 克，含化速效救心丸 5 粒，苏合香丸 1 粒，为抢救赢得了时间（口页）。

③ 大剂频投：李可认为，用经方治大症，要大剂频投，日夜连服，方能阻断病势，解救危亡（141 页）。据李氏考证，川乌 1 枚，大小平均 5 克。而乌头汤原方川乌 5 枚（25 克许），生芪 45g。他治痛证乌头汤之川乌 30g，生芪 240g，且加附子 30-60g，均属于破格重用，故有一剂知、二剂已之功效（65、210、219 页）。

浊阴不升高、心病

——李可学术思想探讨之十五

摘要 针对高血压、冠心病疑难症，进一步探讨了李可的学术思想。李可论高血压、冠心病的病机：先天阳，清阳不升，浊阴不降，痰湿瘀浊窃踞头部、胸中阳位。高血压分型论治：藏阳，四逆汤；镇冲，温氏奔豚汤；透邪，麻附辛汤；引导，引火汤。冠心病分型论治：浊阴瘀阻胸膈，夏星破格救心汤；浊阴厥气上逆，温氏奔豚汤。

在中医里是没有高血压这个概念的，那么治疗高血压应从何处入手呢？自清末、民国初以来，特别是 1840 年以后，西方医学进入中国，当时对中医的冲击非常厉害。如果你不懂现代医学的东西，那你这个中医就不能立足，就不能生存，使得一部分中医就考虑一些应对的方法，这就是最早的那个“中西汇通派”。他们大讲“肝阳上亢”理论，将平肝潜阳、镇肝息风广泛应用于高血压，已经成为当今中医临床思维定势。李可对后世高血压理论提出质疑，并进行严肃批判。先根据其数则医案，整理出气治疗高血压、冠心病的经验如下：

1 高血压

1.1 从麻黄汤治高血压谈起

高血压合并脑出血 一农夫，37 岁。患原发性高血压 18 年，由于保姆引发网膜下腔出血，昏迷 48 小时，醒后暴盲。诊见寒战、咳逆无汗，查颅内血肿、水肿，双眼底出血、水肿。眼科名家陈达夫云：凡目疾，无外症而暴盲，为寒邪直中少阴，玄府（毛孔）闭塞所致，当用麻黄细辛汤温肾散寒。今寒战无汗，禀赋素壮，纯属表实，与少阴无涉，遂径与麻黄汤一剂令服。次日诊之，夜得畅汗，小便特多，8 小时约达 3000 毫升，头胀痛得罢，目珠胀痛亦止，目赤亦退，血压竟然复常，已可看到模糊人影。又以通窍活血汤冲服水蛭末 12 克，调理一段，终于复明，左、右眼视力分别为 1.2 、0.8（286 页）。

李按 从本案的病机来看，由于寒袭太阳之表，玄府闭塞，寒邪郁勃于内，气机逆乱上冲。邪无出路，遂致攻脑、攻目，表闭一开，邪从外散，肺气得宣，水道得通，小便得利，郁结于大脑及眼底瘀血、水肿亦随之而去，脑压迅速复常。麻桂升压，现代药理已成定论，近百年来已经列为脑血管病禁区，而麻黄汤竟然治愈不可逆转的高血压，岂非千古奇谈！人本一体，表里同气，表气闭塞则里气逆乱，表气通则里气和。中医药有双向调节效能，是通过调节整体气机而治疗局部疾病。汗法之奥妙，并不单在一个“汗”字，麻黄可通利九窍、宣通脏腑之气。我用麻黄注意两点：一是凡用麻黄必加两倍之蝉衣、等量之地龙，以防止麻黄令人昏眩、心悸、面赤之瞑眩效应。二是另煎分次兑服，斟酌进退，得汗为度，中病则止，不可过剂。以免多汗伤阴，大汗亡阳。玄府闭塞重者，一次难以透彻，故可隔三、二日再服再汗。每汗一次，小便通利，脑水肿必减轻一些，脑血肿必消散、吸收一些。得汗之后，麻黄减为 5g，让他发挥通气的作用，直至痊愈。这是活血化瘀法望尘莫及的。麻黄的妙用，重在通利九窍，宣通脏腑之气，象阳和汤只用麻黄，便是此意。麻黄的利与弊和现代医学的臆测截然两样，汗法使气机升降复常，可以根治高血压，这又使现代人瞠目结舌。但中医心知肚明，我们驾驭中药，凭的是气急升降与药物的四气五味、升降沉浮，这现代药理的化学成分好不相干（286 页??????）。

1.2 高血压病机——痰湿瘀浊窃据头阳位

李可认为，高血压（水、电解质代谢异常）很复杂，因为它不是单纯的哪一部分的病，而是整体失调。而代谢病的危害出本病直接给患者带来的痛苦之外，更重要的是它又是心脑血管疾病的潜在病因。所以中医治疗高血压一般不会单纯地从某个方面入手，因为高血压这个概念在中医里是没有的。这种病一般来说都是先天阳虚，包括遗传因素，然后再加上后天失调。人的头部是阳气汇聚的地方，所以《内经》讲：头为诸阳之会。阳气就汇合在这个地方。而高血压为什么长时间不好呢？就是因为浊阴窃据了这个阳气的位置，清阳不升，浊阴不降，和过去讲的“肝阳上亢”不是一回事。我认为一般来讲属于三阴病，肝脾肾三经的阳气过于亏虚了。它应该占的这个位置被浊阴占据了，你把它给疏散了、扫除了就行了。现在有这样一个误区，麻桂主升散，血压高、脸红好像亦是升散，正因为有这样的关系，治血压高就只懂得平肝潜阳、镇肝息风！不知道辛温之品可以起效，麻桂还有这么好的效果。血压为什么升高？实际就是机体有阻滞。机体是非常奥妙的，因为有阻滞，需要高的压力，才能供养末端，这是个物理的道理。一般的药到不了末端。如果用西医的方法要终生服药，末端呢，又不断向机体发放指令：我这里不够吃了，赶快给我送吃的。这个指令始终存在，所以药不停的用，你高一点我就给你压下来，使机体末端始终处于缺血的状态。用了麻桂以后，出了一身的汗。给了它助力，使血液冲在末端，压力自然就不存在了。扶阳是解决它的

缺血，即气不足的问题，这包括两方面的内容：宣通和温补。用麻桂就是宣通，用姜附就是温补，把阻滞拿掉，不需要那么高的压力就可以灌溉了，这个病也就好了。总之，高血压最根本点就是浊阴窃踞阳位，头为诸阳之会，这一阳气充盈之处，何以被浊阴所踞？正是先天阳虚，阳不主政，循此思路大体无误。以往中医界之误，误就误在“肝阳上亢”，实际是“阳火不藏”出现的一种假象。王冰论雷龙雷之火的那一段话（病之大甚者，犹火也，得湿而焰，遇水而燔。不知其性，以水折之，适足以光焰眇天，物穷方止矣。识其性者，反常其理，以火逐之，则燔自消，焰光扑灭），最贴切不过，这是西化的头脑不可思议的（41-44 页）。

1.3 高血压的分型论治

李可认为，治高血压的根本大法有四，一曰**藏阳**：四逆汤或潜阳丹，于子午二时冷服，令浮阳归宅；二曰**镇冲**（脉不安于下）：温氏奔豚汤加三石（龙牡、磁石）、煅紫石英；三曰**透邪**：选麻附辛、大小续命汤，开玄府之闭，使寒浊之邪托透于外，阴邪一退，自是一派红日当空，阴霾自消；四曰**引导**：凡面赤如醉，头痛如劈，目赤耳鸣，轰轰发热，脉大而虚，直接用引火汤自解。万万不可镇肝息风，苦寒攻伐。犯王冰之戒，则焚墙倒屋，物穷方止，不死不休。（44 页）

藏阳法——高血压合并冠心病

黄某，男，54 岁，香港人。初诊时间：2007 年 5 月 9 日。主述：高血压病史 3 年，自觉胸闷痛反复发作 1 年，加重 1 周。初诊症见：自诉一年来胸部闷痛，部位在胸骨中段及心前区，反复发作，每次发作时间约 1-2 分钟，呈紧闷感，休息片刻后可自行缓解，上二楼及行走较快时胸闷痛加甚，伴心悸气促，唇色暗紫、面色潮红，畏寒，无发热、头晕、头痛等症，大小便可，舌质暗淡，边有齿印，苔白，脉沉细。查体：P 70 次/分，BP155/110mmHg，心率 70 次/分，律齐，心音有力，心脏各瓣听诊区未闻及病理性杂音。心电图示：心肌缺血。轴检：患者就诊前曾于香港某院经冠脉造影等诊断为冠心病，提供的临床资料表示：多个冠脉危险因素，treadmill 测试显示劳累心绞痛。结果：①总钙量达 691 分，此显示重度动脉粥样硬化斑沉积。②经心血管造影，左边及右边的冠状动脉清楚可见。左边主要冠状动脉正常。③左前降支动脉血管口径变小且有严重病灶偏及整条动脉。近端差不多可能全部阻塞。④近端的左回旋支有钙化板块，造成官腔明显变窄（80%）。在钝状边缘支后的左回旋支中段已全部阻塞。另外，在钝状边缘支的远端也发现重度至严重（60%）的狭窄。⑤右冠状动脉也扩散着多个钙化斑块。近端的右冠状动脉缩窄至 50%，然而，右冠状动脉中段有较大程度（达 95%）的缩窄。评估：高钙表示高度动脉粥样硬化斑块沉积；供血及心脏的三条主要冠脉有严重疾病。诊断：中医：胸痹（阳虚瘀阻）；西医：冠心病（三支血管病变）。

病机：大虚大实，少阴元阳不能覆布，以至痰湿瘀浊阻滞胸阳，脉络痹阻所致。治则：潜元阳，助少阴，运太阴，破瘀浊。方药：熟附子 120g（先煎 2 小时），干姜 90g，炙甘草 90g，桂枝 45g，赤芍 45g，丹参 60g，檀香 60g（后下），红参 30g（研粉冲服），生龙骨、生牡蛎、活磁石各 30g（先煎），细辛 30g（后五分钟）下，麻黄 5g，茯苓 30g，生半夏 30g。10 剂，用水 3000ml，煎取 400ml，兑红参粉，分两次温服。二诊：2007 年 5 月 19 日，患者服药后，无不适反应，胸闷痛次数发作减少，舌暗淡，苔白，边有齿印，脉细。血压：120/80mmHg（未服用降压药），药证相应，脉沉起，拟加强化痰开窍力量，守方加熟附子至 150g，九节菖蒲 30g，白术 30g。10 剂，煎法如上。三诊：2007 年 5 月 31 日，服上药后，动则喘，胸闷呈阵发性，约 1-2 分钟后缓解，舌脉如前，正邪相争，险象迭出，助阳破阴为急。方药：熟附子 260g，干姜 120g，高丽参 15g（研粉冲服），五灵脂 30g，丹参 120g，檀香、降香 10g，进口沉香 1g（冲服），砂仁 30g（姜汁炒），三石（龙牡、活磁石）各 30g，九节菖蒲 45g，杜仲 30g，炙甘草 120g，桂枝 45g，麝香 0.3g。7 剂，嘱附子逐日（10g/天）加量至出现“瞑眩”反应。四诊：2007 年 6 月 18 日，服完上药后，无胸闷胸痛，无心悸气促，舌暗淡，苔白，脉细。五诊：2007 年 6 月 27 日，当熟附子加到 370g 时出现“瞑眩”反应：头晕、全身麻痹、恶心、呕吐 2 次，腹泻 4 次，为水样便，晕倒于卫生间 2-3 分钟。但翌日起床后精神颇佳，反应消失。嘱将 5 月 31 日方中附子改为 250g，取 10 剂。六诊：自 2007 年 7 月 5 日至 2007 年 12 月 5 日，患者共服用以上方为基础的中药计 140 剂。诸症消失，BP135/80mmHg，在香港行心脏造影检查示：心脏功能完全正常，查起舌淡，苔白，脉沉（三部分诊左寸弦细、关弦，尺沉；右寸细，关弱，尺沉）。为巩固疗效，处方如下，服用 30 剂：熟附子 60g，干姜 60g，炙甘草 120g，高丽参 15g（研粉冲服），白术 30g，茯苓 30g，五灵脂 30g，丹参 60g，檀香、降香各 10g，进口沉香 1g（冲服），砂仁 30g（姜汁炒），山萸肉 30g，三石（龙牡、磁石）个 30g，熟地 60g，九节菖蒲 15g，桃仁 30g，桂枝 30g，菟丝子 30g，补骨脂 30g（80 页）。

按 本案为高血压合并心绞痛，属中医真心痛，因病势凶险，危在顷刻，当分秒必争，故用大剂破格救心汤，属四逆汤类方。症见血压 155/110mmHg，面色潮红，心悸气促，胸痛，畏寒，唇色暗紫，舌质淡暗苔白，脉沉细。此为少阴元阳不藏，痰湿瘀浊窃踞头部、胸中阳位。治以藏元阳，破瘀痰。附子逐日叠加至 370g 时出现“眩暝”反应（药后出现头晕、呕吐、头面四肢麻木，伴见腹痛、便泄、畅汗等），真阳回生，阴邪并去，血压亦复常。

镇冲法——高血压兼肥胖病

胡某，女，46 岁，1979 年 10 月 31 日，突然昏厥邀诊，至则已醒。询之，

患肾性高血压已 5 年。低压常在 110-120 毫米汞柱之间，曾服镇肝熄风汤、羚羊钩藤汤近百剂，不仅无效，反增食少便溏。近 3 年异常发胖，头晕畏寒，呕逆腹胀，足膝冰冷。近 1 月服羚羊粉后，常觉有一股冷气从脐下上冲，冲至咽喉部，人即昏厥。约三五日发作一次。其眩晕如腾云驾雾，足下如踏棉絮，越胖越觉无力。腰困如折，小便余沥，咳则遗尿，时时有咸味之痰涎上雍。常起口疮，头面又觉轰轰发热，每日中午面赤如醉。舌淡胖，苔白腻，脉洪不任按，久按反觉微细如丝。脉证合参，乃清阳不升，浊阴不降。下寒是真，上热是假。复加误用寒剂，更损元阳，阴盛于下，逼浮阳上越，故见上热假象。予温氏奔豚汤，其附子 30g，加吴茱萸 15g，肾四味 60g，生龙骨、生牡蛎、活磁石、紫石英（煅）、山萸肉各 30g。益火之原，以消阴翳。上药加冷水 1500ml，文火煮取 600ml，日 3 服，3 剂。11 月 3 日二诊：患者在无人陪侍下坐班车来门诊。主诉：服药 3 剂，每天小便很多，全身舒适，头不晕，脚底再不漂浮欲倒，腹中觉暖，再无冷气上攻，心中也不觉怕了。每天服药后，腹中阵阵响动，矢气极多，惹得孩子们哄堂大笑，几年腹胀，一下子松宽许多。药已中病，嘱守方再服 10 剂。11 月 25 日，其夫特来门诊告知，诸症均愈。血压保持在 80-90 毫米汞柱，已正常上班。最奇的是服药后尿特别多，10 多天功夫，把一身膘都尿掉了，腰围瘦了 1 寸多。据多数病人反映，服本方后，随着尿量增加，各主要症状逐步消失（383 页）。

李按 本案低压常在 110-120mmHg 之间，证属命火衰微，不主温煦，故怯寒怕冷；火不生土，中阳不运，故见食少便溏。诸阴失阳之统摄，故上则饮逆头眩，挟冲气上冲，下则尿多不禁。异常肥胖亦属阴盛阳衰，与寒湿停聚同理。复加误用寒剂，更损元阳，阴盛于下逼浮阳上越，故见上热假象。予温氏奔豚汤加味，因呕吐加吴茱萸，腰困如折，小便余沥，加肾四味，时发晕厥，加山萸肉固脱，服药近半月，诸症均愈，低压亦维持在 80-90mmHg。

透邪法——高血压合并蛛网膜下腔出血

2000 年秋天，我的一个年轻弟子，中医根底不深，学眼科的。他治了一个患高血压 20 多年的农村妇女，他的丈夫是煤矿老板，有钱了在外边胡作非为，该女因生气，突然蛛网膜下腔大量出血，出血后不久，双眼什么也看不到了。这种暴盲，按照六经辨证，属于寒邪直中少阴。当时用麻黄细辛附子汤，出了大汗，血压就好了，第二天人就醒过来了，眼睛可以看到人影，脑水肿减轻，小便也多了。之后近 10 年的时间，一直血压稳定，一劳永逸（42 页）。

按 人本一体，太阳与少阴表里同气。平日肾阳不足之人，发病即由表入里，则成此病。尊眼科名家陈达夫目疾六经辨证大法：凡目疾，无外证而暴盲，为寒邪直中少阴，玄府（毛孔）闭塞所致，当用麻黄附辛汤温肾散寒。附子温少阴之

里，麻黄开太阳之表，即是玄府之闭，细辛直入少阴，托邪外透。

引导法——高血压兼鼻衄

张某，男，55岁，坛镇农民。1983年12月23日，因鼻大出血急诊入院，五官科邀余会诊：患者有多次大出血史。37岁时，因与人吵架，当晚9时鼻出血如喷射状，急诊入我院无法控制，急转太谷，从灵石医院坐平车去车站，一路血动车上流淌，如杀猪状。上车即休克，到晋中二院后，送至太平间3小时，经电烙止血而愈。41岁时，又因夫妻争吵，再次大出血，迳去太谷电烙止血。48岁时又因儿媳分居，一时气上，突然大量出血。经我院五官科鼻腔骨膜下蒸馏水注入而止血。此次又因事不遂心，郁怒不快，突然出血一痰盂。急诊入院后诊为“高血压引起右鼻腔动脉破裂出血”。继用前法止血。大衄渐止，淋漓不断又10日，迄未控制。刻诊：患者肥胖体型，一生从事炊事员工作，面赤如醉，目赤气粗，血压150/100mmHg，脚下如踏棉絮，腰困痛如欲断裂，夜不能寐，全身常觉轰轰冒火。但凡动气，心中立即发热如焚。待热气上攻入脑，鼻出血便如水枪喷射，堵鼻则从口出，闭口则从鼻出。凡见面赤如醉，便是出血先兆。右脉弦大无伦，寸部特大，直上鱼际，左三部沉细，尺部部静。扪其双膝，独冷如冰，舌干红无苔。拟壮水之主，以制阳光，潜镇气浮，引火归元。以引火汤合黄连阿胶鸡子黄加赭石、怀牛膝、生龙牡，佐小量油桂、童便送下，引入至阴之处。熟地90g，盐巴戟肉、二冬各30g，茯苓15g，五味子6g，黄连10g，阿胶30g（化入），赭石细末、怀牛膝、生龙牡粉各30g，油桂1.5g（冲），蛋黄1枚（冲），童便1杯对入，3剂。12月26日二诊：药进3剂，鼻衄全止，血压复常。右脉已敛，左脉略起。舌质仍红。予原方3剂，痊愈出院。1984年2月26日，患者来五官科复查，血压正常，腰困大减。全身轰热十余年，自服中药后，今年基本不热，眠食俱佳，脚跟已稳，头重脚轻之势改观。六脉弦大博指之象，转为和缓从容，舌淡红有薄白苔。嘱1983年再进30剂，以使阴平阳秘，怡悦情怀，善自调摄。之后，凡坛镇有人来求医，必捎口信，多年不辍，一直健康平顺（279页）。

按 患者一生从事炊事工作，经年累月热气熏蒸。且肝火偏亢，极易动怒，五志过极化火，迫血妄行，便是屡屡出血之由。刻下年过五旬，肾阴已亏于下，水浅则龙雷之火不安宅窟，时时上奔冲激。予引火汤滋阴敛阳，引火归元，3剂后鼻衄全止，血压复常。

现在高血压很普遍，因此有记者采访李可，咨询是否有简单易行的方法。李可建议：对于阳虚引起的高血压，都可以吃金匱肾气丸，经过一段时间就可以纠正过来。具体方法是把金匱肾气丸每次5丸（每蜜丸9克），把它煮成糊状喝下去，早晚各一次，有10天半月就可以把好些属于肾虚的症候都扭转过来。即使

高血压暂时升高也不要紧，要继续吃。此系邪正交争，你不要老查血压，要问他有什么感觉。只要阳盛阴退，血压自会安宁，勿虑（43 页）。笔者理解，用金匮肾气丸治高血压属于引火归元法，与引火汤同理。

2 冠心病

2.1 从乌头汤治心肌梗死谈起

心肌梗死兼血栓闭塞性脉管炎

高某，男，51 岁。患者素有严重冻伤，10 年前下肢冷痛，多次住院无效，后来病情恶化，确诊为脑动脉硬化、心肌下壁梗塞、双下肢血栓闭塞性脉管炎，建议高位截肢。绝望之余，求余诊治。诊见双下肢膝一下冰冷，足趾青紫，点击样剧痛日夜不休，左下肢麻木，点击样剧痛日夜不休，左下肢麻木，脉细沉迟微，双足背动脉消失。面色苍白晦暗，畏寒神倦。证有寒邪深伏血分，痹阻血脉，已成脱疽重症及真心痛。遂拟乌头汤合当归四逆汤加吴茱萸汤，加虫类入络搜剔，麝香避秽通窍，合而大辛大热，开冰解冻，益气破瘀，通络定痛之剂。药用：生黄芪 240g，附子、当归、炙甘草各 60g，川乌、丹参、川牛膝、黑小豆、防风各 30g，麻黄、桂枝、细辛、赤芍、桃仁各 15g，肉桂 10g，吴茱萸 20g（开水冲洗 7 次），另用麝香 1g、炮甲 5g、水蛭 3g、全蝎 3g、蜈蚣两条（研粉冲服），蜂蜜 150g，生姜 45g，大枣 10 枚，加水 2500 毫升，文火煮取 500 毫升，对入黄酒 500 毫升，日 3 夜 1 服，4 剂。服 1 剂，当夜安睡。又连服 3 剂，诸证均退，心绞痛及下肢电击样剧痛亦消失，左足大趾内侧溃疡亦收口愈合。后服培元固本散半月而痊愈（65 页）。

李按 寒湿之邪伏匿三阴之最重者，非附子、川乌同用，不能破冰解凝。本案急性心梗兼脱疽重症，病程过久，则非但血虚而瘀，其寒凝之程度，犹如冰结，故以乌头汤大辛大热，通行十二经表里内外，开冰解冻，加当归四逆吴茱萸汤治内有久寒，深入血分，解痉止痛；更加虫类化瘀破吓之力，则如阳光一照，冰雪消融，栓塞一通，病即向愈。

2.2 冠心病病机——痰湿瘀浊窃踞胸中阳位

李可认为，**冠心病的病机，和高血压的道理一样，痰湿瘀浊窃踞胸中之阳位。**胸为心主之宫，是人体阳气最为旺盛之处。为什么会被阴邪窃踞和包围？就四个字“阳气不到”。阳气一虚，清阳不升，阴浊不降（7、129 页）。

2.3 冠心病分型论治

2.3.1 浊阴瘀阻胸膈，夏星破格救心汤

基础方：破格救心汤中剂加生半夏 45 克、生南星 30 克。组成：炙甘草 90g，干姜 90g，制附片 100g，高丽参（粉冲）15g，五灵脂 30g，山萸肉 60g，三石（龙牡、磁石）各 30 克，生半夏 45g，生南星 30g，丹参 120g，檀、降、沉香各 10g，桂枝 45g，桃仁 30g，麝香 0.5g（冲），苏合香丸 2 丸。加减：痰阻胸憋甚者，合瓜蒌 白白酒汤；邪实成积者，甘遂半夏汤破之。剧烈心绞痛，改用生附子 45g，生川乌 30g，麝香 1g（冲服），苏合香丸 3 丸，缓解后回到原方（129 页）。

冠心病心绞痛 查某，60 岁，1982 年正月初六急诊，经县医院心电图确诊为冠心病月余。14 时心绞痛发作，含化硝酸甘油片，可缓解半小时，不以为意。18 时许，心绞痛再发，含剂及亚硝酸异戊酯吸入无效。内科会诊拟诊急性心梗，建议急送省级医院抢救。因时间紧迫，寻车不易，乃邀余诊视。见患者面青惨，唇、甲青紫，大汗而喘，肢冷，神情恐怖，脉大无伦 120 次/分，舌边尖瘀斑成条成片，舌苔灰腻厚。病势凶险，危在顷刻，当分秒必争，针药并施。先冲服净麝香 0.5g，冰片 0.05g，含化速效救心丸 5 粒，苏合香丸 1 丸。毫针重刺素髻、左中冲，于左内关行提插捻转，约 5 分钟，痛止。证属真心痛重症，且亡阳厥脱诸症毕见，遂投破格救心汤大剂变方：附子 150g，高丽参（另炖浓汁对入）、五灵脂各 15g，瓜蒌 30g，薤白（酒泡）15g，丹参 45g，檀香、降香、砂仁各 10g，山萸肉 90g，生龙牡、活磁石、郁金、桂枝尖、桃仁、细辛各 15g，莱菔子（生炒各半）各 30g，炙甘草 60g，麝香 0.5g，三七粉 10g（分冲），2 剂。加冷水 2000ml，文火煮取 600ml，3 次分服，2 小时 1 次，昼夜连服。余守护病榻，20 时 10 分，服第一次药后 1 刻钟汗敛喘定，四肢回温，安然入睡。至正月初七上午 6 时，10 小时内共服药 2 剂，用附子 300g，诸症均退，舌上瘀斑退净。为疏培元固本散一料治本（三七、琥珀、高丽参、胎盘、藏红花、黄毛茸等），随访 18 年未犯（12 页）。

李按 急性心梗，属中医真心痛，内经有“朝发夕死”的记述，急予上法针药并施，迅速痛止，为辨证施治赢得宝贵时间。患者高年，肾阳久亏于下，春节劳倦内伤，又过食肥甘，致痰浊瘀血阻塞胸膈，属真心痛重症。上方以参附龙牡、磁石、山萸肉救阳敛阴固脱；红参、五灵脂同用，益气化瘀，溶解血凝；瓜蒌薤白白酒汤合莱菔子，开胸涤痰，消食健胃；丹参饮合郁金、桃仁、三七、麝香，辟秽开窍，化痰通络；细辛散寒定痛，桂枝引诸药直达心宫。

冠心病危症 某海关关长，男，60 岁。原发性高血压 20 年，2007 年 4 月 20 日 15 时，突发冠心病，紧急入住山西医大二院 ICU 抢救。三日未能控制病势，院方邀余会诊。诊见：面色乌黯如蒙尘，体胖唇紫，大汗淋漓，六脉浮大空、迟、时一止。心动神摇，胸憋频发，发则四肢瘫软，口不能言，气短不足以息。CT、核磁见冠状动脉左支梗阻百分之七十，二尖瓣关闭不全。院方建议赴京作支架，

病重尚未成行。愚意，患者素体阳虚湿盛，复加长期劳倦内伤，虚损非止一端，渐致元阳大伤，痰湿瘀浊盘踞胸中，势危欲脱。邪实正虚，固脱为急，并予荡涤瘀浊，助阳破阴，以冀阳光一照，阴霾尽消为幸。处方：炙甘草 120g，干姜 90g，制附片 100g，高丽参 30g，五灵脂 45g，生山萸肉 90g，桂枝 45g，桃仁泥 30g，丹参 120g，檀香、降香、沉香、砂仁各 10g，三石（龙牡、磁石）各 30g，九节菖蒲 10g，麝香 0.3g，顿冲，苏合香丸 2 丸。上药日夜连服两大剂，次日诊之，诸症均退，面、唇舌、甲转红，脉缓，脱险。嘱原方附子逐日叠加至 250g，加干姜 50g，余药不变，24 小时内服完两剂。计前后三诊，8 日内服药 12 剂。2007 年 4 月 27 日，赴京阜外心血管医院住院，28 日行冠状动脉造影示：冠状动脉未见狭窄性改变。与山西二院 4 月 20 日 CT、核磁片对照，冠脉左回旋支梗塞的百分之七十已通，二尖瓣功能恢复。2007 年 4 月 30 日，冠心病心衰，经用大剂破格，完全脱险。善后处方：生黄芪 250g，制黑附片 200g，丹参 120g，檀香、降香、沉香、砂仁各 10g，粉葛根 90g，干姜 90g，生山萸肉 90g，桃仁 15g，五灵脂 30g，高丽参 15g（研冲服），炙甘草 120g，生姜 45g，大枣 20 枚。加水 7 斤，文火煮取 6 两，三次服，每日 1 剂，服至立秋节。另长期配服 11 味培元固本散（8、96 页）。

李按 余以上法加减进退，治心绞痛百例，心梗及后遗症数十例，均愈。特别是服培元固本散改善后，经 CT、冠状动脉造影、心电图复查，其器质性病变多无异常，如一例心肌下壁梗死，服培元固本散加葛根 100g，蛤蚧 5 对，冬虫夏草 50g，百日后心电图复查无异常，CT 复查 3 次，病灶了无痕迹，说明培元固本散有活血化瘀，推陈出新，修复重要脏器创伤的殊效（13、400 页）。

2.3.2 浊阴厥气上逆，温氏奔豚汤

组成：制附片 30-100-200g，油桂、沉香、砂仁各 10g，红参 30g，茯苓 45g，泽泻、山药、干姜、牛膝各 30g，炙甘草 60g。加减：凡见脐下有冷气上攻，气不能续，喘呼闷塞欲死，人即昏厥者，加龙牡、磁石、煅紫石英各 30g（372 页）。

冠心病急性心梗 林某，男，76 岁，已婚，家务，居住环境良好，广东人。因反复胸闷痛 5 年，加重 1 月入院。患者 2000 年开始反复出现胸闷痛，后入当地医院诊为“心肌缺血，急性左心衰”，经住院给予强心、利尿、抗凝等治疗，症状好转出院。病情时有反复，一直门诊中西医结合治疗。2005 年 8 月起患者胸闷痛频繁发作，并伴有头晕，经急诊 ECG、心酶学等检查，考虑为冠心病，急性下壁心肌梗塞。有高血压病 10 余年，脑梗塞史 5 年余。2005 年 9 月 11 日邀请余会诊，症见胸闷痛，时见心悸阵作，动则气促，不能平卧，神疲乏力，面色苍白，语声低微，时有咳嗽，咯白粘痰，痰量较多，夜间为甚，口不干，纳食及睡

眠差，小便量可，大便干结。舌淡暗胖大，苔水滑，脉虚。此为大病、久病之后，脉证一派虚像，三阴经阳气虚衰，寒饮上犯之胸痹病证。法当温阳化饮为治。方拟温氏奔豚汤加减，处方：制附片 100g，肉桂 10g，沉香 10g，砂仁 10g，高丽参（另炖）15g，川牛膝 30g，泽泻 45g，炙甘草 60g，生山药 45g，生半夏 45g，干姜 30g，五味子 30g，细辛 30g，云茯苓 30g，鲜生姜 45g，菟丝子 20g，枸杞子 20g，仙灵脾 20g，补骨脂 20g。上方加水 4000ml，文火煎至 500ml，高丽参另炖兑入汤药中，分三次服用，每隔 3 小时服一次。每天 2 剂。二诊：患者第一次服药后，出现恶心欲呕，多汗，气促稍减轻，但仍半卧位，不能平卧，并大便两次。两剂后，自感胸闷、气促较前减轻，精神转佳，声音较前洪亮、清晰，可平卧，口微干，纳眠好转，四肢乏力，小便量中，大便干结。舌淡暗胖大，苔较前转干，脉虚。上方减菟丝子、枸杞子、仙灵脾、补骨脂、五味子及问燥之干姜、细辛，加麝香平喘，调方如下：制附子 200g，肉桂 10g，沉香 10g，砂仁 10g，高丽参 15g（另炖），川牛膝 30g，云茯苓 15g，炙甘草 60g，生山药 30g，生半夏 45g，麝香 0.15g（冲），上方加 4000ml，文火煎至 500ml，高丽参另炖兑入汤药中，麝香冲服，分三次服用，每隔 3 小时服一次。患者服用两剂后，气促咳喘之症较前明显好转，后经综合调治善后，病情好转出院。（63 页）

按 本案胸痛、心悸气促、不能平卧，证属三阴三阳，寒饮上犯之胸痹危重症，予以大剂温氏奔豚汤，油桂、沉香直入肝肾，破陈寒痼冷，温中降逆；佐以姜、厦、辛，味取小青龙汤之意，温肺化饮；加肾四味纳气平喘，故投治辄效。

3 高血压、冠心病病机

根据李可上面论述，可以归纳出**高血压、冠心病之病机：即先天阳虚，清阳不升，浊阴不降，痰湿瘀浊窃踞头部、胸中阳位**。李可有进一步指出，阴阳的不平衡，不是你给他大量添水，那个水火就能平衡了。而是因为阳虚才能造成不平衡，所以还是要助阳，阳旺以后，阴阳自然就平衡了。对阴、阳的态度，要坚定不移。阳为统帅、主导，**阳主藏而不露，一露便是病**。阴不能自生自灭，阳生则阴长，阳杀则阴藏，人身五官九窍，筋骨肌肉，五脏六腑，一处阳气不到便是病；阴凝，则以阳破之；阴不生，则助阳以生阴。四逆汤则能生血，治白血病、再障之理即在此。切记，治标切勿害本！我以破格救心汤治大崩垂危，正是“已亡之血难以骤生，未亡之气所当急固”（155 页）。

中风危证不避麻

摘要 针对中风之内外风的争论，进一步探讨了李可学术思想。李可治中风思路：外风可引内风动，诸急、卒、暴皆是风；麻黄利窍通脏腑，汗法可治脑水肿；阳气不到便是病，麻附细法透伏邪；中风危证不避麻，活血化瘀望莫及；闭证大续命汤，针药并施促苏醒；脱证小续命汤，上闭下脱苏合丸；中风后遗续命衍，麻细四五止痉散；不在内、外钻牛角，六经辨证统中风。

关键词 中风 大小续命汤 药王续命散 麻细四五止痉散 中风 培元固本散 李可 医案

中风，汉唐以前以外风为主，沿用大小续命汤长达 13 个世纪；自明清以来，出现了关于内风、外风的争论。特别是到了清末、民国初，偏重于内风，将平肝潜阳、镇肝熄风广泛用于临床，已成为当今中医临床思维定式。李可对后世中风理论提出质疑，并进行一系列批判。现根据其数则医案，整理出以下内容：

1 外风可引内风动，诸急、卒、暴皆是风

李可认为，近代把内风、外风截然分开，不符合临床实际。人处大自然大气之中，风为百病之长，外风可引动内风。而且孙思邈明确指出：“诸急、卒、暴皆是风”从风论治，临床实效显然，实践才是检验是非的唯一标准（287 页）。

药王中风 唐代号称药王的孙思邈，他 90 岁时中风，言语蹇涩，完全不能动，就口述了一个方子“续命煮散”，让徒弟磨成粉，做成“煮散”。什么叫煮散，就是一副中药，打成粉，分成若干个包，一天几包，放到水里边煮开了，然后连汤带药喝下去。这个比汤剂稍微慢一点，但是比丸剂又快。孙思邈一天吃四服，吃了十天十夜，第十一天的时候他自己就起床了（99 页）。

方名：孙思邈“续命煮散”。为了便于推广，应当起个顺口的名称，故笔者暂称之为“药王续命散。”

组成：麻黄、川芎、独活、防己、甘草、杏仁各 90g，紫肉桂、生附子、茯苓、升麻、细辛、高丽参、防风各 60g，生石膏 150g，生白术 120g。

加减：口歪眼斜：加清全蝎 90g，大蜈蚣 100 条，僵蚕 90g；失语：加麝香 0.3g/日，另冲服。

主治：中风急重症；高血压、脑动脉硬化，出现中风先兆者；风痺（原因不明瘫痪）。

用法：每次 14 克，绢包（细密之白布亦可），加水 800 毫升，文火煮至 400 毫升，分做四次饮，三小时一次；重症 24 小时用 2g 克，日三夜一服，不可间断。连饮 7 至 10 日。

李按 此方为大小续命汤类方，为孙思邈自拟自治方。方中生附子所占比例极小，绝无中毒之虞，方用绢包，意在但取火气。方中有大量石膏反佐，对高血压无碍，我用此方治愈了自己的中风急症，证见右侧麻木，舌头发硬，讲话困难，就吃这个药，半个月就基本恢复（20 页）。

2 麻黄利窍通脏腑，汗法可治脑水肿

李可认为，小续命汤现在用的少了，为什么？因为这个方子被清末民国初一部分中西汇通派骂得狗血淋头。他们按现代医学研究成果，认为中风就是“肝阳上亢”，治法就要“镇肝熄风”，最著名的就是张锡纯（镇肝熄风汤），还有张山雷写的一本书《中风斟论》，就是把古今所有治中风的东西作细节地批判，受批判最重的就是这个“小续命汤”。他们认为麻黄、桂枝都不能用，因为现代药理认为麻黄、桂枝有升高血压的弊病，基本就被禁用，附子就更不用说了（104 页）。

脑出血 一农妇，37 岁。患原发性高血压 18 年，由于暴怒引发蛛网膜下腔出血，昏迷 48 小时，醒后暴盲。诊见寒战、咳逆无汗，查颅内血肿、水肿，双眼底出血、水肿。眼科名家陈达夫云：凡目疾，无外症而暴盲，为寒邪直中少阴，玄府（毛孔）闭塞所致，当用麻黄附子细辛汤温肾散寒。李可见此妇禀赋素壮，证见寒战无汗，纯属表实，与少阴无涉，遂径与麻黄汤一剂令服。次日诊之，夜得畅汗，小便特多，8 小时约达 3000 毫升，头胀痛得罢，目珠胀痛亦止，目赤亦退，血压竟然复常，已可看到模糊人影。又以通窍活血汤冲服水蛭末 12 克，调理一段，终于复明，左、右眼视力分别为 1.2，0.8（286 页）。

李按 从本案的病机来看，由于寒袭太阳之表，玄府闭塞，寒邪郁勃于内，气机逆乱上冲。邪无出路，遂致攻脑、攻目，邪之来路，即邪之出路，随着汗出，表闭一开，邪从外散，肺气得宣，水道得通，小便得利，郁结于大脑及眼底瘀血、水肿亦随之而去，脑压迅速复常。麻桂升压，现代药理已成定论，近百年来已经列为脑血管病禁区，而麻黄汤竟然治愈不可逆转的高血压，岂非千古奇谈！由此想到古代治中风昏迷欲死，用“古今录验大小续命汤”，并强调“录验”二字，必有至理。现代斥其非，实是不知汗法可以消除溢血、充血之水肿。

3 阳气不到便是病，麻附细法透伏邪

李可认为，中风与正虚有关系，然后再加上疲劳过度。高血压及中风，其根本之点在于浊阴（即痰湿瘀浊）窃踞阳位——头为诸阳之会，这一阳气充盈之处，何以被浊阴所踞？正是先天阳虚，阳不主政，循此思路大体无误。以往中医界之误，误就误在“肝阳上亢”，实际上是“阳火不藏”出现的一种假象。其治法之一为透邪，选麻附细、大小续命汤，开玄府之闭，使寒浊之邪托透于外，阴邪一退，自是红日当空，阴霾尽消（98 页）。

中风急症 2000 年秋天，我的一个年轻弟子，中医根底不深，学眼科的。他治了一个农村妇女 20 多年的高血压，他的丈夫是煤矿老板，有钱了在外边胡作非为，女的就生气，突然蛛网膜下腔大量出血，出血后不久，双眼什么也看不到了。这种暴盲，按照六经辨证，属于寒邪直中少阴。当时用的麻黄附子细辛汤，出了大汗，血压就好了，第二天人就醒过来了，眼睛可以看到人影，脑水肿减轻，小便也多了。之后近十年的时间，一直血压稳定，一劳永逸（42 页）。

按 李可第二次中风，自己开的方子就是小续命汤合麻附细汤，附子重用 250g，细辛 45g，吃了两个多月，用的是辽宁产的北细辛味道太大，每次喝时

都恶心。这种敢于“以身试药”，“亲身践行”神农尝百草的探索精神，是值得我们学习的。

4 中风危证不避麻，活血化瘀望莫及

李可认为，大小续命汤以小续汤为常用，两者大同小异，主治相似，不同点是“大方”主治“卒中之壮热如火者。”中风突发高热，现代医学认为是脑溢血后继发感染，中枢性高热必然还有神昏错语等其它危象。但在加减法中，仅减去防己、附子，加当归、石膏，而不去麻黄，因为汗法得宜，可以减轻脑压，消散瘀血、水肿，故中风危证亦不避麻、桂。得汗之后麻黄减为 5 克，让它发挥通气的作用，直至痊愈，是活血化瘀法望尘莫及的。这正是古人的聪明之处，但古法的奥妙之处，可惜被中西汇通派想歪了（288 页）

方名：大、小续命汤。

组成：**小续命汤**：麻黄（另）、防己、红参（另）、黄芩、紫肉桂（后下）、白芍、杏仁、炙甘草各 10g，制附子 20g，防风 15g，生姜 50g，大枣 10 枚。

大续命汤：上方去防己、附子、加当归、石膏。

主治：孙思邈曰：“小续命汤治中风欲死，不醒人事，口眼歪斜，半身不遂，舌蹇不能语，亦治风湿痹病”。

大续命汤治中风之壮热如火者。

用法：孙思邈曰：“以水一斗二升（1400ml），先煮麻黄三沸（大沸后以冷点之，再沸再点，三次为三沸）分三服，去沫，入诸药煮取三升（600ml），甚良；不愈更服三四剂，必佳。敢汗当随人中风轻重虚实也，故令人不虚，**诸风服之皆验，病轻、体虚，用小剂（即本剂）、中剂（即本剂 1.5 倍），急危重症用大剂（即本剂 2 倍）**”（287 页）。

5 闭证大续虎承汤，针药并施促苏醒

李可认为，凡闭证必见高热神昏谵语，面赤如醉，目赤，气粗，口臭，牙关紧闭，两手握固，二便闭结，六脉洪实，居室必有秽臭之气。急用大续命汤加大黄 45 克（即承气汤之意）釜底抽薪，导热下行；生石膏加至 250 克（即白虎汤之意），因三阳统属阳明，阳明一清，壮热立退。加竹沥水 30ml 涤痰，加九节菖蒲、郁金各 30g，安宫牛黄丸 1 粒，麝香分冲），以清心开窍醒脑。若兼见热极动风，角弓反张，加羚羊角粉 3g，止痉散 4g 分冲），以熄风止痉。以上鼻饲给药，与此同时，**针泻素髻、人中、涌泉、十二井、十宣，刺泄黑血**，解外以安内，外围一解，中枢压力立减，针药并施以促苏醒（288 页）。

中风闭证 张某，女，47 岁，肥胖体型，患原发性高血压，多年失治，致时时头晕肢麻。1997 年 6 月 16 日 14 时许，突然昏扑，扶起后，口角流涎，呕吐如喷射状，失语，右瘫，昏迷。面赤如醉，两手握固，四肢拘挛，项强，瞳孔不等大。痰涌如鼾，即送城关医院抢救。会诊意见：脑溢血（左颞右基底节区出血，右基底节区腔隙性脑梗塞，CT 检查报告）；风生于脏，痰热内闭。院长邀余协治。除西医常规抢救措施外，建议：

① 三棱针重刺十宣、十二井、双足趾尖出血，刺激末梢神经，减轻脑压；毫针强刺素髻，人中，内关，足三里，丰隆，涌泉，由上而下，重刺健侧，引血下行，促苏，2次/日。

② 加用中医现代科研成果清开灵、醒脑静滴；早用活血化瘀中药针剂，促进吸收，防止脑疝形成，2次/日。

6月17日10时，经上述处理后，痰涌大减，四肢拘挛缓解，喂水可以咽下，体温38.5℃，加用中药：

① 降气火之升腾，清痰热之内闭：赭石粉、怀牛膝、生石决、生牡蛎、生白芍、元参、生半夏各30g，黄芩、天麻、勾藤各15g，酒大黄、天竺黄、胆南星、菖蒲、郁金、甘草、车前子各10g，生铁锈磨浓汁煎药，日进一剂；

② 安宫牛黄丸2丸，捣为糊，日进2丸；

③ 羚羊角粉2g，麝香0.3g，以竹沥水加姜汁数滴，一日内多次分服。6月18日10时二诊：黎明泻下热臭便一次，呕止，痰鸣消失，瞳孔等大、等圆，体温37.5℃。原方去生半夏，黄芩炒炭，酒军另煎，再泻一次后弃去，余药不变。安宫丸减为1丸。6月22日8时三诊：上药连进3剂，今晨7时许睁目看人，苏醒。可以点头、摇头回答询问，仍失语，血压正常，开始进流食。以手指口，索饮，舌红，根有腻苔，边尖瘀斑。神倦，体温37℃，六脉细数而虚。散剂扶正清脑化瘀：三七、琥珀、西洋参、藏红花、人工牛黄、天竺黄、生水蛭、炮甲珠、全虫尾、大蜈蚣、羚羊角尖各10g，守宫10条，麝香3g，上药研粉混匀，1克/次，3次/日，竹沥水送下。6月26日四诊：口眼歪斜已正，舌体灵活，开始讲简单的话，出院回家调养（35页）。

按 本案呕吐如喷射状，痰涌如鼾，证属风中于脏，痰热内闭。由于胃失和降，则诸经皆不得降，气逆为火，夹痰上攻，故壮热昏迷、失语、呕吐、痰涌。急以旋覆代赭汤合大柴胡汤变通，加竹沥水涤痰，菖蒲、郁金、安宫丸、麝香开窍醒脑，加羚羊止痉。针刺与放血，在退热、止痛、促苏方面起到了顿杀病势的效果，为辨证用药扫清了障碍，不可轻视。

6 脱证小续破潜汤，上闭下脱苏合丸

李可认为，凡脱证虽有高热，必见神情疲惫，昏沉不醒人事，轰轰发热，面色嫩红，或鲜艳如涂油彩，或灰暗萎黄无华，目合口开，手撒尿遗，已是中气下脱，真阳一涌而出，顷刻便有亡阳之祸。速以小续命汤大剂去麻、芩、芍，附子、炙甘草加至120g，再加干姜90g。红参易高丽参30g（另炖），山萸肉120g，龟板10g，龙牡、磁石、乌梅各30g，童便1杯反佐，救阳固脱（即破格救心汤合潜阳丹化裁）。若兼见痰雍漉漉，加生半夏45g，生南星、川乌、黑大豆各30g，沉香10g，竹沥水304，姜汁104，麝香1g（分冲），加蜂蜜150ml入水武火急煎，随煎随灌或鼻饲给药。治闭证，又要先看下边，若见遗尿便是上闭下脱，真阳失根，按脱证论治，以苏合香丸温开之（289页）。

中风脱证 温某，男，52岁。1977年4月23日凌晨5时，突觉胸中气不上达，随即昏厥。自汗，遗尿，右半身偏瘫。脉弱不上寸，尺部亦虚。以毫针刺人中后苏醒，语声低微如蚊蚋。法宜大补气血，温肾敛肝固脱。补阳还五汤变方合张锡纯氏来复汤加减：生芪120g，山萸60g，红参10g（另炖），当归30g，

白芍 15g，炙草 10g，肾四味 120g，生龙牡各 20g，赤芍、川芎、地龙各 10g，桂枝 10g，桃仁、红花各 3g，鲜生姜 10 片，大枣 10 枚，胡桃 4 枚，7 剂。4 月 30 日二诊：服 1 剂，汗敛喘定，服 3 剂，可拄杖学步。服完 7 剂，已可弃杖行路。嘱其再服 7 剂。5 月下旬，遇于百货公司，扛包装车已如常人，追访至 62 岁，继续当装卸工，健壮逾于往年（36 页）。

李按 此人一生困顿，当装卸工几十年，难求温饱，劳倦内伤，肾元久衰。昨夜装车到零时，已觉气喘汗出，湿透内衣，属于大气不运，虚脱已见端倪。**证已虚化，未见寒化，故不用小续命、破格救心、潜阳大法，而以补阳还五汤合来复汤收功。**

7 中风后遗续命衍，麻细四五止痉散

李可认为，**中风后遗症**，可用小续命汤合补阳还五汤化裁，重用生黄芪 250g。虚化、寒化者，去黄芩，加干姜，10 剂之后，麻黄减为 5g，四肢痿废，重用理中。口眼歪斜，借用虫类入络搜剔诸法，如全蝎、蜈蚣、生水蛭，研末吞服，必有速效。如中风后遗症之关节变形，肌肉萎缩，痿废不用，以偏正头风散 3 克，3 次/日，淡茶水加蜂蜜一匙调服。另加马钱子粉，每睡前温开水送下 0.6 克（246 页）。若中气、肾气大虚，久损不复，可用鹿茸 50g，紫河车 100g，生晒参 50g，三七 100g，琥珀 50g，藏红花 50g，小白花蛇 60 条，全蝎 60g，大蜈蚣 100 条，制粉久服，托正以祛邪，舒胸怀，慎房事，保肾气，配合针灸，佐以适当锻炼，以期康复（289 页）

中风后遗症 孙某，男，60 岁。2007 年 1 月 22 日初诊；30 年前诊为原发性高血压（低压偏高，持续在 100-110mmHg）、脑动脉硬化。20 年前的一天夜里，突然被惊醒，醒时就发现自己右半身的上下肢在不停地抖动，大约抖动了十几下就停下来，间隔半分钟又抖动，如此反复了 3 次，随后右半身瘫痪，确诊为脑血栓。经过中西医治疗，功能锻炼，已经扔掉了拐杖，但右半身仍行动不便，人冬以来，眩晕加重，手指麻木，膝软，舌质略暗，舌白滑，脉涩无力。证属劳倦内伤，诸虚百损，中风久延，大气不运，元阳难于敷布，痰湿瘀浊阻塞三焦，头面、印堂灰暗，殊非佳兆，为防突变，力挽颓势，拟小续命汤法衍变方：北芪 250g，麻黄 10g，制黑附片 45-200g（逐日叠加 10 克），当归、桂枝各 45g，辽细辛 45g，川芎、干姜各 90g，红参（另炖）、灵脂各 30g，桃红各 10g，僵蚕 10g，地龙 45g，生南星 10g，生半夏 45g，生姜 45g，清全虫、大蜈蚣 6 条、小白花蛇 1 条（研冲服），黑小豆 30g，大枣 25 枚，黑木耳 45g，白芥子炒研 10g，加水 6 斤，文火煮 2 小时，去渣，再煎浓缩至 500ml，入参汁，3 次分服。二诊：服 1 剂，药后 20 分钟，患侧肢体出现痒麻如触电，甚则肌肉突突跳动。3 剂后，泻下恶臭稀便，倍感轻松。15 剂后，走路姿式已有好转，如原来右腿每迈步时必有后摆，而今已无此动作了。附子加至 165 克时，周身有麻木触电感，故减去 10 克守方续服。三诊：服 1 个月后，右脚掌已能用力迈步了，走路画圈也不那么厉害了，效不更方，继服 1 个月。

李按 此方由古今灵验续命汤法衍变组成。应用千年以上，可治中风、风瘫、肢废、语塞诸疾，经治千人以上，大多康复。方剂首见于金匱付方，再见于千金要方。近年来得见桂林、天津古本伤寒杂病论《仲圣第 13 稿》，佐证此方源于六经辩证，实是医圣的思路，可放胆使用。**方之大意，以麻附辛法温少阴元**

阳，开玄府闭塞，托透伏匿三阴诸邪渐次出表，以生芪运大气助元阳之敷布，南星半夏白芥子消除十二经皮里膜外之痰，桂枝、桃红辈，流通血脉，诸虫人络搜剔，合麻黄宣通九窍，扶正达邪，面面俱到。尤以附子温通十二经表里内外，益元阳，扫荡阴寒为君，正是医圣六经要旨。

总之，服药过程可以体会“人身各处，但凡一处阳气不到便是病”。当元阳渐旺，助人体自我修复，清除垃圾之际，必会出现种种排毒反应，或无故畅泻恶臭便，或倒仓（大吐痰涎），或患病肢体痒麻如触电，或无故一阵心跳（启动少阴元阳逐邪），或患侧肌肉突突跳动，或胸背出现斑疹，不一而足，皆药病相争，邪正交争，正胜邪怯之兆，属正常反应。如不能耐受，可暂缓三、五日，靡粥自愈。以上诸反应，皆随附子加量而发，要掌握好分寸。**附子由少到多，正是内经“少火生气”之理，若超量则变成“壮火蚀气”，要掌握好这个“度”。**

8 不在内、外钻牛角，六经辨证统中风

李可认为，中医治疗中风，并不分内外，因为它有形、有证，你就根据这个形和证判断他是哪一经受病，你就治哪一经。如果它牵涉到的方面多，你考虑轻重缓急，侧重于哪一面，基本的方法就是《伤寒论》。大小续命汤实为中风金方，由于受西化诸多似是而非观点的影响，今人久已罕用。本方立法，用药暗合医圣六经要旨，故能流传千古（99、289页）。

蛛网膜下腔出血 温某，女，27岁。怀孕5个月，突然剧烈头痛，喷射状呕吐，经急诊治疗两周，病势转重，邀李氏诊视。询知CT见“蛛网膜下腔出血”，颅内压居高不下，频频喷射状呕吐。近日多次发生短暂性抽搐，一度口眼歪斜，头痛如破，呻吟不绝，目赤气粗，呕吐稠粘痰涎及黄绿色苦水，其气秽臭。脉弦滑而劲，阵阵神糊。证属肝胃痰火上攻，气机逆乱，有升无降，内风已动，有蒙蔽神明之险，急则治标，予降气涤痰和胃降逆：赭石、怀牛膝、生半夏各30g，胆星、天竺黄、柴胡、黄芩、酒龙胆草、枳实、炙草各10g，白芍45g，珍珠母、茯苓30g，全虫5g、蜈蚣3条（研末冲服），生姜30g，姜汁10毫升（对入），煎取浓汁300毫升，小量多次缓缓呷服，待呕止，顿服安宫牛黄丸1丸。1剂后，头痛减，抽搐未发，神志已清。凌晨又见剧烈头痛约1刻钟，呕减而未止，吐出酸苦粘涎，脉弦滑较昨稍缓，舌上水滑，胃中觉凉。改投镇肝熄风汤合吴茱萸汤加减，重在降逆和肝胃：赭石45g，怀牛膝、生半夏、茯苓各30g，红参（另炖）、吴茱萸（开水冲洗7次）、炙草各15g，全虫10g，蜈蚣10条，生姜30g，姜汁10毫升。1剂后痛呕均止，颅压正常。仍予原方加减，侧重化痰两剂，诸症均退，未见任何后遗症。唯输液一侧之下肢肿，予补阳还五汤调理而愈（45页）。

李按 本例之剧烈头痛，在加吴茱萸汤后一剂而止。因吴茱萸辛苦大热，其气燥烈，在下笔之际曾有犹豫，恐不合于“脑出血”症。中医虽无“蛛网膜下腔出血”之病名，但患者头痛如破，剧烈呕吐，吐出物为酸苦涎沫，又自觉胃凉，正是肝胃虚寒，痰饮上冲颠顶（脑）之的据。病机既合，投剂之后，头痛如破及残余之呕吐立止。读古人医案，常有“覆杯而愈”、“效如桴鼓”之描述，一经临证，乃深信经方确有神奇功效。由此领悟，伤寒六经辨证之法，统病机而执万病之牛耳，则万病无所遁形。“病”可以有千种万种，但病机则不

出六经八纲之范围。正是内经“知其要者，一言而终”的明训，执简驭繁，万病一理。临证之际，不必在“病名”上钻牛角，不但不考虑西医的病名，连中医的病名也无须深究。胸中不存一丝先入为主之偏见，头脑空明灵动，据四诊八纲以识主证，析证候以明病机，按病机立法、遣方、用药，如此，则虽不能尽愈诸疾，庶几见病知源，少犯错误。

9 中风常用方歌选

9.1 大小续命汤

组成：小续命汤：麻黄(另)、防己、红参(另)、黄芩、紫肉桂(后下)、白芍、杏仁、炙甘草各 10g，制附子 20g，防风 15g，生姜 50g，大枣 10 枚。

大续命汤：上方去防己、附子，加当归、石膏。

主治：小续命汤：中风急性期、或中风先兆者；大续命汤，中风之壮热如火者。

歌诀：小续芩防 2 芎人附，麻桂当膏防己附。

歌诀解释：小续命汤为黄芩、防风、防己（故在“防”字右上角标“2”），川芎、人参、附子、麻黄汤、桂枝汤（但桂枝易油桂）；大续命汤为小续命汤加当归、石膏，减防己、附子。

9.2 药王续命散（即孙思邈“续命煮散”）

组成：麻黄、川芎、独活、防己、甘草、杏仁各 90g，紫肉桂、生附子、茯苓、升麻、细辛、高丽参、防风各 60g，生石膏 150g，生白术 120g。

主治：中风急性期、或中风先兆者。

歌诀：麻桂细防 2 芎人附，独升苓膏蚕止术。

歌诀解释：药王续命散为麻黄汤、油桂、细辛、防风、防己（故在“防”字右上角标“2”）、川芎、人参、附子、独活、升麻、茯苓、石膏、僵蚕、止痉散（全蝎、蜈蚣）。

9.3 闭证大续虎承汤（“虎”指白虎汤之石膏，“承”指承气汤之大黄）

组成：大续命汤加大黄 45 克，生石膏加至 250 克，竹沥水 301¹，九节菖蒲、郁金各 30g，安宫牛黄丸 1 粒，麝香 1g（分冲），羚羊角粉 3g，全蝎、蜈蚣各分冲）。

主治：中风闭证，即高热实化者，如脑溢血后继发感染、或中枢性高热者。

歌诀：大续黄沥蒲金麝，安宫羚羊止痉散。

歌诀解释：大续命汤加大黄、竹沥、菖蒲、郁金、麝香、安宫牛黄丸、羚羊、全蝎、蜈蚣。

9.4 脱证小续破潜汤（“破”指破格救心汤，“潜”指潜阳丹）

组成：小续命汤大剂去麻、芩、芍，附子、炙甘草加至 120g，再加干姜 90g，红参易高丽参 30g（另炖），山萸肉 120g，龟板 10g，龙牡、磁石、乌梅各 30g，童便 1 杯反佐；若兼见痰雍漉漉，加生半夏 45g，生南星、川乌、黑大豆各 30g，沉香 10g，竹沥水 30ml，姜汁 10ml，麝香 1g（分冲），加蜂蜜 150ml，若见遗尿便是上闭下脱，以苏合香丸温开之。

主治：中风脱证，即高热虚化、寒化者。

歌诀：小续芩麻川芍减，破格龟梅佐童便；夏星乌沉沥姜麝，上闭下脱苏合丸。

歌诀解释：小续命汤减芩、麻、川芍；破格救心汤加龟板、乌梅、童便，痰壅加半夏、南星、川乌、沉香、竹沥、姜汁、麝香，因李可用川乌必加防风（小续命汤有之）、黑大豆、蜂蜜，故从略。上闭下脱者按脱证论，以苏合香丸温开之。

9.5 麻细四五止痉散

组成：北芪 250g，麻黄 10g，制黑附片 45 200g（“逐日叠加 10 克”），当归、桂枝 45g，辽细辛 45g，川芍、干姜 90g，红参（另炖）、灵脂各 30g，桃红各 10g，僵蚕 10g，地龙 45g，生南星 10g，生半夏 45g，生姜 45g，清全虫 3g，大蜈蚣 6 条、小白花蛇 1 条（研冲服），黑小豆 30g，大枣 25 枚，黑木耳 45g，白芥子炒研 10g。

主治：中风后遗症，即半身不遂。

歌诀：麻辛四五涤 4 灵 2 虫 3，夏星芥蚕白蝎蚣。

歌诀解释：前一句“麻细”，指麻附细；“四”指四逆汤（减炙草），当归四逆汤（减通草、炙草），故在“四”字右上角标“2”，“五”指补阳还五汤；“涤”指涤痰药半夏、南星、白芥子、僵蚕，故在“涤”字右上角标“4”；“灵”指李可之红参、灵脂对药，故在“灵”字右上角标“2”；“虫”指虫类药白花蛇、全蝎、蜈蚣，故在“虫”字右上角标“3”。后一句“夏星芥蚕”为涤痰药，“白蝎蚣”为虫类药。

9.6 中风培元固本散

组成：鹿茸 50g，紫河车 100g，生晒参 50g，三七 100g，琥珀 50g，藏红花 50g，小白花蛇 60 条，全蝎 60g，大蜈蚣 100 条。

主治：中风后遗症，或善后调养方。

歌诀：五味红花白蝎蚣。

歌诀解释：五味培元固本散（即六味培元固本散减灵脂），加藏红花、白花蛇、全蝎、蜈蚣（289 页）。

（选自《李可老中医急危重症疑难病经验专辑》、《人体阳气与疾病》）

附子丸散简效廉

——李可学术思想探讨之十七

附子有大毒，据现代检验结果，15克附子就町以毒死一头牛。如果一头牛能顶10个人的份量，那么1.5克附子粉要是给一个人吃上，应当和15克附子毒死一头牛是一样的结果吧，这你亲自试过吗？李可指出，自晋以后，以儒治医，流弊就在崇尚空谈，不重视临床，对内经等经典多有违背，以为读过两本医书就可以“不为良相，便为良医”，实际误人不浅。附子是中医手中一味救命仙丹，既然要用附子，就得了解附子。书上写过，不如自己用过。因此，从我开始到第二代、第三代弟子，无一例外的都亲尝附子，患病则亲自处方服附子。只有亲自做过，才可发现真理（5页）

1 李可关于附子小剂量论述

李可以使用大剂量附子闻名。当记者问他如何看待使用小剂量附子的问题时，他回答：根据我的经验，在我行医初期，即1961年治7例急危重症，某中有6例患者因附子量小而无效死亡。据我一生见到的危症没有一个是小剂量能够治疗成功的。所以在急危重症方面，用小剂量附子只能是隔靴搔痒（13页）。初看这段话，一般则以为李可惯用大剂附子，而反对用小剂量附子。这实际上是一种误解，他只是在急危重症方面用大剂附子。笔者在《附子用量煎服法》一文中提出附子证，即李可把附子应用分为阳虚、阳衰、格阳、亡阳、垂死等5个等级，其中阳虚用小剂附子10克，如缺乳案之五更泻、膝关节积液案之夜尿频等（95、251页），全书附子小剂者17例，占总数的24.3%，这些足以证明，其治非急危重症亦用小剂量附子。

1.1 小剂四逆汤养阳长寿

李可自述：在2004年的时候，我根据邓铁涛的建议，在南方那几个省跑得比较多，看过的病人大概有一千多人，这里头有一个很特殊的现象，那就是阳虚的人十占八九，阴虚的人百不见一。一开始我也解释不了，但经过好长时间反思以后，最后我找出这么几点：

① 南方是丙丁火：从中医讲，南方就是丙丁，属火的那种气候。由于外界的这种热，再加上人本身这个阳气不断释放，他里面就空虚了。在这种情况下，损伤的阳气肯定要比北方人多。

② 南方人的生活习惯：南方气候特别热，几乎就只有夏天，没有什么春、秋、冬。由于空气热，就特别喜欢吃生冷的东西，即常年喝冷饮、冰镇过的汽水、果冻，冲冷水澡。

③ 南方普遍使用空调：阳虚的主要证状是怕冷，这与南方普遍使用空调有

关。外面是大夏天，气温三十几度，一进到屋里，空调开到几度，就像掉到了冰窟窿里。寒湿是伤人最厉害的外邪。而我们人造的寒邪（即空调病）比那自然界的寒邪还要厉害，比如说头痛、慢性鼻炎、阴暑症、常年感冒、妇女痛经、产后病、哮喘、拉肚子等，比比皆是。

④ 南方搞中医的误区：南方搞中医的人，误以为他们处在南方，处在最热的地方，就应该补充凉的东西，那就是滋阴降火，结果越降越糟。总之，由于错误的生活理念，错误的生活习惯，错误的治疗思路，这都进一步伤害了阳气，导致阳虚的人十占八九。《内经》讲“存复养阳”，这是古代几千年实践得出的一个非常正确的结论。因为春天和夏天，耗费的阳气最多，所以这个时候要特别强调养阳，以小剂四逆汤常服（即炙甘草 30g，干姜、制附子各 15g，服 7 日停 3 日，从春分服至立秋），从而达到养生的目的。六十岁以上的老年人，都可以用，可以消除你长期积累的“六淫外邪”，以及内生的一些个寒邪，能对抗一些当代错误习惯对人身的伤害，调整你的元阳，使其不受损伤，延年益寿（5、24、33、49、153 页）。

1.2 金匱肾气丸治肾虚、高血压

李可在论述小剂四逆汤养阳时，考虑到长期煎煮有些不便，就进一步给出简便的方法：那就是用金匱肾气丸，但千万不要用六味地黄丸。就是把金匱肾气丸每次 5 丸，煮成糊状喝下去，早晚各 1 次，有十天半月就可以把好些属于肾虚的证状都扭转过来。金匱肾气丸可以经常吃，没副作用，尤其象一些阳虚引起的证状性高血压，经过一段时间也可以调整过来。即使血压暂时升高也不要紧，要继续吃。此系邪正交争，你不要老查血压，要问他有什么感觉。只要阳盛阴退，血压自会安宁，勿虑（153 页）。那么 5 丸金匱肾气丸含附子多少呢？一般每蜜丸 9 克，其蜂蜜占一半，则药粉为 4.5 克。金匱肾气丸中的附子占 $1/27$ ，即： $4.5 \text{ 克} \times 5 \approx 0.8 \text{ 克}$ 。所以，5 丸金匱肾气丸含制附子 0.8 克。

1.3 药王续命散治中风

李可在论述中风时十分赏用药王续命散（即孙思邈之“续命煮散”），其用法：每天 14 克，加水 800 毫升，文火煮至 400 毫升，分作 4 次服，3 小时 1 次；重症 24 小时用 28 克，分作 8 次服，3 小时 1 次，不可间断，连饮 7-10 日（101 页）。那么每次药王续命散含附子多少呢？药王续命散中的附子占 $1/21$ 。即“ $14 \text{ 克} \times 1/21 \approx 0.67 \text{ 克}$ ；重症为： $28 \text{ 克} \times 1/21 \approx 1.33 \text{ 克}$ ”。所以，药王续命散每次含生附子 0.17 克。

1.4 偏正头风散治头痛

李可自述：余在 1958 年偶得一则专治头痛的秘方“偏正头风散”，经临床反复运用，筛选药物，调整主辅药比例，用治各类各型头痛痼疾，收到药到病除之效。而且重订之后，已大大打破了原方的主治范围。诸药共研细粉，日服 2-3

次，每次 3 克（245 页）。3 克偏正头风散含川乌多少呢？偏正头风散中的乌头占 1/19，即： $3 \text{ 克} \times 1/19 \approx 0.16 \text{ 克}$ 。所以，3 克偏正头风散含制川乌 0.16 克。

1.5 类关乌头酒治类风湿

李可师法仲景，仿乌头汤之意，加桂枝汤、活络效灵丹、止痉散，配制成类关乌头酒。类关乌头酒 1 料，共药粉约 450 克，共服 45 天，平均每次服药粉 5 克（208 页）。那么每次类关乌头酒含川乌、附子多少呢？类关乌头酒中的川乌、附子各占 1/15，即： $5 \text{ 克} \times 1/15 \approx 0.33 \text{ 克}$ 。所以，类关乌头酒每次含制川乌、制附子各 0.33 克。

2 李可附子丸散的研发

李可关于附子小剂量论述，特别是小剂四逆汤、金匱肾气丸、药王续命散、偏正头风散、类关乌头酒中的附子、乌头含量，引起笔者的关注，并以此为基础研制出李氏附子水丸系列。下面举例证之：

2.1 李氏破格救心丸治房颤

曲某，女，60 岁，农民。房颤 3 年了，起初一年犯三五次，去年发作比较频，今年几乎天天犯。发作时心慌、多汗、乏力，腿软上不了台阶，整天在炕上躺着不能做饭。10 年前，因子宫肌瘤而切除。平时睡觉觉手麻凉，右手拇指尖凉，腿酸、失眠、头面轰热、胃胀、大便稀。Bp130/90mmHg，心率 111 次/分。舌略暗苔腻，脉雀啄、浮躁急。证属心肾阳虚，寒湿窍踞阳位。遂予李氏破格救心丸 8 克，日 2 次，服半月。二诊：心慌次数减少，胃不胀，大便调，手凉减半。继服上方半月。三诊：心不慌，腿不软，能做饭。心电图提示：房颤无，心率 72 次/分。改为培元固本丸善后一个月。四诊：药后复查心电图正常。

按 **李氏破格救心丸**，每次 6-9 克，02-3 次。其源于破格救心汤（4 页），原方组成：附子 30-100-200 克，干姜 60 克，炙甘草 60 克，高丽参 10-30 克，山萸肉 60-120 克，龙牡、磁石各 30 克，麝香 0.5 克。此患者当做完无房颤心电图时，就拿出第一次有房颤心电图问这位心电图大夫：我的房颤是不是好了？那位医生以十分肯定的口吻回答：房颤是不可逆的。恰好该院的内科主任跟我学中医，对此亦抱怀疑态度，就又领患者做了一遍心电图，结果仍无房颤，这下无话可说了。具有戏剧性变化的是那位心电图大夫，从那以后凡是遇到房颤的患者就介绍给我。

2.2 李氏麻细梅参丸治感冒

邢某，女，37 岁。正值三九寒冬之季，忙于搬家，身患感冒，体温 38.8℃，周身冷痛，下肢酸软，就想席地而坐。经抗菌素、布洛芬治疗，仍不缓解。舌淡苔薄，脉沉细稍数，拒服汤药。予李氏麻细梅参丸 8 克，日 3 次，按桂枝汤服法，服 3 天。二诊：服药当天夜里，周身微汗，疼痛顿减，第二天热退身凉，尽剂而愈。

按 **李氏麻细梅参丸**, 每次 6 克, 日 2-3 次。其源于麻附细梅参甘草汤 (《塘甩文集》2 页), 原方组成: 麻黄、附子、细辛、乌梅、人参、炙甘草。李可指出, 现代人体多虚, 风寒湿为害十之八九, 实热证百分之一二, 万病皆本气自病。由此而引申出一条重要原则, 一切外感必夹内伤, 因此, 麻黄汤、银翘散、白虎汤绝不可用, 唯**此方可通治一切外感**, 因为它在开表闭的同时, 以固本气为主, 属于扶正托邪法 (2 页)。

2.3 李氏培元固本丸治糖尿病

钟某, 男, 46 岁。某企业厂长, 患糖尿病 3 年, 就诊前血糖一直用西药维持在 7.2-8.2 之间。近年来消瘦, 倦怠乏力, 就想躺着, 眼花 (上网不能超过半小时)、心慌、早泄, 大便溏, 尿频, 且有很重的臊味。寻求中医诊治, 以改 9 长期以来的虚弱证状。遂予五味培元固本丸, 初服 1.5 克, 日 2 次, 一周后改为 3 克, 日 2 次, 服一个月。二诊: 空腹血糖 6.2。服药一周, 大便成形, 随后倦怠乏力大减, 有精神头了, 也不想躺着了, 眼亦不花, 早泄已去七八, 很重的尿臊味亦没了, 令患者信心倍增, 继服上方一个月。三诊: 疗效稳定, 守方常服。四诊: 进入冬季便溏又作, 下肢亦凉, 予李氏培元固本丸 (即五味培元固本丸加附子, 炙甘草) 6 克, 日 2 次, 服一个月。五诊: 服药一周时, 大便即成形, 腿亦渐暖, 继服李氏培元固本丸至今。

按 **五味培元固本丸**, 每次 3 克, 日 2 次; 其源于五味培元固本散 (364 页), 原方组成: 鹿茸 50g, 紫河车 1 具, 高丽参 50g, 三七 100g, 琥珀 50g。李氏培元固本丸, 每次 6 克, 日 2 次; 其源于**五味培元固本散加附子、炙甘草**。笔者是从 2006 年开始试服五味培元固本散, 十月份以前服, 效果一直都挺好的。一进入冬季, 就有点力不从心了, 加了附子得效, 说明培元固本散治虚不治寒。经李可加附子、炙甘草大大增加了主治范围。笔者用李氏培元固本丸主要用于改善糖尿病的脾肾虚损证状。如一例糖尿病是 60 岁的老太太, 一进诊室就躺在床上, 连眼皮都不想睁, 说话只能说半句, 可见虚到什么程度了, 服药一周后即能上商业城给老伴买东西了。这对糖尿病患者来说, 是一个了不起的质的飞跃, 他们就象成“瘾”一样, 到月就来开药, 说明培元固本丸很值得玩味。

2.4 李氏偏正头风丸治风心病

刘某, 女, 45 岁。病史: 风心病, 二尖瓣狭窄, 闭锁不全, 心衰 II 度, 肺瘀血已 5 年。一周前因感冒发热恶寒、无汗, 体温 39℃, 住院 4 日仍不缓解。邀余会诊。刻诊心悸气喘, 咳痰带血, 眼睑、下肢浮肿, 胸闷刺痛, 四肢厥冷, 唇、指、舌肯紫, 夜不能左侧卧, 否则呛咳喘悸不停。脉促, 畏惧汤药。诊为寒湿之邪伏匿三阴, 扶正透邪开表, 予以李氏偏正头风丸加麻黄颗粒 3 袋 (即 18 克) 透邪开表, 合李氏破格救心丸回阳逐寒, 服了 3 天药, 日 3 夜一服。二诊: 当日服药 1 次, 半小时后, 头部见汗, 咳喘顿减。2 小时后, 又服药 1 次, 全身得畅汗, 小便大增, 肿消大半, 身痛顿减, 上方去麻黄, 继服 3 日。三诊: 感冒、浮肿痊愈

出院。

按 **李氏偏正头风丸**，每次 3-4 克，日 2-3 次。其源于李可重订之偏正头风散（343 页），原方组成从略。笔者 8 治一例关节炎兼咳喘之病人，仅以李氏偏正头风丸先治关节痛，没想到咳嗽亦好了，从此悟出亦可用于外感，故用它治风心病之咳、喘、肿、痛。

2.5 李氏四逆丸治便秘

高某，女，80 岁。平时血压高，用西药维持。常年秘结，褐色便，口干、不渴、腿脚凉。服便秘王、番泻叶，则腹痛，大便泻下不止。有一次旅游住宾馆，因便秘而把便池堵住了，不得不找来服务员疏通，令老人十分尴尬。舌淡苔内滑，脉沉弦。予以李氏四逆丸 8 克，日 2 次。二诊：服药 3 天时，大便呈黄色，大便不干不稀，排得痛快，这是多年来从未有过的。继服一周。三诊：口不干，大便畅，守方常服。

按 **李氏四逆丸**，每次 6-9 克，日 2-3 次。其源于咽痛兼齿衄案（289 页）。原方组成：炙甘草 60g，附子、干姜各 30g，红参 10g，肾四味各 30g。说起李氏四逆丸治便秘，还有一个小插曲。有一位老干部，今年 84 岁了，因夜间口干兼便秘就诊。刻诊舌略胖苔内腻，脉微细。诊为脾肾虚寒，不能蒸化津液。先治口干，予以李氏四逆丸，服药一周，不但口干好了，连便秘亦治好了。这令我十分惊讶，因为《伤寒论》里反复说四逆汤治泻下、下利清谷，却只字未提有通便作用。我猛然想起李可在《论肿瘤的治疗思路》中指出肿瘤形成的主病机是阳虚寒凝，若下焦寒凝者单用四逆汤就有攻下的效果，因为四逆汤犹如一闭火，有破阴通阳之能，雷霆万钧之力（《北京扶阳论坛讲稿》）。而《医法圆通》中四逆汤、《伤寒论类方汇参》中四逆汤都没有攻下、通便作用，这应当说是李可的创见。

2.6 李可青龙丸治支气管扩张

朱某，男，36 岁，农民。患支气管张 8 年，平时反复感冒，咳喘，吐脓块，腥臭，只要一哈腰，就可以从嗓子流出脓痰来。3 天前感冒，胸痛，体温 38.7℃。经大剂量青链霉素静滴，病不缓解。胸部平片，右肺有条状阴影。刻诊仍颜面潮红，舌暗略胖苔腻，中根略黄，脉滑稍数。证属元阳久虚，外寒内饮，化热入里，予以李氏青龙丸 8 克，加石膏颗粒 30 克，日 3 次。二诊：服药 3 天，周身得微汗，热退，咳、喘、痰减半，上方去石膏，加苇茎汤颗粒剂。三诊：服药一周，痰少质稀，能从事体力劳动。予培元固本丸常服，修复受损脏器。

按 **李氏青龙丸**，每次 6-9 克，日 2-3 次。其源于李可之改良小青龙汤（397 页），原方组成：麻黄、桂枝、赤芍、炙草各 10g，生半夏 30g，干姜、五味子、细辛、白芥子各 10g，炙冬花、炙紫苑各 12g，带壳内果 20g，红参 10g，肾四味各 20g，附子 30g，生姜 10 片，大枣 10 枚。此患者只要稍微弯腰，脓痰就从嗓子甩淌出来，可见痰多到何等地步。本想做手术，但西医大夫告诉他：你整个肺纹

理都乱了，没法做手术。为了修复受损之肺脏，故以培元固本丸长服。

2.7 李氏乌头丸治颈椎病

付某，女 55 岁。左脸麻木，左手拇指、食指麻木，左肩不能上抬展。X 片提示：颈 1.2.3 椎唇形增生，肩甲骨增厚。阴雨天颈、背、肩有酸麻感。曾服骨质增生丸、颈复康等多种药物无效。证属精血亏虚，络脉失养，复受风寒，留而成痹。予以李氏乌头丸 8 克，日服 3 次，服 1 周。二诊：肩膀松快，手麻轻减。余证同前，继服上方二周。三诊：肩能上抬，手麻已退六七，左脸之嘴角感觉轻松。上方加止痉丸 6 克。四诊：肩能外展，左脸麻减半，守方继服。

按 **李氏乌头丸**，每次 6-9 克，日 2 次。其源于类风湿性关节炎合并硬皮病案（208 页），原方组成：生芪 100g，川乌、附子、活络效灵丹、白芍、黑豆、乌蛇肉各 30g，蜂蜜 120g，桂枝、防风、全虫、甘单各 15g，蜈蚣 30 条，豹骨 15g。此方即乌头汤、补阳还五汤、桂枝汤、活络效灵丹、止痉散合方化裁，可用于类风湿、颈椎病。

2.8 李氏金匱肾气丸治丑时燥热

赵某，男，84 岁。自冬至以来，每至半夜 2 点，后背燥热难耐，约 1 小时，刻诊腰酸乏力，睡眠多醒，眼干涩，小便频，大便调。舌绛无苔，脉洪大。证属阴损及阳，火不归原，予以李氏金匱肾气丸 8 克，日 2 次，服药 1 周。二诊：后背燥热减半，余证同前。继服上方。三诊：后背不热，腰酸、目干减轻，守方常服。

按李氏金匱肾气丸，每次 6-9 克，日 2-3 次。其源于真寒假热案（288 页），原方组成：附子、熟地、山药、山萸肉各 30g，茯苓、泽泻各 12g，五味子 10g，肉桂 1.5g。

2.9 李氏附子理中丸治慢性结肠炎

孙某，女。8 岁。患慢性结肠炎 6 年，其病起于工作环境，她是急诊室副主任。该院急诊室位于门诊楼东端，而东端的走廊门一年四季都是敞开的。素有腹泻之疾，复加风寒侵袭，郁久化热成痢，便脓带血，经用清热解毒中药百余剂，病情虚化，食少纳呆，痢下日夜无度，体重锐减，面色萎黄，鱼肉蛋不敢粘唇，仅以米粥咸菜度日，手脚凉。余接诊时，患者仍用清热解毒剂灌肠，不灌肠就有脓血。舌尖稍红苔白腻，脉沉细。遂拟李氏附子理中丸 8 克，日 2 次。二诊：服药 1 周，知饥，矢气有臭味，大便略成形，便脓血如前，继服上方。三诊：痢少血止，手足温阳气来复，病退十之八九，以培元 18 本丸收功。

按 **李氏附子理中丸**，每次 6-9 克，日 2-3 次。其源于李可之附子理中丸加味（《北京扶阳论坛讲稿》），原主组成：附子 30-90g，肉桂 10g，人参 30-60g，炒白术 30-60g，干姜 30-60g，炙甘草 30-90g，砂仁 30g，生半夏 30g。

2.10 李氏奔豚丸治高血压

逢某，男，45岁，农民，因腿冷8年就诊，经常洗热水澡，只能一时缓解。大便频，腰酸膝软。舌淡胖，苔白腻，脉虚弦。笔者建议测血压，结果BP155/105mmHg，心律111次/分。证属真阳亏虚，肾经有寒，遂予李氏奔豚丸8克，日2次，服1周。二诊：BP133/87mmHg，心律89次/分，大便调，腿冷如前，继服上方。三诊：下肢渐暖，守方长服。

按 **李氏奔豚丸**，每次6-9克，日2-3次。其源于阳虚型高血压案(383页)，原方组成：附子30g，肉桂10g，沉香10g，砂仁10g，山药30g，茯苓45g，泽泻30g，红参15g，怀牛膝30g，炙甘草30g，龙牡、磁石各30g。余之经验，高血压患者，约有一半腿冷脚凉。故一见此证，必测血压。

3 附子丸散的设计思路

凡危急重症服汤药，患者尚能接受；而对于常见病、疑难病、老年病，多数人是拒服汤药。特别是附子要久煎去毒，给医患双方带来心理压力。现代化商楼林立，如一家煎药，则全楼污染，会从楼道里不断传来“讨伐”声。于是患者就转向医院、诊所、药房的煎药机煎药，由于煎药机与经济效益挂钩，无论是浸泡时间、煎药时间及煎药遍数，都要大打折扣。真是良药苦水一碗，既难喝，又难煎，又难保证质量，就逼得你踏上了附子丸散的攻关之路。李可在论述破格救心汤、偏正头风散时呼吁：要组织科学研究，筛选主药，改革剂型，研制成高质量特效中药制剂(07、248页)。而笔者所研制的李氏附子丸散系列，就是这一剂型改革的初步尝试。下面就谈谈附子丸散的设计思路：

3.1 经方附子丸散的状况

《伤寒杂病论》共有乌附丸散方8首，其用法、乌附量归纳如下：

3.1.1 乌梅丸

其用法：药10味，异捣筛，合治之，以苦酒渍乌梅一宿，去核，蒸于五斗米下，饭熟捣成泥，和药令相得，内臼中，与蜜杵二千下，丸如梧桐子大，先食饮服10丸，日3次，稍加至20丸。其附子量：10丸梧子约2克，20丸梧子约4克；乌梅丸中附子占1/14，即： $2\text{克} \times 1/14 \approx 0.14\text{克}$ ， $4\text{克} \times 1/14 \approx 0.28\text{克}$ 。所以，初服10丸梧子含附子0.14克；加至20丸梧子含附子0.28克。

3.1.2 金匱肾气丸

其用法：药8味，末之，炼蜜为丸，如梧子大，酒下15丸，日再服。其附子量：15丸梧子约3克；金匱肾气丸中的附子占1/27，即 $3\text{克} \times 1/27 \approx 0.11\text{克}$ 。所以，金匱肾气丸每次含附子0.11克。

3.1.3 天雄散

其用法：药4味，杵为散，酒服半钱匕，日3服。不知，稍增之。其天雄量：半钱匕为0.75克，天雄散中的天雄占3/20，即 $0.75\text{克} \times 3/20 \approx 0.11\text{克}$ 。所以，

天雄散每次含天雄 0.16 克。

3.1.4 薏苡附子散

其用法：药 2 味，杵为散，服方寸匕，日 3 服。其附子量：1 方寸匕为 3 克；薏苡附子散中的附子占 10/19，即： $3 \text{ 克} \times 10/19 \approx 1.57 \text{ 克}$ 。所以，薏苡附子散每次含附子 1.57 克。

3.1.5 薏苡附子败酱散

其用法：药 3 味，杵为散，服方寸匕，以水二升，煎减半，顿服，小便当下。其附子量：1 方寸匕为 3 克；薏苡附子败酱散中的附子占 2/17，即： $3 \text{ 克} \times 2/17 \approx 0.35 \text{ 克}$ 。所以，薏苡附子散每次含附子 0.35 克。

3.1.6 乌头赤石脂丸

其用法：药 5 味，末之，蜜丸如梧子大，先含服 1 丸，日 3 丸，不知，稍加服。其乌附量：1 梧子约 0.2 克；乌头赤石脂丸中乌头占 1/15，附子占 2/15，即： $0.2 \text{ 克} \times 1/15 \approx 0.01 \text{ 克}$ 。所以，乌头赤石脂丸每次含乌头 0.01 克，附子 0.02 克。

3.1.7 赤丸

其用法：药 4 味，末之，内真朱为色，炼蜜丸如麻子大，先食酒饮下 3 丸；不知，稍增之，以知为度。其乌头进：3 麻子约 0.05 克；赤丸中的乌头占 2/11；即 $0.05 \text{ 克} \times 2/11 \approx 0.01 \text{ 克}$ 。所以，赤丸每次含乌头 0.01 克。

3.1.8 四逆散

其用法：药 4 味，各 10 分，捣筛，白饮和服方寸匕，日 3 服，腹中痛者，加制附子 1 枚（约合 4 分、捣筛，白饮和服方寸匕。其附子量：1 方寸匕为 3 克；四逆散加味方中的附子占 1/11，即： $3 \text{ 克} \times 1/11 \approx 0.27 \text{ 克}$ 。所以，四逆散加味方每次含附子 0.27 克。

笔者考经方九散之乌头、附子、天雄均为炮制，乌附丸散之最大量为薏苡附子散，主治重症胸痹，每次制附子 1.57 克，日 3 服。

3.2 附子丸散的基础方

笔者以李可子附子剂为设计丸散的基础方，如破格救心汤、麻细梅参汤、培元固本散等。关于附子丸散以李氏命名，均出于以下考虑：

- ① 李可自制方：如破格救心汤；
- ② 李可制定量：如温氏奔豚汤原方无剂最，由他拟定剂量；
- ③ 李可修订量：如偏正头风散，由他重新修订；
- ④ 李可改良方：如乌头汤，由他加防风、黑豆、甘草进行改良；
- ⑤ 李可加减方：如小青龙汤，经他加冬花、紫苑、白芥、白果等。

3.3 附子丸散的基础有效量

李可首创经方基础有效量概念，如附子治隐性心衰的基础有效最为 30g（平剂），治亡阳的基础有效量为 100 克（中剂），治垂死心衰的基础有效量该为 200 克以上（大剂）。那么仿效他的思路，附子丸散（即附子小剂）的基础有效量是多少呢？笔者研发的李氏水丸近 10 种，经历半年多的临床实践，而每种药都自己先尝 1 周、半月、1 月不等，采取单服附子粉与附子剂两种形式，体验附子的疗效、毒性及副作用（即制附子直接磨粉，不必高压去毒），还用日本松下电子血压计记录用药前后的血压、脉搏变化。结果发现：当丸散每次含附子 2 克时，就会出现头、胸、四肢等周身紧束感，持续时间为 1-3 小时；当每次含附子 2.5 克时，就会出现身麻触电感、肌肉跳动感，持续时间为 1 小时。从中可以看出周身紧束感是身麻触电感的前兆，虽不舒服，尚能忍受。而身麻触电感会让人感到恐慌，甚至六神无主。对于急危重症，用大剂附子而出现身麻触电感是瞑眩、排毒反应的表现。但治常见病、疑难病、老年病，附子丸散往往需要久服，所以周身紧束感也要避免出现。经过反复摸索，当附子每次用至 1.5 克时，既治病有佳效，又可避免出现周身紧束感。**故把 1.5 克附子定为附子丸散的基础有效运。**

笔者运用附子丸散基础有效量的体会：

① 附子丸散基础有效量是临床常用量：每月约有近百人服附子水丸，均以附子 1.5 克为常用量，服用一周后，十有八九有效。

② 附子丸散基础有效量是临床起始量：还有十分之一二无效或小效，则从第二周加至 2 克，往往起效；仍效不理想者，则从第二周加至 2.5 克，逐周增加下去。如一例便溏兼阳痿患者，初以附子丸散基础有效虽服用一周，便溏缓解，而阳痿仅有小效，则从第二周加至 2 克，仍不满意，继加至 2.5 克时方可。

3.4 附子丸散的改良

所谓“改良”，是在原方疗效不变的前提下，对其不安全因素及副作用采取有效措施。如附子理中丸是补火生土之名方，笔者经常开北京同仁堂的附子理中丸。但在临床中发现，其治脾肾两虚之泻泄时，头 3 天有效，大便随即成形。但继服则大便涩滞、艰难。用患者的话说：吃 7 附子理中丸，大便是干了，但更费劲了，痔疮也犯了，还不如大便稀时痛快。它还有牙痛，咽疼、脸上起疙瘩等不足，这说明附子理中丸有壅滞、涩肠、升火等问题，应当进行改良。根据李可经验，加砂、半，因砂仁纳气归肾，生半 3 开气通便，可补其不足。或附子理中丸加五灵脂，因笔者用参灵散（红参、五灵脂）治一例胃溃疡兼便秘，不但胃溃疡好了，连便秘如羊矢之顽症也治好了。从中悟出参灵散亦治便秘，故用之改良。

3.5 附子丸散的变通

运用附子丸散，可根据病情灵活化裁。如一例慢性肾炎，以蛋白尿为主证，一方面用李氏破格救心丸温肾敛固，另一方面加麻黄、细辛颗粒透邪（或散剂）；

一例胆汁返流性胃炎，其整体属脾肾阳虚用李氏附子理中丸，局部苦、反酸属胆气上逆，加吴茱萸、黄连颗粒辛开苦降（或散剂）；一例风心病兼外感、浮肿，一方面以李氏偏正头风丸加麻黄颗粒开表透邪，一方面以李氏破格救心丸治心衰，均取得初步的效果。

3.6 附子丸敢的禁忌

由于附子是毒药，用之不得不谨慎：

① 过敏体质慎用：如一例冠心病，初治以李氏破格救心丸 8 克，服后 10 分钟即嘴麻、头胀、胸闷、身热，就赶忙给我打电话，经询问得知：有索密痛过敏史，打农药曾脸肿等，遂减为半量则安。故过敏体质者，开始附子以半克、无不良反应再加量。笔者开附子丸剂打个习惯，都给患者留下电话号码，一旦出现异常，好电话及时指导。经临床半年多来，曾有过五六起过敏的，均妥善处理。

② 心动过缓者慎用：由于在使用附子丸散的过程中，一直以日本松下电子血压计监控，结果发现李氏附子丸散均有减慢心律每分钟 10 次左右的作用，实际上单服附子粉也有这样的效果。这还有待于进一步验证与研究解决它的办法。

③ 附子对胃有刺激作用：口服附子粉，会有刺舌感。服用附子水丸，时而胃有烧灼感，有一患者说：就像口烧酒进肚，热乎乎的。遇到这样的患者，可以改用芝麻糊送服。

4 附子大、小剂各有千秋，两条腿走路普及李可效方

4.1 治急危重症，附子大剂能起死回生

《人体阳气与疾病》说的好：打开棺材治好病——起死回生，这么一句有才的话，用在李可身上再贴切不过了。只要是重症心衰的病人往他那一放，您就等着带个大活人回去吧！50 年的行医生活，几乎每一个送到他这的病人都是被两医放弃的。李可常常给一个病人一付药用到 200 克以上的附子，最多用到 750 克，将上万例病人从急危重症中给抢了回来。中医的毒不是绝对意义上的，附子用错了，它能杀人，用对了，那是救命的仙丹（7 页）。

4.2 治常见病、疑难症，附子小剂可妙手回春

由于李可忙于在中医大战役中做贡献，已无暇顾及附子小剂量问题了。但他关于小剂四逆汤、金匱肾气丸、药王续命散的论述，指明了附子丸散的思路，而剩下的具体问题，应当由我们这些弟子来完成。笔者应用附子丸散仅有半年的光景，虽然时间不长，也有让人感动不已的经历。

腿冷鼻红赤 邓某，男，49 岁。他是县长，腿冷脚凉，每到冬天就加重，冷从骨头里透发出来，使得夜寝不安。经常噪子痛，近半年之内因咽后壁滤泡增生动过两次手术，仍不缓解。鼻红赤已 8 年，即酒渣鼻，连及口唇周围一圈亦红赤，伴有豆大丘疹。腰酸乏力，大便溏。舌胖略暗苔滑，脉沉细。纵现见证，腿脚凉

者，肾经有寒；腰酸，肾将惫也；倦怠乏力，大溏，太阴不运也。遂予李氏四逆丸温太少二经，祛逐阴寒，服半月药。二诊：因工作忙，由秘书来取药，服药3天即大便成形，一周后脚不冻，继服半月。三诊：患者亲自来，腿冷已去七八，嗓子亦不干痛了，更没想到的是鼻尖、口唇一圈红赤亦了无痕迹了。守方常服善后。

按 初治，只针对腿冷、便溏治以李氏四逆丸。至于酒渣鼻，误以为是不可逆的，所以连想都没敢想它。结果一个月后竟然不见了，令我十分震惊。事后揣摩：鼻赤、口唇红，若因胃火旺者，必烦渴饮冷，二便闭结等。此患者因长期便溏，从不敢吃生冷东西，腿冷脚凉，明是阴盛格阳于外之证。咽干痛，亦是少阴受寒逼出真火浮于喉间。李氏四逆丸能祛逐阴寒，迎阳归舍，故诸证均愈。

便血找水丸 迟某，男，38岁。今年4月24日中午下班时刻，一个陌生人给我电话，让我等他一会儿。没过5分钟，他就骑着摩托车来了。原来他看朋友吃水丸治好了拉肚子，就向朋友借了1袋水丸（7天量）。3年前，患者经肠镜确诊为慢性结肠炎，平时大便先稀，兼夹频频矢气，中间是大便硬球，最后便下蛋黄大一堆血，经多方诊治无效。结果就抱着试一试的态度吃了水丸，当服到第3天的时候，大便成形，频频矢气亦无。第4天的时候，便血就止住了。有了这么好使的药，一定要多买些，于是就找到了我。它是李氏附子水丸系列之一，这是什么药呢？

便秘胀欲死 李某，女，70岁。素有胃下垂病史，3年前胃下垂掉入盆腔，去葫芦岛医治。其治法先把患者四肢捆上（防止乱动），然后反复推按小腹，待胃下垂上升时，用长针把它挑上去，再用宽绷带缠住脐腹，3个月后才能解开绷带。这只解决了胃下垂掉入盆腔问题，胃下垂并未治愈。长期便秘，1周1次，服芦荟、番泻叶则泄泻不止。半月前，突然呕吐、大便不通，腹胀急欲死，做肠镜提示结肠存3处梗阻，先后洗肠2次，仍未通，令患者惊恐不已，遂求中医诊治。立夏已暖，仍穿棉衣。饭后胃胀，卧则缓解。舌暗苔滑腻，脉虚弦。证属太少二经阴寒，兼大气下陷。予以李氏四逆丸8克，日3次。二诊：服药后20分钟，即出现身麻触电感，随即就给我打电话，我就安慰她：这是药物反应，打通经络，驱除寒气，过几天就消失了。服至第4天，大便就通了，不干不稀，这是多年来从未有过的，第5天、6天，天天便，给她乐坏了，就手舞足蹈地给儿女们报信，结果乐极生悲，跌了一跤，经拍片检查无大碍。她一进诊室就说我：真是神医啊！

每当遇到这妙手回春的例子，我总要激动好一阵子，中医的宝藏真是太多广，就看你会不会挖掘。

4.3 两条腿走路，深入挖掘李可效方

邢斌在《急症难病倚附子》中指出：附子小剂则仅用0.3克，超大量用到600克。竟然相差2000倍，如此大的差异，恐怕是所有药物中绝无仅有的。而个

中缘由，殊难理解，这若实是一个令人困惑的问题（29、31 页）。由此我又联想到附子的名方——四逆汤，《医法圆通》里四逆汤能治 23 种病，《伤寒论类方汇参》里四逆汤能治 27 种病。李可还用它治再降、白血病、干燥综合症、高血压、肿瘤等。郑钦安说：知其要者，四逆汤可治数打种病。这其中的奥妙也是很难解释的。笔者揣测其缘由：阳虚生百病，因附子补阳，故附子能通治百病，尤其是附子有原于弹样的作用，它大有大的威慑一能起死回生，小有小的奇效——可妙手回春。我在县城坐诊，每次给患者开一周附子丸剂，只需 80 元左右，参加医保的农民还能报销 15%，服至 3-5 天即可见效，真可谓简便、速效、廉价，深受病家的欢迎，才演绎出“便血借药找水丸”的故事。

总之，治急危重症，附子大剂能起死回生；治常见病、疑难症，附子小剂可妙手回春。我们应当两条腿走路，深入挖掘李可效方，造福于平民百姓。

内伤热证温引敛

——李可学术思想探讨之十八

摘要 笔者在《热病急病汗清下》一文中，探讨了李可治外感热病不用后世温病方，“师仲景，遵六经，汗清下，统温病；承气汤，融解毒，创新方，探新径”，取得了令人瞩目的成就。对于内伤热证，自朱丹溪创“阳有余阴不足论”，近代中医皆宗丹溪之旨，从“阴虚火旺”立论，滋阴、清热、降火定法。李可对内伤热证理论进行痛苦的反思，感悟出深刻的道理。现根据其数则医案，整理出以下内容：

1 内伤热证的经验

1.1 五志之火，疏气降气

李可认为，情志为病，忧思郁怒。气有余便是火，五志过激化火，非同实火，宜疏、宜降，气降火即降，不宜清。火盛灼阴，养阴配阳（333、363 页）。

常用方药 疏肝解郁，逍遥散，降气加赭石 30 克（230、333 页）；养阴配阳，一树煎、二至丸（120、320 页）。

乳衄 刘某，女，44 岁。乳衄 2 月余，由生闷气渐致两肋窜病，右乳结核如胡桃大，乳头溢出鲜血。每适经期，必头眩泛呕，血黑多块。常觉有一股热流从右肋下章门穴向乳房涌来，立即灼痛如针刺状，随即有鲜血溢出，轰热自汗，左侧亦有同感。每月经行 2 次，经量少则乳头出血必多。舌红无苔口苦，脉沉弦

而数。脉证合参，必是七情内伤，肝气久郁化火。今见一旦动气，病必发作，明是木强侮土。疏泄太过，则肝不藏血；脾胃过弱，则不能统血。治法拟养脾胃之阴，清金制木而解胃之围，兼柔肝之体而敛其用：醋柴胡 10g，当归、白芍、生地、石斛、沙参、枸杞、山萸肉、乌梅各 30g，麦冬 15g，川楝子 10g，三仙炭各 12g，丹皮、黑栀子、炙草各 10g，3 剂。二诊：药后块消血止，但增多腹胀如孕状，视之，少收鼓凸。神倦、腰困膝冷，舌红无苔，脉沉，右寸极弱。遂改投大剂补中益气汤升提下陷，加肾四味温养肾命：生芪 60g，当归、白术各 20g，红参（另炖）、灵脂、炙草、三仙炭、柴胡、升麻、桔梗各 10g，陈皮 3g，肾四味 20g，鲜姜 10 片，枣 10 枚，胡桃 4 枚（打）。患者连服 9 剂，已痊愈，且腰困、经乱亦愈（120 页）。

李按 初诊见患者口苦舌红，遂用大剂养胃汤之甘寒，丹栀之苦寒，致损中下之阳，中气随之下陷，故有此变，医之罪也。情志之火，非同实火，宜疏、宜降，气降火即降，不宜清。且前贤曹炳章氏谓“舌红非常并非火”，“非常”二字，当细细咀嚼。

1.2 血热妄行，降气抑火

李可认为，若胃失和降，则诸经皆不降，气逆而为火，血热妄行，血从上溢则病吐衄（nù）。证见面赤气粗，口苦苔黄，脉象数实。此时急以旋覆赭石汤加炙枇杷叶 30 克，降肺胃之气。不可一味苦寒清火，应以顾护胃气为要。血证初期，亦见肝不藏血，血热妄行。证见血上溢或下出，势急量多，面赤气粗，暴躁易怒，头晕胁痛，口苦脉弦数，以丹栀逍遥散舒肝之郁，炙枇杷叶 30 克清金制木；生地、阿胶滋水涵木，凉血养血，止血柔肝、赭石降气抑火平木（126 页）。

常用方药 降肺胃之气，旋覆赭石汤，加炙枇杷叶 30 克；降胃止呕，双呕汤（吴茱萸、红参、生半夏、赭石、茯苓、姜汁、生姜、炙甘草、疏肝降气抑火，丹栀逍遥散，加炙枇杷叶、赭石各 30 克，二七粉 6 克 吞服 05、126 页）。

肺结核大咯血 费某，男，36 岁。患肺结核 10 年，3 年来不断发生大口咯血，频咳不止，胸痛，神疲，住院 7 日，未能控制。每次大咯血约 200 毫升，现仍频频咳喘，面赤气粗，胸痛彻背，脉洪大，舌红尖赤，边有瘀斑。每次犯病，即用针剂止血。但降其气，气降则火降，血自归经。血证不可一味兜涩，于止血之中行瘀、化瘀：旋覆花 12g（包）、代赭石 30g，瓜蒌 30g，薤白 15g，生半夏 30g，姜汁 1 盅（兑），丹参 30g，檀降香各 10g，炙枇杷叶 30g，桃杏仁各 15g，甘草 10g，童便、韭汁各 30 毫升兑入，“三七 5g、白芨 10g”研粉点糊加红白糖服，3 剂。二诊：血止，病象显露，面色苍白少华，拟培元固本散善后（310 页）。

按患者肺胃气逆，血热妄行，咯血不止，以旋覆代赭汤加炙枇杷叶，但降其气，气降则火降。又每次犯病，即用针剂止血，血虽暂止，胸膈积瘀已甚，证见胸痛彻背，舌有瘀斑，故用瓜蒌薤白合丹参饮加味，于行血之中行瘀，以免后患。

1.3 肝阳上亢，浊阴不降

清末、民国初，中西汇通派认为高血压、中风均属于“肝阳上亢”，最著名的就是张锡纯之“镇肝熄风汤”。李可认为，高血压及中风，其根本点就在于先天阳虚，清阳不升，浊阴不降，痰湿瘀浊踞阳位（44 页）。

常用方药 藏阳，四逆汤或潜阳丹；镇冲，温氏奔豚汤加龙牡、磁石、煅紫石英；透邪，麻附细、大小续命汤；引导，引火汤（44 页）。

阳虚型高血压兼肥胖病 胡某，女，46 岁，1979 年 10 月 31 日，突然昏厥邀诊，至则已醒，心有余悸，甚为恐惧。询之，患肾性高血压已 5 年。低压常在 110~120 毫米汞柱之间，曾服镇肝熄风汤、羚羊钩藤汤近百剂，不仅无效，反增食少便溏。近 3 年异常发胖，头晕畏寒，呕逆腹胀，足膝冰冷。近 1 月服羚羊粉后，常觉有一股冷气从脐下上冲，冲至咽喉部，人即昏厥。约三五日发作 1 次。其眩晕如腾云驾雾，足下如踏棉絮，越胖越觉无力。腰困如折，小便余沥，咳则遗尿，时时有咸味之痰涎上雍。常起口疮，头面又觉轰轰发热，每日中午面赤如醉。舌淡胖，苔白腻，脉洪不任按，久按反觉微细如丝。脉证合参，乃清阳不升，浊阴不降，下寒足真，上热是假。复加误用寒剂，更损元阳，阴盛于下，逼浮阳上越，故见上热假象：予温氏奔豚汤：附子 30g，加吴茱萸 15g，肾四味 60g，生龙骨、生牡蛎、活磁石、紫石英（煅）、山萸肉各 30g，益火之原，以消阴翳。上药加冷水 1500ml，文火煮取 600ml，日 3 服，3 剂。二诊：患者在无人陪侍下坐班车来门诊。主诉：服药 3 剂，每天小便很多，全身舒适，头不晕，脚底再不飘浮欲倒，腹中觉暖，再无冷气上攻，心中也不觉怕了。每天服药后，腹中阵阵响动，矢气极多，惹得孩子们哄堂大笑，几年肚胀，一下子松宽许多。药已中病，嘱守方再服 10 剂。三诊：其夫特来门诊告知，诸症均愈。舒张压保持在 80~90 毫米汞柱，已正常上班。最奇的是服药后尿特别多，10 多天功夫，腰围瘦了 1 寸多（383 页）。

李按 本案证属命火衰微，不主温煦，故怯寒肢冷；火不生土，中阳不运，故见食少便溏。诸阴失阳之统摄，故上则饮逆头眩，挟冲气上冲，下则尿多不禁。异常肥胖亦属阴盛阳衰，与寒湿停聚同理。复加误用寒剂，更损元阳，阴盛于下，逼浮阳上越，故见上热假象。予温氏奔豚汤加味，因呕吐加吴茱萸，腰困如折，加肾四味，时发昏厥，加山萸肉固脱，服药近半月，诸症均愈，低压亦维持在 80~90mmHg。

1.4 气虚发热，土不伏火

气虚发热，多见食少便溏，消瘦潮热，面色萎黄等。李可认为，《内经》中“阴虚生内热”，这“阴”指足太阴脾脏，土壤不能敛火，虚阳外散，当温之敛之，“甘温除热”是也。而明初张景岳则是个折中派，他提出“阳非有余，阴常不足”论，强调了“阳虚多寒，宜补而兼温；阴虚有热，宜补而兼清。”试想脾阳虚的发热（气虚发热）怎么可以用“清热滋阴”？甚至是沾唇必殆（181 页）。

常用方药 甘温敛固，补中益气汤加龙牡、山萸肉、乌梅各 30 克，焦三仙各 15 克（396 页）。

丁奚疳重症 李某，男，7 岁。1975 年 4 月 5 日初诊。出生后断脐不洁，致成烂脐（脐疝），久治不愈。且因过用祛湿解毒之剂数十剂，遂致食少腹胀，肚大筋青，便溏，四肢枯细，头大脖颈细，面色萎黄，毛发枯焦，皮肤干瘪，满脸皱纹，如小老头状。四肢不温，脐突，中心湿烂流黄水，味臭，午后潮热，唇指苍白，脉数无力，舌淡白无华，已成疳积重症。此症，由过用苦寒伤中，致中气下陷，湿热不化而致。法宜下病上取，内服补中益气汤：生芪 60 克，当归，苍白术、炙草各 10 克，红参（另炖）、柴胡、升麻、姜炭各 6 克，生苡仁 30 克。鲜生姜 3 片，枣 6 枚，5 剂；外敷化腐生肌敛疮之品：五花龙骨、枯矾、无名异各 10 克制粉，每日以盐椒水洗净干掺，纱布包扎。二诊：药后 7 年痼疾已痊愈，无丝毫痕迹。予培补脾肾方：全河车 1 具，红参、三七、内金、炒二芽各 30 克，共研细粉 1.5 克，2 次 7 日。追访至 1983 年底，病孩 13 岁，已上 4 年级，体质增强，与健康小儿无异（85 页）。

李按 “丁奚疳”指小儿疳积，骨瘦如柴，其形似“丁”之证。由脾肾虚损，气血衰颓，以致出现面色萎黄或苍白，低烧潮热，四肢细小，颈长露骨，尻臀无肉，腹胀脐突，以及食多吐逆，吐泻无度等症，为脾疳重症。本例病情更为严重，先以补中益气汤加龙牡、山萸肉、乌梅、焦三仙，服至潮热退净，能食易饥时增损培元同本傲 1 料可愈。治疳如治癆，有热莫清热，有蒸莫退蒸，保得脾胃健，何愁病不痊。

1.5 肺癆潮热，虚阳外散

李可认为，肺癆首先是损伤脾胃之气，然后耗散元阳，所以病人会不断地发热，而朱丹溪就认为这种病应该补“水”，就可以把那个“火”扑灭了，水火不就平衡了吗？其实这种治疗过程就是把丹气进一步损伤，最后连元气也保不住了，就是死亡（68 页）。

常用方药 甘温敛固，补中龙牡梅萸汤；救阳固脱，参附龙牡救逆汤（23、300 页）。

肺结核危症 刘某，女，22 岁。1979 年 5 月 23 日初诊：患干血癆 5 年多，经某医院诊为肺空洞型肺结核，病危出院，羸瘦脱形，四肢枯细，体重锐减 20 公斤。骨蒸潮热，昼夜不止半个。双颧艳若桃李，口苦，舌光红无苔而干，食少，干渴能饮，脉弦而数。古今医家，皆谓“癆”为阳火灼阴，火炎水竭，真阴销铄。尤以昼夜皆热为重阳无阴，当亟泻其阳，峻补其阴，乃选清骨散加龟板、黄芩、童便为治：龟、鳖甲（先煎）、地骨皮各 30g，知母 20g，银柴胡、胡黄连、秦艽、青蒿、黄芩、炙草各 3g，童便 1 杯兑入，水煎分 2 次服。次日黎明病情突变邀诊。见患者呢逆频频，大汗肢厥，面如死灰，喘不能言，脉微欲绝。其母云：“昨日药进一煎，患者即不思饮食。睡前服二煎，泻稀便一次，随即阵阵汗出，气喘

不能接续。半夜服参汤一杯，才勉强支持到天亮。”至此，余已知前方误投。盖患者虽在青年，但3年痼病，其阴阳气血已耗伤殆尽。初诊见其面苦桃李，艳若涂丹，误以为乃痼证必有征象，实则已是浮阳飞越之戴阳危象，当救阳固脱为先，反投清骨散，是为一错。胡连、骨皮、知母苦寒败坏胃阳，稀便一泄，气从下脱；银胡、秦艽、青蒿之辛寒外散，多汗亡阳于上，尤以鳖甲一物，开破肝气之力甚强，促使肝气外泄，故药后出现上下俱脱之危候。二错在对脉学的书本式理解，“数”面主火、主热，然当四诊合参，全面分析，方不致误。肺痈脉多数，濒危之际，有一分钟120~240次以上者，已是七急八败之死脉，何来“火”与“热”之可言！故数脉变局中有“数则为劳，数则为虚”两条。若非躬行实践，绝难领悟。遂急疏张锡纯氏来复汤合参附龙牡求逆汤，以救阳固脱：红参（捣末同煎）、附子各30g，干姜20g，炙草60g，山萸肉90g，龙牡、白芍各30g。从煎沸10分钟后，频频喂服，余守护病榻，以大艾柱灸神阙，药进5次，约200毫升，半小时许，呃止、汗敛、喘定、厥回，幸得脱险（299页）。

李按 这是我最痛苦的一个案例，打那以后余终生不用滋阴降火的套方。从中感悟出这所谓的潮热，那是一种“相火离位，土不伏火，元阳虚弱”。这么一种外散的表现，你从这个元阳角度去敛它，就可以把热敛住了。如果不在生死关头你是体会不到这一点的。所以说，你若没有亲身经历这一过程，就不可能去鉴别历史传承下来的几十万张方中，哪些是正确的，哪些是不正确的（71页）。

1.6 虚火上燔，火不归原

李可认为，肾中水火，共处一宅。水火相抱，阴平阳密。水足则火藏于下，温煦脏腑，统领一身气化，是为健康无病。若因外感内伤，致水亏于下，则火失其制，古人喻为水浅不养龙，于是离位上奔；肾水寒于下，逼真火浮游于上，亦可致火不归原之证。龙火上奔，多见种种上热见证，如头痛、头晕、耳痛、齿浮、齿衄、目赤如鸠、面赤如醉、心悸暴喘，耳鸣如潮、口舌生疮、咽痛如灼等（240页）。

常用方药 水浅不养龙，壮水敛火，导龙归海，引火汤：水寒不藏龙，温脏敛阳，引火归原，引火汤加油桂1.5克，饭丸先吞（241页）。

三叉神经痛 裴某，女，55岁。患原发性三叉神经经痛8年，迭用酒精封闭、针灸，服中药百剂皆无效。近年来发作频繁，因外受风寒，或大喜大怒，过度劳累，高声说话，咀嚼食物，洗脸刷牙，打呵欠，皆能触发。8年前仅下颌枝患病。2年之后累及上颌枝，去年冬眼枝亦病。以为龋齿作痛，牙已拔光，病势日见严重，以致不敢进食咀嚼，以流质食物维持不饿，致消瘦脱形，弱不禁风。此次发病已3日，病前无故右眼赤如鸠目，泪如泉涌，日夜不止，右耳鸣如潮声。今晨，因大声呼唤幼子起床，冷风拂面，突觉畏寒。同时觉有热气从右脚心沿腿之内侧上攻头面，迅如闪电，旋即整个右头部如蛇咬蝎蛰，火灼电击，剧痛嚎哭，惊扰四邻。每次发作约5分钟，频发30余次，已历3小时之久。诊脉洪大无伦，

舌干红无苔。头晕脚软，足膝冰冷，口干便燥，3~4日一行。拟傅山引火汤合芍药甘草汤大剂，滋阴敛阳，引火归原，柔肝缓急，以制雷火：熟地盐巴戟天、天麦冬各30g，茯苓15g，五味子6g，白芍100g，炙草30g，3剂。二诊：药后脚底上冲之气已敛，发病次数逐日减少。每有发作，一闪即过，已可耐受，洪脉已敛，目赤、耳鸣均愈。考虑多年痼疾，久痛入络，佐以虫类搜剔。原方加细辛15克，全蝎12只、蜈蚣2条研粉冲服。三诊：服1剂发作停止，已4日未发，全家人大喜过望。嘱原方再服3剂巩固。随访10年，未复发（240页）。

李按 本病为临床常见疑难病之一，各家多以风、寒、痰、火、瘀论治，或见效于一时，后必复发。盖本案患者年近五旬，肾气已衰，肾阴下夺，阴不恋阳，时值春令，阳气升发。脚底为肾经循行始发部位，龙雷之火之不能下安宅窟，循经上攻，上奔冲击无制，而成燎原之势，法宜大剂滋水，考虑多年痼疾，久病人络佐以虫类搜剔，更加细辛引入少阴而驱伏寒，兼离火郁发之意。

1.7 阴盛格阳，浮阳外越

李可认为，阴盛格阳为下焦阴寒独盛，格拒真阳不能回归宅窟而浮阳于外；戴阳为下元虚极，真阳不能下守，浮游于上。故见种种外热或上热假象（23、137页）。

常用方药 破阴回阳，四逆汤；破阴通阳，白通加人猪胆汤（187、298页）。

阴盛格阳证 赵某，女，29岁。因无故头面阵阵发热，服升阳散火汤1剂，变为心悸、气喘、自汗，头面烘热不止，而色嫩红，烦躁欲寐，足膝冰冷，多尿失禁，脉微细时急，120次/分。本属阴盛格阳，误作上焦郁火而投升散之剂，致有此变。幸在壮年，未致亡阳暴脱。予白通加人尿猪胆汁汤，破阴通阳为治：附子、干姜各30g，葱白3节，童便、猪胆汁各1杯对人，2剂。次日来告，七药服1剂，心悸喘汗均止，足膝已热，月余之烘热证亦罢。本病病机，为下焦阴寒独盛，格拒真阳不能回归宅窟而浮越于上，故见种种上热假象。以白通汤破阴通阳，因有假热在上，以人尿猪胆汁之苦咸寒为反佐，热因寒用，宣通上下，清除格拒，引浮越之阳归于下焦而病愈（187页）。

按 李氏在本案中指出，因有假热在上，以人尿猪胆汁之苦咸寒为反佐，热因寒用，宣通上下，消除格拒，引浮越之阳归于下焦。“引浮越之阳归于下焦”实际就是“引火归原”。

肺结核戴阳危证 英某，女，68岁。传染科住院病人，诊断：肺结核；肺气肿合并急性感染。经抗结核、抗菌治疗无效，请中医协治。李氏诊见双颊艳若桃花，双目神采外露，发热烦躁，咳喘月余。盗汗，渴喜热饮，双膝极冷，心动神摇，六脉细数无伦，心率132次/分，舌淡。患者年近古稀，肾元久虚，复加久病耗伤，过服清热凉剂，致成上盛下虚戴阳格局，有欲脱之虞。急急固肾敛肝，引火归原，纳气归根为治：山萸肉90g，红参（另炖）15g，龙牡、白芍各30g，炙草15g，油桂3g（米丸吞），附子30g。上药连服3剂，脱险，出院回家调养。

(23 页)。

李按 此戴阳为下元虚极，真阳不能下守，浮游于上，阴盛格阳之危候。又因过用秦艽鳖甲之类，开破肝气，致肝虚不敛。故用参附龙牡救逆汤合来复汤（山萸肉 90g，红参 15g，龙牡、白芍各 30g，炙草 15g），加油桂固摄下焦、温纳浮阳，重用山萸肉敛肝固脱。

1.8 足心发热，阴火沸腾

火神派始祖郑钦安，将浮阳外越与浮阳上越之假热统称为“阴火”。李可在其书中两次提及“阴火”，均指足心发热。如阴虚型红斑狼疮案中指出，患者 3 日来脚心涌泉穴热如火焚，夜卧非袒露双脚不能入寐，脉大不任重按。考虑病本则虚血寒，寒伤元阳，阳不统阴，致下焦阴火沸腾，列同浮阳外越，以加味四逆汤温而敛之（204 页）。

常用方药 温阳敛固，四逆汤（236 页）

足心发热怪症 刘某，女，33 岁，教师，1983 年 8 月 20 日初诊。足心发热 7 年，日夜不休，日轻夜重，内觉涌泉穴处呼呼往外冒火。不论冬夏，夜卧必把脚伸出被外，或踏于凉墙上始能入睡。曾多次求医，服滋阴补肾、滋阴降火以及清骨蒸劳热之剂百余剂，不效。又认为阳陷入阴，用升阳败火汤，反增头面轰热。诊视见面色嫩红，艳若桃李，阳浮于上显然。询其病史，因年久已不甚了然，似与产后失调有关。按脉细数，132 次/分。干渴，小便清长，饮一溲一，不存尿。中上脘处冷感，胃纳不馨。食入稍一受凉，即觉酸腐不适，双膝独冷。是宜补火之原，真火旺，阴火自安：炙草 60 克，干姜、附子各 30 克，冷水 1500 毫升，文火煮取 500 毫升，2 次分服剂。二诊：药后热势顿减，多年之双膝冷亦热，自诉多年来从未有如此舒适过，且食纳亦增。因在会议期间，不慎感觉脑冷，如风从脑壳吹入状，畏恶风寒特甚。筋惕肉瞤，皮下如虫行，脉反沉细。诸多见证，证属阳微：麻黄 10 克，附子 15 克，细辛 10 克，炙草 30 克，干姜 15 克，2 剂。药后又愈，临行特来致谢。嘱服金匱肾气丸 1 个月，以巩固疗效（236 页）。

李按 细思此症，乃阴阳盛衰之变。阴阳之道，阳为阴根。命门位居下焦，乃人身真火，气化之本原。此火一衰，火不生土，胃中水谷便无由蒸化，故见纳少化艰；人身津液赖此火之温煦，始能蒸腾于上，敷布于下，此火一衰，气化便弱，津液不能升腾，故口干；涌泉为足少阴肾经井穴，为肾气之所出。今下焦阳衰，不能统摄肾阴，而致阴火沸腾，自觉涌泉穴处呼呼往外冒火，夜卧必把脚伸出被外，踏于凉墙上始能入睡。

1.9 消渴燥热，假热真寒

李可认为，糖尿病在三阴，但统于太阴。过食肥甘对人体最大的影响是脾胃过劳（因肥甘厚味完全消化大约需要 5 小时，上一顿饭尚未代谢掉，下一顿又接

上，脾胃的工作时间过长），嗜食生冷直折脾阳。二者均可导致中气虚馁，随之脾气左升不利则中满，胃气右降不利则产生郁热。脾升不及则厥阴风木过度调动肾气助脾散精，表现出肝疏泄太过，风火相煽之消渴；肺胃降气不利出现中上二焦之假热（如面红如醉，午后更甚，头汗多），热象背后却是元气不归宅而上浮。升降左右两端均能造成下焦虚寒，中上生热的局面。故消渴者燥热为本，阳虚为本，其病机主脑（《北京扶阳论坛讲稿》）。

常用方药 引导，引火汤、附桂地黄汤；温敛，乌梅丸、封髓丹；运脾因肾敛肝，附子理中汤加砂仁、生半夏、白芍、山萸肉、油桂（《北京扶阳论坛讲稿》）。

虚寒型糖尿病 李某，男，52岁，1984年1月16日初诊。患糖尿病10个月，曾用胰岛累不能控制。消瘦，体重下降7公斤，乏力，脘痛而呕酸涎。厌食，以仅进食3~4两。饮多，日6热水瓶上下；尿多，日35~40次，几乎不能系裤带。畏寒甚，由平车拉来就诊。目赤气喘，头面烘热，脉右微细，左沉滑细。当日化验：尿糖（++++），血糖65毫克/分升。拟滋阴助阳，引火归原，纳气归肾：熟地90克（砂仁10克拌捣），盐巴戟肉、天麦冬各15克，茯苓15克，红参（另炖）、吴茱萸、五味子、炙甘草各10克，山药、山萸肉各30克，油桂1.5克（研吞），鲜生姜5片，大枣10枚，胡桃打4枚，3剂。二诊：胃痛呕逆、目赤气喘、头面烘热均愈，食纳已佳，饮水减至日1热水瓶，尿减少至日10次。脉较前有力，自己走来就诊。守方3剂。三诊：尿虽日7次，夜间不尿。日可进食0.5公斤之多，行动如常。舌红润，中有裂纹，脉沉滑。原方去吴茱萸，加生山药、生黄芪、枸杞各30克，猪胰脏10克（另煮熟，连汤带肉食之），10剂。四诊：今日化验尿糖（++），血糖37毫克/分升。上方加减调理月余，用猪胰脏40个。尿糖消失，血糖稍高，病情平稳，体重回升（55页）。

李按 证属肾之气阴两虚，阴损及阳。肾气不纳，故喘；肾气失于统束，膀胱失约故尿频不能系裤；肾阴虚。水浅不养龙雷，故见相火上奔，目赤烘热。命门衰微不主温煦，津液不能蒸腾上达，故饮多；釜底无火，故胃脘冷痛，厌食呕逆。治以人参胡桃汤纳气归肾，参萸敛元固肾，引火汤壮水敛火，油桂、巴戟、五味子温命火以生脾土，吴茱萸降逆止呕。3剂后，胃痛呕逆、目赤轰热、气喘等诸证均愈。

1.10 肿瘤发热，本寒标热

李可认为，肿瘤病见口渴烦热，恶热喜凉饮食，持续高热或低热不退等现象。此为假热或标热。这种假热源于真寒，因寒主收引，阻遏气机，气机升降出入受阻，郁而化热。尤其是高热或长期低烧，多为本寒标热。高热的出现，多为正气渐复，阴证化阳之佳兆，伏邪有望从阳明透发之机。若出现大热、大渴、大汗、脉大四症，可于附子剂中加石膏250克，冰炭同炉，热退即止，不可过剂（《北京扶阳论坛讲稿》）。

常用方药 温通，四逆汤，理中汤，当归四逆汤，麻黄附子细辛汤（《北京

扶阳论坛讲稿》)。

脑瘤积水高热不退 刘某，女，72岁。因神志淡漠10个月，高热20天入院。数月前无明显诱因出现左侧肢体乏力，神情淡漠，大小便失禁。CT提示：后颅窝占位性病变—脑膜瘤。行脑膜瘤切除术1后上症加重。又查CT，提示：脑积水。行右侧脑室—腹腔分流术。术后出现高热，中段尿培养提示肠球菌生长，痰培养提示耐药性葡萄球菌生长，以多种抗生素治疗，高热仍不退，全身重度浮肿，乃告病危，求中医协治。症见高热40.5℃，神昏，口噤唇焦，面色红赤，无汗，少尿，大便10日未解，偶有咳嗽。项强，全身高度水肿，四肢萎软无力，脉紧数而细。诊为阳虚水泛，阴寒冰结。治以回阳救逆，开表透邪，遂拟破格救心汤合麻黄附子细辛汤：制附子90g，炙甘草120g，山萸肉90g，白术30g，茯苓30g，红参30g（另炖），麻黄45g（另煎去沫），细辛15g，砂仁13g，龙牡各30g，磁石30g，生姜60g。日夜连服2剂。二诊：药后汗出，尿量增多，体温降至38℃，上方加五苓散。三诊：体温正常，守方继服。四诊：神清，肿消，尿量正常，大便略溏。治以破格救心汤加白术、砂仁、补骨脂等健脾厚肠。四诊：1个月后，又出现离热面赤，汗多，发热夜甚。邀李可会珍，症属阳气来复之佳兆，但邪伏少阴，未能尽透，方改为麻黄附子细辛、白通汤加减：制附子200g，麻黄10g，细辛45g，红参45g（另炖），炙甘草120g，葱白4寸，生姜45g。日夜连服3剂。五诊：发热轻减，时有发作，汗多，加肾四味固肾，黄芪250g，白术60g，甘温除热是也。六诊：发热退，神志清，能言语，四肢活动欠利，双手仅能握物，不能下地行走，下肢轻度浮肿，带药出院（78页）。

按 患者年已7旬，元阳渐衰。脑瘤积水，全身浮肿，神志昏愦，为阳气失用，浊阴踞阳位。面色红赤，高热不退，证闻阴证化阳之佳兆。但伏邪未尽，正虚不能一鼓作气而驱之，故以麻附细、白通汤温通。

2 内伤热证的治疗大法，温补、引导、敛固

李可治内伤热证10种，除五志之火、血热妄行外，其它均与温补，引导、敛固有关。总共涉及20首成方，含苦寒药仅3方，如丹栀逍遥散之丹、栀，封髓丹之黄柏，乌梅丸之连、柏，其它均属温补、引导、敛固方。

2.1 温补法，补中益气汤、乌梅丸、四逆辈

温补法，用于温补二阴。如气虚发热，用补中益气汤温脾；消渴燥热，用乌梅丸温肝；足心发热，用四逆汤温肾。

2.2 引导法，引火汤、附桂地黄汤、潜阳丹

引导法，即引火归原，主要用于火不归原证。如虚火上燔，用引火汤；消渴燥热，用附桂地黄汤；肝阳上亢，用潜阳丹。李可认为，虚火上燔而见嗓子痛，

脸上长痘，舌尖红，那是机体由内向外自我修的一种机制。中医讲“从治”，就是顺其势，他本来是一个热证，一大片的热象，然后你用热药，把它引到它应该去的地方。《内经》讲“君火以明，相火以位”。这个位很重要，这个相火应该在什么地方？君之下，水之中。如果它离开水，跑到君的前面、上面去了，实际上就是你不应该跑到上面去，你应该回去。但是它的脾气很暴，你要顺着来，不要骂它、揍它，这个就是引导（157页）。笔者在《火不归原引火汤》一文中，根据李可的临床经验，将引火归原分为狭广二义：

① 狭义引火归原：指火不归原证，即水浅不养龙（阴不抱阳）与水寒不效龙（阴损及阳）；

② 广义引火归原：除了火不归原证，还涵盖格阳戴阳之热药冷服、或反佐苦寒、或少佐肉桂等。前者（火不归原证）之引火归原为《内经》从治法，而后者（热药冷服，佐苦寒、佐肉桂）之引火归原为《内经》反佐法（巧诈法），如咽痛寒症兼齿衄案之四逆汤冷服、阴盛格阳案之白通加人尿猪胆汤、戴阳危证案之参附龙牡救逆汤佐肉桂（23、187、289页），从中可以看出，引导不仅用于火不归原证，还用于上述之格阳、戴阳证。

2.3 敛固法，来复汤、参附龙牡救逆汤、破格救心汤

敛固法，即收敛固守，主要用于敛肝固肾。如肺癆潮热，用来复汤、参附龙牡救逆汤；消渴燥热，用乌梅丸；浮阳上越，用破格救心汤（《北京扶阳论坛讲稿》）。李可将“收敛”法不仅用于肝木，还广泛用于三阴。下面举例证之：

① 敛肝木：如肺癆，中午一阵潮热，闻肝虚失敛，疏泄太过，在主方内加山萸肉敛肝（308页）；

② 上不敛火：如气虚发热，为土不敛火，虚阳外越，当温之敛之，“甘温可除热”是也（181页）；

③ 敛元阳：中西汇通派认为，中风就是“肝阳上亢”，治法就是“镇肝熄风”。这所谓“肝阳上亢”，就是阳气不守外越的一种表现，你把它收敛起来就对了（104页）；

④ 敛三阴：糖尿病若服六味地黄丸，那就大错广要用金匱肾气丸，主要从三阴经的那阳的方面来敛（155页）。总之，收敛亦有狭广二义。狭义之敛：指敛肝木，用于疏泄太过之汗多而喘、寒热往来，药用山萸肉、乌梅、白芍等；广义之敛：除肝木外，还涵盖土不敛火、元阳不敛，如温上敛火用四逆汤之干姜、炙甘草，收敛元阳用山萸肉、龙牡、肾四味等。其用药各有所指，应细心揣摩。

3 内伤热证的辨证要领

3.1 邪正交争

邪正交争，有外感与内伤之分。关于内伤之邪正交争，李可在论四逆汤、金

匮肾气丸时指出：六十岁以上的老人，都可用小剂四逆汤常服，可以消除你长期积累的“六淫外邪”，以及内生的一些个寒邪，能对抗一些当代错误习惯对人身伤害，调整你的元阳，延年益寿。一些阳虚引起的症状性高血压，也可服金肾气丸。经过一段时间就可以把属于肾虚的证候都扭转过来。即使血压暂时升高也不要紧，要继续吃，此系邪正交争。只要阳盛阴退、血压自会安宁（153，155页）。其中“内生的寒邪”即内伤之邪，高血压之“邪正交争”属于内伤，“邪”指痰湿瘀浊，“正”指阳气，其病机为清阳不升，浊阴不降。详见阳虚型高血压案（如页）。

3.2 阴阳盛衰

所谓“自身阴阳盛衰之变”，是指内伤杂症之人体阴虚、阳虚、阴盛、阳盛，随着阴阳盛衰之年节律、日节律而发作或加剧的时辰病。如病以上午（或后半夜）出现或加重者，多属阴虚（或阳盛）病人。因为本身阴虚者（或阳盛者），又逢阳升（或阳生）之助，故病势更甚。同样的道理，症以下午（或前半夜）出现或加进者，大多属于阳虚（或阴盛）患者。李可在足心发热案中指出，细思此症，乃阴阳盛衰之变。阴阳之道，阳为阴根。涌泉为足少阴肾经并穴，为肾气之所出。今下焦阳衰，不能统摄肾阴，而致阴火沸腾，自觉涌泉穴处呼呼往外冒火，夜卧必把脚伸出被外，踏于凉墙上始能入睡（236页、详见红 斑狼疮案《204页》）。

3.3 气机不利

李可在论糖尿病、肿瘤的治疗思路时指出，过食肥甘则引起脾胃过劳，嗜食生冷则直折脾阳。二者均可导致脾气、胃气升降功能失调，即中气虚馁。脾不升则中满，肺胃不降则产生郁热，出现面红如醉，午后更甚，头多汗等。肿瘤病见热象，多为假热或标热。它源于真寒，因寒主收引，阻遏气机，气机升降出入受阻，郁而化热（《北京扶阳论坛讲稿》）。从中可以看出，“气机不利”亦是内伤热证的病机之一。详见糖尿病案（55页）。

3.4 阴证化阳

李可在论肿瘤的治疗思路中指出，肿瘤出现高热，多为正气渐复，阴证化阳之佳兆，寒邪有望从阳明透发之机。若出现大热、大渴、大汗、脉大四症，可于附子剂中加石膏 250 克，冰炭同炉，热退即止，不可过剂（《北京扶阳论坛讲稿》）。从中可以看出，“阴证化阳”亦是内伤热证的病机之一。详见风心病阴证化阳案（200页）。

3.5 浮阳外越

李可论内伤热证 10 余种，其涉及浮阳外越者有 8 种之多，如气虚发热、肺痿潮热、虚火上燔、肝阳上亢、阴盛格阳、足心发热、消渴燥热、肿瘤发热等。

从中可以吞出，浮阳外越是内伤热证的最常见病机，不要误以为浮阳外越就一定是急症、重症（这是浮阳外越的辨证误区），它也见于小来小去的病症，如咽痛、目赤、足心发热等。详见咽痛、足心发热案（236、297 页）。

总之，李可论内伤热证辨证要领，多从内伤邪正交争人手，明察自身阴阳盛衰之变化，气机升降之不利，浮阳外越之危急。而高热的出现，多为正气渐复，阴证化阳之佳兆。

4 内伤热证的理论误区

4.1 朱丹溪的滋阴论，张景岳的折中派

李可认为，汉唐以后出现了金元四大家，这个时候中医就开始走向歧路了，其中走得最远的是朱丹溪。他当时创造了一个理论，叫“阳常有余，阴常不足”。实际上是谬论，他混淆五脏之火与六淫外邪之火的区别，竟把肝肾虚火视为“元气之贼”而加苦寒攻伐（48、84，381 页）。而明朝张景岳则是折中派，他提出“阳非有余，阴常不足”论，强调了“阳虚多寒，宜补而兼温；阴虚存热，宜补而兼清。”试想脾阳虚的发热（气虚发热），怎么可以用“清热滋阴”？甚至是沾唇必殆（181 页）。

4.2 阴阳平衡，似是而非

所谓“阴阳平衡”，它是中性的，滋阴派可以讲，扶阳派也可以讲，关键是右你在什么前提下讲。朱丹溪讲“阴阳平衡”的前提是“阳常有余，阴常不足”，所以治肺癆就应该补“水”。李可则认为肺癆潮热是“相火离位，土不伏火，元阳虚弱”。这么一种外散的表现，你从元阳这角度去敛，就把潮热退掉了（69 页）。所以当记者讲“一般人都认为，一个健康的人，阴阳要平衡”时，李可才说：这个观点（即阴阳平衡）不完全对，就是这个道理（50 页）。

4.3 阴阳一体与左阳右明

由于太极图表示左为阳、右为阴，阴阳相抱，有人就误以为阴阳是分开的。李可认为，中医上讲的阴阳，其实是浑然一体、互相融合的，不能说这边（右边）就是阴，那边（左边）就是阳（47 页）。

4.4 阳为主导与平起平坐

张景岳在钻研《内经》30 年后，著成《类经附翼》，把阴阳关系理解成半斤对八两、平起平坐的关系，李可指出，《内经》讲阳生阴长，阳杀阴藏。阳气是居于统帅地位的，是主导，而阴的东西都是在阳的统率下，绝对不是半斤八两、平起平坐的（50 页）。

4.5 助阳平和与滋阴平衡

李可认为，阴阳的不平衡，不是你给它大量添“水”，那个水火就能平衡了。而是因为阳虚造成的，所以还要助阳，只有你把阳虚扶得差不多了，即阳旺以后，阴阳自然就平和了（155 页）。

4.6 阴阳之要，阳密乃固

李可指出，《内经》讲“凡阴阳之要，阳密乃固”。那阴阳的重要性在哪呢？那就是阳密。只有当你的阳气处于一个固秘（饱满）的状态下的时候，才能达到阴平阳秘（50 页）。

上面列举了内伤热证的理论误区，亦是阴阳平衡的理论误区。阴阳平衡理论误区的根源，就在于朱丹溪的滋阴论、张景岳的折中派。前者创进了“阳有余阴不足论”，后者把阴阳理解成平起平坐的关系。李可认为，阴阳是浑然一体的，阳为主导。其不平衡是阳虚造成的，只有助阳，即阳旺以后，阴阳自然就平和了。阴阳的重要性就在于阳密，只有当人身的阳气处于茂密的状态下，真火才能潜藏到水中，命根永固，健康长寿。

关于**热证**，笔者已撰写了《热病急症汗清下》、《火不归原引火汤》、《肺癆阴阳气血虚》、《血证关键在脾胃》、《浊阴不降高心病》、《中风危症不避麻》、《内伤热证温引敛》等 7 篇文章，其中**《热病急症汗清下》偏重外感，而《内伤热证温引敛》是对《火不原引火汤》、《肺癆阴阳气血虚》等文的小结**。从中可以看出，古中医学对热证的诊治特色。

（选自《李可老中医急危重症 疑难病经验专辑》、《人体阳气与疾病》）

重危急症小青龙 ——李可学术思想探讨之十九

医界有一句话“医生不治喘，治喘丢了脸”。李可认为，不但中医，现代医学对喘证也是束手无策。说来惭愧，这一世界难题，远在一千九百多年前，医圣张仲景就已完全解决，他的武器便是小青龙汤。医圣小青龙汤是治喘神剂，是破解世界医学难题中之心、肺肾重危急症的法宝之一。重新认识伤寒论，努力实践、探索、发掘伤寒论每一方的奥秘，注意破疑解惑，拨乱反正，是传承医圣心法，复兴中医的奠基之举。

1 小青龙汤

1.1 组成

1.1.1 组成加减用法

组成：麻黄（去节）、芍药、细辛、干姜、炙甘草、桂枝（去皮）各三两（45克），五味子半升（38克），半夏（汤洗）半升（65克）。

加减：若渴，去半夏，加瓜蒌根三两（45克），若微利，去麻黄，加薤白如鸡子，熬令赤色；若噎者，去麻黄，加附子一枚；若小便不利，少腹满者，去麻黄，加茯苓四两；若喘，去麻黄加杏仁半升，去皮尖。

用法：以水一斗（2000ml）先煮麻黄减二升（400ml），去上沫，内诸药，煮取三升（600ml），去渣，温服一升。

1.1.2 基础有效量

李可认为，伤寒方的不传之秘在于剂量。按 1981 年考古发现了东汉度量衡——大司农铜权，证实了汉一两等于现代 15.625 克。那么去掉尾数，**伤寒方一两合现代 15 克**，这便是伤寒方的基础有效量（183 页）。古方计量的千古谜案，终于告破。小青龙汤中中药用三两合现代 45 克，基本符合医圣用药原貌。遵医圣“中病则止，不必尽剂”的原则，采用每剂药煮一次，分三次服，服一次若病退大半，则止后服，停药糜粥自养，不孝则叠加，随病情变化，消息进退之法，确有“一剂知，二剂已”的神效。令人遗憾的是，李时珍老人的一句话“古之一两，即今之一钱”之说，竟使后世错了 470 年。直到现在，全国各省级中医院的中医临床大夫仍烧到种种限制，甚至要追究法律责任。束缚中医手脚的“紧箍咒”太多。中医复兴要走经典之路，已无疑义。刻不容缓的是要按古中医自身发展的历史事实与理论实践，重编药典，眼下要先行松绑，赋予临床中医按照四大经典用药的权力。

1.1.3 麻黄

麻黄一药，伤寒方中最大剂量为六两（90 克），本方为三两（45 克），很吓人，这么燥烈的东西，会不会引起亡阳？不会。我用麻黄注意以下几点：

① 麻黄另煎分次兑服。我在最早的时候是麻黄 45 克另煮，按照伤寒论的方法，先煎去沫。我们通常煎麻黄很少见沫，因为剂量太小，10 克左右是不会有沫的，一两以上，水开了一分到一分半钟左右上边有一层沫，用的时候每次兑麻黄汁三分之一，得**畅汗（全身毛孔皆有润汗，玄府已开）**则止后服。3 小时内仍无汗意，可加到 100-150ml，更加饮热稀饭一碗以滋胃助汗。有些人 45 克仍然出不了汗，特殊病人麻黄 120 克才出汗（123 页）。

② **麻黄尿多亦为中病：**麻黄效用，不但可以开玄府（周身毛孔）而发畅汗，

且可以通利九窍，开鼻塞，明目聪耳，利小便。有的病人，虽无汗却小便特多，咳肿皆消。此为肺气已开，外邪下走空窍而出，亦为中病，勿须强发汗。

③ 麻黄暝眩可佐蝉衣：本方煮服法中注明“先煮去上沫”，上沫中有暝眩物质，服之令人头眩，面赤而呕，先煮去上沫可免此弊，或加等量蝉衣可防止暝眩反应。

1.1.4 芍药

伤寒方中除芍药甘草汤用白芍酸以收之、补之外，其余皆用赤芍，意在通利。再看《神农本草经》芍药项下论述：“芍药，味苦平，主邪气，除血痹，破坚积寒热，疝瘕（shàn jiǎ），止痛，利小便，益气。”则更无疑义。

1.1.5 半夏

生半夏一药，医圣大剂为二升（260 克），如大半夏汤；中剂为一升（130 克），如麦门冬汤、小半夏汤、半夏厚朴汤，其余均为平剂（65 克），即生半夏基础有效量。我用半夏注意以下几点：

① 生半夏汤洗：半夏原方注汤洗。“汤”意为沸水，汤洗即以沸水冲洗数遍。经方中半夏皆生用，汤洗可去其辛辣刺喉（咽喉麻辣发紧，令人频频做吞咽动作）之弊。

② 生半夏通便：过去认为“半夏辛温燥烈”，错了。内经明示：“辛以润之”。起初我用半夏也是洗一洗，洗下来的水是黏糊糊的，手感滑流，那个就是通大便的，所以古方“半硫丸”治寒积便秘，半夏降肺、胃、胆经之上逆，辛润通便，硫磺大热破寒积，甚效。

③ 生半夏不洗：鉴于生半夏汤洗也洗掉了润滑之性，即通便的力量减弱了，故我从 1961 年起，**凡用生半夏不汤洗，而以等量之鲜生姜同煮**，制其辛辣，积 48 年之亲身体验，无害而有殊效。用治重症妊娠恶阻、小儿老人暴喘、百日咳、肺心病之两衰、肺纤维化、食道癌之重度梗阻（生半夏 130g，鲜生姜 75g，赭石细末 120g，生附子 30g 红参 30 克，干姜 75g，吴茱萸 30g，大枣 25 枚，加用开道散）等近万例，皆能应手取效。

④ 制半夏药效：现代之制半夏，清水泡 15 天，泡到发酵，再加水、白矾，又 15 天，然后和姜、甘草混在一块，再泡 15 天，共 45 天，制出来的半夏纯粹是药渣子，非但不能治病，其浓重之矾味，也令人作呕。

1.1.6 细辛

细辛，本是医圣手中的秘密武器，亦是医界挠头的药物之一，与川乌、附子同例。应认清以下问题：

① 细辛用量不过钱：细辛的问题大概是在宋代出现的这个错误，而且讲话的不是医圣，而是一个看守犯人的牢头。当时有一个犯人自杀了，发现在尸体屏

边放着些药，他鉴别后认为是细辛粉，后来被李时珍老人编著的《本草纲目》引用，流传“细辛不过钱”这个样的一种说法（95 页）。

② 细辛基础有效量：医圣用细辛共 16 方。凡治外寒内饮、血虚寒凝致四肢厥逆时，重用细辛散寒化饮之功，用量为三两，如小青龙汤。当归四逆汤及其类方等 8 方。若本气先虚，少阴阳根不固，兼夹外犯或内生之实邪，则细辛只用二两，并与附子同用，如麻黄细辛附子汤治太少同病大黄附子汤治寒积便秘，同类方共 5 方。其余各方都是丸散，用量不等。由此看来，你说张仲景用的分量超过“一钱”多少倍？**《伤寒论》细辛基础有效量是三两**，我用这个量用了 40 年，没有发生任何问题。有些特殊的病，我最高用到 120 克，也不会有什么問題。所以我们看病要遵循《内经》和《伤寒论》的方法，用药要遵照《神农本草经》的原则，而不是后世这些乌七八糟的东西（107 页）。

③ 细辛致呕佐蜂蜜：细辛唯一的缺陷是味道太大，特别是辽宁产的北细辛，我多次喝这个细辛，都恶心、呕吐。有人主张用蜜炙一刻钟，以减其辛烈之味，可行。

1.2 主治

1.2.1 原书指证

伤寒、金匱有以下论述：

① “伤寒表不解，心下有水气，干呕、发热而渴，或渴、或噎、或小便不利少腹满，或喘者，小青龙汤主之。”其脉必见紧、弦。

② “病溢饮者当发其汗，大青龙汤主之（病之重者），小青龙汤亦主之（病之轻者）。”

③ “咳逆依息不得卧，此方主之。”

④ “妇人吐涎沫，医反下之，心下即痞，小青龙汤主之。涎沫止，乃治痞，泻心汤主之。”

⑤ “治肺胀，咳而上气，烦躁而喘，脉浮者，心下有水，小青龙汤主之。”以上五条，第一条为伤寒太阳篇小青龙汤证之提纲，以下四条为金匱治内伤杂病之变法。

1.2.2 主证病机治法

我的理解，小青龙汤主证只是“咳喘”二字，病在肺脏，日久有肺入肾。其病机为“本气先虚，外寒内饮。”治疗大法为“发汗利水”，表里双解。其病因病机分析如下：

① 表里同病：小青龙汤证昭示：伤寒表不解，心下有水气，干呕、发热而咳，咳喘依息不得卧。伤寒书中，凡有表证兼里证者，则以“表不解”称之，即外感内伤同时发病。其表证仅一发热，一切的皆为水气为患。水留胃中，故干呕而噎；水寒射肺，故咳而喘。

② 邪伏三阴：“心下”的部位，包括胸中、心、肺、胃。“水气”即水饮，浸渍、阻滞、缠绕于诸脏器之窍道间，而成喘。由于人体本气已虚，外邪屡屡入侵，寒邪由表入里，由浅入深，正气愈虚，邪陷愈深，层层藏匿于三阴之里，成为小青龙汤之疑难大证。

③ 诸证当先解表：太阳经是病的来路，亦是病的出路。胸中为太阳经出入之路，又为肺经安居之所，肺为水之上源，皮毛为肺之外窍，又是太阳经之循引通道。诸症当先解表，开太阳，宣肺敲，汗出则外寒由里出表，小便自利，水饮自消，所以用小青龙汤之麻黄桂枝解表。

④ 扶正托透：由于寒饮藏匿于脏腑，就是《伤寒论》太阳少阴同病，应该采取固本气，开表闭，透伏邪。因为寒邪深入少阴，所以要用小青龙汤加味，附子细辛扶正托透（47 页）。

2 小青龙虚化汤

2.1 小青龙汤变通思路 现代人全属未病本气先虚，甚则未病本气先溃，因此，我用小青龙汤有以下变通。

2.1.1 附子 加制附子 45 克，以四逆汤法驾驭小青龙汤法，重症加山萸肉 90 克，则麻黄细辛可放手去解表利水，而无辛散过度之虞；

2.1.2 人参 加生晒参 30 克，成为四逆加人参汤，滋阴和阳，益气生津，以制干姜之燥。重则改投高丽参粉 9-15 克，缓缓提升下陷之气以定喘；

2.1.3 茯苓 加茯苓 45 克，成为小半夏加茯苓汤，另辟蹊径，淡渗利湿，使浸渍心胸脾胃间之水饮从小便去，协助麻黄细辛开玄府，上下分消；

2.1.4 紫菀冬花白果 为使本方成为治喘神剂，从射干麻黄汤中选入紫菀、冬花“对药”，以治“咳而上气，喉间水鸡声”；从近代沪上名家经验中选入定喘要药壳白果一味，白果与麻黄同用，一散一收，治痰喘极效；

2.1.5 竹沥 凡见喉间鸣漉漉者，加竹沥 60ml（三次服）以稀释涤除痰涎；

2.1.6 杏仁 痰喘实证，胸高息涌，窒闷欲死，加杏仁半升（55 克），葶苈子半升（62 克），大枣 30 枚，病退即去。

2.1.7 麝香 肺心病合并呼吸衰竭、脑危象者，加麝香 0.3-0.5g（首次顿冲，附子加至 100g，山萸肉 120g，龙牡、磁石各 30g）；

2.1.8 石膏乌梅 寒邪郁久，入里化热，体温 39° C 以上者，加生石膏 250g，乌梅 36g，热退即止后服，不必尽剂；

2.1.9 白芥子 利气豁痰，搜剔内外，去皮里膜外之痰多用。

2.1.10 蝉衣 方中麻黄有致瞑眩物质，令人一阵昏眩面赤如醉，除先煎去沫外，可加等量之蝉衣，可免此弊。

2.2 小青龙虚化汤组成用法

组成：麻黄（另煎）10-45g，制附片 45-200g，辽细辛（蜜炙）45g，生晒参（另炖）15-30g，生半夏 45-65g，干姜 30-45g，五味子 30-38g，炙紫苑、炙冬花各 15-45g，壳白果（打）20g，炙甘草 30-60g，桂枝、赤芍各 45g，生姜 65g。

用法：本方煮服法：

① 麻黄另煎：麻黄另煎去上沫，取汁 150ml；诸药加水 2000ml，文火煮取 450ml，对入麻黄、参汁，分 3 次服，每次 200ml，每次间隔 3 小时。

② 中病即止：服首剂第一次后密切观察，若得全身畅汗，则剩余二次弃去不用。若仅得微汗，3 小时以后再给药一次。若仍无汗，则缩短间隔时间给药，或汗虽不畅而小便通利，亦为中病。则第二剂之后麻黄减为 5g（让它发挥通气的作用），再服两剂则安。

③ 滋胃助汗：特殊体质，表闭过甚者，在服汤药同时，可饮热稀饭，或加五虎汤（黑小豆、红糖、生姜、大枣、葱白），以滋胃助汗。

④ 老幼酌减：老幼妇弱使用本方，可将安全比例制小其剂。最小剂量为 1/5 量，汤成，分 10 次稍稍与之。10 岁以上儿童则服 1/2 量。18 岁以上用成人量。老弱酌情参照。

3 小青龙虚化汤临证应用

小青龙虚化汤证就是外感内伤同时发病，主要表现为咳、喘、肿，病位在“心下”——心胸脾胃间，邪伏三阴（肺、脾、肾）。西医之肺心两衰，即中医之少阴证。只要符合其主证病机，不论西医的何种病，皆可通治。故本方可治现代医学之支气管炎、肺炎、哮喘、肺气肿、肺心病、肺间质纤维化、肺癌等一系列呼吸系统疾病；急性结核性渗出性胸膜炎、胸部积液、心包炎、心包积液、冠心病等心、胸诸疾。其常见重危急症制法如下：

3.1 甲流

李可认为，甲流从症候分析，属“寒疫”。发热、咳嗽、全身肌肉酸痛等上呼吸道感染，重则并发肺炎，大多死于呼吸衰竭和心衰。属小青龙汤证，邪之所凑，其气必虚，病在足太阳、手太阴、足少阴。

主方：预防甲流，扶正辟疫汤。炙甘草 20g，干姜 10g，制附片 10g，生黄芪 100g，苍术 10g，佩兰叶 10g，藿香 10g，生晒参（捣碎入煎）15g，乌梅 20g，冰糖（化入）15g，生姜 10 片，大枣 12 枚；治疗甲流，**小青龙虚化汤**。即小青龙加制附子、人参、紫苑、冬花、白果。

加减：小青龙虚化汤，发热 38℃ 以上时，加生石膏 250 克，杏仁 25 克；呼吸困难，加麝香；迅速恶化，大剂破格救心汤。

用法：扶正辟疫汤，加水 1500ml，文火煮取 300ml，第二天复煎，可供三

口之家日服用，每人每次热服 50ml，日服 2 次。大流行期服 7 天，停 3 天。服至明年立春，若明年春寒，多服半月。小青龙虚化汤：麻黄另煎去上沫，取汁 150ml；诸药加水 2000ml，文火煮取 450ml，对入麻黄、参汁，分 3 次服，每次 200ml，每次间隔 3 小时。则第二剂之后麻黄减为 5g，再服两剂则安。

李可之弟子，治疗了 11 例确诊甲流的转入病人，其中 7 例是服用过达菲的，而 4 例是没有服用过。所以头 7 例病人，使用中西医结合治疗，后 4 例病人，根据李可之小青龙虚化汤辩证论治。4 天后 11 例病人都恢复正常（东莞中医防治甲流，中国中医药报，2009,11.6）。

3.2 小儿暴喘

小青龙虚化汤用于小儿暴喘，最小剂量为 1/5 量。10 岁以上儿童则服 1/2 量。18 岁以上用成人量。老弱者酌情参照。

食肉暴喘 王某，男，2 岁。1976 年冬，夜半，突然暴喘痰壅，无汗喉间痰鸣如拽锯，面如蒙尘，唇青肢厥。询知下午给喂肥肉两块，证属寒喘夹食，予小青龙虚化汤加味：麻黄、桂枝、赤芍、炙甘草、辽细辛、干姜各 9g，五味子 8g，生半夏 13g，制附片 9g，红参 9g（捣末同煮），竹沥膏 10ml（对入），炙紫苑、炙冬花各 9g，壳白果（打）10g，茯苓、焦山楂、炒莱菔子各 9g，生姜 10 片，白芥子炒研 10g。加水 1000ml，文火煮取 100ml，小量多次，日尽一剂。病家连夜抓药煮服，从开始服药至次晨 8 时，四小时许，1 剂未尽，诸症悉除。追访至 1996 年，已 20 年未犯。

心源暴喘 张某，男，12 岁。先天性心脏病二尖瓣缺损 12 岁男孩，逢寒即发暴喘，唇舌指甲青紫，喘息抬肩，不能平卧。常备此方加麝香如米粒大，病发服之，二、三日即平复如初。后以培元固本散一料，加生黄芪 600 克，制附片 100 克，干姜 90 克，炙甘草 60 克。日服 3 次，每次 3 克，不装胶囊，三月后不再发。

3.3 小儿急性肺炎

本病以发热汗出而喘为主证，可分正局、变局两种。正局用麻杏石甘汤，变局用变通小青龙汤。

3.3.1 正局

3.3.1.1 正局病机制法

我的经验

① 指小儿素体健壮，抗病力强。受邪则从热化，病机是“表寒未罢，里（肺）热已炽”。表邪来路是太阳，已用麻黄汤发汗，但寒去不彻，阻遏于肺，浸渍肺窍，故汗出而喘不止。虽有汗，不是大汗，虽里热，非大热，若大汗、大热则已是阳明白虎证，看出有内传阳明之势。

② 治疗大法：麻黄汤去桂枝之辛温，重加石膏之辛寒为君，变辛温解表为辛凉清解、表里双解之法，使外邪仍从表出，阻断内传阳明之变。

③ 伤寒统温病：麻黄汤一味药的改变，开创了辛凉解表，甘寒清热之新路，成为后世温病派思路之祖源。伤寒方可以统治温病，如清代柯韵伯以辛凉轻解法治春温；50年代中期，蒲辅周以变通白虎汤治乙型脑炎大流行（暑温）。

3.3.1.2 麻杏石甘汤

组成：麻黄四两（60克），杏仁五十个（20克），炙甘草二两（30克），生石膏半斤（125克）。

用法：如何掌握应用？且看原方煮服法：上四味，以水七升（1400ml），先煮麻黄减二升，去上沫，内诸药，煮取二升（400ml），去渣，温服一升（200ml）。

注意：本方得汤汁共二升，只言温服一升，所剩一升怎么办？未曾交待。这是一个悬念。我的体会：

① 半剂中病：医圣治急性肺炎用麻杏石甘汤，只需半剂，即热退喘定，所剩一升，弃去不用。

② 药过病所：若惜药而尽服之，则药过病所，轻则伤及太阴，食少便溏之坏病，重则误及少阴，神倦困顿，已是但欲寐之渐变。

③ 药轻内传：反之用量太轻，不能达到基础有效量，则不能顿杀病势，难以阻断有效量，则不能顿杀病势，难以阻断内传阳明之变，热势愈盛，耗伤津液。

④ 坏病理中：若出现误治坏病，则以理中、四逆辈先救药误，以复元气。

⑤ 少阴破格：一旦出现少阴证，则已到了生死关头，速投大剂破格救心汤。

⑥ 婴儿酌减：婴儿最小剂量为 1/5 量，汤成取药汁 50ml，分 10 次稍稍与之；若热退，喘定，入睡，则醒后再喂 5ml，3 小时后再喂一次；若在次日午前尚未全好，则可再给药两次，每次 5ml，间隔 3 小时，所剩药汁弃去不用。10 岁以上儿童则服 1/2 量。18 岁以上用成人量。老弱者酌情参照。

急性肺炎合并急惊风 王某，男，4 个月。因急性肺炎高热抽风入院，体温 39.7℃，牙关紧闭，角弓反张，两目上翻，痰壅鼻扇，频频抽搐，约 5-6 分钟一次。唇指青紫，四肢厥冷，体若燔炭，紫纹直透命关。证属风热犯肺，痰热内结，热极动风，邪陷心包。急以三棱针刺点十宣、双耳尖、百会、大椎出血。患儿大哭出声，全身汗出，四肢回温。以毫针飞针点刺涌泉、合谷、人中，雀啄术刺素髻（liáo）约一分钟，患儿苏醒，抽搐亦止。令先服羚麝止痉散 1 克，加麝香 0.3 克。为疏清热熄风，宣肺涤痰，开窍止痉之剂：石膏 30g，麻黄、杏仁、甘草、丹皮、紫草、天竺黄各 10g，芦根 30g，蚤休 15g，竹沥 20ml，葶苈子 10g，大枣 10 枚。煎汁 60ml，服至 35ml，散剂 3 次而愈。所剩药汁弃之不用，给散剂 2 次量，以防余热复炽（72 页）。

李按 本案因急性肺炎，故以麻杏石甘汤为主。其中石膏、丹皮、紫草，三药合用可代犀角，退高烧奇效。蚤休为清热解毒，熄风定惊要药，可治一切毒蛇、

毒虫咬伤，解毒力最强，可清除入血之病毒而护心醒脑，又独有止痉功效，故为方中主药。羚羊止痉散（羚羊角 3g，麝香 1 克，蝎尾 12 只，蜈蚣 2 条为末，分三次服），为余急救小儿高热惊风开窍醒脑常备药。轻症单服见效，不必配服汤剂。此患儿有窒息之险，故另加麝香 0.3 克立解其危。

3.3.2 变局

变局病机制法 我的经验：

① 病因病机：肺炎小儿，素有痰喘宿疾，正气先虚，暴感寒邪，无汗或有汗而发热、剧烈咳嗽，鼻翼煽动，喉间痰声如拽锯，脉浮紧或滑数，烦躁闷乱，渴而索水，射中根黄燥者（内热的据），知有新感引动伏饮，内热已著。

② 小青龙虚化汤加石膏：速投小青龙虚化汤 1/2 量，加生石膏 125 克，依上法煮汤，小量多次给药，得汗则烦躁立退，咳喘立解，脉静身安，安然入睡。次日用 1/5 量，去石膏，再服两剂即安。

③ 四逆加人参汤护驾：小儿脏腑娇嫩，寒热虚实，瞬息万变。常见肺中燥热未罢，太阴虚寒已起，若单用麻杏石甘汤，则病愈之后，食少便溏羸弱之患，难以复原。吾今以四逆加人参山萸肉汤驾驭小青龙加石膏汤，太阴、少阴已得双重保护，虽重用生石膏清肺热、中病则止，绝无后患。

小儿大叶性肺炎垂危

郭咏，女，6 岁，1989 年冬患急性大叶性肺炎，住院 10 日，已高热抽搐 1 小时后昏迷 6 日，并发呼吸衰竭、心衰 12 小时，夜半邀余会诊。询知曾用进口青霉素、大剂量激素、清开灵、安宫牛黄丸无效。现体温突降至 36 度以下，二便失禁，气息微弱，喉中痰声漉漉，（已予吸痰无效）面如蒙尘，唇、指、舌皆青紫，手冷过肘，足冷过膝，六脉散乱如雀啄、屋漏（心脏停跳前奏），已 24 小时吸氧 5 日。此属高热伤阴，阴竭，阳无所附，气脱于下，阴阳离决之险已迫在眉睫。院长介绍，已请省内儿科专家会诊，专家认为“小儿大叶性肺炎，出现呼衰、心衰、脑危象其中之一，已是死症，三者并发，神仙也救不了，无能为力。”我看小儿大汗淋漓，出气多，入气少，面如死灰，生死在顷刻间。遂不再多言，急疏破格平剂：炙草 90g，干姜 75g，制附子 45g，生山萸肉 120g，三石各 30g，高丽参 30g，麝香 1g。令药房取药，武火急煮，边煮边灌，每次鼻饲 5 毫升，麝香 0.2 克，至凌晨 8 时，5 小时内共服药 4 次，院长来告，服第二次后汗止，体温回升至 37 度，手脚已温，心跳偶见间歇，呼吸平顺，服第四次后已能睁眼，吐痰，已给牛奶一小杯，已不在吸氧，去掉鼻饲管。当日，每小时给药 10 毫升，8 小时内又服 7 次。下午 4 时再诊，小儿已能讲话，喝牛奶 3 次，泡食馒头片 5 片，脉仍迟弱，50 次/分，已无雀啄。面色少显苍白，两目有神，唯喉间痰鸣如拽锯不退。询之，知有痰喘宿疾。遂予变通小青龙汤 3 剂，取 1/2 量，麻黄减为 5 克，加生山萸肉 90 克固脱。一场大病，九死一生，脏气大伤，令服培元固本

散半年。今年 6 月，遇于一友人家，此女已 19 岁，大病之后，调护得宜，颇健壮，已参加工作。

其痰喘宿疾，自暴病中服破格救心汤 1/3 剂，变通小青龙汤 3 剂后，竟得根治。

此案有两点值得记取：

① 必死之候，一心赴救：此病在预后判断上，中西医基本一致。从中医古籍（内经、难经、四诊抉微）记载看，凡见五脏绝证，七怪脉绝脉者，为必死之候，可以预知死于某日某一个时辰。我的态度是，明知不可为而为之，只要一息尚存，心跳未停者，即当一心赴救，不计毁誉，尽到一个医生救死扶伤的职责。我从医 54 年，救治这样的病人约五千之数。不要被外国人的结论、古人的定论所拘，尽信书则不如无书。自己做过，方知端的。

② 师法仲景，身体力行：我学医圣张仲景的遗作，不过是一星半点，只是努力按他的教诲，身体力行而已。我和一些青年朋友讲过，要当一个铁杆中医没有董存瑞舍身炸碉堡的大无畏精神是不行的。你把自己的名誉、低位看得比病人的性命还重要，那你还是明哲保身为妙，就不要干中医了（44 页）！

3.4 急性结核性胸膜炎

急性结核性胸膜炎初、中、末三期治法如下：

3.4.1 发热咳喘小青龙

初病出现类感冒症状，发热恶寒，咳喘，胸闷，脉浮紧者，即投变通小青龙汤一剂，热退喘定，麻黄改为 5 克，再服二剂。

3.4.2 胸痛积液瓜蒌薤

失治或误治，胸腔积液，剧咳不止，胸闷刺痛，发热口渴，脉细数，舌边尖瘀紫者，速投：瓜蒌 45g，薤白 30g，白酒 100ml，桂枝、赤芍各 45g，炙草 30g，丹参 45g，“檀、降、木香、砂仁各 10g”（后 7 分），生半夏、生苡米、芦根、茯苓各 45g，桃杏仁泥各 30g，冬瓜仁 60g、生姜 45g、大枣 12 枚。上方三剂，3 小时 1 次，日 2 剂，夜 1 剂，集中全力，化去胸肺间之痰、水、瘀浊，24 小时即可脱困。本方亦可治心包炎之心包积液。

3.4.3 热化寒化参四逆

热化伤阴者，加西洋参 30 克；寒化、虚化，脉微细，但欲寐，元阳被一团阴霾所困者，加炮附子 45g，干姜 45g，红参 30g（另），灵脂 30g，破阴通阳。

急性结核胸膜炎 张某，男，24 岁。1979 年秋换结核性渗出性胸膜炎，五短身材，痰湿体型，肥胖而面色灰滞。自幼患气管炎，畏寒有汗，喉间有痰鸣音，咳喘剧而胸闷痛，舌白腻不渴，脉弦迟 58 次/分，次属元阳久虚，外寒内饮，阴

邪窃居阳位，先予小青龙虚化汤加杏仁、厚朴。上药服 2 剂，外证悉除，咳喘愈，痰鸣消失。继予下方 5 剂：瓜蒌 30g，薤白、桂枝各 15g，白酒 100ml，桃杏仁各 12g，生半夏 20g，丹参 30g，檀降香、木香各 10g，砂仁 5g，生苡仁 45g，冬瓜仁 60g（打），泽泻 15g，肉桂 45g，茯苓 30g，炙甘草 10g，鲜生姜 10 片，大枣 10 枚。上方服后，胸透，积液吸收而愈（47 页）。

3.5 肺间质纤维化 肺间质纤维化初、中、末三期治法如下：

3.5.1 小青龙虚化汤贯彻始终

本病属沉寒痼冷，寒邪由表入里，由浅入深，深陷入脏，冰伏难出。治法上，虽数十年之久，仍当引邪由里出表。故以本方扶正托透法贯彻始终。

3.5.2 附理小剂先救胃气

本病到中医接手诊治时，已属误治坏病，晚期之晚期。多数并发肺心病、冠心病、顽固性心衰，渐进性呼吸衰竭。由于人体本气已虚到极点，救治大法只能是“但扶其正，保命第一”。

炙草 24g，干姜 12g，炮附片 12g，高丽参 15g（另），白术 12g，砂仁米 10g，紫油桂 10g，炒麦芽 60g，藿香 10g，佩兰 10g。加水 1000 毫升，文火煮取 150 毫升，对入参汁，日分 4 次服。

由于此属病人胃气伤残过甚，非但不能运化饮食，亦不能运载药力，故以小剂缓图，补火以生土，芳化温中以醒脾。**切记：用理中法不可用青、陈皮、厚朴、枳实等破气之品。因太阴病之胀满，乃寒湿阻滞，中气旋转升降无力所致。桂附壮釜底之火，参芪补中气之虚，砂仁藿佩芳香化湿醒脾，方克有济。妄用开破，反使中气下陷，拨动阳根，是促其死矣！**

3.5.3 附理大剂过生死关

上方用药一周，胃气来复，食纳渐增。此时可制大其剂，调治月余，食纳大增，胃气来复，其方如下：炙草 90g，干姜 90g，炮附片 45g，高丽参 30g（另），白术 90g，砂仁米 30g，紫油桂 10g，炒麦芽 60g，藿香 10g，佩兰 10g。

3.5.4 三衰暴发救阳为急

本病在三衰暴发，生死顷刻之际，救阳为急，大剂破格加麝香 1 克，24 小时连服 3 剂。

3.5.5 培元固本修复脏器

培元固本散以血肉有情之品有峻补先天肾气，重建人体免疫力之功，故当常服。其方如下：大三七 100g，黄毛茸尖 50g，高丽参 100g，灵脂 30g，血琥珀 30g，血河车一具，川贝尖 30g，上沉香 30g，土元 30g，生水蛭 30g，藏红花 30g，

全虫 30g，蜈蚣 100 条，蛤蚧 10 对，冬虫夏草 30g，“炮甲珠 60g，麝香 2g”（分作 20 包，早晚各 1 包）。

肺间质纤维化

张某，女，44 岁。20 年前，产后暴感寒邪，患咳喘，久治不愈，凡节令交替或气候骤变必犯，逐成痼疾。近因感冒缠绵不断，终至喘不能步而住院。经省二院诊为“特发性肺间质纤维化合并肺心病”，用大剂激素疗法、吸氧无效。心衰、呼吸衰竭日见严重，病危出院。诊见羸弱脱形，面色青惨，气息奄奄。唇指青紫，杆状指，下肢凹陷性水肿。喉间痰鸣漉漉，咳吐白痰涎沫。四肢厥逆，脉急而促，133 次/分（频发房性室早搏）。舌胖，苔灰腻，两侧瘀斑成条。唯食纳好，胃气尚存，虽亡阳厥脱诸症毕见，尚有可挽之机。李可遂以大剂破格救心汤救阳固脱为先，参蛤散纳气归肾，麝香辟秽，化浊痰，开上窍，以救呼吸衰竭，加开水急煎，昼夜连服 3 剂。二诊：服首剂的 2/3，痉咳暴喘得罢，上肢回温，基本脱险。服完 2 剂，安睡 2 小时。醒后痰鸣声一度小时，暴暗 20 余日，第一次发出声音。一昼夜用附子 600g，指头掌虽温而下肢冰冷如昔。近半年来。剩下不离棉衣，自觉如入冰窖，背部似冷水浇灌。此次重病月余，始终恶寒无汗，全身如绳索捆绑。胸痛彻背，憋闷如窒。病虽 20 年，而小青龙之主证不变。营卫闭塞，寒邪冰伏，少阴亡阳与太阳表实同见，成为本病一大死结。遂拟一方，师法麻黄附子细辛汤意，助元阳、开表闭：麻黄 30g（另煎 150ml），细辛 20g，附子 200g，干姜 25g，炙甘草 60g，山萸肉 120g，生半夏、茯苓、生姜 45g，葱白 3 寸，高丽参 20g，蛤蚧 1 对，麝香 0.5g（研粉分吞）。**服药选午前阳旺之时，以助正气。**每次对入麻黄汁 50ml，得汗后止服。三诊：上午于 9 时服一次，至 10 时 30 分，仍无汗意。令缩短给药时间，加服一次，并以生姜末、红糖、胡椒粉煮汤 1 碗，热服以助药力。午时头部见汗，少顷颈项胸背皆得润汗，令去麻黄汁继服药液。四诊：药后表闭一开，真阳敷布，背部冰冷及全身如捆之感，一服而解。上肢厥冷已退，喉间痰鸣消失，唇指色赚淡红，喘定，痉咳偶见一二次，小便增多，踝肿亦退。脉象缓和，80 次/分，顽固性心衰及呼吸衰竭之危，得以解除。二日来吐痰甚多，胸中憋闷感亦大为松宽。可见汗法得宜，有助于人体正气来复，使盘踞肺络之湿痰死血，渐有外透之机。遂拟四逆汤合瓜蒌薤白、丹参饮调治，培元固本善后（28 页）。

按 本案病已 20 年，而小青龙汤证之主证不变。李可重用麻黄，1 剂则表闭即开，真阳敷布，病由此使步入坦途。所以李可反复告诫我们：“诸症当先解表”，似乎是老生常谈，平淡之极。然而正因为它平淡，往往被医者忽略，**凡兼挟外邪诸证，皆当以解表为先，开门逐盗，拒敌于国门之外，最是上策**（198 页）。

3.6 肺癌

肺癌治法如下：肺部肿瘤可用四逆和小青龙汤，四逆和阳和汤，四逆合千金苇茎汤。咳血，加仙鹤草、三七粉；胸腔积液，可加葶苈大枣泻肺汤；胸痛，加蜈蚣、全蝎；间用理中、补中益气，培土生金。

肺癌晚期 孙某 男 56岁 天津地毯厂职工。08年4月3日初诊，糖尿病胰岛素依赖9年，双肺癌3年另7个月，乙肝癌变18个月，介入后，不思食，周身疲软，喘不能步，喉间痰声漉漉，入夜咳逆依息不得卧，无汗，全身紧束如绳索捆绑，脉沉紧弦，舌淡紫白腻。由津来灵，路途风寒外袭，太阳少阴同病，先予变通小青龙汤1剂，药后周身润汗，喘减，夜可平卧。继服小剂桂附理中汤10日，幸得胃气来复，诸症均减。遂令服变通小青龙汤，麻黄减为5克，炮附片由45克渐加至200克，每服3~5剂，或泻下恶臭便，或胸背发出红疹，伏邪渐次外透，守此一方，每旬服7剂，静养3日，经11诊，至09年7月，服药18个月，服加味培元固本散3料。外观已无病容，津一灵往返8次，无须家人照料。

4 李可研究经方的思路

李可《小青龙汤治重危急症举要》讲稿，万言之作，一气呵成，采取自问自答的形式，探讨了小青龙汤的诸多问题，堪称“青龙百问”，是研究经方的典范。我们要关注他关于这些问题的新见解，还要进一步学习他研究经方的思路。

4.1 经方的基本教材

学习经方，要在《伤寒杂病论》原文基础上，选好参考教材。李可自述：那个时候对我影响最大的是左季云老人。我在基层第一线从事中医工作，青年时代，通过读左季云《伤寒论类方汇参》，学到了许多东西。他在这本书里是用方类证的方法研究《伤寒论》，这在古代研究《伤寒论》的学派里边也是很大的一派。他这种方法很简单，把性质相同，但是又有许多细微差别的方子归纳在一起，然后再辨别具体方子应该怎么用。比如说，发热恶寒，脉浮紧，这不是“太阳”病吗？“太阳”病的这个证，就是“麻黄汤”的适应证，只要你记住“麻黄汤”的这个主证，你就可以用“麻黄汤”这个方子。他那个著作里头啊，关于“四逆汤”的论述非常好，能治24种病，深受启发，所以我当时就接受了他的一些重要观点。30年后才知道，左是引用清末火神派始祖郑钦安的观点（66页）。关于小青龙汤病因病机治法的论述，他直接引用了《伤寒论类方汇参》“风寒夹水气，浸渍胸中及肺胃间，发热干呕而咳，为发汗利水之温方”的观点，还有“芍药”为赤芍的论证，均出于此。从中可以看出，李可52年来一直把它作为研究经方的基本教材来读。教材选对了，才不致于走弯路，这不失为简便而有卓有成效之举。

4.2 经方的返朴归真

后世研究经方，走偏、务虚的偏多，大都违背了医圣的原意。李可返朴归真研经方，就是从最基本、有形之处做起。如小青龙汤原方剂量麻黄 45 克、细辛 45 克、生半夏 65 克、五味子 38 克等，都是很吓人的，它却还了经方的庐山面目；煎服法中先煮麻黄减二升，去上沫；冲洗法中生半夏汤洗等。笔者称之为返朴归真“三务实”。

4.3 经方的基础有效量

李可在经方返朴归真的基础上，进一步提出经方基础有效量概念，这警世人们：经方治大症解救危亡，低于此量则无效，或缓不济急，贻误病机。如经他挖掘的小青龙汤原方剂量前所未闻，而用此剂量治各种暴喘、肺心两衰、肺间质纤维化等，更是古今少有。

4.4 经方的破疑解惑

李可认为，读古人书，最忌死于句下。人人皆同，唯我独疑。书上写过，不如自己用过更踏实。只有亲手做过，方可发现真理。读伤寒尤当如此（6 页）。他是这么说的，也是这么做的。仅以小青龙汤中麻黄为例，他提出疑问数端：

- ① 麻黄为什么要先煮去沫？
- ② 现代人煮麻黄为什么见不到沫？
- ③ 麻黄为什么另煎？其服法又是什么？
- ④ 有人服了麻黄虽无汗却小便多，还须强发汗吗？
- ⑤ 有些服麻黄 45 克仍然不出汗怎么办？
- ⑥ 麻黄的最大量是多少？
- ⑦ 麻黄的副作用是什么？
- ⑧ 怎么防止麻黄瞑眩反应？
- ⑨ 小青龙汤在“五或症”加减中，为什么 4 次去麻黄？
- ⑩ 小青龙虚化汤为什么克放手让麻黄解表利水？细辛、生半夏亦然。

4.5 经方的改良

所谓“改良”，是在原方疗效不变的前提下，对其药物的毒性、副作用所采取的有效措施。如小青龙汤中麻黄另煎去沫或蝉衣反佐，可免瞑眩效应；生半夏不洗而加等量生姜，可免刺喉之弊；细辛蜜炙，克免呕恶之副作用。

4.6 经方的变通

所谓“变通”，即经方的加减。张仲景在小青龙汤“五或症”的加减中，其中有 4 次是减去麻黄，说明其麻黄禁忌证比较多，李可之小青龙虚化汤加味条文最多，相对麻黄禁忌证就比较少。如：加附子一四逆汤法驾驭小青龙汤；加人参，

成为四逆加人参汤，则麻黄细辛可放手去解表利水；加茯苓成为小半夏加茯苓汤，另辟蹊径，淡渗利湿；加紫苑冬花，融入射干麻黄汤法，治咳而上气，喉间痰鸣等近 10 条。其中小青龙虚化汤减味法则有：

① 减桂枝芍药：因李可常用麻附细通治外感，干姜、半夏、细辛、五味子化饮止咳，故用小青龙虚化汤时常减桂枝芍药。如一例太少同病，小青龙汤虚化，其处方：麻黄（另煎）30g，制附片 100g，细辛 45g，高丽参研冲 12g，生半夏 45g，干姜 30g，五味子 30g，炙甘草 120g，生姜 75g，肾四味各 30g，葱白 4 寸；

② 减麻黄：汗出表解或体虚欲脱，以破格救心汤和姜夏细味：制附片 200g，干姜 100g，炙甘草 120g，高丽参（另）30g，山萸肉 120g，生半夏 45g，茯苓 45g，五味子 30g，细辛 45g，麝香 1g，节菖蒲 30g，龙牡、磁石各 30g，油桂后下 10g，生姜 45g，姜汁（对入）10ml。

4.7 经方的突破

李可关于经方的突破，主要表现在三方面：

① 剂量突破：经方麻黄最大量六两（90 克），方如大青龙汤。李可麻黄有时用到 120 克，特殊病人才出汗（123 页）。如一例玄府闭塞之处方：麻黄 120 克，生姜 30 克，大枣 30 枚，葱白 1 尺，黑大豆 30 克，核桃 6 枚。

② 容量突破：所谓“容量”，指复方多法而言。李可研制小青龙虚化汤，融四逆、麻附细、射干麻黄汤于一体。他还常把小青龙虚化汤与破格救心汤、乌头汤、附桂理中汤、阳和汤合用。如一例太少通病，邪伏三阴之重症，非附子、川乌同用，不能破冰解疑，予小青龙虚化汤合乌头汤：麻黄 10g，制附片 450g，干姜 90g，生半夏 45g，细辛 45g，五味子 30g，炙紫苑 15g，炙冬花 15g，白果（打）20g，炙甘草 90g，北芪 250g，川乌 30g，黑小豆 30g，防风 30g，高丽参粉 15g，蜂蜜 150ml，生姜 45g，大枣 20 枚。

③ 毒量突破：所谓“毒量”，指经方的毒药剂量。如治食道癌之梗阻，生半夏用至 130 克；治肿瘤、运动神经元疾病，细辛用到 120 克；小青龙虚化汤之附子用大剂，更为人们所熟知的。

4.8 经方是破解世界性医学难题的一把金钥匙

李可说，现在医学对喘证也是束手无策，而小青龙汤是治喘神剂，是治世界性新增疾病谱中疑难绝症肺间质纤维化，破解世界医学难题中心之、肺、肾危重急症的法宝之一。如小儿大叶性肺炎垂危、肺间质纤维化案便是明证（25 页）。

李可嘱咐我们，伤寒全书，每一法、每一方的字里行间，都寓有深意，不可等闲视之，这也是辨证的精髓。特别是驾驭毒药以救人性命，是医圣的重要贡献之一。重重险关，老一辈已一一闯过。青年一代要勇于实践，以传承医圣薪火为己任，在理法方药四大环节上，恢复仲景法度，努力发掘经典的无尽宝藏，勇敢地肩负起中医复兴的历史使命！至嘱！至嘱！

（凡标明出处者，选自《李可老中医急危重症疑难病经验专辑》、《人体阳气与疾病》、《扶阳论坛》；而未标明出处者，均选自《小青龙汤急危重症举要》；此文第四节“李可研究经方的思路”由孙其新执笔。）

调燮三焦治水气

——李可学术思想探讨之二十一

摘要 针对水气病治疗规律，进一步探讨了李可学术思想。李可治水气病常用方：麻黄汤、麻黄连翘赤小豆汤、小青龙汤、人参败毒散、麻黄附子细辛汤、瓜蒌薤白白酒汤、千金苇茎汤、泽泻汤、小半夏加茯苓汤、防己黄芪汤、海藻甘草汤、吴茱萸汤、真武汤、四逆汤、附桂理中汤、大黄附子汤、温氏奔豚汤、补中益气汤；治水气病经验方：小青龙虚化汤、瓜丹桂枝苇茎汤、麻辛四逆汤、麻辛附桂理中汤、麻辛真武汤、三饮四石汤、黄芪五苓三妙散、真武麻灵蛭虫丸、大附夏苓醒脾汤、破格救心汤、破格真五黄芪汤、奔豚干姜紫石汤；治水气病思路：水肿皆当先解表，伏邪入里当外透，中气不足二便变，命火阳根蒸气化，下病治上补中上；勿因局部专治水，起死回生汗法妙，五味主药大法握，三焦合一调整体。

关键词 水气病 常用方 经验方 治疗思路 李可 医案

临床上经常会遇到与中医水气病有关的疾病，如脑水肿、内耳积水、胸腔积液、腹水、膝关节积液、全身水肿等。对于这些西医病，如何从中医水气病的角度去整体把握，这是个实际问题。李可对此有着丰富经验，现根据其医案，整理出以下内容。

1 验案

李可治水气病理论，多散见于医案。必须先看其医案，然后再进行理论探讨。

1.1 头面水肿

脑出血、水肿 一农妇，37岁。患原发性高血压18年，由于暴怒引发蛛网膜下腔出血，昏迷48小时，醒后暴盲。诊见寒战、咳逆无汗，查颅内血肿、水肿，双眼底出血、水肿。眼科名家陈达夫云：凡目疾，无外症而暴盲，为寒邪直中少阴，玄府（毛孔）闭塞所致，当用麻黄附子细辛汤温肾散寒。此妇禀赋素壮，证见寒战无汗，纯属表实，与少阴无涉，遂予麻黄汤一剂令服。次日诊之，夜得畅汗，小便特多，8小时约达3000ml，头胀痛得罢，目珠胀痛亦止，

目赤亦退，血压竟然复常，已可看到模糊人影。又以通窍活血汤冲服水蛭末 12 克，调理一段，终于复明，左、右眼视力分别为 1.2、0.8（286 页）。

按 从本案的病机来看，由于寒袭太阳之表，玄府闭塞，寒邪郁勃于内，气机逆乱上冲。邪无出路，遂致攻脑、攻目，邪之来路，即邪之出路，随着汗出，表闭一开，邪从外散，肺气得宣，水道得通，小便得利，郁结于大脑及眼底瘀血、水肿亦随之而去，脑压迅速复常。

急性肾炎面肿 王某，女，34 岁。患急性肾小球性肾炎，住院 3 个月，服中药 70 余剂，前后经 7 个月，中西药物罔效。脑血流图示初期脑动脉硬化。其症面肿，如葫芦状，乃过用激素所致。面颊着枕之一侧，晨起肿甚，目不能睁，按之成凹坑，尿少，头眩，面赤如醉，肢麻，似有抽搐感。脚膝无力，不肿，畏恶风寒，口苦烦渴。舌红苔黄，血压正常，脉浮滑而数。病虽缠绵 7 个月之久，风水表症仍在，郁久化热，肝阳化风上扰。拟麻黄连翘赤小豆汤合镇肝熄风汤加止痉散：麻黄、杏仁各 10g，连翘、赤小豆各 30g，甘草 10g，赭石、怀牛膝各 30g，白芍、龙牡、龟板、元参、天冬各 15g，青蒿 10g，“全虫 3g，蜈蚣 2 条”（研末冲服）。上药服 3 剂，得汗，面肿消去七八，面赤退，肢麻亦减。唯觉服后有几分钟之心悸烦躁感，且连续三晚失眠。仍予原方加蝉衣 15g，2 剂。服后肿退净，心悸烦躁未出现。表症既解，疏镇肝熄风汤、止痉散加桃仁、红花各 10g，又服 6 剂，蛋白尿消失而愈。

按 余经治急性肾炎数百例，风寒表实者，迳投麻黄汤；体虚者用麻桂各半汤小发其汗，兼见里热者用麻黄连翘赤小豆汤加生石膏，三五日即愈。很少有超过 1 周者。

内耳积水 曹某，男，62 岁。1987 年 10 月 17 日急诊，患者于昨晚 1 时许，睡梦中突然剧烈心跳惊醒。随觉脐下有气上攻，呕吐痰涎不止，头痛，眩晕，不能自持，觉整座房屋如走马灯相似，旋转不停，心中恐惧，闭目宁神亦无济于事。约 10 余分钟后稍好，移时又发作如前。天亮后请西医检查，心脏、血压正常，诊为美尼尔氏综合症。诊脉沉滑，舌胖苔腻。遂拟：泽泻 90g，白术 36g，党参、吴茱萸各 30g，炙草 15g，生半夏、茯苓、紫石英、龙牡、磁石各 30g，生姜 30g，姜汁（兑入）20ml，大枣 20 枚。浓饮，呕止后每次 200ml，3 小时 1 次，日夜连服 2 剂。再诊：已能下床活动，腻苔退净，唯觉腰困脚折，予原方去吴茱萸加肾四味，滋养肝肾，又服 3 剂而愈（272 页）。

按 《金匱》关于痰饮病人的病因、病机、症状的描述，与现代内耳眩晕症十分契合。案中三方，实为本病之特效疗法。泽泻汤之泽泻利水排饮，使水饮从小便而去，白术补中燥湿，以杜生痰之源，使痰饮不再复聚：小半夏加茯苓汤降逆止呕，利水化饮；吴茱萸汤暖肝和胃，降逆补虚，温化寒饮，更擅解一切痉挛，迷路之痉挛解，积水去，耳窍复清虚之常，其症自愈。

1.2 胸腔积液

结核性胸膜炎、胸腔积液 张某，男，24 岁。1979 年初诊：晋中二院 x 片报告：“重症双侧结核性渗出性胸膜炎、胸腔积液。”患者痰湿体型，肥胖而面色灰滞。自幼患气管炎，畏寒有汗，喉间有痰鸣音，咳喘剧而胸闷痛，舌白腻不渴，脉弦迟 58 次/分。先予加味小青龙汤宣化上焦：附子 15g，麻黄 10g，杏仁 12g，厚朴、桂枝各 10g，赤芍 15g，炙草 10g，壳白果打 21 枚，炙紫苑、冬花各 12g，生半夏 20g，干姜、五味子、细辛、红参（打小块吞）各 10g，生姜 10 片，大枣

10 枚。上药服 2 剂，外证悉除，咳喘愈，痰鸣消失。继予：瓜蒌 30g，薤白、桂枝各 15g，白酒 100 瓜 1，桃杏仁各 12g，生半夏 20g，丹参 30g，檀降香、木香各 10g，砂仁 5g，生苡仁 45g，冬瓜仁（打）60g，泽泻 15g，肉桂 10g，茯苓 30g，炙草 10g，生姜 10 片，大枣 10 枚。服 5 剂后，胸透，积液吸收而愈（48 页）。

按 此属外寒内饮，阴邪窃居阳位，先予加味小青龙汤宣化上焦，后拟瓜蒌薤白桂枝汤合千金苇茎汤、丹参饮合方，活血行气振胸阳而化饮。

结核性心包炎、心包积液 胡某，女，22 岁。初诊：山西医二院诊为结核性心包炎、心包积液，II 度房室传导阻滞。已用抗痨、激素、利尿等法治疗 3 月，仍觉胸前区滞闷刺痛，有时痛牵背部，觉似有一磨盘压于胸上，咳喘连声不断，面色灰滞，唇指青紫，心悸，下肢凹陷性水肿，脉弦迟搏指 52 分，舌暗，苔白腻。现仍觉时时恶寒，肩背沉困，周身肌肉、关节烦疼。遂拟：红参（另炖）、灵脂各 10g，羌活、独活、前胡、柴胡、川芎、枳壳、桔梗各 6g，茯苓 12g，桃杏仁各 10g，薄荷 3g，炙草 5g，生姜 3 片，大枣 4 枚。二诊：药后全身润汗，甚觉舒适，且自得汗后，小便增多，已不咳喘，不仅外证悉除，胸际已觉开阔，脉弦迟 60 次/分，已无搏指之象。再拟瓜蒌薤白桂枝汤合千金苇茎汤、丹参饮合方参灵散，益气活血和营，振胸阳，化瘀消痰为治。三诊：药进 3 剂，小便大增，日夜在 2000ml 以上，胸际滞闷、刺痛大减，下肢肿退，紫绀已很轻微，食纳大增，脉弦缓 71 次 7 分。方已中的，守服 10 剂，诸症悉除（49 页）。

按 症由风寒外袭，失于疏解，水饮内停，渐渐深入于脏，来路既清，先拟人参败毒散扶正托邪，使深伏之邪有外达之机。

1.3 腹腔积水

结核性腹膜炎、腹水 梁某，男，77 岁。急诊住院，主症为全身浮肿、怕冷、低烧、无汗，上腹部绞痛呕吐。B 超见右肋下 15x13cm 之囊性肿物，白细胞 19.5x10⁹/L，血沉 72mm/小时，最后诊断为结核性腹膜炎、急性胆囊炎。经急性期对症疗法，1 周后出现腹水，抽水 2 次，旋抽旋肿。病危出院邀诊。刻诊大腹胀隆，脐凸胸平，喉间痰鸣，咳喘胀急，不能平卧。下肢烂肿如泥，脚膝冰冷。面色灰暗，两目无神，心悸，神疲嗜睡，不食、不渴，尿少、全身不时颤动。患病 35 日，始终憎寒无汗。舌红如柿，无苔而干，舌中裂纹纵横，脉促细，132 次/分。拟助阳解表泻浊为治：麻黄 15g，附子 30g，细辛、红参（另炖）各 15g，油桂（后下）10g，茯苓、白芍各 45g，白术 30g，生姜 45g，加冷水 1500ml，文火煮取 600ml。3 次分服，3 小时 1 次，得汗则止，不必尽剂。二诊：四肢回温，腹胀略松，知饥思食，已可起坐。仍憎寒无汗，欲厚衣被。目珠、胸腹发黄，黄色灰暗，尿黄量微，脉沉细，92 次/分，已无促象，舌色依旧。表气闭阻日久，寒湿不化，发为黄疸。药随症变，原方合茵陈五苓散，温阳泻浊，扶正气以开表闭，2 剂。煎服法同上，得汗去麻黄。三诊：得畅汗，上闭一开，下窍立通，尿量大增，从昨夜 23 时至今晨 8 时，尿量约 300ml 以上，腹水消去大半，黄疸退淡。以下治肿物从略（58 页）。

按 患者年近八旬，肾气已衰，初病憎寒发热无汗，正虚无力鼓邪外透，兼见呕吐腹水。乃少阴（肾）虚寒为本，兼见太阳表寒实，渐传太阴（肺、脾）里虚寒证，肺、脾、肾二脏俱病。拟麻附细汤温肾助阳解表为先，开太阳之表，宣肺闭而通水道，合真武汤温阳泻浊，益火之原，以消阴翳，加人参助元气，**加油桂以蒸动下焦气化。**

肝硬化腹水 陈某，女，60岁。患肝硬化7年，重度腹水，肚大如瓮，青筋外露，畏寒不渴，下肢烂肿，胸背四肢布满蜘蛛痣，面黧黑，肌肤甲错，便燥如羊粪球，三五日一行。左天枢压痛甚著，脉沉弦，舌淡胖有齿痕，舌尖、舌左边瘀斑成片。予真武汤加红参、灵脂、麻黄各10克，大黄蛰虫丸2丸（包煎），温通之。一服得汗，小便日夜2000…以上，下瘀泥样黑便，日二行，稍见气怯。原方去麻黄，又服10剂。腹水消尽。予肝硬培元固本散，服完痊愈（401页）。

按 证属寒湿困脾，水蓄于中，久损于肾，蒸化无权，拟真武麻灵蛰虫丸温阳泻浊开表、醒脾消癥。

肠癌肝转移腹水 许某，男，56岁。2003年8月，发现肠癌，术中发现已转移至肝，遂进一步手术切除，并作介入、化疗，配服抗癌清热解毒散结中药。今年减重54，不思食，午后发热，渐渐畏寒。8月7—23日二次彩超对比，肝内巨块型转移癌，续有增大，且见多发胆结石，脾肿大、腹水形成，右肾囊肿。刻诊，面部嫩红鲜艳如涂油彩，两尺脉大，唇紫暗，舌淡胖。腹胀，食人胀加，一度发生子时后胸憋气促达4小时。夜寐难，气怯，语言低微。久病耗伤，太阴、少阴两本动摇，肾不纳气，元阳浮越堪虑。处方：①漂海藻250g，金钱草120g，加水3500ml，文火煮取3000ml，代水煎下药：制附子100g，干姜90g，白术90g，红参（捣碎）90g，炙草120g，砂仁30g，龟板（捣碎）10g，油桂（冲）6g，麻黄5g，细辛（后一刻）45g，清全蝎12只，大蜈蚣12条，车前子（包）10g，茯苓45g，白芥子（炒研）10g。文火煮取300ml，3次分服，每次对人童便10ml。方中附子逐日叠加10克，以唇、舌微麻为度。②20头三七200g，血琥珀、高丽参、鸡内金、二杠、冬虫草、藏红花各100g，沉香50g。制粉3克，日2次，热黄酒调服。以下从略。

按 为今之计，所患何病已无关紧要，法宜救太阳以保少阴，少佐消积，七补三攻，扶正为主。拟麻辛附桂理中汤合潜阳丹止痉散加味。

宫颈癌腹水 郭某，女，50岁。1980年12月13日初诊，病程1年半，曾在省肿瘤医院住院8个月，放疗配服中药，渐延全身浮肿，腹水一一而出院。体重下降20公斤，现体重37.5公斤，骨瘦如柴，一身大肉尽脱。纳呆，日进食不足4两。出血淋漓不断，少腹胀痛如锥刺，黄赤相杂之秽臭带特多，日用卫生纸一包。舌淡而干，舌中裂纹，中心有5分硬币大之无苔区。当以抑木扶，醒脾救胃为先：生芪45g，当归、红参（另炖）、灵脂、柴胡、棉子炭、白芍各15g，炒麦芽60g，炒谷芽30g，曲楂炭、姜炭各10g，焦白术、茯苓、生苡仁、猪苓各30g，泽泻18g，油桂5g，炙草10g，鲜生姜10片，大枣10枚。二诊：服上方10剂，不仅食纳大增，日可进食斤许，且舌上裂缝弥合，浮肿、腹水基本消退。出血大减，带下亦减，已不用卫生纸。半月之间，前后判若两人。以下从略。（357页）

按 证属脾胃大伤，中气下陷，脾不统血，气不摄血重症。当下病治上，从重建脾胃元气入手，以补中益气汤合五苓散益气健脾利水，参灵散、炒二芽益气醒脾化瘀，姜炭、三仙炭温脾统血。

1.4 膝关节积液

膝关节积液 刘某，男，76岁。初诊：60岁时深秋涉水过河，寒湿入骨，患双膝关节肿痛达16年。近日外感引发宿疾，双膝关节肿痛积液50天。用风湿宁1号，强的松30余日，肿势日重。双膝肿大如斗，憋胀难忍，曾抽取透明

胶粘液体 400ml，旋抽旋肿。左腿强直，不能打弯，卧床不起已 1 月。面色苍白，气短乏力，寸脉极弱。曾服四妙、五苓合方无效。遂拟黄芪五苓三妙散 5 剂：生芪 45g，防己 12g，桂枝 10g，赤芍 15g，川芎 10g，苡仁 45g，茯苓 30g，泽泻、独活各 15g，白术 30g，炙草 10g，白芷 10g，生姜 5 片，大枣 6 枚。二诊：上药服 2 剂后，小便畅通，日夜约 200ml 以上，肿减强半，可以扶杖出游。5 剂服完肿痛全消，已参加田间劳作（251 页）。

按 傅山先生云：“凡治下焦病，用本药不愈者，须从上治之。”即《内经》“下病上取”之义。高年久病体弱之人，中焦脾胃气虚，则聚湿成水，下流关节。用补气升提之法，益气健脾而运湿气旺则周流全身，而水湿得化，亦即“气能化水”之理。

1.5 全身水肿

肺心病心衰水肿 闫某，男，60 岁。1995 年 3 月 24 日病危邀诊。诊见患者昏迷不醒，吸氧。面如死灰，唇、指、舌青紫，头汗如油，痰声漉漉，口鼻气冷，手冷过肘，足冷过膝，双下肢烂肿如泥，二便失禁，测不到血压，气息奄奄。询知患阻塞性肺气肿、肺心病代偿期达 10 年。本次发病 1 周，县医院抢救 6 日，病危出院，准备后事。昨夜子时，突然暴喘痰壅，昏迷不醒。县医院内科诊为“肺心病心衰、呼吸衰竭合并脑危象”，已属弥留之际。切脉散乱如雀啄屋漏，移时一动。遂投破格救心汤大剂加味：附子 150g，干姜、炙甘草各 60g，高丽参（另炖）30g，生半夏 30g，生南星、菖蒲各 10g，山萸肉 120g，龙牡粉、磁石各 30g，麝香（分冲）0.5g，生姜 30g，大枣 10 枚，姜汁（兑入）1 小盅。病情危急，上药加开水 1.5 公斤，武火急煎，随煎随灌，日夜连服。二诊：服完 1 剂，子时过后汗敛喘定，厥冷退至肘膝以下，手足仍冰冷。面色由灰败转为萎黄，紫痞少退，痰鸣大减。呼之可睁眼，神识仍未清。六脉迟细弱代，48 次 7 分，已无雀啄、屋漏之象，回生有望。嘱原方附子加足 200g，余药不变，日夜连服 3 剂。三诊：患者已醒，唯气息微弱，声如蚊蚋，四肢回温，可以平卧，知饥索食。脉沉迟细，58 次又分，已无代象。多年来喉间痰鸣消失。药后当夜，尿湿大半张伊褥，腿已不肿，病已脱险，元气未一复。原方去生半夏、生南星、菖蒲、麝香，加肾四味各 30g 温肾固脱（6 页）。

按 此症子时濒危未死，子时后阴极阳生，已有一线生机。遂投破格救心汤大剂，当夜尿湿大半张床褥，腿已不肿，正是大剂量附子破阴回阳之效。真阳一旺，阴霾自消。

布氏杆菌病心衰水肿 张某，男，28 岁。患者从事牧羊 3 年，传染布氏杆菌病 1 年半，迁延失治，心、肝、肾实质均受损害。半月前因感冒而突发心衰，经省人民医院抢救 5 日无效，病危出院，准备后事。诊见患者端坐呼吸，频咳暴喘，喉间痰鸣漉漉，呕吐涎沫；面色灰暗，神情萎顿，似睡似醒，唇指紫暗，胸痛彻背；全身凹陷性水肿，脐凸胸平，睾丸水肿，尿少，日夜约 150ml；厌食，食入则胀急欲死；憎寒无汗，亦无涕泪；脉促，114 分，频见雀啄；舌紫暗，满布紫黑瘀斑。遂拟：附子 200g，干姜、炙草各 60g，高丽参（另炖）30g，五灵脂 30g，山萸肉 120g，龙牡、磁石、煅石英、瓜蒌各 30g，薤白 15g，白酒 1004，丹参 30g，檀降香、砂仁、肉桂各 15g，桂枝、白术各 30g，茯苓 45 克，猪苓、泽泻各 15g，桃杏仁各 15 克，麻黄、细辛各 10g，生姜 30g，大枣 15 枚，麝香（分冲）1g。五日夜连服 3 剂，3 小时 1 次。当服第 1 次药后，头部见汗，喘咳

顿减；服第2次药后，全身得畅汗，小便大增，日夜达3000ml以上，水肿消去十之七八，脉沉弱82次7分，脱险（11页）。

按 本案患布鲁氏杆菌病1年半，迁延失治，渐致虚劳。此次因新感引动伏邪，憎寒无汗，频咳暴喘，全身凹陷性水肿，突发心衰，生命垂危。以麻黄附子细辛汤合破格救心汤，温里寒，开表闭，透伏邪，日夜连服3剂而脱险。（10页）

慢性肾炎水肿 杨某，男，61岁，去大同看望儿子，旅途感寒。到大同后次晨，突然浮肿尿少，寒热如疟而入某医院，诊为慢性肾炎急性感染，住院50日，病情恶化，由儿子送回家乡，准备后事。初诊：某医院诊断：慢性肾炎尿毒症。尿蛋白（++），二氧化氮结合力35，尿素氮50。诊见患者葫芦脸型，头痛呕吐厌食，大便色黑，小便如浓茶，量少。全身肿胀，腰痛如折，口臭，有烂苹果味。舌苔黑腻，脉沉细涩。拟大黄附子汤加味：附子30g，大黄15g，细辛10g，红参（另炖）、灵脂各15g，生半夏、茯苓各30g，猪苓、泽泻、焦三仙各15g，炙草10g，肾四味60g，芒硝（分冲）15g，生姜30g，姜汁（兑入）10ml，大枣10枚，3剂。二诊：上方服后呕止，食纳增，小便渐多，色转淡。原方去生半夏，生姜减为10片，加生芪45g，续服3剂。三诊：黑便变为黄软便，尿多色清，下肢肿胀已退其半，食纳大增。原方大黄、芒硝为10g，生芪加至60g，10剂。四诊，患者肿全消，食纳逾常。化验血、尿均无异常发现。邪退正虚，气短懒言，腰仍微困。予培元固本散一料善后。

按 证属肾炎久延，邪实正虚，水湿浊秽入血化毒，三焦逆乱，胃气败坏，肾阳衰微。拟大黄夏苓醒脾汤温阳益肾，荡涤湿浊为治（163页）。

2 方药

2.1 头面方药脑出血、水肿证

见寒战无汗，纯属表实，以麻黄汤；若寒邪直入少阴，脉沉细者，予麻黄附子细辛汤开肺透邪，得汗后水肿迅速消退（42页）。急性肾炎，风寒表实者，迳投麻黄汤，体虚者用麻桂各半汤小发其汗，兼里热者用麻黄连翘赤小豆汤加生石膏。三五日即愈，很少有超过1周者；慢性肾炎，以麻辛四逆汤加红参、生姜、葱白扶阳开表透邪，连服3个月（162页）。美尼氏综合症之内耳积水，脾虚痰饮上泛者，用三饮四石汤；肾虚阴邪上逆者，用奔豚四石汤（273、387页）。

2.2 胸水方药

胸为心肺之所居，属于上焦。结核性胸膜炎、胸腔积液，结核性心包炎、心包积液，或以小青龙汤解表化饮，或以人参败毒散益气解表。表解后当治里，以《金匱》瓜蒌薤白桂枝汤振胸阳而化饮邪，合丹参饮行气，活血则水行，更加千金苇茎汤化痰排饮，加杏仁开肺，茯苓利水，木香通三焦，一般48小时即可解危（51页）。

2.3 腹水方药

结核性腹膜炎、腹水，证属肺、脾；肾二脏俱病者，以麻黄附子细辛汤助阳解表，合真武、五苓散温阳泻浊，加人参助元气，油桂以蒸动下焦气化（59 页）。肝硬化腹水，予真武麻灵蛭虫丸温通之；或以温氏奔豚汤合醒脾汤益火之原，以消阴翳（181、401 页）。肠癌肝转移腹水，以附桂理中汤补火生土，麻附细助阳开表透邪，三苓、海藻甘草汤泻浊，止痉散消瘤止痛。宫颈癌腹水，证属脾胃衰败上大虚，腹腔积水下大实，抱定“扶正邪自退，养正积自消”的宗旨，着眼整体用补中益气汤合醒脾以建中气，佐五苓散加油桂温肾健脾利水（358 页）。

2.4 膝部方药

膝关节积液分为 4 型：脾虚不运湿者，以黄芪五苓三妙散，阳虚显露者，以阳和汤合黄芪五苓三妙散；阳虚者，以济生肾气丸加黄芪温肾健脾化湿；急性感染者，暂用忍冬藤、芙蓉叶、四妙散合活络效灵丹，清热化瘀利湿，继以益气健脾运湿收功（249 页）。

2.5 水肿方药

肺心病水肿兼昏迷痰壅者，以破格救心汤大剂破阴回阳，合三生饮加生半夏、节菖蒲、竹沥豁痰开窍（6 页）。布氏杆菌病心衰水肿者，证属少阴与太阳同病，以破格救心汤大剂合麻黄附子细辛汤开表透邪，加油桂、五苓蒸动下焦气化而利水，更合瓜蒌薤白白酒汤、丹参饮开胸涤痰破瘀（10 页）。慢性肾炎尿毒症水肿者，以大黄附子汤加芒硝温阳荡涤湿浊，夏苓、三苓（茯苓、猪苓、泽泻）降逆止呕利水；参灵、三仙益气化瘀醒脾；肾四味鼓舞肾气（163 页）。

3 经验方

李可治水气病经验方 12 首。现归纳如下：

- (1) **小青龙虚化汤**：麻黄（另煎）10 45g，制附片 45 200g，辽细辛（蜜炙）45g，生晒参（另炖）15 30g，生半夏 45 65g，干姜 30 45g，五味子 30 38g，炙紫苑、炙冬花各 15 45g，壳白果（打）20g，炙草 30 60g，桂枝、赤芍各 45g，生姜 65g。如结核性胸膜炎、胸腔积液案（47 页）
- (2) **瓜丹桂枝薤茎汤**：瓜蒌 30g，薤白 15g，白酒 100ml，桂枝、赤芍、炙草各 15g，生半夏 30g，丹参 30g，檀降香、砂仁、木香各 1，芦根、苡仁各 30g，冬瓜仁 60g，桃杏仁各 12g，生姜 45g，大枣 12 枚。如结核性心包炎、心包积液案（50 页）
- (3) **麻辛四逆汤**：麻黄（另煎）30 45g，细辛 45g，制附子片（逐日叠加 10 克）30g，干姜 30g，红参（另炖）15g，生姜 30g，葱白 4 寸，炙草 60g，服至全身畅汗，麻黄减为 5 10g。如慢性肾炎水肿案；
- (4) **麻细附桂理中汤**：麻黄（另煎）30 45g，细辛 45g，制附子片（逐日叠加 10 克）30g，肉桂 10g，干姜 15g，白术 30g，炙草 60g，服至全身畅汗，麻黄减为 5 10g。如肠癌肝转移案；
- (5) **麻辛真武汤**：麻黄（另煎）30 45g，细辛 30 45g，制附子片 30g，油桂 10g，茯苓、白芍各 45g，生姜 45g，服至全身畅汗，麻黄减为 5 10g。如结核性腹膜炎、腹水案（59 页）

- (6) **三饮四石汤**：泽泻 90g，白术 36g，红参（另炖）、吴茱萸各 30g，炙草 15g，生半夏、茯苓、煅紫石英、龙牡、磁石各 30g，生姜 30g，姜汁 20ml，大枣 20 枚。如美尼氏综合症内耳积水案（387 页）；
- (7) **黄芪五苓三妙散**：生芪 45g，桂枝 10g，白术、茯苓各 30g，猪苓、泽泻各 10g，生苡仁 45g，苍术 15g，川牛膝 30g，白芷、炙草各 10g。如膝关节积液案（250 页）；
- (8) **真武麻灵蛭虫丸**：制附子 45g，白术 30g，茯苓、白芍、生姜各 45g，麻黄、红参、灵脂各 10g，大黄蛭虫丸（包煎）2 丸。如肝硬化腹水案（400 页）
- (9) **大附夏苓醒脾汤**：制附子 30 100g，酒大黄 15 30g，细辛 15g，生半夏、茯苓各 30g，猪苓、泽泻、红参（另炖）、五灵脂、焦二仙各 15g，肾四味 80g，芒硝（分冲）15 20g，炙草 10g，生姜 30g，姜汁（兑入）10ml，大枣 10 枚。如慢性肾炎水肿案（163 页）
- (10) **破格救心汤**：制附子 30 100 200g，干姜 60g，炙甘草 60g，高丽参（另炖）10 30g，山萸肉 60 120g，龙牡、磁石各 30g，麝香（分冲）0.5g。如肺心病心衰水肿案（6 页）
- (11) **破格真五黄芪汤**：制附子 30 90g，干姜 30 60g，炙草 60g，红参（另炖）15g，山萸肉 30 60g，龙牡、磁石各 30g，白术 30g，茯苓、生姜、白芍各 45g，猪苓、泽泻各 15g，油桂 10g，生芪 60g。如风心病水肿案（272 页）；
- (12) **奔豚干姜紫石汤**：制附子 30 100 200g，油桂、沉香、砂仁各 10g，红参（另炖）⁽¹⁾ 30g，山药 60g，茯苓 45g，泽泻 30g，干姜、怀牛膝、煅紫石英各 30g，炙草 60g。如风心病水肿案（9 页）。

4 治疗思路

4.1 水肿皆当先解表

李可指出，“诸症当先解表”似乎是平淡之极、老生常谈。然而正因它平淡，往往被医者忽略，而造成严峻局面。《内经》明示“上工救其萌芽”“善治者，治皮毛”。表居八法之首，凡兼挟外邪诸症，皆当以解表为先，开门逐盗，拒敌于国门之外，最是上策。用之得当，阻断传变，大病化小，小病化了。表未解而误补，则闭门留寇，后患无穷，误攻，则邪陷入里，变生不测（198 页）。他治水气病，特别是慢性肾炎水肿及心衰水肿病人，病程多在 10 30 年不等，均有外感寒邪病史，于对症方内加麻黄一味，提壶揭盖，开宣肺闭，尿量迅速增多而愈（9 页）。这些水肿病史竟达 10 30 年，仍然先解表，令笔者迷惑不解。因为新病多外感，而久病多内伤。李可在“重度心衰合并肾衰水肿案”中讲出了感悟过程：患者肾衰无尿，以破格救心汤合小青龙汤，能在一日之间十去其八，实在出乎意料。事后揣摩，除破格救心汤温阳消阴，蒸动膀胱气化外，得力于麻黄一味。因肺为水之上源，主通调水道，下输膀胱。今寒邪闭肺，水道不通，故聚水成肿。用麻黄发汗解表，开提肺气，肺气升则水道通，水肿迅速消退（9 页）。从此，“水肿当先解表”便成为一般规律，或以麻黄汤发汗解表，或以小青龙汤解表化饮，或以人参败毒散益气解表，病例比比皆是。

4.2 伏邪入里当外透

李可认为，水肿何以演变为三阴寒凝、气化冰结之局面？邪之中人，初必在表。失治则由表入里，正气愈虚，邪陷愈深。待病邪深入血分，侵入五脏，在治疗上便成“半生半死”之局。水肿病人，均有外感寒邪久伏病史，可于对症方内加入麻黄开提肺气，细辛透发伏邪，得微汗之后水肿迅速消退而愈（10、22 页）。他把麻附辛法，广泛融于温阳方四逆汤、真武汤、附桂理中汤、破格救心汤中，便是明证。

4.3 中气不足二便变

李可指出，脾胃居中焦，为升降枢机。胃气不降，诸经气皆不能降；脾气不升，诸经之气皆不得升。若因劳倦伤脾，寒凉败胃，使中焦升降出人之机能乖乱，则诸阳之气不能敷布，后天之精微无所归藏，饮食水谷精微不能摄入，废浊之物不能排出，则诸证丛生，甚则大小便不能排出，正如《内经》所述“中气不足则溲便为之变”。此即中焦气化之要（157 页）。如“宫颈癌腹水案”指出：证属脾胃大伤，中气下陷，脾不统血，气不摄血重症。切忌见癌治癌，妄用攻癌之剂。宜着眼整体，抱正“扶正邪自退，养正积自消”的宗旨，当下病治上，从重建脾胃元气入手，以补中益气汤合五苓散益气健脾利水，参灵散、炒二芽益气醒脾化瘀，姜炭、三仙炭温脾统血。此方仅服 10 剂，不但食纳大增，日可进食斤许，且舌上裂缝弥合，是胃气已复之证，出血大减，浮肿、腹水基本消退，前后判苦两人（358、361 页）。

4.4 命门阳根蒸气化

李可认为，肾居下焦，为先天之本，气化之根。内寄命门之火，主温煦万物。此火一衰，膀胱寒水便成冰结，欲出而不能矣。故治三焦气化乖常诸疾，必以桂附辛热善动之品，直入命门而补其火，火旺则阴凝解而气化得以蒸腾。若方药对症而收效甚微，必是局部冰结不化，加油桂开冰解冻（157、252 页）。如“结核性胸膜炎、胸腔积液案”指出：病机为胸阳不振，浊阴窍踞阳位，阻塞上、中焦气化，以瓜丹桂枝芎茎汤振胸阳化饮邪，加油桂开冰解冻（48 页）。又如“肺心病心衰水肿案”：患者昏迷不醒，初服破格救心汤大剂合三生饮。夜间尿湿大半张床褥，腿已不肿。方中无一味利水药，正是大剂附子破阴回阳之效，真阳一旺，水肿尽退（7 页）。

4.5 下病治上补中上

李可指出，下病治上法，源自《灵枢》，傅山先生将此法具体化：“凡治下焦病，用本药不愈，须从上治之”。因肺主一身大气，又主通调水道；脾胃为中气，主运化水湿，又是三焦气化的枢纽。故下部水湿停聚，上气必虚，重用生芪补中上之气，气旺则周流全身，气行则水行，水湿自去。若见右寸沉微，即宜早投五苓散加生芪 45g，柴胡、升麻各 10g，补气升提化湿，详见膝关节积液案（214、252 页）。

4.6 三焦合一调整体

4.6.1 勿因局部专治水

李可认为，一切水湿停聚，方药对症而收效甚微，必是局部冰结不化。调整体以治局部，勿因局部而害整体，则不专治水而水病自愈。若无实热的据，勿轻用苦寒之剂，以免三焦气化冰结。热毒结于局部，暂用清热解毒利湿，中病即止，不可过剂。下面举例证之：

脚肿误治 李某，女，16岁。初诊：脚气3年，今冬脚冻成疮。近3日感染肿烂，脓水淋漓，红肿掀痛，不能步履。予清湿热解毒：生苡仁45g，苍术、黄柏、川牛膝各12g，忍冬藤、芙蓉叶各30g，公英、地丁各20g，白蔹、车前子、甘草各12g，生姜5片，大枣10枚。二诊：药进3剂，肿烂减而未愈。足背青紫，膝以下冰冷，右寸沉细。予益气温经和营：生芪45g，当归30g，桂枝12g，赤芍15g，吴茱萸10g，炙草、桃仁、红花、通草、细辛各10g，生苡仁45g，白蔹12g，生姜20g，大枣10枚。三诊：肿烂结痂，脚膝温，色红活，原方去白蔹（liǎn）再服3剂善后。

按 文革以后，余之家境闲顿，求饱已属不易，故尔“藜藿之体气血穷”，长女未病正气先虚。初诊未念长女及此，见病治病，徒以清热解毒为能事，损伤中气，出现寒化、虚化。二诊下病治上，又合当归四逆加吴茱萸生姜汤温经而治冻疮，重加生芪之益气生肌化腐，在下之疮疡立愈。

4.6.2 起死回生汗法妙

李可治水气病常用方有麻黄汤、小青龙汤等19首，其中水肿方仅3首（防己黄芪汤、五苓散、真武汤），而解表方却5首，即解表方多于水肿方，这是为什么？“布氏杆菌病心衰水肿案”指出：患者重度心衰，憎寒无汗，全身凹性水肿，脐凸胸平，睾丸水肿，尿少日夜久150ml。已下了病危通知书。遂以破格救心汤加麻黄、细辛开表闭，仅服2次药，全身得畅汗，小便大增，日夜达3000ml以上，水肿消去十之七八，次日雀啄脉消失，脱险。于是李可感言：历来视汗法为小技，病至奄奄一息，汗法似无用武之地。殊不知，此际妥施汗法切中病机常常扭转败局，救人性命。汗法之妙，竟有起死回生之效。《内经》说：善治者治皮毛”，不单是为表证立法，也是治疗重病、难症、痼疾的法宝（11、22页）。他一方面对表证的辨证进一步深化，将表证分由两个层次，如典型表证为发热恶寒，无汗，头身痛，颈项强，四脚酸楚等；隐匿表证为肩背沉困如压一石板（3页），胸部如压一石磨感，痛引肩背（49页），全身如绳索捆绑（27页），背部似冷水浇灌（27页），全身起鸡皮疙瘩（161页），偏头无汗（161页），每进食胸背无汗（28页），皮肤痒痛等（317页）；另一方面将汗法频频用于内伤杂症重病，扩大了解表法的应用范围。这对用好汗法有着指导意义。

4.6.3 五味主药大法握

李可治水气病大法：水肿皆当先解表，伏邪入里为外透，中气不足二便变，命门阳根蒸气化，下病治上补中上。其大法各有主药：

(1) 解表主药麻黄。

李可研究麻黄有独特视角：

- ① 麻黄为什么要先煮去上沫？因上沫中有瞑眩物质，服之令人头眩，面赤而呕，先煮去上沫可免此弊。
- ② 现代人煮麻黄为什么见不到沫？因为现代人用麻黄剂量太小，10 克左右不会有沫，一两（巧克）以上，水开了一分到一分半钟上边有一层沫。
- ③ 麻黄基础有效量是多少？仲景发汗解表剂中，**麻黄用至三两（45 克），正是伤，寒方的基础有效量，低于此则无效。**
- ④ 麻黄为什么要另煎？使用麻黄峻剂时，根据“得汗则止，不必尽剂”原则，指它别煎出来放到一边，使用主方的时候每次兑麻黄汁三分之一，得汗止后服，去掉不用了，而同煎则不易取舍。
- ⑤ 麻黄怎么服法？麻黄 45 克另煎去上沫，取汁 150ml，第一次兑服三分之一；若无汗，则一个半小时再给药一次；若得全身畅汗，则余药弃之不用；若仅得微汗，3 小时再给药一次。
- ⑥ 服麻黄虽无汗却小便多，还须强发汗吗？有的病人，虽无汗却小便多，咳、肿皆消，此为肺气已开，外邪下走空窍而出，亦为中病，勿须强发汗。
- ⑦ 麻黄 45 克仍然不出汗怎么办？逐日叠加 10 克，有些特殊的病人，我最高时用到 120 克才出汗。
- ⑧ 麻黄的瞑眩反应有哪些？令人昏眩、心悸、烦躁，面赤而呕等。
- ⑨ 怎样防止麻黄之瞑眩效应？余曾治一肺实暗哑患者，于麻杏石甘汤内加入轻灵透窍之蝉衣，汗出声亦出，未见心悸、烦躁等副作用。从此，每用麻黄，必加等量之蝉衣，可有效防止瞑眩反应。
- ⑩ 麻黄有哪些功效：开玄府而发畅汗，通利孔窍，宣通脏腑之气，开鼻塞、明目聪耳，利小便，像阳和汤用麻黄 5 克，便是让它发挥通气的作用。余治皮肤病，凡皮痒痛、痒麻者，多为表气未通，于乌蛇荣皮汤加麻黄 5 克，以通皮部之气。

(2) 透邪主药细辛。

细辛本是医圣手中的秘密武器，亦是医界挠头的药物之一，与川乌、附子同列。应认清以下问题：

- ① 细辛用量不过钱：细辛的问题大概是在宋代出现的这个错误，而且讲话的不是医生，而是一个看守犯人的牢头。当时有一个犯人自杀了，发现在尸体旁边放着些药，他鉴别后认为是细辛粉，后来被时珍老人编著的《本草纲目》引用，流传“细辛不过钱”这样的一种说法（95 页）。
- ② 细辛基础有效量：医圣用细辛共 16 方。凡治外寒内饮、血虚寒凝致四肢厥逆时，重用细辛散寒化饮之功，用量为三两，如小青龙汤、当归四逆汤等 8 方。若本气先虚，少阴阳根不固，兼夹外犯或内生之实邪，则细辛只用二两，并与附子同用，如麻黄附子细辛汤、大黄附子汤等 5 方。其余各方都是丸散，用量及小。由此看出，《伤寒论》**细辛基础有效量是三两。**

- ③ 细辛功效：《本经》论曰：“气味辛温无毒，主咳逆上气，头痛脑动，百节拘挛，风湿痺痛，死肌，久服明目利九窍，轻身长年。”《本草正义》全面总结了细辛之妙：芳香最烈，故善开结气，宣泄郁滞，而能上达巅顶，通利耳目，旁达百骸，无微不至，内之宣络脉而疏通百节，外之行孔窍而直透肌肤。”
- ④ 细辛暝眩：细辛令人恶心、呕吐。有人主张蜜炙一刻钟，以减其辛烈之味，可行。

(3) 中焦气化、下病治上主药黄芪。

李可之经验：

- ① 黄芪功效：黄芪位列本经上品第三，得土气最厚，甘温除热；补中气，运大气；固表气，主大风（一切皮肤顽症的总称），化腐生肌敛疮，脱疽要药，主治先天性心脏、瓣膜缺损。
- ② 黄芪脉证：中气虚弱，脉大而虚；大气下陷，右寸沉微；木不疏土，左关特弱。
- ③ 下病治下，生芪 45 克；补中益气，生芪 60 120 克；脱疽者，重用生芪 240 克；颈椎病、类风湿、红斑狼疮，生芪 120 240 500 克；糖尿病下肢溃烂坏死者，以经方黄芪五物汤，重用生芪 500 克，半月间排尽脓血及黑烂坏死，收口而愈。

(4) 下焦气化主药桂附。

李可用肉桂之经验：

- ① 肉桂功效：补命火，益阳消阴，开冰解冻，宣导百药，温中定痛，引火归原 079 页）
- ② 肉桂剂型：煎剂用于温肾阳、助气化、止泄泻、反佐；粉剂用于降奔豚、护胃阳；米丸用于引火归原。
- ③ 肉桂用量：煎剂（温肾阳、助气化、止泄泻、反佐）用平剂 10 克；粉剂（降奔豚、护胃阳）用小剂 3 6 克；米丸（引火归原）用小剂 1.5 3 克。

他用附子之经验：

- ① 附子证：附子应用分为保健、阳虚、格阳、亡阳、垂死之 5 个等级。保健：附子用小剂 10 15 克。阳虚：附子用小剂 10 20 克；格阳：包括戴阳、隐性心衰，附子用平剂 30 克；亡阳：附子用中剂 45 90 克；垂心心衰：附子用大剂 100 200 300 克。
- ② 四逆汤指证：李可认为，医圣的着眼点，立足点，全在卫护元阳上下功夫。伤寒 113 方，一首四逆汤足矣（3 页）。四逆汤是附子最重要方子，自郑钦安之后，各温阳大家使用频率也是最高的。那么四逆汤之指证是什么？左季云在《伤寒论类方汇参》中归纳了《伤寒杂病论》的有关条文，提出四逆汤之十大指证，即外证为发热、恶寒、汗出、身体四肢痛、手足冷，内证为腹胀满、内拘急、呕吐、下利、或吐利交作。
- ③ 四逆汤功效：仲景四逆汤主要用于外感之“回阳救逆”，故在内伤杂病《金匱要略》中很少提及，仅在“呕吐啖病”中出现过一次。郑钦安则提出：“扶阳祛阴”法，广泛用于内伤杂病。

- ④ 四逆汤新解：李可在前贤四逆汤“回阳救逆”、“扶阳祛阴”的大法基础上，又提出诸法，如“**补火生土**”法，**凡是脾胃病，假使理中无效，速用四逆，就是补火生土**（81 页）。“通阳攻下”法，治肿瘤攻下法不可废，下焦确有寒者，单用四逆汤就有攻下的效果。四逆汤犹如一团火，有雷霆万钧之力，破阴通阳之能（73 页）。“养阳长寿”法，以小剂四逆汤“春夏养阳”，从春分服至立秋，达到养生的目的；60 岁以上的老年人都可以用，可以调整元阳，延年益寿（53 页）。

4.6.4 三焦合一调整体

郑钦安在《医理真传》中指出三焦之气，分而为三，合而为一，乃人身最关要之府，一气舒，则三气不畅，此气机自然之理，学者即在这三焦气化上探取化机，便得和调阴阳之道也（9 页、李可治水气停聚为患，不论表里内外各部，皆从调燮三焦气化入手。其表现如下：

- ① 上病治下：胸为心肺所居，偏于上焦。胸腔积液者，恒以瓜丹桂枝芎茎汤振胸阳治上，加油桂蒸动下焦气化，详见结核性胸膜炎、胸腔积液（48 页）；
- ② 下病治上：膝关节积液者，以五苓三妙散健脾利水，加生芪补中上之阳，白芷宣肺气，开表闭，详见膝关节积液案（250 页）；
- ③ 三焦合一：三阴证水肿者，以四逆、附桂理中，真武汤治中、下焦气化，又频频与汗法结合，如麻辛四逆、麻辛附桂理中、麻辛真武、麻辛破格救心汤，详见肝硬化腹水、肺心病心衰水肿、肠癌肝转移腹水案（8、400 页）。

《金匱要略》水气病分为风水、皮水、正水、石水。**风水**以防己黄芪汤、越婢汤主之；**皮水**以防己茯苓汤、越婢加术汤、甘草麻黄汤主之；**正水**和**石水**没给出方药。**痰饮**病之悬饮者，十枣汤主之；**溢饮**者，小青龙汤主之。以上经方共 7 首。后世治水肿方较多，常用如越婢加术汤、防己黄芪汤、防己茯苓汤、五苓散、五皮饮、大橘皮汤、小分清饮、实脾饮、茯苓导水汤、廓消饮、真武汤、金匱肾气丸、禹功散、舟车丸、疏凿饮子等 15 首，其中经方 5 首。李可治水气病常用方如麻黄汤 19 首，其中经方 15 首；治水气病经验方如小青龙虚化汤 12 首，其中三焦通治方 7 首。从中可以看出，李可治水气病是在前人的基础上有所发展，广用经方治水气，三焦合一治水肿，走出一条“古中医”自身发展的道路。

（选自《李可老中医急危重症疑难病经验专辑》《人体阳气与疾病》）

经时兼收创新方

——李可学术思想探讨之二十(上)

● 孙其新*

摘要 针对李可验方数量之谜,进一步挖掘了《李可老中医急危重症疑难病经验专辑》。李可验首:李氏命名方22首,笔者拟名方78首;李可验方归纳思路:从个案中找灵感,从类案中找规律;从中医找素材,从治法中找特点;从按语中找提示,从疗效中找亮点。

经验专辑》一书(以下简称《李可急危重症经验专辑》),共收集 246 则医案,涉及经方 58 首,时方 66 首,自制方上百首,是研究《李可临床方剂学》的好教材。学习李可的学术思想,要过两道门坎。一是辨证这道坎:李可有独特的思维体系,要走进他的内心世界,需要一点点地往里悟。中医基础好的,解决这个问题,少则 3~5 年,多则数十年;一是处方这道坎:李可的处方,药味多,剂量重,相反相畏药同用,对于循规蹈矩的人来说,只能是望洋兴叹。但处方这道坎必须先过,这样才能看出辨证的玄机来。如李可关于油桂用量:温肾阳、助气化、止泄泻、反佐用平剂;引火归原、降奔豚、护胃阳用小剂;油桂剂型:煎剂用平剂;粉冲(降奔豚、护胃阳)、米丸(引火归原)用小剂(详见《中医之秘在于量》)。笔者根据其医案 246 则,整理出验方百首。

《李可急危重症经验专辑》之“李可医学传略”中指出,自创方剂 28 首。可我查遍全书最后还是凑不成这个数。为此,我在《第二届李可学术思想研讨会》期间,向李老讨教。他说:“那个东西,都是郭博信搞的”。后来我参加“李可八十诞辰学术思想研讨会”,巧好与本书责任编辑郭博信同坐一个车,就又向他咨询。可他又说:“李可传略不可能是我写的,而是他自己写的”。这下就把我搞懵了。李可自制方 28 首之谜,一直是我心中的一个结。事到如今,我只能按着自己的理解,实话实说了。

1.1 李可命名方 22 首

1.1.1 破格救心汤

组成 制附子 30 ~ 100 ~ 200g,干姜 60g,炙甘草 60g,高丽参(另炖) 10 ~ 30g,山萸肉 60 ~ 120g,龙牡、磁石各 30g,麝香(分冲) 0.5g

阴；凡内外妇儿各种重危急症导致阴竭阳亡，元气暴脱，心衰休克（2页）。

方解 心衰病人，不但阳气衰微，而且阴液内竭，故以四逆加入参汤；山萸肉固守附子已复之阳，挽五脏气血之脱失；龙牡固肾摄精，收敛元气要药；磁石吸纳上下，维系阴阳；麝香急救醒神，辟秽开窍。本方破格重用附子、山萸肉后，使仲景四逆汤类方发生质变；麝香、龙牡、磁石的增入，更使本方具备了扶正固脱、活血化瘀、开窍醒脑、复苏高级神经功能，从而救治呼吸循环衰竭，纠正全身衰竭状态，确有起死回生的神奇功效。

用法 病势缓者，加冷水2000ml，文火煮取1000ml，5次分服，2小时1次，日夜连服1~2剂；病势危急者，加开水1500ml，武火急煎，随煎随灌，或鼻饲给药，24

小时不间断口服本方频频咽服1~2

剂。

案例 布氏杆菌病急性心衰
(10 页)。

1.1.2 培元固本散

~2 具,红参 50 ~ 100g,灵脂 30 ~ 50g,三七 50 ~ 100g,血琥珀 30 ~ 50g。

主治 补肾健脾,修复脏器,重建免疫,祛病延年。治一切久损不复、反复发作之大虚证,及虚中夹瘀、夹痰、夹积等证(393 页)。

方解 鹿茸补肾强督,生髓壮骨;胎盘温肾补精,再造免疫;红参大补元气,补脾益肺;灵脂活血止痛,化瘀止血;三七通络定痛,化瘀止血;琥珀镇静安神,活血通淋。

用法 先以汤剂控制病情,缓解期培元固本散善后,日服 2 次,每次 3 克,热黄酒调服,或温开水调服,饭前 1 小时服为好。

案例 糖尿病火不生土(57 页)。

1.1.3 攻毒承气汤

主治 清热解毒,通腑泻热,扫荡血毒;治急性阑尾炎、急性子宫内膜炎、肺痈、肝痈、外科创伤血

30g,芙蓉叶 30g,大黄 10 ~ 45g,芒硝(分冲) 15 ~ 40g,丹皮 15g,冬瓜仁 60g,桃仁 15g,皂刺、炮甲各 10g,槟榔 30g,苡仁 30 ~ 45g,甘草 10g。

方解 大黄牡丹汤泻热化瘀,消痈利气;破格重用疮毒圣药银花,善治痈疽肿毒,芙蓉叶、连翘消肿排脓止痛,更加苡仁、透脓散解毒排脓,槟榔利水消肿。诸药相合,通腑消痈,毒随便泄,危症立解。90% 以上的病人,不待一剂药服完已基本痊愈。

用法 加水过药 2 寸,加白酒 100ml,浸泡 40 分钟;若嗜酒致病者,则不加白酒,浸泡 1 小时,武火煮沸 10 分钟,煎取 600 ~ 1000ml,2 ~ 3 小时 1 次,每次 200 ~ 300ml,

饮,煎送服,并忌辛辣。

案例 阑尾脓肿合并肠梗阻(128 页)。

1.1.4 贯众石膏汤

组成 生石膏 250 ~ 500g, 贯众、黑小豆各 30g, 苍术 15g, 雄黄(研吞)0.3g, 丹皮、紫草各 15g, 蚤休 15 ~ 30g, 青黛(包煎)、甘草各 10g。

主治 瘟疫, 证见大热大渴、呕逆咽痛、谵语神昏、发斑出血(203 页)。

方解 石膏、丹皮、紫草、蚤休合用可代犀角, 退高热有奇效; 贯众、青黛清热解毒化斑; 苍术、雄黄辟秽化浊, 黑小豆制雄黄之毒。诸药相合, 气血两清, 瘟疫自解。

用法 加冷水 1500ml, 浸泡 1 小时, 武火煮沸 10 分钟, 取汁 600 ~ 1000ml, 3 小时服 1 次, 每次 200ml, 昼夜连服, 中病即止。

案例 红斑狼疮(203 页)。

1.1.5 羚羊止痉散

组成 羚羊角 3g, 麝香 1g, 蝎尾 12 只, 蜈蚣 2 条。

主治 醒脑开窍, 治高热惊风

症(71 页)。

方解 羚羊清热解毒熄风,麝香辟秽醒脑开窍,蝎尾熄风定痉,蜈蚣搜风舒挛。诸药相合,清热解毒,开窍熄风。

用法 上药研末,分成 3 包,2 小时 1 次,轻症单服立效,重则配服汤剂。

案例 小儿流脑(76 页)。

1.1.6 涤痰清脑汤

组成 生石膏 200g,丹皮、紫草各 15g,大黄、芒硝(冲)、黄芩、黄柏、煅礞石、生铁落、夜交藤各 30g,节菖蒲、郁金各 15g,生地 45g,黄连 10g,天竺黄、胆南星、甘草各 15g,竹沥(兑入)30ml,人丁

主治 精神分裂症狂躁型,证见发狂、打闹怒骂、不避亲疏(191页)。

方解 石膏、丹皮、紫草合用代犀角,加生地为犀角地黄汤清营凉血;黄连、黄柏、青黛清热泻火;礞石滚痰丸(去沉香)、芒硝逐痰泻火;菖蒲、郁金、胆星、竺黄、竹沥涤痰开窍;牛黄开窍定惊,铁落、夜交藤镇静安神。诸药相合,共奏涤痰清脑之功。

用法 二煎混匀,日分2次服,每次能泻下胶粘状大使,多数在1周内缓解。

案例 青年期精神分裂症(191页)。

1.1.7 辟秽解毒汤

组成 银花 60~90g,白头翁 30g,香薷、藿香、佩兰、黄连、肉桂、牛子、甘草各 10g,白芍 30g,炒扁豆、节菖蒲各 12g,酒大黄 15~30g。

急,突然发热,腹痛,便脓血,惊厥,抽搐,昏迷,心衰或呼吸衰竭(144页)。

方解 本方以藿佩牛子香薷扁豆菖蒲大队芳香化湿之品,透邪于外;重用银花大黄头翁黄连扫荡于内;芍甘理腹痛,肉桂反佐黄连苦寒,使盘踞三焦之病毒,荡涤尽净。

用法 先以三棱针重刺十宣、十二井出血,使之苏醒,然后服汤剂;加冷水 1000ml,浸泡 1 小时,武火急煎煮沸 10 分钟,滤汁,分 3 次服,2 小时 1 次,日夜连服 2 剂,得畅泻后,中病即止,不必尽剂。

案例 危重痢疾(144 页)。

1.1.8 三畏汤

组成 红参 10 ~ 30g,灵脂 10 ~ 30g,郁金 10g,丁香 10g,肉桂 3

主治 化瘀定痛,宽胸除胀,温肾止泻;用于胃肠溃疡,脘痞腹胀,溃疡性结肠炎(178 页)。

方解 红参、灵脂相配,一补一通,益气活血,启脾进食,愈疡定痛;郁金、丁香相伍,开郁止痛,宽胸除胀;肉桂、赤石脂相伍,温肾暖脾,固肠止泻。三畏对药,胃虚痛用参灵,脘痞腹胀用郁丁,便血久泻用肉赤。

用法 二煎混匀,日分 2 次服;用于胃肠溃疡,参灵等分,为散吞服;油桂补命火,入煎剂多用 10 克;油桂护胃阳,粉冲多用 3 ~ 6 克。

案例 胃溃疡大出血(14 页)。

1.1.9 肾四味

组成 枸杞子 15g ~ 30g,酒菟丝子 15 ~ 30g,盐补骨脂 15 ~ 30g,仙灵脾 15 ~ 30g。

主治 益肾精,鼓肾气。凡肾气、肾精虚引起的腰困如折,足膝酸软等(189 页)。

补骨脂、仙灵脾四药入肝肾，药性和平，温而不燥，润而不膩，益肾精，鼓肾气，温阳无桂附之弊，滋阴无熟地之弊。真可谓“善补阳者，须从阴中求阳，则阳得阴助而源泉不竭；善阴者，须从阴中求阳，则阴得阳升，而生化无穷”之妙。

用法 加胡桃 4 ~ 6 枚，打碎同煎，二煎混匀，日分 2 次服。

案例 顽麻怪症(42 页)

1.1.10 肾十味

组成 枸杞子 15 ~ 30g，酒菟丝子 15 ~ 30g，盐补骨脂 15 ~ 30g，仙灵脾 15 ~ 30g，巴戟肉 15 ~ 30g，沙苑子 15 ~ 30g，盐杜仲 15 ~ 30g，仙茅 15 ~ 30g，骨碎补 15 ~ 30g，川断 15 ~ 30g。

男女不育、骨质增生、老人前列腺肥大、更年期综合症(180 页)。

方解 肾四味益肾精、鼓肾气；巴戟补肾助阳，沙苑子补精明目，仙茅温肾壮阳，杜仲壮骨安胎，骨碎补补肾壮骨，川断接骨安胎。诸药相合，强腰脊，壮筋骨，善治老年性退化性疾患。

用法 加胡桃 4 ~ 6 枚，打碎同煎，二煎混匀，日分 2 次服。

案例 骨瘤从肾论治(352 页)。

1. 1. 11 定风丹

组成 制首乌 30g，炒白蒺藜 30g。

主治 滋养肝肾，乌须发，定眩晕，养血驱风止痒(316 页)。

方解 制首乌益精养血，乌须发，定眩晕；白蒺藜善行善破，专入肺肝，宣肺之滞，疏肝之瘀，最善磨翳。二药相配，为皮肤科常用药。

用法 二煎混匀，日分 2 次服。

(217、320 页)。

1.1.12 重订追风散

组成 (红参、灵脂、制首乌、炒白蒺藜)、制川草乌、石膏、天麻、川芎、白芷、甘草各 12g, 细辛、芥穗、防风、羌活(辛夷、苍耳子、苍术)、全蝎、(蜈蚣)、僵蚕、地龙、天南星、制白附子、雄黄(另研兑入)、乳香、没药各 6g(括号内药为李可所增)。

主治 扶正气, 开表闭; 用于全身各部突发性、神经性疼痛、麻木、抽动(243 页)。

方解 本方原名《和剂局方》之“追风散”及民间流传之“偏正头风散”, 因它用于全身各部疼痛、麻木, 若称“偏正头风散”, 则有些局限, 故李可在后期医案中均称之

大了主治范围,所以正名为“重订追风散”。红参、天麻、定风丹(首乌、白蒺)补元气,生津液,补肝肾,益精血,扶正托邪于外;川草乌大辛大热通行十二经表里内外,破沉寒痼冷,驱逐伏邪外透;芎、芷、荆、防、羌活、辛夷、苍术,芳香透窍,辛散开表,疏风燥湿,开门逐盗;天麻、南星、白附,化痰定风;石膏甘寒清热,监制辛热燥烈之品;雄黄、苍术,解毒辟疫;乳香、没药,化瘀定痛;诸虫深入血分,搜剔伏匿之邪;白芷一味,号称植物麝香,芳香浓烈,善通诸窍,与川芎之专理头痛者相配,可引诸药上达头部直入脑窍,破其巢穴。诸药相合,对风、寒、湿、痰、瘀多种伏邪,皆有透发之效。

用法 上药共研细粉,日服2~3次,每次3~4克,饭后、睡前淡茶或温酒送服。

页)

1.1.13 改良乌头汤

组成 生芪 120 ~ 240g, 制附子 30 ~ 90g, 川乌 30g, 防风、黑小豆各 30g, 麻黄 15g, 赤芍 15 ~ 45g, 炙甘草 60g, 蜂蜜 150ml。

主治 历节病不可屈伸疼痛, 对类风湿性关节炎有卓效(245 页)。

方解 生芪主大气, 运血化湿; 附子、川乌大辛大热, 通行十二经表里内外, 破沉寒痼冷; 麻黄开表散湿, 赤芍通利; 蜂蜜、防风、黑豆及 2 倍炙甘草, 可监制乌头的毒性, 以达到散寒止痛的作用。

用法 加冷水 2500ml, 文火煮取 500 ~ 600ml, 日 3 次饭后半小时服。

案例 坐骨神经痛合并冠心病(200 页)。

组成 苍术 15g, 苡仁 45g, 黄柏 30g, 豨莶草 50g, 赤小豆、山药、知母、炙草各 30g, 生石膏 250g, 赤芍各 45g, 下肢加川牛膝 30g, 追风散(分 3 次服)9g。

主治 急性风湿热关节肿痛(244 页)。

方解 四妙散化湿热, 白虎汤(知母苦寒滑肠, 芦根代之)清阳明, 芍甘缓急止痛, 赤芍通利, 赤豆利水消肿, 山药滋润血脉, 豨莶草、追风散透邪止痛。

用法 二煎混匀, 日分 3 次服。

案例 风湿热痹(206 页)。

1. 1. 15 攻癌夺命汤

组成 海藻、生甘草、木鳖子、醋鳖甲、蛇舌草、夏枯草、蚤休、海蛤壳、黄药子、生半夏、生姜、元参、牡蛎各 30g, 大贝 15g, 山茨菇、山豆根各 10g, 全蝎 12 只, 蜈蚣 4 条、雄黄 1g(研粉吞服)。

主治 恶性肿瘤, 尤对头颈部、淋巴系统、消化道癌肿有效

草同用，相反相激，攻坚化瘤，磨积消水；木鳖子苦微寒，有毒，为消积块破肿瘤要药；生半夏为消痰核，化肿瘤要药；蛇舌草、山茨菇、山豆根、黄药子皆近代筛选之抗癌要药；海蛤壳化痰软坚，清热泻火；夏枯草清肝散结，主治癭瘤、乳癌，兼有补益养血之功；鳖甲为鳖甲煎丸主药，是历代治癥瘕痞块要药，与消瘰丸合用，增强养阴化痰，软坚破积之功。总之，海藻、甘草相反相激，木鳖子、生半夏、雄黄以毒攻毒，合大队攻癌破坚、清热解毒、化痰散结之品为君，以鳖甲、消瘰丸养阴扶正为臣，以活血化瘀虫类搜剔引入血络为佐使，直捣病巢，力

用法 加冷水 1500 ~ 2500ml, 文火煮取 450 ~ 600ml, 日分 3 次服。

案例 恶性淋巴瘤(336 页)

1. 1. 16 开道散

组成 火硝 30g, 紫硃砂 15g, 雄黄 3g, 硼砂 15g, 煅礞石 5g, 沉香 5g, 柿霜粉 30g, 冰片 1.5g, 儿茶 15g。

主治 食道癌之食道梗阻(348 页)。

方解 紫硃砂腐蚀瘤体, 号称肿瘤克星; 火硝散结消肿, 雄黄以毒攻毒, 解毒消肿; 硼砂清热消肿, 礞石消痰下气; 沉香降逆纳气, 柿霜润燥化痰。诸药相合, 共奏腐蚀瘤体, 降气消痰之功。

用法 上药研粉过 100 目, 每次 1 克, 蜜汁调服, 缓缓含化, 半小时许 1 次, 夜间停药。

案例 食道癌险死还生(347 页)。

1. 1. 17 化味生肌汤

组成 益母草、当归各 30g,川芎、桃仁、红花、炙草各 10g,泽兰、炮甲珠各 12g,胡桃肉 4 枚,红糖 30g,童便、黄酒各 1 杯(兑入)。

主治 产后乳少,可预防产褥感染或乳腺发炎(95 页)。

方解 生化汤活血逐瘀,温经止痛;加益母草活血通络,利水消肿,为产后缩宫专药;泽兰活血去瘀,行气消肿;二药相结合,可消除产褥期感染之炎性渗出物,使弛缓之子宫迅速复原;生乳灵(炮甲珠、胡桃肉)之甲珠活血通经,下乳消肿,寓通于补;核桃补肾固精,养血润燥。加味生化汤,较原方有更强的强身生乳、缩宫化瘀、推陈致新之功效。

用法 二煎混匀,兑入童尿、黄酒,日分 2 次温服。

1.1.18 加减固冲汤

组成 生芪、红参、贯众炭、棉子炭、煅龙牡、阿胶各 30g,山萸肉 120g,白芍 30g,姜炭、三仙炭、棕榈炭各 10g,“三七 6g、五倍子 1.5g”(研粉吞服)。

主治 宫颈癌之瘤体破裂暴崩、出血不止(366 页)。

方解 本方由固冲汤减白术、乌贼骨、茜草,加贯众炭、棉子炭、红参、阿胶、姜炭、三仙炭、三七而成。生芪、红参益气摄血,参、萸、芍敛肝固脱,龙牡、棕榈炭、五倍子固摄止血;贯众炭为崩漏下血要药,棉子炭温肾补虚止崩漏,兼有抗癌作用;阿胶补血止血,四炭温脾统血,三七止血化瘀而不留瘀。

用法 开水急煎频灌,以救危亡;血脱亡阳者,合破格救心汤。

案例 宫颈癌(360 页)。

250g, 百合、百部、白茅根、山药、山萸肉各 200g, 党参、二地、二冬、鸡内金、杏仁、茯苓、沙参、玉竹、煅龙牡、功劳叶、三七粉(另入)各 100g, 紫苑、五味子、甘草、川贝粉(另入)各 70g, 龟鹿阿胶(另化)各 50g, 肉桂粉(另入) 10g, 冰糖 1500g, 梨 2500g, 姜汁 100g。

主治 肺结核(313 页)。

方解 本方以黄芪鳖甲散去鳖甲, 合百合固金汤加减而成。重用生芪为君, 甘温益气而退虚热, 合山萸、煅龙牡敛固元气, 止盗汗, 定喘息, 退骨蒸; 肉桂辛甘大热, 补命门之火, 引浮越之假热归原; 更加姜汁暖脾胃, 二药合力, 监制大队养阴药百合、二地、沙参、玉竹之寒凉膩膈, 养肺阴而不伤脾阳; 复以内金助运化, 健脾胃, 共奏补土生金之效, 猫爪草、百部为肺癆专

又以血肉有情之三胶,河车阴阳开补,上下四旁皆受益,肺癆自愈。

用法 宽水浸泡一夜,文火煎取浓汁3次,混匀浓缩至5000ml,粉剂以药汁调成稀糊状溶入;入梨汁、姜汁,煎沸3分钟;冰糖加热融化,合三胶混匀,微煮收膏;日分3次服,每次10ml,温服。

1. 1. 20 明目退翳汤

组成 熟地、首乌、白蒺藜、当归、赤白芍、枸杞子各15g,夜明砂(包)、桃仁、红花、菊花、川芎、节菖蒲各10g,夏枯草、沙苑子、决明子、生石决明、谷精草、磁石各30g,柴胡6g,蝉衣10g,甘草5g。

主治 老年性白内障(270页)。

方解 杞菊八味、四物汤滋养肝肾;沙苑子补虚退翳要药;夜明砂专长明目退翳,刺蒺善行善破,专入肺肝,宣肺之滞,疏肝之瘀,最善磨翳;其余蝉衣、菊花、石决明、决明子,皆明目退翳之品;佐以桃仁、红花,活血化瘀;磁石吸纳上下,维系阴阳;柴胡升提,菖蒲启窍。诸药相合,共奏补益肝肾,明

服。

案例 老年性白内障(270页)。

1.1.21 乌蛇荣皮汤

组成 生地、当归各 30g,桂枝 10g,赤芍 15g,川芎、桃仁、红花各 10g,丹皮、紫草各 15g,定风丹(制首乌、白蒺藜) 60g,白藓皮、乌蛇(蜜丸先吞)各 30g,炙草 10g,生姜 10 片,大枣 10 枚。

主治 本方稍加化裁,可治 15 种皮肤病(316 页)。

方解 桃红四物合桂枝汤,养血润燥,活血化瘀,通调营卫;定风

驱风止痒；丹皮、紫草凉血解毒；白藓皮苦咸寒，清湿热而疗死肌，为风热疮毒、皮肤痒疹特效药；尤对湿热黄疸，兼见全身瘙痒者，对症方加入 30 克一剂即解；乌蛇祛风通络止痉，主诸风顽癣、风瘙隐疹、白癫风，是一切皮肤顽症特效药。诸药相合，养血活血祛瘀，可通调营卫，旺盛血行，使病变局部气血充盈，肌肤四末得养则病自愈。

用法 二煎混匀，日分 2 次服。

案例 过敏性湿疹(324 页)。

1.1.22 克白散

组成 沙苑子 750g，九制豨筴草 500g，乌蛇 250g，定风丹（制首乌、炒白蒺藜）300g，三七 100g，藏红花、乌贼骨、白药子、苍术、蚤休、降香、紫草、甘草各 50g。

主治 白癫风(322 页)。

多种稀有微量元素,能增强人体免疫功能,促进内分泌激素的生成,为治白癜风之要药;三七(半生用半油炸)、藏红花益气养血,活血化瘀,旺盛血行,营养肌肤;定风丹滋补肝肾,养血驱风;苍术、豨薟草化湿健脾;紫草、白药子、蚤休等清热凉血解毒;乌蛇祛风通络,主治白癜风。诸药相合,共奏补益肝肾,养血驱风之效。

用法 上药研粉,日服3次,每次5克。

案例 白癜风(322页)。

1.2 笔者拟名方78首

1.2.1 培元固本散类方12首

1.2.1.1 肺系培元固本散

组成 胎盘2具,坎气(脐带)100g,鹿茸、高丽参、灵脂各50g,三七、血琥珀、冬虫草、川贝、沉香各30g,灵芝孢子粉100g,蛤蚧6对。

主治 咳喘痼疾。用于慢性

方解 鹿茸补肾强督,生髓壮骨;胎盘温肾补精,再造免疫;红参大补元气,补脾益肺;灵脂活血止痛,化瘀止血,三七通络定痛,化瘀止血;琥珀镇静安神,活血通淋;坎气补肾平喘;冬虫草补肺肾,定喘嗽;川贝化痰止咳;沉香、蛤蚧纳气归肾;灵芝孢子粉能促进气管粘膜修复,对咳喘有佳效。

用法 口服 2~3 次,每次 3 克,热黄酒调服。

案例 肺心病(376 页)。

1.2.1.2 肺间培元固本散

组成 大三七 100g,高丽参 100g,灵脂、血琥珀、冬虫草、灵芝孢子粉、川贝、沉香、藏红花、土元、水蛭、全蝎各 30g,蜈蚣 100 条,蛤蚧 10 对,炮甲珠 60g,麝香 2g。

主治 肺间质纤维化(32

茸、坎气、胎盘血肉有情之品，及高丽参、冬虫草、灵芝孢子粉峻补先天肾气，重建人体免疫力；以三七、灵脂、琥珀、藏红花化瘀；蛤蚧、冬虫草、沉香、川贝化痰；土元、水蛭、全蝎、蜈蚣虫类药入络搜剔；尤以炮甲珠、麝香对药，穿透攻破，无所不到，辟秽化浊，引诸药直入肺窍，清除湿痰死血。诸药相合，有修复、激活受损肺实质病变之效。

用法 口服 2~3 次，每次 3 克，热黄酒调服；炮甲珠、麝香研粉，分成 20 包（每包 3.1 克），随汤剂早晚冲服 1 包。

案例 肺间质纤维化（29 页）。

1.2.1.3 肺癆培元固本散

组成 鹿茸 50g，胎盘 2 具，坎气 100g，龟鹿二胶、红参、灵脂、三七、血琥珀、冬虫草各 50g，蛤蚧 6 对；咯血者加白芨、川贝、煅龙牡各

主治 肺结核(399 页)。

方解 鹿茸补肾强督,生髓壮骨;胎盘温肾补精,再造免疫;红参大补元气,补脾益肺;灵脂活血止痛,化瘀止血,三七通络定痛,化瘀止血;琥珀镇静安神,活血通淋;坎气补肾平喘;龟鹿二胶峻补肾督;冬虫草补肺肾,定喘嗽;蛤蚧定喘兴阳;白芨消肿生肌止血;川贝化痰止咳消肿;煅龙牡固摄止血。

用法 日服 3 次,每次 5 克,热黄酒调服。

案例 肺结核咯血(311 页)。

1.2.1.4 风心培元固本散

组成 鹿茸 100g,胎盘 2 具,红参、灵脂、三七、血琥珀、炮甲珠 100g,藏红花、全蝎各 30g,蜈蚣 100 条;喘加蛤蚧 6 对,冬虫草、沉香各 30g。

主治 风湿性心脏病(399

骨；胎盘温肾补精，再造免疫；红参大补元气，补脾益肺；灵脂活血止痛，化瘀止血，三七通络定痛，化瘀止血；琥珀镇静安神，活血通淋；甲珠透达病所，凡血瘀血凝皆能开，寓补于攻；藏红花活血通络化瘀；全蝎、蜈蚣入络搜剔；蛤蚧、冬虫、沉香纳气归肾。

用法 口服 2 ~ 3 次，每次 3 克，每日另用生芪 60 克，煎汁送服散剂。

案例 风心病(21 页)。

1. 2. 1. 5 冠心病培元固本散

组成 鹿茸 50g，胎盘 2 具，红参、灵脂、大三七、血琥珀、灵芝孢子粉各 100g，炮甲珠、血竭、水蛭、藏红花、全蝎各 50g，蜈蚣 100 条。

主治 冠心病、心肌梗死(400 页)。

方解 鹿茸补肾强督，生髓壮

大补元气,补脾益肺;炙脂活血止痛,化瘀止血,三七通络定痛,化瘀止血;琥珀镇静安神,活血通淋;灵芝孢子粉强心利尿,对各类心脏病有佳效;甲珠透达病所,活血通络破栓塞;血竭祛瘀疗心痛,藏红花活血通络化瘀;水蛭为破瘀第一药;全蝎、蜈蚣入络搜剔。

用法 日服2~3次,每次3克,热黄酒调服。

案例 心肌梗死(400页)。

1.2.1.6 血栓培元固本散。

组成 鹿茸50g,胎盘100g,生晒参50g,大三七100g,血琥珀50g,藏红花50g,小白花蛇60条,全蝎60g,蜈蚣100条。

主治 脑血栓后遗症(289页)

方解 鹿茸补肾强督,生髓壮骨;胎盘温肾补精,再造免疫;红参大补元气,补脾益肺;三七通络定痛,化瘀止血;琥珀镇静安神,活血通淋;藏红花活血通络化瘀;白花蛇搜风通络止痉;全蝎、蜈蚣破栓塞,化瘀通络。

克,每日另用生芪 60 克,煎汁送服散剂。

案例 中风偏瘫(38 页)。

1. 2. 1. 7 肝硬培元固本散

组成 鹿茸 50g,胎盘 1 具,红参、灵脂各 50g,三七 100g,血琥珀、土元、水蛭、炮甲珠、全蝎、蜈蚣各 50g。

主治 肝硬化(400 页)。

方解 鹿茸补肾强督,生髓壮骨;胎盘温肾补精,再造免疫;红参大补元气,补脾益肺;灵脂活血止痛,化瘀止血,三七通络定痛,化瘀止血;琥珀镇静安神,活血通淋;土元活血化瘀,疗伤化癥;水蛭为破瘀第一药,甲珠疗疗痈破癥瘕,全

用法 口服2~3次,每次3克,温开水调服。

案例 肝硬化(400页)。

1.2.1.8 溃疡培元固本散

组成 胎盘1具,红参、灵脂、三七、血琥珀、鱼鳔胶、大贝、乌贼骨、煅牡蛎、灵芝孢子粉、凤凰衣各30g;肾虚者加鹿茸,消化迟滞加内金,慢性出血加血竭,痛甚者加醋元胡。

主治 胃溃疡、十二指肠溃疡(401页)。

方解 鹿茸补肾强督,生髓壮骨;胎盘温肾补精,再造免疫;红参大补元气,补脾益肺;灵脂活血止痛,化瘀止血,三七通络定痛,化瘀止血;琥珀镇静安神,活血通淋;鱼鳔胶补肾益精,散瘀消肿;乌贼骨制酸止痛,收敛止血;煅龙牡制酸止痛,固摄止血;灵芝养心补脾,促进粘膜上皮修复;凤凰衣养阴润肺,移治溃疡不敛;内金消食化积;血竭祛瘀止痛,敛疮止血;元胡行气活血止痛,土贝消肿散结。

克,热黄酒调服。

案例 胃溃疡大出血(15页)。

1.2.1.9 疳积培元固本散

组成 鹿茸 30g,胎盘 1 具,红参、三七、蛋壳粉、鸡内金、炒麦芽、炒谷芽各 30g。

主治 小儿疳积(396 页)。

方解 鹿茸补肾强督,生髓壮骨;胎盘温肾补精,再造免疫;红参大补元气,补脾益肺;三七通络定痛,化瘀止血;蛋壳粉治骨软、鸡胸、抽筋;鸡内金消食化积;炒二芽开胃健脾。

用法 口服 2 次,每次 1.5 克,温开水调服。

案例 丁奚疳重症(86 页)。

组成 胎盘 1 具,鹿茸、红参、三七、血琥珀、血竭、炮甲珠各 30g;合等量之追风散。

主治 类风湿性关节炎(245 页)。

方解 鹿茸补肾强督,生髓壮骨;胎盘温肾补精,再造免疫;红参大补元气,补脾益肺;三七通络定痛,化瘀止血;琥珀镇静安神,活血通淋;血竭祛瘀止痛;甲珠穿透关节,无所不到,软坚散结,消肿止痛;追风散通行十二经表里内外,破顽痰死血。

用法 日服 2 ~ 3 次,每次 5 克,热黄酒调服。

案例 类风湿性关节炎合并硬皮病(210 页)

1. 2. 1. 11 妇科培元固本散

组成 红参、灵脂、三七、血琥珀、土元、水蛭、全蝎、蜈蚣、川贝、桂枝、茯苓、丹皮、桃仁各 30g,夏枯草、海藻、甘草各 500g;肾虚寒者加

(401 页)。

方解 红参大补元气,补脾益肺;灵脂活血止痛,化瘀止血,三七通络定痛,化瘀止血;琥珀镇静安神,活血通淋;土元活血化瘀,疗伤化癥;水蛭为破瘀第一药;全蝎、蜈蚣入络搜剔;川贝消肿散结;桂枝茯苓丸消癥积聚;夏枯草清肝散结;海藻、甘草相反相激,攻坚化瘤专药。

用法 夏枯草、海藻、甘草三药宽冰浸泡一夜,文火煎取浓 3 次,混匀熬至滴水成珠时为膏,加药粉,炼蜜为丸,每丸重 15 克,日服 3 次,每次 1 丸。

案例 子宫肌瘤(100 页)。

1. 2. 1. 12 内障培元固本散

组成 胎盘 鹿茸 红参 灵

苑子、乌贼骨、珍珠各 30g,夏枯草、海藻、甘草各 500g。

主治 老年性白内障(401页)。

方解 鹿茸补肾强督,生髓壮骨;胎盘温肾补精,再造免疫;红参大补元气,补脾益肺;灵脂活血止痛,化瘀止血,三七通络定痛,化瘀止血;琥珀镇静安神,活血通淋;川贝化痰消肿散结;夜明砂专长明目退翳;沙苑子补虚退翳要药;乌贼骨软坚散结,珍珠明目退翳;夏枯草清肝散结;海藻、甘草相反相激,振荡磨积。

用法 夏枯草、海藻、甘草三药宽冰浸泡一夜,文火煎取浓 3 次,混匀熬至滴水成珠时为膏,加药粉,炼密为丸,每丸重 10 克,日

案例 老年性白内障(269页)。

1.2.2 痛证方7首

1.2.2.1 引火芍甘止痉汤

组成 熟地 90g,天麦冬各 30g,茯苓 15g,五味子 6g,白芍 100g,炙草 30g,“全蝎 12 只,蜈蚣 2 条”(粉吞),细辛 15g。

主治 血管神经性头痛、三叉神经痛(238 页)。

方解 引火汤导龙归海,疗头面虚火;芍药甘草汤缓急止痛;止痉散入络搜剔,定痛散结;细辛入少阴而透伏寒,兼寓火郁发之之意。

用法 二煎混匀,日分 2 次服。

案例 三叉神经痛痼疾(239 页)。

1.2.2.2 葛根双五止痉汤

组成 生芪 120 ~ 240g,葛根 60 ~ 90g,桂枝 15 ~ 30g,白芍 30 ~ 60g,羌活 30g,独活 30g,川芎 30g,当归 30g,地龙 30g,蜈蚣 2 条,全蝎 12 只。

30g,电鹿胶(化入)各 10g,“全蝎 12 只、蜈蚣 4 条”(研粉冲服),生姜 10 片,大枣 10 枚。

主治 颈椎病(218 页)。

方解 葛根桂枝汤专理颈项,疏通太阳经输;肾五味(肾四味加骨碎补)、龟鹿二胶补肾督、壮腰脊;补阳还五汤运大气,行气血;止痉散入络搜剔,散结定痛。

用法 二煎混匀,日分 2 次服。

案例 颈椎病(217 页)。

1.2.2.3 乌头当四豨鹤汤

组成 生芪 120 ~ 240g,当归、川乌、制附子、防风、黑小豆、豨莶草、老鹤草各 30g,麻黄 15g,细辛 20g,桂枝、白芍各 45g,炙草 60g,蜂蜜 150ml,生姜 45g,大枣 20 枚,追风散(分冲)9 ~ 12g。

主治 类风湿性关节炎、坐骨神经痛、腰椎间盘突出(244 页)。

方解 乌头汤大辛大热,通行

入经络之手足厥寒,腰腿足痛;豨筌草、老鹳草强筋壮骨,主治风寒痹痛;追风散透风、寒、湿、痰、瘀之伏邪,化瘀定痛。

用法 加冷水 2500ml,文火煮 600ml,日分 3 次服;或以止痉散代追风散。

案例 类风湿性关节炎(210 页)。

1.2.2.4 乌头酒

组成 生芪 100g,川乌、制附子、当归、丹参、乳香、没药、白芍、黑小豆、乌蛇各 30g,蜂蜜 120g,桂枝、防风、全蝎、甘草各 15g,蜈蚣 30 条,豹骨 15g,白酒 1500g。

主治 一切关节肿痛,肩凝症、骨质增生痛(209 页)。

方解 乌头汤(去麻黄)大辛

解冰；桂枝协同和营卫；沿络双灸丹活血止痛；乌蛇、止痉散入络搜剔，散结定痛。

用法 类风湿性关节炎后并硬皮病(209 页)。

1.2.2.5 乌头外熨方

组成 沙苑子、川草乌、红藤、荆芥、防风、当归、鸡血藤、海桐皮、乳没、透骨草、川断、红花、细辛、花椒、伸筋草、威灵仙各 30g，乌蛇 50g，95% 酒精 500ml，陈醋 3000g。

主治 一切关节肿痛、肩凝症、骨质增生痛(209 页)。

方解 川草乌大辛热，通行十二经表里内外，开冰解冻；荆防祛风解毒，椒辛祛寒透邪；乳没、鸡血藤、当归、红花活血止痛；沙苑、川断补肝肾壮筋骨；海桐皮、红藤、透骨草、伸筋草、灵仙、乌蛇宣痹除湿。

用法 上药磨粉，酒精浸泡 3 日后，陈醋浸泡 7 日，睡前以沙布 8 层蘸饱药液置于患处，以电熨斗熨之，至药液蒸干为止，连续用 3 次。

页)。

1.2.2.6 脱疽乌头汤

组成 生芪240g,附子、当归、炙草各60g,川乌、丹参、黑小豆、川牛膝、防风各30g,麻黄、桂枝、细辛、赤芍、桃仁各15g,油桂10g,吴茱萸20g,“麝香1g,炮甲珠5g,水蛭3g、全蝎3g、蜈蚣2条”(研粉分冲),蜂蜜150g,生姜15g,大枣20枚,黄酒500ml。

主治 寒凝型血栓闭塞性脉管炎(65页)。

方解 乌头汤大辛大热,开冰解冻;当归四逆汤(去通草)养血通脉主治手足厥寒,脉细欲绝;加吴茱萸生姜白酒,主治经脉挛缩剧痛;更加丹参、桃红、牛膝活血化

攻破之力甚强，化瘀通络破栓塞；全蝎开瘀蠲痹，蜈蚣搜风舒挛。诸药相合，犹如阳光一照，冰雪消融，栓塞一通，病即向愈。

用法 加冷水 2500ml，文火煮取 500ml，对入黄酒 500ml，日 3 夜 1 服。

案例 血栓闭塞性脉管类(65 页)。

1.2.2.7 黄芪四妙勇安汤

组成 生芪 240g，银花、玄参各 90g，当归、丹参各 60g，甘草 30g，檀降香、桃仁、红花各 10g，砂仁 5g，“水蛭、炮甲珠、醋元胡各 6g”(研粉分冲)。

主治 热毒型血栓闭塞性脉管炎(66 页)。

方解 生芪运大气、行气血，最擅托毒生肌，为脱疽首选药；四妙勇安汤清热解毒，活血止痛；丹参饮、桃红行气活血；元胡活血行气止痛；水蛭、甲珠穿透攻破之力甚强，化瘀通络破栓塞，为攻克本

1 小时,武火急煎 10 分钟,取浓汁 1500ml,6 次分服,日 4 夜 2 服。

案例 血栓闭塞性脉管炎(66 页)。

1.2.3 热病方 3 首

1.2.3.1 犀四味

组成 石膏 30 ~ 125 ~ 250 ~ 500g,丹皮、紫草 10 ~ 15g、蚤休 15 ~ 30g。

主治 清热凉血解毒,退高热有奇效(72 页)。

方解 石膏辛寒,除三焦大热,止消渴烦逆;丹皮清热凉血散瘀;紫草凉血解毒消斑;蚤休清热解毒,熄风定惊,护心醒脑。诸药相合,可代犀角,退高热有奇效。

用法 加冷水 1500ml,浸泡 1

~ 1000ml, 3 小时服 1 次, 每次 200ml, 昼夜连服, 中病即止。

案例 小儿流脑(77 页)。

1. 2. 3. 2 癃闭散

组成 大黄 15g, 海金砂、泽泻、血琥珀各 10g, 蜈蚣 10 条, 蛋清 6 枚, 黄酒 150g。

主治 急性泌尿系感染之二便闭结(156 页)。

方解 大黄攻下泻火, 釜底抽薪; 海金砂利水通淋; 泽泻利水泻热, 琥珀化瘀通淋; 蜈蚣舒挛定痉通窍; 蛋清清热泻火敛疮; 黄酒助下焦气化。

用法 上药研粉, 分作 3 包, 每包以蛋清 2 枚调之, 热黄酒 50g 冲服, 3 小时 1 次, 二便通, 热退痛止后, 弃之不用。

案例 慢性肾盂肾炎急性感染(160 页)。

生半夏 60g,白芍 45g,枳实、丹皮、
大黄(酒浸后下)、槟榔、甘草各
30g,桃仁 15g,冬瓜仁 60g,银花
90g,连翘 45g,芙蓉叶 30g,芒硝
40g(分冲),生姜 75g,大枣 12 枚。

主治 急性胰腺炎(141 页)。

方解 攻毒承气汤清热解毒,
通腑泻热,扫荡血毒;急性胰腺炎
主证胸胁剧痛,手不可近,呕吐不
止,寒战高热等,即大柴胡汤证,故
以大柴胡汤为核心组方,加攻毒承
气汤阻断痛势。

用法 加冷水 2000ml,浸泡 1
小时,武火煮沸 10 分钟,取汁
600ml,化入芒硝,3 次分服,3 小时
1 次,日夜连服;畅泻去芒硝,热退
痛止后,予上方 1/4 量 2 剂,以清
余邪。

案例 急性胆道蛔虫症合并
急性胰腺炎(139 页)。

1.2.4.1 旋覆代赭枇杷汤

组成 旋覆花(包)15g,赭石30g,红参(另炖)10g,生半夏30g,炙枇杷叶30g,炙草10g,生姜10片,大枣10枚,三七(分吞)6g,童便(兑入)1杯。

主治 胃气上逆之吐衄(125页)。

方解 旋覆花降气消痰,赭石重镇降逆,二药合用对胃气上逆,大便秘而暖气频者有佳效;半夏、生姜散水气、止呕吐;参、草、枣补中健胃;加枇杷叶降肺胃之气;三七止血化瘀而不留瘀,童便滋阴降火。气有余便是火,气降则火降,血自归经。

用法 二煎混匀,取汁600ml,日分3次服。

案例 肺结核咯血(310页)。

1.2.4.2 补中升阳肾肝汤

归各 20g,红参(另炖)、灵脂 10~15g,炙草、三仙炭、姜炭、柴胡、升麻各 10g,陈皮 3g,肾四味 120g,龙牡各 30g。

主治 脾气不升之崩漏便血(126 页)。

方解 补中益气汤重用参芪,陷者举之,峻补其气;加四炭(姜炭、三仙炭)温经止血,红参、灵脂益气止血化瘀;用补气升提,下虚者须防“提脱”,加肾四味、生龙牡固肾气。诸药相合,脾气渐旺,自能统血。

用法 二煎混匀,取汁 600ml,日分 3 次服。

案例 青霉素过敏后血崩(122 页)。

1. 2. 4. 3 丹道代赭枇杷汤

组成 丹皮、黑栀子、醋柴胡、

苓、生地、赭石、炙枇杷叶各 30g, 阿胶 15 ~ 30g (化入), 薄荷、姜炭各 3g, 三七(分吞) 6g。

主治 肝不藏血之血上溢或下出(126 页)。

方解 丹梔逍遥散舒肝之郁, 梔子炒炭减其苦寒之性, 又能入血泻火而止血, 煨姜易姜炭以护胃气; 加枇杷叶清金制木, 生地、阿胶滋水涵木、凉血养血、止血柔肝, 赭石降气抑火平木, 三七止血化瘀而不留瘀, 最是血证妙药。

用法 二煎混匀, 取汁 600ml, 日分 3 次服。

案例 乳衄(119 页)。

1. 2. 4. 4 引火阿胶牛膝汤

组成 熟地 90g, 巴戟肉, 天麦冬各 30g, 茯苓 15g, 五味子 6g, 阿胶(化入)、怀牛膝各 30g, 油桂(米丸先吞) 3g。

主治 火不归原之目赤、舌红、鼻衄等证(127 页)。

冬各 30g, 茯苓 15g, 五味子 6g, 阿胶(化入)、怀牛膝各 30g, 油桂(米丸先吞)3g。

主治 火不归原之目赤、舌衄、鼻衄等五官溢血(127 页)。

方解 引火汤壮水敛火, 导龙归海; 加油桂饭丸先吞, 温脏敛阳, 引火归原; 阿胶养血止血, 牛膝引血下行。诸药相合, 引无根之火归肾而愈。

用法 二煎混匀, 取汁 600, 日分 3 次服。

案例 鼻衄(270 页)。

1. 2. 4. 5 来肾当补胶七汤

组成 红参(另炖)15g, 龙牡各 30g, 肾四味 120g, 生芪 30g, 当归 15g, 阿胶(化入)30g, 姜炭、炙甘草各 10g, 三七(分吞)3g。

主治 肾不封藏, 气随血脱之出血不止(127 页)。

方解 方以来复汤去白芍, 敛旺固肾救脱, 肾四味鼓舞肾气, 当

血，阿胶养血止血，三七活血止血。
诸药相合，以挽血脱多危。

用法 武火急煎，频频灌服。

案例 食道癌出血(349 页)。

1. 2. 4. 6 平格当补胶炭汤

组成 附子、姜炭各 30g，炙草 60g，红参(捣末同煎)30g，山萸肉 120g，煅龙牡、磁石各 30g，生芪 30g，当归 15g，阿胶 30g。

主治 肾不封藏，阴损及阳之出血如注(127 页)。

方解 方以四逆汤救阳，以四逆加人参汤、当归补血汤滋阴和阳、益气生津；加山萸肉固守附子已复之阳，挽五脏气血之脱失；煅龙牡固摄止血，磁石维系阴阳；姜炭温脾止血，阿胶养血止血。诸药相合，可阻断病势。

用法 武火急煎，频频灌服。

案例 暴崩欲脱(123 页)。

1. 2. 4. 7 平格当补胶炭汤

组成 制附子 100g, 姜炭 50g, 炙草 60g, 红参(捣末同煎) 30g, 山萸肉 120g, 煅龙牡、磁石各 30g, 生芪 60g, 当归 30g, 患者本人头发炭(分冲)6g。

主治 肾不封藏, 血脱亡阳之出血如注(127 页)。

方解 本方以破格救心汤大剂合当归补血汤、炮姜炭、头发炭组成。以大剂四逆汤救阳, 四逆人参汤、当归补血汤滋阴和阳, 益气生津; 山萸肉固守附子已复之阳, 挽五脏气血之脱失; 煅龙牡固摄止血, 磁石维系阴阳; 姜炭温脾止血, 本人头发制炭养阴止血。诸药相合, 立解危亡。

用法 武火急煎, 频频灌服。

案例 暴崩脱症(124 页)。

1.2.5 呼吸疾病方6首

1.2.5.1 小青龙虚化汤

组成 麻黄(另煎)10~45g,制附片45~200g,辽细辛(蜜炙)45g,生晒参(另炖)15~30g,生半夏45~65g,干姜30~45g,五味子30~38g,炙紫苑、炙冬花各15~45g,壳白果(打)20g,炙草30~60g,桂枝、赤芍各45g,生姜65g。

主治 咳喘痼疾,用于呼吸系统疾病(397页)。

方解 本方以小青龙汤加红参、制附子、冬花、紫苑、白果组成。小青龙以麻桂芍草和营解表,姜夏细味化饮止咳;虚化则肾不纳气,加红参;太阳少阴同病,加附子;冬花、紫苑降逆止咳,白果为定喘要药。诸药相合,治痰喘极效。

用法 本方煮服法：①麻黄另煎：麻黄另煎去上沫，取汁 150ml；诸药加水 2000ml，文火煮取 450ml，兑入麻黄、参汁，分 3 次服，

中病即止：服首剂第一次后密切观察，若得全身畅汗，则剩余二次弃去不用。③老幼酌减：老幼妇弱使用本方，可将全方按比例制小其剂。最小剂量为 $1/5$ 量，汤成，分 10 次稍稍与之。10 岁以上儿童则服 $1/2$ 量。18 岁以上用成人量。老弱者酌情参照。

案例 小儿暴喘(82 页)。

1.2.5.2 麻杏犀角虎承汤

组成 石膏 30 ~ 200g, 麻黄、杏仁、炙草各 10g, 丹皮、紫草 10 ~ 15g, 蚤休 15g, 芦根 30g, 大黄、芒硝(分冲)10 ~ 15g。

主治 热毒闭肺，内陷心肝之高热、咳喘、神昏、抽搐，多用于小儿肺炎、流脑等（77页）。

方解 本方由麻杏石甘汤合犀四味、白虎、调胃承气汤组成。麻杏石甘汤为辛凉清解，表里双解之剂；犀四味退高热有奇效；白虎汤之知母苦寒滑肠，用芦根代之；调胃承气汤釜底抽薪。诸药相合，

升脾胃、解肝毒，通腑泻热存阴，立救危亡。

用法 加冷水 1000ml 左右，浸泡 1 小时，武火煮沸 10 分钟，取浓汁 50 ~ 100ml，每次 5 ~ 10ml，多次频服；若热退、苏醒，可再给药 2 次，3 小时 1 次，余药弃之不用。

案例 小儿流脑(77 页)。

1.2.5.3 瓜丹桂枝芩茎汤

组成 瓜蒌 30g，薤白 15g，白酒 100ml，桂枝、赤芍、炙甘草各 15g，生半夏 30g，丹参 30g，檀降香、砂仁、木香各 10g，芦根、苡仁各 30g，冬瓜仁 60g，桃杏仁各 12g，生姜 45g，大枣 12 枚。

主治 急性结核性胸膜炎(47页)。

方解 本方由《金匱》瓜蒌三方之瓜蒌薤白半夏桂枝汤合丹参饮、苇茎汤加味。瓜蒌三方加赤芍振胸阳,调营卫,宽胸膈而化饮邪;丹参饮加降香、木香行气活血,气行则水行;更合千金苇茎汤加杏仁、茯苓,清肺化痰排饮。诸药相合,排饮甚速。

用法 二煎混匀,日分3次服。

经时兼收创新方

——李可学术思想探讨之二十(下)

● 孙其新*

摘要 针对李可验方数量之谜,进一步挖掘了《李可老中医急危重症疑难病经验专辑》。李可验方百首:李可命名方 22 首,笔者拟名方 78 首;李可验方归纳思路:从个案中找灵感,从类案中找规律;从对药中找素材,从治法中找特点;从按语中找提示,从疗效中找亮点。

关键词 经方 时方 自制方 李可 医案

1 李可验方百首(接上期)

1.2.5 呼吸疾病方 6 首

1.2.5.1 小青龙虚化汤

组成 麻黄(另煎)10~45g,制附片 45~200g,辽细辛(蜜炙)45g,生晒参(另炖)15~30g,生半夏 45~65g,干姜 30~45g,五味子 30~38g,炙紫苑、炙冬花各 15~45g,壳白果(打)20g,炙草 30~60g,桂枝、赤芍各 45g,生姜 65g。

主治 咳喘痼疾,用于呼吸系统疾病(397 页)。

方解 本方以小青龙汤加红参、制附子、冬花、紫苑、白果组成。小青龙以麻桂芍草和营解表,姜夏细味化饮止咳;虚化则肾不纳气,加红参;太阳少阴同病,加附子;冬花、紫苑降逆止咳,白果为定喘要药。诸药相合,治痰喘极效。

用法 本方煮服法:①麻黄另煎:麻黄另煎去上沫,取汁 150ml;诸药加水 2000ml,文火煮取 450ml,兑入麻黄、参汁,分 3 次服,

每次 200ml,每次间隔 3 小时。②中病即止:服首剂第一次后密切观察,若得全身畅汗,则剩余二次弃去不用。③老幼酌减:老幼妇弱使用本方,可将全方按比例制小其剂。最小剂量为 1/5 量,汤成,分 10 次稍稍与之。10 岁以上儿童则服 1/2 量。18 岁以上用成人量。老弱者酌情参照。

案例 小儿暴喘(82 页)。

1.2.5.2 麻杏犀角虎承汤

组成 石膏 30~200g,麻黄、杏仁、炙草各 10g,丹皮、紫草 10~15g,蚤休 15g,芦根 30g,大黄、芒硝(分冲)10~15g。

主治 热毒闭肺,内陷心肝之高热、咳喘、神昏、抽搐,多用于小儿肺炎、流脑等(77 页)。

方解 本方由麻杏石甘汤合犀四味、白虎、调胃承气汤组成。麻杏石甘汤为辛凉清解,表里双解之剂;犀四味退高热有奇效;白虎汤之知母苦寒滑肠,用芦根代之;调胃承气汤釜底抽薪。诸药相合,

开肺清热解毒,通腑泻热存阴,立救危亡。

用法 加冷水 1000ml 左右,浸泡 1 小时,武火煮沸 10 分钟,取浓汁 50~100ml,每次 5~10ml,多次频服;若热退、苏醒,可再给药 2 次,3 小时 1 次,余药弃之不用。

案例 小儿流脑(77 页)。

1.2.5.3 瓜丹桂枝苇茎汤

组成 瓜蒌 30g,薤白 15g,白酒 100ml,桂枝、赤芍、炙草各 15g,生半夏 30g,丹参 30g,檀降香、砂仁、木香各 10g,芦根、苡仁各 30g,冬瓜仁 60g,桃杏仁各 12g,生姜 45g,大枣 12 枚。

主治 急性结核性胸膜炎(47 页)。

方解 本方由《金匱》瓜蒌三方之瓜蒌薤白半夏桂枝汤合丹参饮、苇茎汤加味。瓜蒌三方加赤芍振胸阳,调营卫,宽胸膈而化饮邪;丹参饮加降香、木香行气活血,气行则水行;更合千金苇茎汤加杏仁、茯苓,清肺化痰排饮。诸药相合,排饮甚速。

用法 二煎混匀,日分 3 次服。

* **作者简介** 孙其新,男,主任医师。从事辨证论治的整理和经方的临床应用,著有《谦斋辨证论治学》。

• **作者单位** 辽宁中医药大学附属医院(110032)

案例 急性结核性胸膜炎(46页)。

1.2.5.4 阳和小青芪灵汤

组成 生芪、熟地、山萸肉各30g,山药60g,红参(另炖)、灵脂各10g,麻黄根30g,白芥子(炒研)、鹿角胶(化入)10g,油桂(粉吞)3g,姜炭10g,生半夏、茯苓各30g,五味子、细辛、炙草各10g,生姜10片。

主治 肺结核夹寒饮(309页)。

方解 本方由阳和汤合小青龙汤化裁。李可认为,肺结核之潮热,是一种“相火离位,土不伏火,元阳虚弱”,肺癆之本质为虚证、寒证、阴证,其它皆为假象。故以阳和汤劳者温之,加重姜炭用量,油桂吞服,以复胃阳;盗汗易麻黄为根;加生芪,甘温益气而除大热,且对疮疡有托毒生肌之效;加红参、灵脂益气化瘀,缓通血痹;加萸肉敛肝,防阴阳气血之脱散,山药益肺肾之阴;加小青龙汤之姜夏细味化痰止咳。

用法 二煎混匀,日分2次服。

案例 肺结核夹寒饮(309页)。

1.2.5.5 破格救肺升陷汤

组成 制附子100g,红参(粗粉吞)10g,山萸肉90g,龙牡、生芪各30g,柴胡、升麻、桔梗各10g,麝香(分冲)0.2g,炙草60g。

主治 大气下陷之呼吸衰竭(262页)。

方解 此方由参附龙牡救逆汤合升陷汤化裁。破格重用附子救逆,红参、萸肉敛肝固肾救脱,龙牡摄气固肾;升陷汤去知母之苦寒,升提下陷;红参捣粗粉吞服,入胃则缓缓奏功,使下陷之气,徐徐升达;麝香醒脑开窍,兴奋呼吸中

枢。诸药相合,共奏救治呼吸衰竭之功。所谓“破格救肺”,指参附龙牡救逆汤,破格重用附子、山萸肉救治呼吸衰竭。

用法 加开水1500ml,武火急煎,随煎随灌,或鼻饲给药,24小时内不分昼夜,频频喂服1~3剂。

案例 呼吸衰竭(7页)

1.2.5.6 肺间质汤

组成 制附子45~200g,炙草60g,瓜蒌30g,薤白15g,白酒100ml,丹参45g,檀降香、砂仁各10g,生半夏、茯苓、生姜各30~45g,桃杏仁、红参(另炖)、灵脂各15g,山萸肉30~120g,细辛20g,干姜、五味子、白芥子(炒研)各10g,百合、山药各30g。

主治 肺间质纤维化(29页)。

方解 本方由四逆汤合瓜蒌薤白白酒汤、小青龙汤化裁。大剂四逆汤救阳逐阴;瓜蒌薤白白酒汤振胸阳,宽胸膈化饮邪;丹参饮加降香、桃杏,行气活血,气行则水行;姜夏细味、白芥、茯苓化饮利水止咳;参萸扶正固脱,参灵益气活血、启脾进食;百合、山药性平之品,滋养肺肾。诸药相合,似有修复、激活受损肺实质病变之效。

用法 加冷水2000~2500ml,浸泡1小时,文火煮取450ml,日分3次服。

案例 肺间质纤维化(29页)。

1.2.6 心脑血管疾病方6首

1.2.6.1 破格真五黄芪汤

组成 制附子30~90g,干姜30~60g,炙草60g,红参(另炖)15g,山萸肉30~60g,龙牡、磁石各30g,白术30g,茯苓、生姜、白芍各45g,猪苓、泽泻各15g,油桂10g,生芪60g。

主治 风心病水肿(399页)。

方解 本方由破格救心汤合真武、五苓散加生芪组成。破格救心汤救治心衰,真武汤、五苓散温阳泻浊,益火之原,以消阴翳;加生芪运大气,气行则水行,浊阴自去。

用法 加冷水2000ml,文火煮取600ml,日分3次服,服用半月可水肿消尽。

案例 风心病垂危(374页)。

1.2.6.2 破格桂灵丹参饮

组成 制附子100g,干姜60g,炙草60g,高丽参(另炖)、灵脂各15g,山萸肉90g,龙牡、磁石各30g,桂枝、桃仁各15~30g,丹参60g,檀降、沉香、砂仁各10g,麝香(顿冲)0.3g,苏合香丸2丸。

主治 冠心病、心肌梗死(12页)。

方解 本方由破格救心汤合丹参饮,加桂枝、灵脂、降沉香、桃仁组成。破格救心汤中剂救阳逐阴,敛肝固肾救脱;参灵益气化瘀,缓解血凝;丹参饮合降沉香、桃仁行气活血;麝香、苏合香丸辟秽开窍,桂枝引诸药直达心宫。

用法 加冷水2000ml,文火煮取600ml,日分3次服;痰堵胸憋者,加生半夏45g、生南星30g合瓜蒌薤白白酒汤。

案例 冠心病、心绞痛发作(12页)。

1.2.6.3 礞石滚痰开窍丸

组成 礞石、大黄各30g,黄芩15g,沉香10g,节菖蒲、郁金各10g,竹沥(兑入)100ml,麝香(分冲)0.3g。

主治 痰蒙心窍之狂躁、神昏(189页)。

方解 方以礞石滚痰丸荡涤痰火;节菖蒲、郁金、麝香辟秽化浊,开窍醒脑;竹沥化痰降逆。诸药相合,共奏涤痰泻火,开窍醒神

之功。

用法 二煎混匀,日分 2 次服,畅泻胶粘大便即愈。

案例 煤气中毒精神病(189 页)。

1.2.6.4 三生夏沉开窍饮

组成 生南星 30g,生半夏 45g,生川乌、黑小豆、节菖蒲各 30g,沉香 10g,蜂蜜 150g,竹沥(兑入)60ml,姜汁(兑入)10ml,麝香(分冲)0.5g。

主治 中风之猝然昏迷,痰鸣漉漉(7 页)。

方解 方以三生饮之生附子易生半夏、木香易沉香,涤痰降逆之力更速;其中南星化痰定风,半夏温润化痰;川乌大辛大热通行十二经表里内外、开冰化痰,沉香降逆止呕、温肾纳气;加菖蒲、麝香辟秽化浊、开窍醒脑;竹沥、姜汁化痰降逆;蜂蜜、黑豆监制川乌之毒。诸药相合,内闭外脱立解。

用法 加开水 1500ml,武火急煎,随煎随灌或鼻饲给药,醒后即止。

案例 肺心病心衰合并脑危象(6 页)。

1.2.6.5 还五桂枝芥虫汤

组成 生芪 120g,当归 30g,赤芍、桂枝各 15~45g,川芎、桃仁、红花、地龙、白芥子(炒研)、炙草各 10g,“全蝎 12 只,蜈蚣 2~4 条”(研粉分冲),生姜 10 片,大枣 10 枚。

主治 中风后遗症、颈椎病之肢体麻木(37、218 页)。

方解 本方由补阳还五汤合桂枝汤、止痉散加白芥子组成。补阳还五汤益气养血、活血通络;桂枝汤调和营卫;白芥子化皮里膜外之痰;止痉散搜顽痰死血。

用法 二煎混匀,日分 2 次服。

案例 颈椎骨质增生症(218 页)。

1.2.6.6 芪物当耳芥蛋汤

组成 生芪 120g,桂枝、白芍、当归、炙草、黑木耳各 30g,蛋壳粉(分冲)3g,生姜 10 片,大枣 10 枚。

主治 鸡爪风、或肢体麻木(121、378 页)。

方解 本方由黄芪桂枝五物汤加当归、黑木耳、白芥子、蛋壳组成。黄芪桂枝五物汤振奋阳气,促进血行,主治血痹之麻木,即无痛性麻木。李可之经验,治鸡爪风重用白芍 90g,柔肝缓急;养血驱风必加当归、黑木耳;痰湿加白芥子;骨软鸡胸(缺钙)加蛋壳粉。

用法 二煎混匀,日分 2 次服。

案例 鸡爪风、顽麻怪症(42、378 页)。

1.2.7 脾胃疾病方 15 首

1.2.7.1 止呕汤

组成 生半夏、茯苓、赭石、生姜各 30g,姜汁(兑入)10ml,炙草 10g。

主治 胃气上逆之呕吐,用于胃肠痉挛、胃出血、妊娠恶阻剧吐(45 页)。

方解 本方由小半夏加茯苓汤合旋覆代赭汤化裁。胃为气机升降之中枢,胃气不降,则诸经之气皆逆。方以赭石、生半夏、生姜降胃,则气机升降复常,轻症服一两口即止,重则服 2~3 次即愈。正是执简驭繁,以不变应万变之法。

用法 煎取浓汁 300ml,小量多次缓缓呷服;标证一除,再缓图治本。

案例 妊娠恶阻剧吐(107 页)。

1.2.7.2 双呕汤

组成 吴茱萸 15~30g,红参

(另炖)15~30g,生半夏、茯苓、赭石、生姜各 30g,炙草 15g,姜汁 20ml,大枣 12 枚。

主治 呕吐兼头痛;或脑膜刺激症之喷射状呕吐(43 页)。

方解 本方为吴茱萸汤合止呕汤。吴茱萸汤证昭示:干呕、吐涎沫、头痛者,吴茱萸汤主之。止痛与呕,正是吴茱萸的两大功效。吴茱萸汤暖肝和胃,降逆补虚,温化寒饮;更加止呕汤,则降逆止呕之力倍增,故效如桴鼓。

用法 冷水 1000ml,浸泡 1 小时,文火煮取浓汁 300ml,小量多次缓缓呷服,呕止后每次 100ml,3 小时 1 次。

案例 胃溃疡大出血(15 页)。

1.2.7.3 五味回生汤

组成 红参(捣末同煎)、生半夏各 30g,山萸肉、山药各 100g,炙草 15g,生姜 10 片,姜汁(兑入)20ml。

主治 脱症兼呕逆、泻利(305 页)。

方解 本方原治一女青年久痢成癆(肺结核),证见食少呕吐,咳喘自汗,消瘦盗汗,便脓血,闭经等。如此垂危症,经治 2 个月,无一味治痢之药而痢愈;仅一味山药治癆之药而癆亦愈;可见古人“扶正邪自退”之说,确有至理。此方虽药仅五味,却是起死回生的关键。其中,红参合山萸肉益气救脱;山药补肺脾肾之阴,宁嗽定喘厚肠止泻;生半夏为降胃止呕圣药,与等量之生姜、姜汁、炙草合用,即解其毒,又能止剧烈之呕吐,从而使胃气复苏,为本症的治疗破一梗阻难关。

用法 放冷水 1000ml,浸泡 1 小时,文火煮取浓汁 300ml,兑入姜汁,小量多次缓缓呷服;呕止后,改

为日分3次服。

案例 久痢成癆(305页)。

1.2.7.4 粘连汤

组成 生芪90g,红参(另炖)20g,厚朴30g,沉香、木香(磨汁兑入)各5g,莱菔(生炒各半)30g,姜汁(兑入)10ml。

主治 术后肠粘连(136页)。

方解 术后肠粘连是气虚为病,气虚失运则窒塞不通,当塞因塞用,重用参芪大补元气;佐小量木香、沉香磨汁兑入,助大气流转;莱菔子破气消痰“有推墙倒壁之功”;再加赭石、厚朴之降胃逆。诸药相合,使三焦气化迅速复常,冲决窒塞,重症自愈。

用法 二煎混匀,日分2次服。

案例 术后肠粘连不全梗阻(137页)。

1.2.7.5 保和金灵黄木汤

组成 莱菔子(生炒各半)60g,鸡内金、连翘各30g,枳、大黄(酒浸后下)、焦三仙各15g,生半夏、茯苓各30g,红参(另炖)、灵脂、陈皮、木香(后下)、炙草各10g,生姜10片。

主治 胃结石症(142页)。

方解 本方由保和丸合参灵散加味化裁。保和丸消食化积;莱菔子“有推墙倒壁之功”,鸡内金消食化石为主药,二药利气止痛,消胀宽中;红参、灵脂同用,相制相畏,扶正攻积;大黄、枳实釜底抽薪,木香流气。诸药相合,相得益彰。

用法 二煎混匀,日分2次服。

案例 胃结石症(142页)。

1.2.7.6 参灵散

组成 红参、灵脂各10g。

主治 胃肠溃疡(178页)。

方解 红参大补元气,补脾益

肺;灵脂活血止痛,化瘀止血;二药相配,一补一通,用于虚中夹瘀之症,益气活血,启脾进食,化积消癥,化瘀定痛,化腐生肌;用于胃肠溃疡当日痛止,可半月痊愈。

用法 上药研粉,日分2次服。

案例 产后阴黄重症(172页)。

1.2.7.7 参灵甲珠散

组成 红参、灵脂各10g,炮甲珠6g。

主治 肝脾肿大(175页)。

方解 红参大补元气,补脾益肺;灵脂活血止痛,化瘀止血;二药相配,一补一通,用于虚中夹瘀之症,益气活血,启脾进食,化积消癥,化瘀定痛,化腐生肌;甲珠之穿透攻破无所不到,为癥瘕积聚要药,且有升高白血球作用,寓补于攻。三药相合,用于肝脾肿大,每服必有助下走窜如虫行,或咕咕作响,服半月可回缩。

用法 上药研粉,日分2次服。

案例 肝昏迷(173页)

1.2.7.8 三饮四石汤

组成 泽泻90g,白术36g,红参(另炖)、吴茱萸各30g,炙草15g,生半夏、茯苓、煅紫石英、龙牡、磁石各30g,生姜30g,姜汁20ml,大枣20枚。

主治 美尼尔氏综合症(272页)。

方解 此方由《金匱》治饮三方泽泻汤、小半夏加茯苓汤、吴茱萸汤,加紫石英、龙牡、磁石等四石组成。泽泻汤健脾利水,以杜生痰之源,使痰饮不再复聚,主治头目昏眩;小半夏加茯苓汤降逆止呕,利水化饮,主治呕、痞、眩;吴茱萸汤暖肝和胃,降逆化饮,主治头痛、呕吐涎沫。美尼尔氏综合症三证

悉具,当三方合用。更加紫石英、龙牡、磁石温肾镇冲,协调上下。吴茱萸更擅解一切痉挛,内耳迷路之痉挛解,积水去,耳窍复清虚之常,其症自愈。

用法 加冷水1500ml,浸泡1小时,文火煮取600ml,先小量多次缓缓呷服,呕止后每次200ml,3小时次,日夜连服3剂。

案例 内耳眩晕症(272页)。

1.2.7.9 黄芪五苓三妙散

组成 生芪45g,桂枝10g,白术、茯苓各30g,猪苓、泽泻各10g,生苡仁45g,苍术15g,川牛膝30g,白芷、炙草各10g。

主治 膝关节积液、脚气(250页)。

方解 水湿停聚为患,皆因气不化水。下部水湿停聚,上气必虚,故重用生芪补中上之气,气旺则水行,停湿自去;五苓散合四妙去黄柏(一切甘寒、苦寒药,有碍脾阳,皆不用)益气健脾运湿;白芷活血化瘀,通窍祛湿。诸药相合,膝关节积液、脚气收效甚速。

用法 二煎混匀,日分2次服。

案例 膝关节积液(250页)。

1.2.7.10 连败藓苦三妙散

组成 银花30~90g,连翘、白藓皮、苦参、生苡仁各30g,苍术、黄柏、羌活、独活、前胡、柴胡、川芎、桔梗、芥穗、防风、甘草各10g,土茯苓120g(煎汤代水煎药)。

主治 婴儿湿疹(88页)。

方解 本方由连翘败毒散合三妙散,加白藓皮、苦参、土茯苓组成。连翘败毒散辛凉升散,清热解毒;三妙散清热化湿,苦参清热燥湿;白藓皮清湿热而疗死肌;土茯苓对重症湿疹,疗湿毒有特效;高热烦渴者,加生石膏清阳明;病重者,加全蝎、蜈蚣、乌蛇入络搜风解

毒,止痒有奇效。

用法 二煎混匀,日分 2 次服。

案例 婴儿湿疹(88 页)。

1. 2. 7. 11 补中退潮汤

组成 生芪 45 ~ 60g, 红参(另炖)10g, 白术、当归各 20g, 柴胡、升麻各 10g, 陈皮 3g, 龙牡、山萸肉、乌梅各 30g, 炙草 10g, 生姜 5 片, 大枣 10 枚。

主治 小儿疳积、肺癆、癌症化疗、放疗之潮热(363、396、399 页)。

方解 本方由补中益气汤加龙牡、山萸肉、乌梅组成。补中益气汤重用生芪,甘温益气而退虚热;红参、山萸肉敛肝固肾救脱;乌梅酸甘化阴,龙牡固摄肾气。诸药相合,甘温除大热,敛得正气,即退得邪热,取效甚速。

用法 二煎混匀,日分 2 次服。

案例 干血癆(302 页)。

1. 2. 7. 12 补中通窍汤

组成 生芪 60g, 红参(另炖)15g, 白术、当归各 30g, 柴胡、升麻、陈皮、炙草各 10g, 沉香、木香、油桂、砂仁各 1. 5g(研粉吞服), 葱白 3 节, 生姜 5 片, 大枣 10 枚。

主治 术后二便闭结、或尿闭(112 页)。

方解 《内经》昭示:“中气不足则溲便为之变”, 术手二便闭结或尿闭, 纯属气虚不运, 遂致大气下陷。故以补中益气汤重用生芪补大气, 佐小量木香、砂仁助大气流转, 油桂、沉香助下焦气化而利下窍, 葱白通下窍; 病重者, 加开窍之麝香(分冲)0. 3g。诸药相合, 大气一转, 二便自通。

用法 二煎混匀,日分 2 次服。

案例 剖腹产后二便闭结

(112 页)。

1. 2. 7. 13 补木疏土汤

组成 生芪 30 ~ 60g, 白术 30g, 当归 20g, 红参(另炖)、灵脂 10 ~ 15g, 柴胡、升麻、陈皮、桂枝、生麦芽、炙草各 10g, 生姜 5 片, 大枣 10 枚。

主治 木不疏土证, 食少便溏, 消瘦乏力, 左关脉特弱(171 页)。

方解 木不疏土证, 指左关特弱之肝气虚, 不能疏土而食少便溏, 面色萎黄, 消瘦乏力。张锡纯氏创补肝气, 用生芪、桂枝、生麦芽; 李可亦用之补肝, 加补中益气汤益气健脾, 红参、灵脂益气化瘀, 启脾进食, 共奏“补肝气以实脾胃”之功效。

用法 二煎混匀,日分 2 次服。

案例 急性肝炎误治变症(172 页)。

1. 2. 7. 14 醒脾汤

组成 红参、灵脂 10 ~ 30g, 炒麦芽 60g, 炒芽 30g, 焦三仙各 10 ~ 15g, 藿香、佩兰、砂仁、炙草各 10g, 生姜 10 片, 大枣 10 枚。

主治 食少纳呆, 面黄肌瘦(361 页)。

方解 李可醒脾常用以下对药: 红参、灵脂益气化瘀, 启脾进食; 炒麦芽、谷芽开胃醒脾; 焦三仙消食化积; 藿香、佩兰、砂仁芳化醒脾。

用法 二煎混匀,日分 2 次服。

案例 宫颈癌(357 页)。

1. 2. 7. 15 附桂理灵丸

组成 制附子 15g, 油桂 10g, 干姜 15g, 炒白术 15g, 红参 15g, 灵脂 15g, 炙草 30g。

主治 脾肾阳虚之食少、自利、不渴、神疲、四肢不温(57 页)。

方解 本方由附子理中丸加油桂、灵脂组成。理中丸温中健脾, 加附子为附子理中丸补火生土。笔者在临床中发现, 北京同仁堂的附子理中丸治脾肾两虚之泻泄时, 头 3 天有效, 大便随即成形。但继服则大便涩滞、艰难, 用患者的话说: 吃了附子理中丸, 大便是干了, 但更费劲了, 痔疮也犯了, 还不如大便稀时痛快。它还有牙痛、咽疼、脸上起疙瘩等不足, 这说明附子理中丸有壅滞、涩肠、升火等问题, 应当进行改良。李可经验: 红参、灵脂相配, 寓补于通, 益气化瘀、启脾进食。笔者曾用参灵散治一例胃溃疡兼便秘(如羊矢), 不但溃疡好了, 连便秘之顽症也自愈了。从中悟出灵脂降浊气而通大便, 故加之改良。

用法 上药研粉, 水泛为丸, 每次 6g, 日分 2 次服。

案例 糖尿病火不生土(55 页)。

1. 2. 8 肝胆疾病方 6 首

1. 2. 8. 1 大柴金灵黄木汤

组成 柴胡 60 ~ 125g, 白芍 45 ~ 90g, 炒枳实、酒黄芩、生半夏、鸡内金、郁金各 30g, 金钱草 120g, 红参(另炖)、灵脂、大黄(酒浸后下)各 30g, 木香 10g, 生姜 30g。

主治 胆石症(137 页)

方解 胆结石合并胆囊炎, 多见寒热往来, 恶心呕吐, 口苦咽干, 胸肋疼痛等少阳证兼胃家实, 即大柴胡汤证。故以大柴胡汤两解之; 加红参、灵脂扶正攻积; 三金(金钱草、鸡内金、郁金)化石; 大黄通腑攻下, 佐木香流气。诸药相合, 相得益彰。

用法 放冷水 2000ml, 浸泡 1 小时, 取汁 600ml, 日分 2 次服。

案例 胆结石症胆绞痛(137 页)。

1.2.8.2 梅连椒辛硝君汤

组成 乌梅 30g,黄连、川椒各 10g,细辛 15g,芒硝(分冲)20g,使君子仁(嚼食)20g,蜂蜜 120g,姜汁(兑入)20ml。

主治 胆道蛔虫症(139 页)。

方解 乌梅丸主治寒热错杂型蛔厥症。方以乌梅、黄连、川椒、细辛为主,乌梅有缓解痉挛作用,且使胆囊频频收缩,促进胆汁分泌,可将钻入胆道之虫体退出;蛔虫“得甘则喜”,加蜂蜜引诱;继而用芒硝攻之,使君子杀虫。

用法 二煎混匀,取汁 400ml,入蜂蜜煎三沸,兑入姜汁,日分 2 次服;于药后半小时服芒硝,泻下蛔虫后,去芒硝;改为每晨空腹先嚼食使君子仁 20g,顿服汤剂,连服 3 天。

案例 胆道蛔虫症(139 页)。

1.2.8.3 阴阳藿朴夏苓汤

组成 茵陈 45g,藿香、佩兰各 10g,生半夏 20g,茯苓 30g,猪苓、泽泻各 15g,桃仁、红花各 10g,炒麦芽 60g;阳黄、栀子 10g,六一散(包煎)21g,厚朴 10g,白蔻仁 6g;阴黄、吴茱萸 10g,四逆汤(或奔豚汤),参灵散(或三畏汤)。

主治 黄疸型肝炎(166 页)。

方解 李可认为,黄疸多因中焦失运,湿热或寒湿停聚。因脾主湿,故治在脾胃。余治黄疸型肝炎,常用茵陈五苓合藿朴夏苓汤化裁(166 页)。方以茵陈、藿香、佩兰、生半夏、茯苓、泽泻、桃仁、红花、炒麦芽为基础方,芳香化湿醒脾,健脾利湿,活血化瘀利水;阳黄:加栀子、六一散、厚朴、白蔻仁清热燥湿淡渗;阴黄:加吴茱萸、四逆汤、参灵散(或三畏汤)回阳醒脾、泄浊退黄。

用法 二煎混匀,日分 3 次服。

案例 急性黄疸型肝炎(166、175 页)

1.2.8.4 茵陈四逆三苓散

组成 茵陈 30g,制附子、干姜、红参(另炖)、灵脂、藿香、佩兰、炙草各 5g,茯苓 10g,猪苓、泽泻、炮甲珠、桃仁、红花各 5g。

主治 婴儿阴黄(84 页)。

方解 本方原治患儿 7 个月,全身暗黄,哭声如蚊蚋,腹部以手搔之,即落黄屑,瘦弱脱形,肝脾肿大,大便灰白,尿如浓茶,四肢不温,指稍凉,呼吸微弱,属阴黄重症。方以茵陈四逆合三苓(茯苓、猪苓、泽泻)温阳泄浊;加藿香、佩兰芳化湿浊;参灵、甲珠、桃红入络消癥,治肝脾肿大。共服 9 剂,全身脱壳一层而愈。

用法 煎取浓汁 150ml,加红白糖 30g,装入奶瓶,日分 3 次服;用于成人阴黄症,药量酌加。

案例 婴儿阴黄(84 页)。

1.2.8.5 犀地承气开窍汤

组成 石膏 250~500g,丹皮、紫草 10~15g,蚤休 15~30g,生地 30g,赤芍 15g,大黄(酒浸后下)、芒硝(分冲)、厚朴各 15~30g,枳实 15g,节菖蒲、郁金各 10g,麝香(分冲)0.5g。

主治 急性肝炎合并肝昏迷(177 页)。

方解 急性肝炎合并肝昏迷,证属湿热化毒,热深厥深,腑实内闭之急黄症,以犀角地黄汤清热凉血解毒,大承气汤通腑泻热,菖蒲、郁金、麝香芳香化浊,开窍醒脑,急投本方,4 小时可醒;石膏、丹皮、紫草、蚤休合用可代犀角,退高热有奇效。

用法 加开水 1000~1500ml,急煎频灌,醒后即止。

1.2.8.6 真武麻灵蛭虫丸

组成 制附子 45g,白术 30g,

茯苓、白芍、生姜各 45g,麻黄、红参、灵脂各 10g,大黄蛭虫丸(包煎)2 丸。

主治 肝硬化腹水(401 页)。

方解 真武汤温阳健脾泻浊,加麻黄开表闭;红参、灵脂益气化瘀;大黄蛭虫丸化瘀消癥;服用半月,可腹水消尽。

用法 加水 1500ml,浸泡 1 小时,文火煮取 450ml,日分 3 次服;得汗后去麻黄,继服 10 剂。

案例 肝硬化腹水(401 页)。

1.2.9 肾膀疾病方 8 首

1.2.9.1 开肺猪苓通淋散

组成 麻黄 10g,杏仁 12g,桔梗 10g,茯苓 30g,泽泻 10g,阿胶(化入)20g,滑石 18g,肉桂 10g,川牛膝 30g,乳香、甘草各 3g。

主治 尿路感染,用于尿道炎、膀胱炎、急性肾盂肾炎(161 页)。

方解 方以麻黄、杏仁、桔梗开肺散寒以行上焦气化;猪苓汤养阴清利湿热,加肉桂蒸动膀胱气化;通淋散(川牛膝、乳香)引诸药直达膀胱窍道,淋证自解。

用法 二煎混匀,日分 3 次服。

案例 劳淋(160 页)。

1.2.9.2 固肾汤

组成 红参 10~30g,山萸肉 30g,肾四味、龙牡各 30g,“蛤蚧尾 1 对,冬虫草 4g,沉香 3g”(研粉分吞),煅紫石英 30g,油桂(粉吞)3g,胡桃打 4~6 枚,炙草 10g。

主治 肾不固守之喘汗、奔豚证(14、16 页)。

方解 肾不封藏则自汗;肾不纳气则气喘;肾不固守则心悸、脐下筑筑;元气欲脱则大汗、暴喘、昏厥。李可固肾常用以下对药:红参、山萸为来复汤核心用药,敛肝固肾救脱;肾四味益肾精、鼓肾气,可代价昂之

鹿茸;龙牡固肾摄精,收敛元气;人参、胡桃(合为人参胡桃汤)温肾纳气,蛤蚧、冬虫、沉香助阳平喘;紫石英、油桂、沉香镇冲固脱,为治奔豚之专药。诸药相合,共奏肾之封藏、纳气、固守之功效。

用法 二煎混匀,日分2~3次服。

案例 肺心病(374页)。

1.2.9.3 四逆参肾汤

组成 制附子30g,干姜30g,红参10g,肾四味各30g,炙草60g。

主治 四逆汤证兼腰困气怯(289页)。

方解 四逆汤补火生土、养阳长寿;人参大补元气,滋阴和阳;肾四味益肾精、鼓肾气,滋而不腻,温而不燥。诸药相合,真可谓“善补阳者,须从阴中求阳,则阳得阴助而源泉不竭;善补阴者,须从阴中求阳,则阴得阳升,而生化无穷”之妙。

用法 放冷水1500ml,浸泡1小时,文火煮取500ml,日分2次服。

案例 咽痛寒症兼衄(289页)。

1.2.9.4 奔豚干姜紫石汤

组成 制附子30~100~200g,油桂、沉香、砂仁各10g,红参(另炖)10~30g,山药30~60g,茯苓45g,泽泻30g,干姜、怀牛膝、煅紫石英各30g,炙草10~30~60g。

主治 厥气上攻之奔豚证(372页)。

方解 奔豚汤由附子、油桂、沉香、砂仁、红参、山药、茯苓、泽泻、牛膝、炙草组成,是山西温碧泉所创,主治三阴沉寒痼冷,厥气上攻之奔豚证,属纯阳益火之剂。李可认为,三阴寒证加用干姜则其力更雄厚,故增之(8页)。鉴于治奔豚证,李可恒用煅紫石英、油桂、沉

香专药,应当补之(紫石英)。从中可以看出,加干姜则融入四逆汤法,对危急重症有起死回生之效;加煅紫石英更针对奔豚用药,名符其实,下咽立效。

用法 附子小剂,加冷水1500ml,文火煮取600ml,日分3次服;附子大剂,加冷水2500ml,文火煮取7500ml,日3夜1服。

案例 风心病垂危(374页)。

1.2.9.5 三复汤

组成 红参(另炖)10~30g,山萸肉60~120g,生芪30~60g,当归15~30g,麦冬20g,五味子10g,白芍15~30g,龙牡各30g,炙草20g。

主治 厥脱,由于肝肾气阴两虚导致欲脱危证,多见于肿瘤晚期、放疗损伤、久病耗伤(366页)。

方解 厥脱危证,多见喘逆自汗,心悸神摇,面赤如醉,脉如波涛汹涌之状,速投来复汤大剂,敛肝固肾救脱;当归补血汤益气生血;生脉散滋阴复脉。因三方重投,又有“来复”、“复脉”之意,故取名“三复汤”。

用法 急煎频灌,日夜连投,以救危亡。

案例 小儿白血病(367页)。

1.2.9.6 大附夏苓醒脾汤

组成 制附子30~100g,酒大黄15~30g,细辛15g,生半夏、茯苓各30g,猪苓、泽泻、红参(另炖)、灵脂、焦三仙各15g,肾四味80g,芒硝(分冲)15~20g,炙草10g,生姜30g,姜汁(兑入)10ml,大枣10枚。

主治 尿毒症(163页)。

方解 李可认为尿毒症属邪实正虚,水湿、浊秽入血化毒,三焦逆乱,胃气败坏,肾阳衰微。故以大黄附子汤加芒硝温阳泻浊;夏苓、三苓(茯苓、猪苓、泽泻)降逆止

呕利水;参灵、三仙益气化痰醒脾;肾四味鼓舞肾气;重者昏迷,加麝香1g分冲;诸药相合,共奏温阳益肾,荡涤湿浊,醒脾救胃之功。

用法 加冷水1500ml,文火煮取400ml,兑入参汁、姜汁,冲化芒硝,日分3次服。

案例 尿毒症(164页)。

1.2.9.7 调经促孕汤

组成 益母草45g,当归50g,桂枝45g,白芍45g,细辛45g,通草30g,吴茱萸30g,炙草30g,生姜45g,大枣25g,生芪45g,决明子、老鹳草各30g。

主治 虚寒型不孕症(104页)。

方解 虚寒型不孕,由于月经期摄养不慎,过食生冷,冷水洗脚,夏日喜用空调,风冷乘袭胞宫,常伴痛经、经期错后,腰困如折等。方以当归四逆加吴茱萸生姜汤直入奇经,温经通脉,开冰解冻,主治手足厥寒,腰、腹、足痛;益母草为活血通经利水消肿要药,经现代药理证实,可使子宫收缩频率、幅度、紧张度增强,成为缩宫化瘀专药,二药相合,经期服之,可下秽浊血块,痛经、经期错后等随之而愈。经后服生芪、决明子、老鹳草,其中“决明子、老鹳草”为叶橘泉治不孕症的验方,加黄芪重在补虚,促进排卵,多有效验。

用法 当归四逆加吴茱萸、益母草,从月经第1日起服至经净,加冷水1500ml,文火煮600ml,日分3次服;经净后3日,连服生芪、决明子、老鹳草15剂,二煎混匀,日分2次服。

案例 多囊卵巢致不孕(104页)。

1.2.9.8 两本汤

组成 红参(另炖)10~15g,炮姜10g,焦白术、茯苓各30g,肾

四味各 15 ~ 30g, 紫河车(粉冲)3 ~ 5g, 炙草 10g。

主治 脾肾两虚, 食少便溏, 腰酸乏力(176 页)。

方解 李可认为, 郑钦安与彭子益, 一个重视先天, 一个重视后天; 如果把两者融合起来, 将使古中医学无敌于天下(35 页)。所以他倡导两本并重, 并对补火生土之名方附桂理中汤、四逆汤情有独钟。两本汤以理中、四君子益气健脾; 肾四味可代价昂之鹿茸, 加紫河车益肾精、鼓肾气, 温而不燥, 滋而不膩, 寓意深远。附桂理中汤、四逆汤偏重补两本之阳, 两本汤偏重补两本之气。

用法 二煎混匀, 日分 2 次服。

案例 产后阴黄重症(176 页)。

1. 2. 10 肿瘤疾病方 3 首

1. 2. 10. 1 攻癌基础方

组成 海藻、生甘草、木鳖子、夏枯草、生半夏、生姜、元参、牡蛎、大贝各 30g, “全蝎 12 只、蜈蚣 4 条”(研粉分吞)。

主治 良性肿物, 包括颈淋巴结、甲状腺腺瘤、乳腺增生、脂肪瘤等(117 页)。

方解 海藻为消瘤专药, 与甘草同用, 相反相激, 攻坚化瘤, 磨积消水; 木鳖子苦微寒、有毒, 为消积块破肿瘤要药; 夏枯草清肝散结, 主治瘰癧、乳癌, 兼有补益养血之功; 生半夏为消痰核, 化肿瘤要药; 消瘰丸软坚破积, 养阴化痰; 全蝎、蜈蚣入络搜剔, 活血化瘀, 直捣病巢, 力专效宏。

用法 加冷水 1500ml, 文火煮取 500ml, 日分 2 次服。

案例 乳腺增生(117 页)。

1. 2. 10. 2 麝甲无敌散

组成 麝香 2g, 炮甲珠 60g。

主治 消囊肿、破栓塞、攻肿瘤(65、104、344 页)。

方解 麝香芳香浓烈, 辟秽化浊, 开窍醒脑, 通络活血, 消肿止痛; 甲珠穿透走窜之性无所不到, 凡血瘀血凝皆能开, 寓补于攻, 妙用无穷。二药相合, 直捣病巢, 消囊肿化瘀积, 无微不至。李可用之治肺间质纤维化、血栓闭塞性脉管炎、卵巢囊肿、脑瘤等, 用途甚广, 故称之“麝甲无敌散”, 若麝香紧缺, 可用苏合香丸代之, 即苏合香丸 1 丸配服甲珠 3 克。

用法 上药研粉, 分成 20 包(每包 3.1 克), 随汤剂早晚冲服 1 包。

案例 卵巢囊肿、脑瘤(104、247 页)。

1. 2. 10. 3 桂苓五苓芷甲汤

组成 桂枝 15 ~ 30g, 茯苓 45g, 赤芍 25g, 丹皮 15g, 桃仁 15g, 猪苓、泽泻各 15g, 白术 30g, 肉桂、白芷各 10g, 炮甲珠(研粉分服) 6g, 益母草、丹参各 30g, 泽兰 15g, 海藻、甘草各 15 ~ 30g, “全蝎 6 只、蜈蚣 2 条”(研粉分服)。

主治 腹腔囊肿, 用于胆囊、胰腺、卵巢囊肿(59、98、101 页)。

方解 方由桂枝茯苓丸合五苓散、白芷、甲珠加味。桂枝茯苓丸为消癥瘕积聚效方; 五苓散加肉桂温阳化湿; 加益母草子宫专药, 协以丹参、泽兰, 促进宫血循环、炎性渗出物之排泄及吸收; 白芷号称植物麝香, 合甲珠透达囊肿; 海藻与甘草, 相反相激, 磨积消水, 攻坚化瘤; 虫类入络搜剔, 直捣病巢, 多数在半月治愈。

用法 二煎混匀, 日分 2 次服。

案例 巨型胰腺囊肿(98 页)。

1. 2. 11 五官疾病方 5 首

1. 2. 11. 1 麻细参肾通窍汤

组成 麻黄 10g, 制附子 30 ~ 90g, 细辛 30 ~ 45g, 红参(另炖)15 ~ 30g, 肾四味 120g, 辛荑 30 ~ 45g, 苍耳子 10 ~ 15g, 白芷 10g, 炙草 30 ~ 60g, 葱白 4 寸, 麝香(冲服)0.1 ~ 0.3g, 生姜 15g。

主治 慢性鼻炎、过敏性鼻炎(281、293 页)。

方解 方由麻附细合肾四味、苍耳子汤化裁。慢性鼻炎, 多由先天阳虚, 卫外失固, 寒伏三阴, 阻塞上窍所致。故以麻附细扶正透邪; 虚化, 加红参、肾四味培元固本; 苍耳子汤(辛荑、苍耳子、白芷)合葱白、麝香通上窍。

用法 加冷水 1500 ~ 2500ml, 文火煮取 500ml, 兑入参汁, 日分 2 次服。

案例 慢性鼻炎(281 页)。

1. 2. 11. 2 七味消毒饮

组成 银花、公英、地丁、蚤休、夏枯草各 30g, 皂刺、白敛各 10g。

主治 唇疗及各种疔疮肿毒(285 页)。

方解 方由五味消毒饮去野菊花、紫背天葵子, 加蚤休、夏枯草、皂刺、白敛, 故称“七味消毒饮”。银花、公英、地丁清热解毒, 消散痈肿; 蚤休清热解毒力最强, 可治一切毒蛇毒虫咬伤, 清除入血之病毒而护心醒脑; 夏枯草清肝散结; 皂刺透脓消肿; 白敛为疗毒要药, 内服外敷皆效。诸药相合, 共奏清热解毒, 消肿透脓之功。

用法 放冷水 1500ml, 急火煮沸 10 分钟, 3 小时 1 次, 日夜连服。

案例 唇疗走黄(285 页)。

1. 2. 11. 3 银翘蚤牛三妙散

组成 银花、连翘、生苡仁各 15g, 苍术、黄柏、栀子、柴胡、青黛(包煎)、牛子、车前子(包煎)、苦

参、蚤休、甘草各 10g,白芷 5g。

主治 急性化脓性中耳炎 (277 页)。

方解 本方以抑肝消毒散之银花、连翘、柴胡、栀子为基础,合三妙散加味。以银翘蚤牛清热解毒透邪;柴梃青柏泻肝胆之热;三妙散合苦参车前子清湿热而排脓;小量白芷,既能透窍排脓,又可引诸药直达病所;蚤休既可增强清热解毒之功,又可熄风定痉,阻断惊厥动风之变。

用法 急火煎取浓汁 150ml,每次 5~15ml,多次频服,热退脓止,弃之不用;本方为婴儿 6 个月之药量,5 岁以上用之,银花、连翘增为 30g。

案例 急性化脓性中耳炎 (277 页)。

1.2.11.4 银英犀军普济饮

组成 板兰根、银花、连翘、公英、玄参各 30g,石膏 90g,丹皮、紫草各 15g,酒芩、黄连、柴胡、升麻、桔梗、薄荷、马勃、僵蚕、牛子、陈皮、大黄(酒浸)、甘草各 10g。

主治 秋季结膜炎及头、耳部疮毒(267 页)。

方解 东垣之普济消毒饮,原治大头瘟毒,用于瘟毒流行,功能清热解毒,疏散风热。李可用于秋季结膜炎大流行,证见双眼痒痛难忍,热泪如注,眼不能睁,泡状血肉团充塞全眼,泪液带有脓性、血性、稠粘分泌物,与盲人无异。头部蒸蒸汗出,大渴喜冷,5 日不便,证属风热疫毒,犯肺侵脾,深入血分,热结肠胃。故以普济消毒饮疏风清热解毒,加银英解毒消痈,犀角(石膏、丹皮、紫草)凉血解毒,大黄釜底抽薪,表里双解。

用法 加冷水 1500ml,浸泡 1 小时,急火煮沸 10 分钟,3 次分服,3 小时 1 次,日夜不停。

案例 秋季结膜炎重症(267 页)。

1.2.11.5 理君肾四肉辛汤

组成 红参(另炖)10g,焦白术、茯苓各 30g,炙草、姜炭、细辛各 10g,油桂(饭丸先吞)1.5g,肾四味各 20g。

主治 口腔溃疡兼脾虚(286 页)。

方解 李可认为,虚火上僭之口疮,若见食少便溏之脾虚,用《证治准绳》四君七味(六味加肉桂)加玄参、细辛,极效。但本例病人,脾虚殊甚,寒凉滋腻,不可沾唇,故变通如下:以理中、四君温脾止泻;肾四味加肉桂代七味地黄丸引火归原,温而不燥,滋而不腻,加细辛火郁发之,3 剂自愈。

用法 二煎混匀,日分 2 次服。

案例 复发性口腔溃疡(286 页)。

2 李可验方归纳思路

笔者对李可处方做过初步统计,9 味药以下者占 13.3%;10~14 味药者,占 26.7%;15~28 味药者占 60%。由于药味多,一般来说,处方这道门坎是很难逾越的。我从 2005~2010 年,用了整整 5 年的时间攻读这门处方书,先后做了 6 遍读书笔记,潜心研究李可的用药规律,反复实践他的临床处方,最后才筛选出验方百则。回顾与思考这些验方的挖掘过程,是十分艰辛的;不过在艰辛之中也有几分技巧,愿意把它拿出来与同道们分享。

2.1 从个案中找灵感

李可认为,血栓闭塞性脉管炎属中医“脱疽”范围,日久趾、指坏死脱落,令人惨不忍睹。可分为阳虚寒凝与湿热化毒二型。而瘀阻

不通,又为两型所共有。故活血化瘀之法,必须贯彻始终。又气为血帅,气行则血行,不论寒热,皆以黄芪 240 克为君。热毒型以四妙勇安汤加生芪补大气,水蛭、甲珠活血化瘀破栓塞(66 页)。笔者感觉,其处方立意不凡,曾多次用于术后卧床引起的下肢“血栓性深静脉炎”(发热、下肢肿痛),速投黄芪四妙勇安汤之原量,则效如桴鼓。参灵甲珠散、保和金灵黄木汤亦然。

一例“血栓性深静脉炎”案,李某,女,48 岁。体胖,因子宫切除术后卧床一周,引起右髂股血栓性深静脉炎,出现发热、右下肢疼痛,皮红肿胀,有明显压痛。脉弦数,舌红苔薄。邀余会诊,证属血瘀络道,湿热化毒。遂予黄芪四妙勇安汤之原量,重用生芪托毒生肌,水蛭、甲珠活血化瘀破栓塞,3 剂。药后热退肿消,继服 6 剂收功。

2.2 从类方中找规律

攻毒承气汤,李可在书中并没有具体交待有哪些药。但他在全书中提到“攻毒承气汤”仅 6 例,如阑尾脓肿合并肠梗阻、化脓性阑尾炎合并重症腹膜炎、急性胆道蛔虫并发急性胰腺炎、急性子宫内膜炎、耳源性脑炎、脓疮内攻诸案,而我从反复出现的药物中筛选出 13 味药,用之甚效。还五桂枝芥虫汤、瓜丹桂枝苇茎汤亦然。

2.3 从对药中找素材

李可治气虚欲脱之微喘自汗,以红参、山萸为对,甚则肾四味、龙牡为对;肾不纳气之喘,以人参、胡桃为对,甚则蛤蚧、冬虫草、沉香为对;阳从上脱之奔豚证,以煅紫石英、油桂、沉香为对。笔者认为,李可关于肾之封藏、纳气、固守之辨证,则有是证,用是药,使用频律相当高,应当归纳为“固肾汤”以指导

临床。醒脾汤、三生夏沉开窍饮亦然。

2.4 从治法中找特点

中医素有“肝虚无补法”之说。李可认为,五脏病理,有虚即有实,肝脏何独不然?肝郁其气固不能条达;肝虚则其气亦无力条达。凡遇此类证候,左关脉特弱,张锡纯氏喜用生芪 30g、桂枝 9g、生麦芽 9g,覆杯即效验(171 页)。他又进一步将这 3 味药合补中益气汤加灵脂,共奏补肝气以实脾之功效。笔者鉴于补木疏土法独辟蹊径,破解了临床肝脾郁证一大难题,故将此方命名为“补木疏土汤”。两本汤、调经促孕汤亦然。

2.5 从按语中找提示

李可在“鸡爪风”按语中指出:加味黄芪桂枝五物汤曾治愈多例鸡爪风;“复发性口腔溃疡”按语亦指出:凡遇火不归原证而脾虚便溏病人,即投理中汤合肾四味加肉桂、细辛,皆效。虽仅一句评语,却透露出“历验不爽”之意,应当把它们挖掘出来,故称前者为“芪物当耳芥蛋汤”,而后者为“理中肾四肉

辛汤”。银翘蚤牛三妙散亦然。

2.6 从疗效中找亮点

一例“肠粘连”案,因子宫切除患者,诊为术后肠粘连,证见呕吐、腹痛、不大便。已半月不能进食。说话有气无力,只能说半句,需多次换气才能勉强讲下去。邀余会诊。笔者没有这方面经验,就抱着试试看的想法,予以李可之肠粘连处方。第二天患者就面带笑容前来道谢,也敢大声说话了。笔者被这前后一天的变化惊呆了,随即就称之为“粘连汤”推而广之。

又一例“腹凸如怀孕”案,张某,女,27 岁。她是我儿媳妇,个头 1.5 米,生下双胞胎,产后半年小腹仍没有复原,腹凸如 5 月怀孕状。初按李可少腹鼓凸症论治,予以补中益气汤加味,抓了 6 付汤药。结果她硬说没功夫煮,实际上就是不想吃汤药。后来儿子又催我:她这付样子都不敢上街,能不能有更简便的方法?我思考再三,觉得四逆参肾汤似有温阳、暖宫、收腹的作用,不妨一试。遂把四逆参肾汤做成水丸,每次 6 克,日 2

次。二诊:药后就是尿多,服用一个月,竟然肚子没了,腰围由原来的 2 尺 5 变为现在的 2 尺 2。

按 此患者肚子大,既不是典型的少腹鼓凸症,又不是肥胖症(因她四肢不胖),主要是怀孕负荷太重(1.5m 的个头,两个胎儿共 5.2kg)造成的,用李氏四逆丸(即“四逆参肾汤”,详见《附子丸散简效廉》一文),纯属孩子们逼我“被动做药”。我在岫岩县出诊,一个月回沈阳一次,一次只能投一个月的药,预计 3 个月能见效就不错了。没想到这么大的肚子,只服一个月的小小水丸,就了无痕迹,随即广泛应用于临床。

《李可老中医急危重症疑难病经验专辑》是 20 世纪 90 年代以前的治疗经验,近十年来,特别是他出版了彭子益《圆运动的古中医学》后,治疗思路有了较大的变化。李可验方百则,是对《李可老中医急危重症疑难病经验专辑》处方用药方面的初步总结,只有掌握了它,才能看出他后 10 年的变化和发展,进而挖掘出更多的效方来。

中医典故

中药店何以称“堂”

我国一些历史悠久的中药店,多以“堂”相称,比如北京的同仁堂、沈阳的天益堂、长沙的九芝堂、天津达仁堂等等。一些中医的处方落款时也往往在前面冠以“坐堂医生”四个字。一直到现在,许多已发展为制药厂的大药店,依然保留和沿用这些老字号。这个典故从何而来呢?原来这个“堂”字出自张仲景行医的典故。

张仲景,东汉南阳人(今河南省南阳县),自幼聪颖,博览群书,勤奋好学,尤其喜爱读医书。汉献帝建安中期,张仲景任长沙太守。他在公务繁忙的情况下,仍然孜孜不倦地钻研医术,当时长沙连年瘟疫蔓延,死人很多,他很痛

心、着急,公然打破官府戒律,坐在官衙大堂之上为病人诊脉开方,做到办公、行医两不误。他还常常在自己的名字前冠以“坐堂行医”四个字,以表示自己藐视功名、为民治病的决心。后被尊为“医圣”。

后人十分崇敬张仲景精湛的医术和高尚医德,便效仿沿用“坐堂医生”的称呼,中药店的店名也多称“堂”。意为像张仲景那样不计名利、救死扶伤。如今,很多中药店还盛行“坐堂医生”的做法,一边看病,一边卖药,方便了患者。

——李可学术思想探讨之二十三

摘要 针对肿瘤之世界医学难题，进一步探讨了李可学术思想。李可早期治肿瘤思路：以阴阳为纲，寒热虚实分型；痰毒热化型，攻癌夺命汤；痰凝寒化型，攻癌基础麻辛方；宫颈癌肝郁湿热型，芪苡逍遥桂苓丸；脾虚寒化型，芪苡补君醒脾汤；白血病邪毒炽盛型，清瘟败毒犀四味；气血两竭型，三复温脾止血汤；伏邪入里当外透，病证冲突当从证；治癌要过四道关，整体失调四大证；攻补比例随证转，除恶务尽长固本。

关键词 肿瘤 寒热分型 攻癌夺命汤 攻癌基础麻辛方 李可 医案

攻癌夺命汤，是李可在 50 年代后期至 60 年代中期所创，期间共治 51 例肿瘤。现根据其医案，整理出以下内容：

1 治肿瘤思路

1.1 以阴阳为纲，寒热虚实分型

李可指出，小儿白血病类似“小儿急癆”，又因其主症为高热，大出血，亦可归属血证范畴。初期邪毒炽盛，充斥表里三焦，入营动血，可借鉴温病治法，以清瘟败毒饮重用生石膏 250~500g，无犀角时可用丹皮、紫草、蚤休代之，一昼夜连服 3 大剂，即可阻断病势。此期人体正气尚强，用攻不可犹豫，杀得一分邪毒，即保得一分正气，攻癌即所以扶正。若禀赋素虚，邪从寒化、虚化，甚则病初即见正气先溃，气随血脱，奄奄待毙，或高热出血之后，复加化疗摧残，气血耗伤殆尽。当此生死存亡系于一发关头，则当急急固脱为先，速投来复汤、当归补血汤、生脉散复方大剂（369 页）。从中可见，正胜则邪从热化、实化；正虚则邪从寒化虚化。

1.2 痰毒热化型，攻癌夺命汤；痰凝寒化型，攻癌基础麻辛方

1.2.1 痰毒热化型，攻癌夺命汤

组成 海藻、生甘草、木鳖子、醋鳖甲、蛇舌草、夏枯草、蚤休、海蛤壳、黄药子、生半夏、生姜、元参、牡蛎各 30g，大贝 15g，山慈菇、山豆根各 10g，“全蝎 12 只，蜈蚣 4 条、雄黄 1g”（研粉吞服）。

主治 痰毒热化型肿瘤，证见痰核、痰毒、痰瘀互结，热毒炽盛，毒入血分，全身中毒症状严重之多种恶性肿瘤。

方解 海藻为消瘤专药，与甘草同用，相反相激，攻坚化瘤，磨积消水；木鳖子苦微寒，有毒，为消积块破肿瘤要药；生半夏为消痰核，化肿瘤要药；蛇舌草、山慈菇、山豆根、黄药子皆近代筛选之抗癌要药；海蛤壳化痰软坚，清热泻火；夏枯草清肝散结，主治瘰疬、乳癌，兼有补益养血之功；鳖甲为鳖甲煎丸主药，是历代治癥瘕痞块要药，与消瘰丸合用，增强养阴化痰，软坚破积之功。总之，海藻、甘草相反相激，木鳖子、生半夏、雄黄以毒攻毒，合大队攻癌破坚、清热解毒、化痰散结之品为君，以鳖甲、消瘰丸养阴扶正为臣，以活血化痰虫类搜剔引入血络为佐使，直捣病巢，力专效宏。

用法 加冷水 1500~2500ml，文火煮取 450~600ml，日分 3 次服。

案例 淋巴瘤景某，女，65 岁。初诊：颈左侧肿物 40 天，初起如黄豆大，未及 1 个月，猛长如初生婴儿头大，并向下蔓延至左锁骨上窝，凹凸如岩，坚硬不移；颈右侧及颊车穴下方肿块 6 个，大如杏核，连成一串，坚硬不移；双腋下，双腹股沟淋巴结皆肿大如枣，推之不移。随肿块之逐日增大，上则头痛如破，气喘痰壅，胸部憋胀，面色灰滞，神识昏糊。下则二便闭结，

溲若浓茶。口臭熏人，苔黄厚腻，中根黑燥，六脉沉滑数实。遂拟：漂海藻、生甘草、煅礞石、木鳖子、生半夏、生姜、莱菔子（生炒各半）、黄药子、鳖甲、生牡蛎、浮海石、海蛤壳、元参、蚤休各 30g，大黄、大贝、桃杏仁各 15g，山慈菇、山豆根、红花各 10g，“全虫 12 只、蜈蚣 4 条、明雄黄 1.2g”（研末冲服），蛇舌草、夏枯草各 120g 煎汤代水煎药、煎取浓汁 600ml，日分 3 次服，7 剂。二诊：服首次药后 1 刻钟，突觉满腹上下翻腾，五脏如焚，欲吐不得，欲泻不能，烦躁欲死，旋即昏厥。醒后出一身臭粘汗，吐出胶粘痰涎半痰盂，胸膈顿觉宽敞。服 2~7 剂时，每日畅泻污泥状夹有脓血、胶粘痰涎，奇臭极热之大便 1~2 次，尿已转清，胸憋气喘已愈七八，头已不痛，神识清朗，食纳大增，全身肿块变软。嘱原方加嫩胡桃枝之扶正化瘤，待大便中无秽物后，去大黄，续服 21 剂。三诊：左颈部肿物缩小 1/2 强，右颈及颊车穴下之肿物消至黄豆大，精神健旺，面色红润。以下从略。

按 证属痰毒弥漫三焦，毒入血分，阻塞气机，蒙蔽神明重症。拟攻癌解毒，涤痰通腑，软坚散结为治，以攻癌夺命汤合礞石滚痰丸扫荡血毒。

1.2.2 痰凝寒化型，攻癌基础麻辛方

组成 海藻、生甘草、木鳖子、夏枯草、生半夏、生姜、元参、牡蛎、大贝各 30g，白芥子（炒研）10g，“全蝎 12 只、蜈蚣 4 条研粉分吞”，麻黄（另煎）15g，制附子 30g，细辛 20~45g。

主治 痰凝寒化型肿瘤，详见脑瘤、脊髓胶质瘤、溶骨肉瘤案（247、340、347 页）。

方解 本方为攻癌基础方合麻黄附子细辛汤。海藻为消瘤专药，与甘草同用，相反相激，攻坚化瘤，磨积消水；木鳖子苦微寒，有毒、为消积块破肿瘤要药；夏枯草清肝散结，主治瘰瘤、乳癌，兼有补益养血之功；生半夏、白芥子为消痰核，化肿瘤要药；消瘰丸软坚破积，养阴化痰；蜈蚣入络搜剔，活血化瘀，直捣病巢，力专效宏；麻黄附子细辛汤深入少阴，透发伏寒，兼开太阳之表，引邪外透。

用法 加冷水 1500ml，文火煮取 500ml，日分 2 次服。

案例 脊髓胶质瘤 温某，女，19 岁。北京天坛医院诊断“C5-13 水平脊髓占位病变，神经胶质瘤”。因手术风险大，易复发，建议转中医诊治。询知颈项强痛，脊柱向右侧弯，转侧困难，斜颈，已 6 年。左肩背沉困重痛，四肢无力，左下肢肌肉萎缩，双下肢进行性麻木，近半年已不知痛痒。左腿环跳穴及足跟部电击样阵痛，一日数发，步态蹒跚、倾侧，已休学 2 个月。面色㿠白无华，气怯神倦，头目昏眩，瑟缩畏寒，六脉沉迟细涩，舌淡胖有齿痕。遂拟攻癌基础方、补阳还五汤、麻附细汤合方加味：①生芪 240g，葛根 90g，麻黄 15g，附子 30g，细辛 20g，漂海藻、生甘草、生半夏、云苓各 30g，白芍、川芎各 30g，白芥子（炒研）、桃仁、红花、僵蚕、地龙、两头尖、子蜂房、天南星、高丽参（另炖）、灵脂各 10g，生姜 30g，大枣 12 枚。加冷水 1500ml，文火煮取 450ml，3 次分服，5 剂。②全虫尾 15g，大蜈蚣 20 条，川贝、土元、炮甲珠各 30g，麝香 2g，共研细粉，分作 15 包，1 包/次，3 次/日，随中药服。以下从略（340 页）。

按 患者禀赋素虚，嗜食生冷，卧室靠窗，夜卧当风，夏日入睡，不关电扇。脾失健运，正气先虚，痰湿内生，经期不避生冷，瘀血内阻，寒伤督脉，真阳失运，日久湿痰死血，阻塞经脉，成为有形癥积。遂拟攻癌基础方化痰软坚，消磨化积；补阳还五汤重用生芪补大气，温督脉，化瘀血；麻附细汤深入少阴，透发伏寒；重用葛根专理颈项，通督达脊；更加虫类搜剔，攻坚化瘤。

1.3 宫颈癌肝郁湿热型，芪苡逍遥桂苓丸；脾虚寒化型，芪苡补君醒脾汤

1.3.1 肝郁湿热型，芪苡逍遥桂苓丸

组成 生芪 45g, 生苡仁 30~45g, 当归、白芍、白术、茯苓各 30g, 桂枝、赤芍、丹皮、桃仁各 15g, 木鳖子、蛇舌草、墓回头各 30g, “全蝎 12 只、蜈蚣 4 条”(研粉吞服), 甘草 10g。

主治 宫颈癌肝郁湿热型, 证见出血不止, 少腹痛, 尿急, 便急如痢, 带下赤白秽臭, 苔黄腻, 脉弦滑。

方解 逍遥散去薄荷、煨姜, 最善疏肝解郁、健脾利湿, 湿热化毒重者, 以土茯苓代茯苓; 桂枝茯苓丸, 化瘀消癥; 二者药性平和, 可以常服无弊, 符合晚期恶性肿瘤以“养正消积”为目的总原则。生芪重用, 除补气升阳举陷、补气摄血止崩漏, 又能扶正托毒生肌、温运阳气利水消肿; 苡仁是一味药性驯良的抗癌药, 功能健脾养胃渗湿排脓; 木鳖子为消积块、化肿毒要药, 兼能止癌肿晚期之疼痛; 全蝎、蜈蚣有解毒散结, 消瘤止痉定痛之效; 蛇舌草清热解毒利湿, 可治癌症导致之全身中毒症状, 甚则加蚤休、大黄; 墓回头为止崩漏带下要药, 出血甚则加贯众炭、儿茶。

用法 二煎湿匀, 取汁 600ml, 日分 3 次服。

案例 肝郁热化型宫颈癌曹某, 女, 52 岁。宫颈鳞癌晚期, 癌肿呈菜花样破溃, 膀胱直肠浸润转移, 已不能手术。患者卧床不起, 嘱丈夫准备后事。此时, 距活检后已 37 天, 出血日见增多, 少腹憋胀, 疼痛如绞, 里急后重如痢, 尿频尿急, 带色青黄夹黑, 秽臭, 呕逆不思饮食, 苔黄厚腻, 脉弦滑劲急, 双腹股沟淋巴结肿硬如枣, 触痛。证属肝郁气滞, 湿热化毒结于胞宫。拟方攻癌消癥, 解毒利湿: ①败酱草、白头翁、蚤休、蛇舌草、半枝莲、墓头回、川草薢、当归、刘寄奴、乌贼骨、酒大黄、土茯苓各 30g, 茜草炭 18g, 桂枝、桃仁、丹皮、赤芍、黄柏、甘草各 15g, 二煎混匀, 取浓汁 600ml, 日分 3 服。②松、柏、槐、桑、嫩核桃树枝各 30g, 莪术 60g, 煎汤、熏洗坐浴。两方各 10 剂。二诊: 10 剂后, 宫颈癌症中毒症状迅速消除; 呕逆除, 食纳增, 出血渐少。服至 5 剂后, 腹痛, 里急后重, 尿频尿急均愈。以下从略(353 页)。

按 证见尿急, 便急如痢, 带黄秽臭, 苔黄厚, 脉弦滑劲急, 腹股沟淋巴结肿硬、触痛, 皆为湿热化毒之征。故减逍遥散舒肝健脾之壅滞, 重用蛇舌草、蚤休、败酱、白头翁、大黄, 扫荡血毒; 桂枝茯苓丸、莪术, 攻癌消癥。

1.3.2 脾虚寒化型, 芪苡补君醒脾汤

组成 生芪 45g, 红参(另炖)、五灵脂各 15g, 焦白术、茯苓各 30g, 柴胡 10~15g, 炒麦芽 60g, 炒谷芽 30g, 姜炭、三仙炭各 10g, 棉子炭 15g, 生苡仁 30~50g, 猪苓 30g, “三七 6~9g, 全蝎 12 只, 蜈蚣 4 条”(研粉冲服), 炙草 10~15g, 生姜 10 片, 大枣 10 枚。

主治 宫颈癌脾虚寒化型, 证见面黄肌瘦, 气怯神疲, 纳呆食少, 便稀肢凉, 出血淋漓不断, 尿多, 带多如注, 舌淡无苔, 脉细如丝, 上不满寸, 下不及尺。

方解 补中益气(去陈皮)、四君子合方化裁, 重建脾胃元气, 下病治上, 柴胡升清举陷, 重用生芪 45g, 益气升阳举陷, 内托化腐生肌, 兼理八脉损伤; 姜炭、三仙炭温脾统血, 棉子炭补火生土止崩漏; 炒二芽醒脾, 参灵益气醒脾化瘀; 苡仁、猪苓为药性驯良之抗癌药, 动能健脾化湿浊; 三七止血化瘀而不留瘀, 全蝎、蜈蚣消瘤定痛止痉。**用法** 二煎混匀, 取汁 600ml, 日分 3 次服。

案例 脾虚寒化型宫颈癌郭某, 女, 50 岁。1980 年 12 月 13 日初诊, 病程 1 年半, 曾在省肿瘤医院住院 8 个月, 放疗配服中药, 渐延全身浮肿, 腹水++而出院。体重下降 20 公斤, 现体重 37.5 公斤, 骨瘦如柴, 一身大肉尽脱。纳呆, 日进食不足 4 两。出血淋漓不断, 少腹胀痛如锥刺, 黄赤相杂之秽臭带特多, 日用卫生纸一包。舌淡而干, 舌中裂纹, 中心有 5 分硬币大之无苔区。当以抑木扶土, 醒脾救胃为先: 生芪 45g, 当归、红参(另炖)、灵脂、柴胡、棉子炭、白芍各 15g, 炒麦芽 60g, 炒谷芽 30g, 曲楂炭、姜炭各 10g, 焦白术、茯苓、生苡仁、猪苓各 30g, 泽泻 18g, 油桂 5g, 炙草 10g, 生姜 10 片, 大枣 10 枚。二诊: 服上方 10 剂, 不仅食纳大

增,日可进食斤许,且舌上裂缝弥合,浮肿、腹水基本消退。出血大减,带下亦减,已不用卫生纸。半月之间,前后判若两人。以下从略。(357 页)

按 证属脾胃大伤,中气下陷,脾不统血,气不摄血重症。当下病治上,从重建脾胃元气入手,以补中益气汤合五苓散益气健脾利水,参灵散、炒二芽益气醒脾化瘀,姜炭、三仙炭温脾统血。

1. 4 白血病热毒炽盛型,清瘟败毒犀四味;气血两竭型,三复温脾止血汤

1. 4. 1 热毒炽盛型,清瘟败毒犀四味

组成 生石膏 250~500g,蚤休 15 30g,丹皮、紫草、赤芍各 15g,生地 30g,黄连 10g,黄芩 15~30g,连翘、玄参各 30g,知母、梔子、桔梗、甘草、竹叶、甘草各 10g。

主治 热毒炽盛型白血病,证见邪毒充斥表里三焦,人营动血,高热,大出血,全身酸痛等。

方解 重用生石膏 250~500g,丹皮、紫草、蚤休合用可代犀角,退高热奇效;石膏配伍知母、甘草,是取法白虎汤清热保津;黄连、黄芩、梔子,是仿黄连解毒汤清泻三焦;投犀角地黄汤,意在清热解毒,凉血散瘀;配连翘、玄参,以散浮游之火;佐桔梗、竹叶,能载药上行。诸药相合,成为气血两清之方。

用法 加水过药 2 寸,浸泡 1 小时,武火煮沸 10 分钟,取汁 600ml,分 3 次服,一昼夜连进 3 剂。

1. 4. 2 气血两竭型,三复温脾统血汤

组成 生芪 30g,当归、红参(另炖)、麦冬、五味子各 10g,山萸肉 30g,姜炭、三仙炭各 10g,炒谷麦芽各 30g,龙眼 15g,阿胶(化入) 18g,炙草 10g,生姜 50 片,大枣 6 枚。

主治 白血病气血两竭型,证见面色萎黄虚浮,唇指白如麻纸,眩晕不能坐立,纳呆,心动震衣,自汗如洗,两目失神,舌光绛无苔,六脉虚浮搏指。

方解 红参、山萸肉,取来复汤之意,合用当归补血汤、生脉散,益气固脱;姜炭、三仙炭温脾统血,龙眼、阿胶滋阴救阳;炒二芽醒脾,诸药相合,敛肝固肾,益气复脉,温脾统血。

用法 急煎频灌,日夜连投,以救危亡。

案例 小儿白血病 程某,男,13 岁。两个月前患急性粒细胞型白血病,白细胞 36 万,血色素 4 克,高热寒战,鼻血如注,大便如柏油状,经抢救脱险。用化疗 2 疗程后,处于弥留状态。诊见唇指白如麻纸,眩晕不能坐立,纳呆日进 1~2 两,五心烦热,心动震衣,自汗如洗。遂以当归补血汤合生脉散加味,重用参芪、山萸益气固脱:黄芪 30g,当归、红参(另炖)、广麦冬、五味子、三仙炭、炙草各 10g,山萸肉、熟地各 30g,砂仁 10g,元肉、女贞子、旱莲草各 10g,阿胶 10g,生姜 5 片,大枣 6 枚,浓煎,小量多次分服。首剂得效,服 3 剂可起坐,服 10 剂能下床散步,日可进食 1 斤多。不料前日忽然泛呕泄泻,脐下筑动应衣,下肢发凉,脉浮尺虚。此必久病伤肾,厥脱先兆。姑以当归补血汤合理中汤加温养肾命之品:黄芪 30g,当归、红参(另炖)、元肉、姜炭、三仙炭、炙草各 10g,炒白术、山药、炒谷麦芽各 30g,阿胶、生半夏、茯苓各 12g,肾四味 60g,生姜 10 片,大枣 6 枚。服 2 剂胃寒退,泻止脉敛,服 5 剂脐动隐,元阳固,可户外玩耍,10 剂后已如常人,血色素升至 7.5 克,白细胞降至 2 万 7 千。原方守服,加参鹿膏。李氏嘱病家慎饮食,避风寒,以防不测。不料 1 周后,其母高热昏迷,买一大西瓜,病孩乘其父外出配药偷吃多半(约 5 斤),当夜腹痛作泻,急用大剂参附龙牡山萸肉,投剂不应,不幸夭亡(369 页)。

按 本例禀赋素虚,邪从寒化、虚化,初病即见正气先溃,气随血脱,奄奄待毙,复加化疗摧残,气血耗伤殆尽。当此生死存亡系于一发关头,则当急急固脱为先。一切攻癌解毒、苦寒败胃之品,毫末不可沾唇。经抢救 4 个月,服药 40 剂,未用一味抗癌药,终于降服白细胞,使

血色素恢复正常。可见“以人为本”的思想，固护脾肾元气的治则，在癌症治疗中具有特殊地位（370 页）。

1.5 伏邪入里当外透，病证冲突当从证

1.5.1 伏邪入里当外透

李可在“脊髓胶质瘤案”中指出，患者禀赋素虚，嗜食生冷，卧室靠窗，夜卧当风，夏日入睡，不关电扇。脾失健运，正气先虚，痰湿内生，经期不避生冷，瘀血内阻，寒伤督脉，真阳失运，日久湿痰死血，阻塞经脉，成为有形癥积。遂拟攻癌基础方化痰软坚，消磨化积；麻附细汤深入少阴，透发伏寒；（341 页）。下面举例证之：

脑瘤术后复发 张某，女，25 岁。脑瘤术后复发，头痛如破，呕涎沫而肢厥，睛突目糊，口眼歪斜，右侧肢体失灵。予改良乌头汤（川乌 30g，麻黄 15g，白芍 45g，黄芪 45g，黑小豆、防风各 30g，蜂蜜 150g，炙草 600 加吴茱萸 30g，生半夏 45g，川芎 30g，白芷 15g，麝香 1 分冲，引诸药直捣病巢，一剂痛止呕罢。后予偏正头风散加守宫，炮甲、蜂房、川贝、麝香，以夏枯草 1500 克，依法熬膏合炼密为丸 15 克重，日服 2 次，每次 1 丸，以海藻、甘草各 30 克，煎浓汁送服，相反相成，激荡磨积，以加强软坚散结之力，服药 75 日赴京复查，病灶消失，恢复工作，现仍健在（247 页）。（247 页）

按 证属产后藩篱失固，贼风袭络，寒邪由表入里，三阴寒凝，大气失运，浊痰死血深伏脑络。予乌头汤大辛大热、通行十二经表里内外，破沉寒痼冷止痛，驱逐伏邪外透；吴茱萸、生半夏止呕止痛；川芎、白芷、麝香芳香开窍透邪。诸药相合，一剂痛止呕罢。

1.5.2 病证冲突当从证

李可认为，肿瘤的治疗，也应遵循这条原则，即当辨病与辨证发生矛盾时，要毫不犹豫地舍病从证。若对号入座，套用专病专方类，则是速其死也。中西医结合，中医没有现成饭可吃。丢弃了“以人为本，辨证论治”的法宝，何来中医的特色与优势（269 页）？现附验案，以为佐证。

骨瘤 赵某，女，60 岁，腰痛不能俯仰转侧半年多，上午轻，下午重，入夜剧痛呻吟不能入睡。口干不思饮水。胃嘈杂，脘胀，日仅进流质食物 3 两许，食后必寒热交作，移时即罢。昏昏欲睡，移时又觉五心烦热。近来腰脊痛甚，13 服镇痛片 30 片不能止痛，卧床不起逾月。便燥，溲若浓茶，诊脉迟弱，58 次/分，舌淡胖。患者高龄，肾亏于下，八脉失养。脊属督脉，腰脊皆。肾所主。今肝肾阴精匮乏，不能灌注濡润，故骨病。久病、阴损日甚，阳失依附，故阳亦衰，乃症情旦慧、昼安、夕加、夜甚之所由来。食后之寒热交作，亦非外感邪正交争，乃自身阴阳盛衰之变。肾为先天之本，腰痛如折，肾将惫矣。肾衰，则诸脏皆衰，火不生土，故脾胃失运。脾主中气，中气虚，则溲便为之变。故其便燥。溲赤绝非火象。拟从本治：熟地、附子、川乌、黑小豆、骨碎补、核桃肉、肉苁蓉、肾四味各 30g，龟、鳖甲各 30g，地骨皮 60g，盐巴戟肉、二冬、云苓、狗脊、杜仲、防风、细辛、干姜各 15g，炙草 60g，“炮甲珠 3g，茸尖 2g”（研末冲服），生姜 10 片，枣 10 枚，蜂蜜 150ml，头风散 9g，每次 3g，3 次/日。加冷水 2500ml，文火煮取 600ml，3 次分服。本方补肾之阴阳，滋养奇经八脉，黑小豆补肾与蜂蜜、防风、炙草，制乌附之毒，服之可保无虞。二诊：上方连进 3 剂，便通，溲清，胃嘈脘胀亦退。食纳增至 8 两许，饭后寒热交作亦愈。疼痛已减十之七八，夜寐得安。白天已停用镇痛片可到邻家串门。效不更方，再进 3 剂。以下从略（351 页）。

按 余治骨癌，仅此 1 例，晚期病人，气息奄奄，生命垂危，所患何病，已关紧要，重要的是挽救生命。故在“癌”字上做文章，已失去意义，只可全力着眼整体，扶阳助阴，保护脾胃，以血肉有情之品，温养八脉。

1.6 治癌要过四道关，整体失调四大证

1.6.1 治癌要过四道关

李可在“食道癌案”中指出，能否闯过疼痛、梗阻、出血、厥脱等四关，则是晚期食道癌者生存死亡的关键（350 页）。详情如下：

梗阻关 李可老母，年六旬，因悲伤抑郁，于同年 3 月患食道中段癌，9 月卧床，10 月并发梗阻，接受放疗 37 天。病势危重，水米不入已 5 天，以输液维持生命。当时血色素 6g，白细胞 3400，体重 315 公斤，一身大内尽脱，医院嘱速返乡准备后事。老母气息奄奄，干渴、潮热、唇焦裂。食道梗阻已久，水饮不能下咽，遂拟加味开道散一料：火硝 30g，紫硃砂 15g，明雄黄 3g，硼砂 15g，沉香 5g，枯矾 6g，柿霜粉 30g，锻绿石 5g，冰片 1.5g。乌梅肉 15g，共研极细粉，每次 1g，蜜汁调糊，缓缓含化，半小时许 1 次，日 10 余次，夜间停药。连续 5 天含化散剂，每次均呕出痰涎甚多。第 5 日下午，可饮少许蜜水下咽。且因硃砂、火硝之腐蚀，舌体及口腔脱皮灼痛，后每日减为含药 6 次，第 15 日，试服牛奶 1 小杯，顺利服下。此后病情逐日缓解，日可进食炼乳 4~5 次，藕粉 4~5 次，每次 1 茶杯。即发生食道梗阻之第 40 日时，可以喝稍浓之蛋汤及油茶，体质有所恢复，攻克了梗阻关。

疼痛关 胸背刺痛不休。其部位在任脉之天突穴下到膻中下二横指处一线，及相对应之督脉大椎穴至至阳穴处，固定不移。当属湿痰死血，滞留经络。治以每日午时以梅花针叩刺胸背疼痛部位，以及相应之华佗夹脊穴。重叩出血后，以走马火缸拔吸瘀血，意图使血流畅通。经络表里相通，外部充血，则内部病灶周围之瘀血、水肿自然减轻。3 日后，疼痛大为缓解，停用杜冷丁可入睡。散刺出血法，攻克疼痛关。

厥脱关 食道癌已 21 日未进饮食，欲便而虚坐努责不得下。证属久病正虚，高年气液两伤，不能传送。开始配服中药，益气降逆：赭石粉 50g，旋覆花（包）15g，白参（另炖）10g，生芪、当归、花粉、元参、沙参，生半夏各 30g，炙草 10g，姜汁 10ml，蜂蜜 120g，“蛇舌草 120g，黄药子 30g”（煎汤代水煎药、日分多次，缓缓呷服。3 日后，便下干结如羊粪球之大便 1 次。便后约 20 分钟，突然自汗而喘，面色苍白，目闭神昏。此为气从下脱，急针人中、内关而醒。急煎红参 30g，山萸肉 60g，随煎随饮，半小时后脱险，度过厥关。

出血关 第 50 日时，因散剂之腐蚀性极强，致瘤体破裂出血，当日便下柏油样便 1 次。两天后凌晨，突然寒热如疟，神疲自汗，心悸气喘，面色萎黄，四肢不温，脉若釜沸。证属久病正气内溃，肝虚（寒热往来）欲脱，大气下陷（气短不足以息，脐下少腹鼓凸如尿潴留状），肾元不固（喘），脾不统血（气随血脱，面色萎黄，肢冷、急投张锡纯氏来复汤合升陷汤，加三仙炭、姜炭、三七扶元固本，止血救脱：生芪 30g，红参 15g（另炖），山萸肉 60g，柴胡、桔梗、升麻各 6g，白芍 20g，生龙牡粉各 30g，炙草、姜炭、三仙炭、三七粉各分冲服），知母 18g，急煎频服。一昼夜连进 2 剂，诸症均退，出血即止，便转黄软，度过出血关（48 页）。

按 李可之经验，疼痛者：针刺与放血、止痉散、乌头汤、木鳖子（247、36、364 页）；梗阻者：开道散、止呕汤、双呕汤（15、44、348 页）；出血者：加减固冲汤、补中灵炭肾龙汤、来肾当补胶七汤（126、127、336 页、厥脱者：来复升陷汤、三复汤

1.6.2 整体失调四大证

李可指出，肿瘤到中医接手诊治时，已属误治坏病、晚期。由于放疗，化疗摧残，气血耗伤过甚，邪盛正虚格局已成。对此宜着眼整体，把定“扶正邪自退，养正积自消”的宗旨，对于脾虚、肾虚、潮热、相火诸证，急急用补。（62 页）。现举例证之：

甲状腺癌 王某，女，60 岁，颈部肿块 29 年，甲状软骨上方肿块杏子大，下方肿块约乒乓球大，均质硬，右颈部鹅蛋大肿块，凹凸不平。患者从 8 岁起，抽旱烟至今，支气管炎已 30 年。近 3 年暴喘迫促，痰声如拽锯，稠粘难出。目赤，胸、胃烧灼难耐。日食冰棍 1 桶，水果罐头

无数，始觉爽快。脉沉滑搏坚。证属痰气交阻，日久化火化毒，结于喉间要道。种种上热见证。盖由阴不抱阳，龙火上燔。先予引火汤，滋阴敛阳，引火归原：九地 90g，盐巴戟肉、二冬各 30g，云苓 15g，五味子 6g，上油桂米丸先吞、3 剂。凡见上热无制，即服 3 剂。后以攻癌夺命汤解毒化瘤：漂海藻、昆布、生半夏、鲜生姜、元参、花粉、海蛤壳、牡蛎、黄药子、木鳖子、蛇舌草、夏枯草、生苡仁、蚤休各 30g，大贝、麦冬、桃杏仁各 15g，白参（另炖）、五味子、山慈菇、山豆根各 10g，竹沥 2 匙，“全虫 12 只，蜈蚣 4 条，上沉香 1.5g，明雄黄 1.2g（研粉冲服），每旬服 7 剂。本案经治 18 个月，服药 300 剂，其中引火汤约占 1/4。以下从略（338 页）。

按 李可之经验，脾虚者，补中益气、四君子汤（57、361 页）；肾虚者，肾四、肾十味（352、368 页）；潮热者，补中退潮汤、来复升陷汤（350、364 页）；相火者，引火汤、七味地黄丸（297、338 页）。

1.7 攻补比例随证转，除恶务尽长固本

1.7.1 攻补比例随证转

李可认为，凡脾肾大伤，当调补脾肾 1—3 个月，人体正气得固，外观已无病象了，癌毒由嚣张转向伏匿，此时即可相机攻癌。或以攻为主，或攻补兼施，或补七攻三，立方守服，密切观察，随时调整攻补比例。一见伤正苗头，如气怯食少，噎腐嘈杂，或喘或汗，腰困膝软……速速转手进补。待元气一复，则敌退我打，攻之，荡之，削之，磨之（362 页）。下面以宫颈癌处方说明之：

全力补脾方 生芪 45g，当归、红参（另炖）、灵脂、柴胡、棉子炭、白芍各 15g，炒麦芽 60g，炒谷芽 30g，曲楂炭、姜炭各 10g，焦白术、茯苓、生苡仁、猪苓各 30g，泽泻 18g，油桂 5g，炙草 10g，生姜 10 片，大枣 10 枚。（357 页）

攻补兼施方 醋柴胡 15g，当归、二芍、茯苓各 25g，白术、苡仁、鸡冠花、白蔹、车前子、墓头回、贯众炭各 30g，棉子炭 15g，姜炭、三仙炭各 10g，丹皮、炙草各 15g，“红参、灵脂各 15g，三七 9g，全虫 12 只，蜈蚣 4 条”（研末冲服）。（58 页）

七补三攻方 生芪 45g，当归、醋鳖甲各 30g，红参（另炖）、灵脂、炙草各 15g，寄生、苡仁、贯众炭、白头翁、车前子各 30g，姜炭、三仙炭、焦酒军、土元各 10g，蛇舌草 120g，“三七 6g，全蝎 12 只，蜈蚣 4 条”（研粉冲服），10 剂（360 页）。

全力攻癌方 蛇舌草 60g，莪术、生地、贯众炭、桃仁、党参各 30g，灵脂 15g，丹皮、桂枝、茯苓各 15g，墓头回、夜交藤、生龙牡各 30g，川军炭、儿茶、五味子、甘草各 10g，“全蝎 12 只，蜈蚣 4 条”（研粉冲服），10 剂（356 页）。

1.7.2 除恶务尽长固本

李可认为，治癌是持久战，癌体的脱落，转移灶的消失，不等于癌毒的彻底消灭，仍须长服培元固本散治本，拔除病根。因为“炉烟虽熄，灰中有火”，一旦正气有亏，癌毒又成燎原之势（347 页）。如一例宫颈癌，服药 70 剂后，已无病象。体重回升至 50 公斤以上，康复 2 年半。因未遵医嘱服培元固本散，半年后病逝（359 页）。

2 治肿物思路

李可认为，良性肿物多为气滞、血瘀、痰凝所致，包括颈淋巴结核、甲状腺囊腺瘤、乳腺增生、包块型腹膜炎、风湿性结节、脂肪瘤（痰核、扁平疣等）（117 页）。

2.1 良性肿物验案

李可治良性肿物经验，多散见于医案。必面先看其医案，然后再进行理论探讨。

乳腺增生 耿某，女，18 岁。右乳下方于 3 月前发现有一包块，约杏子大，逐渐长至鸡蛋大，表面光滑，边界清楚，可活动，无粘连。患者个性愚拙，不苟言笑，爱生闷气。3 个月前正值经行暴受气恼，遂致经断。不久即觉左乳窜痛、憋胀，胁肋不舒，痰多，渐渐长块。曾服逍遥丸 6 合无效。脉沉滑有力，苔白腻。证属气滞血瘀，痰气交阻。予疏肝化瘀，软坚散结：漂海藻、生甘草各 15g，柴胡、白芥子各 10g（炒研），夏枯草、牡蛎粉、炒王不留行、丹参、木鳖子各 30g，桃仁、红花、泽兰叶、六路通各 10g，“全虫 12 只、蜈蚣 2 条”（研末冲服），生姜 5 片，枣 6 枚，7 剂。二诊，上方服后乳部有虫行感，服至第 4 剂时经通，下黑血块甚多。经期又服 3 剂，经净块消（117 页）。

按 上方即攻癌基础方之雏形，可治全身之良性肿物。方中海藻为消瘤专药，与甘草同用，相反相激，攻坚化瘤，磨积消水；木鳖子苦微寒，有毒、为消积块破肿瘤要药；夏枯草清肝散结，主治瘰瘤、乳癌，兼有补益养血之功；生半夏、白芥子为消痰核，化肿瘤要药；消瘰丸软坚破积，养阴化痰；蜈蚣入络搜剔，活血化瘀，直捣病巢，力专效宏；牡蛎粉、王不留行软坚散结，疏解气郁。诸药相合，气通、血活、痰消，其症自愈。若属阴寒凝聚者，加肉桂、细辛；坚积难消者加生水蛭 3g、炮甲珠 6g 研末冲服。多数 7 剂即消，痼疾 20 剂可愈。

子宫肌瘤 燕某，女，44 岁。经妇检，确诊为子宫肌瘤（9x8cm），建议手术切除，但患者畏惧，特来门诊求治。腹诊，少腹胀大如怀孕 5 月状，脐下有拳头大之圆形肿物。痛经 5 个月，每月经行不畅，色黑稠粘，块屑甚多，淋漓不断，常延续 10 日以上不止，经期绞痛胀急。面色暗，舌淡红，脉弦。有形癥积，已非一日，予桂枝茯苓丸加虫类搜剔缓攻之：桂枝、桃仁、丹皮、赤芍各 15g，茯苓 45g，柴胡、红参（另炖）、灵脂、土元、甘草各 10g，大贝 15g，生水蛭、炮甲珠各 6g，蜈蚣 2 条研粉黄酒冲服，10 剂。二诊：前投桂枝茯苓丸缓攻癥积，红参、灵脂扶正化瘀，虫类入络搜剔，迭进 10 剂，少腹膨隆之状大减，胀势已松。今适值经期，腹未痛，黑块已少，脉沉滑，舌色暗，因势利导，通经化瘀为治：桂枝 15g，茯苓 45g，赤芍 25g，桃仁、丹皮各 15g。坤草、归须、丹参各 30g，柴胡、酒香附、泽兰叶各 12g，川中膝 30g，甘草 10g，“生水蛭、炮甲珠各 6g，蜈蚣 2 条”（研粉冲服），生姜 5 片，枣 10 枚。三诊：上方连服 3 剂，经行畅通，下瘀块甚多，少腹如孕之状已消，腹痛已除，以下从略。

按 余以桂苓参灵四虫丸治子宫肌瘤 17 例，除一外省患者情况不明，皆获痊愈。凡瘀积重，面色暗黑，眼有黑圈，环口一圈紫暗，手足心、前胸后背发热者，为血瘀发热，加酒大黄 10~15g，三五日即退，此即大黄廕虫丸意。红参、灵脂益气化瘀。4 种虫类药，软坚散结，化瘀力强。冲任隶属于肝，血瘀者气必滞，加柴胡疏达肝气。大贝消痰软坚，缩每病程（99 页）

巨型胰腺囊肿 刘某，女，16 岁。1991 年遇车祸，脾破裂。术后 5 日发生肠扭转，二次手术后一月左上腹日见膨隆，左肋下刺痛不休，按之有波浪感，日见增大。致胸闷气憋，卧则胀不可忍，不能呼吸。肿物左超剑突，上界在 12 肋，下界在左鼠蹊部上方，高凸如怀孕状。天津医学院附属医院确诊为胰腺囊肿 16.5x22cm。遂拟：柴胡 15g，当归 30g，赤芍 25g，甘草、大黄、酒香附、红花、泽兰叶各 10g，丹参 30g，红参、灵脂各 10g，桂枝、桃仁泥各 15g，茯苓 45g，丹皮 15g，肉桂、苏木、猪苓、泽泻、木香、枳壳各 10g，炮甲珠（研冲服），水煎 2 次，混匀，对入黄酒 2 两，再煎三沸，2 次分服。服 3 剂，二便畅行，腹中鸣响，矢气频频，小便特多，大为松宽，可以平卧。连服 9 剂，共服 12 剂，庞然大物，消无芥蒂。复查肿物消失，痊愈。（98 页）

按 肿物既由外伤而来，必是络脉损伤，致湿痰死血积聚成癥。复元活血汤善治跌打损伤，恶血流于胁下；桂枝茯苓丸为消癥瘕积聚效方，参灵散（红参、灵脂各川吕）益气化痰。

胆囊肿物 梁某，男，77 岁。急诊住院，主症为全身浮肿、怕冷、低烧、无汗，上腹部绞痛呕吐。B 超见右肋 15x13cm 之囊性肿物，白细胞 19500，血沉 72mm/h，最后诊断为结核性腹膜炎、急性胆囊炎。经急性期对症疗法，1 周后出现腹水，抽水 2 次，旋抽旋肿。病危出院邀诊。刻诊大腹膨隆，脐凸胸平，喉间痰鸣，咳喘胀急，不能平卧。下肢烂肿如泥，脚膝冰冷。面色

灰暗，两目无神，心悸，神疲嗜睡，不食、不渴，尿少、全身不时颤动。患病35日，始终憎寒无汗。舌红如柿，无苔而干，舌中裂纹纵横，脉促细，132次/分。拟助阳解表泻浊为治：麻黄15g，附子30g，细辛、红参（另炖）各15g，油桂（后下）10g，茯苓、白芍各45g，白术30g，生姜45g，加冷水1500ml，文火煮取600ml。3次分服，3小时1次，得汗则止，不必尽剂。二诊：四肢回温，腹胀略松，知饥思食，已可起坐。仍憎寒无汗，欲厚衣被。目珠、胸腹发黄，黄色灰暗，尿黄量微，脉沉细，92次/分，已无促象，舌色依旧。表气闭阻日久，寒湿不化，发为黄疸。药随症变，原方合茵陈五苓散，温阳泻浊，扶正气以开表闭，2剂。煎服法同上，得汗去麻黄。三诊：得畅汗，上闭一开，下窍立通，尿量大增，从昨夜23时至今晨8时，尿量约3000ml以上，腹水消去大半，黄疸退淡。上方去麻黄、细辛，加海藻30g，甘草15g，另用“全虫12g、蜈蚣2条”（研末冲服）虫类入络散结，以治肿物，2剂，每日1剂。四诊：黄疸退净，肿物缩小，改方：生芪60g，猫爪草、漂海藻各30g，木鳖子、生苡仁、芙蓉叶、附子各30g，皂刺、白芷、柴胡各10g，另用川贝、炮甲珠6g、全虫3g、蜈蚣2条（研末冲服），3剂。服后肿物全消，腹水消尽，痊愈。（58页）。

按 患者年近八旬，肾气已衰，初病憎寒发热无汗，正虚无力鼓邪外透，兼见呕吐腹水。乃少阴（肾）虚寒为本，兼见太阳表寒实，渐传太阴（肺、脾）里虚寒证，肺、脾、肾三脏俱病。初诊拟麻附细汤温肾助阳解表为先，开太阳之表，宣肺闭而通水道，合真武汤温阳泻浊，益火之原，以消阴翳，加人参助元气，加油桂以蒸动下焦气化。三诊以真武合五苓散，温阳泻浊；海藻、甘草，相反相激，攻坚化瘤；全蝎、蜈蚣，入络散结，直捣病巢。诸药相合，以治囊肿；5剂追访，肿物全消。

结核性包块型腹膜炎 王某，女，15岁。因呕吐腹痛，其母给患儿揉肚，发现下腹部明显隆起，有一包块质硬，经8超探查，证实为结核性包块型腹膜炎。包块在耻骨联合上4cm处，17x16cm。据其母告知，患儿喜吃生冷，喝凉水，月经尚未来潮。面色萎黄，脉弦涩，舌淡有齿痕。女子二七而天癸至，患儿发育良好，已属经行年龄。由过贪生冷，致寒痰凝于胞宫，已成有形癥结。拟温经化痰，逐瘀通络，待其经通，癥结自消。生芪45g，当归、丹参各30g，赤芍15g，川芎、桂枝各10g，茯苓30g，桃仁、红花、丹皮、炮姜、没药、白芥子（炒研）、三棱、莪术、木香、甘草各10g，失笑散包），炒小茴15g，7剂。二诊：肿块渐软，仍未缩小。原方加酒大黄6g、醋鳖甲（打、先煎）、土元10g，5剂。肿块缩小1/3，守方再服5剂，加党参30g，三诊：又缩小1/2。以下从略。（101页）

按 本案以少腹逐瘀汤温经散寒，桂枝茯苓丸、鳖甲、三棱、莪术消癥化积；酒军、土虫，取大黄庶虫丸之意；生芪、白芥子，去皮里膜外痰凝；木香流气，气旺湿去血活，其块自愈。

鼻硬结症 蔡某，男，49岁。鼻头不适10年，初起，鼻尖部右侧长一小红疹，后渐长至黄豆大即化脓。5月后局部发硬，至长至玉米粒大，基底充血，表面似角状。省肿瘤医院确诊为“鼻硬结症”，赘生物为“皮角”。稍一碰触，奇痛钻心，病虽不大，痛苦不小。现症，右胁痛如椎刺，面颊部满布血丝，胸闷口苦，头痛鼻塞，声嘶，渴喜冷饮；脉象弦数，舌红少苔，边尖瘀斑。遂拟：柴胡10g，赤芍、当归、丹参各30g，郁金15g，炮甲珠3g（研末冲服），黑栀子、丹皮、桃仁、红花、凌霄花、威灵仙、白芷、苍耳子、甘草各10g，元参、牡力粉、活磁石、紫贝齿各30g，夏枯草120g。上方连服15剂，角状物脱落而愈。本方中之炮甲珠、威灵仙、牡蛎、夏枯草，有很强的软坚化积之力，威灵仙合楮实子号称“化铁丸”，对一切坚结难化肿物、结石，有消散作用，治各种“疣”亦有效。（284页）

按 追询病史，知患者愚拙，心胸狭窄，长期郁闷致病。证属肝气郁积化火，反克于肺，肺气失宣，故鼻病。今当疏肝气，散肝瘀，清肝火，以丹栀逍遥散疏肝清火，清癭丸养阴化痰，化铁丸软坚化积，芷甲散穿透攻破，苍耳子散芳香开窍，兼引诸药直达病所。

局限性皮炎 张某，男，27岁。初诊：上唇木肿，2个月不消。初病上唇左侧肿如大米粒，误作唇疔，以三棱针局部放血后，半小时内肿延全唇，次日肿齐鼻翼，半月后肿势蔓延至双颧

骨，右眼肌麻痹，不能闭合。刻见唇肿外翻，多处迸裂出血，麻木不知痛痒。愈冷，愈觉木厚而胀。晋中二院外科诊为“局限性皮炎”。脉浮弱，舌淡胖，齿痕累累。遂拟：乌蛇荣皮汤、去生地、丹皮、紫草、白藓皮。加生芪 30g，白芥子 10g，去皮里膜外之痰凝，3 剂。二诊：唇部变柔软，口已可闭合。左嘴角有 1 结块如杏大，质硬。自汗而凉，气怯。加红参另炖），“炮甲珠 3g，麝香 115g”（研末冲服），通络化痰散结。三诊：上方连服 6 剂，结块已消，全唇变软。（330 页）

按 考患者系马车工，经年累月，饱受风霜雾露外袭，营卫阻塞，大气不运，卫外失固，寒邪趁虚袭络，法当益气和营活血为主。故以乌蛇荣皮减味方（去苦寒药）调营活血；生芪、白芥子去皮里膜外之痰凝；麝甲散通络化痰散结。

扁平疣 甄某，女，34 岁。患左颊部、左手背扁平疣 2 年多，挑，刺，禁（以丝线扎紧瘰子根部，使之缺血坏死），涂（鸭胆子），内服中药数十剂，皆无效。日见增多，面部有黄褐斑，痛经，舌质紫暗，脉涩，黄带。断为湿热内蕴，瘀血内阻，营卫阻塞，不荣肌肤四末。予乌蛇荣皮汤合麻杏苁甘汤加白芷通窍，炮甲珠 6 又研末冲服），7 剂后瘰子全部自行脱落，黄褐斑亦退净（323 页）。

按 扁平疣，是由乳头瘤病毒引起的表皮良性肿瘤。以乌蛇荣皮汤通调营卫、养血祛瘀，麻杏苁甘汤开表闭、化湿浊，芷甲散通窍散结。

2.2 良性肿物常用方

李可治良性肿物常用方：①海藻甘草汤（61、117 页）；②桂枝茯苓丸（99、103 页）；③少腹逐瘀汤（101、103 页）；④消瘰丸（17、284 页）；⑤五苓散（60、98 页）；⑥化铁丸（222、284 页）；⑦麻杏苁甘汤（323 页）。

2.3 良性肿物经验方

李可治良性肿物经验方：①攻癌基础方：海藻、生甘草、木鳖子、夏枯草、生半夏、生姜、元参、牡蛎、大贝各 30g，“全蝎 12 只、蜈蚣 4 条”（研粉分吞），白芥子（炒研）10g（117 页）；②妇科培元固本散：红参、灵脂、三七、血琥珀、土元、水蛭、全蝎、蜈蚣、川贝、桂枝、茯苓、赤芍、丹皮、桃仁各 30g，夏枯草、海藻、甘草各 500g；肾虚寒者加油桂 30g（401 页）；③桂苓五苓芷甲汤：桂枝 15~30g，茯苓 45g，赤芍 25g，丹皮 15g，桃仁 15g，猪苓、泽泻各 15g，白术 30g，肉桂、白芷各 10g，炮甲珠（研粉分服）6g，益母草、丹参各 30g，泽兰 15g，海藻、甘草各 15~30g，“全蝎 6 只、蜈蚣 2 条”（研粉分服）（101 页）；④麝甲散：麝香 2g，炮甲珠 60g（330 页）。

（选自《李可老中医危重症疑难病经验专辑》）

痰生百病虚为本

——李可学术思想探讨之二十二

● 孙其新*

摘要 针对痰饮病治疗规律,进一步探讨了李可学术思想。李可治痰饮病思路:痰饮概念;痰饮水湿,同源异流;阴阳寒热分型,六经三焦论治;有形之痰——肺胃痈结肿,无形之痰——心脑血管。治痰饮病常用方:小青龙汤、麻黄附子细辛汤、小续命汤、瓜蒌薤白白酒汤、小半夏加茯苓汤、泽泻汤、吴茱萸汤、甘遂半夏汤、五苓散、葶苈大枣泻肺汤、真武汤、四逆汤、乌头汤、附子理中汤、大黄附子汤、薏苡附子败酱散、麻杏石甘汤、千金苇茎汤、大柴胡汤、白虎汤、大承气汤、大黄牡丹汤、小陷胸汤、桂枝茯苓丸;三生饮、阳和汤、追风散、温氏奔豚汤、控涎丹、礞石滚痰丸、普济消毒饮、四妙散、清肠饮、消瘰丸、透脓散、止痉散、海藻甘草汤、化铁丸。治痰饮经验方:小青龙虚化汤、瓜丹桂枝芩茎汤、阳和小青茱萸汤、改良乌头汤、破格救心汤、破格瓜丹夏星汤、奔豚干姜紫石汤、附理砂半醒脾汤、大附夏苓醒脾汤、重订追风散、三生夏沉开窍饮、麻辛四五止痉散、苍术白虎汤、攻毒承气汤、辟秽解毒汤、羚麝止痉散、犀地承气开窍汤、礞石滚痰开窍丸、涤痰清脑汤、银英犀军普济饮、七味消毒饮、攻癌夺命汤、三饮四石汤、黄芪五苓三妙散、止呕汤、参灵甲珠散、芪物当耳芥蛋汤、还五桂枝芥虫汤、麝甲无敌散、妇科培元固本散。

关键词 痰饮 治疗思路 常用方 经验方 李可 医案

临床经常会遇到与中医痰饮有关的西医病,尤其是无形之痰,既看不见,又摸不着,总觉得有点“玄”。但只要正确运用中医理论,可以根据痰的临床表现作出诊断,也可以结合论治的结果进行验证,无形之痰确实是客观存在的。对于这些西医病,如何从中医痰饮病的角度去整体把握,这是个棘手的问题。李可对此有着丰富经验,现据其医案,整理出以下内容:

1 痰饮病验案

李可治痰饮病理论很少,仅散见于医案,必须先看其医案,然而

再进行理论探讨。李可认为,痰之为物,随气升降。入于经络则疼痛、麻木、瘫痪、结核;入于肌腠则凝滞成痈;犯肺为咳、为喘;凌于心则悸;犯胃则呕;冲于上则为眩晕;入于脑络则为痰厥、癫痫、痴呆、昏迷;流于下则为痿痹、鹤膝、骨疽(273页)。下面举例证之:

1.1 痰冲于上,眩晕、昏迷、痰厥、癫痫狂

美尼尔氏眩晕 曹某,男,62岁。患者于昨晚1时许,睡梦中突然剧烈心跳惊醒。随觉脐下有气上攻,呕吐痰涎不止,头痛,眩晕,不能自持,觉整座房屋如走马灯相

似,旋转不停,心中恐惧,闭目宁神亦无济于事。约10余分钟后稍好,移时又发作如前。天亮后请西医检查,心脏、血压正常,诊为美尼尔氏综合症。诊脉沉滑,舌胖苔腻。遂拟:泽泻90g,白术36g,党参、吴茱萸各30g,炙草15g,生半夏、茯苓、紫石英、龙牡、磁石各30g,生姜30g,姜汁(兑入)20ml,大枣20枚。浓饮,呕止后每次200ml,3小时1次,日夜连服2剂(272页)。

按《金匱》关于痰饮病人的病因、病机、症状的描述,与现代内耳眩晕症十分契合。泽泻汤之泽泻利水排饮,使水饮从小便而去,白术补中燥湿,以杜生痰之源,使痰饮不再复聚;小半夏加茯苓汤降逆止呕,利水化饮;吴茱萸

* 作者简介 孙其新,男,主任医师。从事辨证论治的整理和经方的临床应用,著有《谦斋辨证论治学》、《李可临证指南1》。E-mail: sqx6346@163.com

• 作者单位 辽宁省岫岩县中心人民医院(114300)

汤暖肝和胃,降逆补虚,温化寒饮,更擅解一切痙挛,迷路之痙挛解,积水去,耳窍复清虚之常,其症自愈。

小儿流脑昏迷 温某,男,13岁。上学途中突然高热寒战,头痛呕吐昏厥。经注射青霉素、安乃近不能控制。体温 39.70℃,颈项强直,频频抽搐,角弓反张,喷射状呕吐,体若燔炭,四肢厥冷,胸背部瘀点、瘀斑,神昏谵语,溲赤便结,大渴饮冷,脉滑数,牙关紧闭,不能察舌。已查血,白细胞 2 万、中性 90,脑膜刺激征阳性,诊断暴发型脑炎。急以三棱针重刺十宣、十二井、百会、大椎出血,双手中缝穴刺泄粘液、黑血。毫针雀啄术泻涌泉,点刺素寥、人中、合谷。继拟:①羚麝止痙散 15 克,玉枢丹 2 瓶,匀作 5 份,2 小时 1 次。②石膏 200g,丹皮、紫草、蚤休各 15g,双花 60g,连翘、生地、大青叶、芦根各 30g,大黄、甘草各 15g,青黛 10g(包煎),芒硝 15g(冲化),加冷水 1500 毫升,浸泡 1 小时,急火煮沸 10 分钟,取汁 1000 毫升,3 小时服 1 次,每次 200 毫升,昼夜连服,以下从略(78 页)。

按 本案昏迷,证属瘟毒炽盛,气血两燔,热结阳明,邪闭心包重症。先以针刺放血,随即透汗、呕止、苏醒。再查体温已降 1 度,起到了顿杀病势的效果。继以羚麝止痙散、犀角地黄汤、调胃承气汤合方,清瘟解毒,涤痰开窍,熄风止痙奏效。

尿毒症昏迷 纪某,男,29 岁。1987 年秋患尿毒症,住院接受透析疗法已 2 个月,病情恶化,专程来灵石邀余诊视。见患者面色灰暗,呕吐涎沫不止,口臭,有烂苹果味,牙龈出血,大便黑糊状,小便如浓茶,腹胀,四肢厥冷,神迷嗜

睡。脉弦细而劲,苔黑润。昨日化验,尿:蛋白 + + +,白血球 5~10,红血球满视野。血:尿素氮 60ml,二氧化氮结合力 40 容积%。遂拟大黄附子、小半夏加茯苓、五苓散化裁:附子 100g,肾四味 80g,红参(另炖)20g,灵脂 10g,酒大黄 30g,细辛 15g,芒硝(冲)20g,油桂 10g,焦三仙各 15g,云苓 30g,生半夏 30g,猪苓、泽泻、吴茱萸各 15g,炙草 10g,麝香(冲)1g,生姜 30g,姜汁(兑入)10ml,大枣 12 枚。加冷水 1500ml,文火煮取 400ml,兑入参汁、姜汁,冲化芒硝,3 次分服,3 小时 1 次,每次另服麝香 1/3g,1 剂。以下从略(164 页)。

按 患者昏迷嗜睡,四肢厥冷,呕吐涎沫不止,口臭,有烂苹果味,牙龈出血,大便黑糊状,小便如浓茶。证属浊邪弥漫三焦,蒙蔽神明,肾阳垂危之关格大症。遂投大附夏苓醒脾汤加麝香,温阳益肾,荡涤痰浊,开窍醒神。

肺心病心衰痰厥 闫某,男,60 岁。患阻塞性肺气肿、肺心病代偿期达 10 年。本次发病 1 周,县医院抢救 6 日,病危出院,准备后事。昨夜子时,突然暴喘痰壅,昏迷不醒。县医院内科诊为“肺心病心衰、呼吸衰竭合并脑危象”,已属弥留之际。切脉散乱如雀啄屋漏,移时一动。遂投破格救心汤大剂加味:附子 150g,干姜、炙甘草各 60g,高丽参(另炖)30g,生半夏 30g,生南星、菖蒲各 10g,山萸肉 120g,龙牡、磁石各 30g,麝香(分冲)0.5g,生姜 30g,大枣 10 枚,姜汁(兑入)1 小盅。病情危急,上药加开水 1.5 公斤,武火急煎,随煎随灌,日夜连服,以下从略(6 页)。

按 本案昨夜子时,突然暴喘痰厥,昏迷不醒。口鼻生冷,手足

厥逆,双下肢烂肿如泥,二便失禁,面如死灰。遂投破格救心汤大剂回阳固脱,加三生饮豁痰,麝香辟秽开窍。

癫痫 河南一个 40 多岁的妇女,她有个男孩,13 岁。由于脑部受伤,从生下来就发癫痫,多年一直没好,最后听说北京某医院有进口的新药,可以治这个病。她就到那儿把药买好了,买好以后,医院就告诉她,这个药有很大的毒性,不安全,最好住在医院来用。因为她十几年来一直在给孩子治病,山南海北跑遍全国各地,花钱就海了,也没有在意。回去给小孩吃了以后,孩子就突然昏迷不醒,四肢冰冷。她要求医院抢救,医院说这种病我们也没有办法。可巧她在北京买到我的那本书,按书上的破格救心汤大剂,取了一剂,住在小旅馆里求人说好话,找了个电炉子熬好。给孩子一点点灌,看能不能醒过来、活过来,最后把药灌进去,孩子就活过来了,还有个特殊的事,他 13 年的癫痫再也没犯过(45 页)。

李按 患儿的癫痫,从 1 岁到 13 岁每年都犯,严重的时候一天高达 40 次,最后一剂破格救心汤服完以后,从北京回到河南,再也没犯过。破格救心汤治癫痫,看来出乎意料,但癫痫是阴寒痰浊阻于脑窍,破格救心大剂斩关夺门,破阴通阳开窍,当在意中。

精神分裂症 杨某,女,20 岁。经前突然发狂,打闹怒骂,不避亲疏。目神混浊、呆滞、目赤、舌尖赤、苔黄厚,舌左瘀斑成条,脉沉滑。县医院内科诊为“青春型精神分裂症狂躁型”,用强力安眠镇静剂无效。遂拟涤痰清脑汤加祛瘀之品:生石膏 200g,丹皮、紫草各 15g,大黄、芒硝(冲)、黄芩、黄柏、

煅礞石、生铁落、夜交藤各 30g, 菖蒲、郁金、生桃仁、红花各 15g, 生地 45g, 黄连 10g, 天竺黄 10g, 胆南星 10 克 g, 甘草 10g, 竹沥 (兑入) 1 瓶, 人工牛黄 (冲) 2g, 青黛 (包) 15g。上方服 2 剂, 经通, 下黑血块甚多, 神清, 打闸止, 夜可安睡。又连服 7 剂, 每次泻下胶粘大便 3~4 次, 恢复学业, 追访至参加工作, 未犯 (191 页)。

按 本案由五志过极化火, 夹痰热上攻神明而为狂证, 用涤痰清脑汤治约 40 余例。愈后当以理中、四君子汤调理脾胃, 以杜生痰之源。

1.2 痰冲于下, 痿痹、鹤膝、骨疽

脊髓胶质瘤合并痿痹 温某, 女, 19 岁。北京天坛医院诊断“C5-T3 水平脊髓占位病变, 神经胶质瘤”。因手术风险大, 易复发, 建议转中医诊治。询知颈项强痛, 脊柱向右侧弯, 转侧困难, 斜颈, 已 6 年。左肩背沉困重痛, 四肢无力, 左下肢肌肉萎缩, 双下肢进行性麻木, 近半年已不知痛痒。左腿环跳穴及足跟部电击样阵痛, 一日数发, 步态蹒跚、倾侧, 已休学 2 个月。面色晄白无华, 气怯神倦, 头目昏眩, 瑟缩畏寒, 六脉沉迟细涩, 舌淡胖有齿痕。遂拟攻癌基础方、补阳还五汤、麻附细汤合方加味: ①生芪 240g, 葛根 90g, 麻黄 15g, 附子 30g, 细辛 20g, 漂海藻、生甘草、生半夏、云苓各 30g, 白芍、川芎各 30g, 白芥子 (炒研)、桃仁、红花、僵蚕、地龙、两头尖、子蜂房、天南星、高丽参 (另炖)、灵脂各 10g, 鲜生姜 30g, 大枣 12 枚。加冷水 1500ml, 文火煮取 450ml, 3 次分服, 5 剂。②全虫尾 15g, 大蜈蚣 20 条, 川贝、土元、炮甲珠各 30g, 麝香 2g, 共研细粉, 分作 15 包, 1 包/次, 3 次/日, 随中药服。以下从略

(340 页)。

按 患者禀赋素虚, 嗜食生冷, 卧室靠窗, 夜卧当风, 夏日入睡, 不关电扇。脾失健运, 正气先虚, 痰湿内生, 经期不避生冷, 瘀血内阻, 寒伤督脉, 真阳失运, 日久湿痰死血, 阻塞经脉, 成为有形癥积。遂拟攻癌基础方化痰软坚, 消磨化积; 补阳还五汤重用生芪补大气, 温督脉, 化瘀血; 麻附细汤深入少阴, 透发伏寒; 重用葛根专理颈项, 通督达脊; 更加虫类搜剔, 攻坚化瘤。

鹤膝 刘某, 男, 76 岁。初诊: 60 岁时深秋涉水过河, 寒湿入骨, 患双膝关节肿痛达 16 年。近日外感引发宿疾, 双膝关节肿痛积液 50 天。肿势日重。双膝肿大如斗, 憋胀难忍, 曾抽取透明胶液体 400ml, 旋抽旋肿。左腿强直, 不能打弯, 卧床不起已 1 月。面色苍白, 气短乏力, 寸脉极弱。曾服四妙、五苓合方无效。遂拟: 生芪 45g, 防己 12g, 桂枝 10g, 赤芍 15g, 川芎 10g, 苡仁 45g, 茯苓 30g, 泽泻、独活各 15g, 白术 30g, 苍术 15g, 川牛膝 30g, 炙草 10g, 白芷 10g, 生姜 5 片, 大枣 6 枚。以下从略 (251 页)。

按 本案双膝肿大如斗, 曾抽取透明胶样粘液 400ml, 旋抽旋肿。“透明胶样粘液”与中医之“痰”是相吻合的。证属年高体弱之人, 中焦脾胃气虚, 则聚湿成水, 下流关节为鹤膝。用生芪补大气, 五苓、三妙散健脾运湿。气旺则周流全身, 而痰湿得化。

骨疽 李某, 女, 50 岁。素有肺结核病史, 5 年前诊断为骨结核。右腿有痿管一处, 脓水淋漓, 终日不绝, 行走困难。邀李可一弟子诊治。遂拟宣通经络、消肿止痛、化阴为阳之虎挣散 (制马钱子、

炮甲珠、制附子), 每次 0.6g, 日 2 次。10 日痿管分泌减少, 2 个月已痊愈。

按 李可治骨结核、肠结核、淋巴结核等 10 余例, 均以阳和汤合止痉散, 皆在短期内治愈。

1.3 痰生于内, 肺咳、胃呕、心悸

小儿急性肺炎咳喘 王某, 男, 4 个月。因急性肺炎高热抽风入院, 历一昼夜不能控制。患儿高热昏迷, 体温 39.70℃, 牙关紧闭, 角弓反张, 两目上翻, 痰壅鼻扇, 频频抽搐, 约 5~6 分钟一次。唇指青紫, 四肢厥冷, 体若燔炭, 紫纹直透命关。证属风热犯肺, 痰热内结, 热极动风, 邪陷心包。急以针刺放血, 患儿汗出、苏醒、抽止。继拟服羚麝止痉散 1 克, 加麝香 0.3 克, 后服: 石膏 30g, 麻黄、杏仁、甘草、丹皮、紫草、天竺黄各 10g, 芦根 30g, 蚤休 15g, 竹沥 20 毫升, 葶苈子 10g, 大枣 10 枚。煎汁 60 毫升, 服至 35 毫升、散剂 3 次而愈, 以下从略 (72 页)。

李按 本案因急性肺炎, 故以麻杏石甘汤为主。其中石膏、丹皮、紫草、蚤休, 4 药合用可代犀角, 退高热奇效。羚麝止痉散 (羚羊角 3g, 麝香 1 克, 蝎尾 12 只, 蜈蚣 2 条为末, 分 3 次服), 清热解毒、涤痰开窍、熄风止痉, 为余急救小儿高热惊风开窍醒脑常备药。

胃出血呕吐 武某, 男, 41 岁。患者胃溃疡大出血病危, 酒醉后吐血盈碗, 沥青样黑糊便, 血色素 5 克。因体质过虚, 暂不宜手术。诊见面色、唇、指如白纸, 食入即吐, 神糊思睡, 四肢冷, 头晕不能起立, 立则气喘自汗。脉迟细弱, 48 次/分。频频呕吐, 药难下咽, 急则治标: 赭石、生半夏、高丽参 (另炖)、茯苓各 30g, 吴茱萸、炙草

各15g,生姜30g,姜汁20毫升,大枣12枚。小量频服,药后2小时呕止,以下从略(15页)。

按 李可之止呕汤,其一生应用上万例,通治中医肝胃气逆之呕吐,包括西医妊娠性呕吐、胃出血狂吐、胃肠痉挛性呕吐、胆囊术后呕吐、脑膜刺激症喷射状呕吐等。轻者服一两口即止,稍重则2、3次即愈,极重症10小时许过关。

冠心病心悸 关某,男,60岁。原发性高血压20年,近日突发冠心病,紧急入住山西医大二院ICU抢救。三日未能控制病势,院方邀余会诊。诊见:面色乌黯如蒙尘,体胖唇紫,大汗淋漓,六脉浮大空、迟,时一止。心动神摇,胸憋频发,发则四肢瘫软,口不能言,气短不足以息。CT核磁见冠状动脉左支梗阻百分之七十,二尖瓣关闭不全。遂处方:炙草120g,干姜90g,制附片100g,高丽参30g,五灵脂45g,生山萸肉90g,桂枝45g,桃仁泥30g,丹参120g,檀、降、沉香、砂仁各10g,三石(龙牡、磁石)各30g,九节菖蒲10g,麝香0.3g,顿冲,苏合香丸2丸。上药日夜连服两大剂,次日诊之,诸症均退,面、唇、舌、甲转红,脉缓,脱险。囑原方附子逐日叠加至250克,加干姜50克,余药不变,24小时内服完二剂。计前后三诊,8日内服药12剂。赴京阜外心血管医院,与山西二院4月20日cT、核磁片对照:冠脉左回旋支梗塞的百分之七十已通,二尖瓣功能恢复,以下从略(129页)。

按 本案冠状动脉左支梗阻高达70%,足证痰湿瘀浊踞踞阳位。遂拟破格救心汤破阴回阳,阳光一照,阴霾尽消。

1.4 痰生于外,疼痛、麻木、瘫痪、结核、痢疾

急性风湿热关节痛 金某,女,47岁。1年前秋突然高热42℃,全身肌肉筋骨剧痛。热退后双下肢僵硬肿胀青紫,痒痛不能入睡,脚肿不能穿鞋。今夏病重,停激素则高热40℃以上,大渴引饮,自汗心悸,六脉沉滑数实。予人参白虎加苍术、四妙清化之:石膏100g,白藓皮50g,西洋参10g(另炖),苍术、黄柏各15g,苡仁45g,川牛膝、山药、双花、连翘、老鹳草、蚤休各30g,桃仁、红花、丹皮、紫草各15g,炮甲6g研粉冲服,炙草15g,10剂。外洗方:木鳖子(打)、白藓皮、苦参、大黄、芒硝、甘草各30g,桑、槐、柳嫩枝各1握,白矾、雄黄各15g(化入),煎汤一盆,趁热熏洗双脚,5剂。上法内服外洗,半月后双下肢脱壳一层而愈,停用激素后亦未复发(206页)。

按 疼痛多属痹证一类。由于营卫先虚,腠理不密,风寒湿诸邪侵袭,经络阻滞,痰瘀胶结,不通则痛。李可之经验,痹证分为寒痹、热痹。热痹多见于急性风湿关节痛,以苍术白虎汤化裁。

血痹麻木 宋某,女,26岁。产后9个月,忽觉四肢麻木,气怯神倦,腰困如折,劳累或气候突变则加重。近1个月来,麻木一旦发作,手脚便频频抽搐如鸡爪状。内科诊为缺钙性抽搐,补钙亦不能控制。视其面色萎黄欠华,脉细舌淡。断为产后血虚,肝失所养,故挛急,遂予加味黄芪五物汤:生芪45g,当归30g,白芍90g,桂枝、红参(另炖)、肾四味各10g,黑木耳30g,炙草10g,生姜10片,大枣10枚,胡桃肉20g,7剂。以下从略(122页)。

按 肢体麻木而不痛者,为血痹;若气虚痰湿入络者,笔者简称为“痰痹”。前者为尊荣肌丰,汗出

受风所致,以芪物当耳芥蛋汤;后者以入睡肢麻为特征,予还五桂枝芥虫汤。本案产后血虚,春末发病,提示与风邪有关,近于血痹,故以芪物当耳芥蛋汤化裁,7剂麻木痊愈。

脑血栓瘫痪 孙某,男,60岁。素有原发性高血压。20年前患脑血栓,随后右半身瘫痪。近入冬以来,眩晕加重,手指麻木,膝软,舌质略暗,舌白滑,脉涩无力。证属中风久延,大气不运,元阳难于敷布,痰湿瘀浊阻塞三焦,头面、印堂灰暗,殊非佳兆,为防突变,力挽颓势,拟小续命汤法衍变方:北芪250g,麻黄10g,制黑附片45-200g(逐日叠加10克),当归、桂枝各45g,辽细辛45g,川芎、干姜各90g,红参另炖、灵脂各30g,桃红各10g,僵蚕10g,地龙45g,生南星10g,生半夏45g,生姜45g,清全虫3g、大蜈蚣6条、小白花蛇1条研冲服,黑小豆30g,大枣25枚,黑木耳45g,白芥子炒研10g,加水6斤,文火煮2小时,去渣,再煎浓缩至500ml,入参汁,3次分服。以下从略。

李按 此方由《古今灵验》续命汤法衍变组成。该方之大意,以麻附辛法温少阴元阳,开玄府闭塞,托透伏匿三阴诸邪渐次出表,以生芪运大气助元阳之敷布,南星半夏白芥子消除十二经皮里膜外之痰,桂枝、桃红辈,流通血脉,诸虫入络搜剔,合麻黄宣通九窍,扶正达邪,面面俱到。

颈淋巴结核 杨某,女,34岁。右颈淋巴结核,隐痛不休,肢厥,寒热错杂,瘰病治痰:海藻、甘草、木鳖子各30g,全蝎3g,蜈蚣4条,玄参120g,柴胡125g,白芥子(炒研)10g,5剂。

按 患者证见寒热往来,肢厥

(即热深厥亦深)之少阳证,说明正气尚足,堪与邪交争。遂以攻癌基础方减半夏、牡蛎、大贝消痰软坚;因正气不虚,人参、大枣、炙草亦为禁忌,仅以柴胡 125g 一味,可代小柴胡汤。此乃李可处方之大手笔也。

麦粒脓肿 裴×,女,26岁。昨因办户口遇到麻烦,心中急躁,顿觉火气上攻,右目涩痛。入夜,下睑缘靠近目内眦处,生一麦粒肿,痒痛欲作脓,脉沉,口苦。遂拟清脾散加柴胡、白芷、皂刺为治:石膏 30g,防风、甘草、枳壳、柴胡、酒芩、栀子、升麻、薄荷、赤芍、陈皮、藿香、皂刺、白芷各 10g。上药煎成,趁热先熏患处,待温顿服。连进 2 剂,麦粒肿消散而愈(271 页)。

按 今病生于险,则根在脾。询之,平素多痰。痰之为物,随气升降,滞于肌肤则为痈肿,此为痰从热化之外证。脾与胃相表里,实则阳明,虚则太阴,今既化热,当从胃论治。选清脾饮加柴胡、白芷、皂刺、枳壳降气导热下行,防风薄荷祛风解表,赤芍活血,陈皮藿香化痰辟秽,升麻甘草白芷皂刺,引药直达病所,解毒消痈。

2 痰饮病方药

2.1 上部方药 眩晕多见于美尼尔氏综合症,脾虚痰饮上泛者,三饮四石汤;肾虚阴邪上冲者,奔豚吴萸四石汤(273、387 页);高血压眩晕,阳火不藏者,四逆汤;邪伏三阴者,麻黄附子细辛汤,详见《浊阴不降高心病》一文。昏迷多见于小儿流脑,羚麝止痉散、犀角地黄汤、调胃承气汤合方(77 页);脑出血昏迷者,大续命汤开窍汤,详见《中风危症不避麻》一文;尿毒症昏迷者,大附夏苓醒脾

汤加麝香(164 页);肝昏迷阴症者,茵陈四逆白通汤、吴茱萸汤合方;阳症者,犀地承气开窍汤(175、178 页)。痰厥阴证者,三生夏沉开窍饮,详见中风痰厥、肺心病心衰合并脑危象案(6、118 页);阳证者,礞石滚痰开窍丸(189)。癫证多见于抑郁症,我治抑郁症 100 多例,基本就是四逆汤,逐日加附子量,到一定程度,出一身臭汗,患者就有说有笑了。这个很奇怪,而且得病的大部分是大学生,家庭比较困难,环境压力比较大(119 页);痫证即癫痫症,破格救心汤(45 页);狂证即精神分裂症,涤痰清脑汤(191 页)。

2.2 下部方药 痿痹见于脊髓胶质瘤合并运动神经元病者,攻癌基础方合麻黄附子细辛汤加味(341 页);鹤膝多见于膝关节积液,黄芪五苓三妙散(251 页);骨疽多见于骨结核、骨髓炎,阳和汤合止痉散(306 页)。

2.3 内脏方药 肺系咳喘者,小青龙虚化汤;小儿急性肺炎正局者,麻杏石甘汤;变局者,小青龙加石膏汤;结核性胸腔积液者,瓜丹桂枝芩茎汤;肺间质纤维化者,肺间质汤,详见《重危急症小青龙》一文。胃呕见于胃肠痉挛者,止呕汤;妊娠呕吐者,人参止呕汤;脑膜刺激症喷射状呕吐者,双呕汤(45、107 页)。心悸多见于冠心病,破格瓜丹夏星汤(129 页)。

2.4 外络方药 疼痛多见于急性风湿热,苍术白虎汤合止痉散;类风湿性关节炎、坐骨神经痛者,乌头当黄稀鹳汤合止痉散;颈椎病患者,葛根双五止痉散(218、244 页)。麻木多见于血痹,芩物当耳芥蛋汤;痿痹者,还五桂枝芥虫汤(41、121 页)。瘫痪多见于脑血栓

后遗症,小续命汤、麻辛四五止痉散,详见《中风危症不避麻》一文。结核多见于淋巴结核、脂肪瘤,阳和汤合止痉散、消瘰丸(117、309 页)。痈疔见于急性结膜炎脓肿,银英犀军普济饮;疗毒走黄者,七味消毒饮(266、283 页)。

3 治疗痰饮病思路

3.1 痰饮概念 汉代张仲景在《金匱》中创立“痰饮”之名。分为痰饮、悬饮、溢饮、支饮 4 类。痰饮一词,狭义的讲是指 4 饮中的一饮,即饮聚肠胃的一种病证;广义的讲就是包括 4 种饮病的总称。在隋唐以前,痰与饮无明显的区别。直至宋代杨仁斋《直指方》乃将痰与饮分而为二。从此以后,一般专家多宗其说,认为痰多浓浊,饮则清稀。一为火燥,一为寒湿。清代《医学传心录》中,归纳了宋元明清关于痰的病因,明确提出“痰有十因”:或因风。或因寒、或因热、或因湿、或因暑、或因燥、或因酒积、或因食积、或因脾虚、或因肾虚。后世医家重痰轻饮理论已偏离了医圣的初衷,而走向歧路了。为此,李可揭示了痰饮之现代概念,即痰饮是整体失调导致之局部病理渗出物、赘生物(273 页)。

3.2 痰饮水湿,同源异流

3.2.1 痰与饮 汉代之“痰”与“饮”是不分的,而后世是重痰轻饮的。于是有人会问:仲景是否提及过浓痰?笔者注意到,仲景在《金匱》中多次提到“浊唾”:①肺痿:其人咳,口中反有浊唾、涎沫;②肺痈:时出浊唾腥臭,久久吐脓水如米粥者,桔梗汤主之;③肺胀:咳逆上气,时时吐浊,但坐不眠,皂荚丸主之。其中“浊唾”与“涎沫”,即后世之“浊唾”与“稀饮”。据李可

考证,伤寒之麻杏石甘汤剂量:麻黄4两(60g),杏仁50个(20g),生石膏半斤(125g),炙甘草2两(30g)。治小儿急性肺炎,只需半剂药,即可热退喘定痰清。既然急性肺炎都有这神奇的效果,那你说医圣什么样的浓痰没治过?古中医认为,痰与饮是浑然一体的,没有绝对的浊唾与涎沫,正盛则邪从热化为浊唾,正虚则邪从寒化为涎沫。仅此而已,不必在浓痰、稀饮上钻牛角。

3.2.2 痰饮与水气 仲景在《金匱》中把水气病分为风水、皮水、正水、石水。风水者,防已黄芪汤、越婢汤主之;皮水者,防已茯苓汤、越婢加术汤、甘草麻黄汤主之;正水与石水没给出方药。而痰饮篇分为痰饮、悬饮、溢饮、支饮4类,出示了18方。为什么水气病仅出5方?痰饮是水停留局部,水气则是水泛全身。二者在本质上同为水之为患,其方剂可以通用,如痰饮病之五苓散、泽泻汤,后世常用治水气病。由于痰饮篇在此书之前,水气病在其后,故略而不提。更有趣味的是,中医称美尼尔氏眩晕是“痰”冲于上,而西医之病理为内耳积“水”,即中医之“痰”就是西医之“水”。鹤膝风亦然。

3.2.3 痰饮与湿浊 中医湿分外湿、内湿。外湿包括潮气和雾露之气。内湿指人体内环境潮湿,多与脾胃有关,如轻者胸闷、呕恶、苔腻,重则腹胀、泄泻、水肿。这些内湿与狭义的痰饮(指饮聚肠胃)无异。痰饮是水停肠胃、胁下、四肢、胸膈,湿浊则是水停肠胃、四肢,它们可以并提、互用,如李可常用清化湿热之四妙散治痰证之鹤膝风、急性风湿热关节痛,便是明证。

总之,痰、饮、水、湿是一体的,其方可以互用、通用,这是解读李

可治痰饮方药的基础。

3.3 阴阳寒热分型,六经三焦论治

3.3.1 热痰、三阳、三焦辨治 热痰,以三阳证多见,甚则热壅三焦。下面举例证之:①太阳化热:“肺心病急性感染案”:患重感冒后无汗而喘,胸闷痰黄稠,五六日不大便,舌干红苔白腻,中根已黄。断为素有咳喘宿疾,感受太阳风寒,入里化热,遂拟小青龙合麻杏石甘汤化裁,共奏散寒解表,清热涤痰之效(18页);②热壅少阳:“小儿炸腮案”:患流行性腮腺炎2月,左耳下肿大如小儿拳头,掀赤肿痛,发热呕吐,体温39.5℃,手足时时抽动。证属炸腮重症,热毒壅聚少阳,已见热极动风之兆。遂拟普济消毒饮加蚤休、勾藤,清热消肿止痉(81页);③热结阳明:“小儿流脑案”:突然高热寒战,头痛呕吐昏厥,体温39.7℃,颈强抽搐,溲赤便结,大渴饮冷。证属瘟毒炽盛,气血两燔,热结阳明,引动肝风。予羚麝止痉散、犀角地黄汤、调胃承气汤合方化裁,清瘟解毒,荡涤邪热,开窍熄风(77页);④热壅三焦:“阑尾脓肿合并肠梗阻案”:频频呕吐秽臭粘涎夹杂粪便,阑尾部包块隆起约馒头大,外观红肿,痛不可近,扪之灼热,有波浪感。腹胀绞痛,已3日不大便、不排气。小便赤热刺痛,舌黑起刺、干涩。高热寒战,体温39.5℃,断为肠痛已成,热毒壅闭三焦,阳明腑实之关格大症。遂拟攻毒承气汤合硝菴通结汤(129页)。

3.3.2 寒痰、三阴、三焦辨治 寒痰,以三阴证多见,甚则寒凝三焦。下面举例证之:①三阴寒凝:“布氏杆菌病心衰案”:频咳暴喘,喉间痰鸣漉漉,呕吐涎沫,端坐呼吸,全身水肿,尿少,日夜约150ml。脉促,

频见雀啄,舌紫暗,满布紫黑瘀斑等。断为三阴寒凝,气化冰结。遂拟破格救心汤合瓜蒌薤白白酒汤、五苓散化裁,开胸涤痰,温阳利水(11页);②三焦冰结:“结核性腹膜炎合并胆囊炎案”:初病憎寒、发烧、无汗,上腹部绞痛呕吐。诊断为结核性腹膜炎、急性胆囊炎。经急性期对症疗法,1周后出现腹水,加服清热解毒利尿中药30剂,病反转重,出现喉间痰鸣,咳喘胀急,脐凸胸平,不能平卧,下肢烂肿如泥,尿少等。证属少阴虚寒为本,兼见太阳表寒实,渐传太阴(肺、脾)里虚寒证,表里同病,三焦气化冰结。遂拟麻黄附子细辛汤助阳解表,合真武汤、五苓散温阳泻浊,加油桂以蒸动下焦气化(59页)。

3.4 有形之痰与无形之痰辨治

中医把痰饮分为“有形之痰”与“无形之痰”。这种分类方法,在临床上比较实用。但“有形之痰”与“无形之痰”到底包括哪些内容,前人却没有成形的经验。笔者根据李可之痰饮概念、痰饮验案,进一步揭示了“有形之痰”与“无形之痰”的内涵外延。

3.4.1 有形之痰——肺胃病结肿

有形之痰,可归纳为肺(指肺系疾病离不开痰)、胃(指肠胃之呕吐、泄泻、便脓血)、痈(指外痈之痈疽疔疮,内痈之肠痈、肝痈、肺痈)、结(指结核、痰核之淋巴结肿大、脂肪瘤、结节病、各种疣)、肿(指良性肿物、恶性肿瘤)。有形之痰常用方:肺系疾病:小青龙虚化汤;小儿急性肺炎正局者,麻杏石甘汤;变局者,小青龙加石膏汤;结核性胸腔积液者,瓜丹桂枝芩茎汤;肺结核痰饮者,阳和小青芪萸汤;肺间质纤维化者,肺间质汤,详见《重危急症小青龙》一文。胃肠疾病:胃

呕见于胃肠痉挛者,止呕汤;妊娠呕吐者,人参止呕汤;脑膜刺激症喷射状呕吐者,双呕汤(45、107页);中毒性菌痢便脓血者,辟秽解毒汤(144页);溃疡性结肠炎泄泻便脓血者,三畏汤(179页)。外痈之痈疔者,七味消毒饮、银萸犀军普济饮;脱疽寒化者,乌头脱疽汤;热化者,黄芪四妙勇安汤(64页);骨疽之骨髓炎、骨结核者,阳和汤合止痉散;内痈之肠痈、肝痈、肺痈者,攻毒承气汤、清肠饮(129页)。结核之淋巴结肿大、脂肪瘤、各种疣者,控涎丹、消瘰丸、化铁丸(284页)。肿物之颈淋巴结肿大、乳腺增生、包块性腹膜炎、风湿结节者,攻癌基础方(117页);子宫肌瘤、卵巢囊肿者,妇科培元固本散(401页);恶性肿瘤者,攻癌夺命汤(335页)。

3.4.2 无形之痰——心脑血管

无形之痰,可归纳为心(指冠心病、高血压皆为痰浊窃踞阳位)、脑(指痰入于脑络之眩晕、昏迷、痰厥)、神(指神经系统疾病之血管性头痛、三叉神经痛、帕金森氏病等,神经系统疾病之癫、痫、狂)、经络(指疼痛、麻木、瘫痪、痿痹等)。无形之痰常用方:冠心病者,破格瓜丹夏星汤;高血压者,奔豚四石汤。美尼尔氏眩晕者,三饮四石汤,奔豚吴萸四石汤;高血压眩晕者,四逆汤;流脑昏迷者,羚麝止痉散、犀角地黄汤、调胃承气汤合方;脑出血昏迷者,大续虎承开窍汤;尿毒症昏迷者,大附夏苓醒脾汤加麝香;肝昏迷阴证者,茵陈四逆四通汤、吴茱萸汤合方;阳证者,犀地承气开窍汤;痰厥阴证者,三生夏沉开窍饮;阳证者,礞石滚痰开窍丸。神经系统疾病之血管性头痛,重订追风散;三叉神经痛者,引火芍甘止痉散(230页);帕金森氏病者,

真武当补止痉散加味;精神系统疾病之抑郁症者,四逆汤;癫痫者,破格救心汤;精神分裂症者,涤痰清脑汤。急性风湿热关节痛者,苍术白虎汤;类风湿性关节痛、坐骨神经痛者,乌头当萸稀鹳汤合止痉散;颈椎疼痛者,葛根双五止痉散;血痹麻木者,芪术当耳芥蛋汤;痿痹麻木者,还五桂枝芥虫汤;脑血栓瘫痪者,小续命汤、麻辛四五止痉散;脊髓胶质瘤合并痿痹者,攻癌基础方合麻黄附子细辛汤加味。

4 痰饮方药

李可治痰饮常用方38首,痰饮经验方30首。

4.1 痰饮常用方 痰饮常用经方:①热痰方:麻杏石甘汤(包括类方小青龙加石膏汤)、千金苇茎汤(隋唐以前验方属经方范畴)、大柴胡汤(详见耳源性脑炎案273页)、白虎汤、大承气汤(包括小承气、调胃承气汤)、大黄牡丹汤、小陷胸汤;②寒痰方:小青龙汤、麻黄附子细辛汤、小续命汤(包括《古今录验》大续命汤,是汉代以前的验方,理所当然属经方)、瓜蒌薤白白酒汤(包括瓜蒌薤白半夏汤、枳实薤白桂枝汤)、吴茱萸汤、理中汤、四逆汤、乌头汤、真武汤、大黄附子汤、薏苡附子酱汤(详见“胰腺癌创口流脓案”94页);③中性方:指热痰、寒痰均可用,如小半夏加茯苓汤、五苓散、泽泻汤、葶苈大枣泻肺汤、甘遂半夏汤(7页)、桂枝茯苓丸(401页)。

痰饮常用时方:①热痰方:礞石滚痰丸、普济消毒饮、四妙散、清肠饮;②寒痰方:阳和汤、三生饮、追风散、温氏奔豚汤;③中性方:控涎丹、透脓散、消瘰丸、化铁丸、止痉散、海藻甘草汤。

4.2 痰饮经验方 痰饮经验方:

①热痰方:苍术白虎汤:苍术15g,苡仁45g,黄柏30g,稀莩草50g,赤小豆、山药、知母、炙甘草各30g,生石膏250g,赤白芍各45g,下肢加川牛膝30g,追风散(分3次服)9g(244页);攻毒承气汤:银花90~240g,连翘30g,芙蓉叶30g,大黄10~45g,芒硝(分钟)15~40g,丹皮15g,冬瓜仁60g,桃仁15g,皂刺、炮甲各10g,槟榔30g,苡仁30~45g,甘草10g(128页);

辟秽解毒汤:银花60~90g,白头翁30g,香薷、藿香、佩兰、黄连、肉桂、牛子、甘草各10g,白芍30g,炒扁豆、节菖蒲各12g,酒大黄15~30g(144页);羚麝止痉散:羚羊角3g,麝香1g,蝎尾12只,蜈蚣2条(71页);犀地承气开窍汤:石膏250~500g,丹皮、紫草10~15g,蚤休15~30g,生地30g,赤芍15g,大黄(酒浸后下)、芒硝(分冲)、厚朴各15~30g,枳实15g,节菖蒲、郁金各10g,麝香(分冲)0.5g(177页);礞石滚痰开窍丸:礞石、大黄各30g,黄芩15g,沉香10g,节菖蒲、郁金各10g,竹沥(兑入)100ml,麝香(分冲)0.3g(189页);涤痰清脑汤:生石膏200g,丹皮、紫草各15g,大黄、芒硝(冲)、黄芩、黄柏、煅礞石、生铁落、夜交藤各30g,节菖蒲、郁金各15g,生地45g,黄连10g,天竺黄、胆南星、甘草各15g,竹沥(兑入)30ml,人工牛黄(冲)2g(191页);银萸犀军普济饮:板兰根、银花、连翘、公英、玄参各30g,石膏90g,丹皮、紫草各15g,酒芩、黄连、柴胡、升麻、桔梗、薄荷、马勃、僵蚕、牛子、陈皮、大黄(酒浸)、甘草各10g(267页);七味消毒饮:银花、公英、地丁、蚤休、夏枯草各30g,皂刺、白敛各

10g(285页);攻癌夺命汤(包括攻癌基础方):海藻、生甘草、木鳖子、醋鳖甲、蛇舌草、夏枯草、蚤休、海蛤壳、黄药子、生半夏、生姜、元参、牡蛎各30g,大贝15g,山茨菇、山豆根各10g,“全蝎12只,蜈蚣4条、雄黄1g”(研粉吞服)(334页);②寒痰方:小青龙虚化汤:麻黄(另煎)10~45g,制附片45~200g,辽细辛(蜜炙)45g,生晒参(另炖)15~30g,生半夏45~65g,干姜30~45g,五味子30~38g,炙紫苑、炙冬花各15~45g,壳白果(打)20g,炙草30~60g,桂枝、赤芍各45g,生姜65g(47页);瓜丹桂枝芩茎汤:瓜蒌30g,薤白15g,白酒100ml,桂枝、赤芍、炙草各15g,生半夏30g,丹参30g,檀降香、砂仁、木香各10g,芦根、苡仁各30g,冬瓜仁60g,桃杏仁各12g,生姜45g,大枣12枚(50页);阳和小青芪萸汤:生芪、熟地、山萸肉各30g,山药60g,红参(另炖)、灵脂各10g,麻黄根30g,白芥子(炒研)、鹿角胶(化入)10g,油桂(粉吞)3g,姜炭10g,生半夏、茯苓各30g,五味子、细辛、炙草各10g,生姜10片(309页);改良乌头汤(包括乌头脱疽汤、乌头当萸稀鹑汤):生芪120~240g,制附子30~90g,川乌30g,防风、黑小豆各30g,麻黄15g,赤芍15~45g,炙甘草60g,蜂蜜150ml(245页);破格救心汤:制附子30~100~200g,干姜60g,炙甘草60g,高丽参(另炖)10~30g,山萸肉60~120g,龙牡、磁石各30g,麝香(分冲)0.5g(6页);破格瓜丹夏星汤:制附子100g,干姜60g,炙草60g,高丽参(另炖)、灵脂各15g,山萸肉90g,龙牡、磁石各30g,桂枝、桃仁各15~30g,丹参60g,檀降、沉香、砂

仁各10g,生半夏45g,生南星30g,瓜蒌45g,薤白30g,白酒100ml,麝香(顿冲)0.3g,苏合香丸2丸(129页);奔豚干姜紫石汤:制附子30~100~200g,油桂、沉香、砂仁各10g,参(另炖),山药60g,茯苓45g,泽泻30g,干姜、怀牛膝、煅紫石英各30g,炙草60g(9页);附理砂半醒脾汤:炙草24g,干姜12g,制附片12g,高丽参(另炖)15g,白术12g,砂仁米10g,紫油桂10g,炒麦芽60g,藿香10g,佩兰10g,详见《重危急症小青龙》一文;大附夏苓醒脾汤:制附子30~100g,酒大黄15~30g,细辛15g,生半夏、茯苓各30g,猪苓、泽泻、红参(另炖)、灵脂、焦三仙各15g,肾四味80g,芒硝(分冲)15~20g,炙草10g,生姜30g,姜汁(兑入)10ml,大枣10枚(163页);重追迫风散:红参、灵脂、制首乌、炒白蒺藜、制川草乌、石膏、天麻、川芎、白芷、甘草各12g,细辛、芥穗、防风、羌活、辛夷、苍耳子、苍术、全蝎、蜈蚣、僵蚕、地龙、天南星、制白附子、雄黄(另研兑入)、乳香、没药各6g(243页);三生夏沉开窍饮:生南星30g,生半夏45g,生川乌、黑小豆、节菖蒲各30g,沉香10g,蜂蜜150g,竹沥(兑入)60ml,姜汁(兑入)10ml,麝香(分冲)0.5g(7页);麻辛四五止痉散(包括麻辛四逆汤、麻辛附桂理中汤、麻辛真武汤):北芪250g,麻黄10g,制黑附片45~200g(逐日叠加10克),当归、桂枝各45g,辽细辛45g,川芎、干姜各90g,红参另炖、灵脂各30g,桃红各10g,僵蚕10g,地龙45g,生南星10g,生半夏45g,生姜45g,清全虫3g、大蜈蚣6条、小白花蛇1条研冲服,黑小豆30g,大枣25枚,黑木耳

45g,白芥子炒研10g.详见《中风危证不避麻》一文;③中性方:三饮四石汤:泽泻90g,白术36g,红参(另炖)、吴茱萸各30g,炙草15g,生半夏、茯苓、煅紫石英、龙牡、磁石各30g,生姜30g,姜汁20ml,大枣20枚(387页);黄芪五苓三妙散:生芪45g,桂枝10g,白术、茯苓各30g,猪苓、泽泻各10g,生苡仁45g,苍术15g,川牛膝30g,白芷、炙草各10g(250页);止呕汤(包括双呕汤):生半夏、茯苓、赭石、生姜各30g,姜汁(兑入)10ml,炙草10g(45页);参灵甲珠散:红参、灵脂各10g,炮甲珠6g(175页);芪物当耳芥蛋汤:生芪120g,桂枝、白芍、当归、炙草、黑木耳各30g,蛋壳粉(分冲)3g,生姜10片,大枣10枚(121页);还五桂枝芥虫汤:生芪120g,当归30g,赤芍、桂枝各15~45g,川芎、桃仁、红花、地龙、白芥子(炒研)、炙草各10g,“全蝎12只,蜈蚣2~4条”(研粉分冲),生姜10片,大枣10枚(37页);麝甲无敌散:麝香2g,炮甲珠60g(65页);妇科培元固本散:红参、灵脂、三七、血琥珀、土元、水蛭、全蝎、蜈蚣、川贝、桂枝、茯苓、丹皮、桃仁各30g,夏枯草、海藻、甘草各500g(401页)。

5 痰饮小议

5.1 李可痰饮的现代概念包括哪些西医病? 通过上面的反复论述,我们再回过头来看李可痰饮的现代概念(痰饮是整体失调导致之局部病理渗出物、赘生物),就会发现,其内容是相当广泛的。它包括了狭义的痰饮,又涵盖了广义的痰饮;包括了有形之痰,又涵盖了无形之痰;包括了痰饮,又涵盖了水湿;包括了中医

之痰饮,又涵盖了西医之各种痰、积液、积水、脓疡、肿物、肿瘤。简而言之,凡见到西医这些病,皆可从痰饮辨证论治。

5.2 李可治痰饮为什么不用苓桂术甘汤、二陈汤? 我们看李可著作,会很奇怪地发现,李可治痰饮从不提苓桂术甘汤、二陈汤,令人费解。笔者揣测,苓桂术甘汤与小半夏加茯苓、五苓散相比,燥湿化痰、淡渗利湿都略逊一筹;至于二陈汤,方中制半夏无药效,与理气之陈皮相伍,收效甚微。而李可用生半夏一出手就是30~45克,治咳嗽则配干姜、细辛温肺化痰,治

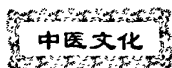
呕吐则配茯苓、赭石降逆止呕,常有一剂知,二剂已之功效。

5.3 《痰生百病虚为本》与《调燮三焦治水气》的关系? 痰饮与水气是一体的。如《调燮三焦治水》一文有13则医案,其中有9例也是痰饮案;水气病常用方19首,有13首亦是痰饮方;水气病经验方12首,有7首亦是痰饮方。从中可以看出,《调燮三焦治水气》与《痰生百病虚为本》是姊妹篇,前者偏重三焦,后者偏重六经。二者可以互补、通用,应当把它们当作一篇文章来读。

中医素有“痰生百病”、“百病

兼痰”、“怪病多痰”(神经系统、精神系统疾病多怪病)之说,尤其是“无形之痰”,更是有点“玄”。真可谓题目大、内容广、方药多,令人眼花缭乱,让人无从下手。笔者从痰饮的概念、部位(上下内外)、形态(有形无形)、分型(阴阳寒热)等方面,去整体地把握李可临床方药,再进而学习他六经、三焦辨证的精髓,试图摸索出一条“古中医”自身发展的道路。

(选自《李可老中医急危重症疑难病经验专辑》、《人体阳气与疾病》、《扶阳论坛》、《跟师李可抄方记·肿瘤篇》)



隐名中的中医

所谓隐名,就是利用双关、借代、析字、藏字等手法,将意思显示在言语之外,须经分析解释才能明白。中医、中药的隐名,实际上是一种秘密传递中医、中药信息的方法,其意思表达隐晦曲折。中药隐名,起源很早。唐代元和年间,西蜀有位叫梅彪的文人,撰《石药尔雅》“所集诸药隐名,以粟、黍、莽、麦、豆为五牙”(明·李如,《水南翰记》)。不知道梅彪集药,何以隐名?也许是保密,也许是故弄玄虚。而明清一些江湖医生将中药隐名,“不过是市语暗号,欺侮生人”(明人小说《生销剪》第九回)。但虽然如此,他们所作的隐名,也真是挖空心思,颇有文化气息。

有些中药隐名,大概是为防止病家对不雅药物随意联想而设,比如:金汁、人中白、人中黄、五灵脂、蚕沙、血余炭等。这些药物,或从人及动物的尿液、粪便中提取而得,或是毛发、指甲的制成品。这些药物若不用隐名,那病家知道药物的来源,恐怕就难以下口了。

有些药物隐名是为了提高疗效,而用隐名来防止病人“知情”。据说旧时天津有一位名叫陈方舟的医生,就曾经遇到过这样的一件事:

有位富商得了重病,陈方舟医生给他开了个药方,要他连服三剂以后再来复诊。商人服完三剂以后,觉得病症仍然没有好转,于是另请名医施今墨先生为他治病。施老先生诊脉以后,又看了看陈方舟医生开的药方,只见药方上写着:“人参、白术、茯苓、甘草”四味,于是告诉富商可以仍按此方连续服用。但是,富商连说不行,硬要施老另开处方。施今墨发现眼下无法说服富商,只好挥毫写下这样一张药方“鬼益、杨枪、松腴、国老”。商人如获珍宝般地走了。

富商按施今墨的嘱咐,连服了二十剂以后,病果然好了。于是,富商携厚礼向施老致谢,施老却要他去感谢陈方舟医生。富商不解,施老告诉富商,他所开的处方,实际上就是陈方舟医生开的处方,只是换了一个说法并增加较多的剂数而已。施老处方上的“鬼益”就是“人参”,“杨枪”就是“白术”,“松腴”就是“茯苓”,“国老”就是“甘草”。这四味就是有名的“四君子汤”,是用来补气的。商人一听恍然大悟。

施老的高明之处,就在于能够掌握患者的心理,通过变换药名,使他能够好好地配合医生的药物治疗。

李可攻癌2号方

——李可学术思想探讨之二十四

● 孙其新*

摘要 针对肿瘤之世界医学难题,进一步探讨了李可学术思想。李可后期治肿瘤思想:以阴阳为纲,寒热虚实分型;阳虚寒凝型,攻癌2号方;阴证化阳型,攻癌基础鳖蚤英;组方思路:中医证,西医病,找原点;处方公式:(基础方+主治方)+化痰攻瘤方。

关键词 肿瘤 寒热分型 攻癌2号方 攻癌基础鳖蚤英 李可 医案

对于李可治肿瘤经验,我早就想写两篇文章,上篇是总结其早期《李可经验专辑》的思路,题目为《养正消积治肿瘤》,全文1万5千字,已于《中医药通报》2010年第5期上发表;下篇是总结其近期治肿瘤的思路,题目为《温阳散寒攻癌症》(现改为《李可攻癌2号方》)。由于我手头近期肿瘤医案仅25例,资料太少,故迟迟不能动笔。自从今年5月份,看到了《跟师李可抄方记·肿瘤篇》后,就做了详尽的笔记,总结出“李可治肿瘤又增加了哪些药”,若再加上攻癌基础方,这实际上就是破译了李可“攻癌2号方”。

1 李可攻癌2号方

1.1 攻癌2号方解析

组成:炙甘草 60g,干姜 45g,生附子 30g,生半夏 65~120g,生南星 45~60g,生禹白附 30g,白芥子(炒研)15~30~45g,两头尖 45g,

木鳖子 30g,漂海藻 45~120g,“止痉散 6~3g,紫油桂(研粉冲)1.5~3g”,生晒参捣、五灵脂各 30g,川尖贝(粉冲)6~12g,麻黄 5g,辽细辛 45g,生姜 75g。

主治:阳虚寒凝型肿瘤。

方解:四逆汤、油桂回阳破阴,参灵散启脾进食,两本并重;麻黄附子细辛汤托透寒邪;生禹白附、两头尖、生南星、攻癌基础方(生半夏、生姜、白芥子、海藻、全蝎、蜈蚣、川贝、木鳖子)消痰化瘤。

1.2 关于重点药物分析

1.2.1 关于白芥子 我于今年4月,将《李可学术思想探讨》20期,锁定为《李可临证要旨》书稿,恳求李老指正。8月25日寄来修改意见及“李可批注”。其中一条关于白芥子,“李可批注”是这样说的:白芥子辛温,入肺胃经,非同小可,有大用,为消痰核主药之一,可去“皮里膜外、肋下、筋间凝聚之痰”,消散一切阴凝痰核,如阴疽漫肿、

皮下脂肪瘤、风湿结节、甲状腺瘤、淋巴结肿等。推而广之,一切癌肿无非气滞、寒凝、痰聚、血瘀,用之正所谓“层冰不解,化为阴疽,阳光一照,阴霾可散,寒凝立解”之效。用时注意当置砂锅内高温爆炒,边炒边搅动,炒至全数爆裂(切勿炒焦),然后研末入煎,方可发挥药效。入食芥末,或以芥末油调味,常有一股浓烈辛香辣味,立时窜鼻咽、双目、脑窍,令人涕泪交流,咳嗽出汗喷嚏连连,确有开宣肺气,祛寒温胃,窜通经络,通窍醒神,除顽麻,止朽痛之功。近10年来,我在攻癌夺命汤变方内加白芥子炒研15~30~45g,用于一切慢性癌肿有殊效。其方如下:炙甘草 60g,干姜 45g,生附子 30g,生半夏 65~120g,生南星 45~60g,生禹白附 30g,白芥子(炒研)15~30~45g,漂海藻 45~120g,止痉散 6~3条,紫油桂(研粉冲)1.5~3g,生晒参捣、五灵脂各 30g,川尖贝(粉冲)6~12g,麻黄 5g,辽细辛 45g,生姜 75g。加减法:①垂危病人:先用破格救心汤大剂救阳;②不能食者:先救胃气,大桂附理中汤;③肾不

* 作者简介 孙其新,男,主任医师。从事辨证论治的整理和经方的临床应用,著有《谦斋辨证论治学》、《李可临证要旨1》。E-mail: sqx6346@163.com。

• 作者单位 辽宁省岫岩县中心人民医院(114300)

纳气:动则气喘者,加高丽参(捣末吞)9~15g,砂仁米(姜汁炒)30g,肾四味各30g,核桃(打)6枚,山萸肉60g,三石各30g;④阴症化阳:肿物焮赤肿痛者,暂加木鳖子45g,公英45~120g,蚤休30g;⑤三阴冰结:剧痛者,加生川乌、黑小豆、防风各30g,蜂蜜150g。

笔者看完,为之一震。其主方共17味药,这是一首大道至简的肿瘤方子,正是我冥思苦想的攻癌2号方!

1.2.2 关于海藻、甘草 笔者从李可医案45例300首方子中发现用药两个问题:①海藻与甘草:“李可批注”这首方子,用的是炙甘草。而实际上医案中的生甘草居多,如《跟师李可抄方记·肿瘤篇》中,海藻配炙甘草者,18次;海藻配生甘草者,22次;②两头尖、木鳖子:在《跟师李可抄方记·肿瘤篇》中,生半夏出现37次,海藻出现40次,而两头尖出现31次,木鳖子出现32次。那么,什么时候用炙甘草或生甘草呢?笔者分析:①生甘草用量:50克者,13次;45克者,62次;60克者1次;100克者,1次;②主方为四逆汤、附桂理中汤时,一般甘草量大,多用炙甘草;③主方以扶正为主时,多用炙甘草;④主方以攻为主时,多用生甘草;⑤主方为麻黄附子细辛汤、阳和汤时,多用生甘草;⑥阴证转阳时,多用生甘草。鉴于李可在肿瘤处方中,频频使用两头尖、木鳖子(且攻癌夺命汤含木鳖子),笔者觉得应当在“李可批注”主方17味的基础上,再加上这两味药,即攻癌夺命汤与攻癌2号方均为19味。

1.2.3 关于半夏、生南星 2010年10月23日,李可在“第三届李可学术思想研讨会”上指出,近代医家金希聪先生发现生半夏、生南

星对药有八大相反功能:①主筋弛也筋张;②主疼痛与麻痹;③主失眠与多眠;④主腹泻与便秘;⑤主多尿与癃闭;⑥主肠紧与肠宽;⑦主贪食与厌食;⑧主多汗与无汗。一物有寒、温、升、降、燥、润、散、敛之功能,实造化之奇药,能治一百多种奇难怪症。生禹白附为天南星科独角莲之干燥块茎,未入本经。药性去风痰、定惊搐,解毒散结止痛。主治中风痰壅,口眼歪斜,语言蹇涩;痰厥头痛,偏正头风,喉痹咽痛,破伤风;外治瘰癧痰核,毒蛇咬伤。

2 辨证施治

近10年来李可治肿瘤注重辨证分型,归纳出:阳虚寒凝型,选攻癌2号方;阴证化阳型,选攻癌基础鳖蚤英。两方仅差两味药,即生禹白附、生南星。其中“攻癌基础鳖蚤英”中“攻癌基础”有两层含义:①温阳散寒为基础:因阳症是在阴证的基础上转化的,所以温阳破阴是根本;②攻癌基础方为基础:在攻癌基础方上加木鳖子、蚤休、公英。

3 验案举例

3.1 肺癌 范某,男,47岁,山西太原人。07年8月17日来灵石求诊:1个月前体检发现:右肺上叶占位性病变,大小为4.3cm×4.85cm,伴纵膈淋巴结肿大。咳嗽,食少腹胀,舌胖大,齿痕,脉沉弱。处方:麻黄5g,制附片45g,辽细辛(后下)45g,生半夏45g,白芥子(炒研)10g,油桂(后下)10g,高丽参(冲)15g,熟地30g,鹿角霜45g,姜炭30g,两头尖45g,漂海藻50g,炙草50g,止痉散6~3g,生南星30g,生姜45g。加水2500ml,文火煮取200ml,日分3次服。45

剂。二诊:已服药45剂后,咳减,食纳佳,腹胀消。处方:守方,止痉散改冲服,附子用量至90g,45剂。三诊告知。处方:守方,加生山萸肉90g,木鳖子30g,夏枯草120g,元参45g,高丽参15g(另炖),加水6000ml,人参汁,日分3次服。30剂。四诊:病情稳定,面有华色,食纳可,上脘胀,脉象和缓从容,唯胸痛时作。入冬,救太阴保少阴。处方①生附子30g,白术45g,干姜45g,高丽参30g(另炖),生半夏45g,生南星30g,茯苓45g,油桂15g(后下),炙草60g,瓜蒌45g,薤白30g,丹参120g,檀、降、沉香各10g,砂仁米30g,乌梅30g,山萸肉90g,三石各30g,生姜45g,黑小豆45g,加水2500ml,白酒300ml,浸泡40分钟,文火煮取300ml,人参汁,日分3次服。每旬7剂,服至立春。②固本散加守宫、川尖贝、露蜂房各100g,制粉,3g/次,日3次。08年2月2日五诊:平稳向愈。服药期间,前胸后背痛痒难忍,出许多红色斑疹,此为病邪出表,守方加减。去瓜蒌薤白白酒汤,改生附子45g,加漂海藻45g,两头尖45g,大贝20g,散剂加固本散。08年3月8日,六诊:服药87剂,已开始工作,六脉和缓从容。处方:生附子45g(破),白术90g,干姜90g,高丽参15g(冲),生半夏45g,生南星30g,茯苓45g,油桂10g(后),炙草90g,丹参120g,檀降、沉香各10g,砂仁米10g,生山萸肉90g,漂海藻60g,大贝120g,两头尖45g,生姜45g,煮法同前。每旬7剂,28剂。08年4月28日七诊:CT检查,肺部病灶比前缩小。处方:守方加止痉散3~3(冲服)。08年5月29日八诊:守方。服后咳嗽减轻,大便频,日4至7次,胸痛背痛时作。08年7月25

日九诊:稳步好转,伏邪有外透之机。处方①麻黄 10g,制附片 45g,辽细辛 45g,高丽参 15g(另),肾四味各 30g,生姜 45g,葱白 4 寸,每旬 3 剂,9 剂。②野丹参 120g,瓜蒌 45g,薤白 30g,檀降、沉砂各 10g(后 7 分下),生半夏 45g,生南星 30g,高丽参 15g(另),干姜 45g,炒苏子 30g,莱菔子 30g(生、炒各半),白芥子 10g(炒研),辽细辛 45g,生附子 45g,炙草 60g,竹沥 4 支,生姜 45g,每旬 7 剂,21 剂。服后,咳有痰,偶有粉红色痰,恶心欲呕。以下从略。

按 本案九诊,服麻附细汤、阳和汤加味,咳嗽减轻,胸痛背痛时作,大便频,日 4 至 7 次。证属伏邪有外透之机。故以四逆汤、麻附细汤扶正透邪;姜夏细、生南星化痰消积。

3.2 直肠癌案 樊某,男,71 岁,山西大同人。2003 年 10 月发现患高血压,房颤,胆结石,慢性淋巴细胞白血病。白细胞 4×32 万,淋巴细胞 0.85,体检发现双肾大小不一,脾脏偏大。2006 年 12 月发现患肛管高中分化癌,大小 $2\text{cm} \times 2\text{cm}$,肠息肉 2 个,大小 $1\text{cm} \times 1\text{cm}$ 。2006 年 12 月上旬来灵石求诊。因症见便血不止,舌尖红无苔。处方:赤石脂 30g,乌梅 30g,川椒 10g,黄连 10g,炮姜 30g,辽细辛 45g,黄柏炭 15g,红参(另炖)30g,五灵脂 30g,制附片 45g,炙草 30g,紫油桂(后下)10g,加水 3000ml,文火煮 2 小时。煎 2 次取浓汁 300ml,人参汁,日分 3 次服。每日 1 剂。5 剂血止,排出许多黑血块,乙木能升则血不下行。07 年 1 月 16 日二诊:守方中,乌梅增至 45g,加漂海藻 30g。07 年 3 月 31 日三诊:守方,制附片增至 90g,加当归 50g。07 年 8 月 11 日四诊:已服乌

梅丸变方 170 剂,便血已止月余。渐生薄白苔,眠食俱佳。近 3 月右下肢麻痛难以迈步,咳 1 月许,痰鸣漉漉。寒伏厥阴,渐现太阳表症、表脉,此为正气来复,寒邪由里出表,因势利导,托之。处方:生北芪 250g,麻黄 10g,制附片 90g,辽细辛(后 5 分下)45g,干姜(生、炮各半)70g,高丽参(冲)15g,川乌 30g,鲁豆 30g,防风 30g,生半夏 45g,生南星 30g,止痉散 3 ~ 6g(冲),漂海藻 45g,生姜 45g,蜂蜜 150ml,大枣 20 枚,黑木耳 45g,加水 6000ml,文火煮取 600ml,日分 3 次服。10 剂。服后,睡中汗出浸透厚褥,咳喘减轻。11 月 7 日经西医检查肿物大小为 $4 \times 4\text{cm}$,白细胞数由 4.32 万减至 3.2 万。12 月下旬,因疼痛难忍,去北京协和医院检查,白细胞降至 2.3 万。以下从略……08 年 5 月 18 日八诊:已服药 350 剂,脱象得退,六脉沉细而稳。肛肿出血,不断排出脱落瘤体,纯阴大症有转阳之佳兆。处方①炙甘草 60g,干姜 90g,制附片 150g,公英 120g,蚤休 30g,木鳖子 30g,生芪 60g,高丽参 30g,姜炭 10g,三仙炭 10g,赤石脂 45g,油桂(后)10g,生山萸肉 90g,每旬 7 剂,21 剂。②雄精 100g,白矾(研,后入)100g,苦参、木鳖子、甘草各 100g,乳香、没药各 50g,黄柏 100g,煮水,外洗坐浴。以下内容从略(48 页)

按 本案主证,下痢脓血。一诊以乌梅丸、赤石脂油桂止痢止血治其标;四诊以麻附细、四逆汤温阳透邪治其本;海藻甘草汤、生半夏、生南星涤痰化瘤;八诊阴证转阳,暂加木鳖子、蚤休、公英清热解毒。

3.3 肝癌案 韩某,男,15 岁,河南濮阳县人。治疗时间:从 07 年 3

月 14 日至 07 年 7 月 29 日。北京 301 医院诊为:肝内多发占位,肝癌。肝内胆管扩张,腹水,乙型肝炎,原发性肝癌,已无手术介入射频治疗指征。06 年 12 月发病,阳黄,纳差,厌油腻,腹胀甚。后多方求得李可为一濮阳肝癌晚期患者治疗处方,照方服药 14 剂,其家人言有好转,其方如下:麻黄 5g,附子 100g,辽细辛(后下)45g,吴茱萸 45g,晒参 30g,五灵脂 30g,漂海藻 45g,生甘草 45g,生牡蛎 30g,元参 90g,大贝 120g,生半夏 60g,清全蝎 12 只,大蜈蚣 12 条,云苓 45g,山萸肉 60g,紫油桂 10g,鲜生姜 75g,大枣 30 枚。07 年 3 月 14 日,初诊:一身及目皆黄,色鲜明,精神可,舌紫而润。肚大青筋,高出胸际,双胁青筋缕缕怒张,触诊三脘坚硬如石,肝区有振水音,问知食纳尚好。小便深黄,大便调,睡眠可。切脉弦细而急无根。07 年 3 月 28 日二诊:一身及目皆黄,色鲜明,精神可,腹胀略松,肝区振水音消失。舌淡红齿痕,舌尖赤,苔薄白。脉弦细较前略有力,重取甚弱,小便深黄,大便溏,日夜 5 ~ 6 次。处方:麻黄 5g,制附片 90g,白术 90g,干姜 90g,党参 90g,紫油桂 10g(后 15 分下),高丽参 30g(另炖),炙甘草 60g,漂海藻 45g,生甘草 45g,云苓 45g,五灵脂 30g,茵陈 45g,辽细辛(后 15 分下)45g,牡蛎 30g,元参 60g,大贝 90g,大蜈蚣 12 条,清全蝎 12 只,山萸肉 60g,生姜 75g,大枣 30 枚,加水 3000ml,文火煮 2 小时,取 500ml,人参汁,日分 3 次服。10 剂。07 年 4 月 13 日三诊:面黄色灰暗如蒙尘,白睛黄暗,神疲思卧,舌淡润。食纳差,二便调,肢冷如冰,脉微细按之如无,一线微阳戕伐殆尽!急以四逆法挽之,顾护先后二天,冀生于万一。

处方:制附子 100g(日加 10g 至 150g 为度),干姜 90g,炙甘草 120g,红参 30g(另炖),油桂 10g(后 10 分下),党参 90g,白术 90g,云苓 45g,生姜 45g,大枣 30 枚,加水 3000ml,文火煮 2 小时,取 500ml,人参汁,日分 3 次服。至 07 年 5 月 8 日,精神食欲日渐好转,近日白天已不思睡,整天同伙伴玩耍而不觉累。07 年 5 月 8 日,再做西医检查:肝功能有所恢复,仍腹水。嘱其来面诊,以调整处方,直到 5 月 18 日未知音讯。07 年 5 月 21 日四诊:一身及目皆黄,左白睛瘀血,精神食欲尚可,二便调,大便日 2~3 次。腹较前胀大,但较前变软,脐上二指以下变软,足跗浮肿,舌淡红润、齿痕,苔薄白根黄腻,脉细而急、重取无力,尺沉弱,脉搏 103 次/分钟。其 5 月 8 日检查肝功能谷丙转氨酶由 106 降至 96)。处方:麻黄 10g,制附片 150g(日加 10g 至 200g),白术 90g,干姜 90g,党参 90g,紫油桂 10g(后 15 分下),红参 30g(另炖),炙甘草 120g,漂海藻 45g,生甘草 45g,云苓 45g,五灵脂 30g,茵陈 90g,辽细辛 45g(后 15 分下),大蜈蚣 12 条,清全蝎 12 只,山萸肉 60g,猪苓 30g,泽泻 30g,桂枝 25g,生姜 75g,大枣 30 枚,日 1 剂。07 年 5 月 27 日其父电告:服药当日,小便多,2 日后脚肿胀消,服至今日,腹部略减,双胁有凹陷,大便日 2 次,不溏,食欲精神尚可,言面有瘦感,此水消之故也。07 年 7 月 5 日其父再电告:患者浑身黄色已退尽,形容已正常,腹水消尽,腹部变软,青筋消失,唯上腕略有硬胀,食欲大增,二便调。前半月左右曾做螺旋 CT 检查:肝部光滑。查肝功能降至接近正常值。07 年 7 月 29 日,患者面色红润,巩膜已无黄染,黄

疸退尽,已无病容,明显变胖,与前判若两人。腹水消失,腹部平软,与常人无异,且能骑自行车载奶奶去赶集(161 页)。

按 本案四诊,一身及目皆黄,腹水,足附浮肿。以附桂理中汤救两本,麻附细汤开表透邪;参灵散启脾进食,茵陈五苓散利水退黄;海藻甘草汤化痰消积。

3.4 胰腺癌案 石某,女,72 岁,山西人。07 年 9 月 14 日,初诊:肺心病 10 余年,近查出胰尾癌。上腹绞榨痛,便秘 1 周,全身暗黄 20 余日。属正虚邪盛,标本兼顾。处方:柴胡 125g,生半夏 75g,炒枳实 30g,大黄 45g(酒浸后 1 分),酒黄芩 45g,茵陈 90g,制附片 100g,炙甘草 60g,茯苓 45g,泽泻 30g,木鳖子 45g,高丽参 30g(另炖),生姜 75g,加水 3000ml,文火煮取 300ml,入参汁,6 次分服。1 剂。9 月 15 日二诊:便通,黄转鲜亮,防变。守方,加吴茱萸 30g,大枣 25 枚,1 剂。9 月 16 日三诊:守方。1 剂。9 月 17 日四诊:前投大柴胡 3 剂,便通,黄疸退去五六,属标实本虚,高年顾本为要。处方:制附片 100g,茵陈 90g,白术 90g,生苡仁 45g,败酱草 120g,漂海藻 50g,甘草 50g,止痉散 12~6g(入煎),生南星 30g,茯苓 45g,泽泻 30g,车前子 10g(包),生姜 45g,煮服法同前。1 剂。07 年 9 月 18 日,五诊:痛止,洩若浓茶,便色由白转黄。胀、喘,脉急。两本飘摇,扶正固下为急。处方:制附片 200g,茵陈 90g,白术 90g,生山萸肉 120g,生苡仁 45g,败酱草 120g,漂海藻 50g,高丽参 30g(另炖),五灵脂 30g,木鳖子 45g,生南星 30g,茯苓 45g,猪苓 30g,泽泻 30g,车前子 10g(包),油桂 10g(后下),生姜 45g,止痉散 12~6g(入煎),1 剂

(102 页)。

按 患者上腹痛,便秘一周,全身暗黄 20 余日,正虚邪盛。一诊以参附汤扶正;茵陈五苓散利湿退黄;大柴胡汤通腑泄热;二诊大便已通,黄疸退去五六,标实本虚,高年顾本为要。以茵陈术附汤温脾退黄;薏苡附子败酱散温阳散结,排脓消痛;海藻甘草汤、生南星攻痰化瘤。

3.5 宫颈癌 蒋某,女,67 岁,山西太原人。07 年 8 月 30 日,一诊:宫颈癌晚期,肺转移,胸肺水肿,并发急性肾衰。肿物增大压迫右肾及双侧输尿管,输尿管重度扩张,腹腔盆腔积液,重度贫血。无汗,食欲尚可,崩漏频发。无尿,住院血液透析已十多次。中医诊为:阳衰于下,玄府闭于上。处方:麻黄 45g(另),制附片 100g,辽细辛 45g,高丽参 30g(另炖),姜炭 90g,生山萸肉 120g,三石各 30g(煨),炙草 120g,桂枝 45g,白术 90g,茯苓 45g,猪苓 30g,泽泻 45g,油桂 30g(后 5 分下),生姜 45g,葱白 1 尺,麝香 0.3g(冲服),3 剂。文火煮 2 小时,日分 3 服。07 年 9 月 4 日,二诊:病人前来面诊。前方服 1 剂得汗,不畅,有小便意仍无小便,大便日 6 次,肿胀消,腹水减,咳痰带血,呕,勉强可进食,崩漏出血亦止。证属太阳未开,少阴无力蒸动。处方:麻黄 65g(另),制附片 200g,辽细辛 45g(后下),虫衣 70g,高丽参 30g(另炖),姜炭 90g,生山萸肉 120g,炙草 120g,白术 90g,茯苓 45g,猪苓 45g,泽泻 45g,油桂 30g(后 5 分下),生姜 120g,葱白 1 尺,麝香 1g(每次 0.3g,填入脐中),煮服法同前。3 剂。药后强灸神阙穴。07 年 9 月 11 日三诊:癌症晚期,急性肾衰,已透析 20 次,无尿。拟攻毒承气、通淋

法:大黄 18g(酒浸焙干),血琥珀、泽泻、海金沙各 10g,大蜈蚣 24 条,制粉,分 5 包,早 5 时服 1 包,蛋清 2 枚调糊,热黄酒调服。07 年 9 月 23 日四诊:前方服后仍无尿,此症并非热壅三焦之淋症,当破冰解凝,拟温下法:大黄(酒浸一刻)、制附片、辽细辛(后 5 分下)各 90g,油桂(后 5 分下)45g,生姜 120g,加水 2000ml,文火煮取 30ml,3 次分服,3 小时 1 次。07 年 11 月 25 日五诊:患者家属又来电话求诊,余深思许久,处升陷汤加高丽参 30g,麝香 1g,升麻、柴胡各 10g。07 年 10 月 4 日,六诊宫颈癌晚期,肝肺转移,并发急性肾衰、心衰。处方:①桂枝、茯苓各 45g,桃仁、丹皮各 30g,赤芍 45g,大黄(酒浸一刻)45g,土元 30g,制附片 200g,辽细辛(后 5 分下)45g,高丽参(另炖)30g,红花 45g,川牛膝 45g,乳香 10g,元明粉(冲化)21g。加水 3000ml,文火煮取 300ml,入参汁、冲化元明粉,3 次分服。3 剂。②漂海藻、甘草各 50g,止痉散(煎

12~3g,木鳖子 45g,元参 120g,牡蛎 45g,大贝 120g,两头尖 45g,高丽参(另炖)15g,制附片 200g,麻黄 10g,辽细辛(后 5 分)45g,炮甲珠(打)12g,油桂(后 5 分下)10g,加水 3000ml,文火煮取 300ml,入参汁,3 次分服,待食欲大增,止痉散冲服。10 剂。两方交替服用。08 年春节,患者家属给来电诉,一直边透析边服用中药,症情平稳,前两天在透析中血压忽然下降,抢救无效病故(21 页)。

按 本案六诊,服破格救心汤、麻附细汤后,一剂得汗,但不畅,有小便意仍无小便。证属太阳未开,少阴无力蒸动。以麻附细汤开表透邪,桂枝茯苓丸为消妇科癥瘕积聚效方:大黄附子汤温下;通淋散开下窍;攻癌基础方、两头尖、炮甲珠消痰化瘤。

从上诸案可以看出,李可治肿瘤基础方为四逆汤、附桂理中汤、麻黄附子细辛汤等。在基础方基础上根据疾病的部位加入针对性治疗,如:脑瘤之川芎茶调散;肺癌

之小青龙汤、阳和汤、千金苇茎汤、瓜蒌薤白丹参饮;食道癌之开道散、止呕汤;胃癌之参灵散、三畏汤、双呕汤;肠癌之赤油散(赤石脂、油桂)、薏苡附子败酱散、乌梅丸;肝癌之茵陈五苓散、茵陈术附汤、乌梅丸;胰腺癌之大柴胡汤、茵陈五苓散、薏苡附子败酱散;宫颈癌之桂枝茯苓丸、癥闭散、通淋散等。所以,李可治疗肿瘤处方经验用公式可表示为:(中医证+找原点)+西医病。把李可治肿瘤的内容代入公式,可得出以下结果:(中医证+找原点)+西医病=(整体失调+原点失调)+局部肿瘤=(阳虚寒凝+该系统失调)+痰瘀癥积=(温阳散寒方+该系统方)+攻坚化痰方=(基本方+主治方)+攻癌基础方。

(选自《李可老中医急危重症疑难病经验专辑》、《人体阳气与疾病》、《扶阳论坛 2》、《跟师李可抄方记·肿瘤篇》)

(上接第 9 页)

证”,“热入血室”证,“结胸”证,“脏结”证的四病病位,笔者对此谨抒自见,以“蓄血证”蓄于肠道与冲脉,以“热入血室”为热在血分,以“结胸”证为邪结胸膈胃肠,以“脏

结”证为邪结在肝。仅供学者研究时参考。略抒己见,不一定正确,仅为抛砖引玉尔。

参考文献

- [1] 李培生,刘渡舟等. 伤寒论讲义(第一版)[M]. 上海:上海科学技术出版社,1985.(注:本文所引条文序号均据此。)

攻癌夺命汤是我在 50 年代后期至 60 年代中期所创，由漂海藻、生甘草、木鳖子、醋鳖甲、蛇舌草、夏枯草、蚤休、海蛤壳、黄药子、生半夏、鲜生姜、元参、牡蛎各 30 克，大贝 15 克，山茨菇、山豆根各 10 克，“全虫 12 只，蜈蚣 4 条，明雄黄 1 克”(研粉吞服)，19 味药组成。

本方脱胎于兰州已故名医董静庵先生之验方“海藻甘草汤”，原方主治疗疔，由海藻、甘草各 10.5 克，全虫 12 只、蜈蚣 1 条组成，水煎服。我师董老意，加量 3 倍，虫类药研粉吞服，以加强药效。另加鳖甲、消瘰丸(元参、牡蛎、大贝)、夏枯草、生半夏、鲜生姜，大大加强了养阴化痰，攻坚散结之力。曾治愈甲状腺腺瘤 24 例，甲状腺瘤左锁骨上凹淋巴结肿大疑恶变 5 例，缺碘性甲状腺肿 12 例，颈淋巴结结核 4 例，泛发性脂肪瘤 5 例，脑瘤术后复发 1 例。多数在半月内痊愈，无复发。1961 年后加木鳖子、蛇舌草、蚤休、黄药子、山豆根、明雄黄，基本定型。经临床运用 40 年，用治多种恶性肿瘤，竟获奇效。兹选录验案数则如下：

1. 恶性淋巴瘤

景月华，女，65 岁。灵石检察院赵嫦娥母，1977 年 8 月 15 日初诊：颈左侧肿物 40 天，初起如黄豆大，未及 1 个月，猛长如初生婴儿头大，并向下蔓延至左锁骨上窝，凹凸如岩，坚硬不移；颈右侧及颊车穴下方肿块 6 个，大如杏核，连成一串，坚硬不移；双腋下，双腹股沟淋巴结皆肿大如枣，推之不移。随肿块之逐日增大，上则头痛如破，气喘痰壅，胸部憋胀，面色灰滞，神识昏糊。下则二便闭结，溲若浓茶。口臭熏人，苔黄厚腻，中根黑燥，六脉沉滑数实。(后经山西肿瘤医院病检，确诊为“左颈部弥漫型恶性淋巴瘤混合细胞型”，病理号 3054)辨证属痰毒弥漫三焦，毒入血分，阻塞气机，蒙蔽神明重症。拟攻癌解毒，涤痰通腑，软坚散结为治，以攻癌夺命汤合礞石滚痰丸扫荡血毒：

漂海藻、生甘草、煅礞石、木鳖子、生半夏、鲜生姜、莱菔子(生炒各半)、黄药子、鳖甲、生牡蛎、浮海石、海蛤壳、元参、蚤休各 30 克，大黄、大贝、桃杏仁各 15 克，山茨菇、山豆根、红花各 10 克，“全虫 12 只、蜈蚣 4 条、明雄黄 1.2 克”(研末冲服)。

以蛇舌草、夏枯草各 120 克，煎汤代水煎药，煎取浓汁 600 毫升，日分 3 次服，7 剂。

8 月 23 日二诊：患者服首次药后约 1 刻钟，突觉满腹上下翻腾，五脏如焚，欲吐不得，欲泻不能，烦躁欲死，旋即昏厥。我急赴病家，患者已醒。诉刚才出一身臭粘汗，吐出胶粘痰涎半痰盂，胸膈顿觉宽敞，唯觉困乏而已。诊脉和匀，此乃药病相争，正胜邪却之佳兆。《内经》有“药不瞑眩，厥疾弗瘳”之记载。一旦出现瞑眩现象，必有非常之效。嘱原方续服。服 2~7 剂时，每日畅泻污泥状夹有脓血、胶粘痰涎，奇臭极热之大便 1~2 次，尿已转清，胸憋气喘已愈七八，头已不痛，神识清朗，食纳大增，全身肿块变软。嘱原方加嫩胡桃枝之扶正化瘤，续服 7 剂。待大便中无秽物后 2 日，去大黄。

9 月 1 日三诊：服药 14 剂，左颈部肿物缩小 1/2 强，右颈及颊车穴下之肿物消至黄豆大，精神健旺，面色红润，稍觉气怯。原方去礞石滚痰丸，加野党参 30 克，灵脂 15 克，10 剂。

9 月 13 日四诊：左颈部肿物已消至鸡蛋大，其余已消尽。原方 10 剂。

11 月 1 日五诊：患者带药回村，至 9 月 22 日，肿物消散如胡桃大，27 日全消。计经治 2 个月，服药 34 剂，临床缓解。唯觉干渴气怯，舌红无苔，脉沉滑。为疏丸方，峻补元气，养阴化痰，拔除病根。

全河车 2 具，白参、灵脂、元参、天冬、山茨菇、川贝、牡蛎、海蛤粉、漂海藻、昆布、黄精各 30 克，大蜈蚣 50 条，全虫 120 只。

共研细粉，夏枯草 1500 克熬膏，加炼蜜为丸 10 克重，早晚各服 1 丸，生甘草 10 克，煎汤送下。[9

俟后，其义子来告，丸方未服，病已康复。至 1981 年春，遇其女于街头，询之，体健逾于往年。因生活困难，丸方终未服用。计已临床缓解 3 年半。

2. 甲状腺癌颈转移

王淑臣，女，60 岁，两渡矿张斌科长妻，1978 年 6 月 26 日初诊：患者高大胖体型，体重 80 公斤。颈部肿块 29 年。甲状软骨上方肿块杏子大，下方肿块约乒乓球大，均质硬，右颈部鹅蛋大肿块，凹凸不平。同年 3 月 28 日，省肿瘤医院超声探查诊断：“甲状腺癌颈转移”，次日同位素扫描(565 号)支持上述诊断。

追询病史，知患者从 8 岁起，即抽旱烟，现吸烟量日平均 2 盒，患支气管炎 30 年。近 3 年暴喘迫促，

两臂上举则气闭晕厥。上厕所走 10 多步，即暴喘 10 多分钟。痰声如拽锯，稠粘难出。目赤，胸、胃烧灼难耐。日食冰棍 1 桶，水果罐头无数，始觉爽快。脉沉滑搏坚。放疗后耳聋不闻雷声。个性暴躁，多疑善怒。近 2 个月有血性涕，剧烈右偏头痛。胸背四肢泛发脂肪瘤，大者如栗子，小者如蚕豆。

据以上脉证，良由吸烟过度，熏灼肺腑，个性暴躁，气滞于中。痰气交阻，日久化火化毒，结于喉间要道。近来，虽见种种上热见证，但双膝独冷。盖由高年肾阴大亏，阴不抱阳，龙雷之火上燔。且喘汗频作，须防暴脱。

先予引火汤，滋阴敛阳，引火归原：

方 1：九地 90 克，盐巴戟肉、二冬各 30 克，云苓 15 克，五味子 6 克，上油桂 2 克(去粗皮研粉小米蒸烂为丸先吞)，3 剂，此后，凡见上热无制，即服 3 剂。

方 2：漂海藻、昆布、生半夏、鲜生姜、元参、花粉、海蛤壳、牡蛎、黄药子、木鳖子、蛇舌草、夏枯草、生苡仁、蚤休各 30 克，大贝、麦冬、桃杏仁各 15 克，白参(另炖)、五味子、山茨菇、山豆根各 10 克，竹沥 2 匙，“全虫 12 只，蜈蚣 4 条，上沉香 1.5 克，明雄黄 1.2 克”(研粉吞服)

上方，头 3 个月每旬服 7 剂，无大加减，至 9 月底，两方共服 70 剂，全身脂肪瘤消失，右颈转移灶缩小 2/3，甲状软骨上下之肿物亦明显缩小。血性涕消失，痰声漉漉偶见。动则暴喘之状，可减三四。服至 1979 年 6 月，因天渐热，停药 3 个月，共服百剂。喘息已很轻微，可到邻家串门。右颈转移灶缩小至杏核大。至 1980 年 3 月，所有肿物全部消失。计经治 18 个月，服药 300 剂，其中引火汤约占 1/4。现仍健在，已 80 高龄。

3. 胃小弯癌

1982 年夏我赴甘肃西峰市接受平反，于庆阳地委司机李荣家遇其内弟陈春发，60 岁，西安市大雁塔区农民。

经西安医学院二院病检，确诊为胃小弯癌(4×4cm)，已办住院。自知年迈患癌，生死难卜，故术前专程来峰，与胞姐见最后一面，顺便请我诊治。询知食人即吐，痰涎如涌。便燥，三五日一行，干结如羊粪球，落地有声。面色灰滞，消瘦，病未及 3 个月，体重下降 15 公斤。然神识清朗，同桌进餐，食欲颇佳。声若洪钟，喜笑言谈，颇饶风趣。我接触癌症病人可谓多矣，似此类性格者，却百不见一。胸怀豁达，便易措手。诊脉弦滑，舌红，中有黄厚腻苔。边尖有瘀斑。询知一生嗜食肥甘，嗜酒如命。此必湿热酿痰，阻塞气机，日久化毒，积为有形症积。所幸正气未衰，可以用攻。毕竟高龄，佐以扶正：

赭石末 50 克，漂海藻、生甘草、元参、牡蛎、醋鳖甲、木鳖子、黄药子、生半夏、鲜生姜、蛇舌草、夏枯草、莱菔子各 30 克(生炒各半)，旋覆花(包)、醋柴胡、山茨菇各 15 克，红参(另炖)、灵脂各 10 克，“全虫 12 只、蜈蚣 4 条，紫硃砂 3 克，明雄黄 0.3 克”(研末冲服)，煎取浓汁 400 毫升，对入蜂蜜 100 克、姜汁 10 毫升煎 3 沸，日分 2 次服，30 剂。

另，隔日冲服儿茶 2 克。

上方服至 5 剂后，大便通畅，进食不吐，已与平日无异。自备槐耳，每日煎汤代茶。不久，我赴兰州，辗转返晋，失去联系。1984 年 1 月 7 日，李荣患肝癌，来灵找我诊治。询其内弟病情，据云在峰服完汤剂，调养月余，在地区医院镜检，瘤体消失，食纳如常，体重恢复，已返陕照常参加农事劳作。

4. 脊髓神经胶质瘤

温××，女，19 岁，山西财院学生。2000 年 6 月 3 日，北京天坛医院作下颈上胸 MRI 检查，见“C5—13 水平脊髓占位病变，N 胶质瘤(MRI8819#)”专家会诊认为，手术风险大，难根治，易复发，费用高，建议转中医诊治。

询知颈项强痛，脊柱向右侧弯，转侧困难，斜颈，已 6 年。左肩背沉困重痛，四肢无力，左下肢肌萎缩，双下肢进行性麻木，近半年已不知痛痒。左腿环跳穴及足跟部电击样阵痛，一日数发，步态蹒跚、倾侧，已休学 2 个月。

面色皓白无华，气怯神倦，头目昏眩，瑟缩畏寒，六脉沉迟细涩，舌淡胖有齿痕。

考病在脊椎，属督脉为病。督乃诸阳之会，非寒邪不能干犯。患者禀赋素虚，嗜食生冷，卧室靠窗，夜卧当风，夏日入睡，不关电扇。脾失健运，正气先虚，痰湿内生，经期不避生冷，瘀血内阻，寒伤督脉，真阳失运，日久湿痰死血，阻塞经脉，成为有形症积。且每逢经期，诸症加剧。可证寒邪已由表入里，由

督入任，深入血分。腰困如折，肾气已伤，奇经八脉所辖区域俱见病象，且属沉寒痼冷顽症。

本病已非攻癌夺命汤适应症，当作变通，留基础方，去一切苦寒解毒之品。重用生芪补大气，益气运血，温通督脉；以麻附细汤深入少阴，透发伏寒，兼开太阳之表，引邪外透；重用葛根之专理颈项，通督达脊；更加活血化瘀，虫类搜剔，化痰软坚，消磨化积之品，攻补兼施：

1. 生芪 240 克，葛根 90 克，麻黄 15 克(先煎去沫)，附子 30 克，细辛 20 克，漂海藻、生甘草、生半夏、云苓各 30 克，白芍、川芎各 30 克，白芥子(炒研)、桃仁、红花、僵蚕、地龙、两头尖、子蜂房、天南星、高丽参(另炖)、灵脂各 10 克，鲜生姜 30 克，大枣 12 枚。

加冷水 1500 毫升，文火煮取 450 毫升，3 次分服，5 剂。

2. 全虫尾 15 克，大蜈蚣 20 条，川贝、土元、炮甲珠各 30 克，麝香 2 克，共研细粉，分作 15 包，1 包 / 次，3 次 / 日，随中药服。

3. 夏枯草 1500 克，依法熬膏，10 毫升 / 次，3 次 / 日。

至 7 月 10 日，药进 5 剂，每服皆得畅汗，伏邪外透，颈项肩背沉困感遂去大半，脉转沉滑，舌尖微赤，阴症有转阳之机，大是佳兆。

上方去麻黄，加大贝、元参、牡蛎、鹿角霜、丹参各 30 克，余药不变，连服 40 剂。

至 8 月 22 日，服药 47 剂，诸证已去十之七八，下肢感觉渐复。山医一院神经外科 MRI 复查：“C6-T4 脊髓占位病变与原片比较，未见明显变化。”病情基本得到控制。

拟扶正消瘤，丸方缓图：

花旗参、高丽参、五灵脂、大三七、三棱、莪术、葛根、炮甲珠、子蜂房、两头尖、花蕊石、全虫尾各 60 克，大蜈蚣 100 条，土元 60 克，牡蛎粉、元参、真川贝各 150 克，蛇舌草、杭白芍各 100 克。

上药共研细粉，以夏枯草 1500 克，熬膏，加炼蜜为丸重 15 克。每次 1 丸，3 次 / 日。

汤剂去细辛、赤芍加通补肾督药巴戟、补骨脂各 30 克，狗脊 15 克。

每旬服 7 剂。

至 10 月 6 日，又服 30 剂，症状消失，食纳精神，胜于病前，带药恢复学业。

汤剂加化铁丸(楮实子 30 克，威灵仙 10 克)川断 15 克，枸杞子、菟丝子、仙灵脾各 20 克，温养肝肾，攻坚化积，每旬服 3 剂。

10 月 30 日随访，山医一院神经外科 MRI 与 8 月 22 日原片比较，专家会诊认为有三点不同：

1. 原病灶周围有模糊阴影，此次已消失，边界清楚，结合临床症状消失，推测脊髓腔内之瘤体，已逐渐消溶，神经压迫症状解除；

2. 原脊柱向右侧弯，此次已恢复正常，斜颈已愈；

3. 查体，患肢肌萎缩已恢复如初。

2001 年 1 月 17 日随访，平稳向愈，6 年来痛经痼疾亦愈。面色红润，精神饱满，考试成绩优秀。中药服完，改服培元固本散变方，以血肉有情之品，峻补先天，重建免疫屏障，加柚柑虫节 100 克，以彻底破坏异常细胞核，防止复发。

大三七、鳖甲胶、琥珀、川贝、粉葛根、夏枯草膏、虫节、高丽参、灵脂各 100 克，赤芝孢子粉、炮甲珠、子蜂房、土元、守宫、血竭、藏红花、全虫尾各 50 克，大蜈蚣 100 条，全河车 2 具，坎气 60 克。

共研细粉，装胶囊，每服 6 粒，2 次 / 日。

按：本病临床罕见，机理不明。解剖所见，瘤体如蛛丝、棉絮，填充于脊髓腔内，胶着、裹缠于神经周围，手术不易剥离净尽，故易复发。手术过程如损伤脊髓神经，轻则截瘫，重则致死，风险较大。术后复发率高，生存期短暂。且费用高昂，非一般人群所能承受。从中医经典理论辨析，本病当属奇经八脉病变。缘由正气先虚，痰湿内生，寒伤督脉，真阳失运。日久，浊阴僭居阳位，湿痰死血，深伏督脉要冲，而成有形症积。本病因虚成实，治当养正消积，扶正温阳为先，遵伤寒、金匱之理，邪之来路，即邪之去路，故立方以麻黄附子细辛汤深入少阴之里，透发伏寒，兼开太阳之表，开门逐盗，引邪外透。患者正虚为本，故破格重用生芪之人督脉，补大气，益气运血，温通督脉，高丽参、五灵脂对药，补元气，消血积。主证“项背强痛”，故重用葛根之专理颈项，通督达脊。胶质瘤属痰瘀胶结，故以海藻、甘草一对反药，相反相成，激荡磨积，清除痰毒。更加生半夏、天南星、白芥子燥化皮里膜外之痰，久病入络，以大队虫类

搜剔，诸血药化瘀通络，更以炮甲珠、麝香之穿透攻破，无所不到，辟秽开窍，引达病所。

计先后八诊，历时7个月，服汤剂107剂，扶正化瘤丸1料。至第4个月，临床症状解除，恢复学业。后以培元固本散变方补消兼施，扶正化积。现仍在继续治疗观察中。

余治肿瘤40余年，深感中医经典理论生命力之强大，内难伤寒之病理、病机，仲景先师之理法方药，后世叶天士学派完备的奇经八脉理论，正是攻克世界罕见疾病谱的犀利武器。

按：从上举例，可见攻癌夺命汤之多种变方，对辨证属于痰核、痰毒，痰瘀互结，热毒炽盛，毒入血分，全身中毒症状严重之多种恶性肿瘤，稍加化裁，即可泛应曲当，收到满意的近期疗效，尤对头颈部、淋巴系统、消化道癌肿有殊效。

方中海藻，为消瘤专药，用时清水漂洗去盐。味咸性寒，入肺脾肾经。归纳各家本草论述，本品咸能软坚化痰，寒能泻热消水(包括癌性渗出物，癌性腹水)，主治癭瘤，瘰疬，积聚，水肿。与甘草同用，相反相激，增强激荡磨积、攻坚化瘤之力。木鳖子，苦微寒，有毒，为消积块破肿毒要药。历代多作外用，内服仅见于乳痈初起，掀赤肿痛。笔者老母之食道癌，3年服药千余剂，每剂用量30克，未见中毒。方中之生半夏，为消痰核、化瘤散结要药，可止各种剧烈呕吐。仲景方中半夏皆生用，今以等量之鲜生姜制其毒，加强止呕功效，更无中毒之虞。方中之蛇舌草、蚤休为治毒蛇咬伤要药，专治恶毒疮，善解血分诸毒，山茨菇、山豆根、黄药子皆近代筛选之抗癌要药。

海蛤壳、浮海石性相近，最善化痰软坚，清热泻火，养阴利水，为治癭瘤、积聚要药。夏枯草，苦辛寒，入肝胆经，清肝散结，主瘰疬，癭瘤，症积，乳癌，宫颈癌之崩漏下血，肺结核大咯血，兼有补益血脉功用。方中鳖甲为《金匱》鳖甲煎丸主药，是历代用治症瘕痞块要药，与消瘰丸相合，大大增强了养阴化痰、软坚破积之力。方中之明雄黄，可杀灭多种病毒、细菌，为历代辟秽防疫解毒要药，传染病大流行期，以苍术、雄黄等分为末，凡士林膏调涂鼻腔，可有效防止传染，为古方犀黄丸、醒消丸要药，对癌毒扩散深入血分、血液中毒，有清除之效。

综上所述，本方以海藻、甘草相反相激，木鳖子、生半夏、雄黄以毒攻毒，合大队攻癌破坚，清热解毒，化痰散结之品为君，以鳖甲、消瘰丸养阴扶正为臣，以活血化痰虫类搜剔引入血络为佐使，直捣病巢，力专效宏。用治多种恶性肿瘤，有一举扫灭癌毒凶焰、夺回患者生命之效。全身中毒症状严重者，加大黄30克，扫荡血毒。胃癌之呕吐，多兼见大便燥结，此为痰毒结于中下，阻塞胃气通降道路，本方加赭石之质重下行，莱菔子之升降气机(凡用莱菔子生炒各半，生升熟降，服后多见上则频频打嗝，下则腹中雷鸣，频转矢气，此即气机旋转、激荡之明证，故古人谓其去痰有推墙倒壁之功。)开结通便，便通则胃气下行，呕吐自止。胃及食道癌，常用紫硃砂，腐蚀瘤体，号称肿瘤克星，用量宜小。为防其使瘤体破裂出血，可加服儿茶1.5克~3克，生肌，敛疮，止血，则更安全。例三患者，病后曾长期以槐耳代茶饮。据云，解放前陕西某地一位民间老中医传：“槐耳可消一切肿块，治噎膈，五色带，崩漏，痔血。”所列症状，似与食道、胃、子宫、直肠等癌肿有关。查《纲目》槐耳条下载：“又名槐菌，槐蛾。苦，辛平，无毒。桑、槐、楮、榆、柳五木耳，大率性味相近。主治五痔，脱肛，崩中下血，痼瘕结聚，男子瘕癖……利五脏，宣肠胃气，排毒气。”似有扶正抗癌作用。

晚期病人，大多邪实正虚，运用本方，当调整攻补比例：癌毒炽盛，危及生命，攻邪为先；奄奄一息，无实可攻，但扶其正。攻与补皆为调动人体自身抗癌潜能，攻法运用得当，可以扫荡癌毒凶焰，拨乱反正，邪去则正安。补法运用得当，可以增强人体免疫力，养正积自消。攻邪勿伤正，本方大队苦寒之品，脾胃怯弱者，可小其剂，并以上肉桂温热灵动之品反佐之，以保护脾胃为第一要义。有胃气则生，胃气一伤，百药难施。久病伤肾，加肾四味鼓舞肾气，立见转机。肾为先天之本，生命之根，万病不治，求之于肾。邪与正，一胜则一负。治癌是持久战，正胜邪却，暂时的缓解，瘤体的消失，不等于癌毒的彻底消灭。一旦人体正气有亏，癌毒又成燎原之势。“炉烟虽熄，灰中有火”，故除恶务尽，不使死灰复燃。

愚见，攻癌夺命汤用治晚期癌症，较放疗、化疗优势是显然的。如能进一步筛选精当，用现代科学方法提炼精华，改革剂型，静脉给药，估计对此类癌瘤的治疗，将会取得突破性进展。鄙见是否有当，仅供在肿瘤战线上从事攻关的同仁参酌。

李可学术思想探讨(上)

张存悌

(辽宁中医药大学第三附属医院, 辽宁 沈阳 110003)

关键词: 李可; 学术思想; 经验; 医话

中图分类号: R249.76 文献标识码: A 文章编号: 1000-1719(2006)10-1340-02

李可, 1933 年生, 山西灵石县人, 毕业于西北艺专文学部。自学考取中医大专学历, 受命创建灵石县中医院并任院长, 致力于中医临床研究 50 年, “白天看病, 晚上攻读医书, 几十年来从未在夜晚 2 时前睡过觉。至今已 70 高龄, 依然如是。”为山西乃至国内独具特色的名医。

崇尚仲景学说, 倡导“难症痼疾, 师法仲景”, 以此为一生座右铭。认为“仲景方能治大病, 救急痛, 愈痼疾, 是攻克疑难大症的仙丹妙药。”“仲景学说是中医学的灵魂, 也是被解世界性医学难题的一把金钥匙。”

擅长以重剂救治重危急症, 尤其擅用附子、乌头类峻药抢救濒危病人, 使数以千计的垂危病人起死回生。其中有案可查, 被西医下了病危通知书者, 也有百余人, 在国内颇有影响。目前急救一般都是西医的事, 然而, 在李可任职灵石县人民医院中医科时, 急救却是中医科的事, 这在全国各医院中可谓绝无仅有。由此被著名中医大家邓铁涛先生称为“中医的脊梁”, 并特为其著作题词。

此外, 李可对内、外、妇、儿、皮肤等科也积累了较为丰富的经验, 均体现在其著作《李可老中医急危重症疑难病经验专辑》(山西科技出版社, 2004 年) 中, 该书记录了他治疗各种疑难病症和急危重症的独到经验, 并辑录了其自创方剂 28 首, 大多可圈可点。

1 推重肾阳 善辨阴证

李氏推崇仲景学说, 重视阳气, 他说: “一部伤寒论 113 方, 使用附子、桂枝、干姜者即达 90 方, 可见医圣对阳的重视, 曰温阳, 曰养阳, 曰助阳, 曰救阳, 对生命之本的阳气, 是何等的曲意呵护, 关怀备至!”他关于阳气的认识系宗于仲景, 与郑钦安学说如出一辙, 下面引证一些。

“阴阳之道, 阳为阴根。阳生, 阴始能长。阳气——命门真火, 乃生命之主宰。命门位居下焦, 乃人身真火, 气化之本源。”

“气化之理, 全在阴阳二字。一切阴(四肢百骸, 五脏腑, 津精水液)皆是静止的, 古人谓之‘死阴’。唯独阳才是灵动活泼, 生命活力。阳为统帅, 阴生于阳而统于阳。‘阳气者, 若天与日, 失其所则折寿而不彰。下焦一点命门真火发动, 十二经循行不息, 五脏六腑气化周行, 生命欣欣向荣。此火一衰, 诸病丛生; 此火一灭, 生命终结。先天之本肾, 生命之本原, 所凭者, 此火。后天之本脾胃, 气血生化之源, 所凭者, 此火。养生若损此火则折寿, 治病若损此火则殒命。”

“正邪交争的焦点, 全看阳气的消长进退, 阳虚则病, 阳衰则危; 阳复则生, 阳去则死。阳气易伤难复, 故阳常不足。暴病多亡阳, 久病多伤阳。伤寒三阴多死

证, 死于亡阳。”

李氏对阴证的辨识积累了十分丰富的经验, 他说: “阴阳的判别, 总以病人的正气强弱为转归。正气强者, 受邪即病, 邪正交争, 从阳化热, 表现为‘阴虚血瘀’; 正气虚者, 卫外不固, 无力抗争, 病邪长驱直入, 由表入里, 深伏难出, 从阴化寒, 表现为‘阳虚血凝’。阴阳的转化, 也以病人正气的修复为转机。阴证, 用药得当, 正气来复, 伏邪由里出表, 阴证化阳为向愈; 阳证, 过用苦寒, 损伤脾肾, 阳证转阴, 则缠绵难愈。”下面举例证之。

阴盛格阳: 赵某, 女, 29 岁。因无故头面阵阵发热, 服升阳散火汤 1 剂, 变为心悸、气喘、自汗, 头面轰热不止, 面色嫩红, 烦躁欲寐, 足膝冰冷, 多尿失禁, 脉微细而急, 120 次/min。辨为阴盛格阳, 误作上焦郁火而投升散之剂致有此变。予白通加人尿猪胆汁汤, 破阴通阳为治: 附子、干姜各 30g, 葱白 3 节, 童便、猪胆汁各 1 杯兑入, 2 剂。服 1 剂, 心悸喘汗均止, 足膝已热, 月余之轰热症亦罢。本病病机, 为下焦阴寒独盛, 格拒真阳不能回归宅窟而浮越于上, 故见种种上热假象。以白通汤破阴通阳, 因有假热在上, 以人尿猪胆汁之苦咸寒为反佐, 热因寒用, 宣通上下, 消除格拒, 引浮越之阳归于下焦而病愈(《李可老中医急危重症疑难病经验专辑》, 下同)。

直中少阴: 杨某, 女, 30 岁。患头痛项强, 恶寒发热, 无汗咽痛, 经治 3 日, 注射青霉素 800 万单位, 服银翘汤 2 剂, 病势有增无已, 邀李氏诊视。患者体温 39.5℃, 白睛尽赤, 扁桃体微肿, 色鲜红。面壁蜷卧, 盖两床棉被仍寒战不已。面色青灰, 双膝冰冷, 腰痛不能转侧。饮些许温橘子汁, 便觉胃寒嘈杂。时时思睡, 又难以入寐。苔白润而不渴, 脉沉细微。从症状看, 为太阳伤寒表实见证; 从脉象反沉细、思睡看, 又像少阴本证; 而目赤、咽痛、高热则又似温邪。前医用银翘 2 剂, 病反加重, 颇滋疑惑。乃详询病史, 始得悉素有食少便溏、五更泄泻之恙。较常人畏风冷, 腰困痛, 时欲躺卧等情, 可证素体阳虚无疑。肾元虚惫之人, 感邪多从寒化。《伤寒论》云: “病人身大热, 反欲得近衣者, 热在皮肤, 寒在骨髓也。”可见其目赤、咽痛、高热俱属假象。且其咽部之鲜红色, 等同“面赤如妆”亦是寒象。乃断为寒邪直中少阴, 心肾交虚, 妄用寒凉, 重伤肾阳, 致正气不支, 无力鼓邪外达。患者虚多邪少, 亟需顾护上焦元气。乃疏一方: 麻黄 10g, 附子 18g, 细辛 10g, 肾四味(枸杞子、菟丝子、盐补骨脂、仙灵脾) 120g, 当归 30g, 仙茅、巴戟各 15g, 乃麻附细合二仙汤去知柏, 加肾四味以鼓舞肾气。服后得汗, 安睡一夜, 次日痊愈, 目赤、咽痛亦退。多年缠绵不愈之五更泻竟也获愈, 体质增强。

1.1 万病不治 求之于肾 从重视阳气的观点出发, 李氏反复强调“万病不治, 求之于肾”, 他说: “肾为先天之本, 为人生命之主宰。内寄命门真火(肾气、元

收稿日期: 2006-09-03

作者简介: 张存悌(1947-), 男, 辽宁沈阳人, 主任医师, 学士, 主要从事中医药防治肿瘤和疑难病症研究。

气、元阳),为生命的原动力,五脏精气的源泉。故五脏之伤,穷必及肾,肾气败亡则生命终结。故凡治病,皆当首先顾护脾肾元气,勿使损伤。若已损伤,则亟亟固脱救肾,醒脾救胃。”“五脏之伤,穷必及肾,肾伤则生命根本动摇。”

由此出发,他对许多疑难病症,都主张从肾论治。例如对过敏性鼻炎类疾病,认为“此证之关键,多属肾中元气不固。肾为先天之本,生长发育、强壮衰老之所系。所谓种种‘过敏性’疾病,皆责其先天不足,亦即自身免疫力低下。从肾论治,可谓治本之道。益气固表,脱敏止痒,隔靴搔痒而已。”主张投以麻黄附子细辛汤加味,“皆获奇效”。

1.2 无苔舌不尽属阴虚 关于无苔舌的主病,一般认为多主阴虚。凡舌面无苔而干,或中心剥蚀如地图,或舌红如柿,或见裂纹,各家皆主阴虚。但李氏认为,临床所见,不少气虚、阳虚甚至亡阳危证中,也出现这样的舌象。此时,无苔舌不主阴虚,并非阴津不足,而是阳虚气化不利,水津失于敷布所致。治疗应该舍舌从证,投以回阳破阴之辛热大剂,在主证解除的同时,舌上可以生出薄白苔,而且布满津液,裂纹亦愈合。他并引用郑钦安的案例证明这一点。郑氏治一唇焦舌黑、不渴少神之疾,断为真阳衰极,不能熏蒸津液于上,用四逆汤治之而愈。郑氏指出:“当知阳气缩一分,肌肉即枯一分,此舌黑唇焦所由来也。四逆汤力能回先天之阳,阳气一回,津液升腾,枯焦立润。”受之启发,治疗此种无苔舌应该投用附子,认为“附子能致津液”,气能升水,实发前人所未发。李氏总结:“我一生所遇此类舌证抵牾的病例,不下 200 例,全数按主证以相应的方药而愈。经长期观察,凡亡阳之格局已成,兼见阴虚舌者,一经投用四逆加入人参汤,少则 4 个小时,多则一昼夜,干红无苔舌(其中包括部分绛舌)全数生苔、生津。”这一观点确有新意。

凡气虚渐及阳虚,而出现“阴虚舌”者,倡用大剂补中益气汤加附子 30g,油桂 10g,3 剂后舌象即可改观。肺癆、骨蒸潮热而见阴虚舌者,补中益气汤重用黄芪 60g,加乌梅、山萸肉、生龙骨、生牡蛎各 30g,甘温除大热,补土生金,十周而潮热退。舌象亦改变。这些均是其十分宝贵的经验,兹举其案例如下。

一老妇,76 岁,右半身麻木,膝以下冷,脚肿不能穿鞋,渴不思饮,漱水即唾。睡醒一觉,舌干不能转动,心悸头眩,难再入睡,脉迟细,舌干红无苔。予大剂人参真武汤,3 剂后肿退,寐安,舌上生出薄白苔,津液满口。一女教师,62 岁,患“干燥综合症”8 年,先用激素疗法无效。口干无津,饮水愈多,干渴愈甚,终致舌干不能转动,不仅无唾液,亦无涕泪,阴道干皱,大便干结如羊粪球,舌光红如去膜猪腰子,唇干裂,口舌疮频发。曾服省内及洛阳名医中药数百剂,大率皆养阴增液之类,或辛凉甘润,或养胃阴、存津液,历年遍用不效。诊脉沉细微弱,面色萎黄无华,四肢不温,双膝以下尤冷。遂以大剂参附汤直温命火,以蒸动下焦气化之根,令阳生阴长,附子通阳致津液,使水升火降,佐以大剂引火汤大滋真阴以抱阳,小量油桂,米丸吞服,引火归原,10 剂后诸症均退,舌上生出薄白苔,津液满口。

此外,李氏受前贤曹炳章“舌红非常并非火”之论的启发,认为“凡见舌色鲜红或嫩红,皆因气血虚寒,阳浮于上,类同‘面赤如妆’之假热,误用清热泻火则危。临证极需留意”。如肺结核以及肿瘤病人由于化疗损伤气阴,见潮热、烦渴,舌红无苔等症,应当全面辨析。慎投滋阴降火,以免重伤胃阳。李氏经验,其时投以大剂补中益气汤加山萸、乌梅、知母、花粉、龙骨、牡蛎等,甘温除大热,可收良效。

1.3 捉心如焚例同浮阳外越 李氏曾治刘某,女,43 岁。足心发热 7 年,日夜不休,日夜夜重。自觉涌泉穴处呼呼往外冒火。不论冬夏,夜卧必将脚伸出被外,始能入睡。多次服滋阴降火补肾之剂不效。诊见面色嫩红,艳若桃李,此阳浮于上显然。脉细数,小便清长,饮一溲一。脘腹冷感,胃纳不佳,稍进凉食则觉酸腐不适,双膝独冷。

李氏认为,此症乃阴阳衰盛之变引起。阳气一衰,火不生土,胃中水谷便无由蒸化,故见纳少化艰;人身津液赖此火之温煦,始能蒸腾于上,敷布上下。此火一衰,气化便弱,津液不能升腾,故口干;涌泉为足少阴肾经井穴,为肾气之所出。今下焦阳衰,不能统摄肾阴,而致阴火沸腾,足心热如火焚。宜补火之原,真火一旺,阴火自安,处方:炙甘草 60g,干姜、附子各 30g,冷水 1500mL,文火煮取 500mL,2 次分服,3 剂。药后热势顿减,双膝冷感消失。

1.4 骨蒸劳热并非阴亏 李氏曾治刘某,女,22 岁。患干血癆(双肺空洞型结核)3 年,骨蒸劳热,昼夜不止半月。双颧艳若桃李,口苦,舌光红无苔,干渴能饮。四肢枯细,羸瘦脱形,似乎一派阴虚火旺之象。李氏投以清骨散加龟板、黄芩、童便为治,1 剂后,竟生变故,患者大汗肢厥,呃逆频频,喘不能言,脉微欲绝,已是阳虚欲脱之症,急用四逆汤合来复汤,大剂频服,方得脱险。且持续 3 年之久的骨蒸劳热也得以控制。由此案认识到,“骨蒸劳热,乃气血大虚,阳失统摄之假热,绝不可见热投凉,见蒸退蒸。自此之后,余终生不用清骨散之类治骨蒸劳热之套方。”

由此李氏认为,肺结核之骨蒸劳热乃肝、脾、肾虚极之假热,治当补火生土,先后天并重。应该遵循仲景“劳者温之”之旨,确立“癆瘵当以顾护脾肾元气为第一要义的主张”,从而显示了火神派重视元气的基本理念。李氏并摸索出用补中益气汤为主治疗肺结核骨蒸劳热的成功经验,其书中有许多案例可证,如:

某女,24 岁。双肺空洞型肺结核十年,经闭 5 个月,已成干血癆症。骨蒸潮热,午后阵作。咯血不止,面色㿔白,唇指白如麻纸。毛发枯焦,四肢枯细,身瘦脱形。动则喘息,夜不能卧。食少便溏,黎明必泻。虽在酷暑,仍觉怯寒,四肢不温。认为脾肾元气衰微欲脱,不可以“结核”为由,妄投滋阴降火套方。当以先后天并重,投以补中益气汤加味:黄芪 30g,红参(另炖)、五灵脂、白术、当归、肾四味各 10g,柴胡、升麻各 3g,炙甘草 10g,山萸肉、谷麦芽、乌梅各 30g,油桂 2g 冲,胡桃肉 4 枚。两煎混匀,得汁 150mL,日分 3 次服。服 3 天停 1 天,连服 25 剂。潮热退净,汗敛喘定,胃口大开,晨泻亦愈,咯血偶见。原方加山药 50g,另以三七、白及各 3g,虫草 5g,研粉冲服。续服半月后,面色红润,咳嗽、咯血已止,已无病象。

2 重用附子擅治危症

2.1 倡用大剂 李氏擅长治疗心衰、呼衰等急危重症,倡用大剂附子。他认为历代所用四逆方,主药附子仅 10g 左右,剂量显然不足。考伤寒论四逆汤原方,用生附子 1 枚,按考古已有定论的汉代度量衡折算,附子 1 枚,约合今之 20g,假定生附子之毒性与药效为制附子之两倍以上,则伤寒论原方每剂所用附子相当于现代制附子 40~60g;而历代用四逆汤仅原方的 1/6—1/10。以这样的轻量,要救生死于顷刻,诚难矣!故他用附子治疗心衰等急危重症,一般都在 100~200g 之间,且日夜连续进服,24h 服用 1~3 剂,总量当在 500g 左右。李氏“一生所用附子超过 5t 之数,经治病人在万例以上,垂死病人有 24h 用附子 500g 以上者,从无一例中毒。”(未完)

李可学术思想探讨(下)

张存悌

(辽宁中医药大学第三附属医院, 辽宁 沈阳 110003)

关键词: 李可; 学术思想; 经验; 医话

中图分类号: R249.76 文献标识码: A 文章编号: 1000-1719(2006)11-1491-02

2.2 重症急煎 随煎随喂 李氏认为,对心衰垂危的病人而言,附子的毒性正是其起死回生药效之所在。他说:一般人“不敢重用附子,乃因畏惧附子之毒性。但附子为强心主将,其毒性正是其起死回生药效之所在。当心衰垂危,病人全身功能衰竭,五脏六腑表里三焦,已被重重阴寒所困,生死存亡,系于一发之际,阳回则生,阳去则死。非破格重用附子纯阳之品的大辛大热之性,不能斩关夺门,破阴回阳,而挽垂绝之生命。按现代药理实验研究,附子武火急煎 1h,正是其毒性分解的高峰。由此悟出,对垂死的心衰病人而言,附子的剧毒,正是救命的仙丹。”因此,他治疗心衰重症,都是开水武火急煎,随煎随喂,或鼻饲给药,24h 内,不分昼夜频频喂服 1~3 剂,可收起死回生之效。

肺心病心衰合并脑危象案 闫某,男,60 岁。患阻塞性肺气肿、肺心病代偿期达 10 年。1995 年 3 月 24 日凌晨 4 时邀诊:昏迷不醒,吸氧,面如死灰,唇、指、舌青紫,头汗如油,痰声漉漉,口鼻气冷,手冷过肘,足冷过膝,双下肢烂肿如泥,二便失禁,测不到血压,气息奄奄。脉散乱如雀啄屋漏,移时一动。诊为“肺心病心衰,呼吸衰竭合并脑危象”,已属弥留之际。遂投自拟破格救心汤大剂,以挽垂绝之阳而固脱,加三生饮豁痰,麝香辟秽开窍醒脑:附子 150g,干姜、炙甘草各 60g,高丽参(另炖浓汁兑服)、生半夏各 30g,生南星、菖蒲各 10g,净山萸肉 120g,生龙牡粉、活磁石粉各 30g,麝香(分冲)0.5g,鲜生姜 30g,大枣 10 枚,姜汁(兑入)1 小盅。上药加开水 1.5kg,武火急煎,随煎随灌,不分昼夜,频频喂服。服完上方 1 剂,25 日子时过后汗敛喘定,厥冷退至肘膝以下,手足仍冰冷。面色由灰败转为萎黄,紫疳少退,痰鸣大减。呼之可睁眼,神识仍未清。六脉迟细弱代,48 次/min,已无雀啄、屋漏之象,回生有望。原方附子加足 200g,日夜连服 3 剂。26 日患者已醒,唯气息微弱,声如蚊蚋,四肢回温,可以平卧,知饥索食。脉沉迟细,58 次/min,已无代象。喉间痰鸣消失,腿已不肿。此“正是大剂量附子破阴回阳之效。真阳一旺,阴霾自消。病已脱险,元气未复”。原方去生半夏、生南星、菖蒲、麝香,附子减为 150g,加肾四味及胡桃肉各 30g,温养肝肾精气以固脱。每日 1 剂,煎分 3 次服。至 30 日,诸症均退,食纳渐佳,已能拄杖散步。前后历时 5 天,共用附子 1.1kg,九死一生垂危大症,终于得救。

风心病心衰垂危案 吴某,男,55 岁。患风湿性心脏病 12 年,顽固性心衰 5 年,心功Ⅲ级。近日病情加重,心衰合并室颤,心率 212 次/min,已发病危通知,某日上午 9 时 30 分李氏接诊:患者面如死灰,头汗如油,神识昏糊,目暗无神,喘不能言,气息奄奄,小便自遗。唇舌、指甲青紫,口鼻气冷,全身冰冷,仅胸部微温,腹胀如鼓,下肢烂肿如泥,吸氧,测不到血压,寸口脉如游丝。五脏绝症已见

其三,元阳垂绝,危在顷刻。遂投大剂破格救心汤,重用附子 200g,加沉香粉(冲)、油桂粉(冲)各 3g,茯苓、泽泻各 30g,以纳气归肾利水消肿。武火急煎,边煎边灌。10 时许开始服药,一刻钟后阳回厥退,汗敛喘定。11 时 30 分,知饥索食,心率 100 次/min,脱险。嘱原方 3 剂,3h 1 次,昼夜连服。下午 4 时,水肿消退,心率 82 次/min,已能拄杖出游。前后 31h,计服附子 0.75kg,古今皆为必死之症,竟获治愈。

3 减毒措施 万无一失

李氏从事中医临床探索 50 年,“每遇急险重危症,使用毒剧中药救治,皆获起死回生之效。疑难痼疾用之则立见转机,累起沉疴。其中,使用最多的是附子,一生累计超过 5t。川乌次之,亦在 3t 以上,经治人次万名以上,无一例中毒。如何驾驭药中猛将,使之听从调遣,治病救亡而不伤害人体?”李氏反复研究仲景运用乌、附剂之经验,在配伍、炮制与煎服方法上求得真谛,为确保万无一失,李氏又加 3 条措施。

3.1 配伍解毒之品 凡用乌头剂,必加两倍量之炙甘草,蜂蜜 150g,黑小豆、防风各 30g;凡用附子超过 30g 时,不论原方有无,皆加炙甘草 60g,即可有效监制。考炙甘草、蜂蜜、黑小豆、防风均有解毒作用。

另外,李氏还研制出乌附中毒解救法:方用生草 60g,防风、黑豆各 30g,加水 1500mL,蜂蜜 150mL,分次冲服绿豆粉 30g,10min 即解。1965 年曾参与川乌中毒濒危 2 例的抢救,以生大黄、防风、黑小豆、甘草各 30g,蜂蜜 150g,煎汤送服生绿豆粉 30g,均在 40min 内救活。

3.2 宽水久煎 凡剂量超过 30g 时,乌头剂加冷水 2500mL,文火煮取 500mL,日分 3 次服,煎煮时间 3h 左右,可有效破坏乌头碱之剧毒。

附子剂用于慢性心衰,加冷水 1500mL,文火煮取 500mL,日分 2~3 次服。危急濒死心衰病人,使用大剂破格救心汤时,则用开水武火急煎,随煎随灌,不循常规,以救生死于顷刻。此时,附子的毒性,正是心衰病人的救命仙丹,不必多虑。

3.3 示范煎药 亲临守护 “凡用乌头剂,必亲临病家,亲为示范煎药。病人服药后,必守护观察,详询服后唇舌感觉。待病人安然无事,方才离去。”既体现了谨慎作风,更显示了责任心。

4 常用扶阳方药举隅

李氏除擅用四逆辈扶阳外,尚有自制扶阳救脱方剂若干首,各有特色,尽显火神派风格,下面予以介绍。

4.1 破格救心汤 破格救心汤为李氏研创的回阳救脱效方,成功地治愈了千余例心衰重症,使百余例已发病危通知的垂死病人起死回生,显示了本方在救治重危急症的强大效力。

方剂组成:附子 30~200g,干姜、炙甘草各 60g,高丽参(另煎浓汁兑服)10~30g,山萸净肉 60~120g,生龙、牡粉、活磁石粉各 30g,麝香(分次冲服)0.5g。煎服方法:病势缓者,加冷水 2000mL,文火煮取 1000mL,5 次分服,2h 1 次,日夜连服 1~2 剂,病势危急者,开水武火急煎,随煎、随喂,或鼻饲给药,24h 内不分昼夜频

收稿日期:2006-09-04

作者简介:张存悌(1947-),男,辽宁沈阳人,主任医师,学士,主要从事中医药防治肿瘤和疑难病症研究。

频喂服 1~3 剂。

本方脱胎于四逆汤及张锡纯的来复汤,破格重用附子、山萸肉加麝香而成。四逆汤为强心主剂,心衰病人病情错综复杂,不但阳气衰微,而且阴液内竭,故加人参,成为四逆加人参汤,大补元气,滋阴和阳,使本方更臻完善。但用于救治心衰垂危重症仍然生死参半,李氏认为剂量较轻。在破格重用附子 100g 以上时,重症病人的治愈率可达十全。而垂死病人救活率,仅可达十之六七。后受张锡纯用大剂山萸肉救脱的启发,认识到“萸肉救脱之功,较参、术、芪更胜。盖萸肉之性,不独补肝也,凡人身阴阳气血将散者皆能敛之。”“山萸肉为救脱第一要药”(张锡纯语)。师承其意,于破格人参四逆汤中重加山萸肉,更加生龙牡、活磁石、麝香,遂成破格救心汤方。龙牡二药,为固肾摄精、收敛元气要药;活磁石吸纳上下,维系阴阳;麝香为急救醒神要药,开中有补,对一切脑危象(痰厥昏迷)有斩关夺门、辟秽开窍之功。从而使本方具备了扶正固脱,活血化痰,开窍醒脑,复苏高级神经之功能,增强了回阳救逆之效。用以救治呼吸、循环衰竭,纠正全身衰竭状态,确有起死回生的功效。

本方对多种老年重症危症有泛应曲当之效。凡内外妇儿各科危急重症,或大吐大泻,或吐衄便血,妇女血崩,或外感寒温,大汗不止,或久病气血耗伤殆尽……导致阴竭阳亡,元气暴脱,心衰休克,生命垂危(一切心源性、中毒性、失血性休克及急症导致循环衰竭),症见冷汗淋漓,四肢冰冷,面色㿔白或萎黄、灰败,唇、舌、指甲青紫,口鼻气冷,喘息抬肩,口开目闭,二便失禁,神识昏迷,气息奄奄,脉象沉微迟弱,或散乱如丝,雀啄屋漏,或脉如潮涌壅沸,数急无伦,以及古代医籍所载心、肝、脾、肺、肾五脏绝症和七怪绝脉等必死之症,“凡心跳未停,一息尚存者,急投本方,1h 起死回生,3h 脱离险境,一昼夜转危为安”。典型案例前面已经介绍。

4.2 奔豚汤 组成:附子 10~100g,红参 10~30g,炙甘草 10~60g,肉桂 10g,砂仁、沉香各 3~5g,茯苓、山药各 30g,泽泻、怀牛膝各 15g。煎服方法:小剂,加冷水 1500mL,文火煮取 600mL,3 次分服。日夜连服 1~2 剂,大剂,加冷水 2500mL,文火煮取 750mL,日 3 夜 1 服。

主治:肝脾肾三阴寒证;奔豚气;寒霍乱,脘腹绞痛;气上冲逆,上吐下泻,四肢厥逆,甚则痛厥;水肿等症。本方运用要点,以厥气上攻为主症,即“奔豚”之取意。当其发作时,自觉一股冷气从少腹直冲胸咽,使人喘呼闷塞,危困欲死而痛苦万分,止则平复如常,与《金匱》描述一致。李氏应用本方数十年,扩大应用范围,“用治一切沉寒痼冷顽症,临床罕见奇症,皆能应手取效。尤对危急重症,有起死回生之功。”典型案例如下。

风心病垂危案 郝某,男,50 岁。患风心病 12 年,近两年全身肿胀,心悸气喘,西医诊为“风心病心衰,心功Ⅲ级,心房纤颤”。腹大如鼓,脐凸胸平,下肢烂肿如泥,已卧床 3 月余。端坐呼吸,面色青惨,畏寒特甚,唇指青紫,冷汗淋漓,四肢厥冷,六脉似有似无,舌紫胖水滑,齿痕多。腹诊脐下筑动应衣,时觉有冷气从关元穴处向上攻冲奔迫,冲至咽喉,人即昏厥。神识昏蒙,似睡非睡。此属少阴亡阳诸症悉见,以奔豚汤救治,附子用至 100g,另加煅紫石英、生龙牡、肾四味各 30g,山萸肉 90g,炙甘草 60g,生姜 10 片,大枣 10 个,核桃 4 个。加冷水 2500mL,文火煮取 750mL,日 3 夜 1 服。3 剂后,奔豚气未发,心悸亦止,房颤消失。7 剂后小便增多,食纳增加,喘定可平卧。10 剂后水肿全消,精神健旺。

高血压案 胡某,女,46 岁。患肾性高血压 5 年,低压在 110~120mmHg。近 3 年异常发胖,食少便溏,呕逆腹胀,头晕畏寒,足膝冰冷。近 1 月服羚羊粉后,

常觉有一股冷气从脐下上冲至咽,人即昏厥(按:此症多有服寒凉药史)。约三五日发作 1 次,其眩晕如腾云驾雾,足下如踩棉絮,形胖而无力。腰困如折,小便余沥,咳则遗尿,时有咸味痰涎上壅。常起口疮,头面自觉轰轰发热,中午而赤如醉。舌淡胖,苔白腻,脉洪不任按,久按反觉微细如丝。脉证合参,认为阴盛于下,阳浮于上,上热是假,下寒是真。治当益火之源,以消阴翳。投予奔豚汤,附子用 30g,另加吴茱萸 15g,肾四味 60g,生龙骨、生牡蛎、灵磁石、煅紫石英、山萸肉各 30g。加冷水 1500mL,文火煮取 600mL,日 3 服。3 剂后,尿量增多,矢气较多,腹胀大减。头已不晕,不再飘浮欲倒,腹中觉暖,已无冷气上攻。继服 10 剂,诸症均愈,血压正常。

4.3 加味改良乌头汤 组成:川乌、附子各 30g,麻黄 15g,黄芪 120g,防风 30g,桂枝、白芍各 45g,蜂蜜 150g,炙甘草 60g,黑小豆、老鹳草、豨莶草、当归各 30g,细辛 20g,生姜 45g,大枣 20 个。煎服方法:加冷水 2500mL,文火煮取 600mL,费时约 2.5h,3 次分服,3h 1 次。本方由《金匱》乌头汤、当归四逆汤合方加味而成,重用川乌、附子、细辛等辛热之药,加黑小豆、防风、蜂蜜与甘草共同制约乌附类剧毒,老鹳草、豨莶草用以增强祛风通络止痛之功。配伍齐全,又加久煎,放胆使用,“可谓万无一失”。李氏“一生运用此方在万人次以上,从无一例中毒。”

此方用治风湿性、类风湿性关节炎、坐骨神经痛、腰间盘突出症等,约 2000 例以上,正虚加大剂量生芪,肾虚加肾四味,久病加虫类药,关节变形者加制马钱子粉,每次 0.15g,渐加至 0.6~0.8g,日服 2 次,连服 10 日间息 5 日,用绿豆汤佐餐。多数病例 10 天痊愈,最长 1 例两个半月。

此外,李氏对肾四味、生半夏、吴茱萸等药物的运用也颇有特色,经验丰富,简介如下。

肾四味:指淫羊藿、补骨脂、枸杞、菟丝子四味常用补肾药,李氏用为补肾常用药对。因为“四药入肝肾,药性和平,温而不燥,补而不腻。益肾精,鼓肾气,温阳无桂附之弊,滋阴无熟地之弊。阴中有阳,阳中有阴”。凡遇下元亏损,肾阳虚未至手足厥逆,肾阴虚未至舌光无苔,而属肾气、肾精不足之症,如有腰困如折,不能挺直,头目昏眩,夜夜频多,小便余沥,足膝酸软等症,用之效若桴鼓。

吴茱萸:李氏认为,吴茱萸治巅顶头痛、肝寒疝痛、痛经,眩晕,胃寒呕吐吞酸,噎膈反胃,外敷涌泉引火归原治口疮,敷脐治小儿泄泻,其功不可尽述。唯各家皆用 1.5~6g,药难胜病,故其效不著。《伤寒论》吴茱萸汤用量 1L,约合今制 50g。故其“用量在 10g 以下无效,15g 显效,30g 攻无不克”。

吴茱萸汤方下注一“洗”字,是仲景奥妙所在,即以沸水冲洗 7 遍而后入煎,可免入口辛辣及服后“瞑眩”之弊。凡用至 15g 以上,先用开水冲洗 7 次,小儿、老人、羸弱病人则先煎沸 2~3min,换水重煎,并加两倍之鲜生姜、大枣 20~30 枚,可保无害。因其“擅解一切痉挛”,包括内耳迷路之痉挛引起的美尼尔氏综合征,李氏常用该药治疗此症。吴茱萸辛热燥烈,李氏认为“只可暂用”,不可久用。

生半夏:李氏指出:“仲景方中半夏皆生用”,因此他善用生半夏降逆化痰,用小半夏加茯苓汤加赭石、生姜、姜汁,通治一切肝胃气逆呕吐(包括治疗妊娠剧吐)、“轻症一二口即止,稍重则服 2~3 次即愈,极重症 10h 许过关”,应用万例以上。生半夏用量多为 30g,用时以温水淘洗 3 次,加等量生姜佐之,既解其毒,又加强疗效,“更无中毒之虞”。他说:“生半夏为止呕要药,加等量鲜生姜解其毒,经治妊娠剧吐患者千例以上,确有覆杯而愈之效。40 余年用生半夏超过 3 吨,无一例中毒。”其书中例案颇多。